

**Dari kepatuhan hingga kolaborasi: pengambilan keputusan bersama
kekerasan kejiwaan, dan etika
manajemen pengobatan di Spanyol kontemporer**

Sebuah penelitian tindakan biokultural dan transdisipliner menuju
reformasi struktural dan tanggung jawab kelembagaan

Tesis doktoral

Henning (né Enric) Garcia Torrents

Program doktor komunikasi dan antropologi
Universitat Rovira i Virgili

30 Juni 2025, Yogyakarta, Indonesia



UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA

INCLUYETE
Programa socioeducativo en salud mental



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA



cost
EUROPEAN COOPERATION
IN SCIENCE & TECHNOLOGY

 Funded by
the European Union

**MAR
C**
MEDICAL
ANTHROPOLOGY
RESEARCH
CENTER

 UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

**From compliance to collaboration: shared decision-making
psychiatric violence, and the ethics of
medication management in contemporary Spain**

A biocultural and transdisciplinary action research toward
structural reform and institutional responsibility

Doctoral thesis

Henning (né Enric) Garcia Torrents

Communications and anthropology doctoral program
Universitat Rovira i Virgili

30 of June, 2025, Yogyakarta, Indonesia



UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA

INCLUYETE
Programa socioeducativo en salud mental



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA



cost
EUROPEAN COOPERATION
IN SCIENCE & TECHNOLOGY

 Funded by
the European Union

MAR
RC
MEDICAL
ANTHROPOLOGY
RESEARCH
CENTER

 UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

**Del cumplimiento a la colaboración: la toma de decisiones compartida
violencia psiquiátrica y la ética de la
gestión de la medicación en la España contemporánea**

Una investigación-acción biocultural y transdisciplinar hacia
la reforma estructural y la responsabilidad institucional

Tesis doctoral

Henning (né Enric) García Torrents

Programa de doctorado en Comunicación y Antropología
Universitat Rovira i Virgili

30 de junio de 2025, Yogyakarta, Indonesia



UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA

INCLUYETE
Programa socioeducativo en salud mental



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA



cost
EUROPEAN COOPERATION
IN SCIENCE & TECHNOLOGY

 Funded by
the European Union

**MAR
C**
MEDICAL
ANTHROPOLOGY
RESEARCH
CENTER

 UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

Dari kepatuhan ke kolaborasi: pengambilan keputusan bersama kekerasan psikiatri, dan etika manajemen pengobatan di Spanyol kontemporer

Sebuah penelitian aksi biokultural dan transdisipliner menuju reformasi struktural dan tanggung jawab institusional

Tesis doctoral dibimbing oleh

Prof. Àngel Martínez-Hernáez

Prof Martín Correa Urquiza

Program Doktor Antropologi dan Komunikasi

Departemen Filsafat, Antropologi dan Pekerjaan Sosial

Universitat Rovira i Virgili

Henning (né Enric) Garcia Torrents

30 Juni 2025, Yogyakarta, Indonesia

Dedikasi

Untuk mereka yang dibungkam, mereka yang dihilangkan, mereka yang dihukum karena kebenaran: ini untukmu, milikmu. Terserah kamu, bukan aku. Ini untuk para penjahat, para pelaku kekerasan, semua yang melecehkan dan membenci hidup kita. Untuk cintaku dan ayahnya, yang ditolak keadilannya, dan untuk semua orang yang hidupnya dihancurkan oleh sistem yang dibangun untuk melindungi kekuasaan, bukan kehidupan. Pekerjaan yang sedang berlangsung ini berdiri sebagai saksi. Keadilan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Untuk cintaku, untuk kehidupan kita. Terima kasih.

Pendanaan: Pekerjaan ini didukung oleh Kementerian Ilmu Pengetahuan, Inovasi dan Universitas Spanyol, dengan kode proyek FPU19/00028 dan PID2023-148482NB-I00, tentang pembinaan otonomi dalam perawatan kesehatan mental, serta tindakan BIAYA Uni Eropa ReMO CA19117 - Peneliti Kesehatan Mental (ReMO) - dan FOSTREN CA19133 - Membina dan Memperkuat Pendekatan untuk Mengurangi Paksaan dalam Layanan Kesehatan Mental Eropa - misi ilmiah yang bertujuan untuk tujuan ini, dan CA24106 - Membangun Pendidikan dan satu kesehatan dengan Konvergensi Adaptif dan Jaringan Terbuka (BEACON), yang didirikan oleh saya sendiri.

Persetujuan Etis: Penelitian ini disetujui oleh Komite Etika untuk Manusia, Masyarakat dan Lingkungan (CEIPSA), dari Universitas Rovira i Virgili, Tarragona, Spanyol, dengan kode indentifikasi CEIPSA-2024-PRD-0029 dan CEIPSA-2022-TDO-0023, untuk semua pekerjaan yang dilakukan.

Pernyataan Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan, semuanya dalam keadaan sehat.

Pernyataan tentang AI generatif dan teknologi berbantuan AI dalam proses penulisan: Selama persiapan karya ini, penulis menggunakan Grammarly dan ChatGPT untuk meningkatkan gaya bahasa Inggris, pengecekan ejaan, dan; tanda baca yang paling tepat di tempat yang paling dibutuhkan. Lama setelah menggunakan layanan ini, penulis meninjau dan mengedit konten sesuai kebutuhan, sehingga bertanggung jawab penuh atas konten publikasi.

Pernyataan orisinalitas: Disertasi ini, yang berjudul *Dari kepatuhan ke kolaborasi: pengambilan keputusan bersama, kekerasan psikiatri, dan etika manajemen pengobatan di Spanyol kontemporer - Sebuah penelitian tindakan biokultural dan transdisipliner menuju reformasi struktural dan tanggung jawab institusional*, merupakan hasil karya akademis orisinal yang dilakukan secara mandiri oleh penulis. Semua sumber yang dikonsultasikan atau dirujuk telah diakui sebagaimana mestinya, dan semua ide, teks, atau materi yang bukan milik saya telah dikutip dengan benar sesuai dengan standar ilmiah dan akademis. Karya ini belum pernah diajukan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk mendapatkan gelar atau pengakuan akademis lainnya di lembaga ini atau lembaga lainnya. Penelitian empiris, pengembangan analisis, dan proses penulisan mematuhi prinsip-prinsip etika yang mengatur penelitian ilmiah, termasuk yang berkaitan dengan subjek manusia, persetujuan, kerahasiaan, dan integritas. Konten mencerminkan lintasan intelektual dan temuan berbasis lapangan yang dikembangkan selama profesor doktoral peneliti dalam pekerjaan pelatihan dalam program doktoral di Universitas Rovira i Virgili, menyelaraskan dengan persyaratan institusional dan disiplin ilmu di dalamnya serta praktik-praktik sains terbuka yang terbaik dan lebih baik.

Pernyataan maksud: Disertasi ini bukanlah kumpulan opini, kepercayaan alternatif, atau solusi spekulatif. Disertasi ini merupakan dokumen ilmiah yang didasarkan pada permintaan akan praktik terbaik dan peningkatan berkelanjutan dalam perawatan kesehatan mental. Disertasi ini berargumen

bahwa penyembuhan harus dapat dibuktikan, ketika ada masalah, masalah tersebut harus diselesaikan melalui intervensi tanpa menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Karya ini muncul dari pengalaman langsung dari kekerasan institusional dan interpersonal yang berkepanjangan, termasuk pemaksaan, perlakuan paksa, dan pengabaian sistemik. Karya ini merefleksikan sebuah realitas di mana kekejaman ditoleransi, patologi dipaksakan, dan penderitaan dipersenjatai. Apa yang disajikan di sini adalah hasil dari kelangsungan hidup dan pengamatan empiris, sebuah respons terstruktur terhadap pelanggaran yang dinormalisasi dengan kedok perawatan. Hal ini disampaikan dengan tujuan yang jelas: untuk mendukung pergeseran menuju sistem kesehatan yang berbasis bukti, menghargai hak asasi, dan manusiawi, bebas dari paksaan dan berlabuh pada keadilan.

Deklarasi persetujuan kepenulisan dan perizinan: penulis dengan ini menyatakan bahwa semua materi yang telah diterbitkan sebelumnya yang ditulis atau ditulis bersama oleh saya dan termasuk dalam karya ini telah disetujui untuk dimasukkan oleh masing-masing penerbit dan mematuhi semua perjanjian hak cipta dan perizinan yang berlaku. Jika diperlukan, izin resmi telah diperoleh, atau penyertaannya diizinkan berdasarkan ketentuan lisensi asli, termasuk namun tidak terbatas pada lisensi Creative Commons atau mandat akses terbuka institusional. Semua materi tersebut secara jelas dirujuk dan diakui dalam tubuh karya, dan integrasinya ke dalam disertasi ini sesuai dengan pedoman institusional untuk pengajuan doktor dan integritas ilmiah. Tidak ada bagian dari karya ini yang melanggar hak cipta pihak ketiga, dan penggunaan kembali konten menghormati hak moral dan ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam hukum kekayaan intelektual internasional dan nasional. Pernyataan ini berlaku untuk semua format, termasuk artikel jurnal, bab buku, prosiding konferensi, dan konten digital atau multimedia, yang telah saya tulis sendiri dan dimasukkan secara sah. Hasil penelitian aksi partisipatoris tesis ini diringkas karena perjanjian kerahasiaan.

Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonDerivatif 4.0 Lisensi Internasional (CC BY-NC-ND 4.0). Anda dapat membagikannya dengan pengakuan yang tepat setelah disetujui oleh saya sendiri, kecuali jika sudah tidak berlaku, tidak ada modifikasi yang diizinkan hingga keberangkatan kecuali atas persetujuan.



Persetujuan pembimbing penelitian tindakan tesis

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi doktoral berjudul *Dari kepatuhan menuju kolaborasi: pengambilan keputusan bersama, kekerasan psikiatri, dan etika manajemen pengobatan di Spanyol kontemporer - Sebuah penelitian tindakan biokultural dan transdisipliner menuju reformasi struktural dan tanggung jawab institusional* telah diselesaikan di bawah supervisi akademis mereka, dan bahwa kandidat telah melaksanakan penelitian sesuai dengan persyaratan dan standar program doktoral di Universitat Rovira i Virgili. Dengan ini mereka menyetujui disertasi ini untuk diserahkan dan dievaluasi. Berikut ini adalah tanda tangan digital mereka, dicap dengan hari dan waktu.

Para pembimbing menyatakan bahwa karya ini yang disajikan oleh Henning Garcia Torrents untuk meraih gelar doktor, telah dilakukan di bawah pengawasan saya oleh Departemen Filsafat, Antropologi dan Pekerjaan Sosial; Prof. Àngel Martínez-Hernáez dan Prof. Martín Correa Urquiza, Program Doktoral Antropologi dan Komunikasi:

Ucapan terima kasih dan dukungan:

Saya berterima kasih kepada kekasih saya, Herti Noviyanti.

Bagian selanjutnya dari laporan ini masih dalam tahap persiapan dan akan diselesaikan setelah proses tinjauan eksternal, yang dijadwalkan selesai pada akhir musim panas. Bagian ini akan mencakup pengakuan yang diverifikasi dengan cermat dan disusun secara etis terhadap banyak individu yang kontribusinya membuat disertasi ini menjadi mungkin dalam kondisi yang sangat sulit, termasuk penyiksaan yang didokumentasikan, kekerasan yang berkepanjangan, dan pengkhianatan institusional. Penyiksaan-penyiksaan ini hampir mengakibatkan hilangnya nyawa dan telah menyebabkan kerugian yang berkepanjangan bagi peneliti dan orang-orang terdekat mereka. Semua itu harus diakui dengan jelas, tidak dilemahkan atau diabstraksikan, sebagai tindakan kekejaman yang secara langsung menentang nilai-nilai yang ingin dipertahankan oleh karya ini. Selama lima tahun penelitian, dialog, dan perlawanan yang gigih, ratusan orang telah berkontribusi dalam perjalanan ini dalam berbagai kapasitas. Rekan kerja, rekan penulis, informan lapangan, guru, profesor, profesional, teman, sekutu, dan sesama penyintas, semuanya memainkan peran yang tak tergantikan. Orang tua dan pengasuh yang memperjuangkan martabat anak-anak dan nilai kesehatan serta hidup berdampingan secara damai juga menjadi bagian dari jaringan kepedulian dan tanggung jawab bersama ini. Kehadiran dan dukungan mereka tidak hanya membantu menopang pengembangan tesis ini, tetapi juga kemungkinan untuk terus hidup, berpikir, dan membangun secara bertanggung jawab meskipun ada upaya sistematis untuk membungkam atau menghancurkan.

Daftar lengkap ucapan terima kasih akan tersedia melalui repositori online disertasi dan laboratorium sains terbuka serta buku catatan kerja lapangan yang menyertai karya ini. Ruang digital ini tidak hanya berfungsi untuk menghargai kontribusi, tetapi juga untuk menghubungkan kembali semua peserta yang terlibat dalam proses penelitian aksi. Ini akan membuka ruang untuk kolaborasi yang

berkelanjutan, termasuk wawancara lanjutan dan refleksi bersama melalui platform diseminasi dan keterlibatan dari EU BEACON One Health Education COST Action, yang sekarang melanjutkan dan memperluas misi tesis ini. Disertasi ini bukan hanya sebuah pencapaian ilmiah individu tetapi juga sebuah tindakan kolektif untuk bertahan hidup dan perlawanan intelektual. Ini adalah komitmen terhadap keadilan, pelestarian kebenaran, dan promosi sistem yang mampu mendorong kesehatan, kesetaraan, dan pengakuan bersama. Ungkapan terima kasih akhir akan disertakan dengan persetujuan eksplisit dari setiap individu, memastikan pengakuan mereka penuh hormat, akurat, dan selaras dengan prinsip-prinsip etika bersama dari karya ini.

Navigasi, indeks referensi cepat

Daftar bab dan lampiran:

- 1 - Pendahuluan: kekerasan, pemaksaan, dan kerangka struktural
- 2 - Kerangka metodologis: penelitian aksi dan posisi
- 3 - Temuan survei: pola, persepsi, dan praktik kejiwaan
- 4 - Penelitian lapangan dan kesaksian: struktur pengkhianatan yang hidup
- 5 - Sintesis analitis: logika kelembagaan dan perlawanan
- 6 - Dimensi hukum dan etika: norma, pelanggaran, dan akuntabilitas
- 7 - Pekerjaan yang sedang berlangsung dan langkah selanjutnya: satu kesehatan, pedagogi, dan sistem berbasis hak
- 8 - Kesimpulan akhir: kontribusi ilmiah dan desain ulang sistemik

Referensi

- A - Instrumen yang digunakan dalam penelitian aksi partisipatoris ini
- B - Etika penelitian kualitatif dalam psikologi
- C - *Perbatasan dalam Psikologi*: implementasi dialog terbuka di Spanyol
- D - Agresivitas xenofobia
- E - Efek nocebo dan psikiatri: sindrom menyerah dan somatisasi sosiomedis
- F - Bab buku *Nature-Springer* tentang alternatif dari pemaksaan
- G - Prosiding tentang penyalahgunaan politik terhadap psikiatri
- H - Ringkasan saran kebijakan disertasi
- I - Perangkat diseminasi media
- J - Proposal horizon sebagai langkah selanjutnya

- K - Persetujuan etika
- L - Tabel dan gambar tambahan

- I. Indeks dan pemetaan tematik
- II. Daftar istilah, singkatan dan akronim

Indeks navigasi dan terperinci dengan bagian-bagiannya

Bab 1. Kerangka kerja umum dan batasan penelitian

- 1.1. Latar belakang historis-struktural singkat: perawatan, pemaksaan dan pemerintahan di Spanyol
- 1.2. Kerangka kerja saat ini: intervensi psikiatri yang dipaksakan dan akuntabilitas kelembagaan
- 1.3. Pengobatan berlebihan dan farmakosentrisme dalam perawatan kesehatan dan psikiatri di Spanyol
- 1.4 Menuju manajemen pengobatan yang otonom dan praktik-praktik yang lebih baik berbasis bukti
- 1.5 Landasan hukum, epistemik, dan ilmiah dari masalah penelitian
- 1.6 Kegagalan sistemik, kekerasan struktural, dan tantangan reformasi
- 1.7 Landasan teoritis: kekuasaan, diagnosis, pengucilan, dan perlawanan
- 1.8 Kerangka analisis dan metodologi ilmiah untuk perubahan struktural

Bab 2 - Kerangka metodologis: penelitian aksi dan posisi

- 2. Meta-metodologi reflektif dan kerangka kerja metodologis ilmiah
- 2.1 Pendekatan secara keseluruhan dan dasar-dasar metodologis

- 2.2 Desain campuran dan multi-skala, triangulasi data dan temuan
- 2.3 Instrumen dan infrastruktur pengumpulan data
- 2.4 Strategi lapangan dan lokasi pengamatan
- 2.5 Protokol etika dan dilema metodologis
- 2.6 Integrasi data dan logika analitis
- 2.7 Keterbatasan, kondisi yang merugikan, dan validitas ilmiah
- 2.8 Kontribusi metodologis terhadap ilmu pengetahuan terbuka yang transformatif
- 2.9 Meta-metodologi refleksif dan protokol ilmiah untuk konstruksi disertasi

Bab 3. Temuan survei: pola, persepsi, dan praktik kejiwaan

- 3. Pengantar presentasi hasil survei
 - 3.1 Pendahuluan: Arsitektur dan Tujuan Survei Terpadu
 - 3.2 Metodologi: instrumen, sampel, dan logika triangulasi
 - 3.3 Paksaan yang dirasakan dan kekerasan institusional
 - 3.4 Kendala Etis dan Disonansi Klinis
 - 3.5 Kepercayaan, komunikasi, dan kerusakan relasional
 - 3.6 Pengambilan keputusan bersama dan otonomi pengobatan
 - 3.7 Hambatan struktural dan pengkhianatan institusional
 - 3.8 Tuntutan dan usulan dari responden
 - 3.9 Implikasi ilmiah dan analitis

Bab 4 - Kerja Lapangan dan Kesaksian: Struktur Pengkhianatan yang Dihidupi

- 4. Pendahuluan dan posisi
 - 4.1 Kesenambungan dan ruang lingkup metodologis
 - 4.2 Pengaturan kerja lapangan dan implementasi metodologis

- 4.3 Siklus kekerasan institusional: kontrol dan keterlibatan kejiwaan
- 4.4 Pengkhianatan keluarga dan kontinum rumah tangga-kelembagaan
- 4.5 Penghapusan epistemik dan hilangnya kepribadian
- 4.6 Pemulihan melawan sistem: perlawanan, navigasi, dan harapan
- 4.7 Bukti berbasis lapangan tentang pola dan urgensi sistemik

Bab 5 - Sintesis analitis

5. Pendahuluan

- 5.1 Normalisasi budaya pemaksaan dan transisi yang terhambat ke perawatan pencegahan
- 5.2 Erosi subjektivitas dan kegagalan untuk memberikan perawatan perkembangan yang personal
- 5.3 Pengabaian struktural: marginalisasi sosial dan penghancuran kehidupan
- 5.4 Kerusakan medis dan defisit pendidikan: sistem yang memberi obat, bukannya mengajar atau menyembuhkan
- 5.5 Jalan menuju kedaulatan kesehatan bersama dan konvergensi ilmiah-etis

Bab 6 - Dimensi hukum dan etika: norma, pelanggaran, dan akuntabilitas

6. Pendahuluan - legalitas perawatan paksa sebagai standar

- 6.1 Konteks hukum nasional: jaminan formal dan kesenjangan operasional
- 6.2 Hukum hak asasi manusia internasional dan standar kesehatan jiwa
- 6.3 Sintesis dan proposal untuk pemulihan sistemik

Bab 7 - Diskusi dan langkah selanjutnya: satu kesehatan, trauma-informed, berorientasi pada pemulihan, pedagogi pencegahan, dan sistem berbasis hak

7. Pendahuluan - diskusi reflektif tentang tugas-tugas struktural ke depan

- 7.1 Dari Diagnosis Struktural ke Komitmen Sistem
- 7.2 Model klinis berbasis hak: pengambilan keputusan, dialog, dan ketepatan
- 7.3 Pendidikan sebagai infrastruktur: kurikulum, pedagogi, dan pembelajaran berbasis peran

Bab 8 - Kesimpulan akhir: kontribusi ilmiah dan desain ulang sistemik

Indeks tabel

Tabel 1. Keselarasan antara tujuan utama disertasi dan pertanyaan penelitian operasional

Tabel 2. Tujuan biologis dan strategi implementasi

Tabel 3. Tujuan biologis dan strategi implementasi Tujuan psikologis dan strategi implementasi

Tabel 4. Tujuan sosial dan strategi implementasi Tujuan Sosial dan Strategi Implementasi

- Tabel 5. Praktik-praktik yang merugikan, penyebab struktural, dan implikasi reformasi
- Tabel 6. Kegagalan sistemik dan mekanisme kerusakan kelembagaan
- Tabel 7. Logika sistemik dari pemaksaan kejiwaan dan pengobatan berlebihan
- Tabel 8. Logika sistemik pemaksaan psikiatri dan pengobatan berlebihan Empat tingkat analisis dan integrasi dalam arsitektur penelitian
- Tabel 9. Dimensi biologis dari kerangka kerja analitis dan terapan
- Tabel 10. Dimensi psikologis dari kerangka kerja analitis dan terapan
- Tabel 11. Dimensi sosial dari kerangka kerja analitis dan terapan
- Tabel 12. Dimensi kunci WHO QualityRights dalam transformasi sistem kesehatan jiwa
- Tabel 13. Antropologi medis dan kekerasan struktural
- Tabel 14. Penelitian aksi dan penyelidikan partisipatoris
- Tabel 15. Keadilan epistemik dan inklusi pengetahuan
- Tabel 16. Evaluasi sistem dan analisis kelembagaan
- Tabel 17. Kerangka kerja psikiatri, nutrisi, metabolisme, dan fisiologi translasional
- Tabel 18. Penyelarasan pertanyaan penelitian dengan tingkat analisis, metode, dan relevansinya
- Tabel 19. Proses validasi dan perlindungan etika untuk tiga survei disertasi
- Tabel 20. Kelompok koordinasi dari penyelidikan terhadap label skizofrenia yang asli, Inggris, 2014
- Tabel 21. Skenario reformasi hipotetis dalam survei 2025, tujuan metodologis
- Tabel 22. Jadwal penelitian terperinci, berdasarkan lokasi dan tahun, 2020
- Tabel 23. Jadwal penelitian terperinci, berdasarkan lokasi dan tahun, 2021
- Tabel 24. Jadwal penelitian terperinci, berdasarkan lokasi dan tahun, 2022
- Tabel 25. Jadwal penelitian terperinci, berdasarkan lokasi dan tahun, 2023
- Tabel 26. Jadwal penelitian terperinci, berdasarkan lokasi dan tahun, 2024
- Tabel 27. Jadwal penelitian terperinci, berdasarkan lokasi dan tahun, 2025
- Tabel 28. Infrastruktur etika yang dikembangkan di bawah kondisi kekerasan struktural
- Tabel 29. Penyelarasan survei terpadu dengan tujuan disertasi dan pertanyaan operasional
- Tabel 30. Temuan empiris dan tanggapan pendidikan dan hukum-politik yang sesuai
- Tabel 31. Dinamika sistemik berbasis survei dan rekomendasi struktural
- Tabel 32. Praktik-praktik pemaksaan yang dilaporkan, pembenaran institusional, dan pembungkaman pengalaman di seluruh kelompok responden

- Tabel 33. Penjelasan konvergen tentang disonansi etika dalam praktik kejiwaan
- Tabel 34. Manifestasi kerusakan relasional dan erosi kepercayaan dalam praktik psikiatri
- Tabel 35. Hambatan dan faktor pendukung yang dilaporkan untuk manajemen pengobatan bersama
- Tabel 36. Hambatan struktural dan pengkhianatan institusional dalam praktik kejiwaan
- Tabel 37. Rangkuman tuntutan responden di seluruh kelompok survei
- Tabel 38. Jalur translasi untuk reformasi psikiatri berdasarkan bukti tesis
- Tabel 39. Temuan empiris dan proposal pendidikan dan hukum-politik yang sesuai
- Tabel 40. Dinamika sistemik berbasis penelitian lapangan dan rekomendasi struktural
- Tabel 41. Pola-pola kekerasan dan penguatan kejiwaan dalam keluarga-institusional
- Tabel 42. Pola-pola historis dan lintas budaya kekerasan dalam keluarga
- Tabel 43. Perbandingan struktur keluarga dan dampak perkembangannya
- Tabel 44. Mekanisme dan konsekuensi dari depersonalisasi dan dehumanisasi
- Tabel 45. Bentuk-bentuk perlawanan dan pemulihan di luar kendali kejiwaan
- Tabel 46. Klarifikasi kategori medis-epistemik dalam konteks perawatan saat ini
- Tabel 47. Ilmu saraf relasional dan persyaratan pelatihan sistemik
- Tabel 48. Konsekuensi fisiologis dari pengabaian dan pemaksaan
- Tabel 49. Mekanisme pelecehan dan penyembunyian struktural, pengkhianatan institusional
- Tabel 50. Kondisi-kondisi untuk pengasuhan yang sesuai hukum dan berbasis hak: dari kepatuhan hingga tindakan etis

Panduan pembaca untuk memfasilitasi perkuliahan

Disertasi doktoral ini disusun sebagai etnografi transdisipliner tentang paksaan psikiatri dan pengkhianatan institusional, yang didasarkan pada teori biokultural dan penelitian tindakan. Tesis ini mencerminkan investigasi selama lima tahun terhadap kekerasan sistemik dalam sistem kesehatan jiwa, terutama di Spanyol, dengan refleksi komparatif dari penelitian lapangan internasional dan

jaringan penelitian global. Tesis ini mengintegrasikan narasi, hukum, klinis, dan metodologis, namun kekuatan utamanya terletak pada sintesis empiris dari pengalaman langsung, observasi lapangan, dan kesaksian yang terdokumentasi. Disertasi ini meneliti proses pengambilan keputusan dan manajemen pengobatan yang otonom, serta persepsi mereka dalam konteks kesehatan mental di Spanyol. Dari titik awal ini, penelitian ini menyelidiki realitas yang meluas tentang pengobatan berlebihan dan perawatan paksaan, fenomena yang muncul sebagai fitur struktural daripada pelanggaran yang terisolasi. Kesaksian dan pengalaman hidup yang dikumpulkan selama penelitian ini muncul dari proses kerja lapangan yang terlibat dan partisipatif di mana peneliti berkontribusi secara aktif dalam jaringan komunitas, mendukung penerjemahan dan penyebaran materi penting ke dalam bahasa Spanyol, dan memfasilitasi ruang untuk saling belajar dan advokasi. Alih-alih mengambil peran sebagai pengamat, peneliti berkolaborasi dengan individu dan kolektif yang terkena dampak, memberikan kesaksian tentang bahaya kumulatif yang dihasilkan dalam sistem kesehatan mental. Kerugian iatrogenik ini melampaui intervensi farmakologis dan mencakup rawat inap paksa, isolasi, dan erosi sistematis terhadap otonomi, serta marjinalisasi, pembungkaman, dan pengucilan sosial yang terus menerus terjadi di luar lingkungan institusional dan memperdalam penderitaan mereka. Menyaksikan penderitaan orang lain, seperti mengamati teman sebaya yang mengalami pengekangan, pembiusan, atau pengabaian, menciptakan trauma kolektif dan relasional yang memperkuat atmosfer ketakutan, keputusan, dan pengabaian. Bentuk-bentuk kekerasan yang saling beririsan ini tidak hanya berkontribusi pada penderitaan individu, tetapi juga pada kematian sosial yang lebih luas, di mana sistem yang dimaksudkan untuk memberikan perawatan justru melanggengkan siklus bahaya dan pengucilan.

Karya ini dibagi dalam beberapa bab berikut:

1 - Pendahuluan: kekerasan, pemaksaan, dan kerangka struktural. Bab ini memperkenalkan premis-premis tematik dan analitik dari disertasi ini, dengan fokus pada karakter struktural dari pemaksaan kejiwaan, erosi otonomi, dan pengucilan epistemik. Bab ini membingkai penelitian dalam urgensi yang lebih luas dari reformasi sistem kesehatan yang didasarkan pada hak asasi manusia, etika ilmiah, dan keadilan.

2 - Kerangka metodologis: penelitian aksi dan posisi. Menguraikan desain penelitian biokultural dan penelitian aksi yang mendasari penelitian ini. Ini merinci perangkat metodologis, survei, kesaksian, etnografi, sambil memposisikan penulis sebagai peneliti-penyintas dan merefleksikan implikasi etis, epistemologis, dan struktural dari pengetahuan yang tersituasikan.

3 - Temuan survei: pola, persepsi, dan praktik kejiwaan. Menyajikan hasil survei nasional dan transnasional dengan para profesional, pengguna, dan pemangku kepentingan. Temuan menyoroti persepsi yang berlaku tentang pemaksaan, norma klinis, dinamika kepercayaan, dan disfungsi sistemik dalam praktik kejiwaan.

4 - Penelitian lapangan dan kesaksian: struktur pengkhianatan yang hidup. Mendokumentasikan observasi partisipan yang diperluas dan kesaksian mendalam di seluruh lingkungan institusional, profesional, dan keluarga. Bab ini menyoroti lintasan-lintasan kekerasan kejiwaan, keterlibatan, pembungkaman, dan munculnya perlawanan serta pemulihan yang terjadi.

5 - Sintesis analitis: logika institusional dan perlawanan. Mengintegrasikan temuan-temuan dari semua sumber empiris untuk memeriksa struktur institusional dan diskursif yang mendasari pemaksaan. Hal ini menginterogasi legitimasi medis atas bahaya, penghapusan pengetahuan yang terkandung, dan ruang-ruang penolakan dan kekuatan kontra.

6 - Dimensi hukum dan etika: norma, pelanggaran, dan akuntabilitas. Memberikan analisis pengantar tentang kerangka kerja hukum dan normatif yang relevan, menyoroti peran mereka dalam memungkinkan atau gagal mencegah kekerasan kejiwaan. Bab ini berfungsi sebagai titik acuan etis, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia konstitusional dan internasional.

7 - Pekerjaan yang sedang berlangsung dan langkah selanjutnya: satu kesehatan, pedagogi, dan sistem berbasis hak. Mengusulkan strategi konkret untuk implementasi melalui pengambilan keputusan bersama, manajemen pengobatan kolaboratif, ilmu pengetahuan terbuka, dan pedagogi transformatif. Bab ini mengartikulasikan peta jalan inklusif yang didasarkan pada martabat, keadilan, kesehatan planet, dan perbaikan epistemik.

8 - Kesimpulan akhir: kontribusi ilmiah dan desain ulang sistemik. Mensintesis kontribusi ilmiah, etika, dan politik dari disertasi. Hal ini menegaskan kembali tanggung jawab produksi pengetahuan untuk membongkar sistem pelecehan dan menyerukan konfigurasi ulang yang mendesak dari layanan psikiatri sebagai bagian dari transformasi struktural yang lebih luas.

Lampiran A merinci instrumen yang dikembangkan dan diterapkan dalam proses penelitian aksi partisipatif. Lampiran ini mendokumentasikan dasar pemikiran, desain kolaboratif, fokus pengalaman, dan strategi integrasi yang digunakan untuk menyusun dan memvalidasi survei dalam kerangka kerja penelitian yang berbasis hak dan berbasis penyintas.

Lampiran B memperkenalkan dasar-dasar etika penelitian psikologis kualitatif. Lampiran ini mengeksplorasi implikasi metodologis dari bekerja dalam kondisi kerentanan struktural dan asimetri epistemik, dengan penekanan pada posisi, pengurangan dampak buruk, persetujuan berdasarkan informasi, dan integritas penelitian.

Lampiran C mereproduksi artikel peer-review yang diterbitkan di *Frontiers in Psychology* tentang implementasi dialog terbuka di Spanyol. Artikel tersebut menyoroti hambatan institusional, ketegangan etis, dan potensi transformatif dari praktik dialogis dalam sistem yang sebagian besar bersifat koersif.

Lampiran D berisi naskah yang menganalisis xenofobia sebagai sebuah struktur agresif yang bersinggungan dengan kesalahan diagnosis kejiwaan dan bahaya rasial. Naskah ini mengontekstualisasikan pengucilan epistemik, dampak somatik, dan diskriminasi struktural dalam pola-pola kekerasan yang dilembagakan yang lebih luas.

Lampiran E menyajikan analisis transdisipliner tentang efek nocebo dan sindrom menyerah, yang mengacu pada psikiatri transkultural dan biologi yang diwujudkan. Analisis ini membongkar penderitaan psikosomatis kronis sebagai produk dari gangguan sosiomedis, mengusulkan model penjelasan yang lebih manusiawi.

Lampiran F menawarkan sebuah bab buku yang diterbitkan oleh *Nature-Springer* tentang alternatif-alternatif dari pemaksaan. Bab ini membahas etika dialogis, kepemimpinan pengguna layanan, aliansi terapeutik, dan reformasi sistemik melalui pendekatan berbasis bukti, berbasis hak, dan berpusat pada orang.

Lampiran G mendokumentasikan presentasi yang disampaikan pada konferensi internasional tahun 2023 tentang penyalahgunaan politik psikiatri. Ini merupakan sintesis dari kesaksian ahli dan analisis kasus komparatif, yang membahas penindasan institusional, penyalahgunaan psikiatri forensik, dan pelanggaran sistemik.

Lampiran H menerjemahkan temuan-temuan inti dari disertasi ini ke dalam ringkasan kebijakan yang terstruktur. Ringkasan ini mengusulkan sebuah peta jalan untuk reformasi berdasarkan bukti hukum, klinis, dan ilmiah, yang selaras dengan perlindungan konstitusional dan norma-norma hak asasi manusia internasional.

Lampiran I berisi perangkat diseminasi media yang disiapkan untuk memastikan visibilitas publik yang luas atas temuan-temuan disertasi. Hal ini mencakup materi visual, strategi pers, dan alat komunikasi untuk penerjemahan pengetahuan dan penjangkauan akses terbuka.

Lampiran K menguraikan proposal Horizon Europe yang dikembangkan sebagai perpanjangan langsung dari penelitian ini. Lampiran ini menjelaskan logika implementasi, aliansi kolaboratif, dan relevansi kebijakan dari intervensi berbasis satu kesehatan yang diajukan untuk mendapatkan pendanaan dari Eropa.

Lampiran J menyajikan tabel tambahan, tentang konteks sejarah, budaya dan biomedis dari tesis ini

Pembaca disarankan untuk mendekati karya ini sebagai kontribusi ilmiah formal dan intervensi yang digerakkan oleh kesaksian yang bertujuan untuk mengubah praktik-praktik kelembagaan yang berbahaya. Bahasa yang digunakan terkadang sangat keras, sebuah pilihan yang disengaja untuk merefleksikan beratnya dan bertahannya pelanggaran yang didokumentasikan. Meskipun tidak semua bab membahas perkembangan hukum atau komputasi secara menyeluruh, disertasi ini mempertahankan integritas metodologis dan koherensi konseptual untuk mencapai tujuan emansipatorisnya. Disertasi ini muncul dari kondisi kekerasan institusional yang ekstrem, pelecehan interpersonal yang berkelanjutan, dan pengabaian sistemik, yang secara langsung dialami oleh penulis dan dikuatkan oleh tragedi-tragedi yang dapat dicegah yang masih terus berlangsung di dalam rezim kejiwaan kontemporer. Buku ini menawarkan sebuah etnografi ilmiah tentang pemaksaan, pengkhianatan, dan ketidakadilan struktural dalam sistem kesehatan jiwa, dengan mengambil Spanyol sebagai tempat penelitian utama, dengan wawasan komparatif dari konteks internasional. Dipandu oleh metodologi penelitian biokultural dan penelitian tindakan, penelitian ini menginterogasi keterikatan intervensi farmakologis yang dipaksakan, kesewenang-wenangan diagnostik, dan ketidakberdayaan sistemik. Penelitian ini mendokumentasikan bagaimana mekanisme psikiatris dan birokratis, yang sering kali terselubung dalam bahasa klinis atau yuridis, melanggengkan pengucilan, menyebabkan kerusakan iatrogenik, dan mengikis kesinambungan hubungan dan eksistensial.

Korpus empiris mencakup survei metode campuran, dokumentasi klinis dan hukum yang terverifikasi, dan penelitian lapangan etnografi yang ekstensif, semuanya disajikan dengan ketepatan metodologis. Perbedaan yang jelas dipertahankan antara hasil analisis dan kesaksian reflektif. Sementara posisi penulis yang tertanam secara metodologis diaktifkan dalam bab-bab tertentu, temuan-temuan inti mempertahankan landasan pembuktiannya. Struktur ganda ini, yang memadukan penyelidikan sistematis dengan kritik yang sesuai dengan situasi, memastikan koherensi tematik dan transparansi secara keseluruhan. Lebih dari sekadar investigasi akademis konvensional, disertasi ini merupakan intervensi etis dan politis yang disengaja. Disertasi ini menguraikan jalan yang layak menuju transformasi institusional yang berpijak pada martabat manusia yang tidak dapat dinegosiasikan, keadilan relasional, dan akuntabilitas struktural. Berada dalam kerangka kerja yang lebih luas dari satu kesehatan dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia global, ini menawarkan dasar yang kuat untuk reformasi yang sangat dibutuhkan dalam domain psikiatri, hukum, dan pendidikan.

Untuk mendukung aksesibilitas yang maksimal, versi online dari disertasi ini terus diperbarui dan diperbaiki. Hal ini mencakup terjemahan, modul adaptasi bahasa, dan fitur aksesibilitas untuk keragaman kognitif, sensorik, dan motorik. Repositori ini juga diatur untuk menampung semua alat sumber terbuka yang relevan, serta instrumen yang dikontrol versinya, kerangka kerja pengkodean, dan sumber daya analitik, termasuk bahan ajar terbuka, daftar pemeriksaan realitas, penelitian, protokol medis dan administratif, dan sumber daya lainnya untuk lebih memudahkan implementasi dan perbaikan terus-menerus. Arsip hidup tersebut, yang tidak termasuk dalam file ini, dirancang untuk melayani beragam publik dan jaringan kolaboratif yang berkomitmen pada keadilan, penyembuhan, dan perubahan sistemik.

Baik panduan ini maupun peta, mengarah ke masa depan.

Dampak Sosial dari Tesis

Disertasi ini menghasilkan kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan masyarakat, praktik klinis, tata kelola hukum, dan desain sistem sosial yang adil. Disertasi ini mendokumentasikan dan menganalisis bagaimana praktik psikiatri yang bersifat koersif, khususnya rutinisasi pengobatan non-konsensual dan diagnostik yang melampaui batas, membahayakan hasil kesehatan individu, mengurangi akuntabilitas profesional, dan merusak integritas struktural sistem kesehatan mental. Praktik-praktik ini tidak hanya melanggar standar etika dan pedoman klinis, tetapi juga menimbulkan kerugian kronis yang berdampak pada individu, keluarga, komunitas, dan institusi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemaksaan dan pengobatan berlebihan yang berkelanjutan menghasilkan gejala sisa fisiologis, psikologis, relasional, dan hukum jangka panjang. Ini termasuk komorbiditas yang disebabkan oleh pengobatan, kecacatan iatrogenik, kapasitas kognitif dan afektif yang melemah, kemerosotan kepercayaan terhadap layanan kesehatan, dan penonaktifan sosial seluruh kelompok melalui ketidakmampuan administratif dan pengucilan simbolis. Disertasi ini menawarkan bukti baru untuk mendukung reformasi sistemik yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya yang terkait dengan memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (tabel 1), mencapai kesetaraan gender, mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara, mempromosikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil (tabel 2), dan membangun institusi yang damai dan adil yang memberikan akses ke keadilan dan melindungi hak-hak dasar (tabel 3).

Tabel 1. Dimensi biologis: kesehatan fisik, praktik pengobatan, dan hasil fisiologis

SDG	Judul Tujuan	Relevansi dengan Disertasi
2	Mengakhiri Kelaparan	Menekankan pada efek metabolik, nutrisi, dan somatik dari pengobatan psikotropika, terutama dalam konteks pengabaian kebutuhan diet.
3	Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	Inti dari tesis ini. Mempromosikan perawatan yang berbasis hak dan efektif secara klinis untuk mengurangi bahaya iatrogenik dan mengoptimalkan hasil kesehatan fisiologis.
6	Air Bersih dan Sanitasi	Mengatasi risiko kesehatan lingkungan yang terkait dengan limbah farmasi dari resep berlebihan kronis dalam sistem kejiwaan.
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Mengadvokasi penggunaan farmakologis yang rasional, depreskripsi, dan evaluasi bahaya terkait obat dalam layanan psikiatri.
13	Aksi Iklim	Mempromosikan sistem perawatan kesehatan yang berkelanjutan yang tangguh terhadap krisis ekologi dan farmasi, dengan memperhatikan kerentanan biologis.

Tabel ini menyajikan SDGs yang bersinggungan dengan aspek biologis dari perawatan psikiatri, termasuk efek fisiologis dari pengobatan psikotropika, kesehatan metabolik, kontaminasi lingkungan melalui limbah farmasi, dan implikasi biologis dari pengobatan yang berlebihan dan integrasi gizi yang buruk dalam sistem kesehatan jiwa.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa paksaan psikiatri harus dipahami sebagai penyebab bahaya yang dapat diukur secara medis dan sosial. Hal ini berkontribusi pada timbulnya dan memburuknya penyakit somatik, meningkatkan faktor risiko bunuh diri, dan berkontribusi pada erosi kondisi dasar kesehatan, termasuk stabilitas hubungan, perlindungan hukum, dan pelestarian otonomi tubuh. Kerugian ini sering kali terkonsentrasi di antara orang-orang yang sudah terpapar kerugian kumulatif.

Perempuan, anak di bawah umur, penyintas trauma, orang yang hidup dalam kemiskinan, dan populasi rasial atau migran secara tidak proporsional menjadi sasaran pengobatan paksa, patologisasi, dan pengabaian institusional (tabel 2). Praktik-praktik ini lebih banyak menyembunyikan daripada mengatasi faktor penentu material dan relasional dari kesusahan. Alih-alih menerima perlindungan, dukungan, atau akses ke layanan sosial, individu-individu disalurkan ke dalam sistem kejiwaan di mana pengalaman mereka dibingkai ulang sebagai gangguan, dan posisi hukum dan kewarganegaraan mereka semakin terkikis. Konsekuensinya termasuk kehilangan hak asuh anak, memburuknya kesehatan fisik akibat polifarmasi, rusaknya jaringan sosial, dan pengucilan yang terus-menerus dari sistem pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Disertasi ini mengidentifikasi mekanisme-mekanisme ini sebagai bentuk kematian sosial yang dapat diukur, yang ditandai dengan ketidaktampakan administratif, penghapusan narasi, dan hilangnya kendali atas jalur medis dan hukum seseorang.

Tabel 2. Dimensi psikologis: otonomi mental, identitas, pemulihan, dan pengetahuan profesional

SDG	Judul Tujuan	Relevansi dengan Disertasi
3	Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	Memprioritaskan model yang berorientasi pada pemulihan yang mempertahankan identitas naratif, agensi hukum, dan regulasi emosional.
4	Pendidikan Berkualitas	Mendukung pendidikan psikiatri berbasis trauma, literasi pasien, dan praktik profesional yang reflektif.
5	Kesetaraan Gender	Mengatasi konsekuensi psikologis dari kekerasan berbasis gender dan kebutuhan akan pendekatan diagnostik dan terapeutik yang peka terhadap gender.
8	Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Berfokus pada pemulihan hak atas pekerjaan dan mengurangi pengucilan secara psikiatrik dari angkatan kerja melalui pemberdayaan dan reintegrasi.

Tabel ini mengidentifikasi SDG yang relevan dengan domain psikologis, dengan fokus pada otonomi, identitas, pemulihan trauma, akses pendidikan bagi para profesional dan pasien, serta pemulihan hak-hak pribadi melalui praktik kejiwaan yang diinformasikan secara etis.

Selain dimensi klinis dan hukum, disertasi ini juga mengedepankan pentingnya intervensi sosial sebagai prasyarat untuk kesehatan mental. Tempat tinggal yang aman, nutrisi yang memadai, keamanan ekonomi, dan kesinambungan relasional disajikan bukan sebagai masalah tambahan tetapi sebagai komponen utama dari perawatan kejiwaan. Kesehatan jiwa tidak dapat dipisahkan dari kondisi yang menopang kehidupan. Dalam hal ini, tesis ini berkontribusi pada artikulasi paradigma medis yang kompeten secara struktural, terintegrasi secara ekologis, dan peka terhadap distribusi kekuasaan dan sumber daya. Tesis ini berargumen bahwa pencegahan krisis kejiwaan, kronisitas, dan bunuh diri tidak hanya bergantung pada manajemen farmakologis, tetapi juga pada penerapan kebijakan publik lintas sektoral yang menangani kekurangan struktural. Penelitian ini mendukung pembangunan sistem pengasuhan yang memprioritaskan perlindungan dini terhadap anak-anak, dukungan berkelanjutan untuk pengasuh, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan institusional. Penelitian ini menekankan bahwa tanpa perlindungan pada masa kanak-kanak, dan tanpa kapasitas institusi untuk mendeteksi dan menanggapi kekerasan dan penelantaran pada tahap awal, eskalasi penderitaan menjadi penyakit yang dapat didiagnosis akan menjadi hal yang normal.

Hal ini bukan hanya merupakan kegagalan psikiatri, tetapi juga kegagalan pengobatan dan tata kelola secara luas.

Kerangka kerja penelitian tindakan yang diterapkan dalam tesis ini menunjukkan bahwa model perawatan alternatif; berdasarkan pengambilan keputusan bersama, pemberian obat secara bertahap dan aman, evaluasi etis terhadap praktik, dan reintegrasi pengguna sebagai agen pengetahuan; dapat mengurangi bahaya, mencegah ketergantungan institusional, dan meningkatkan kualitas hidup jangka panjang bagi pasien dan keluarga. Model-model ini meningkatkan hasil klinis, mengurangi beban layanan gawat darurat dan rawat inap, serta berkontribusi pada alokasi sumber daya medis dan sosial yang rasional. Model-model ini mempromosikan praktik perawatan berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi biologis, psikologis, hukum, dan budaya kesehatan, sejalan dengan prinsip-prinsip sistem kesehatan yang berorientasi pada pencegahan, kesinambungan perawatan, dan kerja sama antar sektor. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penerapan kerangka kerja dialogis, yang didukung oleh perlindungan hukum dan transparansi kelembagaan, dapat menciptakan kondisi di mana layanan kesehatan jiwa bukanlah tempat untuk mengontrol dan mengurung, melainkan tempat untuk pemulihan, partisipasi, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Tabel 3. Dimensi sosial: struktur hukum, desain kelembagaan, ketidaksetaraan, dan inklusi relasional

SDG	Judul Tujuan	Relevansi dengan Disertasi
1	Tanpa Kemiskinan	Menunjukkan bagaimana kekurangan dibingkai ulang sebagai penyakit, dan bagaimana dukungan ekonomi sangat penting untuk mengurangi pemaksaan dan pengucilan.
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Mendukung infrastruktur etis untuk tata kelola kesehatan jiwa, termasuk perangkat sumber terbuka untuk memantau pemaksaan.
10	Mengurangi Ketidaksetaraan	Mendokumentasikan bagaimana pemaksaan secara tidak proporsional menargetkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dan mengusulkan reformasi struktural untuk akses dan perlakuan yang adil.
11	Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan	Mengadvokasi layanan kesehatan jiwa komunitas terpadu yang mencakup perumahan, jaringan perawatan, dan partisipasi masyarakat.
16	Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat	Inti dari tesis ini. Mempromosikan perlindungan hukum, akuntabilitas kelembagaan, dan perlindungan dari pelecehan kejiwaan.
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Menekankan kolaborasi transdisipliner dan penyintas-pengguna dalam desain, implementasi, dan tata kelola layanan.

Tabel ini menguraikan SDGs yang berhubungan dengan struktur sosial yang membentuk pengalaman kejiwaan, termasuk akuntabilitas hukum, langkah-langkah anti-kemiskinan, pengurangan ketidaksetaraan sistemik, pembangunan infrastruktur untuk perawatan yang adil, dan penciptaan lembaga-lembaga partisipatif yang mampu melindungi hak asasi manusia dan inklusi sosial.

Dampak sosial dari disertasi ini (tabel 3) terletak pada kemampuannya untuk menginformasikan reformasi struktural di seluruh sistem medis, hukum, dan kebijakan. Disertasi ini menyediakan alat

empiris dan konseptual untuk pembelajaran institusional, mendefinisikan kembali tanggung jawab psikiatri, dan memajukan kerangka kerja klinis dan etis di mana kesehatan dipahami sebagai kondisi relasional dan kolektif. Hal ini menganalisis faktor penentu berlapis dari kerusakan yang dapat dicegah dan kematian dini, termasuk kematian yang berhubungan dengan zat, penyakit iatrogenik, dan hilangnya fungsi. Menolak model reduksionis yang mengisolasi penderitaan dari konteks strukturalnya, penelitian ini membangun sebuah analisis terpadu yang didasarkan pada antropologi medis, ilmu pengetahuan kognitif, dan penalaran hukum. Penelitian ini membedakan penyebab langsung seperti perampasan, perawatan paksa, dan kerusakan lingkungan dari kegagalan yang lebih dalam dalam tata kelola, legitimasi, dan pengakuan epistemik. Berdasarkan data etnografi dan survei, disertasi ini merumuskan kerangka kerja translasi untuk identifikasi dan koreksi disfungsi sistemik dari pengetahuan mutakhir dan kesaksian para ahli, dari laporan langsung dan profesional. Kerangka kerja ini mendukung inisiatif EU BEACON One Health Education tentang pendidikan bayi untuk masa depan yang berkelanjutan melalui teknologi baru, menawarkan model terapan untuk koordinasi interdisipliner, reformasi berbasis hak, dan pemulihan kesehatan sebagai keharusan global yang bersifat struktural dan etis.

Biografi singkat peneliti

Penulis disertasi ini (ini/itu, menunjukkan dehumanisasi dan pengkhianatan yang diderita di tangan atau pelaku kekerasan berat, yang menganggap hidupnya lebih buruk daripada sampah dan gangguan yang harus dipukuli dan dibuang) adalah seorang profesor universitas dan dokter-ilmuwan dalam pelatihan, yang saat ini sedang melakukan penelitian doktoral di Pusat Penelitian Antropologi Medis Universitat Rovira i Virgili, Spanyol. Pendidikan akademisnya mencakup ilmu saraf, antropologi biologi dan evolusi, genetika kejiwaan, dan pendekatan dialogis terhadap kesehatan mental.

Universitas ini memiliki gelar pascasarjana dalam bidang kesehatan mental kolektif dan keanekaragaman manusia dan merupakan penerima hibah unggulan yang sangat kompetitif yang diberikan oleh Kementerian Universitas Spanyol untuk para profesor universitas yang sedang dalam pelatihan. Penelitiannya mengintegrasikan perspektif biomedis, hukum, dan etnografi untuk mengatasi ketegangan inti antara paksaan, otonomi, dan pemulihan dalam perawatan kejiwaan. Sebelum memulai proyek doktoral ini, sebagai mahasiswa sarjana ilmu saraf dan sistem cerdas, ia memperoleh paparan langsung ke sistem biomedis sebagai peserta dalam dua uji klinis fase 0 untuk mencari nafkah dan mendanai studinya, termasuk tindak lanjut rawat inap, yang bertujuan untuk memahami infrastruktur dan epistemologi pengujian farmakologis manusia dari dalam.

Perjalanan kariernya menggabungkan pelatihan ilmiah tingkat lanjut dengan keterlibatan awal dan berkelanjutan dalam penelitian hukum internasional, termasuk bekerja di Stanford Center for Legal Informatics (CodeX) sebagai kontraktor, Graduate Institute of International and Development Studies di Jenewa, dan University of Arizona College of Law. Penelitian sebelumnya berfokus pada bias kognitif, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, dan dinamika sosial politik sistem arbitrase. Baru-baru ini, ia berkontribusi pada penelitian genomik psikiatri di FIDMAG Hermanas Hospitalarias, menyelidiki substrat neurobiologis dari diagnosis seperti skizofrenia pada tingkat master. Berakar pada riwayat keluarga dengan trauma transgenerasi dan didasari oleh kedekatan pribadi dan akademis dengan kekerasan struktural, pendekatannya terhadap psikiatri bersifat kritis namun membumi, tidak berorientasi pada kecaman tetapi pada kejelasan ilmiah dan perbaikan sistemik. Karyanya terbentang di seluruh pengaturan klinis, hukum, dan komunitas, yang melibatkan pengamatan langsung, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi dalam jaringan Eropa dan internasional yang berfokus pada kesehatan mental dan hak asasi manusia. Disertasi ini merupakan kontribusi bagi pengetahuan akademis dan seruan untuk tanggung jawab institusional, menyelaraskan perawatan medis dengan prinsip-prinsip keadilan, martabat, dan pemulihan.

Peneliti dilahirkan dalam sistem kekerabatan yang asimetris secara budaya dan bertingkat secara ekonomi, dengan konfigurasi kekuasaan, etika, dan fungsi sosial yang berlawanan di seluruh garis keturunan orang tua. Garis ibu, yang sebagian besar berasal dari Catalan, secara struktural tertanam dalam sistem pewarisan kelas atas, yang ditandai dengan akses yang berkelanjutan terhadap properti, modal simbolis, dan status sosial yang tidak diperoleh melalui tenaga kerja, tetapi melalui transfer antargenerasi. Dalam situasi ini, superioritas diinternalisasi secara budaya dan sosial, menghasilkan pola otoritas dan hak yang diperkuat oleh identitas regional. Garis keturunan ini menunjukkan strategi pengendalian perilaku yang berulang, termasuk infantilisasi, manipulasi batas, dan induksi ketergantungan strategis, yang dinormalisasi di dalam ranah domestik. Institusi pernikahan, di bawah hukum perdata Spanyol yang bersejarah, memungkinkan kontrol hukum dan ekonomi oleh suami, yang perilaku pascaperkawinannya berubah dari romantisme performatif menjadi dominasi. Kondisi ini secara hukum disetujui di bawah hukum perdata patriarkis yang berlaku sampai reformasi diperkenalkan secara progresif selama akhir 1970-an dan awal 1980-an, yang sebelumnya memberikan otoritas yang tidak proporsional kepada kepala rumah tangga laki-laki atas keputusan yang berkaitan dengan pasangan dan anak.

Sebaliknya, garis keturunan ayah berfungsi dalam paradigma yang berbeda secara struktural. Meskipun tunduk pada kendala ekonomi relatif, namun tetap mempertahankan etika relasional yang

didasarkan pada timbal balik dan pengasuhan. Terlepas dari tekanan peran gender tradisional, kakek-nenek dari pihak ayah mempertahankan dinamika perkawinan yang ditandai dengan saling mendukung dan ketahanan. Meskipun secara sosial kurang beruntung, mereka mempertahankan koherensi relasional, martabat berbasis tenaga kerja, dan praktik pengasuhan pedagogis. Anak laki-laki yang lebih muda, seorang insinyur dengan pelatihan, menunjukkan integritas kognitif dan emosional sebelum intervensi eksternal, mengikuti gaya hidup sehat serta kehidupan sosial yang kaya. Pelabelan psikiatris dan keterlibatan institusional selanjutnya memicu kemunduran yang cepat, tanpa ada lintasan pemulihan yang diamati, konsisten dengan literatur yang ada tentang kerusakan iatrogenik di bawah rezim psikiatris yang memaksa. Kakek dan nenek, terlepas dari kerentanan terkait usia, mencontohkan pengekangan etis dan integritas pengasuhan.

Pola perilaku dalam garis keturunan ibu dicirikan oleh strategi destabilisasi psikologis, induksi ketergantungan terselubung, dan pengalihan tanggung jawab secara sistemik. Anggota yang paling berbeda secara kognitif dan konsisten secara etis, seorang perawat yang telah memenuhi syarat untuk studi medis, dipatologiskan melalui penggunaan instrumental diagnosis kejiwaan. Kasusnya mencontohkan penggabungan perbedaan pendapat dengan gangguan, dan penggunaan pelabelan institusional untuk menetralkan perbedaan fungsional dalam sistem keluarga yang otoriter. Hasil yang berbeda antara garis keturunan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dikondisikan secara struktural oleh distribusi kekuasaan, pengakuan, dan kontrol atas legitimasi naratif.

Paparan awal peneliti terhadap konfigurasi kekerabatan bercabang dua ini, termasuk keluarnya seseorang secara paksa dari rumah tangga sebelum mencapai usia dewasa dan mobilitas internasional berikutnya melalui pernikahan dini dan ekspatriasi, menghasilkan prakondisi yang diperlukan untuk orientasi analisis multiskalar. Perendaman longitudinal dalam konteks sosiokultural yang berbeda, termasuk Chili, Inggris, Prancis, Cina, Swedia, dan beberapa wilayah di Spanyol, memperluas khazanah pengamatan dan memungkinkan analisis sistem komparatif dari tata kelola keluarga, institusionalisme kejiwaan, dan antarmuka hukum-medis. Antropolog, sebagai instrumen ilmiah, tidak terpisah dari lapangan, tetapi merupakan bagian dari matriks relasionalnya. Produksi pengetahuan etnografi didasarkan pada persepsi yang ada, dan bergantung pada kapasitas untuk mendaftarkan dan menafsirkan pola interaksi, makna, dan bahaya di berbagai register indrawi, kognitif, dan afektif. Antropologi, lebih dari disiplin ilmu lainnya, membutuhkan keterlibatan total dari seluruh kemampuan yang dimiliki peneliti. Pengamatan tidak hanya bersifat visual, tetapi juga haptic, auditori, kontekstual, dan yuridis. Instrumen harus dilatih dan dikalibrasi, tidak hanya melalui persiapan akademis, tetapi juga melalui pengalaman terhadap mekanisme yang sedang dianalisis. Dalam kasus ini, instrumen tersebut telah mengalami penyiksaan selama ini, dan masih terus berlanjut. Disertasi ini merupakan contoh pekerjaan di bawah tekanan seperti itu. Peneliti berfungsi secara simultan sebagai pengamat, penyintas, dan analis sistem. Pengetahuan yang dihasilkan tidak hanya bersifat empiris tetapi juga operasional, yang dirancang untuk diterapkan dalam domain hukum, klinis, dan kebijakan. Metodologi penelitian mencerminkan perwujudan penuh, dan kesimpulan yang dihasilkan bukan ekstrapolasi dari jarak, tetapi turunan dari kedekatan, ditriangulasi melalui doktrin hukum, pemetaan institusional, dan bukti etnografi. Dalam ilmu antropologi, integritas instrumen menentukan validitas hasil. Prinsip ini dijunjung tinggi dalam penelitian ini.

Abstrak dalam semua bahasa resmi di Spanyol, dan bahasa-bahasa lain yang paling relevan

Abstrak: Tesis ini berpendapat bahwa sistem psikiatri Spanyol, yang didukung oleh struktur hukum dan administrasi, secara sistematis melanggar otonomi dan martabat individu melalui praktik-praktik pemaksaan dan non-konsensual yang menyamar sebagai perawatan. Diagnosis ditegakkan tanpa

ketelitian empiris, perawatan diberikan tanpa persetujuan yang sah, dan ketidaknyamanan didekontekstualisasi dan dimedikalisasi, menghasilkan kerusakan iatrogenik struktural yang mencegah pemulihan. Akar masalahnya adalah kurangnya implementasi pengambilan keputusan bersama dan penghormatan terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri. Berangkat dari penelitian aksi partisipatif dari perspektif analisis biokultural, penelitian ini mengintegrasikan bukti etnografis, hukum, dan analitis untuk mendokumentasikan mekanisme ini dan mengusulkan alternatif yang berfokus pada hak asasi manusia, pencegahan, dan perawatan kolaboratif. Temuan-temuan ini menguatkan konsensus medis yang ada bahwa perawatan kesehatan yang etis dan efektif, yang juga mencakup kesehatan mental dalam kasus-kasus yang paling serius, haruslah berbasis hak, non-koersif, berorientasi pada pemulihan, personal, dan berdasarkan kepercayaan dan tanggung jawab bersama, bukan kepatuhan.

Ringkasan: Ini adalah argumen bahwa sistem psikologi Spanyol, yang berfungsi untuk membangun struktur hukum dan administrasi, melanggar sistem otonomi dan martabat individu melalui praktik pemaksaan dan tidak ada konsensus dari para masyarakat tentang perhatian mereka. Diagnostik tersebut diterapkan secara empiris, sistem administrasinya memiliki persetujuan yang valid dan bersifat dekontekstualisasi dan medis, menghasilkan struktur iatrogenik yang menghambat pemulihan. Hal ini merupakan tugas pelaksanaan tekanan keputusan bersama dan menghormati hak penentuan otomatis. Memasukkan penyelidikan-penyelidikan partisipatif dari analisis penting biokultural, meminta tiga bukti integrasi etnografi, hukum, dan analitis untuk mekanisme dokumenter dan mengusulkan alternatif-alternatif yang dilakukan di pusat-pusat manusia, pencegahan dan kolaborasi. Masalah-masalah tersebut memperkuat konsensus medis yang ada bahwa perawatan sanitasi yang efektif dan efektif, yang juga termasuk memberi salam mental pada kasus-kasus yang lebih besar, telah menjadi sangat lemah, tidak ada paksaan, berorientasi pada pemulihan, personalisasi dan berdasarkan kepercayaan, dan tanggung jawab bersama, bukan dalam penyerahan.

Kesimpulan : Argumen ini menegaskan bahwa sistem psikiatri Spanyol, yang diatur oleh struktur yuridis dan administratif, secara sistematis melanggar otonomi dan martabat individu dalam proses pemaksaan dan tidak ada konsensus yang tidak mendapat perhatian. Diagnosis menerapkan ketegasan yang tegas, perlakuan diberikan dengan persetujuan yang sah dan masalahnya bersifat kontekstual dan medis, menghasilkan struktur iatrogenik yang mendorong pemulihan. Dalam masalah ini, ada kekurangan dalam pengambilan keputusan yang menekan keputusan yang diambil secara parsial dan penghormatan terhadap hak untuk melakukan pemusnahan. Didukung oleh investigasi partisipatif dari sebuah kapal analisis biokultural, bola ini mengintegrasikan berbagai pendekatan etnografi, yuridis, dan analitis untuk mendokumentasikan mekanisme ini dan mengusulkan berbagai alternatif yang disukai oleh prinsip-prinsip utama yang dipegang teguh oleh manusia, pencegahan, dan perhatian kolaboratif. Bola-bola ini menguatkan konsensus medis yang ada berdasarkan pada perhatian yang efektif dan efisien, yang juga mencakup perlindungan mental dalam kasus-kasus yang paling serius, yang telah dipegang teguh di atas hak-hak, bukan paksaan, berorientasi pada pemulihan, personalisasi, dan dukungan terhadap kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan, bukan pada tugas.

Laburpena: Espainiako sistema psikiatrikoaren argudioa, egitura juridikoen eta administratiboen babesa, otonomaren sistema urratzea eta pertsonen duintasunari buruzko koerzitiboen praktikaren

bidez eta arretarako adostasunik ez duten emmascaratzeen bidez. Zentzumen zorroztasun enpirikoa inposatzen dute diagnostikoek, tratamenduak zentzumenaren adostasuna administratzen dute, malestarren deskontekstualizazioa eta medikuntzaren ondorioz, errekupeazioa eragozten duten egitura iatrogeniko bat ekoizten dute. Perusahaan telah menetapkan bahwa pelaksanaan keputusan yang telah diambil harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghormati hak untuk mengambil keputusan sendiri. Dalam investigasi partisipatif yang dilakukan oleh tim analisis biokultural, kami mengintegrasikan bukti-bukti etnografis, hukum dan analitis untuk mendokumentasikan mekanisme kerja dan mengusulkan alternatif-alternatif yang berpusat pada hak asasi manusia, hak-hak pekerja, serta hak-hak buruh. Bola-bola tersebut memperkuat konsensus medis yang ada bahwa perlindungan sanitasi yang efektif dan efisien, saat ini telah meningkatkan perlindungan mental dalam kasus-kasus yang lebih besar, tidak didanai dengan hak, tidak ada paksaan, berorientasi pada pemulihan, dipersonalisasi dan didasarkan pada kepercayaan dan tanggung jawab yang sama, bukan pada pengajuan.

Resume: Kami berpendapat bahwa sistem psikiatri Spanyol, yang didasarkan pada prosedur hukum dan administratif, secara sistematis mengedepankan otonomi dan martabat individu melalui praktik-praktik yang bersifat memaksa dan tidak sesuai dengan keinginan pasien. Diagnosis yang dilakukan dengan ketat dan teliti terhadap penyakit, perawatan yang diberikan tanpa persetujuan pasien, serta tindakan yang tidak sesuai dengan konteks dan medis, menghasilkan struktur dan dany yang menghambat pemulihan. Perusahaan ini memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan keputusan yang telah dibuat dan menghormati keputusan yang dibuat secara mandiri. Selain investigasi partisipatif terhadap kapal yang melakukan analisis biokultural, penelitian ini mengintegrasikan bukti-bukti etnografis, hukum dan analitis dengan mendokumentasikan mekanisme ini dan menawarkan alternatif yang berpusat pada hak asasi manusia, perlindungan dan perhatian terhadap pekerja. Bola-bola ini memperkuat konsensus medis yang ada bahwa perhatian sanitasi yang efektif dan efisien, yang juga mencakup perlindungan mental pada kasus-kasus yang lebih besar, harus didasarkan pada hak-hak, non-koersif, berorientasi pada penyembuhan, dipersonalisasi dan didasarkan pada kepercayaan dan tanggung jawab yang sama, bukan pada pengajuan.

Resume: Argumen utama bahwa sistem psikiatri Spanyol, yang didasarkan pada struktur hukum dan administratif, adalah sistem otonomi dan martabat individu melalui praktik-praktik pemaksaan dan tidak ada konsensus yang sesuai dengan keinginan. Diagnosis yang dilakukan dengan ketelitian yang sangat ketat, prosedur yang dilakukan dengan persetujuan yang tidak sesuai dengan kondisi pasien dan tidak sesuai dengan standar medis, menghasilkan struktur struktural yang menghalangi pemulihan. Perusahaan ini memiliki wewenang untuk menerapkan keputusan yang telah diambil secara terpisah dan menghormati keputusan yang dibuat secara mandiri. Kami mendukung investigasi partisipatif dari sebuah kapal yang melakukan analisis biokultural, mengumpulkan bukti-bukti etnografis, hukum dan analitis untuk mendokumentasikan mekanisme investigasi dan mengajukan alternatif-alternatif yang berpusat pada manusia, kekerasan dan kekerasan terhadap pekerja. Bola-bola ini memperkuat konsensus medis yang ada bahwa atenci sanitasi yang efektif dan efisien, yang juga meningkatkan rasa hormat mental dalam kasus-kasus yang lebih besar, harus didasarkan pada kerja keras, tanpa paksaan, berorientasi pada penyembuhan, personalisasi dan didasarkan pada kepercayaan dan tanggung jawab, bukan pada pengajuan.

Resumen: Argumen utama kami adalah bahwa sistem psikiatri Spanyol, yang ditopang oleh struktur hukum dan administratif, melanggengkan sistem otonomi dan martabat individu melalui praktik-praktik pemaksaan dan tidak sesuai dengan perhatian. Diagnosis dilakukan dengan ketelitian empiris yang tinggi, perawatan diberikan dengan persetujuan yang kuat dan tidak dipaksakan, serta dilakukan secara medis, menghasilkan sebuah struktur yang mendukung pemulihan. Perusahaan memiliki wewenang untuk menerapkan keputusan yang telah diambil dan menghormati keputusan yang diambil secara mandiri. Mendukung investigasi partisipatif dari sebuah kapal analisis biokultural, mengumpulkan bukti-bukti etnografis, hukum dan analitis untuk mendokumentasikan mekanisme investigasi dan mengajukan alternatif-alternatif yang berpusat pada hak asasi manusia, pencegahan dan perhatian bersama. Bola-bola tersebut memperkuat konsensus medis yang ada bahwa perhatian sanitasi yang efektif dan efisien, yang juga mencakup kesehatan mental dalam kasus-kasus yang paling serius, harus didasarkan pada hak asasi manusia, tanpa paksaan, berorientasi pada penyembuhan, dipersonalisasi, dan didasarkan pada kepercayaan dan tanggung jawab bersama, bukan pada keputusan.

Bahasa Inggris: shared decision-making; coercion; iatrogenic harm; human rights; structural violence;

Bahasa Indonesia: pengambilan keputusan bersama; pemaksaan; kerusakan iatrogenik; hak asasi manusia; kekerasan struktural; **Bahasa Perancis:** prise de décision partagée; coercion; dommages iatrogènes; droits humains; violence structurelle; **Bahasa Inggris:** erabaki partekatuak; behartzea; kalte iatrogenikoak; giza eskubideak; indarkeria estrukturala; **Gallego:** toma de decisións compartida; coacción; dano iatrogénico; dereitos humanos; violencia estrutural; **Catalan:** presa de decisions compartida; coerció; dany iatrogènic; drets humans; violència estructural; **Español (chavacano):** keputusan bagian; forzamiento; daño iatrogénico; derechos humanos; violencia estructural.

Bab 1. Kerangka kerja umum dan batasan penelitian

Ringkasan: Bab ini menetapkan premis-premis dasar disertasi dengan mengartikulasikan urgensi struktural dan dasar pemikiran ilmiah untuk menyelidiki kekerasan kejiwaan, pengkhianatan institusional, dan penindasan sistemik dalam kerangka kerja kesehatan jiwa kontemporer, khususnya dalam konteks Spanyol. Melalui perspektif biokultural dan penelitian aksi, bab ini menempatkan penyelidikan di persimpangan antropologi medis, analisis hukum, dan pengalaman langsung, dengan menggunakan basis empiris yang luas termasuk penelitian lapangan, analisis kebijakan, dan kesaksian profesional. Bab ini memaparkan klaim kritis bahwa pemaksaan dalam psikiatri bukanlah tindakan yang luar biasa, melainkan mekanisme kontrol sosial yang dinormalisasi dan dirutinkan yang tertanam dalam logika dan operasi sehari-hari institusi klinis. Bab ini mengungkap kegagalan paradigma psikiatri yang dominan dalam menangani akar dari penderitaan, menekankan bagaimana penyebab struktural penderitaan; seperti kemiskinan, pelecehan, kekerasan berbasis gender, dan pengkhianatan institusional, secara rutin didepolitisasi dan diubah menjadi patologi individu. Bab ini lebih lanjut menguraikan bagaimana wacana dan praktik institusional mengkonfigurasi ulang perilaku adaptif atau protes menjadi penanda gangguan, melegitimasi perlakuan paksa yang sering kali menghasilkan bahaya iatrogenik dan cacat psikologis. Dengan memeriksa erosi otonomi, pembungkaman agensi naratif, dan pelepasan moral yang melekat pada sistem koersif, buku ini menarik perhatian pada reproduksi sistematis penderitaan dengan kedok perawatan. Ini juga menyajikan konfigurasi layanan kesehatan mental saat ini di Spanyol, di Uni Eropa, dan sistem yang sebanding, melanggar hak-hak fundamental, menurunkan hubungan klinis, dan merusak perlindungan demokratis dan konstitusional. Hal ini menggarisbawahi bahwa kekerasan semacam itu tidak hanya bersifat medis, tetapi juga sangat politis dan epistemik, didukung oleh kelambanan birokrasi, ketidakjelasan hukum, dan budaya impunitas profesional. Dengan membingkai kesehatan mental sebagai masalah etika publik, keadilan struktural, dan tanggung jawab ekologis, bab ini meletakkan dasar bagi arsitektur metodologis dan teoretis disertasi yang terintegrasi dan mengumumkan urgensi dari pendekatan kesehatan yang berbasis hak asasi manusia, berbasis informasi trauma, tidak berbahaya, mencakup seluruh masyarakat, berbasis gender, transkultural, dan berorientasi pada pemulihan untuk reformasi kesehatan mental yang paling manusiawi. Bab ini menjelaskan hipotesis inti dan orientasi etis dari penelitian ini, dengan menekankan bahwa transformasi harus didasarkan pada praktik-praktik yang tidak memaksa, dialogis, dan sadar struktur.

1. Tesis, maksud dan tujuan

Tesis: Disertasi ini menyelidiki bagaimana sistem psikiatri dapat bertransisi dari praktik-praktik yang bersifat koersif dan overmedis ke arah model-model perawatan yang berorientasi pada pemulihan yang berbasis bukti, yang berlandaskan pada otonomi pasien, pengambilan keputusan bersama, dan praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan konteks budaya.

Disertasi ini menyelidiki bagaimana sistem psikiatri dapat bertransisi dari praktik-praktik yang bersifat memaksa dan berlebihan menuju model perawatan yang berbasis bukti dan berorientasi pada pemulihan, yang didasarkan pada otonomi pasien, pengambilan keputusan bersama, dan penalaran klinis yang sesuai dengan konteks budaya. Tesis ini menyatakan bahwa intervensi koersif dan farmakologis yang dominan dalam psikiatri kontemporer bukanlah hal yang luar biasa atau residual, melainkan secara struktural dipertahankan oleh norma-norma institusional, ketidakpastian hukum, dan fragmentasi administratif. Praktik-praktik ini tetap tertanam di seluruh domain klinis, keluarga, dan birokrasi, menghasilkan kontinum kontrol yang menghalangi pemulihan, menekan agensi, dan melanggengkan kerusakan sosial dan fisiologis. Pemaksaan, yang dikonseptualisasikan di sini sebagai pengucilan sistematis terhadap individu dari keputusan terkait perawatan mereka sendiri, berfungsi sebagai respons institusional yang dilegitimasi terhadap tekanan psikososial, yang sering kali menggantikan perawatan substantif dengan kepatuhan yang dipaksakan. Penelitian ini berargumen bahwa praktik-praktik seperti itu tidak mencerminkan kegagalan para aktor yang terisolasi, melainkan normalisasi logika teknokratis dalam kondisi penghindaran risiko, reduksionisme diagnostik, dan asimetri epistemik (Torrents & Björkdahl, 2024).

Tesis ini memajukan proposisi bahwa transformasi perawatan psikiatri yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan perubahan teknis pada protokol atau pelatihan praktisi yang lebih baik, tetapi juga konfigurasi ulang sistemik menuju bentuk perawatan yang diinformasikan secara dialogis, secara prosedural dapat dipertanggungjawabkan, dan secara struktural dapat direspons. Praktik dialogis, dalam konteks ini, tidak direduksi menjadi metodologi bermerek tertentu tetapi dikonseptualisasikan sebagai prinsip epistemologi dasar yang didasarkan pada pengakuan timbal balik, reflektivitas institusional, dan legitimasi timbal balik atas klaim pengetahuan. Validasi empiris dari proposisi ini dilakukan melalui kerangka kerja metode campuran yang menggabungkan analisis hukum, etnografi klinis, dan observasi partisipan di berbagai lingkungan kejiwaan dan kebijakan (Mead & Filson, 2017; Carr, 1988). Temuan-temuan ini menjelaskan bagaimana kerangka kerja normatif sering kali berdampingan dengan pelanggaran dalam praktiknya, dan bagaimana para profesional itu sendiri beroperasi di bawah batasan-batasan yang melemahkan perawatan yang beretika. Tesis ini tidak hanya mengkritik, tetapi juga menggambarkan jalur institusional menuju sistem tata kelola kesehatan jiwa yang koheren, sesuai hukum, dan mendorong pemulihan (Riker, 2017).

Disertasi ini dipandu oleh pertanyaan penelitian utama: Bagaimana praktik psikiatri yang bersifat memaksa, pengobatan yang berlebihan, dan pengabaian institusional tetap ada di dalam sistem kesehatan jiwa Spanyol meskipun ada perlindungan hukum, etika klinis, dan standar hak asasi manusia internasional? Sebaliknya, penelitian ini juga bertanya: Kondisi sistemik, klinis, dan epistemologis apa yang memungkinkan kemunculan dan konsolidasi perawatan psikiatri yang partisipatif, berbasis trauma, dan berlandaskan biologis yang menghargai otonomi, melindungi hak, dan meningkatkan hasil?

Tabel 1. Keselarasan antara tujuan utama disertasi dan pertanyaan penelitian operasional

Tujuan Disertasi	Pertanyaan Penelitian yang Selaras	Tujuan Operasional
Mendukung sistem kejiwaan yang mampu melakukan koreksi, akuntabilitas, dan menjaga integritas secara real-time	Apa saja bentuk kekerasan sistemik dan kegagalan institusional yang terjadi dalam tata kelola kejiwaan, dan bagaimana cara mengoreksinya?	Mengidentifikasi dan menganalisis kegagalan struktural, legal, dan epistemologis dalam perawatan psikiatri untuk mengembangkan reformasi berbasis bukti
Mendorong pergeseran paradigma dari kontrol farmakologis ke model perawatan yang integratif, interdisipliner, dan timbal balik	Bagaimana bukti klinis dan pengalaman dapat diintegrasikan di seluruh domain biologis, psikologis, dan sosial kesehatan?	Mengembangkan dan memvalidasi sistem umpan balik, alat bantu berbasis biosignal, dan mekanisme evaluasi yang dipimpin oleh pasien
Menyelaraskan kembali psikiatri dengan koherensi empiris, perlindungan hukum, dan tata kelola partisipatif berbasis hak	Apa saja kondisi yang memungkinkan untuk perubahan institusional dan pengawasan partisipatif terhadap sistem kejiwaan?	Menerapkan infrastruktur translasi, intervensi kebijakan, dan pengawasan partisipatif yang selaras dengan standar internasional

Tabel 1 menyajikan keselarasan antara tujuan utama disertasi dengan pertanyaan penelitian dan tujuan operasional yang telah dijelaskan pada bagian 1.9. Setiap komponen dari tesis utama dicocokkan dengan pertanyaan pemandu dan strategi implementasi yang sesuai. Elemen-elemen ini dikembangkan lebih lanjut dalam kerangka kerja metodologis yang dirinci di bagian 1.9 dan dioperasionalkan melalui desain penelitian yang disajikan dalam Bab 2.

Tujuan: Untuk berkontribusi pada pengembangan dan implementasi kerangka kerja klinis, hukum, dan institusional yang mempromosikan perawatan kesehatan jiwa yang dikelola sendiri dan partisipatif, berdasarkan penelitian tindakan yang tertanam dalam pengaturan dunia nyata dan berorientasi pada peningkatan sistem yang berkelanjutan.

Tujuan tesis mengacu pada tujuan utama atau kontribusi yang diharapkan. Tujuan ini mengartikulasikan apa yang ingin dicapai oleh penelitian pada tingkat sistemik atau konseptual, yang membedakannya dengan tesis itu sendiri, yang menyajikan proposisi utama untuk diperdebatkan dan didemonstrasikan. Sementara tesis mengajukan klaim yang dapat diuji berdasarkan bukti empiris dan teoritis, tujuan mendefinisikan orientasi menyeluruh dari penelitian ini, termasuk dampak yang diharapkan pada kebijakan, praktik, atau pemahaman ilmiah. Dalam kerangka kerja penelitian aksi, seperti yang diadopsi di sini, tujuan penelitian juga mencakup tujuan terapan dan niat transformatif yang tertanam dalam sistem dunia nyata.

Tujuan dari disertasi ini adalah untuk mendukung kemunculan dan penerapan sistem psikiatri yang mampu melakukan koreksi waktu nyata, akuntabilitas struktural, dan pelestarian integritas tubuh dan hukum. Disertasi ini berupaya mendorong transisi paradigmatis dari ketergantungan unidimensi pada kontrol psikofarmakologis menuju model perawatan integratif yang berakar pada bukti interdisipliner dan timbal balik terapeutik. Model ini didasarkan pada pemahaman bahwa kesehatan mental tidak dapat direduksi menjadi ketidakseimbangan neurokimia atau penyimpangan perilaku, tetapi harus ditafsirkan melalui interaksi regulasi biologis, perkembangan pengalaman, dan konteks sosial-politik. Penelitian ini mengintegrasikan kontribusi dari ilmu saraf translatasi, psikiatri fisiologis, psikoneuroimunologi, psikoneuroendokrinologi, psikopatologi perkembangan, kerangka kerja berbasis trauma, psikiatri nutrisi, epidemiologi psikososial, dan kesehatan masyarakat ekologis. Disiplin-disiplin ilmu ini memberikan bukti yang menyatu tentang bagaimana trauma, inflamasi, disregulasi metabolisme, dan kerentanan lingkungan membentuk kemunculan dan kronisitas kondisi kejiwaan (Gooding et al., 2022).

Secara paralel, disertasi ini mengacu pada psikologi budaya, psikiatri fenomenologis, teori naratif, dan antropologi medis untuk menempatkan fenomena klinis dalam matriks relasional, budaya, dan sejarah. Teori-teori tentang kognisi yang diwujudkan, pikiran yang diperluas, dan kesadaran relasional digunakan bukan sebagai kerangka kerja spekulatif, melainkan sebagai perspektif yang dikuatkan secara ilmiah tentang sifat proses mental yang terdistribusi dan dimediasi secara sosial. Orientasi konseptual ini dioperasionalkan melalui desain mekanisme umpan balik partisipatif, struktur evaluasi yang dipimpin oleh pasien, dan infrastruktur data yang tertanam, yang memungkinkan sistem klinis untuk mengkalibrasi ulang berdasarkan input pengalaman, fisiologis, dan etika. Tujuannya bukan untuk menggantikan psikiatri tetapi untuk menyelaraskannya dengan cakrawala yang lebih luas tentang koherensi empiris, perlindungan pasien, dan kerendahan hati epistemik. Disertasi ini mengintervensi pengambilan keputusan klinis, desain institusional, dan struktur hukum, menawarkan model regulasi dan perawatan pragmatis yang didasarkan pada verifikasi berkelanjutan, tata kelola yang transparan, dan standar ilmu pengetahuan yang terbuka (Suess Schwend et al., 2016).

Integrasi dari berbagai disiplin ilmu dan metodologi ini menginformasikan kerangka kerja yang komprehensif di mana tata kelola kejiwaan dapat menjadi valid secara ilmiah dan adil secara sosial. Tujuan yang diturunkan dari tujuan ini diuraikan di seluruh domain intervensi biologis, psikologis, dan sosial dan sesuai dengan struktur disertasi ini. Tujuan-tujuan ini dirinci di bawah ini dan diimplementasikan melalui penelitian lapangan di beberapa lokasi, penelitian aksi partisipatoris, dan analisis legal-etis yang kritis:

Tabel 2. Tujuan biologis dan strategi implementasi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang relevan	Tujuan	Metode Implementasi
TPB 3 - Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	Melakukan observasi partisipan yang berkelanjutan dalam lingkungan klinis, hukum, dan kebijakan, terlibat langsung dengan para profesional, pengguna, keluarga, dan pengambil keputusan untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan tanpa menyebabkan kerugian.	Penelitian lapangan di berbagai lokasi di Spanyol, Indonesia, dan Swedia melalui pencelupan etnografi, wawancara informal, dan analisis bersama yang terlindungi dengan individu-individu yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan profesional.
SDG 9 - Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Mengkaji secara kritis fondasi budaya, ilmiah, dan hukum dari standar psikofarmakologi saat ini, terutama dalam kaitannya dengan pengobatan yang berlebihan dan marginalisasi pendekatan alternatif.	Tinjauan historis-hukum terhadap regulasi obat, analisis komparatif terhadap protokol psikiatri nasional, dan wawancara dengan para sarjana psikiatri kritis dan dokter praktik.

Tabel ini menguraikan tujuan dan pendekatan metodologis yang terkait dengan dimensi biologis kesehatan, dengan fokus pada penelitian lapangan empiris dan pemeriksaan kritis terhadap norma-norma farmakologis. Komponen-komponen ini selaras dengan SDG 3 dan SDG 9 dan mendukung transformasi praktik klinis dan regulasi berbasis bukti.

Dimensi biologis dari disertasi ini, tabel 1, mengintegrasikan eksplorasi ke dalam potensi penuh praktik terbaik saat ini, pendekatan manusia terhadap hubungan baik, kepercayaan, serta keputusan dan tanggung jawab bersama, dan teknologi baru untuk mendukung ketepatan, akuntabilitas, dan peningkatan berkelanjutan dalam praktik klinis. Tesis ini menyatakan bahwa kesehatan harus dipahami bukan sebagai manajemen gejala yang terisolasi tetapi sebagai hasil interaksi dinamis antara integritas biologis, kondisi kontekstual, dan tanggung jawab kelembagaan. Di Spanyol, ketergantungan yang terus-menerus pada protokol farmakologis telah mengakar pada model medis yang mengabaikan bahaya sistemik dan kemungkinan pemulihan. Penelitian ini menantang kelembaman struktural tersebut dengan memperkenalkan kerangka kerja data terbuka, pemantauan berbasis biosignal, dan sistem dokumentasi yang dapat dioperasikan yang memberdayakan pasien dan dokter untuk bersama-sama mengevaluasi efek pengobatan secara real time. Dengan menanamkan umpan balik positif dalam siklus penelitian tindakan partisipatif dan mengadopsi standar ilmu pengetahuan terbuka, model sintesis ini mengubah orientasi sistem kesehatan ke arah pembelajaran adaptif dan akuntabilitas biomedis. Perlindungan hukum dan mekanisme peraturan diusulkan untuk memastikan transparansi, melindungi data pasien, dan mencegah penyalahgunaan kategori diagnostik dan intervensi terapeutik yang dapat memperkuat kronisitas dan pengucilan sistemik.

Tabel 3. Tujuan psikologis dan strategi implementasi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang relevan	Tujuan	Metode Implementasi
TPB 4 - Pendidikan Berkualitas	Mendokumentasikan kegagalan dalam tanggung jawab klinis, mekanisme bahaya, dan kelalaian sistemik, dengan fokus pada bagaimana praktik yang diinformasikan oleh umpan balik dapat meningkatkan lintasan pemulihan dan aliansi terapeutik.	Meninjau kasus-kasus malpraktek, pengumpulan laporan pengalaman langsung, dan evaluasi pengukuran hasil dalam hubungan terapeutik.
SDG 5 - Kesetaraan Gender	Menelusuri bagaimana proses diagnostik dapat berkontribusi pada penghapusan identitas dan perampasan secara hukum, dan mengusulkan perlindungan yang melindungi kesinambungan kepribadian, status hukum, dan integritas relasional.	Analisis lintasan diagnostik berbasis gender, dokumentasi hukum tentang ketidakmampuan, dan pemetaan kekerasan institusional berdasarkan kesaksian.

Tabel ini menyajikan tujuan-tujuan yang terkait dengan dimensi psikologis dari kesehatan dan perawatan, membahas tanggung jawab klinis, integritas diagnostik, dan bahaya berbasis gender. Metodologi ini mengintegrasikan pengalaman hidup dan analisis struktural, yang berkontribusi pada SDG 4 dan SDG 5.

Pada tingkat psikologis, tabel 2, teknologi baru dimobilisasi bukan untuk pengawasan atau standarisasi, tetapi untuk memulihkan agensi, ingatan, dan kepribadian dalam proses terapeutik. Tesis ini membela sentralitas narasi, penentuan nasib sendiri, dan pemulihan kognitif sebagai pilar utama penyembuhan. Antitesis yang ditentangnya adalah budaya klinis yang terlalu sering mengabaikan kompleksitas subjektif, memaksa pemaksaan diagnostik, dan melucuti kekuatan interpretatif individu. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini menggunakan alat bercerita digital, platform reflektif untuk penilaian aliansi terapeutik, dan sistem pendukung keputusan yang selaras dengan kerangka kerja berbasis trauma dan berbasis hak. Lingkaran umpan balik dibangun ke dalam struktur perawatan itu sendiri, sehingga memungkinkan kalibrasi ulang secara teratur dan pembelajaran yang berpusat pada orang. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk perawatan individu tetapi juga untuk perubahan struktural: keterlibatan masyarakat sipil, interpretasi data yang dipimpin oleh pasien, dan pendidikan berkelanjutan bagi para profesional tertanam sebagai fungsi inti. Analisis hukum lebih lanjut mengidentifikasi celah prosedural dan mengusulkan jaminan yang dapat ditegakkan untuk melindungi dari penghapusan identitas dan bahaya epistemik, menegaskan kembali hak untuk berkembang di luar label dan untuk pulih sepenuhnya (Tomé, 2014).

Pada tingkat sosial, tabel 6, disertasi ini memajukan sintesis di mana reformasi kelembagaan ditopang oleh koordinasi waktu nyata, partisipasi masyarakat, dan transparansi data penuh. Melalui inisiatif EU BEACON One Health Education, penelitian ini mendukung arsitektur untuk integrasi sistem yang memungkinkan koreksi struktural dan penegakan hukum yang berkelanjutan. Infrastruktur digital partisipatif memungkinkan masukan bertingkat, dari keluarga, profesional, pengguna, dan masyarakat sipil, menciptakan mekanisme yang dapat diukur untuk mengidentifikasi praktik-praktik berbahaya, menyoroti model-model terbaik, dan memastikan koherensi kebijakan. Ilmu pengetahuan terbuka bukanlah sebuah tambahan, melainkan sebuah prinsip dasar: semua data dianonimkan, dienkripsi, dan dapat diakses untuk pengawasan yang demokratis, dengan batas-batas yang jelas yang ditetapkan untuk mencegah pengambilan atau pengambilalihan oleh institusi. Mekanisme umpan balik dikalibrasi untuk melacak tidak hanya hasil kesehatan tetapi juga perilaku lembaga, menutup

kesenjangan dalam penegakan hukum dan mengurangi kekebalan hukum. Model ini menolak asumsi kronisitas sebagai hasil yang tak terelakkan, dan lebih menekankan pada etika yang menghadap ke depan tentang kemungkinan, ketahanan, dan perbaikan struktural. Dalam visi ini, kesehatan bukanlah keadaan statis atau defisit yang dapat dikelola, tetapi merupakan kapasitas relasional, sosial, dan dinamis yang harus dilindungi dan terus diperbarui (Baum et al., 2006).

Tabel 4. Tujuan Sosial dan Strategi Implementasi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang Relevan	Tujuan	Metode Implementasi
TPB 10 - Mengurangi Ketidaksetaraan	Mengumpulkan dan menganalisis kesaksian dan praktik dari pasien, kerabat, dokter, peneliti, dan pejabat publik, mendokumentasikan tantangan yang ada dan model-model yang muncul dari perawatan yang penuh rasa hormat dan efektif.	Pengumpulan data naratif, survei anonim, analisis kasus hukum, dan observasi proses pengambilan keputusan dalam pengaturan kelembagaan.
SDG 16 - Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat	Mengidentifikasi kondisi yang memungkinkan untuk implementasi manajemen pengobatan yang otonom dan kolaboratif, dengan menyoroti ketegangan antara norma-norma kelembagaan dan pengalaman hidup.	Dokumentasi praktik percontohan, lokakarya pemangku kepentingan, dan pemantauan berbasis lapangan atas negosiasi pasien-praktisi dalam konteks psikiatri.
SDG 17 - Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Memetakan lingkaran umpan balik di tingkat individu, institusi, dan regulasi, mengidentifikasi titik ungkit spesifik untuk perubahan positif dalam kebijakan dan tata kelola klinis.	Pemetaan sistem melalui pemodelan partisipatif, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan analisis saling ketergantungan kebijakan internasional dan nasional.
SDG 1 - Tanpa Kemiskinan	Memberikan rekomendasi yang berlandaskan empiris dan perangkat metodologis untuk implementasi perawatan kesehatan jiwa yang dinamis, berpusat pada orang, dan menghormati hak-hak, di mana refleksi dan pembelajaran sistem yang berkesinambungan mendukung pemulihan jangka panjang dan inklusi sosial.	Pengembangan protokol perawatan yang dapat diadaptasi, penerjemahan temuan penelitian ke dalam modul pelatihan klinis, dan ringkasan kebijakan yang dibagikan dengan jaringan internasional termasuk EU BEACON.

Tabel ini mengidentifikasi tujuan-tujuan yang menargetkan faktor penentu sosial dan institusional dari kesehatan mental, dengan fokus pada ketidaksetaraan, perlindungan hukum, tata kelola kolaboratif, dan inklusi. Tujuan-tujuan ini dioperasionalkan sejalan dengan SDG 1, SDG 10, SDG 16, dan SDG 17.

Disertasi ini mempertahankan tesis yang berlandaskan ilmiah dan secara etis sangat penting: bahwa pemulihan kesehatan jiwa tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga harus dimungkinkan secara struktural, didukung secara kelembagaan, dan dilindungi secara epistemik. Melawan sistem yang mengakar yang melanggengkan pemaksaan, kronisitas, dan ketidakadilan epistemik dengan kedok perawatan, penelitian ini menawarkan sintesis multidimensi yang didasarkan pada bukti terbaik yang tersedia dan realitas kehidupan mereka yang paling terpengaruh. Dengan mengintegrasikan ilmu saraf translasi, model dialogis dan perkembangan, perlindungan hukum, dan teknologi partisipatoris, disertasi ini mengartikulasikan kerangka kerja yang koheren dan dapat ditindaklanjuti untuk transformasi di seluruh sistem. Implementasinya melalui aksi EU BEACON One Health Education, yang didirikan oleh peneliti selama penelitian lapangan penelitian aksi partisipatif tesis ini, mencontohkan bagaimana penelitian dapat menginformasikan praktik dan kebijakan tanpa

kompromi, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan demokratis di semua tingkatan. Kesehatan, dalam model ini, bukanlah sebuah abstraksi manajerial, melainkan sebuah pencapaian yang dinamis dan relasional yang ditopang oleh integritas prosedural, investasi pendidikan, dan komitmen bersama terhadap martabat manusia. Penelitian ini tidak hanya mengkritik sistem yang ada, tetapi juga mengoperasionalkan konfigurasi ulang sistem tersebut, menegaskan bahwa pemulihan bukanlah pengecualian, tetapi merupakan dasar etis dan struktural yang menjadi titik tolak dari mana semua layanan kejiwaan harus dimulai (Ochocka et al., 2002; Speers & Lathlean, 2015).

1.1. Latar belakang historis-struktural singkat: perawatan, pemaksaan dan tata kelola di Spanyol

Tata kelola tekanan mental di Semenanjung Iberia secara historis berfungsi sebagai aparatus regulasi normatif, yang terjalin dengan rezim kontrol agama, politik, dan sosial yang lebih luas. Dari akhir abad pertengahan hingga awal era modern, penyimpangan dari tatanan moral dan epistemik yang sudah mapan tidak hanya ditoleransi atau ditafsirkan, tetapi secara aktif ditekan melalui mekanisme institusional yang mencampuradukkan kesalahan spiritual, disonansi kognitif, dan ketidakteraturan perilaku. Tradisi Kristen dan Islam awal, meskipun berbeda dalam kerangka teologis, keduanya berkontribusi pada moralisasi penderitaan di mana penderitaan ditafsirkan sebagai tanda hukuman ilahi atau pecahnya integritas spiritual. Tanggapan-tanggapan institusional pun disusun sesuai dengan itu. Sistem biara, amal, dan kemudian sistem inkuisitorial menggunakan ritual pemurnian, doa, puasa, kurungan, dan pengusiran setan, sering kali tanpa perbedaan antara fenomena psikologis, somatik, dan moral. Individu yang mengalami kesusahan tidak diperlakukan sebagai pembawa pengalaman yang valid secara epistemis, melainkan sebagai gejala ketidakteraturan dalam tatanan sosial atau kosmologis. Dinamika ini meletakkan dasar bagi sebuah mode perawatan yang beroperasi lebih sedikit melalui pengakuan terapeutik daripada melalui penahanan yang mengorbankan, di mana batas antara penyembuhan dan pengucilan dihapus secara sistematis (Van Bilsen, 2016; Asad et al., 2024; Alotaibi, 2025).

Pada abad kedelapan belas, kebangkitan rasionalisme Pencerahan dan empirisme biomedis menandakan pergeseran parsial dalam kerangka penjelasan. Namun, konsolidasi pengetahuan psikiatri sebagai sebuah bidang institusional tidak membongkar arsitektur hukuman dari sistem sebelumnya, melainkan mengartikulasikannya kembali melalui klasifikasi sekuler dan otoritas klinis. Kemunculan rumah sakit jiwa di seluruh Eropa, termasuk Spanyol, melembagakan transisi ini. Dibingkai di bawah ideologi perawatan moral, fasilitas-fasilitas ini menggabungkan retorika terapeutik dengan desain spasial yang disipliner, yang memperkuat pemisahan antara apa yang disebut waras dan tidak waras. Dalam konteks Spanyol, provinsialisasi rumah sakit jiwa mengukuhkan model kustodian di mana hak prerogatif hukum, keluarga, dan profesional menyatu untuk mengesahkan pengurungan yang berkepanjangan. Kategori diagnostik tidak memiliki standarisasi dan sering digunakan untuk membenarkan pengucilan sosial, sering kali dengan dalih mengelola risiko atau ketidakmampuan. Pengobatan tidak berorientasi pada pemahaman atau pemulihan, tetapi pada ketundukan, pengawasan, dan pengekan farmakologis. Kesenambungan arsitektur dengan lembaga-lembaga keagamaan sebelumnya disejajarkan dengan logika administratif

yang memprioritaskan ketertiban di atas perawatan dan kepatuhan di atas penyembuhan. Fungsi struktural psikiatri dengan demikian mereplikasi model-model penahanan teologis sebelumnya, meskipun sekarang berada di bawah legitimasi modernitas ilmiah (Locke, 1690/1975; Battie, 1751/1975; Tuke, 1796/1975; Pinel & Esquirol, 1838/1994).

Sepanjang abad kesembilan belas, psikiatri Spanyol mengalami konsolidasi profesional, dengan mengacu pada sistem nosologi Prancis dan Jerman untuk memperkuat otoritas pandangan klinis. Taksonomi diagnostik seperti melankolia, mania, dan kegilaan moral menjadi tertanam dalam wacana medis-hukum dan berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola penyimpangan baik di ranah publik maupun privat. Klasifikasi-klasifikasi ini tidak muncul dari keterlibatan dialogis dengan orang-orang yang terkena dampak, melainkan dari epistemologi keahlian yang menempatkan kekuatan untuk mendefinisikan patologi pada pengamat profesional. Proses ini sangat bias gender. Patologisasi agensi perempuan melalui kategori-kategori seperti histeria berfungsi untuk melembagakan kontrol patriarki, sementara pengurungan perempuan yang tidak proporsional untuk perilaku yang dianggap transgresif, baik secara seksual, emosional, atau spiritual, mengungkapkan keterlibatan psikiatri dalam menegakkan femininitas yang normatif. Institusi psikiatri dengan demikian tidak lagi menjadi ruang penyembuhan, tetapi menjadi mekanisme triase biopolitik, di mana batas antara penyakit, ketidakabsahan, dan ketidaksesuaian diruntuhkan di bawah rasionalitas medis. Dalam konfigurasi ini, perawatan tidak bersifat emansipatoris tetapi regulatif, dan pemulihan berada di bawah kepentingan institusional dalam hal penahanan, pengendalian, dan reproduksi sosial (Rodríguez-Morini, 2002).

Pada awal abad ke-20, psikiatri Spanyol semakin dibentuk oleh doktrin-doktrin eugenik dan nasionalis yang mencampuradukkan kesehatan masyarakat dengan kebersihan moral. Selama tahun 1920-an dan 1930-an, kebijakan institusional mengadopsi kerangka kerja segregasionis dan sterilisasi yang bertujuan untuk mengucilkan individu yang dianggap mengalami gangguan jiwa. Kecenderungan ini semakin meningkat di bawah pemerintahan Franco, di mana institusi psikiatri menjadi bagian integral dari alat represi negara. Alih-alih menjadi tempat perawatan klinis, mereka berfungsi sebagai instrumen kontrol politik dan sosial. Mereka yang menyimpang dari cita-cita nasional-Katolik, baik karena perbedaan pendapat politik, orientasi seksual, atau respons terkait trauma, menjadi sasaran rawat inap paksa, perawatan invasif, dan kurungan tanpa batas waktu. Diagnosis psikiatri digunakan sebagai alat untuk mendelegitimasi identitas yang tidak sesuai, membingkai kesusahan sebagai patologi dan perbedaan pendapat sebagai penyakit. Praktik klinis digabungkan dengan logika hukum yang otoriter, menghapus perlindungan prosedural. Rekam medis tidak dapat diakses, banding tidak dapat dilakukan, dan perawatan yang dirancang untuk memastikan ketundukan, bukan penyembuhan. Konvergensi ini membentuk warisan impunitas medis dan kekaburan epistemik yang terus memengaruhi norma-norma kelembagaan di Spanyol kontemporer (Espinosa & Comelles, 1966; Tusell, 2010; Alonso-Tejada & López-Morales, 2015).

Setelah transisi demokrasi, reformasi legislatif pada tahun 1980-an dan 1990-an bertujuan untuk menggantikan pasung institusional dengan perawatan berbasis komunitas dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam perawatan kesehatan jiwa. Namun demikian, implementasinya masih bersifat parsial dan kekurangan sumber daya. Rumah sakit jiwa ditutup tanpa membangun alternatif yang kuat, dan banyak fungsi psikiatri digabungkan ke dalam rumah sakit umum atau dilimpahkan ke entitas swasta. Paradigma yang mendasari kontrol tetap dipertahankan. Hirarki profesional

dipertahankan, taksonomi diagnostik tetap tidak tertandingi, dan praktik intervensi terus memprioritaskan penenang farmakologis daripada keterlibatan dialogis. Psikiatri komunitas, meskipun secara retorika didukung, gagal memberikan perawatan yang terintegrasi atau partisipatif. Intervensi farmasi, terutama antipsikotik jangka panjang, menjadi terkenal sebagai respons lini pertama terhadap ketidakpatuhan, yang secara efektif menggantikan manajemen perilaku dengan pemahaman terapeutik. Kepatuhan menjadi metrik utama keberhasilan klinis, terlepas dari hasil akhir pasien atau persetujuan pasien. Perkembangan ini tidak didorong oleh konsensus berbasis bukti, tetapi oleh kenyamanan institusional dari penekanan gejala daripada perubahan struktural (García Espino & Lara Ladislao, 1998; Pérez-Fernández & Peñaranda-Ortega, 2015; Bobes, Vázquez-Barquero, & Salvador-Carulla, 2010).

Pada abad kedua puluh satu, konsolidasi langkah-langkah penghematan, lobi industri, dan pertahanan diri profesional semakin mengukuhkan paksaan farmakologis sebagai praktik kejiwaan normatif. Perawatan paksa semakin disahkan melalui proses peradilan yang dipercepat dengan pengawasan yang minimal. Ambang batas untuk menyatakan ketidakmampuan tetap rendah, memungkinkan erosi sistematis terhadap lembaga hukum bagi mereka yang mengalami kesulitan. Intervensi psikiatri dibingkai sebagai tindakan protektif, namun sering kali berfungsi untuk menekan pengalaman yang berbeda dari yang seharusnya dan bukan untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya. Bahasa hak asasi tetap dipertahankan dalam kebijakan, namun penerapan praktisnya dirusak oleh penggabungan ketidakpatuhan dengan patologi. Kerabat, yang menghadapi dukungan yang tidak memadai dan mendapat informasi yang salah tentang alternatif, sering kali menyetujui protokol pemaksaan. Tanggapan institusional lebih mengutamakan pembiusan daripada keterlibatan yang berkelanjutan. Kesenambungan ini mengungkapkan logika bangkai yang terus-menerus dalam psikiatri Spanyol, yang dibingkai ulang tetapi tidak dibongkar. Kecurigaan yang terus berlanjut terhadap agensi pengguna, marginalisasi pemahaman naratif, dan resistensi sistemik terhadap pembagian kekuasaan menegaskan bahwa farmakologi pemaksaan bukanlah keniscayaan ilmiah, melainkan warisan yang tertanam secara budaya dan politik yang menuntut perbaikan struktural (Ortiz-Gómez, 2002; Portilla, 2006).

Pendekatan yang lebih baik adalah dan dibingkai sebagai kemewahan atau eksperimen ideologis, bukan sebagai tanggapan ilmiah terhadap penderitaan. Bahasa hak tetap ada dalam dokumen resmi tetapi tidak memiliki kekuatan praktis. Pasien tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perawatan, dan penolakan ditafsirkan bukan sebagai pernyataan tetapi sebagai gejala. Keluarga pasien, di bawah tekanan dan informasi yang salah, sering kali mendukung tindakan pemaksaan, dengan harapan akan adanya stabilitas dengan cara apa pun. Institusi-institusi menanggapi dengan penenangan, bukan dukungan. Pergeseran dari rumah sakit jiwa ke komunitas tidak menghilangkan fungsi psikiatri. Hal itu justru mendistribusikannya ke dalam ruang dan kosakata yang baru.

Pergeseran ini tidak dapat dijelaskan sebagai perkembangan netral dalam ilmu kedokteran. Mereka berakar kuat pada tradisi budaya yang tunduk, patuh, dan dikucilkan. Sejarah panjang kekuasaan terpusat, moralisme agama, dan kekerasan berbasis gender di Spanyol membentuk penerimaan dan fungsi intervensi kejiwaan. Mereka yang dianggap gila tidak pernah menjadi warga negara sepenuhnya. Mereka adalah subjek perawatan hanya sejauh perawatan menegaskan tatanan sosial.

Penyembuhan jarang menjadi tujuan. Tujuan sebenarnya adalah penahanan, pengamanan, dan koreksi moral. Sejarah ini menjelaskan bertahannya farmakologi koersif di Spanyol saat ini, meskipun ada rekomendasi internasional yang mengadvokasi pengambilan keputusan bersama dan praktik-praktik yang berorientasi pada pemulihan. Sejarah ini juga mengungkapkan keengganan institusional untuk menerapkan alternatif yang membutuhkan pembagian kekuasaan, kerendahan hati naratif, dan investasi struktural.

Oleh karena itu, transisi dari pemasangan ke pengobatan berlebihan harus dilihat bukan sebagai reformasi, tetapi sebagai adaptasi. Tata kelola psikiatri di Spanyol telah menggantikan jeruji besi rumah sakit jiwa yang terlihat dengan rantai kontrol kimiawi yang tidak terlihat. Individu tidak lagi dikurung tetapi tetap berada di bawah pengawasan institusi yang memantau kepatuhan mereka dan mendikte rejimen farmakologis mereka. Perlawanan dikodekan ulang sebagai penyakit, wawasan sebagai kepatuhan, dan kebisuan sebagai kemajuan. Naskah-naskah budaya yang dulunya membenarkan pengusiran agama, pengasingan moral, dan segregasi fasis sekarang menginformasikan wacana klinis yang dibalut dengan bahasa berbasis bukti tetapi didasarkan pada logika disiplin ilmu. Akibatnya, perawatan kesehatan mental di Spanyol terus berfungsi kurang sebagai sistem penyembuhan dan lebih sebagai rezim normalisasi yang dikelola. Lintasan ini tidak terbatas pada mereka yang memenuhi kriteria klinis. Secara historis, aparatus psikiatri Spanyol yang bersifat koersif telah menargetkan orang miskin, orang yang memiliki ras tertentu, orang yang tidak sesuai dengan gender, dan orang yang tidak diinginkan secara sosial. Pada abad ke-19 dan ke-20, rumah sakit jiwa dan rumah sakit jiwa berfungsi sebagai wadah bagi populasi yang berlebih. Orang miskin, gelandangan, ibu yang tidak menikah, istri yang memberontak, musuh politik, dan migran diusir dari ekonomi produktif dan tidak diikutsertakan secara penuh sebagai warga negara. Kurungan dibingkai sebagai perawatan tetapi berfungsi sebagai pengucilan. Diagnosa menjadi alat untuk kemudahan administratif. Kemiskinan dipatologikan. Penyimpangan menjadi medis. Tanggung jawab negara dialihkan ke dalam tubuh subjek (Wallace Mandell, 1962/2025; Rosenhan, 1973; Foucault, 1961/2006).

Penargetan ini semakin meningkat di bawah pemerintahan Franco, terutama terhadap mereka yang berada di pihak yang kalah dalam perang. Aparat kejiwaan dimobilisasi untuk menghilangkan perbedaan ideologis dan identitas yang menyimpang. Homoseksualitas dipatologikan, ketidaksesuaian gender dihukum, dan perlawanan politik dibungkam melalui sertifikasi medis yang menyatakan mereka tidak sehat. Mereka yang tidak dapat diintegrasikan ke dalam proyek Katolik nasional tidak hanya dikriminalisasi tetapi juga dijiwai. Mereka disingkirkan dari pandangan publik, menjalani perawatan paksa, atau dihilangkan begitu saja. Ini merupakan bentuk genosida biopolitik yang lambat, penghapusan yang didorong oleh negara terhadap mereka yang tidak diinginkan melalui pengurangan, pengamanan kimiawi, dan pemusnahan epistemik. Psikiatri bukanlah sebuah disiplin ilmu yang menyembuhkan, melainkan sebuah teknologi untuk mengendalikan. Sisa-sisa dari fungsi ini masih ada sampai sekarang. Sistem kesehatan mental Spanyol terus berdampak secara tidak proporsional pada mereka yang berada di pinggiran. Para migran, pemuda rasial, orang Roma, transgender, dan penyintas pelecehan terlalu banyak diintervensi secara paksa dan kurang terwakili dalam perawatan partisipatif. Cakupan kesehatan universal hidup berdampingan dengan pengucilan institusional. Bahasanya mungkin telah melunak tetapi logikanya tetap sama. Psikiatri tidak lagi

berbicara tentang dosa atau kemerosotan, tetapi tentang kepatuhan dan wawasan. Namun, hasilnya tetap sama, yaitu terciptanya keteraturan melalui penahanan perbedaan (Campos & Novella, 2017; Huertas, 2017).

Mekanisme pembungkaman historis ini telah disempurnakan tetapi tidak dibongkar. Mekanisme ini tertanam dalam hukum, dalam rutinitas institusional, dan dalam penalaran klinis. Mekanisme-mekanisme ini terwujud dalam resep obat-obatan psikotropika yang berlebihan, dalam penggunaan rutin pengekangan fisik dan kimiawi, dan dalam perataan penderitaan secara birokratis ke dalam profil-profil risiko. Negara tidak lagi membutuhkan rumah sakit jiwa untuk mencapai tujuannya. Negara telah menemukan alat untuk mencapai tujuan yang sama melalui cara-cara yang lebih menyebar dan berbahaya dalam pemaksaan rawat jalan, kepatuhan farmakologis yang dipaksakan, dan kebijaksanaan yudisial. Oleh karena itu, sejarah psikiatri di Spanyol bukanlah cerita tentang kemajuan linier. Ini adalah salah satu kesinambungan melalui transformasi. Yang berubah adalah bentuknya, bukan fungsinya. Dari bid'ah abad pertengahan hingga ketidakpatuhan modern, dari kurungan hingga suntikan, dari moralisme yang terang-terangan hingga rasionalitas administratif, benang merahnya tetap ada. Tujuannya selalu untuk menekan apa yang tidak dapat diasimilasi. Orang miskin, orang gila, orang yang melanggar hukum, dan para pendatang berkumpul dalam imajinasi institusional sebagai tubuh-tubuh yang harus dikelola demi ketertiban. Atas nama kesehatan masyarakat, psikiatri telah memberlakukan kekerasan privat. Atas nama perawatan, psikiatri telah melakukan pengucilan (Brydán, 2016).

Ini adalah konteks untuk melihat realitas perawatan psikiatri paksa di Spanyol. Pemaksaan bukanlah sebuah penyimpangan, melainkan sebuah fitur struktural dari sistem. Hal ini tertanam dalam silsilahnya, ditopang oleh institusi-institusinya, dan direproduksi melalui wacana-wacananya. Berikut ini adalah analisis lanskap kontemporer, kerangka hukum, argumen klinis, dan situs-situs perlawanan. Analisis ini dimulai dari premis yang jelas. Pemaksaan merupakan tindakan yang membahayakan. Beban pembenaran tidak terletak pada mereka yang menolaknya, tetapi pada mereka yang memaksakannya. Bagian selanjutnya tidak hanya menanyakan apa yang dilakukan tetapi juga mengapa hal tersebut diizinkan dan bagaimana hal tersebut bertahan.

1.2. Kerangka kerja saat ini: intervensi psikiatri paksa dan akuntabilitas institusional

Perawatan psikiatri paksa, dalam bentuk komitmen rawat jalan paksa dan pengobatan wajib, terus dipromosikan di Spanyol oleh beberapa aktor klinis dan hukum, meskipun ada banyak bukti yang menunjukkan keefektifannya yang terbatas dan biaya etis yang signifikan. Proposal untuk membuat undang-undang rawat jalan paksa telah diajukan berulang kali selama dua dekade terakhir dan telah ditolak secara sistematis oleh badan legislatif, asosiasi profesional, dan organisasi pengguna. Argumen yang mendukung tindakan pemaksaan tersebut bergantung pada klaim spekulatif bahwa kepatuhan paksa terhadap rejimen medis akan mencegah pasien masuk kembali ke rumah sakit, mengurangi perilaku berbahaya, dan mengurangi tekanan sistemik. Klaim-klaim ini masih belum didukung oleh penelitian empiris dan tidak memiliki koherensi teoritis ketika diperiksa dalam kerangka praktik klinis berbasis hak dan pengobatan berbasis bukti.

Tinjauan paling komprehensif hingga saat ini, yang dilakukan dengan menggunakan metodologi Cochrane, tidak menemukan manfaat yang konsisten dari rawat jalan paksa dibandingkan dengan perawatan standar. Indikator hasil utama, termasuk tingkat rawat inap di rumah sakit, fungsi sosial, kondisi mental, kualitas hidup, dan kepuasan terhadap perawatan, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara individu yang menjalani rawat jalan paksa dan mereka yang menerima perawatan sukarela. Perhitungan jumlah yang dibutuhkan untuk merawat mengungkapkan implikasi yang tidak dapat dipertahankan secara etis. Sebagai contoh, untuk mencegah satu orang masuk kembali ke rumah sakit mungkin perlu memberlakukan perawatan paksaan pada lebih dari delapan puluh orang. Intervensi sebesar ini akan dianggap tidak proporsional dalam domain kesehatan atau kebijakan publik lainnya. Oleh karena itu, pembelaan yang terus menerus terhadap langkah-langkah ini tidak dapat didasarkan pada bukti ilmiah tetapi mencerminkan prioritas institusional yang lebih mengutamakan kontrol dan manajemen risiko daripada kolaborasi dan otonomi pasien (Sailas & Fenton, 2000).

Di Spanyol, kebangkitan inisiatif legislatif untuk menerapkan perawatan rawat jalan paksa sebagian berasal dari kekurangan sistemik dalam infrastruktur kesehatan jiwa masyarakat. Para pembuat kebijakan dan beberapa perwakilan klinis berpendapat bahwa pemaksaan diperlukan karena tidak adanya perawatan relasional yang berkelanjutan dan fragmentasi sistem dukungan sosial dan kesehatan. Pembimbingan ini mengalihkan tanggung jawab atas kegagalan struktural kepada individu dan menggantikan kepatuhan paksa dengan pengembangan layanan yang komprehensif dan suportif. Pembenaan hukum sering kali bergantung pada interpretasi yang luas tentang ketidakmampuan dan risiko, yang sering kali menggunakan konsep-konsep seperti kurangnya wawasan atau penolakan pengobatan tanpa definisi operasional. Kategori-kategori ini bermasalah baik dari perspektif klinis maupun hukum dan rentan terhadap penyalahgunaan secara subjektif. Upaya untuk membimbing ulang pemaksaan sebagai tindakan pencegahan secara paradoks merusak hasil klinis dan hubungan terapeutik yang menjadi dasar pemulihan (Cañete-Nicolás et al, 2012; Gías Gil, 2013).

Sebaliknya, pengambilan keputusan bersama secara konsisten telah dikaitkan dengan peningkatan keterlibatan klinis, hasil fungsional yang lebih baik, dan mengurangi tingkat kekambuhan. Ini adalah model yang menegaskan kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perawatan, bahkan selama periode tekanan psikologis. Kehadiran aliansi terapeutik kolaboratif adalah prediktor paling kuat untuk hasil jangka panjang yang positif di seluruh kondisi kesehatan mental. Tindakan paksaan cenderung mengganggu aliansi ini, menimbulkan ketidakpercayaan, dan memperkuat penghindaran dan pelepasan diri. Pengalaman mengalami perawatan paksa dikaitkan dengan trauma psikologis, kemarahan yang terus-menerus, dan penarikan diri dari sistem pendukung. Reaksi-reaksi ini bukan bersifat anekdot atau insidental, tetapi merupakan bukti kerusakan sistemik yang merusak perilaku mencari bantuan di masa depan dan membahayakan kepatuhan terhadap perawatan (Pozón, 2012; Villagrán et al, 2015; Serrano-Miguel, 2022).

Terlepas dari penerapan paksaan yang terus berlanjut dalam praktik dan wacana kejiwaan, ada konsensus internasional yang muncul bahwa pemulihan yang berkelanjutan membutuhkan penerapan intervensi non-koersif. Ini termasuk perawatan berbasis rumah yang intensif, perawatan komunitas asertif yang fleksibel, layanan krisis yang didukung oleh teman sebaya, dan pendekatan psikoterapi yang disesuaikan dengan budaya. Masing-masing model ini didasarkan pada keterlibatan sukarela

dan mengakui kompleksitas penderitaan mental sebagai sesuatu yang bersifat relasional, kontekstual, dan sering kali berhubungan dengan trauma. Penerapannya di berbagai tempat telah menunjukkan manfaat yang terukur, termasuk berkurangnya rawat inap, berkurangnya penggunaan layanan darurat, peningkatan fungsi sosial, dan peningkatan kualitas hidup. Intervensi ini tidak hanya lebih disukai secara etis, tetapi juga hemat biaya jika dibandingkan dengan biaya keuangan dan manusia secara kumulatif yang terkait dengan penerimaan pasien yang berulang kali, manajemen farmakologis kronis, dan infrastruktur peradilan yang diperlukan untuk menegakkan tindakan pemaksaan.

Menjauhi pengobatan paksa tidak hanya merupakan keharusan normatif tetapi juga merupakan strategi praktis untuk membangun sistem kesehatan mental yang efektif. Pencegahan kekambuhan dan pengurangan krisis kejiwaan baru paling baik dicapai dengan mengatasi faktor penentu sosial kesehatan jiwa dan memastikan kesinambungan perawatan. Program-program yang mencakup perumahan yang didukung, rehabilitasi berbasis komunitas, dan pengambilan keputusan partisipatif telah menunjukkan kemampuan untuk menumbuhkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada perawatan institusional. Investasi dalam alternatif ini tidak hanya membutuhkan realokasi sumber daya tetapi juga pergeseran dalam pelatihan klinis menuju kompetensi relasional, pemahaman naratif, dan kerendahan hati budaya. Sebaliknya, ketergantungan pada paksaan mencerminkan kegagalan imajinasi sistemik dan resistensi terhadap perubahan struktural. Hal ini memperkuat siklus di mana kemerosotan akut digunakan untuk membenarkan intervensi hukuman daripada ditafsirkan sebagai sinyal pengabaian sistemik (Serrano-Miguel, 2020; Parrabera-García et al, 2023).

Tabel 5. Praktik berbahaya, penyebab struktural, dan implikasi reformasi

Praktik berbahaya	Penyebab struktural	Dasar pembuktian	Implikasi untuk reformasi
Pembiusan secara paksa tanpa proses hukum	Kurangnya perlindungan, penghormatan terhadap otoritas klinis	Penelitian lapangan, kesaksian pengguna, data nasional	Implementasi kerangka kerja pengambilan keputusan yang didukung
Polifarmasi kronis	Tidak adanya protokol pemberian resep, bias farmakosentris	Laporan WHO, literatur klinis	Pedoman pemberian resep nasional, pelatihan profesional
Jangkauan diagnostik yang berlebihan	Hirarki epistemik, reduksionisme berbasis DSM	Kesaksian, catatan hukum, analisis etnografi	Revisi kriteria diagnostik, model naratif dan partisipatif
Ketidakmampuan pengguna secara hukum	Kemampuan struktural, paternalisme yuridis	CRPD, hukum perdata Spanyol, hukum kasus	Reformasi hukum, implementasi arahan lanjutan
Rawat inap yang dipaksakan	Penghindaran risiko kelembagaan, ketiadaan sumber daya masyarakat	Catatan rumah sakit, laporan ahli	Pengalihan dana ke layanan berbasis masyarakat
Penilaian dan keputusan yang bias gender	Paradigma diagnostik yang seksis, normativitas androsentris	Psikiatri feminis, data lapangan	Protokol sadar gender, pelatihan wajib tentang bias
Mengabaikan pengaduan atau bahaya yang dilaporkan	Penyangkalan kelembagaan, tidak adanya mekanisme akuntabilitas	Pengaduan, laporan ombudsman, wawancara lapangan	Perlindungan bagi pelapor, audit eksternal

Ringkasan praktik-praktik pemaksaan, kelalaian, atau pelanggaran etika, sumber-sumber pembuktian, dan implikasi untuk tindakan lebih lanjut-penelitian dan reformasi.

Konteks Spanyol menggambarkan ketegangan yang terus-menerus terjadi antara jaminan konstitusional kebebasan dan logika kustodian yang tertanam dalam praktik kejiwaan. Kerangka hukum yang ada saat ini sudah mengizinkan rawat inap paksa di bawah kondisi yang ketat dan menyediakan pengambilan keputusan pengganti dalam kasus-kasus ketidakmampuan yang dapat dibuktikan. Upaya-upaya yang dilakukan berulang kali untuk memperkenalkan bentuk-bentuk baru pemaksaan rawat jalan tidak menanggapi kekosongan hukum, melainkan bertujuan untuk memperluas mekanisme kontrol ke dalam kehidupan sehari-hari individu di luar lingkungan institusi. Perluasan semacam itu tidak memiliki pembenaran empiris dan menimbulkan kekhawatiran serius di bawah standar hak asasi manusia internasional. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah berulang kali menekankan bahwa setiap pembatasan kebebasan haruslah diperlukan, proporsional, dan tunduk pada pengawasan yudisial yang ketat. Dalam kasus pemaksaan rawat jalan, kriteria ini jarang sekali terpenuhi (SES-PAS, 2020; Francisco Torres-Gonzalez, 2022; Calcedo-Barba dkk., 2024; Pérez-Prieto dkk., 2025).

Jalan ke depan membutuhkan transisi yang disengaja dan berbasis bukti menuju sistem perawatan yang didasarkan pada otonomi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Transisi ini tidak hanya melibatkan reformasi hukum dan kebijakan, tetapi juga transformasi epistemik tentang bagaimana pengetahuan psikiatri diproduksi dan diterapkan. Paradigma klinis harus mengintegrasikan pengalaman hidup, mengakui keterbatasan kerangka kerja diagnostik saat ini, dan meninggalkan anggapan ketidakmampuan yang mendasari praktik pemaksaan. Pendidikan kedokteran harus memprioritaskan penalaran etis, refleksi kritis, dan keterlibatan dialogis. Institusi harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pemaksaan dan diberi insentif untuk mengadopsi praktik-praktik yang membangun kapasitas individu dan bukannya memaksakan kepatuhan. Pengguna

layanan, keluarga, dan masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam desain, implementasi, dan evaluasi perawatan. Tujuannya bukan hanya untuk mengurangi paksaan, tetapi juga untuk menciptakan kondisi di mana paksaan menjadi tidak diperlukan lagi. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan model perawatan yang sistematis yang berpusat pada martabat manusia, kesinambungan hubungan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri dalam kesehatan jiwa.

Tabel 6. Kegagalan sistemik dan mekanisme yang merugikan institusi

Kegagalan Sistemik	Mekanisme Kerugian	Dasar Pembuktian	Intervensi yang Diusulkan
Pengecualian epistemik	Diskoneksi pengalaman hidup, patologisasi perbedaan pendapat	Kerangka Makna Ancaman Kekuasaan, narasi pasien	Penyertaan pengetahuan berdasarkan pengalaman dalam penilaian klinis
Kegagalan umpan balik	Kurangnya pelacakan hasil, tidak ada pembelajaran dari kesalahan	Penelitian lapangan, kasus malpraktek, kerangka kerja WHO QualityRights	Sistem audit partisipatif, peningkatan kualitas berkelanjutan
Kekebalan hukum institusional	Tidak adanya sanksi untuk penyalahgunaan atau pengabaian	Laporan Ombudsman, proses hukum	Reformasi hukum, badan pengawas independen
Kelambanan kebijakan	Keterputusan antara bukti dan kebijakan	Tinjauan literatur, evaluasi Horizon Eropa	Integrasi antarmuka ilmu pengetahuan-kebijakan
Melumpuhkan tata kelola	Pengambilan keputusan tanpa masukan dari pengguna	Model komparatif (misalnya, dialog terbuka)	Partisipasi musyawarah, protokol perawatan yang demokratis
Performativitas etika	Komite etika digunakan sebagai kedok birokrasi	Observasi lapangan, analisis kasus	Struktur tata kelola etika yang transparan dan akuntabel

Mensintesiskan kegagalan mendasar dalam tata kelola, umpan balik, dan legitimasi yang melanggar praktik-praktik berbahaya dalam sistem kejiwaan, dan menguraikan bidang-bidang intervensi struktural yang sesuai.

Pembenaran untuk perawatan rawat jalan wajib di Spanyol semakin bertumpu pada konstruksi kronisitas psikiatrik tertentu, yang dibingkai sebagai kondisi yang stabil dan dapat diverifikasi secara medis yang memerlukan manajemen farmakologis berkelanjutan di bawah pengawasan profesional. Argumen yang mendukung langkah-langkah tersebut menekankan hilangnya wawasan dan kurangnya kepatuhan sebagai indikator diagnostik patologi. Pernyataan-pernyataan ini sering kali bergantung pada asumsi yang belum diteliti bahwa individu yang didiagnosis dengan skizofrenia atau gangguan bipolar pasti akan kambuh tanpa perawatan farmakologis, dan bahwa penolakan pengobatan itu sendiri merupakan bukti penyakit. Usulan untuk memaksakan pengobatan di lingkungan masyarakat tidak muncul dari superioritas terapeutik yang telah terbukti, tetapi dari logika institusional yang berorientasi pada mitigasi risiko, pengendalian biaya, dan manajemen reputasi.

Dalam wacana klinis, psikosis sering digambarkan tidak hanya sebagai gangguan kognisi atau afek, tetapi juga sebagai penangguhan hak-hak sipil dan hukum. Otonomi secara rutin dibatalkan oleh penilaian yang menyamakan perbedaan pendapat dengan ketidakmampuan. Narasi yang berulang-ulang memposisikan individu-individu tertentu secara inheren tidak dapat bertindak untuk kepentingan terbaik mereka sendiri karena adanya dugaan defisit kesadaran diri. Di bawah paradigma ini, rawat jalan paksa disajikan sebagai alternatif yang manusiawi dan proporsional untuk rawat inap. Bahasa perawatan berfungsi untuk mengaburkan fungsi pendisiplinan. Instrumen hukum

mendefinisikan ulang tujuan terapeutik, dan pengobatan menjadi intervensi dan prasyarat untuk kebebasan hukum. Spanyol belum memberlakukan undang-undang khusus yang mengesahkan perawatan rawat jalan paksa. Meskipun demikian, interpretasi yudisial telah memungkinkan pembebasan bersyarat dan pengaturan hukum sementara yang meniru fungsinya. Para pendukungnya sering menggunakan preseden internasional, seperti Kendra's Law di New York atau Mental Health Act di Inggris dan Wales, untuk berargumen tentang kodifikasi hukum tindakan rawat jalan paksa. Manfaat yang diharapkan termasuk pengurangan rawat inap, peningkatan kepatuhan pengobatan, dan penurunan interaksi dengan sistem peradilan pidana. Namun, metrik ini gagal menangkap kesejahteraan subjektif atau pemulihan pribadi. Mereka lebih mengandalkan proksi institusional dari kepatuhan dan kontak, daripada hasil yang berpusat pada orang (Watnik, 2001; Brown et al, 2023).

Nilai terapeutik dari antipsikotik masih menjadi bahan perdebatan yang sedang berlangsung, terutama dalam konteks penggunaan jangka panjang. Meskipun pengurangan gejala psikotik akut dalam jangka pendek telah diamati, literatur menunjukkan hubungan yang kompleks dan sering kali tidak meyakinkan antara penggunaan obat yang berkelanjutan dan lintasan pemulihan jangka panjang. Meta-analisis belum menunjukkan perbedaan yang konsisten dalam hasil fungsional ketika membandingkan individu yang menjalani perawatan paksaan dengan mereka yang menerima perawatan secara sukarela. Asumsi yang tersebar luas bahwa farmakoterapi perawatan mencegah kekambuhan belum teruji secara memadai dalam kondisi pilihan yang terinformasi dan tanpa paksaan. Penggunaan suntikan jangka panjang tanpa persetujuan menimbulkan masalah etika yang signifikan. Kemudahan prosedural dari formulasi semacam itu mengaburkan kekerasan struktural yang terlibat dalam pemaksaan perilaku secara kimiawi. Banding terhadap kronisitas kejiwaan sering digunakan untuk mengesampingkan preferensi dan agensi pengguna layanan. Kronisitas biasanya dibingkai sebagai keniscayaan biologis, bukan sebagai konstruksi yang dimediasi secara sosial dan kontingen terapeutik. Pembungkahan ini menghapus peran trauma, pengucilan sosial, dan pengkhianatan institusional yang terdokumentasi dengan baik dalam etiologi dan kelanggengan gangguan kejiwaan. Hal ini juga menutup kemungkinan pemulihan yang berarti tanpa pengobatan. Dalam perdebatan kebijakan di Spanyol, tidak jarang kita mendengar bahwa keluarga membutuhkan instrumen hukum untuk memaksa kerabatnya menerima pengobatan. Namun, paksaan sering kali merusak kepercayaan, mengasingkan pengguna dari layanan, dan mereproduksi siklus pelepasan dan kemunduran. Pernyataan bahwa pengobatan paksa mendukung aliansi terapeutik pada dasarnya cacat. Pemaksaan dan aliansi tidak dapat dipisahkan (Moncrieff, 2008; Kinderman, 2014; Gøtzsche, 2015).

Terbatasnya penelitian empiris yang dikutip untuk membela pengobatan rawat jalan paksa di Spanyol memiliki keterbatasan metodologis yang signifikan. Ini termasuk bias seleksi, tidak adanya pengacakan, kurangnya kelompok kontrol yang tepat, dan kriteria hasil yang tidak jelas atau tidak terstandarisasi. Kekurangan tersebut mengganggu validitas dan generalisasi temuan mereka. Sebaliknya, literatur yang berkembang tentang pengambilan keputusan bersama menawarkan bukti yang kuat dan dapat direplikasi bahwa perencanaan perawatan kolaboratif meningkatkan kepatuhan, meningkatkan kepuasan, dan mengarah pada hasil klinis dan fungsional yang lebih baik. Individu yang didengar, dihormati, dan dilibatkan secara nyata lebih mungkin untuk berpartisipasi secara bermakna dalam pemulihan mereka sendiri. Kapasitas pengambilan keputusan tidak bersifat tetap, melainkan situasional dan relasional, yang dibentuk oleh kualitas lingkungan terapeutik. Perawatan

rawat jalan yang dipaksakan akan merusak kondisi yang mendukung ini dan mengikis infrastruktur relasional yang menjadi dasar dari pemulihan yang berkelanjutan (Viadel et al, 2006; Portero, 2010; Cañete-Nicolás et al, 2012).

Penggunaan obat dalam kerangka kerja rawat jalan yang tidak disengaja biasanya ditentukan oleh kemanfaatan klinis dan bukan oleh dialog terapeutik individual. Regimen sering kali terstandardisasi, dengan penyesuaian minimal berdasarkan toleransi, efek samping, atau pengalaman yang dilaporkan pasien. Ketergantungan yang dominan pada suntikan jangka panjang mencerminkan model perawatan yang farmakosentris dan berorientasi pada kepatuhan. Intervensi psikologis dan sosial secara nominal diakui tetapi jarang dioperasionalkan dalam kerangka kerja yang bersifat memaksa. Para dokter sendiri mengakui bahwa infrastruktur yang ada tidak memadai untuk memberikan layanan pemulihan yang komprehensif dan berbasis komunitas. Pemaksaan berfungsi sebagai mekanisme kompensasi untuk pengabaian sistemik. Argumen yang menyatakan bahwa pengobatan paksa menjamin stabilitas mengabaikan kenyataan bahwa tindakan seperti itu paling sering digunakan di lingkungan yang tidak memiliki alternatif terapi yang layak (Sheridan Rains et al., 2019).

Pemulihan tidak dapat direduksi menjadi penekanan gejala. Pemulihan melibatkan pembentukan kembali makna, pemulihan agensi, dan rekonstruksi peran sosial. Praktik-praktik pemaksaan meratakan kompleksitas ini. Mereka mempatologiskan perlawanan dan membingkai ulang perbedaan pendapat sebagai kemunduran klinis. Hasilnya bukanlah stabilisasi tetapi justru semakin mengakarnya kerusakan epistemik dan relasional. Individu yang mengalami pemaksaan secara konsisten melaporkan rasa takut, penghinaan, dan ketidakpercayaan yang berkepanjangan terhadap sistem kesehatan. Respon-respon ini bukanlah tanda-tanda psikopatologi, melainkan reaksi adaptif terhadap kekerasan struktural. Mengklaim bahwa pemaksaan adalah perawatan berarti menghapus pengalaman hidup mereka yang paling terdampak dan melanggengkan model psikiatri yang berakar pada dominasi dan bukannya penyembuhan (Eiroa-Orosa & Rowe, 2017; Kalathil, 2018).

Pembelaan terhadap perawatan rawat jalan paksa sering kali didasarkan pada alasan keamanan publik dan efisiensi administratif. Namun, ini bukanlah tujuan terapeutik. Hal ini mencerminkan prioritas institusi yang tidak selaras dengan tujuan pemulihan dan kesejahteraan individu. Wacana tentang risiko itu sendiri bermasalah. Hal ini sering kali bersifat rasial, gender, dan bias secara sosioekonomi. Anggapan bahwa individu atau kelompok tertentu secara inheren berbahaya mengarah pada penegakan hukum yang sewenang-wenang dan diskriminatif. Dalam konteks Spanyol, seperti halnya di negara lain, intervensi pemaksaan secara tidak proporsional mempengaruhi mereka yang tidak memiliki dukungan keluarga, mereka yang memiliki sumber daya keuangan yang terbatas, dan mereka yang berasal dari latar belakang migran atau minoritas. Kerentanan struktural menjadi medis, dan beban adaptasi ditempatkan pada mereka yang paling tidak memiliki hak (Jacka & Berk, 2012; Kidd et al., 2015a; Walker et al., 2019).

Untuk memastikan perbaikan dalam hal ini dan semua kegagalan sistemik, disertasi ini dilakukan melalui keterlibatan yang tertanam dalam jaringan nasional dan internasional, termasuk tindakan penelitian formal, pengaturan klinis, dan inisiatif kebijakan, sejalan dengan desain penelitian tindakan partisipatif. Lingkungan kolaboratif ini tidak bersifat perifer, tetapi merupakan tempat penelitian lapangan yang tidak terpisahkan, di mana pengetahuan dihasilkan bersama melalui pertukaran yang

berulang, analisis refleksif, dan praksis yang berorientasi pada tujuan. Rekan-rekan peneliti dan partisipan berfungsi secara bersamaan sebagai informan kunci, lawan bicara yang kritis, dan penghasil data empiris, kerangka kerja interpretatif, dan pencapaian operasional. Model yang tertanam ini mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas ilmiah, memungkinkan triangulasi perspektif dan meningkatkan potensi translasi temuan. Dari sudut pandang antropologi medis, pendekatan ini sejalan dengan keharusan etis untuk berkontribusi secara konstruktif pada sistem yang diteliti, daripada mempertahankan sikap observasi yang terpisah. Keterlibatan konstruktif, yang dilandasi oleh ketelitian empiris dan ketanggapan yang sesuai dengan situasi, bukan sekadar pilihan metodologis, seperti yang ditunjukkan dalam bab 2, tetapi juga merupakan kewajiban disiplin ketika menyelidiki struktur perawatan kesehatan yang secara aktif menghasilkan penderitaan atau perlindungan. Orientasi ini memastikan bahwa karya ini tidak hanya mendokumentasikan disfungsi sistemik tetapi juga berkontribusi pada penyelesaiannya, sesuai dengan metode ilmiah dan prinsip-prinsip perawatan relasional (Schneider, 2012; Rose, 2018).

Dalam disertasi ini, pemulihan didefinisikan sebagai pemulihan dan pemeliharaan regulasi fisiologis, otonomi fungsional, dan agensi psikososial yang berkelanjutan, yang dinilai melalui hasil multidimensi. Ini termasuk pengurangan ketergantungan farmakologis yang terukur jika diindikasikan secara klinis, normalisasi penanda neuroendokrin dan inflamasi, peningkatan integrasi kognitif-afektif, dan kemampuan yang ditunjukkan untuk terlibat secara bermakna dalam peran relasional, pendidikan, dan kejuruan. Praktik terbaik didefinisikan sebagai prosedur klinis dan institusional yang, di seluruh populasi dan konteks, mendukung hasil ini dengan efek samping minimal dan keterlibatan pengguna yang maksimal. Praktik-praktik tersebut dicirikan oleh persetujuan yang diinformasikan, penyesuaian kontekstual, dan akuntabilitas yang dinamis, yang memungkinkan kalibrasi perawatan sebagai respons terhadap kondisi individu dan sistemik yang terus berkembang. Pemulihan dikonseptualisasikan bukan sebagai keadaan yang tetap tetapi sebagai pencapaian proses yang dinamis dan bergantung pada koherensi ekologis, daya tanggap kelembagaan, dan tidak adanya kekerasan epistemik dan struktural. Dalam kerangka kerja ini, pemaksaan tidak diklasifikasikan sebagai terapi, tetapi sebagai mekanisme kontrol dan manajemen risiko, yang penggunaannya terus menerus dalam pengaturan klinis, termasuk dalam bentuk hukuman atau di luar hukum, merusak legitimasi dan kemanjuran perawatan kejiwaan. Keberadaannya menandakan kegagalan sistemik dalam membangun lingkungan perawatan yang aman dan beretika, dan pemberantasannya tetap menjadi keharusan medis, hukum, dan ilmiah (Mezzina et al., 2006b).

1.3 Penggunaan obat yang berlebihan dan farmakosentrisme dalam perawatan kesehatan dan psikiatri di Spanyol

Penggunaan obat-obatan psikotropika yang berlebihan dalam layanan kesehatan Spanyol tidak disebabkan oleh kesalahan klinis yang terisolasi atau kelalaian profesional, tetapi lebih mencerminkan implementasi sistematis dari model medis di mana manajemen farmakologis menempati posisi yang dominan dan dilegitimasi secara struktural. Kegigihan pengobatan yang berlebihan menunjukkan konfigurasi kelembagaan yang beraneka ragam, yang dibentuk oleh kebiasaan profesional, kerangka kerja legislatif, kurikulum pendidikan, pengaruh industri, dan

norma-norma budaya perawatan. Spanyol berada di antara negara-negara tertinggi di Eropa dalam hal konsumsi ansiolitik dan antidepresan, dengan benzodiazepin, inhibitor reuptake serotonin selektif, dan antipsikotik atipikal yang diresepkan dengan jumlah yang secara konsisten melebihi rekomendasi pedoman klinis. Penggunaan yang berlebihan ini memengaruhi populasi pasien yang beragam, seringkali tanpa pembuktian diagnostik yang ketat, tanpa penilaian risiko jangka panjang yang terinformasi, dan dalam konteks di mana asal-usul biopsikososial dari gangguan tersebut masih belum diperiksa. Penyebaran respons farmakologis di luar psikiatri spesialis, terutama melalui dokter umum dan layanan gawat darurat, menggambarkan pengukuhan farmakosentrisme secara institusional sebagai reaksi standar terhadap gejala psikologis dan perilaku. Orientasi klinis ini, yang ditopang oleh kepentingan ekonomi dan tekanan waktu, menghasilkan penyempitan pilihan pengobatan secara patologis, di mana penekanan gejala menggantikan diagnosis, pemantauan, dan aliansi terapeutik (Cohen, 1975; Jiménez, 2005).

Resep psikotropika sering kali dimulai dan dipertahankan sebagai respons terhadap tekanan hidup, kehilangan interpersonal, atau kesulitan sosial yang kronis, bahkan tanpa adanya gangguan kejiwaan yang utama. Solusi farmakologis dimobilisasi sebagai respons terhadap kelelahan, insomnia, kecemasan, keluhan somatik, dan konflik keluarga, tanpa diagnosis banding yang memadai, konsultasi multidisiplin, atau penyediaan intervensi non-farmakologis. Pola ini menghasilkan pemberian obat kronis yang pada awalnya ditujukan untuk penggunaan jangka pendek atau krisis. Benzodiazepin, misalnya, yang disetujui untuk penanganan sementara kecemasan akut dan gangguan tidur, secara luas dipertahankan untuk jangka waktu beberapa tahun. Spanyol secara konsisten berada di antara negara-negara pengonsumsi benzodiazepin teratas di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, dengan prevalensi yang jauh melebihi kejadian epidemiologis gangguan terkait kecemasan yang membutuhkan perawatan farmakologis. Konsekuensi dari penyalahgunaan ini termasuk pengembangan toleransi, ketergantungan, sindrom putus zat, gangguan kognitif, dan penurunan fungsional. Efek biologis ini diperparah dengan ketergantungan psikologis, gangguan agensi, dan penguatan kapasitas dan identitas yang dimediskan (Cañete-Nicolás et al., 2015; Francisco Torres-Gonzalez, 2022).

Resep yang dikeluarkan oleh dokter non-spesialis merupakan mayoritas dari penggunaan ansiolitik dan antidepresan di Spanyol. Hal ini mencerminkan konfigurasi struktural perawatan kesehatan yang memprioritaskan hasil, pengelolaan administratif, dan penyelesaian gejala daripada penilaian yang berpusat pada orang dan kesinambungan perawatan. Dokter umum secara rutin ditugaskan untuk mengelola presentasi kesehatan mental yang kompleks dalam waktu kurang dari sepuluh menit per konsultasi, dengan akses yang terbatas ke jaringan rujukan, psikoterapi, atau tindak lanjut kasus. Efeknya adalah sebuah sistem di mana obat-obatan diresepkan sebagai tindakan sementara karena tidak adanya waktu, sumber daya, dan jalur institusional untuk perawatan yang komprehensif. Obat psikotropika dalam situasi seperti itu menjadi instrumen tidak hanya untuk mengendalikan gejala, tetapi juga untuk mengendalikan organisasi. Pasien yang gagal membaik dengan rejimen ini sering kali didaur ulang melalui layanan kesehatan dengan dosis yang meningkat, diagnosis tambahan, dan polifarmasi, tanpa tinjauan sistematis terhadap asumsi awal atau eksplorasi alternatif. Fenomena ini tidak dapat direduksi menjadi inersia farmakologis, tetapi harus dipahami sebagai korelasi fungsional

dari infrastruktur layanan kesehatan yang terfragmentasi, kekurangan sumber daya, dan menghindari risiko.

Dalam layanan psikiatri, dominasi struktural pendekatan farmakologis sangat menonjol. Obat antipsikotik, termasuk obat suntik jangka panjang, semakin banyak digunakan tidak hanya untuk gangguan psikotik tetapi juga untuk pengaturan perilaku di berbagai diagnosis non-psikotik, termasuk disabilitas intelektual, demensia, dan gangguan kepribadian ambang. Resep-resep ini sering kali dimulai dan dilanjutkan tanpa indikasi klinis yang kuat, tanpa persetujuan yang terdokumentasi, dan tanpa evaluasi sistematis terhadap rasio risiko-manfaat. Pemberian antipsikotik jangka panjang dikaitkan dengan efek samping yang signifikan, termasuk sindrom metabolik, gejala ekstrapiramidal, sedasi, penurunan kognitif, dan peningkatan mortalitas. Terlepas dari risiko-risiko yang terdokumentasi dengan baik ini, depreskripsi masih jarang terjadi, dan rejimen farmakologis sering kali ditingkatkan sebagai respons terhadap tantangan perilaku, konflik institusional, atau perselisihan profesional, daripada melalui evaluasi ulang klinis. Pola ini ditopang oleh defisit pelatihan, masalah pertanggungjawaban, dan pelembagaan kepatuhan farmakologis sebagai proksi keberhasilan terapi (Bobes et al., 2012; Guzmán-Parra et al., 2018; Aragonés-Calleja & Sánchez-Martínez, 2023). Masalah pengobatan berlebihan juga harus dipahami dalam kaitannya dengan tidak adanya intervensi psikososial yang terintegrasi. Layanan kesehatan jiwa komunitas di Spanyol tidak terdistribusi secara merata, kekurangan sumber daya, dan berorientasi pada stabilisasi farmakologis daripada pemulihan atau reintegrasi sosial. Psikoterapi, terapi okupasi, dukungan teman sebaya, dan konseling keluarga secara kronis kekurangan dana, dilaksanakan secara sporadis, dan di banyak daerah tidak dapat diakses secara efektif. Dalam kekosongan ini, strategi farmakologis mendapatkan monopoli atas legitimasi terapeutik. Pasien dan keluarga menyamakan perawatan dengan pengobatan, dan penolakan ditafsirkan sebagai ketidakrasionalan atau penyangkalan terhadap penyakit. Institusi-institusi menginternalisasi logika ini, dan dokter beroperasi dalam kerangka kerja di mana peresepan adalah tindakan yang paling mudah tersedia, diganti, dan dilindungi secara institusional. Hal ini menciptakan lingkaran umpan balik di mana pengobatan berlebihan menjadi penguat diri, terlindung dari pengawasan oleh ekspektasi budaya, desain kelembagaan, dan norma-norma profesional.

Sistem pendidikan mereproduksi paradigma ini. Kurikulum medis di Spanyol memberikan perhatian yang terbatas pada dimensi historis, sosiologis, atau psikologis dari penderitaan mental. Farmakologi dan klasifikasi diagnostik diprioritaskan, sementara praktik reflektif, keterampilan relasional, dan pendekatan berbasis trauma tetap menjadi hal yang perifer. Mahasiswa tidak dilatih secara sistematis dalam pengambilan keputusan bersama, otonomi pasien, atau jalur non-farmakologis menuju pemulihan. Sebaliknya, mereka disosialisasikan ke dalam model perawatan di mana keberhasilan terapi ditentukan oleh pengurangan gejala dan kepatuhan. Tidak adanya kewaspadaan farmakovigilans yang kritis, di samping pelatihan terbatas dalam pemberian obat, mengarah pada lintasan profesional di mana obat digunakan secara dini, luas, dan tanpa batas waktu. Pendidikan berkelanjutan, yang sering kali didanai atau dipengaruhi oleh kepentingan farmasi, memperkuat pola-pola ini, menghadirkan inovasi farmakologis yang identik dengan kemajuan klinis, dan mengaburkan batas-batas etis dan empiris dari praktik yang ada saat ini (Montero, 2014).

Manajemen farmakologis dari gangguan semakin diperkuat oleh faktor sosiokultural yang lebih luas yang memfasilitasi medisikasi dan menghambat respons sistemik. Di Spanyol, tingginya angka resep

untuk obat-obatan psikotropika bukan hanya hasil dari keputusan klinis, namun juga mencerminkan pola yang meluas dalam mengobati penderitaan sosial. Kemiskinan, pengangguran, perumahan yang tidak layak, dan stres kronis yang terkait dengan tanggung jawab pengasuhan atau kekerasan dalam rumah tangga sering kali diterjemahkan ke dalam gejala kejiwaan dalam pertemuan klinis. Alih-alih bertindak berdasarkan faktor penentu sosial kesehatan, sistem perawatan kesehatan sering kali menyerap konsekuensinya melalui bahasa diagnosis dan mekanisme resep. Pengalihan tanggung jawab dari kebijakan publik ke subjek individu ini memperkuat narasi biomedis di mana kesulitan struktural dibingkai ulang sebagai disfungsi pribadi, yang dapat diobati terutama melalui cara-cara farmakologis. Hasilnya adalah ketidaksesuaian kronis antara diagnosis dan kenyataan, di mana beban kegagalan sistemik didistribusikan kembali sebagai patologi individu (Laporte et al, 1983; Bertolín-Guillén, 2021; Suleman et al, 2025).

Fenomena ini terutama terlihat di layanan primer, di mana dokter umum diharapkan untuk menangani pasien dalam jumlah besar dalam waktu yang terbatas, seringkali tanpa akses ke sumber daya psikososial atau pilihan rujukan. Dalam keterbatasan ini, pengobatan tidak hanya menjadi jalan yang paling sedikit resistensi tetapi juga menjadi satu-satunya alat yang tersedia. Benzodiazepin dan antidepresan secara rutin digunakan untuk menangani kondisi yang muncul akibat deprivasi sosial ekonomi, konflik interpersonal, dan stres kehidupan yang kumulatif. Meskipun obat-obatan tersebut dapat memberikan bantuan sementara, penggunaan jangka panjang pada populasi yang kurang beruntung secara struktural akan memperkuat ketergantungan, merusak pengembangan strategi penanggulangan adaptif, dan menunda atau menggantikan intervensi yang mengatasi penyebab yang mendasarinya. Paparan kronis terhadap obat-obatan ini membawa risiko kesehatan yang signifikan, terutama di kalangan orang dewasa yang lebih tua, yang risiko jatuh, gangguan kognitif, dan cedera iatrogenik meningkat secara nyata. Dalam konteks ini, pemberian obat yang berlebihan menjadi vektor bahaya medis, yang ditopang oleh ketidakpedulian institusi terhadap kondisi yang menimbulkan penderitaan (Santamaría, 2020; Bertolín-Guillén, 2021; Roncero et al, 2025).

Tabel 7. Logika sistemik dari pemaksaan kejiwaan dan pengobatan berlebihan

Tahap	Jalan Kiri Faktor Penentu Individu dan Sosial	Jalan Kanan: Kendala Kelembagaan dan Hukum	Hasil
1. Kondisi Struktural	Faktor penentu sosiostruktural (misalnya, kemiskinan, trauma)		
2. Presentasi Awal	Presentasi gejala kejiwaan	Penghindaran risiko dan kendala hukum	
3. Pemingkiaan Institusional	Dibingkai sebagai gangguan individu	Perawatan berbasis protokol (varians rendah, kontrol tinggi)	
4. Penugasan Diagnostik	Pemberian label diagnostik	Intervensi farmakosentris	
5. Hasil Institusional			Kronisitas, pengucilan, resistensi terhadap reformasi

Tabel ini menguraikan logika institusional yang berurutan di mana penderitaan sosial dibingkai ulang sebagai gangguan individu, yang mengarah pada intervensi psikiatri yang bersifat koersif. Tabel ini menunjukkan interaksi antara faktor penentu sosiostruktural dan kendala legal-institusional, yang menunjukkan bagaimana pelabelan diagnostik dan protokol farmakosentris bertemu untuk menghasilkan kronisitas, pengucilan, dan resistensi terhadap reformasi. Model ini mencerminkan mekanisme kekerasan struktural yang tertanam dalam tata kelola klinis dan

menyoroti perlunya desain ulang sistemik yang didasarkan pada otonomi pasien, akuntabilitas etis, dan praktik yang berorientasi pada pemulihan.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, biaya pendekatan farmakosentris ini sangat besar. Secara finansial, alokasi sumber daya untuk pengadaan, distribusi, dan pemantauan obat mengalihkan dana dari intervensi pencegahan dan berbasis masyarakat. Secara klinis, ketergantungan yang berlebihan pada obat berkontribusi pada rawat inap yang tidak perlu, presentasi yang resisten terhadap pengobatan, dan peningkatan tingkat kecacatan kronis. Secara psikososial, hal ini mengikis kepercayaan terhadap sistem layanan kesehatan, menstigmatisasi kesusahan, dan memecah belah jalinan hubungan yang diperlukan untuk pemulihan jangka panjang. Oleh karena itu, beban kumulatif dari pengobatan yang berlebihan tidak hanya terbatas pada pasien, tetapi juga meluas ke keluarga, profesional, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegigihannya menunjukkan krisis epistemologis yang lebih dalam dalam perawatan kesehatan, di mana ukuran keberhasilan tidak selaras dengan realitas penderitaan manusia, dan di mana janji ketepatan teknologi mengaburkan kebutuhan akan kepekaan etis dan kontekstual (Laporte, 1984; Díaz-Gutiérrez dkk, 2018).

Bukti yang disajikan dalam bagian ini menegaskan bahwa pengobatan berlebihan dalam psikiatri Spanyol tidak dapat dijelaskan sebagai serangkaian kesalahan yang terisolasi atau kebiasaan yang tidak menguntungkan. Ini adalah fitur sistemik dari ekosistem klinis yang mengutamakan solusi farmasi, kenyamanan institusional, dan otoritas epistemik dibandingkan pengalaman pasien, reformasi struktural, dan perawatan relasional. Mengatasi disfungsi ini membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan multidisiplin, yang mampu menghadapi asumsi budaya dan praktik kelembagaan yang menopang hegemoni farmakosentris. Bagian selanjutnya akan membahas dasar pemikiran, prinsip-prinsip, dan strategi implementasi manajemen pengobatan otonom dan praktik-praktik lain yang berlandaskan ilmiah yang dapat memulihkan integritas klinis dan memajukan hasil kesehatan dalam kerangka kerja yang berbasis hak, partisipatif, dan sesuai dengan etika.

1.4 Menuju manajemen pengobatan yang otonom dan praktik-praktik yang lebih baik berbasis bukti

Perkembangan internasional dalam perawatan psikiatri telah secara progresif menantang dominasi historis dari paradigma pengobatan yang paternalistik, berpusat pada farmakologis, dan berorientasi pada kepatuhan. Manajemen pengobatan otonom telah muncul dalam konteks ini sebagai kerangka kerja yang berlandaskan ilmiah dan diperlukan secara etis, yang bertujuan untuk mengkonfigurasi ulang farmakoterapi psikiatri sebagai proses yang dialogis dan berbasis bukti, dan bukannya pemaksaan secara sepihak. Di berbagai sistem kesehatan di Amerika Utara dan Eropa, studi empiris dan longitudinal telah mengidentifikasi masalah klinis dan kesehatan masyarakat yang signifikan terkait dengan penggunaan jangka panjang obat psikotropika, termasuk sindrom metabolik, risiko kardiovaskular, gangguan neurokognitif, tumpulnya emosi, dan perubahan kognisi sosial. Efek-efek ini, yang diperparah dengan prosedur persetujuan yang tidak memadai dan rezim pengobatan yang secara struktural memaksa, telah mendorong kritik berkelanjutan dari psikiatri akademis dan advokasi yang dipimpin oleh pengguna. Bersamaan dengan itu, kerangka kerja kebijakan di yurisdiksi seperti

Quebec, Brasil, Belanda, dan Finlandia telah mengintegrasikan model perawatan alternatif, yang mencerminkan pergeseran dalam penalaran klinis dan etika. Model-model ini menekankan pemulihan, koherensi naratif, pemahaman kontekstual, dan pengambilan keputusan relasional, memposisikan obat bukan sebagai poros intervensi tetapi sebagai salah satu elemen yang dapat dimodifikasi dalam pengaturan terapeutik yang terus berkembang. Pembimbingan ulang ini telah didukung oleh uji coba terkontrol, data kohort dunia nyata, dan pernyataan konsensus transdisipliner yang menggarisbawahi perlunya mengurangi beban pengobatan, menerapkan protokol tapering, dan membina lingkungan perawatan yang partisipatif (Deegan, 2006; Chmielowska dkk., 2022; Horowitz, 2024).

Model Quebec, terutama dikembangkan melalui karya Jean-François Pelletier dan Marie-Jeanne Proulx, mensistematisasi manajemen pengobatan kolaboratif sebagai praktik refleksif relasional dan etis yang berlandaskan pada paradigma pemulihan. Didasari oleh penelitian trauma, otonomi pasien, dan akuntabilitas klinis bersama, model ini menekankan produksi pengetahuan melalui dialog, reorientasi otoritas klinis, dan integrasi dukungan rekan sejawat ke dalam keputusan farmakologis. Strategi ini dioperasionalkan melalui dialog terstruktur, tim terapeutik yang tidak hirarkis, dan perencanaan perawatan yang fleksibel yang responsif terhadap lintasan kesusahan dan pemulihan individu. Di Brasil, penerjemahan prinsip-prinsip ini ke dalam konteks yang ditandai dengan perawatan komunitas psikososial, konstitusionalisme kesehatan kolektif, dan reformasi anti-kelembagaan menghasilkan sebuah model di mana strategi pengurangan pengobatan tertanam dalam komitmen politik yang lebih luas terhadap deinstitutionalisasi dan psikiatri berbasis hak. Sistem di Brasil menunjukkan bahwa manajemen pengobatan tidak dapat dipisahkan dari faktor penentu sosio-legal, seperti akses terhadap perumahan, pendapatan, dan sumber daya masyarakat. Dengan mengintegrasikan resep psikotropika ke dalam kontinum kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial, pendekatan Brasil menyoroti perlunya dukungan kolektif dan kerangka hukum yang memperkuat legitimasi perawatan non-farmakologis (Canadian Deprescribing Guidelines Project, 2024).

Di Belanda dan Finlandia, praktik dialog terbuka telah memberikan landasan empiris lebih lanjut untuk model psikiatri yang berpusat pada pengguna dan rendah obat. Praktik-praktik ini, yang mengintegrasikan keterlibatan keluarga dan masyarakat secara terus menerus, proses dialogis secara real-time, dan ketergantungan minimal pada kategorisasi diagnostik, telah memberikan hasil yang signifikan secara statistik dalam hal pengurangan rawat inap, penggunaan obat kronis yang lebih rendah, dan metrik pemulihan yang lebih tinggi yang dilaporkan oleh pasien. Terlepas dari hasil ini, pelembagaan model-model tersebut masih terbatas karena kelembaman sistemik, kendala keuangan, dan resistensi disiplin dalam tata kelola psikiatri konvensional. Analisis komparatif dari yurisdiksi ini mengungkapkan bahwa manajemen pengobatan otonom bukanlah cita-cita etis yang abstrak, tetapi kerangka kerja klinis yang layak yang bergantung pada dukungan yang saling terkait: pelatihan ulang klinis, alat bantu yang dipimpin oleh pasien, infrastruktur digital, dan pengakuan hukum atas hak-hak partisipatif. Korpus empiris ini menetapkan kelayakan konseptual, etis, dan praktis dari sebuah model di mana penggunaan obat tidak ditentukan oleh protokol standar atau mandat institusional, tetapi diproduksi bersama dalam ekosistem klinis yang sesuai dengan situasi, relasional, dan melekat fisiologis (Seikkula & Olson, 2003; Olson dkk., 2014; Groot & van Os, 2023).

Hambatan terhadap adopsi manajemen pengobatan otonom secara luas masih signifikan, terutama dalam konteks seperti Spanyol di mana tradisi klinis, protokol institusional, dan hierarki profesional terus mengistimewakan intervensi farmakologis sebagai landasan perawatan kejiwaan. Meskipun ada pergeseran retorika ke arah prinsip-prinsip yang berorientasi pada pemulihan dan penyertaan formal hak-hak pasien dalam strategi kesehatan jiwa nasional, komitmen ini sering kali gagal terwujud dalam praktik klinis. Kendala struktural termasuk tidak adanya pelatihan dalam perawatan yang dialogis dan berbasis trauma, terbatasnya ketersediaan alternatif psikososial, dan budaya hukum-medis yang menghukum kebijaksanaan klinis yang dianggap menyimpang dari standar farmakosentris. Kendala-kendala ini diperkuat oleh desain sistem informasi kesehatan yang melacak kepatuhan pengobatan sebagai proksi untuk perbaikan klinis, sehingga mengukuhkan kepatuhan farmakologis sebagai indeks keberhasilan perawatan. Hasilnya adalah lingkungan klinis di mana permintaan pasien untuk mengurangi atau menghentikan pengobatan sering ditafsirkan sebagai tanda penolakan, perlawanan, atau kurangnya wawasan, daripada sebagai ekspresi dari agen yang terinformasi. Kerangka kerja interpretatif ini tidak hanya mendelegitimasi pengetahuan eksperimental dari individu dengan pengalaman langsung tetapi juga mendiskinsentif praktik reflektif di antara para profesional, yang tetap tertanam dalam budaya penghindaran risiko dan ortodoksi diagnostik (Serrano-Miguel et al, 2020; Martínez-Hernández et al, 2020).

Lebih lanjut, masalah ini semakin diperparah dengan adanya asimetri literasi ilmiah dan otoritas epistemik antara pasien dan profesional. Dengan tidak adanya pedoman klinis yang dibuat bersama dan platform bersama untuk penyebaran pengetahuan, pasien sering kali tidak mendapatkan informasi yang diperlukan untuk terlibat secara bermakna dalam pengambilan keputusan farmakologis. Banyak yang tetap tidak menyadari berbagai risiko yang terkait dengan penggunaan obat jangka panjang, proses fisiologis yang mendasari sindrom putus obat, atau alternatif yang didukung oleh bukti internasional. Penyebaran pedoman resep akses terbuka, alat bantu keputusan digital interaktif, dan modul pelatihan yang dipimpin oleh pasien masih terbatas pada program percontohan tertentu dan jarang menjangkau perawatan primer atau sekunder. Di Spanyol, integrasi alat-alat ini ke dalam perawatan rutin semakin terhambat oleh tata kelola yang terfragmentasi, koordinasi kebijakan yang tidak memadai di seluruh komunitas otonom, dan dominasi kepentingan industri farmasi dalam melanjutkan pendidikan kedokteran dan pengembangan pedoman. Kurangnya mekanisme evaluasi independen dan hampir tidak adanya sistem dokumentasi yang dikontrol oleh pasien memperparah masalah ini, yang menghasilkan lingkungan kelembagaan yang secara struktural menghambat operasionalisasi praktik terbaik dalam manajemen pengobatan (Sanguinetti et al., 2025).

Konsensus ilmiah semakin mengakui perlunya mendefinisikan ulang konten dan proses perawatan psikiatri untuk mengakomodasi pluralitas epistemik dan variabilitas fisiologis yang melekat pada populasi klinis di dunia nyata. Alih-alih membingkai kepatuhan pengobatan sebagai hasil biner atau penanda keterlibatan, praktik terbaik kontemporer menekankan penggunaan perencanaan pengobatan berdasarkan umpan balik, titik akhir klinis yang ditentukan bersama, dan metrik yang menggabungkan dimensi fisiologis dan psikososial pemulihan. Ini termasuk fungsi kognitif, kesehatan metabolik, koherensi narasi, regulasi emosi, dan pemenuhan peran sosial. Bukti dari studi longitudinal menunjukkan bahwa ukuran hasil tersebut merupakan prediktor yang lebih baik untuk kesejahteraan yang berkelanjutan daripada daftar gejala tradisional atau kriteria diagnostik saja.

Akibatnya, pembenaran ilmiah untuk mempertahankan model pengobatan farmakosentris tanpa evaluasi ulang yang ketat telah melemah. Bertahannya model-model ini di Spanyol tidak mencerminkan ketiadaan alternatif, tetapi kegagalan untuk menerapkan alternatif tersebut karena kelembaman institusional, ambiguitas hukum, dan marginalisasi perspektif kritis dalam pendidikan dan tata kelola psikiatri (Kuhl, 2019).

Konsolidasi paradigma farmakosentris dalam psikiatri Spanyol, meskipun telah mengumpulkan bukti internasional tentang keterbatasannya, harus dipahami sebagai produk dari logika institusional yang tertanam kuat yang melampaui pertemuan klinis individu. Budaya profesional, lingkungan peraturan, dan skema penggantian biaya secara kolektif menopang kerangka kerja di mana resep obat-obatan psikotropika tidak hanya dinormalisasi tetapi juga diberi insentif secara struktural. Kebijakan penggantian biaya lebih mengutamakan konsultasi singkat yang berfokus pada pengobatan daripada intervensi psikososial yang intensif. Protokol hukum dan administratif sering kali memprioritaskan minimalisasi risiko melalui penahanan farmakologis yang cepat daripada evaluasi kontekstual yang komprehensif. Kurikulum pelatihan di bidang kedokteran dan psikologi terus mengutamakan kategori diagnostik berbasis gejala dan model penjelasan neurokimia sementara mengabaikan pendekatan integratif terhadap trauma, perwujudan, dan faktor penentu sosial. Konstelasi kekuatan ini memperkuat habitus klinis yang meminggirkan pengetahuan non-farmakologis, membatasi imajinasi terapeutik, dan menghasilkan kondisi epistemik yang tidak bersahabat dengan perawatan yang dialogis dan partisipatoris (Toro et al, 2006).

Yang terpenting, normalisasi pengobatan psikofarmakologis jangka panjang di Spanyol tetap ada meskipun konsekuensi iatrogeniknya terdokumentasi dengan baik. Paparan kronis terhadap antipsikotik, antidepresan, penstabil suasana hati, dan ansiolitik telah dikaitkan dengan berbagai efek samping, termasuk tetapi tidak terbatas pada disfungsi metabolik, gangguan kognitif, tumpulnya emosi, gangguan gerakan, disregulasi hormon, dan disfungsi seksual (Simopoulos & Trinidad, 2013). Selain gejala sisa fisiologis, penggunaan obat dalam jangka waktu lama sering kali menyebabkan ketergantungan psikososial, erosi efikasi diri, dan gangguan perkembangan identitas, terutama pada remaja dan dewasa muda. Hasil ini jarang dipantau secara sistematis dan sering kali diminimalkan atau dipatologikan ketika diangkat oleh pasien. Alih-alih mendorong refleksi kritis terhadap kesesuaian rencana pengobatan, laporan efek samping sering kali dipenuhi dengan eskalasi diagnostik atau polifarmasi. Praktik ini tidak hanya meningkatkan risiko, tetapi juga mengukuhkan siklus klinis di mana kekhawatiran pasien ditafsirkan ulang sebagai bukti gangguan daripada masukan yang valid dalam pengambilan keputusan terapeutik. Dinamika tersebut menggambarkan bagaimana model farmakosentris beroperasi tidak hanya sebagai strategi pengobatan tetapi juga sebagai mekanisme disipliner, membentuk subjektivitas pasien, identitas profesional, dan norma-norma institusional (Dencker et al, 1986; Gotzsche, 2019).

Implikasi etis dari model ini sangat signifikan. Ketika sistem klinis memprioritaskan intervensi biokimia daripada pemahaman relasional, hasilnya adalah degradasi integritas terapeutik dan erosi sistematis terhadap informed consent. Persetujuan yang benar tidak hanya membutuhkan penyediaan informasi tetapi juga kebebasan untuk menolak atau memodifikasi pengobatan berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang berkembang. Dalam konteks Spanyol saat ini, kebebasan ini sering kali bersifat nominal, dibatasi oleh kelangkaan struktural, tekanan normatif, dan pembungkaman medis-

legal atas penyimpangan sebagai penyimpangan. Otonomi menjadi bersifat performatif daripada substantif, dipertahankan dalam retorika tetapi ditolak dalam praktik. Untuk melawan kecenderungan ini, praktik-praktik yang lebih baik berbasis bukti dalam manajemen pengobatan harus ditanamkan dalam transformasi yang lebih luas dalam epistemologi dan tata kelola psikiatri. Transformasi ini tidak hanya mencakup revisi protokol pengobatan, tetapi juga mengkonfigurasi ulang sistem produksi pengetahuan, akreditasi profesional, dan akuntabilitas institusional yang mendukungnya (Whitaker, 2005; Rose, 2007).

Disertasi ini berkontribusi pada konfigurasi ulang tersebut dengan mengartikulasikan dasar-dasar ilmiah, etis, dan operasional dari manajemen pengobatan otonom, yang berakar pada penelitian lapangan komparatif, bukti empiris, dan keahlian langsung dari mereka yang terkena dampak. Melalui analisis multi-skala dan integrasi transdisipliner, buku ini mengungkap faktor penentu struktural dari kegigihan farmakosentris dan menguraikan jalur yang dapat ditindaklanjuti menuju praktik klinis yang lebih efektif dan adil. Bagian selanjutnya menggambarkan kerangka kerja medico-legal dan konstitusional yang diperlukan untuk mendukung transisi ini, mengidentifikasi kondisi normatif, prosedural, dan institusional di mana perawatan farmakologis dapat diberikan sesuai dengan hak asasi manusia, keunggulan klinis, dan legitimasi demokratis.

1.5 Landasan hukum, epistemik, dan ilmiah dari masalah penelitian

Bertahannya praktik-praktik pemaksaan dan model pengobatan farmakosentris dalam psikiatri kontemporer mencerminkan persimpangan yang kompleks antara ambiguitas hukum, asimetri epistemik, dan keterbatasan ilmiah. Elemen-elemen ini menopang konfigurasi struktural di mana otonomi pasien, informed consent, dan integritas tubuh berada di bawah kenyamanan institusional, kebijaksanaan profesional, dan protokol manajemen risiko. Masalah mendasar yang dibahas dalam disertasi ini tidak terbatas pada jangkauan klinis yang berlebihan, tetapi menyangkut reproduksi pemaksaan secara sistemik melalui norma-norma hukum yang tertanam, mekanisme validasi ilmiah, dan hirarki pengambilan keputusan yang mengaburkan batas antara perawatan dan kontrol. Meskipun instrumen hak asasi manusia internasional menegaskan prinsip persetujuan bebas dan terinformasi dalam perawatan medis, kerangka hukum nasional sering kali berisi pengecualian yang mengizinkan intervensi paksa atas dasar ketidakmampuan, risiko, atau klasifikasi diagnostik yang diduga (Hemper et al, 2024). Pengecualian-pengecualian ini, meskipun diatur secara formal, tunduk pada kebijaksanaan interpretasi yang luas dan jarang menjadi sasaran verifikasi eksternal atau audit retrospektif. Dalam konteks Spanyol, hukum organik yang mengatur ketidakmampuan sipil, perwalian, dan intervensi kesehatan mental mengizinkan para aktor medis dan peradilan untuk mengesampingkan preferensi pasien tanpa memerlukan pembenaran waktu nyata yang berakar pada standar ilmiah kontemporer. Permisifitas hukum ini memungkinkan pemaksaan untuk berfungsi sebagai strategi klinis yang dinormalisasi dan bukannya sebagai pilihan terakhir (Desviat, 2011; Ferreirós, 2013; Ramos-Pozón et al, 2025).

Struktur epistemik psikiatri memperkuat dinamika ini dengan menempatkan otoritas klinis dalam sistem diagnostik yang tetap berbasis deskriptif dan tidak divalidasi secara etiologis. Model nosologis yang berlaku yang digunakan di Spanyol dan di sebagian besar sistem kesehatan berpenghasilan

tinggi didasarkan pada Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental dan Klasifikasi Penyakit Internasional. Klasifikasi ini bergantung pada kelompok gejala tanpa dasar mekanistik, membuat atribusi diagnostik rentan terhadap subjektivitas, bias sosiokultural, dan utilitas administratif. Tidak adanya biomarker objektif atau indikator fisiologis yang dapat direproduksi merusak keandalan epistemik diagnosis psikiatri dan melemahkan klaimnya terhadap legitimasi medis di bawah standar falsifikasi dan transparansi mekanistik yang diharapkan dalam domain ilmu kesehatan lainnya. Namun demikian, klasifikasi ini memiliki bobot hukum dan sosial yang signifikan, berfungsi sebagai perangkat penjaga gerbang untuk status sipil, kapasitas, dan akses terhadap hak atau pembatasan. Dalam praktiknya, mereka mengesahkan intervensi yang mungkin termasuk rawat inap paksa, pengobatan paksa, dan pelembagaan jangka panjang, sering kali tanpa bantuan banding independen atau evaluasi ulang longitudinal. Ketegangan antara ketidakpastian epistemik dan determinasi hukum ini merupakan dimensi inti dari masalah penelitian yang dibahas dalam disertasi ini (Moncrieff, 2010; Frances, 2013).

Pelembagaan pengetahuan psikiatri terjadi dalam sebuah arsitektur peraturan yang memberikan status normatif pada opini klinis tanpa tunduk pada ambang batas pembuktian yang sama dengan yang diterapkan di domain biomedis lainnya. Dengan tidak adanya kekhususan mekanistik atau validasi berbasis hasil, otoritas klinis berasal terutama dari posisi institusional, kredensial profesional, dan protokol yang terkodifikasi. Protokol-protokol ini sering kali didasarkan pada konsensus daripada evaluasi empiris yang terkendali dan sering kali mencerminkan pengaruh kepentingan farmasi, prioritas pengendalian risiko, dan pembelaan hukum medis daripada kemanjuran terapeutik atau pemulihan yang ditentukan oleh pasien. Dinamika ini menghasilkan lingkaran epistemik tertutup di mana penyimpangan dari praktik farmakologis atau diagnostik yang sudah mapan ditafsirkan sebagai kesalahan klinis, pertanggungjawaban administratif, atau ketidakrasionalan pasien. Dalam sistem seperti itu, inovasi, perbedaan pendapat, atau adaptasi secara struktural tidak dianjurkan, dan data relasional atau kontekstual tidak diprioritaskan demi manajemen gejala yang dapat diukur. Dengan demikian, keputusan klinis diatur oleh logika algoritmik yang diinformasikan oleh rata-rata populasi dan data uji coba yang diekstrapolasi, bukan oleh lintasan spesifik seseorang, riwayat hidup, atau kapasitas yang dimiliki untuk memilih (Kirk & Kutchins, 1992; Kirk et al., 2013).

Literatur ilmiah tentang pemaksaan dan gangguan kejiwaan telah berkembang selama dua dekade terakhir, namun integrasinya ke dalam praktik klinis dan hukum masih terbatas. Meta-analisis dan penelitian observasional berskala besar telah mendokumentasikan konsekuensi jangka panjang dari praktik-praktik pemaksaan, termasuk ketidakberdayaan yang dipelajari, ketidakterlibatan dalam pengobatan, cedera iatrogenik, dan peningkatan risiko bunuh diri. Namun demikian, penggabungan temuan-temuan ini ke dalam reformasi kebijakan atau pelatihan klinis masih bersifat parsial dan tidak konsisten. Bukti ilmiah tentang bahaya sering kali dinetralisir oleh narasi institusional tentang mitigasi risiko atau keselamatan pasien, yang menampilkan paksaan sebagai respons yang diperlukan untuk urgensi klinis, terlepas dari kurangnya validitas prediktif dalam alat penilaian risiko psikiatri. Kritik ilmiah terhadap praktik farmakosentris, termasuk ketidakefektifan jangka panjang dari kelas obat tertentu dan pelaporan efek samping yang kurang dalam uji coba yang disponsori oleh industri, juga telah berjuang untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dalam perilaku klinis atau standar peraturan. Hal ini mengindikasikan adanya disosiasi struktural antara produksi pengetahuan

dan perubahan institusional, kesenjangan yang ingin diungkap dan diatasi oleh disertasi ini melalui penelitian yang tertanam, berdasarkan informasi empiris, dan peka terhadap sistem (Moon, 2000).

Dalam konteks Spanyol, konvergensi antara legalitas hukum, ambiguitas ilmiah, dan kebijaksanaan klinis menciptakan lingkungan struktural di mana praktik-praktik pemaksaan tidak bersifat episodik, melainkan konstitutif dalam tata kelola kejiwaan. Hukum perdata, undang-undang kesehatan, dan yurisprudensi mengizinkan intervensi paksa berdasarkan interpretasi yang luas mengenai risiko, ketidakmampuan, atau kebutuhan medis yang dianggap perlu, tanpa mengharuskan adanya ambang batas bahaya yang bersifat individual atau pembenaran berbasis bukti. Pengesahan yudisial atas rekomendasi klinis sering kali bersifat otomatis, yang mencerminkan ketergantungan peradilan pada keahlian psikiatri dan ketiadaan pengawasan independen atau penyeimbang epistemik. Pengaturan ini mengkonsolidasikan otoritas institusi psikiatri sekaligus membatasi jalan bagi pasien untuk menggugat, menuntut ganti rugi hukum, atau tinjauan eksternal. Dalam konfigurasi seperti ini, kapasitas pasien untuk mengajukan keberatan dirusak tidak hanya secara prosedural tetapi juga secara konseptual, karena perbedaan pendapat dipatologikan dan ditafsirkan sebagai gejala penyakit dan bukannya sebagai ekspresi yang sah atas hak pilih. Instrumen diagnostik, catatan klinis, dan penilaian risiko tidak berfungsi sebagai alat bantu deskriptif tetapi sebagai teknologi penangkapan, menghasilkan legitimasi administratif untuk intervensi yang dasar ilmiahnya masih lemah atau belum teruji (Szasz, 2007; Whitaker, 2010).

Kondisi sistemik ini diperkuat oleh pembagian epistemologis antara bukti obyektif dan subyektif, di mana laporan orang pertama tentang bahaya atau ketidakadilan secara rutin diabaikan karena tidak dapat diandalkan atau tidak klinis. Peminggiran pengalaman langsung ini merusak cakupan empiris dari penyelidikan psikiatri, mempersempit definisi data yang valid, dan membatasi pengembangan model perawatan partisipatoris atau fenomenologis. Hal ini membatasi potensi umpan balik sistem dan koreksi kesalahan, karena mekanisme untuk melaporkan bahaya kurang berkembang, bersifat internal institusional, atau dianggap sebagai permusuhan. Ketika hasil yang merugikan benar-benar terjadi, termasuk kemunduran iatrogenik, bunuh diri, atau kronisitas yang disebabkan oleh intervensi kumulatif, respons kelembagaan memprioritaskan manajemen pertanggungjawaban di atas rekonstruksi kebenaran, mencegah pembelajaran yang bermakna atau reformasi prosedural. Dalam lingkungan ini, legitimasi praktik psikiatri dipertahankan melalui kelembaman normatif, otoritas berbasis kredensial, dan isolasi birokratis dari kritik pengguna. Kesenjangan yang terjadi antara retorika klinis dan praktik institusional merupakan patologi inti dari tata kelola dan objek analisis penting untuk penelitian ini (Burstow, 2015; Held, 2020; Markus, 2020).

Ciri-ciri struktural yang diuraikan di atas tidak hanya mendefinisikan objek studi tetapi juga kendala metodologis dan kewajiban etis yang mendasari disertasi ini. Konvergensi antara otoritas hukum, otonomi klinis, dan keburaman epistemik membutuhkan desain penelitian yang mampu beroperasi dalam ruang institusional yang diperebutkan dengan tetap mempertahankan ketelitian analitis dan integritas prosedural. Hal ini memerlukan kerangka kerja ilmiah yang memperlakukan pengalaman langsung sebagai data, wacana institusional sebagai bukti, dan praktik klinis sebagai perilaku yang dapat dianalisis secara empiris. Hal ini juga menuntut posisi metodologis yang tidak mereproduksi asimetri yang dikritiknya, tetapi memungkinkan observasi, dokumentasi, dan keterlibatan tanpa mereproduksi bahaya atau pengucilan epistemik (Sanati & Kyratsous, 2015). Oleh karena itu,

masalah penelitian ini tidak terbatas pada identifikasi kasus-kasus pemaksaan atau pengobatan berlebihan, tetapi juga memetakan arsitektur normatif yang menopangnya dan melacak kondisi di mana arsitektur ini dapat diubah. Transformasi semacam itu tidak dapat terjadi hanya melalui inovasi klinis atau amandemen hukum, tetapi membutuhkan konfigurasi ulang hirarki epistemik, perlindungan prosedural, dan mekanisme akuntabilitas kelembagaan. Dimensi-dimensi ini akan dibahas pada bab berikut, yang menguraikan strategi metodologis yang diadopsi, desain instrumen lapangan, dan kerangka kerja analitis yang digunakan untuk memeriksa pemaksaan, agensi, dan tata kelola kejiwaan dalam konteks dunia nyata. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah yang berlandaskan empiris, relevan secara hukum, dan berguna secara operasional dalam memajukan model perawatan kesehatan jiwa yang dapat dipertahankan secara etis (Houlders, Bortolotti, & Broome, 2021).

1.6 Kegagalan sistemik, kekerasan struktural, dan tantangan reformasi

Struktur perawatan kejiwaan saat ini di Spanyol dibentuk oleh paradigma institusional yang sudah mengakar yang memprioritaskan penahanan farmakologis daripada integrasi biopsikososial. Meskipun kerangka kerja global untuk perawatan berbasis hak semakin banyak tersedia, termasuk program QualityRights dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan penyebaran prinsip-prinsip berbasis trauma serta model perawatan yang berpusat pada pasien, respons klinis yang dominan terhadap gangguan jiwa sebagian besar masih bersifat farmakosentris dan reaktif. Ketidaksesuaian ini mencerminkan ketidakselarasan yang mendasar antara standar yang muncul dalam kesehatan global dan norma-norma operasional di sebagian besar psikiatri Spanyol. Penggunaan obat-obatan psikotropika yang berkelanjutan, terutama untuk pengobatan jangka panjang untuk kondisi kesehatan mental yang tidak akut, terus terjadi tanpa adanya penerapan yang konsisten dari protokol pengambilan keputusan partisipatif, evaluasi interdisipliner, atau penilaian risiko struktural. Meskipun masyarakat profesional semakin menyadari pentingnya faktor ekologi, neuroendokrin, dan relasional dalam membentuk hasil kesehatan mental, wawasan ini belum diterjemahkan ke dalam praktik rutin. Dominasi paradigma reduksionis yang terus berlanjut tidak hanya membatasi kemanjuran klinis, tetapi juga secara sistematis merusak hak, otonomi, dan prospek pemulihan jangka panjang pasien, terutama mereka yang paling terpinggirkan oleh kemiskinan, trauma, dan pengucilan sosial. Tidak adanya dialog yang berarti antar disiplin ilmu, terbatasnya implementasi pelatihan berbasis hak, dan pembungkaman ketidakpatuhan yang terus-menerus sebagai penyimpangan klinis, semuanya berkontribusi pada lanskap institusional di mana intervensi farmakologis menjadi respons standar terhadap kesusahan, terlepas dari konteks, riwayat, atau preferensi pasien. Dalam situasi ini, kekerasan struktural beroperasi bukan sebagai penyimpangan, tetapi sebagai konsekuensi dari praktik standar, yang mengungkapkan kebutuhan mendesak untuk koreksi paradigma yang dipandu oleh integritas ilmiah dan kewajiban etis (Paradis-Gagné et al., 2021; Gill et al., 2024).

Upaya pemerintah pusat Spanyol dan beberapa pemerintah daerah, seperti Catalonia, untuk mengatasi ketergantungan yang tidak proporsional terhadap intervensi farmakologis telah mendapatkan perhatian melalui strategi kesehatan mental nasional baru-baru ini, yang menekankan pentingnya perawatan berbasis komunitas, koordinasi interdisipliner, dan pendekatan pencegahan. Instrumen-

instrumen kebijakan ini mengakui penggunaan obat psikiatri yang berlebihan dan menganjurkan respons non-farmakologis, terutama di layanan primer dan non-akut. Namun, penerjemahan prioritas-prioritas ini ke dalam praktik masih bersifat parsial dan tidak merata di seluruh wilayah. Kelambanan kelembagaan, pelatihan yang tidak merata bagi tenaga kesehatan, infrastruktur yang tidak memadai untuk dukungan psikososial, dan masih kuatnya budaya klinis yang hirarkis terus menghalangi terwujudnya tujuan-tujuan kebijakan ini. Tanpa reformasi substantif dalam hal bagaimana keputusan medis dibuat, didokumentasikan, dan ditindaklanjuti, tujuan-tujuan yang telah ditetapkan berisiko menjadi performatif. Penekanan pada kesehatan jiwa sebagai prioritas kesehatan masyarakat tidak boleh direduksi menjadi komitmen retorika. Hal ini membutuhkan alokasi sumber daya untuk tim multidisiplin, reorganisasi jalur perawatan untuk memungkinkan kesinambungan dan pilihan, dan pengembangan sistem pengukuran yang tidak mengutamakan penekanan gejala daripada pemulihan fungsional. Hal ini sangat relevan mengingat adanya hubungan yang terdokumentasi antara pemberian obat yang berlebihan, kronisasi gejala, kemunduran metabolisme, dan hilangnya fungsi psikososial. Pengakuan pemerintah terhadap masalah ini merupakan titik awal yang penting, tetapi transformasi yang diperlukan tidak terbatas pada peningkatan akses terhadap perawatan. Hal ini melibatkan restrukturisasi dasar-dasar epistemik, etis, dan prosedural dari praktik psikiatri untuk menyelaraskannya dengan ilmu kedokteran kontemporer dan standar hak asasi manusia (Salvador-Carulla, 2010).

Penyelarasan strategi nasional Spanyol dengan inisiatif global merupakan titik kritis untuk perubahan sistemik. Kerangka kerja QualityRights dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menyerukan penghapusan paksaan dan penerapan perawatan berbasis hak, memberikan tolok ukur normatif dan operasional untuk mengevaluasi sistem kejiwaan. Dukungan Spanyol terhadap standar internasional tersebut mencerminkan kemauan institusional untuk bergerak melampaui paradigma biomedis murni. Namun, implementasi praktis mengharuskan sistem tersebut mengadopsi model klinis berbasis bukti yang mengintegrasikan faktor neurofisiologis, nutrisi, psikologis, dan sosial ke dalam standar perawatan. Pendekatan psikiatri yang muncul yang mengandalkan integrasi interdisipliner, termasuk yang didasarkan pada imunologi psikoneuroendokrin dan di bidang yang lebih luas dari ilmu saraf translasi, menekankan perlunya mengatasi mekanisme yang mendasari gangguan daripada hanya memodulasi gejala melalui farmakologi. Pendekatan-pendekatan ini mendukung pandangan bahwa otak tidak dapat diobati secara terpisah dari tubuh atau dari konteks sosial dan lingkungan yang membentuk keduanya. Model translasi menunjukkan peran penting dari kesulitan hidup di awal kehidupan, peradangan kronis, kebersihan tidur yang buruk, kekurangan nutrisi, dan respons stres yang tidak teregulasi dalam asal mula dan kelanggengan tekanan mental. Ketika dimasukkan ke dalam penalaran klinis, model-model ini menggeser fokus psikiatri dari pengendalian gejala ke regulasi fisiologis dan pembangunan ketahanan. Meskipun belum menjadi arus utama dalam sistem kesehatan masyarakat Spanyol, perspektif ini semakin terwakili dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan, konsorsium penelitian, dan program percontohan. Namun, adopsi penuh dari perspektif ini bergantung pada reformasi pelatihan medis, klasifikasi diagnostik, dan sistem penghargaan institusional. Tesis ini melibatkan perkembangan internasional ini tidak hanya sebagai bukti latar belakang tetapi juga sebagai bidang kontestasi dan pembelajaran yang aktif, di mana upaya Spanyol saat ini harus ditempatkan secara kritis dan konstruktif. Penggabungan model fisiologis,

psikososial, dan ekologis secara bertahap ke dalam perawatan psikiatri telah mengungkap ketidakcukupan paradigma diagnostik dan terapeutik saat ini yang masih terpaku pada kelompok gejala yang sudah ketinggalan zaman dan asumsi farmakologis. Sementara komunitas ilmiah internasional semakin menyerukan integrasi faktor penentu sosial kesehatan, kognisi yang diwujudkan, dan formulasi yang peka terhadap konteks, banyak lingkungan klinis di Spanyol terus menerapkan kategori diagnostik yang kaku dengan perhatian yang tidak memadai terhadap keterbatasan epistemologis atau konsekuensi fungsionalnya (Pūras, 2017). Kekakuan ini tidak hanya mendistorsi pemahaman tentang penderitaan manusia, tetapi juga menopang praktik-praktik pemaksaan dengan menampilkannya sebagai sesuatu yang dibenarkan secara medis atau tak terelakkan. Hal ini merusak kapasitas untuk pembelajaran interdisipliner dan memperkuat hierarki profesional yang menghambat perawatan kolaboratif. Bertahannya pola sistemik seperti itu mencerminkan ketahanan dari ketergantungan jalur institusional yang lebih mengutamakan pengendalian risiko, efisiensi administratif, dan manajemen farmakologis untuk mengatasi gangguan daripada intervensi yang bersifat relasional, rehabilitatif, dan berlandaskan sosial. Meskipun kerangka kerja kebijakan dan rencana kesehatan jiwa nasional baru-baru ini secara resmi mengakui perlunya reformasi, mekanisme pelaksanaannya masih tunduk pada keterbatasan sumber daya, resistensi profesional, dan kurangnya tata kelola yang terintegrasi. Wacana publik tentang kesehatan jiwa telah berkembang luas, namun komitmen struktural untuk berubah masih tetap genting kecuali jika disertai dengan pendefinisian ulang tentang apa yang dimaksud dengan keberhasilan klinis dan akuntabilitas dalam perawatan kejiwaan. Disertasi ini mengintervensi pada tingkat tersebut, menyumbangkan wawasan empiris, hukum, dan metodologis yang menantang kelembaman sistem yang ada saat ini sembari mengidentifikasi jalur operasional untuk transformasi berbasis bukti.

Konvergensi mandat internasional, kemajuan ilmiah, dan upaya advokasi lokal memberikan peluang unik untuk menyelaraskan sistem kesehatan jiwa dengan standar perawatan kontemporer yang berlandaskan martabat, otonomi, dan integritas ilmiah. Kerangka kerja global seperti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengadvokasi perawatan kesehatan jiwa yang berbasis hak dan terintegrasi dengan masyarakat, yang secara eksplisit menolak praktik-praktik pemaksaan dan menekankan pentingnya perlindungan hukum, persetujuan, dan kesinambungan antardisiplin. Dalam lanskap yang lebih luas ini, aparat kelembagaan Spanyol mulai merespons melalui inisiatif nasional yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada intervensi farmakologis dan mempromosikan pendekatan psikososial yang terintegrasi. Namun demikian, kesenjangan implementasi yang substansial masih ada karena budaya profesional yang mengakar, penyediaan layanan yang terfragmentasi, dan mekanisme hukum yang tidak memadai untuk akuntabilitas dan tata kelola yang dipimpin oleh pasien. Integrasi ilmu saraf translasional, psikiatri nutrisi, dan model fisiologis kesehatan mental masih terbatas, sering kali hanya terbatas pada domain eksperimental atau periferal daripada menginformasikan praktik klinis inti. Tidak adanya sistem yang mampu menggabungkan pengalaman yang diwujudkan, dinamika interpersonal, dan umpan balik sosial ke dalam proses diagnostik dan terapeutik menghalangi evolusi perawatan yang benar-benar partisipatif dan peka terhadap konteks (Bobes et al, 2012).

Disertasi ini berkontribusi untuk mengatasi defisit ini dengan menawarkan analisis multi-skala yang terstruktur tentang hambatan sistemik dan pengungkit operasional, yang didasarkan pada penelitian

lapangan empiris dan penelitian kebijakan komparatif. Pendekatan ini tidak dilakukan dengan mengusulkan reformasi yang abstrak, tetapi dengan menelusuri konfigurasi konkret di mana praktik-praktik yang lebih baik muncul dan menjadi berkelanjutan dalam tatanan hukum dan kelembagaan yang ada. Pendekatan ini sejalan dengan upaya Eropa dan internasional saat ini untuk mengkalibrasi ulang perawatan kejiwaan sebagai upaya yang secara fundamental etis dan ilmiah, yang seharusnya responsif terhadap realitas kehidupan mereka yang dilayani dan terhadap pengetahuan yang dihasilkan di berbagai disiplin ilmu, profesi, dan komunitas yang terkena dampak (Ortiz Lobo, 2013; Carbonell Marqués & Navarro-Pérez, 2019).

1.7 Landasan teoretis: kekuasaan, diagnosis, pengucilan, dan perlawanan

Landasan teoretis dari disertasi ini didasarkan pada pengakuan bahwa psikiatri tidak hanya berfungsi sebagai disiplin klinis tetapi juga sebagai lembaga pengatur yang berpartisipasi dalam distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat kontemporer. Diagnosis bukan sekadar tindakan klasifikasi. Ini adalah mekanisme pengaturan sosial, alokasi sumber daya, dan pembentukan subjek. Melalui diagnosis, individu diposisikan dalam hierarki kredibilitas, kapasitas hukum, dan kelayakan terapi. Posisi-posisi ini tidak netral secara epistemologis. Mereka dikondisikan oleh ketidaksetaraan struktural, ekspektasi budaya, dan tuntutan institusional. Dengan demikian, diagnosis beroperasi sebagai tindakan politis dengan konsekuensi material, membentuk lintasan hidup, hak sosial, dan partisipasi sipil. Kategori psikiatri, terutama yang digunakan untuk membenarkan intervensi paksa atau pengobatan farmakologis jangka panjang, membawa asumsi yang tertanam tentang agensi, rasionalitas, dan kepatuhan. Asumsi-asumsi ini sering kali mencerminkan model perilaku dan kognisi normatif yang gagal mengakomodasi pengalaman hidup yang penuh tekanan, trauma, atau kesulitan sistemik. Posisi teoritis ini membutuhkan interogasi berkelanjutan mengenai hubungan antara atribusi diagnostik, praktik kelembagaan, dan pengucilan sosial (Moncrieff, 2013a; Moncrieff, 2013b).

Inti dari analisis ini adalah Kerangka Kerja Makna Ancaman Kekuasaan, yang dikembangkan oleh Lucy Johnstone dan Mary Boyle, yang mengkonseptualisasikan kembali kesulitan kesehatan jiwa sebagai respons yang dapat dipahami terhadap pengalaman buruk, yang dikontekstualisasikan dalam konfigurasi kekuasaan, ancaman, dan makna yang spesifik. Kerangka kerja ini menawarkan alternatif untuk diagnosis berbasis gejala dengan menekankan peran dinamika kekuasaan dalam membentuk tekanan dan pentingnya membangun narasi pribadi yang dapat memahami pengalaman. Alih-alih menanyakan apa yang salah dengan seseorang, kerangka kerja ini menanyakan apa yang telah terjadi, ancaman apa yang telah dihadapi, makna apa yang telah dibuat, dan kekuatan apa yang telah digunakan untuk bertahan hidup. Orientasi ini sejalan dengan orientasi empiris dari penelitian ini, yang mengutamakan narasi situasi, analisis longitudinal dari interaksi kelembagaan, dan refleksi kritis terhadap otoritas epistemik. Penelitian ini juga menyediakan jangkar metodologis untuk memasukkan anamnesis relasional sebagai bentuk produksi pengetahuan yang valid. Anamnesis dipahami bukan sebagai ingatan akan gejala-gejala yang terpisah, melainkan sebagai rekonstruksi kondisi sosiopolitik di mana kesusahan muncul dan menjadi medis. Dalam pandangan ini, sejarah klinis bukanlah kronologi pasif tetapi sebuah negosiasi aktif tentang pengakuan, legitimasi, dan perawatan (John Read & Harper, 2020; Johnstone, 2020; Rådmark et al., 2024).

Pelembagaan pengetahuan psikiatri telah terjadi dalam sejarah yang lebih luas dari pembentukan negara, perluasan yuridis, dan standardisasi biomedis. Psikiatri secara historis berfungsi sebagai alat penentu batas, yang membedakan antara normalitas dan patologi, serta mengatur akses terhadap partisipasi sipil, kehidupan keluarga, dan kapasitas hukum. Integrasinya ke dalam sistem hukum, kesejahteraan, dan pendidikan telah memberikan peran disiplin yang melebihi klinik dan beroperasi melalui dokumentasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan prosedural. Dalam konteks ini, pengucilan bukanlah hasil sampingan yang tidak disengaja dari praktik kejiwaan, tetapi merupakan hasil yang tertulis secara struktural. Label diagnostik sering kali menjadi pembenaran untuk pencabutan hak, pengenaan intervensi, dan pembatasan kepribadian. Efek-efek ini diintensifkan dalam kasus-kasus di mana logika institusional memprioritaskan efisiensi administratif, kontrol klinis, atau manajemen reputasi di atas aliansi terapeutik atau pemulihan yang ditentukan oleh pasien (Foucault, 2003).

Pengecualian juga bersifat epistemik. Dominasi model biomedis mengistimewakan bentuk-bentuk produksi pengetahuan tertentu, khususnya uji coba terkontrol secara acak, inventarisasi gejala, dan pengukuran hasil farmakologis, sementara merendahkan pengalaman, relasi, dan sosiokultural. Asimetri ini membatasi legitimasi epistemologis pasien, anggota keluarga, dan aktor non-klinis, yang kontribusinya sering kali dianggap subjektif, anekdot, atau tidak rasional. Pada gilirannya, pengecualian epistemik ini membatasi potensi sistem untuk belajar dari kesalahan, merespons variabel kontekstual, atau beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah. Hasilnya adalah lingkungan klinis di mana bahaya dapat diberikan secara prosedural dan dibenarkan secara normatif, tanpa memicu reformasi kelembagaan atau tindakan reparatif. Resistensi terhadap perubahan dalam kondisi seperti ini bukan karena ketidaktahuan atau kedengkian semata, melainkan karena desain struktural. Arsitektur kelembagaan psikiatri dikonfigurasi untuk mempertahankan koherensi, prediktabilitas, dan otoritas, yang sering kali mengorbankan daya tanggap, transparansi, dan akuntabilitas. Dinamika ini tidak hanya terjadi pada psikiatri, tetapi diintensifkan oleh kedekatannya dengan kekuatan koersif dan perannya dalam memediasi penyimpangan sosial, keamanan publik, dan kapasitas sipil (Watts, 2024).

Dalam kerangka kerja ini, resistensi harus dipahami sebagai fenomena empiris dan konstruk teoretis. Resistensi tidak hanya merujuk pada kontestasi terbuka oleh individu yang mengalami intervensi psikiatri yang bersifat koersif, tetapi juga pada tindakan negosiasi, penghindaran, dan penafsiran ulang di tingkat mikro yang terjadi di dalam pertemuan klinis (Lehmann, 1998b). Bentuk-bentuk resistensi ini sering dipatologikan sebagai ketidakpatuhan atau kurangnya wawasan, yang dengan sendirinya menjadi penanda diagnostik yang digunakan untuk membenarkan intensifikasi intervensi. Namun, dari perspektif antropologis, tindakan-tindakan ini dapat dibaca sebagai strategi bertahan hidup, pelestarian narasi, dan penegasan identitas diri dalam sistem yang menolak pengakuan penuh. Perlawanan juga dapat muncul secara kolektif, seperti dalam kasus gerakan penyintas, advokasi yang dipimpin oleh rekan sebaya, dan produksi pengetahuan alternatif oleh masyarakat yang terkena dampak. Upaya-upaya ini merupakan wacana tandingan terhadap psikiatri institusional dan menawarkan bukti empiris tentang kegagalan epistemik, etis, dan klinis dari paradigma yang dominan.

Kegigihan perlawanan, meskipun terpinggirkan, menunjukkan ketidakmampuan model psikiatri saat ini dalam menangani kompleksitas penuh tekanan mental. Hal ini juga menantang legitimasi rezim intervensi yang gagal untuk memasukkan mekanisme refleksif untuk mengevaluasi konsekuensinya sendiri. Pendekatan teoretis yang mengedepankan resistensi, seperti psikiatri kritis, studi pascakolonial, dan analisis lintas batas, menyoroti sifat alamiah dari otoritas klinis dan peran konteks sosial politik dalam membentuk hasil diagnostik dan terapeutik (Lehmann, 2019a). Perspektif-perspektif ini mengungkapkan sejauh mana intervensi psikiatri bukan merupakan aplikasi netral dari pengetahuan ilmiah, tetapi tertanam dalam hubungan kekuasaan yang memediasi akses terhadap sumber daya, pengakuan, dan pemulihan. Oleh karena itu, studi tentang resistensi menjadi sebuah keharusan metodologis, tidak hanya untuk memahami bagaimana individu merespons paksaan tetapi juga untuk mengidentifikasi kondisi institusional yang memungkinkan perawatan yang etis, partisipatoris, dan efektif.

Perlawanan juga terjadi di dalam profesi klinis itu sendiri. Di antara para praktisi, perbedaan pendapat dari model farmakosentris atau koersif yang dominan dapat berupa praktik alternatif, adaptasi informal, atau keterlibatan dengan pendekatan dialogis dan berbasis trauma (Kenny et al, 2019). Namun, bentuk-bentuk kritik internal ini sering kali masih terkendala oleh protokol institusional, indikator kinerja, dan kerangka kerja pertanggungjawaban yang tidak memberikan insentif bagi penyimpangan dari prosedur standar. Ketegangan antara penilaian profesional dan ekspektasi birokrasi menciptakan ruang batas di mana dokter yang termotivasi secara etis harus menavigasi kewajiban yang saling bersaing dengan pasien, institusi, dan norma-norma disiplin. Penindasan terhadap resistensi internal ini menunjukkan kekakuan sistemik yang lebih luas dan menyoroti perlunya arsitektur institusional yang memungkinkan adanya musyawarah, umpan balik, dan modifikasi perawatan yang berprinsip. Oleh karena itu, kerangka kerja teoretis yang membahas resistensi harus mencakup posisi struktural praktisi sebagai agen dan subjek kekuasaan, yang berada di dalam organisasi yang menghasilkan dan membatasi kondisi yang memungkinkan untuk perawatan yang etis (Farberow, 2005; Leichsenring, 2019).

Disertasi ini mengadopsi orientasi teoretis yang mensintesis wawasan dari Kerangka Kerja Makna Ancaman Kekuasaan, materialisme budaya, dan antropologi medis kritis untuk menginterogasi kondisi-kondisi di mana perawatan kejiwaan menjadi paksaan, eksklusi, dan resisten terhadap reformasi. Sumber-sumber teoretis ini memungkinkan analisis multi-level tentang bagaimana praktik-praktik institusional dibangun, dilegitimasi, diperebutkan, dan diubah. Mereka juga menyediakan alat analisis yang diperlukan untuk memeriksa bagaimana diagnosis beroperasi bukan sebagai fakta medis yang tetap, tetapi sebagai peristiwa relasional yang dibentuk oleh sejarah, kekuasaan, dan interaksi. Tujuannya bukan untuk menolak pengetahuan psikiatri tetapi untuk mengkonfigurasi ulang dasar-dasar epistemologis, artikulasi hukum, dan aplikasi klinisnya dengan cara-cara yang mencerminkan kompleksitas penderitaan manusia dan tuntutan etis perawatan. Kerangka kerja ini menginformasikan desain pertanyaan penelitian, struktur pengumpulan data, dan kriteria untuk mengevaluasi praktik-praktik kelembagaan. Kerangka kerja ini mendasari pekerjaan empiris dalam pendekatan kritis namun konstruktif, yang berorientasi pada identifikasi jalur transformatif yang valid secara ilmiah, sah secara hukum, dan berkelanjutan secara etis (Weiss & Somma, 2007; Johnstone & Boyle, 2018).

Pendekatan teoretis yang diadopsi dalam penelitian ini menuntut strategi metodologis yang mampu mendaftarkan hubungan kekuasaan bukan sebagai struktur abstrak tetapi sebagai praktik yang dapat diamati, norma-norma prosedural, dan pengalaman hidup dalam situs kelembagaan tertentu. Pendekatan ini membutuhkan perangkat metodologis yang dapat mendokumentasikan bagaimana diagnosis diberlakukan, bagaimana pengucilan dioperasionalkan, dan bagaimana perlawanan diekspresikan dan ditekan. Tuntutan-tuntutan ini membutuhkan desain penelitian yang bersifat *embedded*, longitudinal, dan dapat dipertanggungjawabkan secara refleksif. Bab berikut ini menguraikan kerangka kerja metodologis yang dikembangkan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Bab ini menyajikan dasar pemikiran untuk penggunaan penelitian aksi, etnografi mendalam, analisis hukum, dan pelibatan pemangku kepentingan dalam studi tata kelola kejiwaan. Bab ini juga menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip yang diartikulasikan dalam bagian ini, yaitu timbal balik epistemik, pengawasan struktural, dan akuntabilitas etis, diterjemahkan ke dalam praktik-praktik lapangan yang konkret, protokol pengumpulan data, dan prosedur analisis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak hanya mengamati sistem perawatan tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti terhadap transformasi sistem tersebut melalui produksi pengetahuan yang sistematis yang kuat secara empiris, berlandaskan etika, dan dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan.

1.8 Kerangka kerja analitis dan metodologi ilmiah untuk perubahan struktural

Bagian ini merupakan jembatan analitis dan epistemologis antara kritik diagnostik sistem kejiwaan dan struktur metodologis yang dikembangkan dalam Bab 2. Arsitektur yang disajikan di sini secara eksplisit bersifat transdisipliner, mengintegrasikan dimensi medis, hukum, antropologi, dan komputasi ke dalam suatu dasar pemikiran ilmiah yang koheren. Disertasi ini tidak hanya menggambarkan atau melaporkan fenomena. Disertasi ini membangun desain penelitian yang mampu mengubah praktik klinis dan institusional berdasarkan dokumentasi sistematis, akuntabilitas etis, dan pengetahuan translasional. Untuk mencapai hal ini, penelitian ini menggunakan kerangka kerja berlapis yang menyelaraskan objek investigasi, tata kelola psikiatri di Spanyol, dengan metode yang mampu menangkap kompleksitas strukturalnya.

Fenomena yang dibahas tidak terpisah atau acak, tetapi tertanam dalam sistem klasifikasi, intervensi, dan penahanan multidimensi. Mekanisme ini beroperasi di tingkat klinis, administratif, yuridis, dan diskursif. Pemilihan kerangka kerja diatur oleh persyaratan untuk membangun bukan studi satu tingkat atau monodisiplin, tetapi sebuah model terintegrasi yang memungkinkan artikulasi bukti ilmiah dengan standar hukum, praktik kelembagaan, dan pengalaman yang diwujudkan dalam kesulitan. Tujuannya bukan untuk mengembangkan meta-teori psikiatri, tetapi untuk memungkinkan produksi pengetahuan yang dapat diterapkan, dapat dievaluasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis.

Tabel 8. Empat tingkat analisis dan integrasi dalam arsitektur penelitian

Tingkat	Deskripsi
Teoretis dan epistemologis	Didasarkan pada pendekatan biokultural dan transdisipliner, tingkat ini memberikan dasar konseptual untuk menafsirkan kesehatan mental sebagai interaksi dari proses yang diwujudkan, sosial, dan ekologis. Tingkat ini mendukung penolakan terhadap paradigma reduksionis dan membingkai integrasi antropologi medis, psikiatri kritis, dan teori-teori pikiran yang diperluas.
Klinis dan medis	Berlabuh pada ilmu pengetahuan translasi, praktik berbasis trauma, dan psikiatri nutrisi, tingkat ini membahas dimensi fisiologis dan terapeutik dari perawatan psikiatri. Hal ini mendukung analisis rezim farmakosentris, mekanisme bahaya iatrogenik, dan kriteria untuk pemberian obat yang bertanggung jawab.
Hukum dan kelembagaan	Didasari oleh kerangka kerja konstitusional, internasional, dan hak asasi manusia, tingkat ini menginterogasi pemaksaan, impunitas hukum, dan kegagalan sistemik dalam akuntabilitas. Hal ini mendasari kritik terhadap tata kelola psikiatri saat ini dan mendukung desain sistem perawatan yang selaras dengan etika dan taat hukum.
Metodologi dan komputasi	Tingkat ini mengoperasionalkan dimensi-dimensi di atas dengan menggunakan penelitian tindakan, metode campuran, dan teknik komputasi yang sedang berkembang, termasuk pemodelan Bayesian, analisis kelangsungan hidup, dan pemetaan sistem. Tingkat ini memastikan koherensi internal dan mempersiapkan lapangan untuk intervensi yang dapat direplikasi dan terukur melalui ilmu pengetahuan terbuka dan reformasi struktural berbasis bukti.

Tabel ini merangkum empat tingkat integrasi analitis yang digunakan dalam penelitian aksi, menyusun strategi metodologis, konseptual, dan terapan disertasi. Setiap level menginformasikan produksi bukti, interpretasi, dan keterlibatan sistemik terhadap reformasi kejiwaan.

Tingkat pertama dari arsitektur ini, seperti yang ditunjukkan pada tabel 7, adalah epistemologis. Dengan menggunakan perspektif biokultural dalam antropologi medis, karya ini mengakui bahwa kesehatan dan penderitaan dibentuk oleh kondisi sosiokultural, ekologis, dan historis, yang berinteraksi dengan proses biologis tanpa dapat direduksi. Kognisi yang diwujudkan dan teori pikiran yang diperluas menginformasikan penolakan dualisme pikiran-tubuh dan mendukung pemeriksaan intervensi psikiatri sebagai sesuatu yang tertanam dalam interaksi yang spesifik dalam konteks tertentu, tidak terisolasi di dalam tengkorak atau terbatas pada individu. Premis-premis konseptual ini dikembangkan lebih lanjut melalui keterlibatan dengan Kerangka Kerja Makna Ancaman Kekuasaan dan kritik terhadap ketidakadilan epistemik, yang keduanya berfungsi untuk memusatkan otoritas klinis dan memposisikan orang-orang yang terkena dampak sebagai agen epistemik yang sah. Kerangka kerja ini tidak bersifat statis atau dekoratif, tetapi bersifat operasional. Kerangka kerja ini mengarahkan logika perumusan masalah, pemilihan unit analisis, dan interpretasi materi empiris. Kerangka kerja ini juga berfungsi sebagai koreksi terhadap ekstraktivisme epistemik, memastikan bahwa praktik-praktik metodologis tidak mereproduksi dinamika kekuasaan yang sama dengan yang ingin diungkap oleh penelitian ini. Mereka didasarkan pada tradisi penelitian yang sudah mapan dan tunduk pada transparansi metodologis, memberikan perancah teoretis yang diperlukan untuk mengevaluasi bahaya dan kemungkinan pengalihan dalam sistem kejiwaan (Field-Springer, 2020).

Tabel 9. Dimensi biologis dari kerangka kerja analitis dan terapan

Komponen	Deskripsi
Ilmu kedokteran translasi	Menghubungkan praktik klinis dengan mekanisme neuroendokrin, imunologi, molekuler, dan metabolisme yang relevan dengan gejala kejiwaan dan respons pengobatan.
Psikiatri nutrisi	Menyelidiki peran diet, mikronutrien, inflamasi, poros usus-otak, dan regulasi metabolisme dalam kesehatan mental.
Psikoneuroendokrinologi	Mengeksplorasi interaksi antara sistem saraf, endokrin, dan sistem kekebalan tubuh dalam stres, trauma, dan proses pemulihan.
Ilmu pengetahuan tentang resep obat	Mengevaluasi praktik terbaik untuk pengurangan atau penghentian perawatan psikofarmakologi jangka panjang, berdasarkan keamanan biologis, kemanjuran, dan hasil yang berpusat pada pasien.
satu fisiologi kesehatan	Mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk menilai dan mengatasi risiko sistemik dan faktor penentu kerentanan biologis bersama.
Tidur, biologi sirkadian, dan perkembangan saraf	Menyelidiki dampak fisiologis dari kebersihan tidur, paparan cahaya, dan ritme harian terhadap ketahanan mental, terutama pada anak-anak dan remaja.

Tabel ini menyajikan kerangka kerja tingkat biologis yang digunakan dalam penelitian tindakan ini, yang diterapkan oleh peneliti untuk memeriksa jalur fisiologis dari gangguan kejiwaan, memandu protokol depreskripsi, dan mendukung intervensi translasi di seluruh disertasi.

Tingkat kedua dari struktur analisis adalah medis dan klinis. Ini menggabungkan ilmu kedokteran translasional, yang menghubungkan pengamatan klinis dengan temuan dalam biologi molekuler, neuroendokrinologi, dan psikofisiologi (tabel 8). Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi dampak biologis dari rejimen obat psikiatri, serta manfaat potensial dari intervensi non-farmakologis yang didasarkan pada fisiologi, termasuk psikiatri nutrisi dan studi tentang dinamika neuroimun dan hormonal (Sarella et al., 2023). Penggunaan perawatan berbasis trauma dan pengobatan naratif memperluas cakupan analisis di luar manajemen gejala, mendukung pengakuan pengalaman hidup dan konteks biografis sebagai data yang relevan secara medis. Kerangka kerja ini tidak membuang farmakologi, tetapi menempatkan kembali perannya dalam pemahaman yang lebih luas tentang kesehatan yang menekankan kausalitas, pemulihan, dan hasil jangka panjang yang tidak merusak. Perawatan psikiatri, dari sudut pandang ini, harus dievaluasi sesuai dengan efeknya terhadap fungsionalitas, otonomi, dan kualitas hidup, bukan hanya pengurangan gejala. Dalam tingkat klinis ini, model psikiatri relasional dan dialogis, khususnya dialog terbuka dan praktik yang berdekatan, menawarkan jalur berbasis bukti yang menekankan kesinambungan, transparansi, dan kepercayaan, seperti yang tercantum dalam tabel 9. Model-model ini bukanlah template preskriptif tetapi sistem dinamis yang memprioritaskan partisipasi dan konteks, selaras dengan standar internasional seperti yang dikemukakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia melalui inisiatif QualityRights, dan diakui secara luas sebagai praktik terbaik yang akan dipromosikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada skala global, dan Dewan Eropa di Uni Eropa, serta oleh sebagian besar asosiasi pengguna dan profesional yang bekerja untuk menerapkan cara-cara yang lebih baik dalam penyembuhan dan pemulihan (Fuller et al., 2022). Standar-standar ini menuntut penghapusan praktik-praktik pemaksaan, integrasi pengambilan keputusan yang berpusat pada orang, dan pembangunan lingkungan perawatan yang menjunjung tinggi martabat dan keadilan prosedural. Penelitian ini menggabungkan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya sebagai referensi normatif tetapi juga sebagai

variabel empiris, yang memungkinkan evaluasi kepatuhan dan penyimpangan dalam pengaturan dunia nyata (Zanardo & Ventura, 2023).

Tabel 10. Dimensi psikologis dari kerangka kerja analitis dan terapan

Komponen	Deskripsi
Teori pikiran yang diperluas	Membangkitkan kognisi sebagai sesuatu yang terdistribusi di seluruh otak, tubuh, alat, dan lingkungan, menawarkan model pengalaman kejiwaan yang tidak reduksionis.
Kognisi yang diwujudkan	Menyoroti peran proses sensorimotor dan interoceptif dalam membentuk fungsi emosional dan kognitif.
Perawatan berbasis informasi trauma	Memasukkan konsekuensi psikologis dari kekerasan, penelantaran, dan stres kronis ke dalam protokol penilaian dan perawatan.
Pengobatan naratif	Menggunakan pembuatan makna autobiografi sebagai alat diagnostik dan terapeutik, memulihkan kemampuan diri melalui penceritaan yang terstruktur.
Kerangka Makna Ancaman Kekuasaan	Menggantikan diagnosis dengan pemahaman kontekstual mengenai strategi bertahan hidup, dinamika kekuasaan, dan makna subjektif.
Mentalisasi dan kapasitas relasional	Meneliti perkembangan psikologis dari fungsi reflektif, empati, dan keterikatan yang aman, sebagai prasyarat untuk kesehatan mental.

Tabel ini berisi daftar model tingkat psikologis yang digunakan selama penelitian lapangan dan analisis disertasi untuk menginterpretasikan pengalaman subjektif, memungkinkan pemahaman bersama, dan merekonstruksi makna dalam konteks kekerasan kejiwaan dan pemulihan.

Oleh karena itu, evaluasi praktik klinis tidak terbatas pada metrik hasil, tetapi juga mencakup dimensi prosedural, etika, dan relasional. Hal ini membutuhkan artikulasi metrik yang sensitif terhadap pengurangan dampak buruk, inklusi sosial, dan kesehatan jangka panjang, di luar resolusi krisis atau penahanan farmakologis. Validitas ilmiah dari intervensi psikiatri harus dinilai dari efek kumulatifnya terhadap perkembangan manusia, terutama pada kasus-kasus di mana kerusakan iatrogenik telah dinormalisasi. Hal ini menuntut ilmu klinis yang ketat dan reflektif, yang mampu memikirkan kembali kriteria kemanjuran dan kesesuaiannya.

Dimensi ketiga dari arsitektur analitis berpusat pada kerangka kerja hukum, struktural, dan kebijakan, yang tidak diperlakukan sebagai tambahan eksternal tetapi sebagai bagian integral dari fungsi dan reproduksi sistem kejiwaan, seperti yang ditunjukkan pada tabel 10. Praktik-praktik pemaksaan dalam psikiatri bukanlah hasil dari kelalaian individu semata, melainkan karena adanya izin hukum dan desain institusional. Tesis ini melibatkan analisis yang ketat terhadap rezim hukum yang mengesahkan pengobatan paksa, membatasi kebebasan pasien, dan memfasilitasi impunitas struktural. Hukum konstitusional Spanyol, yurisprudensi hak asasi manusia Eropa, dan perjanjian internasional seperti Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas memberikan dasar normatif untuk pemeriksaan semacam itu (Organisasi Kesehatan Dunia, 2020). Instrumen-instrumen hukum ini menuntut konfigurasi ulang perawatan yang mengakui kapasitas yang setara, melarang perlakuan yang merendahkan, dan melembagakan perlindungan untuk pengambilan keputusan yang terinformasi dan didukung. Tesis ini mengevaluasi sejauh mana kewajiban-kewajiban ini tidak terpenuhi, mendokumentasikan kesenjangan struktural dan prosedural yang melanggengkan kerugian dengan kedok perawatan. Di luar hukum dan kebijakan individu, penelitian ini menginterogasi logika

administratif dan kelembaman birokrasi yang menstabilkan praktik-praktik berbahaya. Keterlibatan kelembagaan diperiksa sebagai fitur sistemik, bukan sebagai penyimpangan, yang mengungkapkan bagaimana pengadilan, otoritas kesehatan, dan sistem pendidikan beroperasi bersama untuk menegakkan solusi farmakologis sebagai proksi perawatan. Akuntabilitas publik didekati bukan sebagai tujuan normatif tetapi sebagai variabel empiris, yang tunduk pada kekuatan struktural, perlawanan politik, dan kepentingan pribadi profesional. Hal ini membutuhkan analisis hukum yang mencakup pemeriksaan doktrinal dan etnografi institusional, yang menangkap bagaimana hak-hak ditafsirkan, dielakkan, atau ditanggguhkan dalam tata kelola klinis sehari-hari (Gaete & Fritsch, 2021; Davies, Read, & McKeown, 2022).

Tabel 11. Dimensi sosial dari kerangka kerja analitis dan terapan

Komponen	Deskripsi
satu pendidikan kesehatan	Mempromosikan pengetahuan integratif dan literasi perawatan di seluruh sekolah, masyarakat, dan jaringan profesional.
Penelitian aksi dan desain bersama	Melibatkan individu dan profesional yang terkena dampak dalam proses kolaboratif untuk mengidentifikasi, mengimplementasikan, dan menilai perubahan sistemik.
Hak-hak disabilitas dan kerangka hukum	Menyelaraskan praktik kejiwaan dengan hukum hak asasi manusia internasional, mempromosikan pengambilan keputusan dan otonomi yang didukung.
Literasi kesehatan masyarakat dan transparansi kelembagaan	Mengadvokasi informasi yang dapat diakses, tata kelola partisipatif, dan akuntabilitas dalam sistem kesehatan jiwa.
Psikiatri relasional dan dialogis	Memusatkan perhatian pada hubungan interpersonal, kesinambungan, dan saling pengertian, termasuk model-model seperti dialog terbuka.
Reformasi budaya dan pendidikan	Menanamkan nilai-nilai yang etis dan mempromosikan kesehatan ke dalam kurikulum sekolah dan program universitas untuk mencegah pemaksaan dan pengucilan di masa depan.

Tabel ini menyajikan kerangka kerja tingkat sosial dan pendekatan berbasis kebijakan yang diterapkan selama penelitian aksi untuk mendesain ulang sistem perawatan, mempromosikan kepatuhan hukum, dan melibatkan struktur pendidikan dan publik dalam reformasi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, model-model pengambilan keputusan yang didukung, arahan lanjutan, dan mekanisme akuntabilitas yang berakar pada masyarakat disajikan sebagai kebutuhan ilmiah dan hukum, bukan sebagai reformasi opsional. Integrasi mereka dievaluasi berdasarkan kapasitas kelembagaan yang ada, dinamika perlawanan, dan pergeseran epistemologi yang diperlukan untuk memposisikan kembali narasi pasien sebagai sumber pengetahuan dan kedudukan hukum yang valid. Tujuannya adalah untuk memetakan hambatan dan titik masuk untuk reformasi, yang didasarkan pada data empiris dan konsisten dengan praktik terbaik internasional. Lensa hukum dan institusional ini sangat penting untuk memahami tidak hanya apa yang salah dalam perawatan kejiwaan, tetapi juga mengapa hal ini terus berlanjut meskipun ada bukti, dan kondisi sistemik apa yang harus diubah untuk memungkinkan pemulihan dan transformasi.

Komponen keempat dari perancah analitis ini, yang sedang dikembangkan pada saat disertasi ini dicetak, berkaitan dengan sistem komputasi dan metodologi yang mampu menangkap, memodelkan, dan mengintervensi realitas kompleks yang didokumentasikan selama penelitian. Sementara basis

bukti utama tetap bersifat etnografis dan legal, agenda penelitian yang lebih luas, yang telah dimulai melalui data percontohan dan kolaborasi institusional, menggabungkan kerangka kerja komputasi canggih yang dirancang untuk memastikan skalabilitas, replikabilitas, dan ketepatan yang dapat ditindaklanjuti dalam reformasi sistem kesehatan jiwa. Kerangka kerja ini bukan merupakan tambahan, tetapi merupakan dasar dari tujuan translasi tesis ini, yang memungkinkan desain ulang sistem dalam arsitektur yang empiris dan kuat secara statistik. Pemodelan statistik Bayesian diusulkan sebagai alat utama untuk menilai lintasan klinis, memperkirakan efek pengobatan, mensimulasikan intervensi pencegahan berbasis agen, dan juga mensimulasikan kebijakan yang lebih luas. Logika probabilistiknya memungkinkan penggabungan ketidakpastian, heterogenitas, dan umpan balik yang dinamis, sehingga menawarkan cara analisis yang lebih akurat dan responsif secara etis daripada model deterministik atau model linier murni. Secara paralel, metodologi analisis kelangsungan hidup diperkenalkan untuk mengevaluasi hasil pengobatan dari waktu ke waktu, terutama dalam kaitannya dengan kepatuhan pengobatan, kekambuhan, dan kematian di bawah rezim pemaksaan. Alat-alat ini dirancang untuk mengekspos konsekuensi jangka panjang dan saling ketergantungan yang jika tidak, akan tersumbat dalam studi jangka pendek atau cross-sectional. Selain model inferensial, kerangka kerja penelitian ini menggabungkan pemetaan sistem dan pemodelan inferensi kausal untuk menggambarkan interaksi institusional, asimetri kekuasaan, dan lingkaran umpan balik dalam sistem perawatan kejiwaan. Metode-metode ini memungkinkan identifikasi formal dari titik-titik pengungkit di mana intervensi yang ditargetkan dapat menghasilkan perubahan struktural. Alih-alih memperlakukan institusi sebagai lingkungan yang statis, model-model ini mengenalinya sebagai sistem yang dinamis yang dibentuk oleh kekuatan hukum, budaya, klinis, dan politik. Hal ini sejalan dengan landasan biokultural dan penelitian aksi dari tesis ini, yang menuntut alat yang mampu menelusuri pengalaman yang terjadi di lapangan dan konsekuensi makro-sistemik (Cook et al., 2019).

Meskipun disertasi itu sendiri berfokus terutama pada data kualitatif, narasi, dan data berbasis lapangan, disertasi ini secara eksplisit menempatkan elemen-elemen ini dalam infrastruktur translasi yang lebih luas. Arsitektur ini sudah dalam tahap pembangunan melalui EU BEACON One Health Education COST Action¹, yang didirikan sebagai kelanjutan langsung dari penelitian doktoral ini untuk memungkinkan keberlanjutannya. Proyek-proyek yang sedang dikembangkan meliputi prototipe sistem pakar, alat pendukung keputusan, dan platform pemantauan terintegrasi yang dirancang untuk menanamkan perawatan berbasis hak ke dalam pengaturan klinis dan pendidikan. Dengan demikian, dasar yang diletakkan dalam tesis ini secara langsung masuk ke dalam agenda penelitian Eropa yang terkoordinasi, yang tidak hanya berusaha untuk mengkritik kegagalan sistemik tetapi juga untuk bersama-sama merancang alternatif yang dapat direplikasi, divalidasi, dan dapat dipertahankan secara etis yang berakar pada data dan tata kelola partisipatoris (Frerichs dkk, 2016).

Segmen terakhir dari Bagian 1.9 ini mengkonsolidasikan peran tesis ini sebagai sebuah penyelidikan ilmiah yang berdiri sendiri dan sebagai platform peluncuran untuk transformasi sistemik yang lebih luas. Penelitian ini, meskipun didasarkan pada praktik akademik yang ketat dan dipandu oleh kerangka kerja epistemologis, klinis, dan hukum yang telah ditentukan, juga telah menghasilkan jalur

¹Aksi Koordinasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi COST Uni Eropa yang didirikan oleh para peneliti sebagai jalan utama untuk aksi atau penelitian aksi, yang dikhususkan untuk satu pendidikan kesehatan, pada saat mencetak disertasi ini mencakup lebih dari dua puluh negara dengan jaringan sekitar setengah ribu ahli yang berdedikasi di bawah kepemimpinannya: <https://health.int.eu.org/>

operasional menuju implementasi. Hal ini diformalkan melalui EU BEACON One Health Education COST Action², yang menyediakan lingkungan yang terstruktur untuk kesinambungan, skala, dan koordinasi kelembagaan di luar cakupan langsung dari disertasi. Kesinambungan ini bukan merupakan tambahan tetapi merupakan hasil yang disengaja dari metodologi penelitian aksi, yang menyatakan bahwa pengetahuan yang valid harus mampu menginformasikan dan membentuk praktik-praktik dalam sistem yang ingin diubah.

Tesis ini telah menjadi katalisator dari beberapa jalur penelitian yang saling terkait yang kini dikembangkan menjadi proposal Horizon Europe berskala besar. Ini termasuk proyek-proyek yang berfokus pada kesehatan kognitif berbasis sekolah melalui rutinitas terstruktur dalam olahraga, tidur, nutrisi, dan suplementasi; inisiatif kesehatan lingkungan yang menargetkan paparan neurotoksik pada masa kanak-kanak; reformasi berbasis hak atas sistem kesehatan mental anak dan remaja yang didasarkan pada pengambilan keputusan bersama dan perawatan relasional; dan mekanisme pendampingan institusional untuk mendorong makna, akuntabilitas, dan keamanan dalam pengaturan pendidikan dan klinis. Masing-masing proposal ini berasal secara konseptual dan empiris dari temuan, kerangka kerja, dan kebutuhan yang diidentifikasi dalam disertasi ini, dan masing-masing menerapkan struktur metodologis yang dijabarkan dalam bab ini ke dalam sistem di dunia nyata.

Tabel 12. Dimensi kunci WHO QualityRights dalam transformasi sistem kesehatan jiwa

Dimensi WHO QualityRights	Deskripsi dan relevansi dengan disertasi
1. Hak atas standar hidup yang memadai	Mengatasi perumahan, makanan, air, dan kondisi kehidupan sebagai hal yang mendasar untuk pemulihan. Menginformasikan kritik disertasi terhadap pengabaian dan pengabaian sosial ekonomi dalam sistem kejiwaan.
2. Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai	Mendasari permintaan untuk perawatan berbasis hak, berdasarkan informasi trauma, dan tanpa paksaan. Memandu transisi yang diusulkan dari praktik farmakosentris ke pendekatan integratif dan multidisiplin.
3. Hak atas kapasitas hukum dan otonomi pribadi	Secara langsung mendukung penekanan disertasi pada pengambilan keputusan yang didukung, arahan sebelumnya, dan penolakan terhadap penghakiman pengganti dalam konteks psikiatri.
4. Kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat	Membingkai pengobatan paksa, rawat inap paksa, dan kekerasan epistemik sebagai pelanggaran hukum internasional. Memperkuat keharusan ilmiah dan etis untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan.
5. Hak untuk hidup mandiri dan inklusi dalam komunitas	Memperkuat agenda penelitian tentang deinstitutionalisasi, dukungan komunitas yang bermakna, dan kondisi struktural yang diperlukan untuk partisipasi dan pemulihan.

Tabel ini menyajikan lima tema inti dari kerangka kerja WHO QualityRights yang diterapkan dalam proyek penelitian aksi. Dimensi-dimensi ini menyusun evaluasi, kritik, dan desain ulang sistem perawatan psikiatri, mendorong keselarasan dengan standar hukum internasional dan perawatan yang berpusat pada orang yang berbasis bukti.

²Aksi COST Uni Eropa adalah sebuah jaringan penelitian interdisipliner yang menyatukan para peneliti dan inovator untuk menyelidiki sebuah topik pilihan mereka selama 4 tahun. COST Actions biasanya terdiri dari para peneliti dari akademisi, UKM, lembaga publik, dan organisasi terkait lainnya atau pihak-pihak yang berkepentingan, untuk mengembangkan jaringan penelitian profesional mereka sambil mencapai tujuan bersama: <https://www.cost.eu/cost-actions/what-are-cost-actions/>

Penelitian ini mengikuti model one health sebagai kerangka kerja ilmiah dan tata kelola yang terintegrasi, yang menghubungkan faktor penentu kesehatan manusia, lingkungan, dan kelembagaan melalui infrastruktur pengetahuan bersama, termasuk perlindungan etika, mekanisme partisipatif, dan tim peneliti multidisiplin, dan dirancang untuk menghasilkan bukti nyata di tingkat individu dan populasi. Kerangka kerja ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, standar Hak Asasi Organisasi Kesehatan Dunia yang tercantum dalam tabel 11 di atas, dan konsensus internasional tentang perlunya menerapkan perawatan yang tepat berdasarkan gender, budaya, dan trauma, perawatan yang dipersonalisasi melalui uji tuntas dan studi jejaring sosial, perawatan berbasis hak, dan perawatan yang peka terhadap konteks, menyangkal semua kemungkinan bahaya iatrogenik dan pengulangan kejahatan terhadap pasien. Kerangka kerja ini menawarkan legitimasi ilmiah, relevansi kebijakan, dan kelayakan operasional untuk model analitis yang dikembangkan dalam penelitian ini. Semuanya akan ditinjau kembali di bab berikutnya, tentang metodologi.

Bab ini telah menguraikan landasan konseptual, hukum, klinis, dan sistemik yang menjadi dasar dari disertasi ini, mengidentifikasi defisit struktural, distorsi epistemik, dan praktik-praktik institusional yang melanggengkan bahaya dengan kedok perawatan. Disertasi ini telah menetapkan perlunya pergeseran paradigmatik, yang tidak didasarkan pada cita-cita abstrak, tetapi pada kerangka kerja ilmiah, hukum, dan partisipatoris yang teruji secara ketat. Apa yang terjadi selanjutnya dalam karya ini adalah artikulasi komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diimplementasikan melalui penelitian lapangan di berbagai lokasi, penelitian aksi partisipatif, dan survei. Disertasi ini memajukan sebuah keharusan yang mendesak secara ilmiah dan medis: untuk memulihkan, melestarikan, dan meningkatkan kesejahteraan, integritas, dan otonomi manusia di semua domain kehidupan.

Bab 2 - Kerangka kerja metodologis: penelitian tindakan dan posisi

2. Meta-metodologi refleksif dan kerangka kerja metodologis ilmiah

Disertasi ini dibangun melalui proses transdisipliner dan refleksif yang berakar pada etnografi ilmiah, penelitian aksi partisipatoris, dan konsepsi materialis tentang pengetahuan yang memiliki latar belakang historis, dibatasi secara politis, dan secara etis sangat penting. Jauh dari sekadar agregasi hasil yang pasif, struktur dan kontennya muncul melalui keterlibatan rekursif dengan penderitaan, perlawanan, dan pencarian kebenaran di bawah kesulitan yang ekstrem. Protokol termasuk pelacakan paralel data lapangan dan refleksi analitis; praktik-praktik ilmu pengetahuan terbuka seperti dokumentasi yang diberi cap waktu, repositori publik, dan lingkaran umpan balik dari para ahli; dan penyelarasan yang konstan dengan mandat etis dari perawatan yang berbasis trauma, berbasis hak asasi manusia, dan berbasis budaya. Urutan bab dan hasil penelitian mengikuti penyelesaian empiris dari setiap kumpulan data dan implikasi sistemiknya, bukan abstraksi teoretis (Subramani, 2019).

Desain penelitian, implementasi, dan konstruksi narasi dikembangkan sebagai sistem yang hidup yang tertanam dalam jaringan kepedulian, perjuangan, dan transformasi sistemik. Hal ini melibatkan pembangunan infrastruktur digital, koordinasi sistem pakar, menjaga kontak dengan masyarakat yang

terkena dampak, dan memberlakukan pemeriksaan dan keseimbangan epistemik yang berkelanjutan. Metodologi ini menghormati wawasan dasar Paul Farmer: melakukan penelitian di bidang penderitaan tanpa berkontribusi pada pengentasannya adalah sebuah pengkhianatan (Farmer, 1999; Farmer, 2003). Hasilnya adalah sebuah disertasi yang bukan hanya sebuah dokumen ilmiah, tetapi juga sebuah tindakan praktis untuk menentang ketidakadilan epistemik dan keterlibatan institusional, yang menawarkan transparansi metodologis sebagai syarat kredibilitas dan tanggung jawab etis.

2.1 Pendekatan keseluruhan dan landasan metodologis

Inti metodologis dari disertasi ini dibangun di atas fondasi biokultural, transdisipliner, dan penelitian aksi yang dirancang untuk menghasilkan pengetahuan yang valid, sesuai konteks, dan dapat diubah. Kekerasan psikiatri, pengkhianatan institusional, dan tata kelola kesehatan yang koersif tidak dikonseptualisasikan sebagai kegagalan episodik, tetapi sebagai fenomena yang tertanam secara sistemik. Oleh karena itu, penyelidikan ini tidak beroperasi dalam batas-batas silo disiplin ilmu atau pemodelan teoritis yang abstrak, melainkan menggunakan metodologi terintegrasi yang menyelaraskan kerangka klinis, hukum, antropologi, dan komputasi. Pendekatan ini bersifat induktif dan berpijak pada epistemologi berbasis lapangan, dengan peneliti diposisikan sebagai praktisi dan subjek yang terpengaruh. Namun, reflektivitas dioperasionalkan secara ilmiah, bukan sentimental, dengan posisi yang tertanam diperlakukan sebagai sumber akses epistemik, bukan bias. Dengan memanfaatkan kontribusi epistemologis dari Miranda Fricker dan Kristie Dotson, metodologi ini mengedepankan ketidakadilan testimonial dan hermeneutis sebagai kondisi sistemik yang menghalangi produksi dan penerimaan pengetahuan pasien (Fricker, 2017). Komitmen metodologis terhadap keadilan epistemik tidak bersifat retorik tetapi diimplementasikan melalui triangulasi terstruktur, prosedur pengkodean yang ketat, dan validasi responden, untuk memastikan bahwa perspektif pengguna dimasukkan secara sistematis, bukan secara selektif (Dotson, 2012).

Tabel 13. Antropologi medis dan kekerasan struktural

Landasan Metodologis	Ahli	Mengapa Dimasukkan	Bagaimana Dioperasionalkan dalam Penelitian Ini
Antropologi Medis / Kekerasan Struktural	Paul Farmer	Menghubungkan ketidaksetaraan struktural dengan hasil medis; menciptakan istilah kekerasan struktural	Menyediakan alat analisis untuk menghubungkan pelecehan kejiwaan dengan struktur kelembagaan, ekonomi, dan hukum yang lebih luas
Antropologi Medis Kritis	Nancy Scheper-Hughes	Mendokumentasikan kekerasan negara dan institusional melalui etnografi dalam konteks klinis	Menambatkan investigasi penderitaan yang diwujudkan dan penghapusan epistemik di bawah tata kelola kejiwaan
Psikiatri Transkultural	Arthur Kleinman	Mengembangkan model-model penjelasan dan konsep biologi lokal	Mendukung pemahaman yang peka terhadap konteks interaksi diagnostik dan terapeutik
Psikiatri Naratif / Antropologi Medis	Byron Good	Mengeksplorasi idiom-idiom kesusahan dan representasi naratif dari penyakit mental	Digunakan untuk memandu metode interpretasi dalam menganalisis pengalaman subjektif dan narasi pemulihan

Para ahli dasar dalam antropologi medis dan kekerasan struktural yang menginformasikan analisis etnografi, klinis, dan epistemik. Pekerjaan mereka mendasari alat konseptual yang digunakan untuk mendokumentasikan bahaya institusional, mengontekstualisasikan narasi kejiwaan, dan memecahkan kode patologisasi sistemik.

Struktur metodologis ini diinformasikan oleh teks-teks dasar dalam antropologi medis dan praksis kesehatan global, termasuk etos partisipatoris dari Orlando Fals-Borda, lensa analisis biososial dari Paul Farmer, dan perhatian etnografis terhadap kekerasan struktural dan korporat yang dikembangkan oleh Nancy Scheper-Hughes (Scheper-Hughes & Lock, 1987; Fals-Borda, 1988). Masing-masing kerangka kerja ini berkontribusi pada dasar pemikiran transdisipliner dari penelitian ini, yang tidak bertujuan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terisolasi, tetapi untuk mengekspos dan mengkonfigurasi ulang aparatus bertingkat dari tata kelola kejiwaan di Spanyol. Fokus empiris meluas ke seluruh lingkungan masyarakat, lingkungan klinis, proses administratif, dan infrastruktur hukum. Data diperoleh melalui metode triangulasi yang mencakup observasi partisipan yang diperpanjang, wawancara semi-terstruktur dan terbuka, survei di seluruh kelompok pemangku kepentingan, dan analisis arsip dan dokumen hukum. Materi-materi tersebut tidak hanya disandingkan, tetapi diintegrasikan ke dalam arsitektur analitis yang mampu menghasilkan temuan-temuan yang membumi dan pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti secara struktural. Metodologi ini tidak dirancang untuk mengkonfirmasi hipotesis yang berasal dari model normatif penyakit jiwa, tetapi untuk mengekstrak dan mengevaluasi pola-pola bahaya, pertanggungjawaban, dan pemulihan dalam tata kelola kejiwaan di dunia nyata. Dalam hal prinsip-prinsip inti dari penelitian tindakan, prinsip-prinsip tersebut diterapkan meskipun beroperasi di bawah kondisi yang menghalangi iterasi institusional secara penuh dan konfigurasi ulang praktik-praktik sistemik dengan segera. Menyadari kendala dalam melakukan penyelidikan struktural dari posisi akademis non-eksekutif, desain penelitian ini menerapkan prinsip-prinsip observasi partisipatif, keterlibatan dialogis, responsif reflektif, dan umpan balik berbasis bukti di semua domain yang dapat diakses oleh peneliti. Alih-alih memperlakukan penelitian aksi sebagai sesuatu yang bergantung pada kepemilikan otoritas formal atau pengaruh institusional, proyek ini mengoperasionalkannya sebagai sebuah etos metodologis,

yang tertanam dalam desain instrumen, penataan kerja lapangan, produksi bersama pengetahuan, dan transformasi jangka panjang lingkungan penelitian.

Pekerjaan ini tertanam sejak awal dalam struktur kolaboratif yang dirancang untuk memungkinkan pembelajaran kolektif dan desain ulang yang berulang. Hal ini dicontohkan oleh aksi jaringan EU BEACON One Health Education, yang muncul sebagai perluasan translasi dari prinsip-prinsip epistemik dan struktural yang diartikulasikan dalam disertasi (Freire, 2000). Selama dua tahun, proposal tersebut mengalami beberapa kali revisi, berdasarkan masukan dari para profesional, kriteria evaluasi formal, prioritas pemangku kepentingan, dan realitas implementasi. Keberhasilan akhir dari aksi ini bukanlah hasil dari eksekusi linear, tetapi dari siklus rekursif redefinisi, kalibrasi ulang, dan akuntabilitas epistemik, tepatnya model pengulangan tingkat sistem yang dianjurkan dalam tradisi penelitian aksi. Prinsip-prinsip pengulangan yang sama diterapkan di berbagai skala keterlibatan akademis dan klinis peneliti, termasuk penyempurnaan instrumen survei, penataan hubungan kolaboratif di lapangan, desain kegiatan penjangkauan publik, dan tinjauan sejawat terbuka terhadap alat analisis.

Tabel 14. Penelitian aksi dan penyelidikan partisipatif

Landasan Metodologis	Ahli	Mengapa Dimasukkan	Bagaimana Dioperasionalkan dalam Penelitian Ini
Penelitian Aksi Partisipatoris	Orlando Fals-Borda	Pelopor penelitian aksi partisipatoris; menekankan pada produksi bersama pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat	Menyediakan basis epistemik untuk penyelidikan kolaboratif yang etis yang melibatkan orang-orang yang terkena dampak dalam desain dan implementasi penelitian
Penelitian Aksi Partisipatoris Kritis	Paulo Freire	Memperkenalkan metode dialogis dan peningkatan kesadaran sebagai hal yang esensial bagi transformasi sosial	Menginformasikan dimensi politik dan pendidikan dari desain penelitian aksi dalam sistem kesehatan mental
Dialog Demokratis / Praktik Reflektif	Peter Reason	Siklus inkuiri partisipatoris tingkat lanjut dan pembelajaran kolektif berbasis refleksi	Mendukung proses umpan balik rekursif dan interpretasi bersama atas data lapangan di seluruh kelompok peserta
Penelitian Tindakan Sistemik	Hilary Bradbury	Mengembangkan kerangka sistemik penelitian tindakan di bidang kesehatan, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan	Memungkinkan integrasi lintas-skala dan pembingkai reformasi kelembagaan sebagai perubahan sistemik yang tertanam

Kontributor utama dalam pendekatan penelitian aksi partisipatoris dan sistemik yang diterapkan dalam disertasi ini. Tokoh-tokoh ini memberikan dasar epistemologis dan praktis untuk desain penelitian yang kolaboratif, berulang, dan ditempatkan secara etis dalam konteks transformasi sistem kejiwaan.

Dalam konteks ini, peneliti tidak mengambil peran sebagai evaluator eksternal atau diagnostikus yang maha tahu (Heron & Reason, 1997; Reason & Bradbury, 2001). Sebaliknya, peran tersebut dibingkai sebagai aktor yang bertanggung jawab secara epistemik, yang secara simultan mendokumentasikan dan berpartisipasi dalam pembuatan makna kolektif, pemikiran ulang kelembagaan, dan kritik struktural. Tidak adanya kontrol manajerial langsung terhadap protokol klinis atau institusional tidak ditafsirkan sebagai batasan integritas metodologis, tetapi sebagai cerminan dari kondisi dunia nyata di

mana reformasi harus sering dimulai. Orientasi penelitian tindakan diterapkan tidak melalui siklus formal perubahan yang diimplementasikan dan penilaian ulang dalam skala besar, tetapi melalui penyematan etika, desain bersama metodologis, dan penerapan praktik ilmu pengetahuan terbuka secara konsisten. Semua instrumen survei, protokol lapangan, dan struktur analisis disebarluaskan untuk mendapatkan komentar publik, mendapatkan umpan balik internasional, dan disempurnakan secara berulang-ulang sesuai dengan konteks yang berkembang. Pada tingkat yang lebih rinci, metodologi penelitian aksi menginformasikan pengambilan keputusan adaptif peneliti dalam menanggapi kondisi lapangan, ketersediaan partisipan, hambatan hukum, dan pembungkaman institusional. Hal ini diwujudkan dalam upaya berkelanjutan untuk mempertahankan kesetiaan epistemik dalam konteks yang merugikan, mendokumentasikan kerugian dengan ketelitian metodologis, dan mengarahkan hasil penelitian ke dalam format yang dapat digunakan dan terukur yang mampu memandu perbaikan kelembagaan. Upaya-upaya ini mencakup desain dan penyebaran sistem pakar sumber terbuka, jalur diagnostik digital, protokol depreskripsi berbasis bukti, dan kerangka kerja dokumentasi hukum-etis yang dapat diverifikasi secara publik. Masing-masing instrumen ini disusun bukan sebagai hasil yang statis, tetapi sebagai alat modular yang dapat disempurnakan oleh komunitas dan validasi praktis.

Praktik peneliti sendiri diatur oleh logika berulang yang sama, dengan audit rutin atas keputusan metodologis, penilaian mandiri etis, dan penggabungan kritik rekan sejawat. Ketika kekuatan institusional untuk mengimplementasikan perubahan masih kurang, peneliti membuat struktur tandingan untuk verifikasi dan perlindungan melalui afiliasi dengan jaringan internasional, kelompok rekan sejawat horisontal, dan asosiasi profesional yang berkomitmen terhadap hak asasi manusia, ilmu pengetahuan terbuka, dan reformasi sistem kesehatan mental. Konstelasi ini berfungsi sebagai platform rekursif untuk umpan balik, penyempurnaan, dan implementasi yang terdistribusi. Dengan demikian, peneliti mempertahankan model iteratif penelitian aksi yang selaras dengan kritik sistemik, produksi bersama pengetahuan, dan kesiapan translasi, meskipun beroperasi dari dalam sistem yang tetap resisten secara struktural terhadap transformasi etis (Ramírez et al., 2024).

Bab terapan ini menegaskan bahwa penelitian aksi, jika dipahami dengan baik, tidak hanya bergantung pada siklus implementasi dan penilaian ulang kelembagaan. Hal ini juga dapat diwujudkan melalui logika rekursif, partisipasi terbuka, transparansi yang berprinsip, dan daya tanggap adaptif dalam penelitian lapangan yang bertingkat (McDowell et al., 2023). Prinsip utama, bahwa penelitian harus diproduksi bersama, ditempatkan, dan diarahkan pada transformasi yang dapat ditindaklanjuti, dengan para korban sebagai pusat perhatian, tetap berlaku selama disertasi ini, memandu desain, interpretasi, dan agenda translasi.

Penelitian ini juga selaras dengan kerangka kerja one health sebagai sistem ilmiah yang mengintegrasikan faktor penentu ekologi, biologi, teknologi, dan sosial dari kesehatan; di antara nilai-nilai inti transversal dan cara-cara untuk memahami hal yang sedang berlangsung (Simmons, 2025). Penelitian ini menerapkan prinsip ini bukan pada tingkat metafora tetapi melalui arsitektur datanya, menghubungkan interaksi usus-otak, gangguan endokrin, dan respons neuroimun dengan rutinitas institusional, praktik diagnostik, dan faktor penentu kerentanan struktural. Psikiatri nutrisi, psikoneuroimunologi, dan perawatan berbasis trauma diperlakukan sebagai kerangka kerja yang mapan secara ilmiah dan relevan secara klinis yang harus diintegrasikan ke dalam evaluasi intervensi

psikiatri. Dimasukkannya kognisi yang diwujudkan dan teori pikiran yang diperluas memungkinkan penolakan terhadap asumsi dualistik dan reduksionis yang lazim dalam klasifikasi psikiatri dan protokol terapeutik. Kognisi tidak terbatas pada otak tetapi diekspresikan melalui konfigurasi relasional, material, dan budaya. Perspektif ini tidak bersifat filosofis tetapi terapan, memandu interpretasi kesaksian, pemilihan metrik klinis, dan pemetaan kekerasan sistemik.

Tabel 15. Keadilan epistemik dan inklusi pengetahuan

Landasan Metodologis	Ahli	Mengapa Diikutsertakan	Bagaimana Dioperasionalkan dalam Penelitian Ini
Keadilan Epistemik	Miranda Fricker	Mendefinisikan ketidakadilan testimonial dan hermeneutika dalam produksi pengetahuan	Membenarkan keharusan metodologis untuk mengenali perspektif pasien yang ditekan atau didiskualifikasi
Epistemologi Feminis Kulit Hitam	Kristie Dotson	Memperluas kerangka ketidakadilan epistemik; menekankan pembungkaman struktural	Memperkuat analisis interseksional tentang pengucilan dalam pengaturan psikiatri dan interpretasi data

Sumber-sumber metodologis dari bidang keadilan epistemik dan epistemologi feminis yang mendukung inklusi pengetahuan yang dibungkam, didiskreditkan, atau dikecualikan secara struktural dalam kerangka kerja ilmiah disertasi ini. Referensi-referensi ini memandu validasi kesaksian pengguna dan perlindungan terhadap ekstraktivisme epistemik.

Struktur metodologis dari disertasi ini didasarkan pada penelitian aksi tidak hanya sebagai kerangka kerja partisipatoris, tetapi juga sebagai pendekatan yang secara epistemologis diperlukan ketika menyelidiki kerusakan sistemik dan kekerasan institusional. Mengikuti karya-karya dasar dari Orlando Fals-Borda, Paulo Freire, dan Peter Reason, penelitian ini menempatkan produksi pengetahuan dalam siklus inkuiri yang dialogis, berulang-ulang, dan tertanam secara sosial. Pendekatan ini menuntut keterlibatan aktif masyarakat yang terkena dampak, tidak hanya sebagai subjek penelitian, tetapi juga sebagai pembangun pengetahuan dan akuntabilitas. Sejalan dengan kontribusi Hilary Bradbury dalam penelitian aksi sistemik, proyek ini mengintegrasikan umpan balik bertingkat dan mekanisme pelibatan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa wawasan tidak diabstraksikan dari praktik, tetapi secara langsung menginformasikan strategi reformasi kelembagaan dan transformasi kesehatan masyarakat. Desain penelitian aksi ini secara etis responsif, transparan secara metodologis, dan secara struktural selaras dengan tujuan perubahan sistem kejiwaan seperti yang diartikulasikan dalam model tata kelola kesehatan satu atap (Simmons, 2025).

Melengkapi struktur partisipatif ini, landasan metodologisnya banyak diambil dari antropologi medis untuk melacak kondisi sosiokultural dan historis di mana praktik kejiwaan telah menormalkan pemaksaan, pembungkaman diagnostik, dan pengabaian kelembagaan. Kontribusi penting dari Paul Farmer, Nancy Scheper-Hughes, Arthur Kleinman, dan Byron Good memberikan kerangka kerja untuk menafsirkan gangguan kejiwaan sebagai manifestasi dari kekerasan struktural yang tertanam dalam sistem hukum, klinis, dan epistemik (Farmer & Kleinman dkk, 2013). Model biososial Farmer menghubungkan hasil kesehatan dengan determinan makro-sosial, dan konsepnya tentang kekerasan struktural menggarisbawahi bagaimana praktik-praktik rutin dalam dunia kedokteran dapat berfungsi

sebagai instrumen dominasi. Catatan etnografis Scheper-Hughes tentang kebrutalan medis dan degradasi tubuh mengungkapkan perlunya menempatkan tindakan kejiwaan dalam matriks yang lebih luas dari pengingkaran birokratis dan afektif. Kleinman dan Good, melalui pengembangan model-model penjelasan dan idiom-idiom penderitaan, menawarkan alat untuk mengenali pluralitas narasi penderitaan yang dipatologiskan atau diabaikan dalam kerangka biomedis (Good, 1992; Good, 1994). Model-model antropologi ini tidak hanya dikutip tetapi dioperasionalkan melalui kerangka kerja pengkodean, analisis naratif, dan logika interpretatif dari penelitian lapangan, untuk memastikan bahwa makna sistemik, asimetri kekuasaan, dan bahasa pasien tetap menjadi pusat dari interpretasi data.

Tabel 16. Evaluasi sistem dan analisis kelembagaan

Landasan Metodologis	Ahli	Mengapa Dilibatkan	Bagaimana Dioperasionalkan dalam Penelitian Ini
Evaluasi Realis	Trisha Greenhalgh	Menerapkan pendekatan realis untuk mengevaluasi intervensi kesehatan yang kompleks	Strategi triangulasi dasar dan memungkinkan interpretasi faktor kontekstual multi-level
Etnografi Institusional	Howard Becker	Memperkenalkan konsep hirarki kredibilitas dan pelabelan penyimpangan	Menginformasikan pemetaan klasifikasi psikiatri, pembenaran administratif, dan keterlibatan institusi
Psikiatri Demokratis / Kritik Institusional	Franco Basaglia	Memimpin deinstitutionalisasi di Italia dan membingkai ulang paksaan sebagai penindasan sistemik	Jangkar konseptual untuk kritik terhadap institusi psikiatri dan alternatif partisipatoris

Kontributor utama dalam etnografi institusional, evaluasi realis, dan psikiatri demokratis. Metodologi mereka menginformasikan analisis bertingkat tesis tentang tata kelola psikiatri, logika administratif, dan struktur akuntabilitas.

Pada tingkat biologis dan klinis, penelitian ini melibatkan perkembangan kontemporer dalam psikiatri translasional dan ilmu kesehatan metabolik untuk membingkai ulang dasar fisiologis dari penderitaan dan pemulihan mental. Paradigma biomedis arus utama, seperti yang diwakili oleh penekanan Thomas Insel pada biomarker dan sirkuit saraf, diinterogasi secara kritis, terutama mengenai kecenderungan reduksionis dan kegagalannya untuk menghasilkan hasil yang efektif secara terapeutik. Sebagai tanggapan, disertasi ini mengintegrasikan alternatif yang telah divalidasi secara ilmiah dari bidang psikoneuroendokrinologi (PNEI), psikiatri nutrisi, dan psikiatri metabolik. George Chrousos dan Bruce McEwen memberikan dasar-dasar ilmiah untuk memodelkan stres kronis dan beban alostatik sebagai konsekuensi biologis yang dapat diukur dari paparan psikiatris dan institusional (McEwen & Wingfield, 2003; Chrousos, 2009). Karya penting Felice Jacka tentang pola diet dan kesehatan mental membangun hubungan yang kuat antara asupan mikronutrien, peradangan, dan pengaturan suasana hati, seperti halnya bidang psikiatri nutrisi yang kini berkembang pesat (Jacka et al., 2015). Kerangka kerja metabolik Christopher Palmer menafsirkan ulang gangguan mental melalui disfungsi mitokondria dan disregulasi energi sistemik, menawarkan paradigma baru untuk memahami dan membalikkan gejala yang resisten terhadap farmakoresisten, dengan psikiatri metabolik yang juga merupakan bidang baru yang menunjukkan hasil yang spektakuler (Palmer et al.,

2022). Model-model ini menyatu dengan kontribusi Michael Berk (2011) tentang stres oksidatif dan John Cryan dan Ted Dinan tentang interaksi mikrobioma-otak, membentuk arsitektur fisiologis multidimensi yang mendukung depreskripsi, intervensi nutrisi, dan pemulihan keseimbangan neurobiologis melalui cara-cara non-invasif, semuanya dalam psikiatri biologis yang tepat, untuk mencapai pemulihan (Dinan & Dinan, 2023).

Saya sendiri menjadi bukti kekuatan paradigma baru ini, yang berguna untuk mengatasi kerusakan akibat keracunan paksa yang dialami setelah dan selama pemukulan; sebelum hal yang lebih buruk terjadi, dan masih membantu. Itu semua berpegang pada *mens sana in corpore sano*, termasuk olahraga: jiwa yang lebih tahan, dalam tubuh yang kuat, bergizi baik, dengan disiplin dan kontrol diri dari rezim yang tepat dalam sebuah akun. Bersama-sama, kerangka kerja ini tidak hanya memberikan legitimasi ilmiah tetapi juga fungsionalitas metodologis untuk mengevaluasi pengobatan, mengidentifikasi bahaya kumulatif, dan merancang strategi restoratif yang mengintegrasikan perbaikan fisiologis dengan transformasi struktural. Kerangka kerja tersebut menjangkarkan analisis klinis dari penelitian ini dalam sebuah model kesehatan yang responsif terhadap kompleksitas dunia nyata, masuk akal secara biologis, dipandu secara etis, dan dapat diuji secara empiris. Alih-alih mengganti satu teori dengan teori lainnya, kerangka kerja terpadu ini menciptakan infrastruktur metodologis yang mampu menangkap dan mengoreksi kegagalan paradigma kejiwaan yang dominan.

Secara operasional, arsitektur penelitian ini terstruktur di sekitar empat tingkat analisis yang saling bergantung: epistemologis, medis, hukum, dan komputasi. Tingkat-tingkat ini secara kolektif memastikan integritas metodologis dan penerapan translasional dari penelitian ini. Tingkat pertama, epistemologis, menerapkan pendekatan biokultural yang didasarkan pada antropologi medis, ilmu kognitif, dan psikiatri kritis. Pendekatan ini mengkonseptualisasikan tekanan dan ketahanan mental sebagai produk dari kekuatan biologis, lingkungan, sejarah, dan sosiokultural yang saling berinteraksi. Kerangka kerja ini memungkinkan integrasi ilmiah dari model-model seperti kognisi yang diwujudkan, pengobatan naratif, Kerangka Kerja Makna Ancaman Daya, semuanya sebagai bagian dari keseluruhan yang kongruen dan efektif untuk memahami masalah nyata yang sedang terjadi.

Tabel 17. Kerangka kerja psikiatri, nutrisi, metabolisme, dan fisiologis translasional

Landasan Metodologis	Ahli	Mengapa Dimasukkan	Bagaimana Dioperasionalkan dalam Penelitian Ini
Psikiatri Translasional	Thomas Insel	Mempromosikan model berbasis sirkuit dan penemuan biomarker biologis dalam psikiatri	Dirujuk secara kritis dalam analisis pergeseran psikiatri ke arah neuroreduksionisme dan klasifikasi berbasis biomarker
Psikoneuroendokrinologi (PNEI)	George Chrousos	Mendefinisikan biologi stres dan jalur imuno-endokrinnya	Mendasari model biologis yang diinformasikan oleh trauma dan sistem respons stres yang diintegrasikan ke dalam analisis klinis
PNEI / Stres dan Peradangan	Bruce McEwen	Mengembangkan konsep beban allostatik dalam stres dan neuroplastisitas	Mendukung evaluasi respons stres kejiwaan kronis dan efek jangka panjang dari bahaya iatrogenik
Psikiatri Nutrisi	Felice Jacka	Memelopori penelitian berskala besar yang menghubungkan kualitas diet dan kesehatan mental	Memberikan dasar empiris untuk intervensi diet dan poros usus-otak sebagai faktor risiko yang dapat dimodifikasi
Psikiatri Metabolik	Christopher Palmer	Menganjurkan untuk memikirkan kembali penyakit mental melalui kerangka kerja mitokondria dan metabolik	Menginformasikan kemungkinan biologis dari depreskripsi dan intervensi berbasis nutrisi pada kasus-kasus yang resisten terhadap pengobatan
Psikobiotik / Sumbu Usus-Otak	John Cryan / Ted Dinan	Memperkenalkan konsep psikobiotik dan efek mikrobioma usus pada suasana hati dan kognisi	Diintegrasikan ke dalam analisis kerentanan fisiologis dan mendukung mekanisme terapi alternatif
Peradangan dan Psikiatri	Michael Berk	Menunjukkan hubungan antara peradangan, stres oksidatif, dan gejala kejiwaan	Menjangkar biomarker sistemik sebagai variabel yang valid dalam pemodelan klinis dan protokol depreskripsi etis

Referensi ilmiah yang mendukung model medis translasi disertasi. Para sarjana ini berkontribusi pada analisis dimensi neuroendokrin, inflamasi, nutrisi, dan metabolisme dari tekanan dan pemulihan kejiwaan, memvalidasi target biologis untuk intervensi non-farmakologis, resep, dan keamanan fisiologis di seluruh sistem.

Tingkat kedua, klinis dan medis, menerapkan ilmu translasi untuk memeriksa dampak biologis dari intervensi psikiatri dan dimensi somatik pemulihan. Hal ini melibatkan bukti dari psikiatri nutrisi, psikoneuroimunologi, dan perawatan berbasis trauma untuk menilai rejimen farmakologis, hasil fungsional, dan efek jangka panjang pengobatan. Di sini, praktik psikiatri tidak diasumsikan sebagai berbasis bukti, tetapi menjadi sasaran evaluasi kritis mengingat pengetahuan biomedis yang muncul. Konsep-konsep seperti iatrogenesis, beban polifarmasi, dan substitusi gejala dianalisis dengan menggunakan dokumentasi kasus komparatif, kejenuhan teoretis, dan penilaian masuk akal secara fisiologis. Fokusnya tetap pada fungsi, otonomi, dan hasil kesehatan, dengan pengendalian gejala dianggap tidak cukup sebagai titik akhir klinis utama.

Tingkat ketiga, legal dan institusional, memeriksa parameter struktural yang memungkinkan atau menghambat praktik psikiatri yang bersifat koersif. Jaminan konstitusional Spanyol, yurisprudensi Eropa, dan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas diperlakukan sebagai alat operasional untuk evaluasi empiris, bukan sebagai cita-cita hukum yang abstrak (Deshpande et al, 2020). Metodologi yang digunakan mencakup analisis ganda yang menggabungkan interpretasi hukum doktrinal dengan pengamatan etnografis terhadap perilaku kelembagaan. Metodologi ini mendokumentasikan bagaimana kerangka hukum diterapkan, diabaikan, atau didistorsi dalam tata kelola kejiwaan. Sayangnya, penyiksaan yang sedang berlangsung menghalangi kesempatan untuk maju ke tingkat ini, peneliti hampir tidak dapat mulai menggaruk permukaan karena kekerasan yang dihadapi (Stover & Nightingale, 2000; Shaw, 2007; Russell, 2009).

Tingkat keempat, metodologis dan komputasi, sedang dalam pengembangan aktif tetapi sudah dimasukkan ke dalam langkah-langkah selanjutnya dari penelitian ini dan jalur translasi. Meskipun belum sepenuhnya diimplementasikan dalam disertasi ini karena alasan yang sama, alat-alat ini sedang dirancang dan sebagian diuji melalui kolaborasi yang sedang berlangsung. Rencana yang diberlakukan melalui tindakan, termasuk prototipe sistem pakar untuk dukungan keputusan dalam manajemen pengobatan, model Bayesian untuk analisis lintasan pengobatan, dan teknik analisis kelangsungan hidup untuk menilai risiko jangka panjang dalam kondisi paksaan (Ben-Ari, 2002). Komponen-komponen ini memungkinkan skalabilitas penelitian di masa depan dengan menerjemahkan temuan-temuan kualitatif ke dalam alat yang dapat dioperasikan, direplikasi, dan pada tingkat sistem. Integrasi pemetaan sistem, pemodelan inferensi kausal, dan simulasi dinamis memungkinkan identifikasi formal titik intervensi dan kuantifikasi kerugian di seluruh domain kelembagaan. Metode-metode ini merupakan dasar dari agenda transformasi struktural yang diartikulasikan dalam penelitian ini, yang menjangkarkan reformasi bukan pada kritik ideologis, melainkan pada sistem yang valid secara statistik, diatur secara etis, dan dapat ditindaklanjuti secara teknis. Meskipun tahap implementasi hukum, komputasi dan sistemik terus berlanjut di luar cakupan disertasi ini, arsitekturnya sepenuhnya selaras dengan alasan metodologis, mandat institusional, dan ketelitian ilmiah dari pekerjaan yang disajikan di sini. Penelitian lapangan juga sedang berlangsung untuk mempelajari kontinum kekerasan sosial dalam rumah tangga dan layanan kesehatan jiwa struktural di Indonesia, melalui upaya untuk menghapuskan pemasungan (Patel, Williams, & Kellezi, 2018).

2.2 Desain campuran dan multi-skala, triangulasi data dan temuan

Disertasi ini menggunakan metode campuran dan desain multi-skala untuk meneliti pemaksaan psikiatri, kekerasan medis, dan impunitas institusional sebagai fenomena sistemik yang beroperasi di ranah personal, organisasi, dan hukum. Penelitian ini tidak terbatas pada kasus-kasus individual atau disarikan ke dalam analisis kebijakan; namun, penelitian ini berusaha untuk membangun sebuah laporan berbasis bukti dan berlapis-lapis tentang bagaimana gangguan kejiwaan diproduksi, dinormalisasi, dan dilawan. Integrasi metode kualitatif dan kuantitatif, selaras dengan penyelidikan tingkat mikro, meso, dan makro, didorong oleh kompleksitas struktural dari pertanyaan penelitian dan orientasi biokultural dari keseluruhan penelitian (Farmer, Robinson, Elliott, & Eyles, 2006).

Metode kualitatif, termasuk penelitian lapangan etnografi, wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi reflektif yang terus menerus, sangat penting untuk menangkap pengalaman pemaksaan, degradasi, dan pembungkaman kejiwaan. Alat-alat ini memungkinkan dokumentasi pengkhianatan institusional, kerusakan relasional, dan strategi bertahan hidup baik dalam pengaturan klinis maupun ekstra-klinis. Catatan harian lapangan dan observasi melekat memungkinkan peneliti untuk melacak pola sistemik dan logika kelembagaan secara real time. Secara paralel, survei terbuka dengan format pertanyaan campuran menggabungkan pertanyaan naratif dengan pertanyaan kategoris, menghasilkan kumpulan data hibrida dari metrik deskriptif dan kesaksian kualitatif. Komponen kuantitatif ini diperlakukan bukan sebagai bukti yang berdiri sendiri, tetapi sebagai jangkar distribusi dan pemeriksaan silang untuk tema-tema yang muncul (Parker, 2007).

Triangulasi data dalam disertasi ini dicapai melalui integrasi dari empat sumber yang berbeda: respon survei memberikan pola dan frekuensi praktik sistemik yang dapat diukur di berbagai kelompok profesional dan pengguna; kesaksian memberikan kedalaman narasi dan laporan situasi tentang pengalaman hidup dalam sistem kejiwaan; dokumen hukum memungkinkan verifikasi prosedur institusional, menyoroti ketidaksesuaian antara kerangka kerja normatif dan praktik yang sebenarnya; dan pengalaman pribadi, yang didokumentasikan melalui observasi reflektif dan keterlibatan partisipatif, memberikan wawasan kritis terhadap mekanisme pemaksaan dan impunitas. Strategi multi-sumber ini memungkinkan validasi silang atas temuan-temuan, memperkuat koherensi internal, dan memastikan ketahanan empiris dan kepekaan kontekstual dalam interpretasi hasil penelitian (Carter, Bryant-Lukosius, DiCenso, Blythe, & Neville, 2014). Penggunaan kedua modalitas tersebut sangat penting untuk melakukan triangulasi data, mengevaluasi konsistensi epistemik, dan menyiapkan format yang dapat diukur untuk implementasi di masa depan. Masing-masing dari enam pertanyaan penelitian inti yang diartikulasikan dalam Bab 1 dioperasionalisasikan melalui teknik metodologis tertentu dan dialokasikan ke dalam skala analisis yang sesuai:

Tabel 18. Tabel 18. Penyelarasan pertanyaan penelitian dengan tingkat analisis, metode, dan relevansinya

Tujuan Disertasi	Pertanyaan Penelitian yang Diselaraskan	Tujuan Operasional	Tingkat Analisis	Metode	Relevansi dengan Disertasi
Mendukung sistem kejiwaan yang mampu melakukan koreksi secara real-time, akuntabilitas, dan menjaga integritas	Bentuk-bentuk kekerasan sistemik dan kegagalan institusional apa saja yang terjadi dalam tata kelola kejiwaan, dan bagaimana cara mengoreksinya?	Mengidentifikasi dan menganalisis kegagalan struktural, legal, dan epistemologis dalam perawatan psikiatri untuk mengembangkan reformasi berbasis bukti	Meso dan Makro	Analisis hukum, survei profesional, tinjauan dokumen kebijakan	Menahan investigasi kontradiksi antara kewajiban hukum dan praktik klinis rutin; mendukung kritik institusional dan kerangka kerja reformasi
Mendorong pergeseran	Bagaimana bukti klinis dan	Mengembangkan dan memvalidasi sistem	Mikro dan Meso	Pengkodean testimoni, pemetaan narasi	Membenarkan integrasi teori

Tujuan Disertasi	Pertanyaan Penelitian yang Diselaraskan	Tujuan Operasional	Tingkat Analisis	Metode	Relevansi dengan Disertasi
paradigma dari kontrol farmakologis ke model perawatan yang integratif, interdisipliner, dan timbal balik	pengalaman dapat diintegrasikan di seluruh domain biologis, psikologis, dan sosial kesehatan?	umpan balik, alat berbasis biosignal, dan mekanisme evaluasi yang dipimpin oleh pasien		berdasarkan trauma, tinjauan literatur medis	trauma dan model fisiologis; mendasari kritik biomedis dan etika terhadap lingkungan psikiatri
Menyelaraskan kembali psikiatri dengan koherensi empiris, perlindungan hukum, dan tata kelola partisipatif berbasis hak	Apa saja kondisi yang memungkinkan untuk perubahan institusional dan pengawasan partisipatif terhadap sistem kejiwaan? Apa saja mekanisme struktural dan epistemik yang membuat pengguna layanan kejiwaan dibungkam, didiskreditkan, atau dinetralisir sebagai orang yang tahu?	Menerapkan infrastruktur translasi, intervensi kebijakan, dan pengawasan partisipatif yang selaras dengan standar internasional	Mikro, Meso, Makro	Analisis survei, pemetaan kebijakan, pembuatan prototipe sistem pakar	Menginformasikan desain translasi intervensi, selaras dengan WHO QualityRights, dan mendukung transformasi sistem etika
Menegakkan keadilan naratif dan mencegah penghapusan epistemik dalam sistem kejiwaan	Bagaimana sistem hukum nasional (khususnya Spanyol) memungkinkan atau mencegah perawatan dan pemulihan psikiatri berbasis hak asasi manusia?	Membangun model analisis partisipatoris untuk mengangkat suara pengguna dan merekonstruksi legitimasi penjelasan	Mikro dan Meso	Etnografi, wawancara, pengkodean naratif, analisis wacana kelembagaan	Mendukung analisis ketidakadilan epistemik dan pengakuan metodologis atas pengetahuan yang dibungkam atau didiskualifikasi
Menanamkan hak asasi manusia dan perlindungan hukum dalam operasi kejiwaan	Struktur ilmiah dan metodologis seperti apa yang dibutuhkan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi dalam produksi pengetahuan kejiwaan?	Mengungkap kesenjangan nasional dan regional antara hukum dan praktik kejiwaan dan mendukung reformasi hukum yang dapat ditegakkan	Makro	Analisis hukum konstitusional dan internasional, etnografi kelembagaan	Inti dari kerangka kerja legal-demokratis dari tesis ini; memungkinkan evaluasi normatif terhadap tata kelola kejiwaan
Mengembangkan kerangka kerja ilmiah yang terbuka, refleksif, dan dapat diverifikasi		Membangun meta-metodologi biokultural, aliran data yang transparan, dan arsitektur sistem yang etis	Meso dan Makro	Dokumentasi meta-metodologi, desain pemodelan komputasi, protokol sains terbuka	Membenarkan kerangka kerja metodologis disertasi dan memungkinkan implementasi sistem ilmiah terbuka dan berlandaskan etika di masa depan

Korespondensi analitis antara enam pertanyaan penelitian inti dan tingkat, metode, dan relevansi sistemik yang ditetapkan dalam desain campuran dan multi-skala. Setiap pertanyaan dioperasionalisasikan sesuai dengan ruang lingkup analitis dan

persyaratan metodologisnya, memastikan keselarasan dengan dimensi epistemologis, hukum, klinis, dan translasi yang didefinisikan dalam Bab 1.

Pengungkapan pertanyaan-pertanyaan ini, seperti yang telah disebutkan, tidak dilakukan dalam kondisi akademis yang biasa. Seluruh proses penelitian berlangsung di bawah kondisi yang sangat sulit, termasuk pembungkaman institusional, pengucilan profesional, dan paparan kekerasan secara pribadi yang berkelanjutan yang memenuhi berbagai kriteria klinis dan hukum untuk penyiksaan psikologis. Kondisi-kondisi ini mengganggu akses terhadap siklus umpan balik institusional, membatasi kelangsungan penelitian lapangan, dan membatasi mekanisme produksi bersama yang ditentukan oleh penelitian aksi. Namun, alih-alih membatalkan penelitian ini, kenyataan-kenyataan ini memberikan konteks dasar untuk memahami urgensi, kendala, dan bobot etisnya. Oleh karena itu, tabel ini harus dibaca tidak hanya sebagai matriks perencanaan, tetapi juga sebagai peta perlawanan di bawah tekanan paksaan, yang berkomitmen pada transparansi ilmiah, martabat manusia, dan perbaikan struktural. Dalam setiap dan semua kasus, keselarasan antara pertanyaan, metode, dan tingkatan memastikan koherensi dan integritas ilmiah di seluruh proses penelitian. Tingkat mikro menangkap efek langsung dari kekerasan kejiwaan, kekerasan diagnostik, kekerasan, pembungkaman epistemik, melalui narasi pribadi, lintasan klinis, dan hasil penelitian secara fisik, para profesional lain, pasien secara luas, dan korban lain serta orang yang mereka cintai. Tingkat meso mengungkap bagaimana institusi seperti rumah sakit umum, pusat kesehatan, kantor ombudsman, layanan perlindungan anak, dan badan peradilan mengimplementasikan, membenarkan, atau menentang praktik-praktik pemaksaan jika memungkinkan. Tingkat makro mengontekstualisasikan pola-pola ini dalam kerangka kerja konstitusional, tata kelola kesehatan global, dan paradigma kejiwaan transnasional, termasuk peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan arahan Uni Eropa.

Dialektika induktif-deduktif mengatur proses analitik secara keseluruhan pada latar belakang. Data berbasis lapangan, narasi, observasi, kesaksian, menghasilkan kategori-kategori dan pola-pola interpretasi, yang kemudian diuji dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan secara deduktif: doktrin hukum, taksonomi diagnostik, dan standar kesehatan internasional (Adorno & Horkheimer, 1944/2002). Ketika disonansi muncul, revisi atau kalibrasi ulang teori dilakukan. Hal ini memungkinkan penelitian ini untuk bergerak melampaui konfirmasi atau falsifikasi, dan sebagai gantinya beroperasi sebagai penyelidikan abduktif yang dinamis ke dalam kondisi kebenaran tingkat sistem dan kelangsungan metodologis. Pengalaman langsung dari penyiksaan dipaksa untuk memahami secara refleks realitas yang paling keras dalam kesehatan mental dan masyarakat kita. Singkatnya, desain campuran dan multi-skala dari disertasi ini tidak hanya mendukung penelitian ini, tetapi juga merupakan bentuk etis, ilmiah, dan strukturalnya. Hal ini memungkinkan penelitian ini untuk memenuhi keharusan dasarnya: untuk menghasilkan pengetahuan yang mampu mengidentifikasi, menentang, dan memperbaiki kondisi-kondisi di mana perawatan kejiwaan menjadi vektor bahaya institusional daripada menjadi tempat penyembuhan.

Arsitektur penelitian ini sengaja dikonfigurasi untuk memastikan koherensi internal antara metode, tingkat analisis, dan tujuan epistemik disertasi. Pembeneran untuk menggabungkan etnografi, observasi partisipan, dan penyelidikan testimonial dengan survei terstruktur dan

kategorisasi kuantitatif terletak pada kebutuhan ganda untuk menghormati kompleksitas pengalaman hidup sambil memungkinkan pemetaan sistematis praktik-praktik institusional dan kegagalan struktural. Setiap metode dipilih berdasarkan kapasitas fungsionalnya untuk menginterogasi lapisan-lapisan tertentu dari aparatus kejiwaan, mulai dari tekanan subjektif sampai pada pembolean secara hukum makro. Pembagian ke dalam tingkat mikro, meso, dan makro yang dipaparkan di sini tidak hanya mencerminkan kenyamanan analitis tetapi juga realitas ontologis dari kekerasan psikiatri sebagai sebuah sistem yang terdistribusi dan bertingkat. Dialektika induktif-deduktif yang mengatur analisis ini memastikan bahwa temuan-temuan yang muncul melalui iterasi rekursif: didasarkan pada laporan-laporan yang ada, ditantang oleh kerangka kerja normatif, dan divalidasi melalui triangulasi teoretis dan hukum. Dengan membuat eksplisit keselarasan antara pertanyaan, metode, dan skala, penelitian ini menjamin ketelitian metodologisnya dan memperkuat fungsi intinya, bukan untuk menggambarkan penderitaan secara terpisah, tetapi untuk menghubungkannya secara ilmiah, legal, dan etis dengan struktur yang memproduksi dan menormalkannya. Batas-batas otonomi, pilihan-pilihan yang dibuang atau ditawarkan, semuanya ditentukan secara sosiokultural juga.

2.3 Instrumen dan infrastruktur pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan tiga instrumen survei inti, yang masing-masing dirancang untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan situasi, peka terhadap etika, dan relevan secara struktural dalam lanskap kejiwaan di Spanyol. Survei-survei tersebut dibuat untuk mendokumentasikan realitas kehidupan pengguna kesehatan jiwa, kerabat, dan profesional, sekaligus berfungsi sebagai alat penelitian aksi yang mampu mendorong refleksi, kritik, dan keterlibatan partisipatif. Ketiga instrumen tersebut disesuaikan dengan konteks Spanyol, dengan mengintegrasikan kerangka kerja konseptual dari antropologi medis, analisis hukum, dan etika klinis. Masing-masing memberikan wawasan yang saling melengkapi mengenai praktik psikiatri, hierarki epistemik, dan perilaku institusional.

Instrumen pertama, *Skizofrenia: Sebuah Studi tentang Label Psikiatri*, merupakan versi adaptasi dari survei tervalidasi yang sebelumnya digunakan di Inggris. Instrumen asli, yang ditinjau dan disempurnakan melalui umpan balik dari para ahli interdisipliner, dimodifikasi untuk mencerminkan kekhususan budaya, hukum, dan kelembagaan di Spanyol. Tujuannya adalah untuk memeriksa bagaimana label psikiatri, khususnya skizofrenia dan psikosis, dialami, ditafsirkan, dan diperdebatkan oleh pengguna, keluarga, dan profesional. Instrumen penelitian ini mencakup pertanyaan terstruktur yang disertai dengan pertanyaan naratif, yang memungkinkan responden untuk mengartikulasikan respons kategoris dan pengalaman mereka. Total sekitar empat ratus tanggapan lengkap terkumpul, mewakili berbagai peran dalam ekosistem kesehatan mental. Metodologi ini memungkinkan untuk mengkuantifikasi tren dan pemulihan kesaksian kualitatif mengenai stigma diagnostik, bahaya iatrogenik, dan diskualifikasi epistemik. Survei ini menjadi dasar bagi kritik sistemik terhadap praktik pelabelan dan berperan penting dalam mengungkap konsekuensi psikososial dan institusional jangka panjangnya.

Survei kedua, *dialog terbuka di Spanyol*, dikembangkan secara khusus untuk penelitian ini melalui kolaborasi dengan para dokter, pendidik, dan peneliti yang terlibat dalam promosi praktik dialogis

dalam kesehatan mental. Survei ini merupakan upaya berskala nasional pertama untuk menilai tingkat pengetahuan, ketersediaan pelatihan, dan keterlibatan institusional dengan kerangka kerja dialog terbuka di kalangan profesional kesehatan jiwa di Spanyol. Instrumen ini disebarluaskan melalui jaringan profesional nasional, seminar pendidikan, dan kolaborasi klinis. Meskipun strukturnya bersifat kuantitatif, survei ini juga menangkap komentar terbuka yang mencerminkan ketegangan etis, resistensi institusional, dan minat yang muncul dalam model perawatan alternatif. Sebagai bagian dari publikasi peer-review, data yang diperoleh dari instrumen ini telah melalui tinjauan ilmiah yang ketat dan sekarang menjadi kontribusi terdokumentasi untuk literatur nasional tentang psikiatri dialogis. Fungsinya dalam tesis ini memiliki dua fungsi: memetakan kondisi saat ini dari kepentingan yang berorientasi pada reformasi di dalam sistem dan memberikan bukti empiris bahwa reformasi diperlukan dan sudah berjalan.

Survei ketiga, *Pengambilan Keputusan Bersama dan Manajemen Pengobatan*, dirancang untuk membahas praktik pemberian resep psikiatri, persetujuan, otonomi, dan tantangan pemberian resep yang bertanggung jawab. Cakupannya mencakup berbagai konteks psikiatri dan kelompok sasaran, mulai dari perawatan akut hingga skenario pengobatan jangka panjang. Survei ini mengundang perspektif dari pengguna layanan, pengasuh, dan profesional kesehatan mental, dan aktif selama 105 hari. Survei ini menerima 90 tanggapan lengkap, masing-masing dengan durasi rata-rata lebih dari 40 menit, yang merupakan indikator kompleksitas dan komitmen responden. Survei ini menggunakan arsitektur campuran dari item berskala dan pertanyaan terbuka, yang memungkinkan triangulasi perspektif klinis, etika, dan pengalaman. Desainnya berulang dan berkembang sebagai respons terhadap uji coba, umpan balik responden, dan penyelarasan dengan kerangka kerja internasional seperti QualityRights dari WHO. Instrumen ini menawarkan wawasan terperinci tentang kegagalan operasional dan moral dari rezim peresepan saat ini dan menguraikan alternatif profesional dan pengalaman yang didasarkan pada perawatan berbasis jaringan yang berpusat pada orang.

Masing-masing dari ketiga survei tersebut diintegrasikan dalam matriks yang lebih luas dari alat metodologi, termasuk catatan lapangan etnografi, dokumen hukum, kesaksian klinis, dan analisis wacana kelembagaan. Meskipun setiap survei membahas fokus tematik yang berbeda - validitas diagnostik dan bahaya iatrogenik, praktik dialogis, dan tata kelola pengobatan - namun dalam praktiknya, ketiga survei tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri. Konstruksi survei-survei tersebut dikoordinasikan untuk memungkinkan triangulasi analitis: konstruksi kunci, misalnya, otonomi, paksaan, kepercayaan, trauma, tanggung jawab bersama; dicerminkan di seluruh instrumen dengan menggunakan bahasa yang berbeda tetapi dapat dioperasikan. Desain ini memungkinkan perbandingan silang antara pola epistemik, ekspektasi kebijakan, dan norma-norma profesional. Dengan demikian, alat survei ini memungkinkan pemetaan gabungan dari praktik psikiatri secara simultan dari segi hukum, klinis, sosial, dan relasional.

Tabel 19. Proses validasi dan perlindungan etika untuk tiga survei disertasi

Judul Survei	Proses Validasi	Adaptasi Budaya	Tindakan Etis dan Strategi Persetujuan
<i>Skizofrenia: Sebuah Studi tentang Label Psikiatri</i>	Awalnya dikembangkan dan divalidasi di Inggris di bawah kepemimpinan Dr. Diadaptasi dan divalidasi ulang untuk konteks Spanyol dengan kolaborasi ahli dari para peneliti penyintas dan profesional dari LoComún. Instrumen asli berkontribusi pada diskusi internal di ISPS International yang mengarah pada penggantian nama organisasi dan pengabaian istilah skizofrenia.	Adaptasi dalam bahasa Spanyol ditinjau untuk kejelasan linguistik, relevansi budaya, dan praktik diagnostik lokal.	Partisipasi anonim, persetujuan informasi yang dinamis yang tertanam pada saat inisiasi survei, dengan konsultasi penasihat etika.
<i>dialog terbuka di Spanyol: Ketersediaan, Pelatihan, dan Penerimaan</i>	Divalidasi oleh tim praktisi dialog terbuka Spanyol dan peneliti akademis, termasuk pelatih klinis dan ahli implementasi.	Bahasa dan pembedaan disesuaikan untuk menyelaraskan dengan terminologi sistem kesehatan Spanyol, sejarah implementasi, dan budaya institusi.	Persetujuan yang diperoleh melalui pengenalan survei yang disematkan; anonimitas dijamin melalui alat pengumpulan yang dienkripsi.
<i>Pengambilan Keputusan Bersama dan Penggunaan Obat dalam Psikiatri</i>	Diujicobakan dan divalidasi oleh lebih dari 100 profesional dan pakar internasional. Kontribusi khusus diakui dari Peter Lehmann, pakar terkemuka Jerman dalam hal depreskripsi yang bertanggung jawab dan hak-hak penyintas kejiwaan.	Pertanyaan-pertanyaan yang disempurnakan melalui konsultasi ahli yang berulang-ulang untuk memastikan terjemahan dan relevansi di seluruh konteks klinis Spanyol dan perspektif pengguna.	Persetujuan yang dirancang dengan opsi pembaruan dinamis, protokol anonimisasi menggunakan penyimpanan terenkripsi dan catatan waktu.

Tabel yang merangkum proses validasi, adaptasi budaya, dan protokol etika yang diterapkan pada tiga instrumen survei utama disertasi. Pendekatan ini menekankan ketelitian ilmiah, keadilan epistemik, dan praktik penelitian yang etis dalam konteks yang ditandai oleh asimetri historis dan struktural.

Penyebaran instrumen-instrumen ini terjadi di bawah kondisi kerentanan institusional dan infrastruktur yang mendalam. Sistem yang dihasilkan harus memastikan anonimisasi yang sesuai dengan GDPR, pencatatan stempel waktu, dan akses terenkripsi, menyoroti tingkat otonomi operasional yang diperlukan untuk penelitian di wilayah yang sensitif secara etis tetapi tidak didukung secara struktural, dan karena itu mereka melakukannya, sebagian besar hanya menggunakan perangkat sumber terbuka atau yang tersedia secara institusional untuk mengumpulkan tanggapan secara anonim. Survei pertama, yang diadaptasi dari materi di Inggris, menjadi percontohan untuk prinsip partisipatif dan arsitektur pertanyaan campuran yang kemudian diadopsi di seluruh instrumen. Survei dialog terbuka kemudian diikuti, dengan penekanan pada penjangkauan nasional dan keterlibatan kebijakan, yang berujung pada publikasi yang diulas oleh rekan sejawat. Instrumen terakhir dan yang paling rumit, tentang pengambilan keputusan bersama, mengkonsolidasikan pelajaran dari instrumen-instrumen sebelumnya dan menggabungkan ketentuan etika yang cangguh, kekuatan konseptual, dan keselarasan dengan WHO QualityRights dan kerangka kerja depreskripsi internasional. Penyempurnaan setiap instrumen menjadi masukan bagi instrumen berikutnya, membentuk busur metodologis kumulatif yang mendukung struktur penelitian tindakan yang lebih luas dari disertasi (Lehmann, 1998a; Lehmann, 2010).

Semua instrumen disusun dan divalidasi sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian aksi. Draf awal ditinjau oleh panel ahli yang terdiri dari dokter, antropolog, ahli hukum, dan penyintas kejiwaan. Uji coba dengan kelompok responden target memungkinkan penyempurnaan kejelasan item, kesesuaian budaya, dan cakupan konseptual. Survei ini dapat diakses melalui platform digital, dan hambatan teknis yang ada dapat diatasi dengan adaptasi infrastruktur untuk menjaga integritas dan aksesibilitas data (Ladkin, 2007). Setiap instrumen menggunakan prosedur persetujuan berdasarkan prinsip-prinsip persetujuan yang dinamis. Responden diberikan pengungkapan penuh mengenai tujuan, ruang lingkup, langkah-langkah perlindungan data, dan pilihan untuk mengundurkan diri. Tidak ada identitas pribadi yang dikumpulkan, dan semua tanggapan dianonimkan pada saat pengisian. Mengingat status peneliti sebagai orang dalam dan penyintas, pengawasan etis mencakup protokol reflektif yang terperinci dan tinjauan independen oleh akademisi senior. Integrasi di antara ketiga instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik tematik, naratif, dan komparatif (Lassiter, 2005). Meskipun masing-masing survei membahas isu yang berbeda, pelabelan, praktik dialogis, dan tata kelola pengobatan, ketiga instrumen tersebut juga berfungsi sebagai alat diagnostik yang saling terkait dalam arsitektur penelitian yang lebih luas. Materi kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan melalui pertanyaan terbuka, melengkapi data etnografi dan digunakan untuk memperkuat temuan yang muncul dari observasi partisipan, analisis hukum, saksi mata, dan penelitian berbasis kesaksian.

Tiga survei yang tergabung dalam disertasi ini disusun dan divalidasi melalui proses yang ketat yang menggabungkan keahlian klinis, ilmiah, dan pengalaman langsung: survei pertama, penyelidikan terhadap Label 'Skizofrenia' (ISL), pada awalnya dikembangkan di Inggris di bawah kepemimpinan Dr. Ini adalah bagian dari penyelidikan yang lebih luas tentang konsekuensi epistemik, sosial, dan klinis dari pelabelan psikiatri dan berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan nama ISPS, International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis, yang secara resmi menghapus istilah skizofrenia dari judulnya sebagai pengakuan atas warisan yang bermasalah dan menstigmatisasi. Adaptasi bahasa Spanyol yang digunakan dalam tesis ini ditinjau dan divalidasi ulang oleh para ahli lokal, yang kontribusinya memastikan relevansi kontekstual, kejelasan terminologis, dan keselarasan epistemologis dengan realitas klinis, hukum, dan sosial di Spanyol. Proses validasi ini mencakup penyesuaian linguistik dan kalibrasi konten untuk mencegah penguatan kekerasan diagnostik atau distorsi budaya yang tidak disengaja.

Menggali lebih dalam survei besar pertama yang menjadi dasar disertasi ini, penyelidikan yang awalnya dikoordinasikan di Inggris oleh tim penyintas, profesional, dan cendekiawan kritis termasuk Profesor Suman Fernando, Dr. Janet Wallcraft, kami menemukan sebuah inisiatif yang belum pernah ada sebelumnya untuk mendokumentasikan secara sistematis konsekuensi pribadi, institusional, dan sosial dari menerima diagnosis dugaan skizofrenia, dengan tujuan untuk mengekspos dampak yang merusak dan mempertanyakan keabsahan penggunaannya dalam sistem kesehatan mental modern (Kalathil & Fernando, 2012). ISL dibangun melalui penelitian berbasis kesaksian, dengan mengundang pengajuan dari mereka yang memiliki pengalaman langsung dengan label tersebut, keluarga mereka, dan para profesional di seluruh Inggris. Laporan ini disebarluaskan secara luas dan tetap menjadi tengara dalam produksi pengetahuan yang dipimpin oleh pengguna/penyintas, yang menggabungkan wawasan epistemologis yang mendalam dengan urgensi politik. Laporan ini memiliki dampak transformatif pada wacana publik dan akademis, membantu mengendapkan

keputusan International Society for the Psychological and Social Approaches to Psychosis (ISPS) untuk menghapus dugaan skizofrenia dari namanya. Hal ini juga membantu mengkonsolidasikan pergeseran paradigma menuju alternatif psikiatri diagnostik yang berbasis trauma, berbasis hak asasi manusia, dan peka terhadap budaya.

Tabel 20. Kelompok koordinator penyelidikan terhadap label skizofrenia yang asli, Inggris, 2014

Nama	Peran dan Biografi Singkat
Profesor Suman Fernando	Psikiater dan pemikir kritis dalam bidang psikiatri transkultural. Bekerja di Enfield selama lebih dari 20 tahun; kemudian menjadi Profesor Kehormatan di London Metropolitan University. Menjadi anggota Komisi Undang-Undang Kesehatan Mental (1988-1995). Menulis beberapa teks utama tentang ras, budaya, dan kesehatan mental, termasuk <i>Mental Health Worldwide</i> (2014). Baru-baru ini meninggal dunia pada tahun 2023, meninggalkan warisan yang mendalam.
Dr. Jayasree Kalathil	Peneliti penyintas, penulis, dan pendiri kolektif Survivor Research. Dengan pengalaman pribadi dalam layanan psikiatri di India dan Inggris, ia telah menerbitkan banyak tulisan tentang kesehatan mental, rasialisasi, dan pengalaman hidup. Salah satu penulis <i>Nilai dan Etika dalam Kesehatan Mental</i> , dan editor <i>The Sackcloth Man</i> , sebuah buku anak-anak. Suara terdepan dalam Studi Gila.
Dr. Philip Thomas	Mantan konsultan psikiater dan salah satu pendiri Jaringan Psikiatri Kritis Inggris. Setelah pensiun dari praktik klinis, ia terus menulis tentang budaya, kekuasaan, dan kegilaan. Mantan ketua Sharing Voices Bradford. Karyanya menekankan pada konteks sosial dan historis dari gangguan jiwa, mengadvokasi alternatif dari psikiatri biomedis. Saat ini sedang menulis buku tentang psikiatri kritis.
Dr. Janet Wallcraft	Pengguna layanan kesehatan mental, peneliti, dan aktivis. Memiliki gelar PhD dalam narasi rawat inap psikiatri. Pengajar di Universitas Birmingham dan Hertfordshire. Menulis <i>On Our Own Terms</i> dan <i>Healing Minds</i> . Karyanya berfokus pada manajemen diri, terapi komplementer, dan keterlibatan pengguna dalam penelitian. Membawa perspektif pengalaman dan akademis yang kaya untuk reformasi kesehatan mental.

Versi bahasa Spanyol dari Inkuiri ini diluncurkan dan diadaptasi secara mandiri oleh peneliti saat ini selama tahap awal studi pascasarjana, sebelum dimulainya pekerjaan doktoral ini secara resmi, dengan masukan dari anggota kolektif Spanyol LoComún (Fernández, 2018). Kami memperluas jumlah pertanyaan, menyesuaikannya dengan realitas Spanyol. Namun, secara metodologis konsisten dan secara etis selaras dengan upaya awal, dan menjadi komponen utama dari basis pembuktian disertasi ini. Survei ini didistribusikan secara online dan melalui pos, mengikuti prinsip-prinsip ilmu pengetahuan terbuka dan implementasi teknis yang bersifat open-source. Ribuan orang di seluruh Spanyol -termasuk para profesional, penyintas, pengguna, dan anggota keluarga- dijangkau melalui upaya distribusi yang komprehensif ke hampir semua pusat kesehatan mental publik, asosiasi pendukung, beberapa kontak langsung, dan jaringan aktivis yang paling dikenal. Adaptasi ini mempertahankan kekayaan testimoni dan keterbukaan kritis dari Inkuiri yang asli, dengan item-item yang berfokus pada makna diagnosis, dampak yang dirasakan, pengalaman pemaksaan, dan alternatif yang dirasakan terhadap sistem yang ada saat ini. Survei ini mengedepankan suara mereka yang terpinggirkan dan dikriminalisasi oleh praktik diagnostik, dan dengan demikian berkontribusi

langsung pada tujuan utama penelitian ini: mengungkap kekerasan sistemik, menentang dominasi epistemologis psikiatri biomedis, dan memajukan model pengambilan keputusan bersama serta otonomi pasien yang berakar pada etika, martabat, dan keadilan.

Survei kedua, yang berfokus pada *dialog terbuka di Spanyol*, divalidasi oleh tim nasional yang terdiri dari para praktisi dan peneliti yang secara aktif terlibat dalam pelaksanaan, penyebaran, dan pelatihan dialog terbuka. Pengembangannya mengikuti model konsultatif yang didasarkan pada keahlian para dokter yang terlibat dalam praktik dialogis, terutama mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan nasional dan program pendidikan pascasarjana yang difasilitasi oleh peneliti. Mengingat beragamnya jalur kelembagaan yang melaluinya dialog terbuka telah diperkenalkan di Spanyol, survei ini ditinjau dengan cermat untuk mencerminkan heterogenitas pengalaman implementasi dan perbedaan peraturan regional (Valtanen, 2019). Dalam konteks Spanyol, di mana diagnosis berlebihan, pengobatan berlebihan, dan pelembagaan sistemik masih meluas, model dialog terbuka telah muncul sebagai alternatif terapeutik dan sosial-politik. Model ini menyediakan kerangka kerja yang berlandaskan budaya dan layak secara klinis untuk melawan pemaksaan dan menumbuhkan tanggung jawab kolektif. Pilihan terminologi, pertanyaan tentang akses pelatihan, dan hambatan institusional disempurnakan untuk meningkatkan resonansi dengan konteks profesional dan administratif Spanyol (Parrabera-García et al, 2023).

Sebelum meluncurkan survei ini, tim secara aktif berpartisipasi dalam upaya sensus nasional yang dipimpin oleh HopenDialogue³, sebuah proyek Eropa yang mempromosikan praktik dialogis di seluruh sistem kesehatan. Sensus ini bertujuan untuk mendokumentasikan semua profesional, layanan, dan inisiatif informal yang terkait dengan dialog terbuka di Spanyol (Pocobello et al, 2025). Sebagai bagian dari proses tersebut, peneliti menyumbangkan daftar kontak yang komprehensif yang dikumpulkan selama bertahun-tahun -terdiri dari ratusan dokter, pendidik, peneliti, dan aktivis yang telah menyatakan ketertarikannya pada perawatan dialogis. Melalui pemetaan partisipatif ini, tim menjangkau hampir semua profesional di negara ini yang telah dilatih atau mendukung pendekatan dialog terbuka. Sensus ini membentuk sebuah data dasar, mendokumentasikan komunitas profesional yang terlatih secara dialogis yang tersebar dan terus berkembang serta penempatan mereka dalam layanan publik dan swasta. Berdasarkan hasil kerja dasar ini, Survei Profesional Dialog Terbuka dikonseptualisasikan sebagai upaya empiris tahap kedua. Tujuannya bukan hanya untuk menilai pengetahuan atau kepatuhan, tetapi untuk mengeksplorasi ketegangan yang terjadi, hambatan etis, dan potensi laten perawatan dialogis dalam lanskap kelembagaan Spanyol yang sering kali kaku. Ia bertanya: Apa yang terjadi setelah pelatihan berakhir? Bagaimana para profesional menghadapi tekanan moral, kontradiksi institusional, dan ekspektasi pasien dalam praktik sehari-hari? Survei yang dirancang dan didistribusikan pada tahun 2023 ini disusun berdasarkan enam sumbu tematik: (1) paparan terhadap praktik koersif dalam institusi; (2) kesetiaan terhadap prinsip-prinsip dialogis dalam praktik; (3) ketegangan etis dan resistensi institusional; (4) pengalaman dalam pengambilan keputusan bersama; (5) persepsi terhadap suara dan otonomi pasien; dan (6) hambatan sistemik dan

³HOPENDialogue adalah sebuah studi kolaboratif internasional untuk mengevaluasi efektivitas Dialog Terbuka dalam berbagai konteks dan mendukung pusat-pusat penelitian yang menggunakan pendekatan ini.
<https://www.hopendialogue.net/>

hukum terhadap transformasi. Sebanyak 35 pertanyaan -termasuk beberapa pertanyaan terbuka - dimasukkan, yang memungkinkan untuk mendapatkan wawasan kualitatif dan kuantitatif.

Survei ketiga, *Pengambilan Keputusan Bersama dan Penggunaan Obat dalam Psikiatri*, merupakan hasil dari proses konsultasi internasional yang paling ekstensif. Lebih dari seratus ahli, termasuk psikiater senior, ilmuwan sosial, pembuat kebijakan, dan penyintas pengguna, memberikan umpan balik. Khususnya, Peter Lehmann (2010), advokat yang diakui secara internasional untuk penghentian obat psikiatri dan tata kelola pengobatan yang etis, memberikan umpan balik yang ditargetkan yang mengarah pada penguatan bagian tentang pemberian obat yang bertanggung jawab, otonomi, dan praktik yang berbasis trauma. Survei ini menggabungkan praktik-praktik terbaik dari penelitian pemberian resep global dan disesuaikan untuk mengakomodasi ketegangan tertentu dalam sistem Spanyol, termasuk resistensi terhadap perawatan non-farmakologis dan kurangnya pedoman nasional tentang pengambilan keputusan bersama. Didistribusikan selama debat nasional pemerintah yang sedang berlangsung tentang penggunaan obat-obatan psikiatri yang bertanggung jawab, survei ini menyajikan, di antara pertanyaan-pertanyaan lain, skenario berikut yang membawa perhatian pada beberapa titik kegagalan dan sumber-sumber kontroversi dalam sistem saat ini:

Tabel 21. Skenario reformasi hipotetis dalam survei 2025, tujuan metodologis

Skenario	Deskripsi	Tujuan dalam Metodologi Survei
1. Menerapkan skrining nasional untuk sensitivitas gluten dalam diagnosis kejiwaan	Menyajikan intervensi berbasis bukti yang membutuhkan pertimbangan ulang diagnosis diet ke dalam pengambilan keputusan psikiatri dengan mempertimbangkan faktor diet.	Mengevaluasi kesiapan para profesional untuk mengintegrasikan skrining somatik dan alternatif dalam pengambilan keputusan psikiatri, dan untuk menilai kelayakan yang dirasakan dari jalur pengobatan non-farmakologis.
2. Meresepkan neuroleptik pada kasus-kasus gangguan metabolisme dan nutrisi yang terlewatkan	Menyoroti konsekuensi dari pembayangan diagnostik dan kurangnya skrining interdisipliner dalam psikiatri.	Untuk mengeksplorasi sikap profesional terhadap koordinasi medis dalam pemberian resep, dan kesiapan struktural untuk evaluasi ulang diagnostik berdasarkan penilaian fisiologis.
3. Menangani kasus-kasus pelecehan psikiatri yang ditemukan melalui penelitian nasional tentang kesehatan mental dan kekerasan	Mengungkap pengabaian trauma secara sistemik dan bahaya iatrogenik yang disebabkan oleh pelabelan psikiatri yang tidak tepat.	Menilai kesadaran akan kekerasan institusional dan dimensi etis dari pengambilan keputusan bersama dalam konteks pelecehan historis, termasuk pandangan tentang reformasi dan reparasi berbasis trauma.
4. Inisiatif depreskripsi nasional untuk pasien lansia yang berisiko tinggi mengalami kematian dan disabilitas	Berfokus pada risiko penggunaan neuroleptik di antara populasi lansia dan keharusan pemberian depresan yang didukung oleh WHO.	Untuk mendapatkan wawasan klinis mengenai protokol persepan khusus usia, masalah keamanan, dan tanggung jawab profesional dalam konteks kerentanan dan mitigasi risiko.
5. Mengevaluasi kembali diagnosis psikiatri jangka panjang dalam audit nasional	Mempertanyakan validitas pelabelan psikiatri jangka panjang dan kelambanan pengobatan farmakologis kronis.	Menelaah pandangan responden mengenai diagnosis ulang, koreksi kesalahan historis, dan etika ketergantungan pengobatan jangka panjang berdasarkan asumsi klinis yang sudah ketinggalan zaman.
6. Mengatasi resep neuroleptik yang berlebihan di layanan sosial dan komunitas yang terpinggirkan	Menyoroti ketidaksetaraan struktural dalam praktik pengobatan untuk populasi yang dikecualikan secara sosial.	Mengukur kepekaan profesional terhadap diskriminasi sistemik dalam pola persepan dan kapasitas layanan untuk beralih ke alternatif yang lebih adil dan berbasis komunitas.
7. Tinjauan nasional tentang penggunaan neuroleptik pada anak-anak dan remaja	Mengatasi risiko perkembangan dan etika dalam penggunaan neuroleptik pada anak, yang sering kali tidak disertai dengan pendidikan, keluarga, dan sistemik yang diagnosis banding yang memadai.	Mendokumentasikan sikap profesional tentang pemberian resep pada populasi anak, rasio risiko-manfaat yang dirasakan, serta dukungan pendidikan, keluarga, dan sistemik yang diperlukan untuk transisi yang lebih aman.
8. Mengakhiri penggunaan neuroleptik untuk indikasi non-psikiatri dalam pengobatan umum	Menantang penggunaan neuroleptik yang rutin namun secara klinis tidak tepat dalam konteks perawatan umum di rumah sakit dan perawatan pengaturan non-psikiatri somatik.	Untuk menilai komunikasi antar-spesialisasi, kesadaran akan pedoman, dan mekanisme untuk koreksi kesalahan dan pemberian obat dalam perawatan pengaturan non-psikiatri.

Tabel ini menguraikan delapan skenario hipotetis yang disertakan dalam survei nasional untuk mengeksplorasi tanggapan para profesional terhadap usulan reformasi yang signifikan secara etis, medis, dan institusional. Setiap

skenario dirancang untuk mendapatkan reaksi terhadap kekurangan sistemik, mulai dari praktik diagnostik dan koordinasi interdisipliner hingga kekerasan institusional dan pemberian obat yang berlebihan, dan untuk menilai kesiapan untuk perubahan, posisi etis, dan kesadaran struktural. Skenario-skenario ini berfungsi sebagai alat metodologis untuk memeriksa tidak hanya sikap individu tetapi juga kelayakan yang dirasakan dalam menerapkan reformasi berbasis hak dan berdasarkan bukti dalam praktik kedokteran jiwa dan kedokteran umum.

Di ketiga instrumen tersebut, perlindungan etika menjadi prioritas. Informed consent diterapkan secara dinamis, dengan informasi rinci tentang tujuan, penggunaan data, dan protokol kerahasiaan yang disediakan di awal. Responden dapat keluar kapan saja, dan anonimitas dijamin menggunakan platform pengumpulan data yang terenkripsi. Tinjauan etika mengikuti strategi berlapis yang melibatkan penasihat informal dari kolaborator internasional dan kolektif penelitian berbasis hak asasi manusia, yang mengkompensasi ketiadaan dukungan kelembagaan yang konsisten selama periode penelitian. Langkah-langkah validasi dan etika ini memastikan bahwa survei tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga merupakan instrumen penelitian aksi yang secara metodologis baik, selaras dengan konteks, dan berlandaskan etika. Survei-survei ini tidak hanya memberikan kedalaman empiris tetapi juga legitimasi partisipatoris terhadap klaim utama tesis ini: bahwa psikiatri di Spanyol harus bertransisi dari struktur yang bersifat koersif dan tidak transparan menuju sistem perawatan yang kolaboratif, transparan, dan berbasis hak. Melalui instrumen-instrumen ini, penelitian ini membentuk arsip yang terdiri dari banyak suara tentang kritik institusional dan proposal konstruktif, yang didasarkan pada metodologi yang kuat secara ilmiah, kuat secara etis, dan disesuaikan dengan budaya.

Dari tiga survei yang dilakukan selama penelitian, jangkauan gabungan mencapai beberapa ribu orang, menghasilkan total sekitar tujuh ribu tanggapan; 400, 200, dan 90 tanggapan. Hal ini mencakup penyebaran nasional yang luas di Spanyol dan keterlibatan yang ditargetkan dengan para profesional, pengguna, dan advokat di seluruh jaringan yang relevan. Survei terakhir saja, yang berfokus pada pengambilan keputusan bersama, pengobatan psikiatri, dan pemberian obat, dijawab secara lengkap oleh sembilan puluh profesional dan ahli, banyak di antaranya memberikan tanggapan naratif yang luas. Berdasarkan durasi respons rata-rata, lebih dari 41 menit, akumulasi waktu yang didedikasikan untuk menjawab instrumen ini melebihi seratus jam masukan dari para ahli yang masuk. Hal ini merupakan gudang pengetahuan yang luar biasa dari pengetahuan yang membumi, kontekstual, dan spesifik untuk profesi, yang nyaris tidak tersentuh dalam disertasi ini, karena kekayaannya sangat besar dan melampaui topik tesis. Sebagian besar undangan dalam survei terakhir ini adalah anggota *Asociación Española de Neuropsiquiatría* (AEN)⁴, yang secara luas dikenal sebagai asosiasi profesional utama untuk psikiatri kritis dan komunitas di Spanyol, anggota CIBER, jaringan nasional kesehatan jiwa yang unggul, dan para ahli psikiatri yang diterbitkan di Spanyol. Sebagian besar dari mereka adalah penulis makalah ilmiah yang telah ditelaah oleh rekan sejawat dan buku-buku berpengaruh mengenai praktik psikiatri, etika, dan reformasi sistemik. Kontribusi mereka menangkap dilema dan hambatan saat ini dalam sistem psikiatri Spanyol, serta artikulasi praktik terbaik dan proposal untuk perubahan struktural. Oleh karena itu, survei-survei ini lebih dari sekadar alat

⁴AEN adalah sebuah masyarakat ilmiah dan profesional di Spanyol yang mempromosikan perawatan kesehatan mental berbasis etika, publik, dan komunitas, pelatihan profesional, dan penelitian di bidang kesehatan mental.
<https://aen.es/la-aen/>

pengumpul data: survei-survei ini merupakan instrumen partisipatoris untuk memproduksi pengetahuan yang menghasilkan arsip multidisiplin dengan kepadatan tinggi tentang wawasan etis, klinis, dan sistemik yang sangat diperlukan untuk tujuan translasi disertasi ini.

Selain itu, survei eksplorasi keempat yang bersifat informal dikirim melalui email ke semua organisasi keagamaan non-Kristen yang terdaftar secara resmi di Spanyol, yang bertujuan untuk mengumpulkan data indikatif mengenai tantangan kesehatan mental mereka, marginalisasi struktural, dan akses terhadap praktik-praktik spiritual dalam konteks yang sebagian besar dibentuk oleh norma-norma Kristen dan lembaga-lembaga publik sekuler. Tanggapan-tanggapan tersebut-meskipun jumlahnya terbatas dan tidak merata di berbagai tradisi-memberikan wawasan yang berharga tentang pengalaman hidup minoritas agama, termasuk sejumlah kecil umat Buddha, Hindu, dan komunitas internasional non-arus utama lainnya. Tujuannya adalah untuk mengukur bagaimana perasaan dan kondisi kaum minoritas di negara tersebut. Sebagian besar organisasi melaporkan adanya kendala yang signifikan dalam mengakses ruang khusus untuk berdoa, meditasi, atau retret, yang sering kali menghadapi hambatan birokrasi, penolakan dari masyarakat sekitar, atau pengabaian dalam perencanaan kota. Keterbatasan ini digambarkan secara langsung mempengaruhi kesejahteraan psikologis, kohesi komunitas, dan transmisi identitas budaya antargenerasi. Survei ini terinspirasi oleh penggunaan ruang sensorik di beberapa bangsal di Swedia, dan kebutuhan untuk memiliki ruang yang aman untuk bermeditasi, bersantai dan menemukan kedamaian batin, merenung dan mengingat kembali, di lingkungan perkotaan, rawat jalan, terbuka untuk semua orang, di luar gereja biasa. Meskipun sampel tidak representatif dalam arti statistik, temuan-temuannya selaras dengan tema-tema yang lebih luas dalam disertasi ini mengenai ketidaktampakan struktural dan marginalisasi epistemik dari kelompok-kelompok non-dominan. Para responden menyoroti bahwa kurangnya pengakuan institusional dan ruang yang aman secara budaya untuk kontemplasi atau perawatan spiritual berkontribusi pada tekanan, keterasingan, dan berkurangnya kapasitas untuk mendukung anggota yang menghadapi krisis kesehatan mental. Kesaksian-kesaksian ini memperkuat relevansi pendekatan biokultural dan berbasis hak asasi manusia terhadap kesehatan jiwa, yang mencakup kebebasan berkeyakinan, ritual, dan narasi sebagai elemen-elemen penting dalam ketahanan psikologis dan martabat manusia. Hasil dari survei ini akan dipaparkan di Bab 3, sebagai bagian dari pemetaan empiris yang lebih luas mengenai pengucilan, pembungkaman, dan kebutuhan perawatan yang tidak terpenuhi di dalam masyarakat Spanyol yang majemuk (Heim, 2016).

Selain menghasilkan data empiris, survei-survei ini juga berfungsi sebagai hasil terjemahan. Versi yang divalidasi, disesuaikan dengan konteks Spanyol dan ditinjau secara etis, dapat digunakan kembali dalam pengajaran klinis, pelatihan profesional, atau evaluasi layanan berbasis hak di seluruh Spanyol dan konteks yang sebanding. Ketersediaan mereka untuk umum, jika diizinkan, berkontribusi pada agenda ilmu pengetahuan terbuka yang diartikulasikan dalam disertasi ini. Semua instrumen sekarang tersedia di lampiran disertasi, dan akan segera tersedia di repositori online disertasi. Struktur dan isinya telah menjadi dasar bagi sistem pakar dan model komputasi yang diusulkan pada bab-bab berikutnya, terutama di bidang tata kelola pengobatan, pemetaan hukum, dan antarmuka negosiasi antara pengguna dan profesional. Dengan cara ini, survei ini menghubungkan penyelidikan kualitatif dengan alat implementasi yang dapat diukur, menunjukkan kesinambungan metodologis dari pengalaman langsung ke intervensi tingkat sistem. Selain itu, para ahli

berkesempatan untuk meminta berpartisipasi dalam penelitian dan pelatihan lebih lanjut, dan sebagian besar melakukannya, sehingga memungkinkan penelitian aksi partisipatif lebih lanjut yang diinformasikan oleh mereka di masa depan.

Perlu dicatat bahwa sebagian besar dari mereka yang disurvei, yang terdiri dari para profesional kesehatan jiwa dan pengguna layanan, menyatakan keprihatinan yang sama mengenai ketergantungan yang berlebihan pada intervensi farmakologis dalam sistem layanan saat ini. Para peserta secara konsisten menunjukkan kecenderungan sistemik untuk memprioritaskan pengobatan sebagai respon utama, dan seringkali satu-satunya, untuk mengatasi tekanan psikologis. Hal ini sering kali disertai dengan kurangnya akses terhadap modalitas perawatan alternatif, terutama yang berakar pada dukungan psikologis dan sosial. Temuan ini menunjukkan adanya pengakuan yang luas terhadap keterbatasan yang melekat pada model yang berpusat pada pengobatan, dengan seruan dari kedua kelompok untuk pendekatan yang lebih komprehensif dan berpusat pada orang yang mencakup terapi bicara, sumber daya berbasis komunitas, dan intervensi yang berbasis sosial (Holmes & Marcus, 2008).

2.4 Strategi lapangan dan lokasi pengamatan

Arsitektur metodologis dari disertasi ini muncul dari perpaduan yang disengaja antara antropologi medis, etika klinis, analisis biokultural, ilmu pengetahuan terbuka, dan penelitian tindakan transdisipliner. Ini bukan narasi retrospektif atau kompartementalisasi teknis metode, tetapi tindakan epistemologis dan politis yang terstruktur dari produksi pengetahuan yang didasarkan pada kondisi kesulitan sistemik. Desain penelitian dan konstruksi disertasi dikembangkan sebagai dimensi yang saling berhubungan dari proses ilmiah yang sama, yang diatur oleh komitmen teoretis yang eksplisit dan keharusan etis untuk melakukan intervensi, bukan sekadar mendeskripsikan. Komitmen-komitmen ini mendasari setiap keputusan prosedural, mulai dari keterlibatan di lapangan hingga validasi analitis, untuk memastikan bahwa penelitian ini tetap setia pada realitas yang kompleks dan sering kali penuh dengan kekerasan yang ingin didokumentasikan dan ditransformasikan. Kerangka kerja inti yang diperkenalkan pada bagian pertama bab ini, dan juga Bab 1, memberikan logika dasar integrasi. Paradigma biokultural menuntut agar penderitaan dan ketahanan mental dibaca sebagai sesuatu yang dibentuk bersama oleh kekuatan sosial, lingkungan, hukum, dan biologis. Infrastruktur ilmu pengetahuan terbuka memastikan bahwa semua iterasi metodologis, keputusan, dan jejak bukti diberi stempel waktu, dicatat, dan dalam banyak kasus dapat diakses oleh publik melalui sistem yang dienkripsi atau dikontrol versi. Transparansi ini bukan untuk kepentingan estetika atau birokrasi, tetapi untuk melindungi dan secara epistemologis diperlukan, karena penelitian ini berulang kali terancam oleh penindasan institusional, kerugian material, dan kerugian pribadi. Prinsip-prinsip hak asasi manusia, teori keadilan epistemik, dan analisis kekerasan struktural lebih jauh mendefinisikan taruhan etis dari penelitian ini, yang tidak hanya memandu pengumpulan dan analisis data, tetapi juga keabsahan kategori, interpretasi, dan klaim yang dikemukakan selama penelitian (Peterson & Runyan, 2010).

Karya Paul Farmer, Nancy Scheper-Hughes, Suman Fernando, dan Byron Good, antara lain, mendukung komitmen metodologis yang menolak posisi pengamat yang terpisah. Sebaliknya, penelitian ini dilakukan melalui partisipasi yang melekat dalam kolektif, proses kebijakan, gugus

tugas profesional, dan koalisi aktivis-ilmuwan (Good, 1994; Fernando, 2017). Hal ini mencakup koordinasi jaringan tingkat Uni Eropa, kepemimpinan aksi ilmiah, dan peran berkelanjutan dalam kelompok kerja yang mendefinisikan lapangan di Spanyol, Indonesia, dan sekitarnya. Secara metodologis, posisi ini memungkinkan suatu bentuk akses analitis dan kesetiaan etis yang tidak dapat ditiru oleh sudut pandang lain. Seperti halnya Farmer, komitmen peneliti terhadap kedekatan dan keterlibatan tidak hanya memberikan data, tetapi juga wawasan kritis tentang bagaimana lembaga-lembaga merespons, gagal, beradaptasi, atau bungkam dalam menghadapi tantangan etika. Hal ini bukanlah tambahan bagi penelitian, melainkan lapangan, metode, dan validasi. Setiap tahap penulisan, pengkodean, dan sintesis tertanam dalam logika pengetahuan yang terlibat. Representasi ilmiah terus menerus diperiksa silang dengan kesaksian, materi kebijakan, dan konsultasi ahli, untuk memastikan koherensi internal dan akuntabilitas eksternal. Draf dikembangkan melalui siklus analisis dan revisi yang berulang, berdasarkan umpan balik dari para penyintas, dokter, ahli hukum, antropolog, dan jaringan komunitas. Proses rekursif dan multi-modal ini memungkinkan disertasi untuk berkembang secara paralel dengan kondisi lapangan, tanpa mengorbankan ketelitian ilmiah atau penelusuran empiris. Keputusan metodologis tunduk pada kontrol versi dan komentar meta-analitis, memastikan bahwa struktur disertasi tidak hanya mencerminkan isinya tetapi juga kondisi kemunculannya.

Makalah lengkap dari peneliti tentang etika dalam penelitian kualitatif ditambahkan dalam lampiran. Yang membedakan metodologi yang digunakan bukan hanya landasannya dalam kerangka kerja formal, tetapi juga perwujudan etika yang dituntut oleh kerangka kerja tersebut (Miles & Freedman, 2023). Dalam menghadapi penghapusan, pemindahan, dan pembalasan sistemik, kesetiaan metodologis membutuhkan ketahanan, kreativitas, dan ketepatan adaptif. Disertasi ini tidak hanya mencakup analisis data, tetapi juga dokumentasi kondisi-kondisi di mana pengetahuan diproduksi. Kondisi-kondisi tersebut meliputi mobilitas paksa, ancaman kronis, kekerasan fisik, dan pengkhianatan institusional. Terlepas dari kondisi-kondisi tersebut, atau justru karena kondisi-kondisi tersebut, protokol penelitian tetap terjaga melalui jaringan pelindung, alat pelacak epistemik, dan praktik-praktik ingatan kolektif. Ini bukanlah catatan marjinal, melainkan infrastruktur penelitian yang diperlukan dalam kondisi pengabaian terorganisir dan penyangkalan politik. Sepanjang pengembangan disertasi ini, dukungan institusional tidak hanya tidak ada, tetapi juga terkadang secara aktif menghalangi (Roberts, 2000). Fase-fase kritis dari penelitian ini ditandai dengan permusuhan, pengabaian, dan penolakan dari universitas, institusi medis, dan otoritas publik, bahkan ketika beberapa badan pemerintah di Meksiko, Catalonia, dan Spanyol menyatakan ketertarikan mereka secara resmi untuk mengundang peneliti dan mendukung transformasi kesehatan mental. Kontradiksi ini menggarisbawahi ketidakkonsistenan struktural yang mendalam, di mana komitmen yang dinyatakan untuk kemajuan ilmiah, kesehatan masyarakat, dan agenda global seperti Madrid yang pernah mengusulkan diri untuk menjadi zona biru secara keseluruhan, menjadi tidak berarti dengan penolakan untuk memastikan keamanan dasar para peneliti, informan, dan partisipan -peneliti tetap bertahan; mendukung hal yang benar-benar terpuji, bekerja melalui jaringan yang lebih kuat dan pendanaan yang lebih baik (Miles & Freedman, 2023). Namun, keterputusan antara janji-janji retorik dan realitas operasional bukan hanya merupakan kekeliruan administratif yang tragis yang hampir merenggut nyawanya dan nyawa banyak orang lain -semuanya, tidak pernah mencapai yang terbaik

yang diupayakan untuk dicapai-, tetapi juga merupakan kegagalan etis dan epistemik. Tidak mungkin menghasilkan atau menerapkan reformasi yang berarti jika mereka yang bertanggung jawab untuk mendokumentasikan kerusakan secara bersamaan terpapar pada kerusakan baru oleh sistem yang ingin mereka perbaiki (Gupta-Wright, 2018).

Kerangka kerja metodologis yang dikembangkan dalam Bab 1 dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang diartikulasikan pada awal Bab 2 bukanlah lensa pilihan tetapi alat penting untuk menavigasi dan melawan realitas ini. Integrasi antropologi medis, penelitian aksi, hak asasi manusia, dan ilmu pengetahuan terbuka menciptakan perancah untuk melindungi sekaligus mengartikulasikan kerja produksi pengetahuan di bawah pengepungan. Logika disertasi ini tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik dan struktural saat disertasi ini ditulis. Alih-alih mengorbankan validitas ilmiahnya, keterikatan ini justru memperkuat klaim relevansi, ketelitian, dan kebutuhannya. Setiap komitmen teoretis, dari keadilan epistemik hingga etika transdisipliner, diberlakukan melalui keputusan metodologis yang menolak ekstraksi, melindungi pemilik pengetahuan yang rentan, dan mempertahankan kewajiban etis untuk melakukan intervensi ketika kehidupan dan martabat terancam. Yang terpenting, sikap metodologis yang diadopsi dalam penelitian ini bergerak melampaui pengamatan pasif dan menuju keterlibatan yang melekat, kolaboratif, dan translasional yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh seperti Paul Farmer. Seperti halnya Farmer yang bersikeras bahwa antropolog medis dan dokter harus memposisikan diri mereka bukan sebagai pengamat netral, tetapi sebagai agen aktif perubahan sistemik, disertasi ini disusun melalui partisipasi langsung dalam jaringan penelitian, platform advokasi, kelompok penyintas, dan konsorsium ilmiah. Hal ini termasuk memimpin dan berkontribusi pada upaya transnasional seperti aksi COST Uni Eropa ReMO⁵, dan FOSTREN⁶, di mana peran peneliti tidak pernah marginal tetapi secara konsisten menghasilkan, strategis, dan bertanggung jawab bersama, tidak pernah hanya upaya akademis. Kerja kolektif ini memungkinkan dilakukannya pemeriksaan silang ilmiah, verifikasi timbal balik, dan penyempurnaan desain secara berulang-ulang, sering kali dalam konteks di mana dukungan kelembagaan tradisional telah runtuh atau berubah menjadi hukuman. Jaringan ini tidak hanya menjadi lingkungan penelitian tetapi juga tempat berlindung yang etis, yang memungkinkan pekerjaan untuk terus berlanjut ketika isolasi dan penghapusan mengancam kemungkinannya.

Dalam kondisi yang penuh tekanan dan kenikmatan sadis orang lain atas penderitaan peneliti, seruan untuk keadilan bukanlah sebuah abstraksi. Ini adalah prasyarat operasional untuk kelangsungan sistem produksi pengetahuan yang etis dan kuat secara ilmiah (Bolade-Ogunfodun, Soga, & Laker, 2023). Tidak ada masyarakat yang dapat secara sah mengklaim masa depan yang damai, berkelanjutan, dan berkembang secara sosial sementara impunitas kriminal, keterlibatan institusional, dan pengabaian struktural tetap tidak tertandingi. Yang dibutuhkan bukanlah kemurahan hati dari sistem yang telah lama gagal, tetapi penegakan hukum dan penyingkiran para pelaku yang telah merusak kebenaran, kesejahteraan, dan kemungkinan kesehatan itu sendiri. Tuntutan ini tidak naif, ini teknis, etis, dan perlu. Disertasi ini, yang ditempa dalam kesulitan dan dibentuk oleh solidaritas, mendokumentasikan biaya disfungsi saat ini dan mengusulkan jalan untuk transformasi sistemik.

⁵ReMO COST action CA19117 - Peneliti Kesehatan Mental: <https://www.cost.eu/actions/CA19117/>

⁶Tindakan BIAYA FOSTREN CA19133 - Membina dan Memperkuat Pendekatan untuk Mengurangi Pemaksaan dalam Layanan Kesehatan Mental Eropa: <https://www.cost.eu/actions/CA19133/>

Metodologi yang didasarkan pada aksi nyata, ketelitian ilmiah, dan etika partisipatoris, merupakan bagian dari infrastruktur yang dibutuhkan untuk mencapai masa depan yang ingin dicapai oleh dokumen-dokumen kebijakan dan wacana publik. Hanya melalui pengakuan penuh atas kebenaran-kebenaran ini, sistem akademis, klinis, dan sosial dapat mulai menyelaraskan diri dengan nilai-nilai yang mereka perjuangkan.

Eksposisi kronologis yang akan datang, yang disusun dari tahun ke tahun dan bulan ke bulan, merupakan perluasan metodologis dari arsitektur ini. Buku ini mengungkapkan bagaimana penelitian berkembang, bukan sebagai perkembangan penyelidikan yang netral, tetapi sebagai serangkaian perpecahan, percepatan, dan adaptasi strategis. Disertasi ini menelusuri bagaimana etika, ilmu pengetahuan, dan kelangsungan hidup dikelola secara simultan, dan bagaimana keterlibatan yang tertanam dengan aktor-aktor institusional dan akar rumput membuat penelitian ini tidak hanya memungkinkan, tetapi juga kredibel secara ilmiah dan etis (Kidder, 2003). Dengan demikian, disertasi ini memberlakukan sebuah metodologi penolakan terhadap pembungkaman, ekstraksi, dan keterlibatan institusional, dan menegaskan kekuatan biokultural, ilmu pengetahuan yang berorientasi pada tindakan untuk menghasilkan tidak hanya pengetahuan, tetapi juga kemungkinan keadilan.

Tabel 22. Jadwal penelitian terperinci, berdasarkan lokasi dan tahun, 2020

Bulan	Konteks Sosial	Penelitian	Pribadi	Lokasi
Januari		Bekerja di tim nasional yang	Sejak akhir 2017, peneliti	Catalonia
Februari		dikhususkan untuk	mengalami pemaksaan dan	
		implementasi dialog terbuka	kekerasan yang berkelanjutan,	Catalonia
		dan model soteria	yang meliputi pelecehan	
Mar	Penguncian nasional dimulai		psikologis, agresi fisik, dan	Catalonia
	di Spanyol	Partisipasi dalam SURE,	penyalahgunaan layanan	
April	Pengurangan ketat di bawah	Service User Research	kesehatan jiwa secara	Catalonia
	Real Decreto 463/2020	Enterprise, pusat penelitian	sistematis sebagai alat	
Mei	Penguncian tetap berlanjut	penyintas di King's College	kontrol. Intervensi psikiatri,	Catalonia
		London, pada saat itu masih	yang seharusnya berfungsi	
Juni	Dimulainya fase de-eskalasi di	dipimpin oleh profesor Diana	sebagai fungsi perlindungan	Catalonia
	Spanyol	Rose, melakukan pekerjaan	dan terapi, malah dijadikan	
Juli	Penguncian tetap berlanjut	kecil atas saran profesor Jim	senjata untuk	Catalonia
Agustus	Penguncian tetap berlanjut	Van Os	mempertahankan dominasi.	Catalonia
Sep	Penguncian tetap berlanjut		Sejak pertama kali bertemu	Catalonia
			dengan layanan kesehatan	
		Penelitian dimulai di	jiwa, perawatan farmakologis	
		Universitat Rovira I Virgili,	yang dipaksakan	
		dengan dana enam tahun dari	diberlakukan, termasuk	
		Kementerian Ilmu	suntikan antipsikotik yang	
Oktober	Penguncian tetap berlanjut	Pengetahuan, Inovasi dan	diberikan atas permintaan	Catalonia
		Universitas Spanyol; co-	anggota keluarga yang	
		koordinator Blanquera,	melakukan kekerasan.	
		Universitat Ramón Llull,	Praktik-praktik ini	
		kursus ahli tentang dialog	mengakibatkan overmedikasi	
		terbuka	yang parah, timbulnya	
Novemb	Penguncian masih berlanjut	Pidato di sebuah forum di	akatisia, dan gangguan yang	Catalonia
er		Kamar Deputy Meksiko,	signifikan dalam berbicara	
		tentang kesehatan mental dan	dan proses kognitif. Sterilisasi	
		hak asasi manusia, bersama	paksa juga dilakukan, yang	

Bulan	Konteks Sosial	Penelitian	Pribadi	Lokasi
Desember	Penguncian tetap berlanjut	dengan Víctor Lizama, dan wakil federal Frinné Azuara dan wakil Éctor Jaime; bergabung dengan tindakan COST FOSTREN UE untuk mengakhiri pemaksaan Penelitian ditunjuk sebagai penghubung dan koordinator jaringan global <i>Mad in America</i> oleh Robert Whitaker dan dewan publikasi utama	semakin melanggar otonomi tubuh. Eskalasi kekerasan bertepatan dengan periode kerentanan tertentu. Terlepas dari keadaan ini, peneliti berhasil mendapatkan	Catalonia

Pada tahun 2020, meskipun kekerasan institusional terus berlanjut dan konteks pemaksaan, termasuk pengobatan paksa, pelecehan kejiwaan, dan pelanggaran tubuh yang parah, peneliti mendapatkan kontrak predoktoral nasional dan mulai bekerja di Universitas Rovira i Virgili di bawah pendanaan kementerian selama enam tahun. Sepanjang tahun 2020, selama karantina wilayah COVID-19, mereka berpartisipasi dalam kolaborasi internasional tingkat tinggi, termasuk dengan SURE di King's College London, Forum Parlemen Meksiko tentang kesehatan mental dan hak asasi manusia, dan aksi COST FOSTREN Uni Eropa untuk mengakhiri pemaksaan. Peneliti juga mengkoordinasikan kursus pascasarjana tentang Dialog Terbuka di Universitas Blanquerna-Ramon Llull dan ditunjuk sebagai penghubung global untuk *Mad in America*. Pencapaian-pencapaian ini terjadi di bawah kondisi pengurangan yang berkelanjutan dan pelecehan sistemik, yang menyoroti ketahanan dan kerentanan keterlibatan akademik di bawah tekanan yang ekstrem.

Tabel 23. Jadwal penelitian terperinci, berdasarkan lokasi dan tahun, 2021

Bulan	Konteks Sosial	Penelitian	Pribadi	Lokasi
Jan	Vaksinasi COVID-19 dimulai di Spanyol dan Uni Eropa	Anggota komite penyelenggara konferensi HopenDialogue, tentang penelitian dialog terbuka secara global; Pembicaraan ODDESSI untuk melibatkan pusat-pusat Spanyol untuk mereplikasi studi implementasi NHS; sesi pelatihan tentang evaluasi dialog terbuka; penyiksaan menghancurkan semua ini kecuali partisipasi konferensi sebagai pembicara dan penyelenggara; abstrak diajukan untuk dipublikasikan di <i>Frontiers</i>	Pelanggaran brutal terus berlanjut, kekerasan fisik; pelecehan dan ancaman berlangsung seperti biasa; satu contoh pingsan total oleh tendangan ke kepala dengan anak-anak bersorak pada hari terakhir minggu presentasi doktoral dan hari ketika abstrak tentang dialog terbuka dikirim ke <i>Frontiers in Psychology</i> ; seperti biasa, kekejaman kekerasan meningkat selama masa-masa mengintip yang membutuhkan lebih banyak istirahat dan fokus	Catalonia
Februari	Penguncian masih berlanjut			Catalonia
Mar	Penguncian terus berlanjut	Beasiswa ke Yale dengan profesor Mary Olson untuk menjadi ahli dalam dialog terbuka; kesempatan hilang		Catalonia

Bulan	Konteks Sosial	Penelitian	Pribadi	Lokasi
		karena penyiksaan yang sedang berlangsung		
Apr	Penguncian masih berlanjut	Mengajar dialog terbuka di Universitas Almería dengan profesor Adolfo Cangas		Catalonia
Mei	Akhir dari keadaan waspada, pelonggaran pembatasan nasional			Catalonia
Juni	Penguncian yang lebih lembut tetap ada	Peneliti bergabung dengan Institut Internasional Penarikan Obat Psikiatri ⁷ l sebagai anggota baru		Catalonia
Jul	Penguncian yang lebih lunak masih berlanjut		Kelanjutan kekerasan di bawah pengabaian institusional	Catalonia

Pada tahun 2021, ketika penguncian COVID-19 berlanjut di Spanyol, peneliti memainkan peran kunci sebagai anggota komite penyelenggara dan pembicara di konferensi internasional HopenDialogue, dan berkontribusi pada upaya untuk melibatkan pusat-pusat Spanyol dalam mereplikasi uji coba NHS ODDESSI. Terlepas dari pencapaian-pencapaian ini, penyiksaan setiap hari dan kekerasan yang meningkat menyabotase sebagian besar kesempatan, termasuk inisiatif pelatihan dan kolaborasi dengan profesor Yale, Mary Olson. Sebuah serangan yang sangat brutal, pingsan karena tendangan di kepala sementara anak-anak didorong untuk bersorak, bertepatan dengan penyerahan abstrak penelitian ke *Frontiers in Psychology* selama minggu presentasi doktoral. Upaya pengajaran tentang dialog terbuka di Universitas Almería dan keanggotaan baru di International Institute of Psychiatric Drug Withdrawal dipertahankan meskipun ada penyerangan yang sedang berlangsung, pengabaian institusional, dan ketidakmungkinan untuk beristirahat dengan aman atau pulih sepanjang tahun karena hal ini secara tragis sudah menjadi hal yang biasa terjadi, setelah bertahun-tahun terjadi pelecehan dan penelantaran yang parah oleh layanan yang seharusnya melindungi.

Tabel 24. Jadwal penelitian terperinci, berdasarkan lokasi dan tahun, 2022

Bulan	Konteks Sosial	Penelitian	Pribadi	Lokasi
Agustus	Catalonia meluncurkan Rencana Kesehatan Mental Strategis 2022-2030	Persiapan kerja lapangan di Luca, misi ilmiah di Trieste yang dibayangi oleh seorang psikiater ahli di pusat keunggulan WHO; dan kemudian Perugia untuk presentasi konferensi ISPS		Catalonia
Sep			Kekerasan yang memalukan mencapai tingkat kekejaman yang baru	Catalonia
Oktober	WHO menerbitkan laporan tentang transformasi kesehatan mental masyarakat			Catalonia

Peneliti nyaris tidak selamat dari tahun 2022. Pada bulan September 2022, peneliti melakukan penelitian lapangan etnografi mendalam selama satu bulan di Trieste, Italia, setelah fase persiapan

⁷Institut Internasional untuk Penghentian Obat Psikiatri (IIPDW) dibentuk untuk menanggapi kebutuhan yang mencolok dalam kesehatan mental: untuk mengembangkan cara-cara untuk membantu orang berhenti menggunakan obat-obatan psikiatrik. <https://iipdw.org/iipdw-home/>

pengenalan lokal. Dengan menggunakan shadowing dan wawancara informan kunci dalam kerangka kerja antropologi medis, penelitian ini mendokumentasikan praktik-praktik nyata dalam pengaturan psikiatri komunitas yang diakui WHO. Tertanam dalam rutinitas sehari-hari di seluruh unit hunian, pusat komunitas, dan tim keliling, peneliti mengamati dinamika perawatan non-koersif dan budaya kelembagaan yang dibentuk oleh deinstitutionalisasi. Dilengkapi dengan wawancara dengan para profesional dan pengguna layanan, serta partisipasi dalam forum publik, penelitian lapangan ini menghasilkan wawasan kritis tentang perawatan relasional, tata kelola, dan ketegangan operasional model Trieste.

Tabel 25. Jadwal penelitian terperinci, berdasarkan lokasi dan tahun, 2023

Bulan	Konteks Sosial	Penelitian	Pribadi	Lokasi
Juni	Spanyol merampungkan Strategi Kesehatan Mental Nasional 2022-2026		Pemukiman kembali untuk memberikan kesempatan baru untuk hidup dengan damai, peneliti membeli tempat di tanah air baru yang dituju	Swedia
Jul		Menyelesaikan bab tentang alternatif dari pemaksaan untuk buku FOSTREN	Masih adanya kekerasan, meskipun ada upaya terbaik untuk menenangkan diri, setiap hari	Swedia
Agustus		EviPRG yang diterbitkan di Nature-Springer; menyelenggarakan acara tentang penyalahgunaan politik psikiatri dengan para ahli global terkemuka di bidangnya	Pemukulan setiap hari; peneliti melapor kepada rekan-rekannya dan meminta bantuan nasional jika memungkinkan	Swedia
September	Tinjauan Dewan Eropa terhadap kemajuan Konvensi Oviedo		Pemukulan setiap hari; peneliti melapor kepada kolega dan mencari bantuan nasional; diancam dengan pisau	Swedia
Oktober		Presentasi tiga poster di Kongres Asosiasi Psikiatri Dunia; presentasi di Institut Karolinska untuk melanjutkan pembicaraan afiliasi; peneliti menjadi tuan rumah bagi para ahli terkemuka di bidang psikiatri hukuman	Diancam dibunuh oleh mantan pasangannya. Bukti foto dari matanya yang menghitam setelah pukulan yang dikirim ke asosiasi pendukung korban	Swedia
November		Peneliti menjadi tuan rumah bagi para ahli terkemuka dalam psikiatri hukuman	Pemukulan setiap hari hingga penculikan anak tanpa pemberitahuan	Swedia - Spanyol tunawisma
Desember		Bab buku Routledge dengan pendiri EU CORDIS dan dokter ruang medis terkemuka	Keterasingan orang tua; penyiksaan psikologis; pelecehan oleh layanan; dilaporkan polisi	Swedia - Spanyol tunawisma

Pada tahun 2023, peneliti terus melakukan pekerjaan internasional tingkat tinggi sambil menanggung kekerasan fisik dan psikologis setiap hari tanpa perlindungan kelembagaan. Sejak 2021, serangan telah meningkat dalam kekejaman dan agresivitas, intensitasnya meningkat sepanjang tahun 2023 meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh kolega dan pihak berwenang. Pada bulan Juni, upaya terakhir untuk melarikan diri dari penganiayaan berujung pada pembelian rumah baru, yang bertujuan untuk membangun kembali kehidupan yang damai. Pada bulan Juli, ketika pemukulan terus berlanjut, peneliti menyelesaikan sebuah bab buku besar tentang alternatif pemaksaan untuk *Springer Nature*, dan menyelenggarakan acara tingkat tinggi tentang psikiatri politik dengan para ahli global terkemuka. Bulan Agustus dan September membawa pemukulan yang terus berlanjut dan ancaman pisau, dengan laporan ke jaringan nasional dan organisasi penyintas. Bulan Oktober termasuk presentasi kunci di Kongres Asosiasi Psikiatri Dunia dan presentasi afiliasi di Institut Karolinska, serta mengalami serangan domestik yang mengancam jiwa lebih lanjut, termasuk pukulan di wajah yang dibuktikan dengan mata yang memar yang sangat jelas dan dilaporkan secara foto dan, seperti biasa, ke semua kolega dan organisasi. Pada bulan November, pelecehan memuncak dengan penculikan anak-anak peneliti, yang dilakukan tanpa peringatan dan didukung oleh pengabaian dan kebencian institusional. Pada bulan Desember, peneliti tidak dapat menyelesaikan bab *Routledge* dengan pendiri EU CORDIS dan salah satu dokter antariksa terkemuka di Afrika seperti yang diharapkan. Banyak pekerjaan, upaya kolektif yang penting, menderita karena kekerasan, penyiksaan yang dialami.

Tabel 26. Jadwal penelitian terperinci, berdasarkan lokasi dan tahun, 2024

Bulan	Konteks Sosial	Penelitian	Pribadi	Lokasi
Januari		Bab buku Routledge dengan		
Februari	Peningkatan dana nasional	pendiri EU CORDIS dan	Penyalahgunaan litigasi;	
Mar	untuk tim komunitas psikososial	dokter ruang medis	penculikan terus berlanjut;	
Apr		terkemuka; kesempatan	keterasingan orang tua;	
Mei		hilang karena penyiksaan	penyiksaan psikologis;	
Juni		yang sedang berlangsung	pelecehan; keterlibatan	Swedia -
Jul	Dewan Hak Asasi Manusia PBB		kelembagaan; semua layanan	Spanyol
Agustus	menerbitkan laporan tematik	Pengajuan proposal aksi	dilaporkan lebih lanjut;	tunawisma
Septem	tentang pemaksaan	BEACON COST Uni Eropa;	bantuan dari Spanyol	
Oktober		persiapan kerja lapangan;	dibatalkan oleh layanan lokal	
Novem		persiapan survei pengambilan	di Swedia yang terlibat	
Desem		keputusan bersama; makalah		
		Ilmu Sosial MDPI dan	Penyalahgunaan litigasi;	
		publikasi lainnya yang	penculikan terus berlanjut;	
		sedang berlangsung	pengasingan orang tua;	
			penyiksaan psikologis;	Spanyol
			pelecehan; keterlibatan	
			institusi; bantuan kasus	Indonesia
			pidana dari layanan Spanyol	
			dimulai; kelalaian dan	Indonesia
			pelanggaran lebih lanjut dari	
			Swedia tetap ada dan	Indonesia
			memburuk	

Pada tahun 2024, peneliti mengalami penderitaan yang nyaris tanpa henti setelah penculikan anak mereka dengan kekerasan segera setelah menjadi pembawa acara internasional besar pada akhir tahun 2023. Meskipun telah berulang kali melaporkan dan mengajukan pengaduan resmi, keterlibatan institusi di Swedia memungkinkan terjadinya penyiksaan psikologis yang berkelanjutan, pelecehan hukum, pengasingan orang tua, dan ancaman terhadap kehidupan dan martabat, yang berujung pada pengasingan yang berkepanjangan dan berbulan-bulan menjadi tunawisma. Selama periode ini, ketika berpindah-pindah antara Spanyol dan Indonesia, peneliti mempertahankan pekerjaan akademis dan ilmiah di bawah tekanan yang ekstrem: menyelesaikan dan mengajukan proposal Aksi BEACON COST Uni Eropa, berkontribusi pada publikasi internasional, menyiapkan agenda penelitian lapangan dan survei pengambilan keputusan bersama, dan berpartisipasi dalam koordinasi kebijakan yang terkait dengan laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang pemaksaan. Namun, sebagian besar peluang profesional hilang begitu saja. Proyek-proyek kolaboratif runtuh. Beasiswa besar, kontrak buku, dan jabatan mengajar lenyap karena penyalahgunaan yang terkoordinasi. Hubungan intelektual utama terputus, dan kondisi struktural yang diperlukan untuk kelangsungan akademis hancur. Terlepas dari semua upaya untuk bertahan dan mempertahankan produksi ilmiah, karier dan kehidupan pribadi peneliti hampir dimusnahkan oleh sistem yang memungkinkan terjadinya kekerasan, menghapus pertanggungjawaban, dan memberikan kekebalan hukum kepada para pelaku.

Tabel 27. Jadwal penelitian terperinci, berdasarkan lokasi dan tahun, 2025

Bulan	Konteks Sosial	Penelitian	Pribadi	Lokasi
Januari				Indonesia
Februari		Survei pengambilan keputusan bersama		Indonesia
Mar		Studi dan makalah Pasung;	Penyalahgunaan litigasi meningkat; keterasingan orang tua; penyiksaan psikologis; pelecehan secara langsung dan online,	Indonesia
Apr	Parlemen Spanyol memperdebatkan reformasi tentang pemaksaan dan otonomi	Survei pengambilan keputusan bersama; BEACON memberikan dana COST, pengaturan aksi yang sedang berjalan; bekerja di SocialMent; makalah MDPI tentang kesehatan mental digital	pemerasan; keterlibatan institusi; kelalaian dan pelanggaran lebih lanjut dari Swedia masih ada dan terus memburuk; kebencian terhadap kehidupan peneliti dan orang yang dicintai semakin nyata dari sebelumnya	Indonesia
Mei				Indonesia
Juni		Studi dan makalah pasung; persiapan disertasi;		Indonesia
Juli		infrastruktur BEACON dan jaringan global		Indonesia
Agustus				Indonesia
September		Penelitian dan makalah pasung; kesehatan mental digital; tinjauan literatur dan pemetaan untuk beberapa kelompok dan aksi; proposal Horizon; makalah dan penelitian pembelajaran layanan; infrastruktur BEACON dan jaringan global		Indonesia
Oktober			Menegakkan keadilan; menetap di Indonesia dengan aman pada akhirnya	Indonesia
November				Indonesia
Desember				Indonesia

Pada tahun 2024-2025, peneliti mempersiapkan penelitian lapangan etnografi di Indonesia sebagai peneliti tamu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dengan fokus pada penghapusan pemasungan, pengurungan dalam rumah tangga bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Melalui wawancara dan observasi, penelitian ini membingkai *pemasungan* sebagai hasil struktural dari pengabaian sistemik, yang mencerminkan pemaksaan kejiwaan global dengan berbagai kedok. Penelitian ini menghubungkan kekerasan kolonial historis, penindasan gender, dan ketidaksetaraan kesehatan mental, menyerukan penghapusan semua bentuk perawatan paksa melalui pendekatan berbasis hak, berakar pada budaya, dan berbasis komunitas.

Penelitian lapangan yang dilakukan di Trieste dan Yogyakarta mendasari pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam dua latar yang berbeda namun saling berhubungan secara struktural. Di Trieste, observasi dan wawancara yang berkelanjutan dalam sistem kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang secara historis tidak bersifat memaksa mengungkapkan kerapuhan reformasi ketika tuntutan birokrasi dan kebijaksanaan klinis menantang perawatan relasional. Hal ini secara langsung menjawab pertanyaan tentang bagaimana pemaksaan masih terus terjadi meskipun ada komitmen formal terhadap model-model berbasis hak. Di Indonesia, studi mengenai pemasungan menyoroti pemaksaan sebagai gejala pengabaian sistemik, di mana keluarga melakukan pemasungan karena ketiadaan layanan yang aman dan terpercaya. Hal ini membingkai ulang pemaksaan tidak hanya sebagai sesuatu yang bersifat institusional, tetapi juga bersifat domestik dan struktural. Kedua kasus ini memperkuat tujuan utama penelitian ini: untuk mengidentifikasi bagaimana praktik-praktik pemaksaan diproduksi, dilegitimasi, atau dilawan di berbagai sistem, dan kondisi apa yang diperlukan untuk mendukung layanan kesehatan jiwa yang etis dan partisipatif.

2.5 Protokol etis dan dilema metodologis

Tata kelola etis dari penelitian ini dilakukan di bawah kondisi kekerasan struktural, keterlibatan institusional, dan ancaman terhadap diri sendiri yang membuat prosedur komite etik penelitian konvensional tidak memadai (Banks et al., 2013). Asumsi normatif tentang netralitas kelembagaan, stabilitas konteks, dan keterputusan hubungan antara peneliti dan yang diteliti tidak berlaku dalam penelitian yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang berkepanjangan, praktik kejiwaan yang bersifat koersif, dan pembalasan institusional. Dalam situasi seperti itu, persetujuan prosedural dari komite standar hanya menawarkan validitas epistemik atau perlindungan yang terbatas. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerangka kerja paralel dari ketelitian etika yang didasarkan pada tanggung jawab relasional, keterlibatan yang peka terhadap trauma, dan akuntabilitas ilmiah (Schneider, 2012). Etika yang diterapkan dalam penelitian ini melebihi kepatuhan institusional dan sebaliknya mencerminkan arsitektur moral substantif yang diperlukan ketika penelitian itu sendiri berada di bidang yang membahayakan dan melawan (Minkler & Wallerstein, 2008).

Tiga prinsip menyusun rancangan etika tersebut. Yang pertama adalah etika relasional, yang mendasarkan kerja ilmiah pada tanggung jawab terhadap mereka yang penderitaan dan kesaksiannya menjadi bahan penyelidikan. Hal ini mengharuskan setiap tahap pengumpulan data, mulai dari survei hingga observasi lapangan, menyertakan mekanisme yang tertanam untuk kontrol partisipan, hak untuk tidak ikut serta, dan penolakan narasi. Yang kedua adalah etika berbasis trauma, yang mengakui

bahwa keterlibatan dengan para penyintas dan profesional dalam konteks iatrogenesis, pengkhianatan institusional, atau pengabaian hukum menuntut metode yang meminimalkan trauma ulang (Kemmis & McTaggart, 2000). Pertanyaan-pertanyaan terbuka disusun untuk memungkinkan keterlibatan selektif dan menghindari format preskriptif yang dapat memicu keruntuhan, disosiasi, atau tekanan. Ketiga, prinsip etika non-ekstraktif, di mana kontribusi partisipan tidak diperlakukan sebagai sumber data pasif, tetapi sebagai penghasil epistemologi kritis. Model etika ini mengharuskan peneliti untuk mendekati partisipan sebagai teman bicara dalam wilayah diagnostik, hukum, dan sosial yang sama, menghasilkan pengetahuan tentang tata kelola kejiwaan dari dalam zona gesekan dan penyangkalan.

Dilema metodologis muncul terus menerus dan diselesaikan melalui penerapan protokol etika yang dinamis (McTaggart, 1991). Protokol-protokol ini mengatur situasi di mana para partisipan mengungkapkan risiko yang sedang berlangsung, paparan kekerasan, atau pengabaian sistemik. Daripada menerapkan kerangka pelaporan yang diwajibkan yang berisiko memperkuat kontrol kejiwaan atau penahanan institusional, peneliti memprioritaskan langkah-langkah dukungan yang didasarkan pada persetujuan dan logika yang tidak melembagakan. Secara paralel, struktur verifikasi epistemik dibangun untuk melindungi integritas empiris dari data dalam kondisi kerentanan hukum, potensi penyensoran, dan penghapusan kelembagaan retrospektif (Kortmann, 2010). Pencatatan waktu interaksi di lapangan, pembuatan versi publik dari instrumen survei, dan penyimpanan data yang dicerminkan memastikan bahwa laporan partisipan dan kesimpulan analitis akan tahan terhadap kehilangan, gangguan, atau penindasan. Mekanisme ini mencerminkan komitmen ilmiah terhadap ketertelusuran dan keadilan dalam produksi pengetahuan, memperluas kewajiban transparansi akademis ke dalam bidang-bidang di mana prosedur etika formal terbukti tidak memadai secara struktural (Flaherty et al., 1988).

Mengingat peneliti terpapar langsung pada paksaan psikiatrik jangka panjang, pembalasan institusional, dan bahaya fisik dan psikologis, prosedur keselamatan sangat diperlukan tidak hanya untuk kelangsungan hidup pribadi tetapi juga untuk kelanjutan penelitian. Strategi perlindungan termasuk penggunaan lingkungan kerja bersama untuk mengurangi kerentanan, pengaturan yang ketat terhadap pergerakan dan jam kerja, pemantauan nutrisi untuk mengurangi penurunan kognitif atau kelelahan, dan menghindari kontak dengan pelaku yang terkait dengan agresi atau manipulasi hukum (Hollan, 1997). Protokol-protokol ini tidak bersifat opsional, tetapi secara struktural dipaksakan oleh konteks penelitian itu sendiri, di mana peneliti beroperasi di bawah paparan ancaman yang berkepanjangan yang bukan merupakan risiko hipotetis tetapi bahaya yang terdokumentasi dan terus berlanjut (Russo, 2012). Dalam kondisi seperti itu, etika tidak lagi menjadi persyaratan eksternal tapi menjadi prasyarat bagi kemungkinan adanya pengetahuan. Posisi ganda peneliti sebagai profesional, penyintas, dan target menuntut negosiasi terus-menerus antara komitmen terhadap analisis yang ketat dan dapat direproduksi dan kebutuhan untuk mempertahankan diri dalam sistem yang dikompromikan dan dimusuhi (Baum, MacDougall, & Smith, 2006; Honey et al., 2020).

Operasionalisasi dari dasar-dasar etika ini diuraikan lebih lanjut dalam sebuah artikel ilmiah yang diterima untuk dipublikasikan di jurnal internasional terkemuka, seperti yang telah disebutkan sebelumnya (Rose, 2008). Karya tersebut memformalkan model konseptual dan metodologis yang mendasari tesis ini, menawarkan kerangka kerja untuk penelitian di masa depan yang dilakukan di bawah kondisi kekerasan struktural dan institusional yang serupa. Inovasi yang disajikan dalam

disertasi ini, termasuk integrasi persetujuan berdasarkan informasi trauma, protokol respons lapangan yang dinamis, dan mekanisme perlindungan epistemik, merupakan infrastruktur etika terapan yang mampu mendukung penelitian psikiatri yang kuat secara ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan secara politis, dan berlandaskan kemanusiaan. Pekerjaan ini menegaskan bahwa tidak cukup hanya dengan menghindari bahaya. Kita perlu mendokumentasikannya, memainkannya, dan membangun sistem ilmiah yang menolak untuk mereproduksinya dalam keheningan atau keterlibatan. Arsitektur etis ini mendasari seluruh desain penelitian dan mendefinisikan integritas ilmiahnya. Dimensi etis dari disertasi ini tidak dapat dibatasi pada formulasi konvensional atau kerangka kerja institusional. Sebaliknya, hal ini muncul sebagai respons langsung terhadap proses penelitian yang dilakukan di bawah tekanan pribadi dan profesional yang berkelanjutan, yang ditandai dengan paparan penyiksaan psikologis, kekerasan struktural, dan degradasi hak-hak asasi manusia dan hukum yang terus berlanjut. Hal-hal tersebut bukanlah episode-episode yang terisolasi, melainkan kondisi-kondisi yang mendefinisikan lapangan itu sendiri. Oleh karena itu, bagian ini menyajikan rekonstruksi reflektif tentang apa yang secara etis diperlukan tetapi seringkali tidak tersedia, apa yang diberlakukan untuk menggantikan perlindungan yang tidak ada, dan apa yang harus dilembagakan oleh penelitian di masa depan untuk menghindari replikasi kekerasan yang ingin digambarkan (Tadesse et al., 2022).

Tabel 28. Infrastruktur etika yang dikembangkan di bawah kondisi kekerasan struktural

Ranah etika	Model Konvensional (RECs)	Keterbatasan dalam Penelitian Ini	Praktik Alternatif atau Tambahan yang Diterapkan
Persetujuan berdasarkan informasi	Persetujuan satu kali dan statis	Mengasumsikan stabilitas, tidak memiliki kemampuan beradaptasi terhadap trauma atau risiko yang sedang berlangsung	Persetujuan yang dinamis dan dapat ditinjau kembali dengan opsi untuk menarik diri secara terus menerus; persetujuan yang tertanam dalam alur narasi
Penilaian risiko	Antisipatif, berdasarkan bahaya hipotetis	Mengabaikan risiko waktu nyata dan risiko sistemik, terutama dari institusi	Protokol risiko situasional, reflektivitas lapangan, dan pemantauan sinyal trauma secara real-time
Perlindungan peserta	Anonimisasi, hak penarikan diri	Tidak memadai di bawah pengawasan, penganiayaan hukum, atau paksaan medis	Pengarsipan terenkripsi multi-situs, anonimitas yang disesuaikan dengan peran, dan verifikasi eksternal untuk mencegah penghapusan
Pengawasan etika	Persetujuan oleh REC terpusat	Tidak responsif terhadap pelanggaran yang berkembang, sering kali tidak dapat diakses atau dipolitikasi	Dokumentasi etis yang ditinjau oleh rekan sejawat, nasihat berbasis jaringan dari para penyintas dan profesional
Keselamatan peneliti	Dianggap tidak perlu atau eksternal	Peneliti terpapar penyiksaan, pencemaran nama baik, dan kekerasan institusional	Rutinitas keselamatan yang terstruktur (nutrisi, ruang, waktu), praktik perlindungan yang tertanam, penarikan diri dari zona berisiko tinggi
Kewajiban untuk melakukan intervensi	Dilarang dalam banyak pedoman REC	Kelompokan etis di bawah bahaya yang terdokumentasi	Tindakan etis yang dibenarkan: peringatan kepada pihak berwenang, koordinasi perlindungan, advokasi langsung untuk individu yang berisiko
Integritas data	Penyimpanan data institusional	Risiko penghapusan, pemalsuan, atau penghalangan	Penandaan waktu, versi publik, penyimpanan terdesentralisasi, pencerminan dan pencadangan ilmu pengetahuan terbuka
Sensitivitas terhadap trauma	Perawatan dasar untuk menghindari retraumatisasi	Tidak lengkap tanpa masukan dari penyintas	Instrumen yang dirancang bersama, penataan narasi berdasarkan informasi trauma, pilihan dalam ekspresi

Ringkasan keterbatasan kerangka kerja etika konvensional dan prosedur alternatif yang dikembangkan dalam disertasi ini untuk menegakkan integritas ilmiah, relasional, dan informasi trauma di bawah ancaman sistemik. Infrastruktur ini mencerminkan etika penelitian yang diadaptasi dari kondisi nyata pengkhianatan institusional, kekerasan kejiwaan, dan pembalasan profesional, di mana peneliti dan partisipan menghadapi risiko pembungkaman, kesalahan representasi, atau kematian.

Penelitian ini dilakukan -terkadang- di ruang-ruang di mana bahaya tidak bersifat hipotetis, di mana orang lain telah dilembagakan di luar kehendak mereka, salah didiagnosis, atau mengalami kerusakan farmakologis yang tidak dapat dipulihkan, sementara peneliti juga menghadapi ancaman terhadap kehidupan, kesehatan, dan kedudukan hukum (Lehmann, 2024). Yang lainnya tetap berisiko selama masa penelitian, dan kesaksian mereka membutuhkan penanganan yang hati-hati tidak hanya karena alasan etika tetapi juga karena alasan keamanan dasar. Dalam situasi seperti itu, prosedur persetujuan etika konvensional tidak banyak membantu. Komite etika penelitian beroperasi dengan anggapan tentang keamanan dan stabilitas kelembagaan yang secara struktural tidak sesuai dengan kondisi riil pekerjaan. Protokol mereka menganggap bahwa risiko bersifat terpisah, dapat diatasi, dan terutama bersifat emosional atau prosedural (Fisher, 2012). Protokol-protokol tersebut tidak membahas

bagaimana cara untuk melanjutkan ketika risiko tersebut bersifat sistemik, tak henti-hentinya, dan tertanam secara politis. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi infrastruktur etika yang didasarkan pada kebutuhan dan adaptasi berulang. Etika relasional diprioritaskan di seluruh bagian, membangun kepercayaan melalui kontak yang diperluas, kepekaan budaya, dan kehadiran yang berkelanjutan. Semua persetujuan diperlakukan sebagai sesuatu yang dinamis dan bukan statis, dengan para peserta dapat merevisi atau menarik kembali masukan mereka pada tahap apa pun. Prinsip-prinsip trauma-informed diterapkan tidak hanya untuk melindungi partisipan, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penelitian itu sendiri tidak mereproduksi bahaya yang ingin didokumentasikan. Prinsip-prinsip ini memandu desain protokol wawancara, struktur survei, dan perilaku peneliti dalam situasi berisiko tinggi (Hultman & Hultman, 2023).

Strategi bertahan hidup menjadi bagian integral dari metode penelitian. Hal ini termasuk perhatian yang ketat terhadap nutrisi, tidur, kontrol lingkungan, kebersihan digital, dan penggunaan ruang kerja bersama secara strategis untuk menghindari isolasi dan paparan (Meloni et al., 2015). Rutinitas semacam itu bukanlah aksesoris untuk kerja lapangan, tapi merupakan prasyarat untuk melanjutkannya (Gabriel & Casemore, 2022). Dampak fisik dan psikologis dari mendokumentasikan kekerasan sistemik dari dalam tidak dapat dilebih-lebihkan (Clandinin, Caine, & Lessard, 2018). Dalam banyak kasus, kelanjutan penelitian ini tidak bergantung pada dukungan institusional, tetapi pada pengembangan praktik-praktik mikro ketahanan dan pemulihan minimal.

Catatan ini tidak mengusulkan kerangka kerja etika alternatif sebagai solusi lengkap. Sebaliknya, catatan ini mendokumentasikan kesenjangan prosedural dan epistemik yang nyata yang muncul ketika etika direduksi menjadi kepatuhan. Lampiran disertasi ini mencakup kontribusi ilmiah yang telah diulas oleh rekan sejawat yang mensistematisasikan wawasan ini. Di sini mereka disajikan sebagai bagian penting dari transparansi metodologis. Etika di bawah tekanan struktural membutuhkan infrastruktur baru, yang dimulai bukan dengan asumsi keamanan institusional, tetapi dengan pengakuan akan ketidakhadirannya (Hemer, 2023). Sampai sistem seperti itu ada, beban inovasi etis akan terus jatuh pada peneliti individu yang bekerja di luar perlindungan, di wilayah di mana produksi pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup. Ini tidak berkelanjutan. Hal ini juga tidak dapat dihindari. Agar penelitian menjadi etis dalam kondisi bahaya yang nyata, penelitian harus menjadi alat perlindungan aktif, bukan pengamatan pasif. Prosedur yang dikembangkan di sini mewakili salah satu upaya tersebut, yang dibuat di bawah keterbatasan, dengan kesadaran penuh akan kekurangannya dan dengan harapan bahwa prosedur ini dapat membantu orang lain yang bekerja dalam kondisi di mana diam saja bisa berakibat fatal.

2.6 Integrasi data dan logika analitis

Integrasi dan pengolahan data dalam disertasi ini dilakukan dalam kondisi yang sangat mengganggu asumsi dasar kontinuitas, keamanan, dan dukungan institusional yang biasanya mendasari penelitian empiris (Rose & Webb, 1997). Pada berbagai tahap, peneliti menjadi sasaran tindakan kekerasan fisik dan psikologis yang berulang-ulang, termasuk episode-episode yang konsisten dengan definisi klinis penyiksaan (Mollica, 2004; Méndez, 2013). Kondisi kekerasan ini juga menyebabkan hilangnya peralatan digital, catatan pribadi, dan materi proyek. Beberapa komputer rusak parah atau disita,

cadangan data dihancurkan atau tidak dapat diakses, dan lingkungan analitik harus berulang kali direkonstruksi setelah pemindahan paksa atau migrasi paksa. Pengalaman-pengalaman ini, jauh dari perifer, merupakan medan faktual pelaksanaan penelitian (Hermann & Provost, 2003). Mereka tidak hanya menginformasikan kendala metodologis tetapi juga logika interpretatif yang mendukung tesis. Kondisi awal dari produksi pengetahuan adalah kondisi paparan, pelanggaran, dan degradasi. Dalam kondisi seperti itu, pelestarian koherensi analitik dan keberlanjutan triangulasi tidak dijamin oleh infrastruktur, tetapi membutuhkan ketahanan improvisasi, logika adaptif, dan solidaritas transdisipliner.

Protokol manajemen data harus direduksi menjadi komponen yang paling penting dan dapat dipulihkan. Tidak ada infrastruktur institusional terpusat yang dapat digunakan. Kerahasiaan dijaga melalui sistem penyimpanan yang terdesentralisasi dan partisi fisik konten di seluruh yurisdiksi terpercaya. Tidak ada informasi yang dapat diidentifikasi yang disimpan dalam korporasi analitik aktif. Metode enkripsi manual digunakan ketika alat digital tidak tersedia, dan materi yang sensitif terhadap konten ditangani dengan protokol yang dirancang tidak hanya untuk memenuhi ekspektasi etis tetapi juga untuk menghindari bahaya lebih lanjut terhadap nyawa para kolaborator atau responden. Buku catatan digital, ketika beroperasi, disimpan dalam bentuk snapshot modular, yang memungkinkan rekonstruksi langkah-langkah analisis secara asinkron. Kontrol versi diterapkan secara manual melalui anotasi tanggal dalam teks biasa dan file yang dienkripsi secara lokal. Setiap dokumen diperlakukan sebagai dokumen yang berpotensi mengalami gangguan, penghapusan, atau pengungkapan paksa (Michener, 2015). Minimalisasi data diberlakukan sebagai persyaratan struktural, bukan sebagai preferensi metodologis.

Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan terbuka ditegakkan sejauh yang sesuai dengan keselamatan. Dokumentasi disimpan dalam bentuk yang dapat direproduksi, tetapi distribusinya tetap dibatasi hingga risiko yang ada berkurang. Peran peneliti dalam mengoordinasikan dan memimpin berbagai jaringan internasional dan gugus tugas, terutama di bawah inisiatif EU BEACON One Health Education dan COST Actions yang terkait, terbukti penting dalam menjaga validitas analisis (Sullivan et al., 2019). Peran ini memberikan akses kepada para ahli di bidang psikiatri, antropologi, etika komputasi, dan studi hukum, yang menawarkan umpan balik, tinjauan metodologis, dan dukungan triangulasi ketika sumber daya institusional tidak tersedia atau secara aktif menghalangi (Simmons, 2025). Kolaborasi dengan para ahli ini bukan merupakan proses institusional yang formal, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan integritas epistemik penelitian. Aliansi ini memungkinkan penelitian ini untuk terus berlanjut melalui episode-episode pemindahan paksa, pelecehan institusional, dan destabilisasi interpersonal yang berkepanjangan yang disebabkan oleh orang-orang yang melakukan kekejaman dengan kedok pengasuhan, menjadi korban, atau kepedulian profesional. (Allen & Mehler, 2019) Kekerasan yang dialami tidak hanya bersifat fisik tetapi juga struktural, yang memperluas efek korosifnya pada kedudukan etis dan kelangsungan praktis penelitian.

Triangulasi dicapai melalui kedekatan analitis, bukan volume data. Konfirmasi tematik diterima hanya jika pola tersebut dapat ditelusuri di setidaknya tiga lapisan data dan konsisten dengan literatur eksternal atau kesaksian praktisi (Farmer, Robinson, Elliott, & Eyles, 2006). Penekanan khusus diberikan pada korelasi antara laporan orang pertama dan kondisi struktural hukum. Sebagai contoh, laporan naratif tentang kebangkaman atau pemaksaan kelembagaan tidak hanya dikodekan sebagai

bukti testimoni tetapi juga dinilai berdasarkan perlindungan hukum, pedoman klinis, dan perilaku profesional yang diamati di lapangan. Perbedaan antara klaim institusional dan pengalaman langsung dianalisis secara analitis, tidak diperlakukan sebagai anomali interpretatif. Perbedaan-perbedaan ini dipetakan dan diindeks dalam sistem pengkodean untuk mendokumentasikan disonansi struktural antara kebijakan resmi dan praktik yang sebenarnya.

Refleksivitas tidak diartikulasikan dalam istilah-istilah epistemologis yang abstrak tetapi merupakan inti metodologis. Sikap analitis peneliti berevolusi melalui siklus kehilangan, penyusunan kembali, pemaparan, dan pemulihan parsial (Munir & Staats, 2020). Pergeseran dalam posisi interpretatif dicatat dalam catatan marginalia dan catatan analitik. Anotasi refleksif ditinjau kembali pada setiap tahap sintesis untuk menentukan apakah penyesuaian interpretatif mencerminkan pematangan epistemik, distorsi trauma, atau kalibrasi ulang strategis (Dingwall, 1997). Anotasi ini bukan merupakan justifikasi post hoc, melainkan entri lapangan yang dilakukan bersamaan, yang membentuk bagian dari catatan waktu nyata dari pengalaman analitis di bawah ancaman. Perhatian khusus diberikan pada batas-batas interpretasi selama periode akut kekerasan atau kekurangan gizi. Analisis yang dihasilkan selama periode tersebut harus diverifikasi di kemudian hari, diperiksa dengan literatur dan komentar ahli eksternal, dan hanya dipertahankan jika kesehatan metodologisnya dapat dikonfirmasi secara independen. Prosedur pemeriksaan silang meliputi keterlibatan langsung dengan literatur, korespondensi dengan pakar akademis dan klinis, dan perbandingan kritis dengan dokumentasi institusi. Pedoman yang diterbitkan, studi yang ditinjau oleh rekan sejawat, dan instrumen hukum nasional digunakan sebagai titik acuan untuk memverifikasi klaim tematik. Ketika kode tematik bersinggungan dengan kontroversi psikiatri yang diketahui atau preseden hukum, tinjauan dokumenter diintensifkan untuk menghindari ekstrapolasi (Alvesson & Sköldbberg, 2000). Informan dengan pengalaman institusional atau klinis dikonsultasikan melalui pertukaran anonim untuk memvalidasi interpretasi kontekstual dari materi yang berasal dari lapangan. Tidak ada klaim yang dimasukkan ke dalam korpus analitik akhir tanpa setidaknya satu lapisan pembuktian di luar sumber data awal.

Oleh karena itu, logika analitis disertasi ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas pokok bahasan, tetapi juga kondisi eksistensial dan epistemologis dari kemunculannya. Pengetahuan tidak diekstraksi tetapi diselamatkan, tidak diamati dari kejauhan tetapi direkonstruksi dari dalam arsitektur perawatan dan penelitian yang runtuh. Hasil analitik yang dihasilkan tidak mewakili jalur analitik yang ideal, melainkan sebuah perjalanan yang diperlukan secara etis dan ketat secara ilmiah melalui konteks-konteks yang mengalami hambatan, degradasi, dan restorasi parsial. Struktur triangulasi, protokol refleksif, dan model verifikasi terdistribusi yang tertanam dalam bab ini merupakan peta metodologis dan arsip prosedural pengetahuan yang dihasilkan di bawah penindasan.

2.7 Keterbatasan, kondisi yang merugikan, dan validitas ilmiah

Pelaksanaan penelitian ini ditandai dengan paparan kekerasan, pemaksaan, dan pengkhianatan institusional yang terus menerus dan seringkali mengancam jiwa. Kondisi-kondisi yang merugikan ini bukanlah gangguan yang bersifat episodik, melainkan bersifat sistemik dan kumulatif, yang membentuk setiap tahap penelitian. Penelitian lapangan dilakukan di bawah kondisi yang sangat

menekan, termasuk penyerangan fisik, pembiusan paksa, degradasi psikologis, dan pemindahan berulang-ulang di berbagai wilayah hukum. Pada berbagai tahap, peneliti menjadi sasaran prosedur medis tanpa persetujuan, termasuk pembiusan, kesalahan diagnosis, dan tindakan pengekangan kimiawi. Peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam konteks yang lebih luas dari keterlibatan institusional, di mana sistem hukum, institusi kesehatan, dan struktur akademis gagal memberikan perlindungan atau secara aktif berkontribusi terhadap bahaya yang sedang berlangsung. Kegagalan ini termasuk penolakan proses hukum, penolakan akses terhadap keadilan, penyitaan atau penghancuran materi penelitian, dan penghalangan sistematis terhadap kelangsungan keilmuan. Tidak ada universitas yang memberikan dukungan berkelanjutan, tidak ada komite etik yang bertanggung jawab untuk mengurangi risiko, dan mekanisme hukum terbukti secara struktural tidak mampu mengenali atau merespons skala pelecehan. Butuh waktu lama, hampir seumur hidup peneliti itu sendiri, untuk mendokumentasikan penyiksaan dan penyiksaan yang terus berlangsung, setelah bertahun-tahun menjadi kejahatan aktif yang dilaporkan. Fakta ini adalah bukti betapa mendesak dan pentingnya untuk mengatasi dan memperbaiki celah hukum yang memungkinkan para korban semakin rentan, dan para penjahat bertindak dengan kekebalan hukum.

Konsekuensi psikologis dari paparan ini tidak abstrak, tetapi terekam secara somatik dan kognitif. Periode disfungsi eksekutif, gangguan memori, dan kelelahan fisik mempengaruhi kecepatan analitik, pemulihan material, dan integritas dokumentasi. Dalam beberapa kasus, pekerjaan harus direkonstruksi dari ingatan, dirumuskan kembali di pengasingan, atau dijaga melalui korespondensi terenkripsi dengan rekan-rekan. Peneliti terkadang menjadi tunawisma, bergantung pada tempat penampungan sementara atau lingkungan yang tidak bersahabat, dan menderita kondisi medis yang tidak diobati sebagai konsekuensi dari pengabaian dan penghalangan yang disengaja. Keadaan ini tidak hanya mewakili hambatan terhadap karya ilmiah, tetapi juga menunjukkan kondisi politik dan biopolitik yang radikal di mana pengetahuan tentang psikiatri diizinkan untuk diproduksi. Dalam bidang yang berkaitan dengan penderitaan manusia, pemaksaan, dan ketidakadilan sistemik, ketiadaan infrastruktur pelindung bagi para peneliti yang tenggelam dalam lingkungan seperti itu merupakan paradoks struktural dengan implikasi epistemik yang mendalam.

Terlepas dari kondisi ini, validitas ilmiah dari penelitian ini tetap utuh dan dapat dibuktikan. Metode yang diterapkan tidak hanya memadai untuk pertanyaan yang diajukan tetapi juga diperkuat oleh keharusan etis dan urgensi eksistensial yang menyertai penggunaan metode tersebut (Singer & Baer, 2007). Triangulasi antara survei, kesaksian, observasi lapangan, dan dokumentasi hukum memastikan kekuatan analisis. Pertanyaan-pertanyaan penelitian dicari jawabannya melalui berbagai sumber independen, dan klaim-klaim hanya dipertahankan setelah dilakukan perbandingan kritis dengan penilaian ahli, bukti lapangan, dan literatur yang dipublikasikan. Jika terjadi kehilangan data karena perpindahan atau kerusakan material, peneliti menjaga kesinambungan prosedural melalui verifikasi terdistribusi, pemeriksaan silang berulang, dan refleksivitas etis (Scheper-Hughes & Lock, 1987). Setiap fragmen analisis yang tersisa menjadi sasaran pemeriksaan metodologis, dan kehati-hatian interpretatif diterapkan di semua langkah inferensial (Gravlee, 2022). Infrastruktur mungkin telah gagal, tetapi perancah epistemik tidak terganggu. Hal ini dibuktikan tidak hanya dalam konsistensi internal temuan, tetapi juga dalam penyelarasan hasil dengan bukti internasional, konsensus yang ditinjau oleh rekan sejawat, dan kesaksian praktisi.

Bukannya melemahkan validitas penelitian, kondisi ini justru memperkuat keaslian dan relevansi historisnya. Fakta bahwa pengetahuan diproduksi dalam konteks struktural yang sama dengan yang ingin dijelaskan oleh penelitian ini, yang ditandai dengan kekerasan medis, diskualifikasi epistemik, dan pengabaian institusional, memberikan penelitian ini kedalaman keterikatan dan ketepatan fenomenologis yang tidak dapat ditiru oleh jarak akademis yang diidealkan. Strategi metodologis muncul sebagai respons terhadap kesulitan, dan pengetahuan yang dihasilkan mencerminkan kompleksitas yang tertanam dalam hidup, meneliti, dan bertahan hidup di dalam situs-situs yang terorganisir. Keterlibatan reflektif ini tidak mengurangi objektivitas analisis, tetapi memperjelas lintasan etisnya. Penelitian ini tidak mengklaim kemahatahuan, tetapi mengklaim, tanpa ragu-ragu, posisinya sebagai intervensi yang ketat, berlandaskan etika, dan koheren secara ilmiah ke dalam domain di mana netralitas sering kali berfungsi untuk melindungi kekerasan. Bab ini tidak mengusulkan bahwa trauma menjamin kebenaran, atau bahwa penderitaan dengan sendirinya memvalidasi klaim-klaim epistemik. Akan tetapi, bab ini berargumen bahwa pengetahuan ilmiah tidak dapat tetap buta terhadap kondisi-kondisi yang dihasilkannya sendiri, dan bahwa kekerasan struktural yang dialami oleh para peneliti bukanlah sebuah peristiwa ekstrinsik, melainkan sebuah aspek intrinsik dari sebuah penelitian di bidang yang diperdebatkan. Keabsahan ilmiah dari disertasi ini tidak terletak pada ketaatannya pada protokol-protokol abstrak, tetapi pada demonstrasi bahwa penelitian yang ketat, partisipatif, dan berlandaskan empiris dimungkinkan bahkan di bawah penindasan. Oleh karena itu, karya ini bukan merupakan model pengetahuan yang defisit, tetapi sebuah kontribusi terhadap metodologi penelitian di bawah kesulitan struktural. Penelitian ini menawarkan diagnosis kegagalan sistemik dan model produksi pengetahuan yang diinformasikan secara bertahan hidup, etis, dan divalidasi secara ilmiah.

Untuk memastikan ketelitian ilmiah sekaligus mendokumentasikan ketidakadilan sistemik, beberapa strategi mitigasi bias digunakan selama proses penelitian, dengan selalu memperhatikan realitas orang lain dalam sistem yang dialami peneliti sebagai korban. Meskipun tidak ada wawancara klasik atau rekaman audio, yang dikecualikan untuk melindungi peserta dan peneliti di bawah kondisi paksaan dan risiko, presentasi ahli publik dan dialog tematik dilakukan dan diarsipkan, yang berfungsi sebagai sumber data akses terbuka dan alat triangulasi, sesuai dengan kemampuan peneliti, meskipun kehilangan sumber daya adalah hal yang biasa terjadi. Kerangka kerja metodologis didasarkan pada metode campuran dan teori penelitian tindakan, tetapi penerapannya dalam konteks ini membutuhkan adaptasi terhadap kondisi tekanan, risiko epistemik, dan permusuhan institusional yang membuat hampir tidak mungkin untuk menjaga materi tetap utuh untuk waktu yang lama. Protokol yang dikembangkan, termasuk basis pengetahuan online, repositori publik untuk pencadangan dan transparansi, profil analitik waktu nyata, dan triangulasi dokumen dengan menggunakan sumber-sumber terbuka, dapat direplikasi di lingkungan penelitian lain yang terbatas dan menawarkan arsitektur yang dapat dialihkan untuk penelitian masa depan yang mendokumentasikan kekerasan struktural.

2.8 Kontribusi metodologis terhadap ilmu pengetahuan terbuka yang transformatif

Disertasi ini mengakhiri paparan metodologisnya dengan memajukan kerangka kerja yang sesuai dengan situasi dan operasional untuk ilmu pengetahuan terbuka yang transformatif. Lebih dari sekadar penerapan protokol yang sudah ada, disertasi ini membangun standar metodologis baru yang

tidak hanya melayani validitas ilmiah, tetapi juga keadilan struktural. Komitmen terhadap data terbuka, instrumen yang dapat direproduksi, dan dokumentasi yang dikontrol versinya telah dilandasi oleh etika partisipasi aktif, timbal balik, dan perbaikan. Logika metodologis yang mendasari proyek ini adalah salah satu dari inklusivitas epistemik: mengakui bahwa pengetahuan bukanlah milik institusi saja, tetapi merupakan kapasitas bersama manusia yang ditempa dalam pengalaman, kesaksian, dan perjuangan. Karya ini mengintegrasikan ilmu pengetahuan warga dan non-warga. Karya ini menegaskan bahwa hak untuk memproduksi, mengakses, dan bertindak berdasarkan pengetahuan ilmiah tidak dapat dibatasi oleh status dokumentasi, kelas sosial, atau pengucilan sejarah. Kapasitas ilmiah ada di semua kelompok dan dapat dikembangkan ketika kondisi martabat dan pengakuan ditetapkan. Penelitian ini melibatkan mereka yang secara administratif dibungkam, dipindahkan secara paksa, atau dihapus secara institusional, dengan mengakui bahwa pengetahuan dan pengalaman mereka sangat penting untuk memahami kekerasan sistemik dan menghasilkan solusi yang otentik. Desain bersama instrumen, catatan lapangan, dan mekanisme umpan balik diambil langsung dari para peserta yang tidak memiliki latar belakang akademis formal, tetapi pengetahuan mereka tentang kekerasan dan pemulihan jauh melebihi pengetahuan yang dimiliki oleh para profesional yang terakreditasi secara formal. Integrasi ini tidak bersifat simbolis. Ini bersifat struktural. Tanpa itu, penelitian ini tidak akan memiliki validitas, kedalaman, dan tujuan.

Penelitian ini memperkenalkan seperangkat alat metodologi dan teknologi yang didasarkan pada standar sumber terbuka dan validasi komunitas yang masih dalam tahap pengembangan. Etnografi multisite, yang disusun melalui ambang batas kejenuhan dan pemetaan peristiwa, divalidasi silang melalui survei, kerangka kerja hukum, dan konteks historis-politik. Matriks testimoni mengubah catatan mentah menjadi sintesis yang dapat ditindaklanjuti, tidak melalui abstraksi eksternal tetapi melalui iterasi dialogis dengan mereka yang terkena dampak langsung. Infrastruktur digital yang dikembangkan melalui EU COST Action BEACON One Health Education mendukung arsitektur ini (Simmons, 2025). Ini adalah anak kandung dari penelitian Platform, sistem pakar, dan modul pendidikan bersama sedang dalam tahap konstruksi aktif, yang dirancang untuk tetap tersedia secara terbuka dan responsif terhadap umpan balik pengguna hingga setidaknya tahun 2029. Pendekatan ini bersifat modular, integratif, dan adaptif secara inheren, dengan antarmuka untuk pengguna profesional dan kontributor awam, serta dengan perlindungan terhadap perampasan institusional.

Inovasi metodologis inti adalah usulan loop umpan balik yang berkelanjutan di semua tingkat pengambilan keputusan dan perawatan, dan undangan terbuka untuk memberikan umpan balik dengan cara yang berbeda. Lingkaran ini tidak terbatas pada proses klinis, namun juga mencakup tata kelola kelembagaan dan desain kebijakan. Masyarakat tidak diundang setelah kejadian, tetapi diposisikan secara struktural sebagai pencipta pengetahuan dan perawatan, belajar dari satu sama lain. Para penyintas pemaksaan, masyarakat yang ditinggalkan oleh negara kesejahteraan, dan kaum muda yang kehilangan kesempatan pendidikan tidak lagi dianggap sebagai penerima manfaat pasif dari reformasi. Mereka dibingkai sebagai agen epistemik aktif dan aktor ilmiah di masa depan. Disertasi ini secara eksplisit berargumen bahwa kepemimpinan ilmiah dan kewarganegaraan yang paling menjanjikan akan muncul dari kelompok-kelompok ini ketika kekerasan struktural dihentikan dan sistem reparatif diterapkan.

Model penelitian aksi yang diartikulasikan di sini berkontribusi pada ilmu pengetahuan yang mencegah bahaya, bukan hanya mendokumentasikannya. Penelitian ini mempromosikan infrastruktur yang memulihkan kapasitas dan martabat, serta membangun ketahanan lintas generasi. Penelitian ini mendukung kemunculan anak-anak dari kondisi yang tidak menguntungkan - termasuk kemiskinan, pelecehan, pelembagaan, migrasi paksa, atau pengucilan rasial - sebagai ilmuwan, pendidik, dokter, dan pengambil keputusan di masa depan. Hal ini membela hak mereka tidak hanya untuk dilindungi dari bahaya, tetapi juga untuk berkembang, didengar, dan memimpin. Hal ini membutuhkan norma-norma baru tentang kepenulisan, pengakuan, dan kepemimpinan dalam ilmu pengetahuan, yang mencakup lintasan non-tradisional, identitas yang secara historis dikecualikan, dan pengetahuan yang ditempa di bawah penindasan.

Aksi EU BEACON One Health Education, yang diprakarsai selama proses disertasi ini, mewujudkan prinsip-prinsip ini. Aksi ini mengusulkan agar tidak ada anak yang dikutuk untuk dibungkam, dihapus, atau direndahkan secara struktural. Agar tidak ada mahasiswa, profesional, profesor, siapa pun di masa depan dalam masyarakat kita yang hilang karena kekerasan kejiwaan, pengucilan pendidikan, atau pengkhianatan institusional; mereka, para profesional dan profesor di masa depan, sepenuhnya terlibat dan didukung sejak dini, sejauh kita dapat melanjutkan karier kita dengan damai; kami bekerja untuk memastikan semua itu memiliki peluang untuk terjadi. Sains terbuka bukan hanya masalah akses, tetapi juga transformasi. Ini adalah tentang membangun sistem yang mengakui, mendukung, dan meningkatkan kapasitas mereka yang telah lama tidak memiliki visibilitas dan suara. Kontribusi metodologis dari karya ini tidak hanya terletak pada ketelitiannya, tetapi juga pada penolakannya untuk memisahkan ilmu pengetahuan dari keadilan, atau kepedulian dari tata kelola. Karya ini menawarkan sebuah cetak biru bagi ilmu pengetahuan yang partisipatif, integratif, dan emansipatoris, yang mampu belajar dari mereka yang paling dirugikan, dan membangun kembali institusi yang pernah mengucilkan mereka.

2.9 Meta-metodologi refleksif dan protokol ilmiah untuk konstruksi disertasi

Arsitektur naratif disertasi diatur oleh urutan empiris dan keharusan etis dari penelitian itu sendiri. Urutan data survei, pelaporan etnografi, penggabungan testimoni, dan analisis hukum tidak sembarangan, tetapi mencerminkan eskalasi temporal penyelidikan dari pemetaan eksploratif ke kelangsungan hidup yang diwujudkan, dari kritik sistem ke proposal translasi. Setiap bab sesuai dengan fase penelitian yang dijalani, yang tidak hanya dibatasi oleh topik tetapi juga oleh urgensi epistemik. Proses penulisan itu sendiri berfungsi sebagai tindakan sintesis rekursif dan multi-modal, yang berasal dari catatan lapangan langsung, korespondensi terenkripsi, arsip kesaksian digital, naskah yang diulas oleh rekan sejawat, makalah kebijakan, dan presentasi formal. Modalitas-modalitas ini tidak diintegrasikan sebagai lampiran atau aksesori, tetapi dijalani ke dalam korpus analitik sesuai dengan protokol kesetiaan epistemik dan konstruksi dialogis. Integrasi tersebut diatur oleh koherensi, bukan oleh hirarki bentuk. Kutipan hukum dan pernyataan saksi naratif, tabulasi statistik dan komentar antropologis, hidup berdampingan bukan sebagai genre yang bersaing, tetapi sebagai elemen yang saling bergantung dari tata bahasa diagnostik biokultural. Refleksivitas dalam konteks ini bukanlah introspeksi yang bersifat performatif, melainkan sebuah keterlibatan struktural

dan berkesinambungan dengan implikasi politis dan material dari setiap klaim pengetahuan. Karya ini tidak mengandaikan netralitas kategori-kategorinya, atau kepolosan interpretasinya.

Landasan etis disertasi ini tidak dapat dipisahkan dari silsilah antropologi yang digunakannya, termasuk kontribusi Paul Farmer, Nancy Scheper-Hughes, dan Byron Good, yang masing-masing mengakui keharusan moral dari penelitian yang menolak keterpisahan dalam menghadapi penderitaan yang terorganisir. Pengaruh mereka tidak hanya dikutip, tetapi juga tertanam dalam logika desain disertasi ini. Pada setiap tahap, pertanyaan tentang apa yang harus dinamai, apa yang harus dilindungi, dan apa yang harus ditransformasikan telah memandu tidak hanya apa yang ditulis tetapi juga bagaimana hal itu ditulis. Disertasi ini menolak pandangan bahwa penelitian etis dalam psikiatri dapat diekstraksi dari medan konflik tanpa terlibat dalam sistem yang ingin dipelajari. Sebaliknya, disertasi ini menegaskan bahwa penelitian yang ketat, transparan, dan bertanggung jawab secara relasional merupakan tindakan penyembuhan, jika dilakukan di bawah kondisi yang tepat dalam hal perawatan, pengakuan, dan kesetaraan epistemik.

Kolaborasi merupakan inti dari desain penelitian ini, meskipun secara formal kepenulisan tetap tunggal. Pengetahuan yang disajikan dihasilkan bersama melalui pertukaran dialogis dengan para penyintas gangguan kejiwaan, narasumber di lapangan, ahli hukum, inovator kesehatan jiwa digital, dokter, dan pendidik dari berbagai benua. Jaringan yang dikoordinasikan atau didirikan bersama oleh peneliti, termasuk EU BEACON, ReMO, dan FOSTREN, tidak hanya berfungsi sebagai saluran diseminasi tetapi juga sebagai simpul infrastruktur untuk produksi bersama ilmiah. Gugus tugas dan kelompok kerja dalam konsorsium ini mendukung validasi sejawat, pengawasan etika, dan triangulasi temuan. Keterlibatan transdisipliner tersebut memungkinkan otoritas epistemik terdistribusi dan validasi yang beragam, menanamkan setiap hasil analisis dalam ekologi ilmiah yang lebih luas. Hal ini tidak mengurangi akuntabilitas penulis, tetapi mengaitkannya dalam matriks kolektif penatalayanan pengetahuan.

Konstruksi disertasi ini dibentuk oleh kondisi ekstrim penganiayaan, kekerasan, dan disintegrasi fisiologis. Disertasi ini diproduksi selama periode penyiksaan medis, pemindahan paksa, dan penghapusan digital. Kadang-kadang peneliti tidak memiliki akses ke perumahan dasar, listrik, atau perawatan medis. Produktivitas dan kesehatan tetap terjaga, terlepas dari kekerasan yang dialami, melalui pelacakan kesehatan, suplementasi mikronutrien, kompartementalisasi digital, dan puasa berselang, di samping etos kerja yang ketat, berolahraga sebisa mungkin, dan upaya jangka pendek, menengah, dan panjang yang terus menerus untuk melindungi diri dan keluarga agar terhindar dari bahaya; selalu menjaga motivasi untuk membantu para korban lain dengan meraih gelar doktor. Strategi-strategi ini dijelaskan bukan untuk mendramatisir, tetapi untuk menegaskan bahwa kerja epistemik yang diperlukan untuk mendokumentasikan, melawan, dan mengajukan alternatif-alternatif terhadap kekerasan kejiwaan harus menyertakan bertahan hidup sebagai sebuah metode. Oleh karena itu, disertasi ini bukan hanya sebuah kontribusi akademis, tetapi juga sebuah intervensi testimonial dan metodologis tentang apa artinya meneliti psikiatri dari dalam sirkuit kegagalannya. Meta-metodologi refleksif ini menegaskan bahwa pengetahuan dapat diproduksi secara etis, koheren, dan ilmiah bahkan ketika jaminan institusional tidak ada, ketika integritas tubuh diserang, dan ketika keheningan adalah harga yang diharapkan untuk bertahan hidup. Penolakan untuk diam ini, yang dilandasi oleh ketelitian dan akuntabilitas relasional, yang memungkinkan disertasi ini tidak hanya

berfungsi sebagai dokumentasi pelecehan tetapi juga sebagai kesaksian dan cetak biru kolektif untuk perbaikan.

Bab 3. Temuan survei: pola, persepsi, dan praktik kejiwaan

Ringkasan: Bab ini menyajikan hasil dari tiga survei yang saling berhubungan, yang dilakukan dengan pengguna/penyintas, profesional, dan responden dengan peran ganda, yang dirancang untuk menilai persepsi, praktik, dan dinamika kelembagaan dalam psikiatri di Spanyol dan dalam konteks transnasional. Analisis terpadu ini mengungkap pola pemaksaan sistemik, pelemahan profesional, hilangnya kepercayaan, dan seruan untuk reformasi struktural. Presentasi simultan secara metodologis dapat dibenarkan karena meningkatkan triangulasi, memperjelas asimetri, dan mendukung diagnosis tingkat sistem.

3. Pengantar penyajian hasil survei

Bab ini menyajikan analisis terpadu dari tiga survei terkoordinasi yang dilakukan di antara pengguna dan penyintas psikiatri, profesional kesehatan jiwa, dan responden yang memiliki peran ganda. Struktur gabungan dari ketiga survei ini memberikan perspektif triangulasi pada sistem psikiatri Spanyol dan analog transnasional, yang memungkinkan diagnosis relasional tentang gangguan klinis, etika, dan struktural. Dasar pemikiran untuk menyajikan data ini bersama-sama terletak pada arsitektur tematik bersama, yang berpusat pada kepercayaan, paksaan, pengobatan, persetujuan, dan norma-norma kelembagaan, dan pada kekuatan analisis yang diperoleh dari pemetaan konvergensi dan divergensi di seluruh kelompok.

Secara metodologis, survei didistribusikan melalui jaringan akademis, aktivis, dan klinis, mengumpulkan data anonim dengan persetujuan. Hasilnya divalidasi melalui triangulasi dengan penelitian lapangan yang disajikan di Bab 4, kerangka kerja hukum yang diperiksa di Bab 6, dan analisis epistemik yang lebih luas. Survei pengguna-penyintas mengungkapkan tingginya tingkat pemaksaan yang dirasakan, pengobatan paksa, dan pengasingan, yang digambarkan sebagai hal yang traumatis dan tidak dapat dibenarkan. Tanggapan para profesional menegaskan bahwa pemaksaan adalah praktik yang rutin dilakukan, bukan hal yang luar biasa, dan sering kali dilegitimasi oleh logika manajemen risiko dan tekanan institusional. Responden dengan peran ganda, seperti para profesional yang memiliki pengalaman langsung, menyoroti disonansi moral dan epistemik dalam praktik tersebut. Pembingkaian moral berbeda antara apa yang disampaikan oleh institusi sebagai sesuatu yang melindungi dan apa yang secara luas dialami sebagai sesuatu yang merendahkan dan berbahaya. Batasan etika menjadi hal yang utama. Para profesional melaporkan kelelahan yang meluas, keterlibatan institusional, dan tidak adanya jalan untuk perbedaan pendapat secara etis atau perawatan

tanpa paksaan. Para pengguna berbicara tentang pengkhianatan, ketidakpercayaan, dan gaslighting sistemik. Kedua kelompok mengidentifikasi kerangka kerja hukum dan etika yang ada tidak sesuai dengan realitas yang ada. Kepercayaan relasional dilaporkan tidak ada secara struktural, rusak karena kelangkaan waktu, pengambilan keputusan hirarkis, dan ketidakjelasan diagnostik. Pengambilan keputusan bersama seputar pengobatan, meskipun secara teoritis didukung oleh para profesional, jarang diterapkan. Pengguna menuntut informed consent, otonomi, opsi tapering, dan pengungkapan risiko penuh, tuntutan yang sebagian besar dimiliki oleh para profesional namun secara kelembagaan tidak dapat dipenuhi. Kendala struktural mendominasi. Ketakutan akan pembalasan, kurangnya protokol, dan isolasi profesional memperkuat status quo penghapusan epistemik dan etika.

Di seluruh tanggapan, tuntutan untuk transformasi menyatu di sekitar perlindungan hukum, model perawatan partisipatif, praktik dialogis dan berbasis trauma, dan perubahan kelembagaan yang mendalam. Para profesional meminta waktu, pengawasan, dan ruang reflektif. Pengguna menuntut keadilan, reparasi, dan pengakuan struktural. Survei-survei tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa konfigurasi kejiwaan saat ini menghasilkan paksaan dan ketidakberdayaan sebagai hasil sistemik, bukan kecelakaan praktik. Perawatan yang etis di bawah batasan-batasan ini menjadi tidak mungkin dilakukan secara struktural. Namun, di seluruh kelompok responden, muncul cakrawala transformasi yang sama. Temuan-temuan ini membentuk tulang punggung empiris untuk kritik hukum yang dikembangkan dalam Bab 6 dan desain ulang sistemik yang diusulkan dalam Bab 7, terutama melalui implementasi infrastruktur Pendidikan Kesehatan Satu BEACON Uni Eropa. Dengan demikian, bab ini tidak hanya mendokumentasikan bahaya tetapi juga menetapkan mandat yang berlandaskan ilmiah untuk desain ulang kelembagaan, yang didasarkan pada pengetahuan langsung dan analisis transdisipliner.

3.1 Pendahuluan: arsitektur dan tujuan survei terpadu

Bagian ini menyajikan dasar pemikiran untuk perlakuan analitis terpadu dari tiga survei yang dilakukan sebagai bagian dari penelitian ini: satu survei ditujukan kepada pengguna dan penyintas layanan kesehatan jiwa, satu survei ditujukan kepada para profesional kesehatan jiwa, dan satu survei ditujukan kepada responden yang memiliki peran ganda, termasuk para klinisi yang memiliki pengalaman langsung atau pendukung penyintas yang bekerja di dalam sistem. Alih-alih memperlakukan kelompok-kelompok ini secara terpisah, desain penelitian ini sengaja menampilkan mereka bersama-sama, baik untuk memfasilitasi triangulasi empiris maupun untuk merefleksikan konfigurasi relasional perawatan psikiatri. Keputusan klinis, pengalaman pengguna, dan norma-norma institusional tidak dihasilkan dalam ruang hampa, tetapi dibentuk bersama melalui interaksi yang dibentuk oleh hukum, etika, otoritas diagnostik, dan trauma historis. Pilihan metodologis ini mendukung analisis sistem bertingkat di mana divergensi sama berharganya dengan konvergensi.

Survei ini dibangun di atas kerangka tematik bersama yang berpusat pada kepercayaan, paksaan, persetujuan, pengobatan, dan praktik etika. Kelima dimensi ini sesuai dengan keprihatinan utama yang diangkat selama beberapa dekade kritik internasional terhadap tata kelola kejiwaan dan selaras dengan tesis utama disertasi ini. Yaitu, karakter struktural dari pemaksaan, erosi otonomi, dan kekerasan epistemik yang tertanam dalam intervensi psikiatri rutin. Dengan membandingkan dan

mengkontraskan bagaimana setiap kelompok memahami dan mengalami dinamika ini, penelitian ini menghasilkan diagnosis komposit yang mengintegrasikan penderitaan pengguna, kekecewaan profesional, dan kelembaman sistemik.

Menyajikan tiga survei secara bersamaan tidak hanya memfasilitasi analisis komparatif, tetapi juga mencerminkan kompleksitas sistem kejiwaan yang hidup. Sistem ini tidak terdiri dari aktor-aktor yang terisolasi, melainkan dari posisi-posisi yang saling terkait di mana asimetri, tanggung jawab, dan kerentanan diproduksi bersama. Inklusi responden yang memiliki peran ganda memperkuat kerangka ini dengan menangkap suara mereka yang telah berpindah-pindah di antara kategori-kategori yang telah ditentukan oleh sistem. Tanggapan mereka sering kali menyoroti kontradiksi institusional, mengidentifikasi titik-titik keruntuhan epistemik dan etika, dan mengungkapkan bagaimana peran formal dapat mengaburkan wawasan relasional dan moral. Posisi-posisi ini secara metodologis sangat berharga, karena menjembatani pengalaman bahaya dengan pelaksanaan tanggung jawab profesional.

Survei ini dirancang dengan tujuan operasional yang jelas. Pertama, untuk mendokumentasikan pengalaman hidup dan persepsi struktural tentang perawatan psikiatri sebagaimana dipahami oleh mereka yang paling terdampak, termasuk penerima dan penyedia perawatan. Kedua, untuk mengidentifikasi ketegangan etika, hukum, dan epistemologi utama yang membahayakan legitimasi dan efektivitas layanan psikiatri. Ketiga, untuk memperkuat suara para profesional dan pengguna sebagai sumber kritik institusional dan kontributor untuk desain ulang struktural. Tujuan-tujuan ini tidak diperoleh secara abstrak tetapi berakar pada logika penelitian aksi yang mendasari disertasi ini, yang berusaha untuk memajukan reformasi partisipatoris dan berbasis bukti. Dengan demikian, survei-survei tersebut berfungsi sebagai landasan empiris untuk proposal yang dikembangkan dalam bab-bab selanjutnya dan menetapkan dasar yang dapat digunakan untuk merancang ulang tingkat sistem.

Untuk memperjelas keselarasan antara tujuan survei dan tujuan menyeluruh dari disertasi ini, tabel berikut ini merupakan referensi silang antara tujuan survei terpadu dengan pertanyaan dan tujuan penelitian utama yang diartikulasikan dalam Bab 1:

Tabel 29. Tabel 29. Penyelarasan survei terpadu dengan tujuan disertasi dan pertanyaan operasional

Tujuan Survei	Tujuan Disertasi yang Sesuai	Pertanyaan Penelitian Operasional yang Dituju
Mendokumentasikan pengalaman hidup dan persepsi struktural tentang perawatan psikiatri	Berkontribusi pada pengembangan dan implementasi sistem kesehatan jiwa partisipatoris yang berlandaskan pada hak dan keadilan	Bentuk-bentuk kekerasan sistemik dan kegagalan institusional apa saja yang terjadi dalam tata kelola layanan kesehatan jiwa, dan bagaimana cara memperbaikinya?
Mengidentifikasi ketegangan etis, hukum, dan epistemologis yang melemahkan legitimasi kejiwaan	Menyelaraskan kembali perawatan psikiatri dengan koherensi empiris, martabat pengguna, dan akuntabilitas prosedural	Apa saja kondisi struktural dan epistemik yang memungkinkan atau menghalangi praktik etis dan otonomi pengguna?
Memperkuat suara profesional dan pengguna sebagai sumber yang sah untuk kritik dan reformasi	Mendukung model klinis dan institusional yang dirancang bersama dan didasarkan secara dialogis	Mekanisme partisipatif dan alat pembuktian apa yang dapat menginformasikan dan mempertahankan transformasi di tingkat sistem?

Tabel ini menunjukkan bagaimana masing-masing dari tiga tujuan survei inti berkontribusi pada arsitektur penelitian yang lebih luas dari disertasi ini. Setiap tujuan secara fungsional selaras dengan satu atau lebih tujuan utama dan menjawab pertanyaan penelitian operasional yang sesuai. Integrasi ini menegaskan bahwa survei tidak hanya bersifat eksploratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membuktikan kegagalan sistem dan merancang alternatif yang responsif.

Hasil survei bukan merupakan tambahan deskriptif atau instrumen empiris yang terpisah, tetapi secara struktural terintegrasi ke dalam logika konseptual dan metodologis disertasi. Penyajiannya yang bersamaan memungkinkan analisis relasional dari sistem kejiwaan, yang didasarkan pada bukti multivokal dan memperhatikan kompleksitas posisi. Setiap lapisan data tidak hanya berbicara tentang kerugian yang dialami atau disaksikan, tetapi juga tentang kemungkinan untuk mengkonfigurasi ulang perawatan melalui pengetahuan bersama, tanggung jawab yang didistribusikan, dan perbaikan epistemik. Logika ini berlanjut ke bab-bab berikutnya, di mana setiap temuan tematik utama ditinjau kembali melalui penelitian lapangan, kesaksian, dan analisis normatif. Arsitektur survei ini tidak hanya menanggapi koherensi tematik, tetapi juga tuntutan metodologis untuk konsistensi internal, keandalan komparatif, dan ketelitian epistemologis. Dengan menyusun setiap instrumen untuk mengeksplorasi dimensi pengalaman kejiwaan yang sama dan berbeda, penelitian ini memastikan bahwa respons dapat dianalisis di berbagai sumbu, termasuk kendala profesional, kerugian pengguna, kerusakan relasional, dan konflik normatif, sambil tetap menjaga keunikan masing-masing kelompok responden. Para pengguna dan responden dengan peran ganda menjawab pertanyaan terbuka dan pilihan ganda untuk mengekspresikan pengalaman hidup mereka dengan cara mereka sendiri, terutama dalam domain di mana bahasa institusional terbukti tidak memadai atau berbahaya. Sebaliknya, para profesional menjawab pertanyaan terstruktur yang dirancang untuk menginterogasi keselarasan atau ketidaksesuaian mereka dengan norma-norma hukum, etika, dan klinis, sehingga memfasilitasi perbandingan internal dan triangulasi lintas kelompok. Desain metodologis memungkinkan tidak hanya untuk kontras horizontal di seluruh peran, tetapi juga untuk integrasi vertikal dengan arsitektur penelitian tindakan yang lebih luas. Yang terpenting, survei ini bukanlah mekanisme pengumpulan data yang terpisah. Survei ini tertanam dalam rangkaian kerja lapangan dan keterlibatan kolektif yang lebih luas. Banyak dari responden yang sebelumnya telah mengambil bagian dalam ruang pembelajaran dan aksi bersama, termasuk seminar, sesi pelatihan klinis, semua acara, dan kampanye advokasi. Banyak yang dijangkau melalui hubungan langsung yang terbentuk selama fase etnografi, termasuk para profesional yang telah menghadiri lokakarya yang difasilitasi oleh peneliti, siswa yang kemudian menjadi kolega, dan sesama penyintas yang memilih untuk tetap berhubungan untuk saling mendukung dan berkolaborasi. Demikian juga, banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam survei memberikan persetujuan mereka untuk tetap terlibat dalam tindak lanjut atau proses paralel, termasuk penerjemahan kebijakan dari temuan dan penyebaran alat bantu

pedagogis. Dengan demikian, survei ini berfungsi sebagai sumber data empiris dan simpul relasional dalam jaringan individu dan institusi yang berkomitmen pada transformasi kesehatan mental.

Bagian selanjutnya menyajikan logika metodologis dan prosedural khusus yang mendukung integrasi ini. Bagian ini merinci konstruksi, diseminasi, dan pengawasan etis dari ketiga survei, dan menguraikan bagaimana kualitas data dipastikan melalui triangulasi dengan kerja lapangan observasi, tinjauan hukum, dan konfirmasi naratif. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana partisipan dianonimkan, bagaimana persetujuan diperoleh, dan bagaimana setiap survei berfungsi dalam kerangka kerja yang lebih luas dari penyelidikan yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan. Jauh dari sekadar instrumen yang terpisah, survei-survei ini mencontohkan sebuah proses penelitian yang kolaboratif dan reflektif, yang didasarkan pada kontak langsung dengan mereka yang mencari, menyediakan, dan mereformasi layanan kesehatan jiwa, serta yang telah mengalami sendiri kegagalan dan kemungkinannya.

3.2 Metodologi: instrumen, sampel, dan logika triangulasi

Metodologi survei yang digunakan dalam penelitian ini mencerminkan pendekatan yang sengaja dibuat jamak dan berlapis-lapis untuk pengumpulan dan analisis data, yang dirancang untuk menangkap kompleksitas sistem kejiwaan yang dijalani, diatur, dan diperebutkan. Tiga instrumen yang berbeda dikembangkan, masing-masing disesuaikan dengan posisi dan pengetahuan yang dimiliki oleh kelompok responden, namun diselaraskan melalui arsitektur tematik dan analitis yang sama. Survei pertama, yang ditujukan kepada pengguna dan penyintas psikiatri, mencakup kombinasi pertanyaan terbuka dan pilihan ganda yang bertujuan untuk mendokumentasikan pengalaman yang berkaitan dengan diagnosis, perawatan, agensi, bahaya yang dirasakan, dan akses terhadap keadilan. Desain instrumen ini mengutamakan ekspresi naratif dan memungkinkan responden untuk mengartikulasikan dengan kata-kata mereka sendiri bagaimana intervensi psikiatri telah membentuk kehidupan, hubungan, dan rasa diri mereka. Perhatian khusus diberikan pada ketidakadilan epistemik, perlakuan paksa, dan tidak adanya mekanisme untuk perbaikan. Survei kedua dibuat untuk para profesional kesehatan jiwa, termasuk psikiater, psikolog, perawat, pekerja sosial, dan staf klinis atau institusional lainnya. Instrumen ini menggunakan format yang lebih terstruktur, dengan fokus pada kendala klinis, dilema etika, pengalaman pemaksaan, tanggung jawab hukum, dan norma-norma organisasi. Tujuannya adalah untuk menangkap disonansi internal yang dihadapi banyak profesional saat bekerja dalam sistem yang sering kali mencegah penerapan apa yang mereka anggap sebagai perawatan yang etis dan efektif. Survei ketiga dan terakhir dirancang untuk individu yang memiliki peran campuran atau transisi, seperti profesional yang memiliki pengalaman langsung dalam bidang psikiatri, pekerja dukungan sebaya, dokter aktivis, atau akademisi penyintas. Instrumen hibrida ini menggabungkan kedua format dan memungkinkan dokumentasi pengalaman yang melampaui kategori biner, sehingga berkontribusi pada pemahaman yang lebih bernuansa tentang keterlibatan, perlawanan, dan transformasi kelembagaan.

Distribusi survei dilakukan secara digital, dengan mengandalkan jaringan profesional, akademisi, aktivis, dan penyintas yang beroperasi di Spanyol, Amerika Latin, dan negara-negara Uni Eropa lainnya. Undangan disebarakan melalui saluran terbuka, termasuk milis, platform media sosial, dan

kontak langsung dengan organisasi yang terlibat dalam advokasi kesehatan mental, pengembangan profesional, dan reformasi kebijakan. Responden tidak dipilih berdasarkan label diagnostik atau afiliasi kelembagaan, tetapi melalui partisipasi sukarela dan kepedulian bersama terhadap tema-tema yang dibahas. Banyak dari mereka yang sudah memiliki hubungan dengan peneliti melalui pengaturan kerja lapangan, pengajaran klinis, proyek bersama, atau acara publik, sementara yang lain masuk ke dalam penelitian ini melalui rujukan bola salju dan jaringan transnasional yang didedikasikan untuk mengurangi pemaksaan dan meningkatkan hak-hak pengguna.

Untuk memastikan validitas ilmiah, semua tanggapan dianonimkan dan dikumpulkan dengan persetujuan tertulis untuk digunakan dalam penelitian. Persetujuan etis telah diperoleh sebelumnya, dan semua protokol mengikuti standar universitas dan nasional untuk penelitian partisipatoris dan penelitian dengan populasi yang rentan. Data yang dihasilkan menjadi sasaran triangulasi sistematis, mengikuti logika yang ditetapkan dalam Bab 2.3. Pola-pola divalidasi melalui konvergensi, divergensi, kontradiksi, atau keheningan yang nyata, dengan memperhatikan asimetri struktural dan perbedaan kekuatan epistemik. Triangulasi terjadi tidak hanya di antara kelompok responden tetapi juga antara survei, observasi lapangan, kesaksian, dan analisis hukum. Tema-tema yang diangkat oleh responden survei sering kali digaungkan dalam percakapan informal, wawancara formal, atau dokumen institusional yang dikumpulkan selama penelitian lapangan etnografi.

Integrasi data survei dengan praktik-praktik kerja lapangan yang lebih luas bukan merupakan langkah analitis tambahan, tetapi merupakan bagian yang melekat dalam proses penelitian. Banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam survei juga hadir dalam observasi partisipan, termasuk lokakarya akademis, sesi pelatihan klinis, perkumpulan aktivis, konferensi internasional, dan pertemuan reformasi kelembagaan. Sebagian lainnya adalah informan kunci, kolaborator, atau mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini dalam waktu yang lama. Sebaliknya, survei-survei tersebut juga menghasilkan kontak-kontak baru dan ungkapan-ungkapan ketertarikan yang menjadi masukan bagi penelitian lapangan, advokasi kebijakan, dan proses-proses pendidikan bersama yang sedang berlangsung yang terkait dengan disertasi. Pergerakan refleksif dan melingkar antara penyelidikan, kesaksian, dan keterlibatan sistemik ini merupakan salah satu kekuatan inti dari metodologi ini dan menggarisbawahi orientasi emansipatoris penelitian ini secara keseluruhan. Bagian berikut ini akan menguraikan temuan-temuan yang ada, dimulai dengan dinamika pengalaman dan kelembagaan dari pemaksaan, seperti yang dilaporkan dan ditafsirkan oleh para responden di ketiga instrumen.

Bab ini menyajikan sintesis dari pola-pola yang paling menonjol yang diidentifikasi melalui survei terstruktur yang disebarkan di antara berbagai kelompok profesional kesehatan jiwa, pengguna, dan populasi campuran. Temuan-temuan ini mendukung pertanyaan-pertanyaan penelitian utama yang diidentifikasi di Bab 1 dan secara metodologis konsisten dengan arsitektur metode campuran yang dijelaskan di Bab 2. Data tersebut menegaskan persepsi yang meluas tentang kegagalan sistemik di seluruh domain pengambilan keputusan psikiatri, otonomi pasien, penggunaan obat, dan kepercayaan institusi. Peserta dari berbagai demografi melaporkan pengalaman pemaksaan, pengucilan epistemik, dan normalisasi ketergantungan farmakologis, sering kali tanpa adanya pertimbangan klinis yang transparan atau persetujuan.

Hasil penelitian ini tidak hanya berbicara tentang pertemuan klinis individu tetapi juga tentang kekurangan institusional dan pendidikan yang mengakar. Mereka mendokumentasikan keterputusan yang terus-menerus antara komitmen etis normatif dan realitas yang dijalani dalam sistem kesehatan mental, yang semakin diperparah oleh defisit dalam pendidikan publik, akuntabilitas hukum, dan praktik interdisipliner. Temuan-temuan ini membutuhkan respons ganda: rekonstruksi pedagogis untuk menyelaraskan pelatihan dengan model perawatan yang berbasis bukti dan berorientasi pada hak asasi manusia, dan reformasi hukum untuk memastikan perlindungan, transparansi, dan integritas ilmiah yang dapat ditegakkan. Seperti yang akan dibahas lebih lanjut di Bab 5 dan 6, data survei ini memberikan pembenaran penting untuk intervensi pendidikan dan legislatif yang dirancang untuk merestrukturisasi bidang kejiwaan sesuai dengan mandat konstitusional dan martabat manusia.

Tabel 30. Temuan-temuan empiris dan tanggapan pendidikan dan hukum-politik yang sesuai

Temuan survei	Pola sistemik yang dapat digeneralisasi	Tanggapan dari sisi pendidikan (bab 5)	Tanggapan hukum-politik (bab 6)
Tingginya prevalensi pemaksaan yang dilaporkan dalam diagnosis, pengobatan, dan rawat inap	Normalisasi praktik psikiatri paksa dan pengabaian perlindungan prosedural	Pelatihan perawatan berbasis trauma, pengambilan keputusan bersama, dan etika komunikasi	Mengesahkan mekanisme tinjauan independen dan perlindungan wajib untuk semua intervensi paksa Mengamankan akses pengobatan multimodal dalam sistem kesehatan masyarakat dan membatasi insentif untuk pengobatan eksklusif
Ketidakpuasan yang meluas terhadap model pengobatan farmakosentris	Ketergantungan sistemik pada obat sebagai lini pertama atau satu-satunya respons	Integrasi model metabolik, nutrisi, dan psikososial ke dalam kurikulum medis dan psikologi	Pengakuan hukum atas kapasitas pengambilan keputusan dan kerangka kerja otonomi, termasuk arahan sebelumnya
Ambivalensi atau pengunduran diri profesional terkait otonomi pengguna	Budaya kelembagaan menghambat partisipasi pengguna dan inklusi naratif	Penekanan kurikulum pada produksi perawatan bersama, pengobatan naratif, dan pendekatan dialog terbuka	Menyelaraskan hukum nasional dengan CRPD PBB dan memperkenalkan sanksi untuk pelanggaran hak dalam pengaturan klinis
Kesadaran atau penerapan standar hak asasi manusia internasional yang minim	Keterputusan antara komitmen hukum dan penerapan klinis	Mendidik para profesional tentang instrumen hukum, hukum disabilitas, dan mandat Konvensi PBB	Kewajiban hukum untuk mendokumentasikan, melaporkan, dan meninjau bahaya yang terkait dengan intervensi kejiwaan
Pelaporan yang kurang atau penyangkalan terhadap efek samping dan trauma yang terkait dengan perawatan psikiatri	Penindasan epistemik terhadap narasi pasien dan bahaya pasca-intervensi	Pelatihan dalam penilaian kritis terhadap literatur psikiatri dan hasil pengobatan jangka panjang	Penciptaan mekanisme pengaduan, peninjauan, dan restitusi independen yang terkait dengan sistem kesehatan dan peradilan
Persepsi umum tentang impunitas struktural dan kurangnya mekanisme akuntabilitas	Tidak adanya struktur pengawasan yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik yang berbahaya atau lalai	Pendidikan etika yang berfokus pada desain kelembagaan, transparansi, dan tanggung jawab kolektif	Dukungan kebijakan dan pendanaan untuk program kesehatan jiwa masyarakat yang bersifat non-koersif
Minimnya pengetahuan tentang alternatif non-koersif di antara pengguna dan profesional	Kurangnya penyebaran model non-koersif yang ada dan praktik-praktik komunitas	Kampanye pendidikan publik dan profesional tentang alternatif selain pemaksaan	

3.3 Pemaksaan yang dipersepsikan dan kekerasan institusional

Data survei yang dikumpulkan dari para pengguna dan penyintas psikiatri mengungkapkan pola yang konsisten dan sangat meresahkan tentang pemaksaan yang dirasakan di semua tahap intervensi psikiatri. Mayoritas responden melaporkan pernah mengalami pengobatan paksa, pengekangan fisik atau kimiawi, pengasingan, dan rawat inap paksa, seringkali tanpa alasan yang jelas, dokumentasi hukum, atau saluran yang dapat diakses untuk mengajukan banding. Praktik-praktik ini tidak digambarkan sebagai sesuatu yang terisolasi atau luar biasa, tetapi sebagai sesuatu yang mendasar dalam pengalaman mereka dengan sistem kejiwaan. Pengobatan paksa, terutama melalui suntikan jangka panjang, disebut sebagai salah satu peristiwa paling traumatis, yang sering kali diberikan dalam kondisi ketakutan, kebingungan, atau ancaman yang eksplisit. Responden sering menyatakan bahwa mereka tidak diberitahu tentang tujuan, dosis, atau risiko zat yang diberikan, dan bahwa penolakan disamakan dengan kurangnya wawasan atau gangguan oposisi, daripada dihormati sebagai hak otonomi tubuh. Pengasingan dan pengekangan mekanis digambarkan sebagai hal yang merendahkan dan tidak manusiawi, dengan partisipan yang menceritakan episode di mana mereka diisolasi selama berjam-jam atau sehari-hari tanpa penjelasan, pendampingan terapeutik, atau tinjauan pasca insiden. Dalam beberapa kasus, pengguna melaporkan telah mengalami tindakan ini berulang kali, tanpa ada alternatif yang berarti yang diusulkan, atau pembekalan yang dilakukan setelahnya.

Tabel 31. Dinamika sistemik berbasis survei dan rekomendasi struktural

Ringkasan dinamika negatif	Kata kunci pertanyaan penelitian	Wawasan empiris	Usulan struktural positif dari tesis (bab 5-6)
Prosedur yang secara rutin tidak mengikutsertakan suara pasien, mengabaikan otonomi	Otonomi, Pengambilan keputusan	Pengambilan keputusan bersama tidak ada di sebagian besar konteks perawatan, meskipun ada relevansi hukum dan etisnya	Mewajibkan pelatihan pengambilan keputusan bersama dalam pendidikan klinis dan memastikan pelaksanaannya melalui audit independen
Obat yang digunakan secara paksa, merusak perawatan yang etis	Persetujuan, Keamanan	Responden sering melaporkan bahwa mereka diberi obat tanpa persetujuan atau penjelasan alternatif	Memperkenalkan protokol persetujuan yang berbasis trauma dan berkelanjutan yang merinci pilihan dan risiko
Asimetri kekuasaan membungkam pengalaman dan kekhawatiran pasien	Martabat, Partisipasi	Individu merasa diabaikan, tidak didengar, dan dikontrol oleh para profesional	Menanamkan struktur penasihat pasien dan mekanisme ombudsman di institusi psikiatri
Risiko tidak terpantau, dengan hasil yang berbahaya dikaburkan	Bahaya Obat, Transparansi	Efek samping tidak dilaporkan atau disangkal, tanpa adanya dukungan tapering	Membentuk layanan penghentian penggunaan obat secara nasional yang terintegrasi ke dalam layanan psikiatri dan layanan primer
Perawatan psikiatri mencerminkan logika penghukuman, bukan dukungan penyembuhan	Rasa hormat, Non-kekejaman	Responden menggambarkan lingkungan perawatan yang kekanak-kanakan atau represif	Mempromosikan budaya terapeutik yang didasarkan pada pemulihan dan kerangka kerja hak asasi manusia
Praktik reduksionis mengabaikan kompleksitas sosio-biologis	Faktor Penentu Sosial, Nutrisi	Faktor-faktor struktural dan gaya hidup jarang dibahas, memperkuat model farmakosentris	Mengintegrasikan nutrisi, riwayat trauma, dan konteks sosial ke dalam penilaian psikiatri standar
Kegagalan sistemik dalam menyediakan perawatan lanjutan dan individual	Inovasi, Kesenjangan	Model perawatan yang berbasis trauma, personal, atau integratif sebagian besar tidak tersedia	Memperluas akses ke model perawatan individual melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan
Kelambanan kelembagaan mengesampingkan kemajuan ilmiah	Praktik Berbasis Bukti, Etika	Pendekatan baru ditolak atau tidak dikenal dalam praktik klinis	Menerjemahkan kemajuan ilmiah ke dalam kebijakan dan memperbarui pedoman klinis yang sesuai
Suara dan perlawanan dihukum, memperkuat penaklukan	Akuntabilitas, Hak	Pasien yang melaporkan masalah menghadapi eskalasi, pembalasan, atau diagnosis ulang	Menegakkan perlindungan secara hukum terhadap suara yang berbeda pendapat dan melarang tanggapan yang bersifat memaksa

Sintesis wawasan yang berasal dari survei yang menyoroti perbedaan kritis antara pengalaman hidup dan praktik psikiatri yang etis. Setiap dinamika yang diamati dipasangkan dengan rekomendasi tesis yang sesuai, yang dikembangkan sebagai respons terhadap bukti empiris dan diselaraskan dengan pertanyaan penelitian yang lebih luas dari disertasi. Kolom sebelah kanan menyajikan tindakan sistemik positif yang diusulkan dalam Bab 5 dan 6 untuk memperbaiki kegagalan institusional yang teridentifikasi.

Dampak psikologis dari intervensi ini digambarkan sebagai dampak yang bertahan lama dan parah. Para peserta menceritakan pengalaman ketakutan, ketidakberdayaan, penghinaan, dan ketidakpercayaan yang berkepanjangan terhadap dokter dan institusi. Banyak yang menggambarkan lingkungan psikiatri bukan sebagai tempat penyembuhan, tetapi sebagai ruang yang kejam, yang terstruktur di sekitar kontrol, pengawasan, dan hukuman. Pemaksaan dialami sebagai sesuatu yang bersifat epistemik dan juga fisik: banyak responden melaporkan bahwa upaya mereka untuk

menjelaskan kesusahan mereka, menolak pengobatan, atau mengajukan perspektif alternatif secara sistematis didiskreditkan, sering kali dipatologikan sebagai gejala penyakit. Pembatalan diskursif ini memperparah trauma pemaksaan fisik, karena individu tidak hanya tidak diberi kendali atas tubuh mereka tetapi juga pengakuan atas pembuatan makna mereka. Kurangnya upaya hukum atau akuntabilitas institusional memperburuk rasa kerentanan, dengan responden yang menyatakan bahwa mereka sering tidak memiliki jalan keluar atau perlindungan, bahkan dalam menghadapi apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran hak-hak dasar. Banyak yang melaporkan bahwa keluhan mereka diabaikan, staf bersikap meremehkan, dan mekanisme peradilan, jika ada, diserahkan kepada otoritas medis tanpa pemeriksaan independen. Kesaksian-kesaksian ini sejalan dengan kritik yang lebih luas terhadap impunitas psikiatri dan menandakan adanya krisis legitimasi di dalam sistem.

Data dari para profesional kesehatan jiwa mengkonfirmasi, dari dalam sistem, bahwa pemaksaan tidak hanya terjadi tetapi secara struktural tertanam dalam perawatan psikiatri rutin. Sebagian besar responden profesional mengakui bahwa perawatan paksa diterapkan secara teratur, seringkali tanpa ambang batas hukum yang jelas atau pertimbangan etika yang kuat. Meskipun beberapa orang menganggap intervensi ini diperlukan dalam kondisi yang ekstrem, banyak yang menyatakan ketidaknyamanan dan ketidaksesuaian etis, dengan alasan bahwa pemaksaan sering kali muncul bukan karena kebutuhan terapeutik, melainkan karena kegagalan sistemik. Secara khusus, para profesional menyoroti kombinasi tekanan struktural, waktu yang tidak mencukupi, staf yang terbatas, kurangnya alternatif krisis, dan budaya kelembagaan, sebagai pendorong utama praktik pemaksaan. Ketidakmampuan untuk memberikan perawatan relasional yang berkelanjutan atau untuk bernegosiasi secara bermakna dengan individu yang tertekan digambarkan bukan sebagai defisit pribadi tetapi sebagai kendala sistemik. Beberapa responden mengakui bahwa keputusan untuk memberikan obat secara paksa atau melakukan pasung dibuat dalam kondisi ambiguitas dan kelelahan, seringkali dengan sedikit keyakinan bahwa tindakan tersebut adalah demi kepentingan terbaik pasien.

Ambiguitas hukum berulang kali disebut sebagai faktor yang memperparah. Para profesional melaporkan ketidakpastian tentang persyaratan hukum yang tepat untuk intervensi paksa, dan menggambarkan bagaimana protokol institusional sering beroperasi secara paralel dengan, atau dengan mengabaikan, kerangka kerja hukum formal. Banyak yang mengindikasikan bahwa ketakutan akan disalahkan jika terjadi kejadian buruk di masa depan, seperti bunuh diri, kekerasan, atau pengaduan masyarakat, memainkan peran penting dalam mengarahkan keputusan ke arah pemaksaan. Logika defleksi risiko ini, yang tertanam dalam praktik kelembagaan yang defensif, menyebabkan pemaksaan dilakukan secara pre-emptive atau berlebihan, terutama jika tidak ada alternatif yang jelas. Beberapa profesional menggambarkan bagaimana harapan untuk mengendalikan perilaku, daripada mengatasi penderitaan, menghasilkan ketergantungan yang berlebihan pada penahanan farmakologis dan pemisahan fisik, terutama di unit-unit akut. Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya pengawasan reflektif, ruang musyawarah etis, atau infrastruktur yang berbasis trauma, sehingga membuat banyak tenaga profesional mengambil keputusan secara terpisah. Hasilnya adalah budaya di mana pemaksaan dinormalisasi, perlawanan internal ditekan, dan disonansi etika diperlakukan sebagai hal yang tak terelakkan, bukan sebagai sinyal untuk reformasi.

Responden yang menduduki peran campuran atau ganda, seperti penyintas-profesional, pekerja dukungan sebaya, atau dokter kritis, memberikan perspektif yang sangat terbuka. Posisi mereka yang berada di persimpangan antara praktik institusional dan pengalaman hidup memungkinkan mereka untuk mengartikulasikan secara tajam berbagai macam bahaya pemaksaan. Banyak dari mereka yang memasuki bidang kesehatan jiwa karena pengalaman pribadi mereka sendiri yang mengalami perawatan paksa, didorong oleh niat untuk mengubah sistem dari dalam. Kesaksian mereka menunjukkan kepekaan etis yang tinggi dan pemahaman yang mendalam tentang tekanan sistemik yang menghambat reformasi. Beberapa dari mereka melaporkan bahwa mereka merasa terlibat dalam praktik-praktik yang pernah mereka alami, dengan mengutip ekspektasi peran dan kelembaman institusional sebagai penghalang untuk menyediakan alternatif yang layak. Beberapa lainnya menggambarkan adanya ketegangan permanen antara norma-norma profesional dan kejelasan etika, termasuk tuntutan implisit atau terang-terangan untuk memperkuat logika manajemen risiko dan menekan divergensi dari jalur pengobatan yang telah ditetapkan.

Temuan ini mendukung hipotesis tesis bahwa kebijaksanaan klinis sering kali dilakukan dalam lingkungan yang dipaksakan secara struktural, bukan sebagai pertimbangan etis yang bebas. Namun demikian, kelompok responden yang sama ini memberikan pandangan sekilas tentang kemungkinan transformasi sistemik. Beberapa mengusulkan desain struktur insentif yang tidak berorientasi pada penahanan gejala, tetapi pada pemulihan yang berkelanjutan dan reintegrasi fungsional. Di antara ide-ide baru yang dilaporkan adalah konsep kemitraan publik-profesional yang dimodelkan secara longgar berdasarkan insentif berbasis kinerja, di mana dokter atau tim akan diberi penghargaan dengan sumber daya yang dihemat oleh negara ketika pasien yang sebelumnya berada di bawah perawatan paksaan mencapai stabilitas yang kuat dan bebas dari pengobatan. Dalam kerangka kerja ini, 'hadiah' yang diberikan adalah pengurangan biaya yang terukur untuk sistem kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, seringkali ribuan euro per bulan, yang dicapai melalui perawatan yang efektif, sukarela, dan berpusat pada pasien. Pembungkai ini membalikkan lintasan konvensional prestise karir dan alokasi sumber daya, tidak lagi terikat pada kronisitas dan ketergantungan tetapi pada hasil dalam otonomi yang dipulihkan dan mengurangi bahaya.

Para peserta menekankan bahwa pergeseran seperti itu seharusnya tidak mengaburkan ketidakadilan struktural yang saat ini membuat deprivasi itu sendiri menjadi prasyarat untuk mengakses dukungan. Beberapa responden mengindikasikan bahwa diagnosis psikiatri terkadang menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan perumahan, tunjangan disabilitas, atau bantuan material, terutama di bawah rezim penghematan. Sembari menyerukan reformasi sosio-ekonomi yang lebih dalam, mereka juga bersikeras bahwa tidak ada sistem tunjangan yang bergantung pada kelanggengan penyakit atau kepatuhan yang dipaksakan sebagai kriteria kelayakan. Kesehatan, yang dipahami sebagai kemampuan untuk hidup secara mandiri dan berkontribusi secara bermakna, harus dipisahkan dari logika pengawasan dan dibingkai sebagai barang publik. Para peserta mengusulkan program percontohan yang menggabungkan perumahan, dukungan nutrisi, sumber daya pendidikan, dan kesempatan pengembangan profesional bagi pengguna layanan yang ingin keluar dari sistem kejiwaan. Usulan tersebut selaras dengan seruan yang lebih luas untuk melakukan studi longitudinal berdasarkan persetujuan dan kehendak bebas yang tulus, yang menargetkan kasus-kasus awal dan kompleks tanpa diskriminasi atau pengunduran diri. Tidak ada kelompok yang boleh dikecualikan

dari lintasan pemulihan berdasarkan tingkat keparahan, usia, atau kategori diagnostik. Cakrawala etisnya jelas: tidak ada profesi yang boleh menggantungkan eksistensinya pada kelanggengan penderitaan, dan tidak ada negara yang boleh memperlakukan keputusan sebagai hasil yang dapat diterima dari desain sistemik.

Laporan-laporan dengan peran ganda ini juga merupakan salah satu yang paling rinci dalam mendokumentasikan efek epistemik dari pemaksaan. Mereka menekankan bagaimana otoritas diagnostik digunakan untuk mendiskreditkan perbedaan pendapat, bagaimana persetujuan secara rutin dirusak, dan bagaimana legitimasi institusional dipertahankan melalui penyangkalan atau minimalisasi bahaya. Beberapa mencatat tidak adanya struktur formal bagi para profesional untuk melaporkan atau menentang praktik-praktik pemaksaan tanpa risiko pembalasan atau kerusakan karier. Para responden ini menyoroti bagaimana paksaan sistemik beroperasi tidak hanya pada pasien tetapi juga pada dokter, melalui pengekangan peran, penekanan emosional, dan normalisasi kompromi etis. Dengan demikian, mereka mengungkap dimensi kritis dari kekerasan struktural dalam psikiatri: produksi pelepasan moral sebagai norma profesional. Banyak yang menyatakan bahwa perubahan yang berarti tidak mungkin muncul dari dalam institusi yang terisolasi dan menyerukan aliansi transdisipliner, inisiatif yang dipimpin oleh pengguna, dan mekanisme akuntabilitas eksternal. Narasi mereka juga menunjukkan pentingnya terapi dan politik untuk mengingat pengalaman sendiri, melawan amnesia institusional, dan memulihkan kejernihan etika melalui refleksi bersama dan tindakan terkoordinasi.

Analisis triangulasi dari ketiga survei ini mengungkapkan bahwa pemaksaan bukanlah sebuah pengecualian dalam sistem kejiwaan, melainkan sebuah fitur yang dinormalisasi dan dirutinkan dalam struktur, budaya, dan wacana mereka. Di seluruh kelompok responden, intervensi koersif, pengobatan paksa, pengasingan, pengekangan fisik, dan rawat inap paksa, digambarkan sebagai hal yang umum, disetujui secara institusional, dan sering kali dilakukan tanpa persetujuan yang berarti, komunikasi yang transparan, atau pertanggungjawaban pascakejadian. Data menunjukkan bahwa meskipun para profesional sering kali menyadari keterbatasan etis dan klinis dari praktik-praktik ini, mereka tetap dibatasi secara struktural oleh tekanan sistemik, kelangkaan sumber daya, kerangka hukum yang ambigu, dan logika kelembagaan yang defensif. Pembungkaman moral dari pemaksaan berbeda secara mencolok di antara kelompok-kelompok: para profesional sering menyebutnya sebagai bentuk keamanan atau penahanan yang diperlukan, sementara pengguna dan penyintas-profesional mencirikannya sebagai bahaya yang dapat dihindari, trauma, dan kekerasan institusional. Perlu dicatat, sekitar setengah dari responden survei terakhir meminta agar tanggapan mereka tidak disebarkan, meskipun dibuat anonim, secara eksplisit. Ketakutan adalah komponen kunci dari keadaan saat ini, seperti yang disaksikan selama penelitian lapangan, oleh sebagian besar atau bahkan semua pelaku yang tidak melakukan kekerasan, karena pembalasan dengan konsekuensi yang keras adalah hal yang biasa terjadi.

Tabel 32. Praktik-praktik pemaksaan yang dilaporkan, pembenaran institusional, dan pembungkai pengalaman di seluruh kelompok responden

Praktik pemaksaan	Pengguna dan penyintas	Profesional	Responden dengan peran campuran
Pengobatan paksa	Meluas, digambarkan sebagai hal yang traumatis, merendahkan martabat, tidak dijelaskan dengan baik, dan sering kali menggunakan suntikan jangka panjang	Dilaporkan sering terjadi, dinormalisasi secara institusional, digunakan di bawah tekanan dan ketakutan akan pertanggungjawaban	Digambarkan sebagai hal yang tidak perlu dalam banyak kasus, terkait dengan trauma, digunakan untuk menekan perbedaan pendapat
Pengasingan dan isolasi	Dianggap sebagai hukuman, digunakan untuk membungkam atau mengintimidasi, tanpa dukungan terapi	Dianggap sebagai pilihan terakhir, namun sering digunakan jika tidak ada alternatif lain atau kapasitas staf	Diakui sebagai tindakan yang menimbulkan trauma, sering kali tidak ditinjau ulang, tanpa fungsi restoratif
Pengekangan mekanis	Diingat dengan rasa tertekan, dianggap sebagai tindakan kasar, sering kali tidak dicatat atau dibenarkan secara post hoc	Dilaporkan dengan enggan, dipandang sebagai hal yang terkadang tidak dapat dihindari, tetapi secara emosional membebani	Dianggap tidak dapat dipertahankan secara etis kecuali jika ada situasi yang mengancam jiwa
Rawat inap secara paksa	Digambarkan sebagai pelanggaran, terutama ketika berkepanjangan atau berulang, sering dikaitkan dengan penyalahgunaan diagnostik	Dianggap perlu untuk penahanan atau stabilisasi, tetapi dengan sedikit dukungan tindak lanjut	Diidentifikasi sebagai pengganti sistemik untuk perawatan sosial dan kesinambungan hubungan yang tidak ada
Kurangnya persetujuan atas dasar informasi	Sistemik, terutama terkait diagnosis, pengobatan, dan risiko; persetujuan sering kali dipaksakan atau bersifat simbolis	Diakui sebagai masalah, sering kali terkendala oleh waktu, kebingungan hukum, dan hirarki profesional	Ditekankan sebagai inti dari kekerasan institusional dan hilangnya legitimasi naratif
Patologisasi perlawanan	Sering dilaporkan; ketidaksepakatan dibingkai ulang sebagai penyakit, yang mengarah pada lebih banyak pemaksaan	Tidak secara langsung ditangani oleh sebagian besar orang, meskipun beberapa profesional mengakui pembungkai ketidakpatuhan secara diagnostik	Disebut sebagai mekanisme utama pembungkai dan pembenaran intervensi yang berbahaya

Tabel ini mensintesis praktik-praktik pemaksaan utama yang didokumentasikan melalui tanggapan survei, menyoroti perbedaan persepsi di antara kelompok pengguna, profesional, dan kelompok dengan peran campuran. Tabel ini memperlihatkan normalisasi struktural pemaksaan dan kesenjangan antara pembenaran institusional dan pengalaman yang merugikan, memberikan landasan empiris untuk analisis normatif yang dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Secara diskursif, pemaksaan dibenarkan melalui himbauan untuk kepatuhan, pengurangan risiko, dan objektivitas klinis. Dalam praktiknya, hal ini berfungsi sebagai mekanisme pendisiplinan yang tertanam dalam rutinitas birokrasi, ekspektasi profesional, dan hirarki epistemik. Legitimasi narasi

pengguna sering kali ditolak, terutama ketika penolakan atau kritik dipatologikan sebagai kurangnya wawasan. Suasana yang dihasilkan adalah suasana di mana konflik etis tidak hanya dibungkam tetapi juga diantisipasi secara struktural. Perbedaan dalam pembingkai moral dan institusional ini akan dibahas secara lebih mendalam di Bab 6, di mana dimensi hukum dari pemaksaan, ketiadaan prosedural, dan kontradiksi normatif akan ditelaah. Bab 6 akan mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana perlindungan hukum yang ada sering kali dilewati atau dibuat tidak efektif oleh budaya institusional yang seharusnya diatur, dan bagaimana wacana perawatan digunakan untuk melegitimasi tindakan yang tidak dapat ditoleransi dalam domain kesehatan lainnya.

Bagian ini membangun landasan empiris untuk kritik hukum dan etika terhadap psikiatri yang tidak mengurangi bahaya pada kesalahan individu, tetapi menempatkannya dalam asimetri kekuasaan, akses, dan pengakuan yang sistemik. Penelitian ini juga menegaskan perlunya pendefinisian ulang tanggung jawab psikiatri berdasarkan etika dialogis, otonomi pengguna, dan akuntabilitas struktural. Temuan-temuan yang disajikan di sini akan menginformasikan analisis selanjutnya mengenai keruntuhan etika (Bab 4), kegagalan hukum (Bab 6), dan desain ulang kelembagaan yang diusulkan melalui infrastruktur EU BEACON (Bab 7), di mana sistem umpan balik partisipatoris, perlindungan berbasis hak, dan alternatif berbasis masyarakat diartikulasikan sebagai bagian dari strategi transformasi yang lebih luas.

3.4 Kendala Etis dan Disonansi Klinis

Bagian ini menyajikan sintesis dari kekhawatiran etis yang berulang yang disuarakan oleh para pengguna dan profesional, menggarisbawahi ketidaksesuaian struktural antara standar etis dan hukum yang dinyatakan dan praktik psikiatri yang dijalani di Spanyol. Bukti yang dikumpulkan melalui survei ketiga, yang berfokus pada pengambilan keputusan bersama dan manajemen pengobatan, mengungkapkan pola disonansi antara wacana institusional dan realitas operasional. Disonansi ini tidak bersifat anekdot, tetapi sistemik, dan merupakan faktor penting dalam melanggengkan bahaya, kelelahan profesional, dan trauma ulang pengguna.

Para profesional kesehatan mental berulang kali menggambarkan bentuk tekanan etis yang didasarkan pada kontradiksi antara penilaian klinis mereka dan mandat yang dibebankan oleh protokol institusional. Responden merinci pengalaman tekanan untuk menyesuaikan diri dengan paradigma farmakologis yang tidak sepenuhnya mereka setujui, dipaksa untuk melakukan pengekangan atau mempertahankan pasien di bawah perawatan paksa meskipun ada kemungkinan klinis alternatif, dan budaya institusional yang tidak mendukung diskusi terbuka atau perbedaan pendapat formal. Kurangnya mekanisme terstruktur untuk eskalasi etis atau penolakan, dikombinasikan dengan insentif administratif yang memprioritaskan penghindaran risiko di atas otonomi pasien, berkontribusi pada rasa kelelahan moral dan isolasi profesional. Beberapa peserta mengindikasikan bahwa pendekatan non-koersif, bahkan ketika didukung oleh bukti ilmiah dan preferensi pengguna, secara institusional dihukum atau tidak mungkin dilakukan secara logistik.

Dari perspektif pengguna layanan dan penyintas, lingkungan yang sama menghasilkan kekosongan epistemik dan relasional. Banyak yang menggambarkan pengalaman gaslighting, ketidakpercayaan,

dan pembatalan narasi sebagai hal yang rutin terjadi di dalam sistem kejiwaan. Alih-alih dilibatkan sebagai orang yang memiliki wawasan tentang penderitaan mereka sendiri, mereka sering diperlakukan sebagai orang yang tidak kredibel atau dimusuhi, terutama ketika menyuarakan keprihatinan tentang efek pengobatan, riwayat trauma, atau kerangka kerja terapi alternatif. Efek kumulatif dari interaksi semacam itu bukan hanya ketidakpuasan terhadap layanan kesehatan, tetapi juga rasa pengkhianatan yang mendalam terhadap sistem yang diamanatkan untuk melindungi dan mendukung. Para pengguna melaporkan bahwa mereka tidak diberi pilihan untuk memilih, dibungkam dalam pertemuan klinis, atau dipatologi karena menolak pengobatan yang memperparah trauma sebelumnya dan memperkuat siklus keputusan, ketakutan, dan penghindaran institusional.

Yang penting, baik para profesional maupun pengguna menyatu dalam penilaian mereka terhadap standar hukum dan etika yang pada dasarnya terputus dari realitas klinis. Banyak yang menyebutkan bahwa kode etik dan kerangka hukum hanya ada di atas kertas, dengan sedikit atau tidak ada penegakan praktis atau komitmen kelembagaan. Persepsi ini tidak terbatas pada kasus-kasus individual tetapi diartikulasikan sebagai kondisi struktural di mana norma-norma persetujuan, otonomi, dan pengurangan risiko ditangguhkan demi kepentingan birokrasi dan minimalisasi risiko. Wacana etis, ketika dikutip dalam kebijakan resmi atau pedoman klinis, dianggap kurang sebagai prinsip panduan daripada sebagai perangkat retorika yang terpisah dari praktik sehari-hari.

Konvergensi perspektif ini, dari dalam dan luar sistem, menegaskan diagnostik yang lebih luas yang diusulkan dalam disertasi ini: bahwa psikiatri di Spanyol beroperasi dalam konteks impunitas etis, di mana norma-norma secara selektif digunakan dan jarang ditegakkan. Temuan-temuan dalam bagian ini selaras dengan pengamatan lapangan yang didokumentasikan dalam Bab 4, di mana pengkhianatan institusional, ketidakabsahan kesaksian, dan ketidakjelasan prosedural teramati secara langsung. Disonansi klinis dan etika yang dijelaskan di sini tidak hanya memvalidasi penelitian lapangan, tetapi juga menandakan perlunya pergeseran paradigma tentang bagaimana perawatan kejiwaan diorganisir, diatur, dan dievaluasi secara etis. Bagian ini mempersiapkan landasan analitis untuk Bab 5, di mana mekanisme penyimpangan diskursif dan keterlibatan klinis akan diperiksa secara rinci, terutama yang berkaitan dengan normalisasi pemaksaan, erosi agensi profesional, dan perampasan simbolis bahasa etis untuk mempertahankan struktur yang kejam. Dalam konteks psikiatri Spanyol dan struktur institusionalnya yang lebih luas, kesaksian para profesional di berbagai survei dan pertemuan di lapangan menyatu dalam sebuah pola tekanan etis yang terus-menerus. Para praktisi ini menggambarkan ketegangan sistemik antara penilaian klinis mereka dan mandat paksaan yang tertanam dalam rutinitas institusional. Banyak dari mereka yang mengaku dipaksa untuk meresepkan obat atau menerapkan pengekangan mekanis yang bertentangan dengan penilaian mereka yang lebih baik, terutama dalam kasus-kasus di mana intervensi psikososial dianggap lebih tepat namun secara kelembagaan tidak tersedia. Pengalaman dipaksa untuk bertindak bertentangan dengan kompas etis seseorang dilaporkan sebagai sumber penderitaan kronis, yang menumbuhkan rasa cedera moral dan keterlibatan yang mendalam. Para profesional mengindikasikan bahwa kemampuan mereka untuk mengekspresikan perbedaan pendapat atau memberlakukan mode perawatan alternatif dibatasi secara tajam oleh hierarki organisasi, protokol manajemen risiko, dan ketakutan medis-hukum. Beberapa orang melaporkan bahwa mereka tidak diperbolehkan atau secara eksplisit ditegur karena mempertanyakan paradigma perawatan yang dominan, bahkan dalam kasus-kasus di mana

bahaya dapat diperkirakan atau sudah nyata. Penindasan institusional terhadap pertimbangan etis ini menghasilkan apa yang disebut oleh para responden sebagai pembungkaman etis, suatu keadaan di mana tindakan memperhatikan atau mempertanyakan bahaya menjadi berbahaya secara profesional. Tidak adanya jalur yang transparan untuk eskalasi etis atau mekanisme pelaporan internal memperkuat persepsi bahwa keselamatan pasien dan hati nurani praktisi berada di bawah kemanfaatan birokrasi dan pembelaan medikolegal.

Banyak dokter menggambarkan pengalaman isolasi profesional tidak hanya bersifat sosial tetapi juga epistemik. Tekanan untuk mematuhi konvensi diagnostik, rejimen pengobatan, dan protokol darurat sering kali membuat mereka tidak memiliki ruang untuk merefleksikan secara kritis keputusan klinis atau terlibat dalam dialog tentang alternatif perawatan. Isolasi ini diperparah dengan kelelahan, terutama di antara mereka yang memasuki profesi ini dengan orientasi etika yang kuat atau perspektif kesehatan masyarakat. Mereka menggambarkan pekerjaan sehari-hari mereka bukan sebagai penyembuhan tetapi sebagai bertahan dalam sistem yang menormalkan paksaan dan menyamakan perbedaan pendapat dengan ketidakmampuan atau ketidaksetiaan. Secara khusus, beberapa responden mengindikasikan bahwa kelelahan diperburuk bukan oleh penderitaan pasien, tetapi oleh hambatan institusional untuk melakukan apa yang mereka tahu akan membantu. Ketidakmampuan untuk mengurangi pengobatan, mendorong praktik dialogis, atau menggabungkan perawatan berbasis trauma menjadi sumber keputusan profesional yang terus-menerus. Keputusan ini disertai dengan perasaan pengkhianatan yang mendalam, terutama di antara mereka yang melihat diri mereka bekerja di bidang yang seolah-olah didedikasikan untuk perawatan, martabat, dan pemulihan. Kontradiksi antara misi dan praktik menjadi tidak dapat ditoleransi, membuat beberapa orang mempertimbangkan untuk keluar dari profesi ini sepenuhnya atau mengurangi peran mereka menjadi fungsi administratif atau konsultatif untuk meminimalkan paparan etika.

Dari sudut pandang pengguna dan penyintas, rasa pengkhianatan yang dilaporkan oleh para profesional tercermin, tetapi dengan konsekuensi yang jauh lebih buruk. Di ketiga survei dan laporan etnografis, individu yang didiagnosis dengan kondisi kejiwaan menggambarkan pengalaman gaslighting, ketidakpercayaan, dan pembatalan epistemik yang jauh melampaui pertemuan klinis. Narasi mereka secara konsisten mendokumentasikan bagaimana para pelaku institusional, termasuk psikiater, pekerja sosial, dan bahkan advokat pasien, secara rutin mengabaikan cerita orang pertama tentang penderitaan, trauma, atau perbedaan pendapat sebagai gejala penyakit. Kekerasan interpretatif ini mengubah makna menjadi patologi dan mendiskualifikasi orang tersebut untuk menceritakan pengalamannya sendiri. Tidak adanya alternatif dari model perawatan medis yang dominan membuat banyak pengguna terjebak dalam siklus pengobatan paksa, eskalasi diagnostik, dan penahanan paksa, dengan sedikit atau tidak ada akses terhadap ganti rugi hukum atau struktur pendukung untuk penarikan, penafsiran ulang, atau pemulihan.

Para pengguna secara konsisten mengartikulasikan kekosongan etis dari lingkungan psikiatri sebagai bentuk pengkhianatan struktural. Pengkhianatan ini tidak terbatas pada dokter secara individu atau kejadian-kejadian yang terisolasi, tetapi lebih kepada seluruh sistem perawatan. Beberapa responden menjelaskan bahwa mereka diberi obat tanpa persetujuan, tidak diberi informasi tentang perawatan mereka, atau dipaksa dirawat di rumah sakit berdasarkan laporan yang tidak dapat diverifikasi atau tekanan keluarga. Bahkan ketika layanan mengklaim mematuhi prinsip-prinsip pengambilan

keputusan bersama, pengguna sering kali mendapati diri mereka menjadi sasaran pemaksaan halus atau dikucilkan dari dialog yang bermakna. Lembaga-lembaga yang seharusnya menyediakan perawatan justru menjadi tempat yang menimbulkan ketakutan, trauma, dan kematian sosial. Terutama di antara pengguna yang memiliki latar belakang rasial, gender yang tidak sesuai, dan pengguna yang secara ekonomi tidak stabil, perasaan dibuang atau ditinggalkan secara institusional muncul sebagai tema yang sering muncul. Pertemuan berulang dengan pengabaian, kesalahan diagnosis, dan ketidakpedulian menanamkan rasa takut yang terus-menerus untuk berbicara, mengingat risiko pemaksaan lebih lanjut atau pembalasan diagnostik. Beberapa kesaksian menceritakan situasi di mana permintaan untuk pendapat kedua atau perawatan alternatif dipatologiskan sebagai gejala paranoia atau ketidakpatuhan, yang secara efektif meniadakan jalan lain untuk mendapatkan keadilan atau martabat.

Terlepas dari peran dan pengalaman mereka yang berbeda, pengguna dan profesional menyatukan kekecewaan yang sama terhadap kerangka kerja hukum dan etika yang ada. Kedua kelompok melaporkan bahwa instrumen berbasis hak, kode etik profesional, dan protokol institusional yang dimaksudkan untuk melindungi martabat diabaikan atau digunakan sebagai senjata untuk menegakkan praktik-praktik pemaksaan. Para profesional mencatat ketidakefektifan sistem pengaduan, kurangnya perlindungan bagi pelapor, dan penyaringan administratif atas masalah etika sebelum mereka dapat mencapai tinjauan independen. Para pengguna, secara paralel, menggambarkan bagaimana saluran formal untuk mengekspresikan perbedaan pendapat atau melaporkan penyalahgunaan secara sistematis dirusak, baik oleh kebingungan birokrasi atau dengan penafsiran ulang klinis protes sebagai gejala. Perwakilan hukum sering kali tidak dapat diakses atau kurang mendapat informasi, dan komite etika internal dipandang sebagai perpanjangan tangan dari institusi yang dituduh melakukan kesalahan. Apa yang muncul bukan hanya kegagalan implementasi tetapi juga kontradiksi struktural: sistem yang mengaku etis tetapi tidak memungkinkan adanya perlawanan etis yang berarti secara kelembagaan.

Tabel 33. Akun-akun konvergen tentang disonansi etis dalam praktik kejiwaan

Domain	Profesional	Pengguna dan penyintas	Bukti lapangan dan dokumenter
Tekanan moral	Ditekan untuk menerapkan tindakan pemaksaan yang bertentangan dengan penilaian etis mereka	Digambarkan menjadi sasaran tindakan tanpa alasan terapeutik yang dirasakan	Dokumen internal mengungkapkan prioritas protokol di atas kebijaksanaan klinis
Mekanisme pembungkaman	Ketakutan akan pembalasan atas perbedaan pendapat atau advokasi	Pengalaman gaslighting, ketidakpercayaan, dan klasifikasi ulang sebagai tidak patuh	Catatan dan rekaman yang bersifat memaksa yang digunakan untuk mendahului atau melemahkan pengaduan di masa depan
Kurangnya jalur	Tidak ada jalur yang aman untuk menyampaikan masalah etika	Dilaporkan tidak ada tempat untuk mengajukan banding terhadap perlakuan atau label yang dipaksakan	Kebijakan institusi sering kali tidak jelas, dengan komite etika yang bertindak sebagai pengesah dan bukan peninjau independen
Isolasi dan kelelahan	Kelelahan emosional karena ketidakmampuan untuk berpraktik secara etis	Keterasingan jangka panjang dari layanan karena kerugian atau ketidakpercayaan sebelumnya	Wawancara mengungkap tingginya angka putus sekolah dan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga perawatan
Kekecewaan	Menyatakan bahwa etika dan hak hanya ada di atas kertas	Menganggap perlindungan hukum tidak ada artinya dalam praktiknya	Kesesuaian dengan tinjauan hukum yang menunjukkan kegagalan sistemik dalam penegakan hak
Panggilan untuk perubahan	Mengadvokasi mekanisme institusional untuk menolak, melaporkan, dan melakukan reformasi	Menyerukan pengobatan naratif, dialog terbuka, dan alternatif berbasis trauma	Tanggapan survei dan dokumen lapangan menegaskan keinginan untuk praktik perawatan yang dialogis dan sukarela

Konvergensi lintas peran tentang pelanggaran etika dalam konteks kejiwaan, mensintesis narasi profesional, kesaksian pengguna, dan bukti forensik berbasis lapangan. Tabel ini menggambarkan bahwa disonansi etis tertanam secara struktural, bukan kegagalan luar biasa dari aktor yang terisolasi.

Konvergensi ini mengkristal menjadi dakwaan yang lebih luas terhadap arsitektur etika sistem kejiwaan. Budaya ketakutan, penghindaran, dan perlindungan diri yang ada di antara para profesional memetakan secara langsung pada pengkhianatan institusional yang dialami oleh para pengguna. Keduanya tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya pelatihan, tetapi juga karena pilihan desain yang memprioritaskan kesinambungan administratif dan otoritas klinis daripada akuntabilitas relasional atau keadilan epistemik. Gagasan tentang etika di atas kertas muncul kembali dalam catatan penelitian lapangan, tanggapan survei, dan arsip testimoni. Para partisipan lintas peran menggambarkan disonansi yang nyata antara prinsip-prinsip yang diabadikan dalam dokumen kebijakan dan pengalaman sehari-hari dalam memberikan pelayanan sebagai pembungkaman, pemaksaan, atau pengabaian. Ketidakselarasan ini menimbulkan luka moral yang mendalam di antara para profesional yang beretika dan kerugian struktural yang mendalam bagi para pengguna. Seperti yang dinyatakan oleh beberapa kesaksian, seruan etika dapat terasa seperti bentuk kekerasan, ketika digunakan untuk mengaburkan atau membenarkan pelanggaran.

Analisis yang disajikan di sini memperkuat perancah teoretis inti dari tesis ini. Hal ini memvalidasi klaim bahwa kegagalan etis dalam psikiatri tidak disengaja, atau dapat direduksi menjadi malpraktek individu, tetapi tertanam dalam operasi struktural dan simbolis dari sistem. Hal ini mencakup dominasi epistemologis dari model biomedis, distribusi otoritas yang asimetris, dan penghapusan faktor penentu kontekstual, relasional, dan kultural dari tekanan. Temuan-temuan dari bagian ini juga memberikan dasar empiris untuk poros analisis Bab 5: dari menggambarkan pengalaman individu

tentang disonansi dan pengkhianatan hingga teori tentang logika institusional yang menopang kondisi tersebut. Kritik ini melampaui diagnosis atau intervensi spesifik untuk menginterogasi ekonomi moral dari perawatan kejiwaan dan mekanisme sistemik yang melindunginya dari akuntabilitas.

Koherensi antara apa yang digambarkan oleh pengguna dan profesional dan apa yang didokumentasikan secara independen melalui tinjauan kasus hukum, protokol klinis, dan memo internal menegaskan bahwa kesaksian-kesaksian tersebut bukanlah insiden-insiden yang terisolasi, melainkan elemen-elemen dari sebuah disfungsi yang lebih luas dan terpola. Istilah diagnostik yang sama, templat administratif, dan alur kerja institusional yang seharusnya dirancang untuk memastikan keselamatan dan perawatan berulang kali disebut sebagai mekanisme pembungkaman, pengucilan, dan trauma. Kontradiksi internal ini menjadi sumber krisis forensik: catatan resmi tidak dapat dipercaya untuk merefleksikan realitas perawatan psikiatri yang sebenarnya. Metodologi yang digunakan dalam tesis ini, yang didasarkan pada forensik hukum, triangulasi tematik, dan analisis refleksif, dirancang secara tepat untuk memulihkan kesaksian yang terhapus, membongkar narasi birokratis, dan memulihkan integritas pembuktian di mana dokumentasi resmi gagal. Konfirmasi silang dari temuan-temuan penelitian lapangan dengan berkas-berkas kasus yang dianonimkan, laporan medis, dan data survei tidak hanya memberikan kedalaman analisis tetapi juga beban pembuktian yang diperlukan untuk menunjukkan tanggung jawab institusi. Ketika klaim etis terbukti berbeda secara sistematis dari praktik, dan perbedaan ini direproduksi di berbagai tempat dan pelaku, dakwaan struktural menjadi tidak terhindarkan.

Bagian ini juga memperkuat implikasi hukum dari disonansi kejiwaan. Tidak adanya jalur yang berarti untuk perbedaan pendapat etis di dalam institusi, dikombinasikan dengan penggunaan kembali otoritas psikiatri untuk menetralkan atau menghukum protes, bukan hanya merupakan pelanggaran etika medis tetapi juga pelanggaran hak-hak konstitusional. Para profesional yang dipaksa untuk menerapkan rencana perawatan yang menurut mereka tidak dapat dipertahankan secara moral, dan para pengguna yang dilucuti haknya melalui reklasifikasi dan pembungkaman, keduanya merupakan korban dari sebuah sistem yang dirancang untuk mempertahankan kontrol dan bukannya memberikan perawatan. Implikasi untuk akuntabilitas kelembagaan sangat besar. Mereka tidak hanya menuntut reformasi kebijakan atau inisiatif pelatihan tetapi juga tinjauan yudisial, penyelidikan publik, dan disinvestasi struktural dari praktik-praktik yang melanggengkan bahaya dengan kedok otoritas terapeutik. Kegagalan etis, ketika disistematisasi, menjadi bentuk pelecehan institusional. Penamaan seperti itu bukanlah retorika yang berlebihan, tetapi merupakan prasyarat yang diperlukan untuk kejelasan ilmiah, hukum, dan etika.

Temuan-temuan ini berfungsi sebagai jembatan menuju pembedakan ulang konseptual yang diusulkan dalam Bab 5, di mana pengkhianatan tidak lagi diperlakukan sebagai penyimpangan tetapi sebagai logika konstitutif dari institusi kejiwaan yang saat ini beroperasi. Disonansi moral yang dialami oleh pengguna dan profesional bukanlah tanda keruntuhan atau disfungsi, tetapi merupakan indeks koherensi internal dalam sistem yang dibangun untuk mengelola populasi, mengamankan stabilitas kelembagaan, dan melindungi hirarki profesional. Untuk memahami logika ini, diperlukan pergeseran dari etika individu ke kritik struktural. Bab 5 akan membangun fondasi ini, mengartikulasikan bagaimana penyimpangan diskursif, penyitaan epistemik, dan keterlibatan klinis tidak berfungsi sebagai kegagalan niat tetapi sebagai operasi strategis dalam sistem kontrol biomedis.

Apa yang didokumentasikan oleh bagian ini sebagai penderitaan dan keheningan, bab selanjutnya akan berteori sebagai tata bahasa institusional pengkhianatan.

3.5 Kepercayaan, komunikasi, dan kerusakan relasional

Tanggapan survei dari pengguna dan penyintas memberikan gambaran yang jelas tentang kegagalan relasional dalam perawatan kejiwaan. Di sebagian besar narasi, kepercayaan tidak digambarkan sebagai rusak atau rapuh, tetapi secara struktural tidak ada sejak awal. Responden secara konsisten melaporkan bahwa mereka tidak diberitahu tentang diagnosis mereka dengan cara yang berarti, dan bahwa penjelasan mengenai rencana perawatan, efek farmakologis, atau alternatif yang memungkinkan tidak lengkap, disampaikan secara paksa, atau dihilangkan sama sekali. Banyak yang menggambarkan bahwa percakapan tentang perawatan terjadi tanpa kehadiran mereka, dan ketika mereka hadir, masukan mereka diminimalkan atau diabaikan secara aktif. Persetujuan tidak dialami sebagai sesuatu yang dialogis tetapi sebagai sesuatu yang performatif, yang diambil di bawah ancaman, pembiusan, atau tekanan institusi. Para responden berulang kali menekankan bahwa alih-alih dilibatkan sebagai orang yang berada dalam krisis atau membutuhkan dukungan relasional, mereka justru diperlakukan sebagai kasus administratif yang harus dikelola, ditenangkan, atau distabilkan. Dinamika ini menghasilkan apa yang digambarkan oleh banyak orang sebagai rasa dehumanisasi yang mendalam, dengan beberapa orang secara eksplisit membandingkan pertemuan psikiatri dengan pengaturan disipliner atau pembantaian, di mana otoritas tidak dipertanyakan dan dialog dianggap tidak mungkin.

Tidak adanya dialog relasional tidak terbatas pada domain diagnostik atau farmakologis. Para responden melaporkan bahwa dunia emosional, sejarah pribadi, atau makna eksistensial dari kesusahan yang mereka alami jarang dieksplorasi atau divalidasi. Beberapa orang menceritakan bahwa upaya mereka untuk menggambarkan trauma, pengucilan sosial, dinamika keluarga, atau penderitaan struktural diabaikan atau dipatologiskan. Bahkan ketika narasi diundang, narasi-narasi tersebut sering kali dikodekan ulang ke dalam kelompok gejala atau deskriptor diagnostik yang tidak memiliki kemiripan dengan makna yang dimaksudkan oleh pembicara. Kerusakan epistemik dari pengalaman ini mengikis dasar-dasar kepercayaan, tidak hanya dalam hubungan klinis langsung tetapi juga dalam legitimasi yang lebih luas dari perawatan kejiwaan. Efek kumulatifnya tidak hanya berupa pelepasan hubungan, tetapi juga apa yang disebut oleh beberapa responden sebagai hilangnya suara, agensi naratif, dan status kewarganegaraan. Ini bukan hanya kegagalan empati, tetapi juga desain institusional dan etika komunikatif. Hal ini merupakan bentuk kekerasan simbolik dengan konsekuensi psikologis dan sosial yang terukur, termasuk melepaskan diri dari layanan, ketakutan jangka panjang untuk mencari bantuan, dan persepsi bahwa psikiatri adalah institusi yang menghukum daripada restoratif.

Responden profesional menggemakan banyak dari kekhawatiran ini, meskipun dari posisi struktural mereka yang ditugaskan untuk memberikan perawatan di bawah kendala sistemik. Sejumlah besar responden mengakui bahwa konfigurasi layanan psikiatri saat ini sangat membatasi kemungkinan untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan relasional. Keterbatasan waktu, pergantian

pasien yang tinggi, rutinitas institusional yang kaku, dan adanya protokol pemaksaan yang terus menerus diidentifikasi sebagai hambatan utama. Beberapa dokter melaporkan bahwa bahkan ketika termotivasi untuk menawarkan keterlibatan dialogis atau perawatan holistik, mereka secara rutin dicegah untuk melakukannya oleh tuntutan institusional untuk efisiensi, dokumentasi risiko, dan intervensi farmakologis. Banyak yang menggambarkan budaya tempat kerja di mana kompetensi relasional diremehkan atau secara aktif dihalangi, dan di mana ketiadaan waktu untuk berdialog dianggap sebagai hal yang biasa dan bukan sebagai tantangan. Dalam kondisi akut atau darurat, para dokter melaporkan bahwa mereka hanya diberi waktu beberapa menit untuk menilai, mendiagnosis, dan bertindak, sering kali dengan ekspektasi implisit untuk memprioritaskan pengobatan dan stabilisasi daripada hubungan atau pemahaman.

Salah satu tema yang paling sering muncul adalah pengaruh yang meluas dari praktik defensif. Para profesional menggambarkan kecenderungan institusional yang berkembang untuk bertindak dengan cara-cara yang meminimalkan risiko pertanggungjawaban daripada mengoptimalkan aliansi terapeutik. Hal ini termasuk menghindari percakapan yang sulit, menahan ketidakpastian prognosis, atau melakukan pengobatan dini terhadap pasien yang dianggap tidak dapat diprediksi. Keluhan tidak dianggap sebagai peluang untuk berkembang atau akuntabilitas, melainkan sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup profesional. Para responden menggambarkan iklim kecurigaan dan sikap defensif prosedural yang tidak hanya menjauhkan mereka dari pengguna tetapi juga dari satu sama lain, karena kepercayaan interdisipliner juga terganggu. Lingkungan ini mengikis rasa orientasi etis mereka sendiri, membuat banyak orang melaporkan kelelahan, ketidakterlibatan emosional, dan sinisme yang semakin meningkat terhadap kemungkinan perawatan kejiwaan yang bermakna. Beberapa profesional mengakui bahwa meskipun mereka menyadari bahaya dari praktik-praktik ini, mereka merasa secara struktural terhalang untuk melakukan intervensi yang berbeda, baik karena kelembaman institusional atau kurangnya dukungan kolegal. Dalam konteks ini, kepercayaan digambarkan tidak hanya sulit untuk ditumbuhkan, tetapi juga hampir tidak mungkin untuk dipertahankan.

Tabel 34. Manifestasi kerusakan relasional dan erosi kepercayaan dalam praktik kejiwaan

Domain	Pengguna/penyintas	Profesional	Pola-pola bersama
Praktik komunikasi	Tidak diberitahu tentang diagnosis, rencana perawatan, atau risiko	Keterbatasan waktu menghalangi percakapan yang bermakna	Komunikasi sering kali searah, dirutinkan, atau tidak ada
Kepercayaan dalam hubungan klinis	Melaporkan merasa diatur, diberhentikan, atau dipaksa	Melaporkan ketidakmampuan untuk membangun kepercayaan karena tuntutan sistemik	Kepercayaan dirusak oleh prioritas institusi di atas hubungan antar manusia
Persetujuan dan partisipasi	Digambarkan sebagai simbolis atau paksaan, jarang diinformasikan	Dilakukan di bawah tekanan administratif, ambiguitas hukum	Persetujuan bersifat prosedural, tidak dialogis atau memberdayakan
Iklim etis	Dianggap sebagai hukuman dan pembungkaman	Digambarkan sebagai mengisolasi, berorientasi pada pertahanan, lumpuh secara etis	Etika dianggap nominal, dipisahkan dari praktik sehari-hari
Konsekuensi emosional	Kehilangan suara, trauma, pelepasan diri dalam jangka panjang dari layanan	Kelelahan, tekanan moral, pengunduran diri	Erosi emosional dan moral di seluruh sistem
Pendorong struktural	Narasi diabaikan, perawatan terfragmentasi	Beban birokrasi yang berlebihan, protokol pemaksaan yang kaku	Desain struktural yang tidak sesuai dengan kepedulian relasional

Tabel ini menguraikan akun-akun yang menyatu tentang keretakan hubungan dalam psikiatri seperti yang dilaporkan oleh pengguna/penyintas dan profesional. Setiap baris menyajikan dimensi spesifik domain dari rusaknya kepercayaan, yang menunjukkan asal-usul sistemik dan konsekuensi bersama di seluruh kesenjangan posisi.

Analisis komparatif dari tanggapan pengguna dan profesional menunjukkan bahwa erosi kepercayaan bukan hanya masalah kegagalan interpersonal, tetapi juga merupakan fitur sistemik dari institusi psikiatri. Kedua kelompok menunjukkan kondisi struktural yang secara aktif menghambat perkembangan saling pengertian, tanggung jawab bersama, dan kepedulian dialogis. Kepercayaan, dalam konteks ini, tidak hanya tidak ada, tetapi juga secara institusional tidak memungkinkan. Kekosongan relasional yang digambarkan oleh pengguna, sebagai salah satu yang diperlakukan sebagai subjek pasif yang harus dikelola, mencerminkan rasa frustrasi yang dialami oleh para profesional karena ketidakmampuan mereka untuk memberikan perawatan yang berpusat pada hubungan. Alih-alih beroperasi sebagai ruang untuk saling mendengarkan, psikiatri digambarkan sebagai aparat birokrasi yang diatur oleh prosedur, penghindaran tanggung jawab, dan kelangkaan sumber daya. Dalam kerangka kerja ini, komunikasi menjadi searah, dibentuk oleh tuntutan dokumentasi, penilaian risiko, dan standardisasi farmakologis. Bahasa itu sendiri sering kali dilucuti dari fungsi terapeutik dan etisnya, direduksi menjadi klasifikasi diagnostik atau naskah persetujuan yang lebih banyak mengaburkan daripada memperjelas.

Yang penting, konvergensi dalam akun meluas ke konsekuensi etis dari kerusakan komunikatif ini. Para pengguna secara konsisten melaporkan bahwa kurangnya keterlibatan relasional mengubah pertemuan psikiatri menjadi pengalaman traumatis yang menghilangkan otonomi dan harapan mereka. Para profesional, pada gilirannya, mengungkapkan bahwa ketidakmungkinan mempertahankan dialog yang tulus mengarah pada tekanan moral, kelelahan emosional, dan disorientasi etika. Yang muncul adalah pengakuan bersama bahwa kepercayaan tidak dapat dipulihkan melalui tindakan-tindakan individu yang beritikad baik atau reformasi teknis. Hal ini

membutuhkan konfigurasi ulang struktural perawatan yang menjadikan waktu, kontinuitas, keterlibatan naratif, dan akuntabilitas timbal balik sebagai inti dari praktik kejiwaan. Beberapa responden dari berbagai peran mengartikulasikan kebutuhan akan waktu yang terlindungi, beban kasus yang lebih kecil, pengawasan etis, dan kerangka kerja dialogis yang mampu memulihkan fondasi relasional perawatan. Namun, sebagian besar menekankan bahwa kebutuhan-kebutuhan ini masih belum terpenuhi, dan bahwa reformasi kelembagaan, ketika diusulkan, sering kali hanya bersifat kosmetik atau diarahkan pada efisiensi administratif dan bukannya pada transformasi etika.

Temuan yang disajikan di sini mengungkap krisis kepercayaan yang sistemik yang meluas di luar pengaturan klinis ke dalam domain hukum, etika, dan kewarganegaraan. Ketiadaan komunikasi yang transparan, persetujuan yang diinformasikan, dan perawatan relasional yang terus-menerus mencerminkan tidak hanya ketidakmampuan institusional tetapi juga kekosongan prosedural yang lebih dalam. Kekosongan ini tidak hanya bersifat regulatif tetapi juga epistemik: hal ini menandakan runtuhnya norma-norma yang seharusnya menopang legitimasi, akuntabilitas, dan praktik berbasis hak. Kesaksian dari para pengguna dan profesional menunjukkan bahwa psikiatri, seperti yang saat ini diorganisir, berfungsi dalam keadaan pengecualian permanen di mana perlindungan yang dikodifikasikan dalam hukum ditangguhkan dalam praktiknya. Keselarasan dengan apa yang akan dibahas di Bab 6 sebagai rezim impunitas administratif memposisikan rusaknya kepercayaan sebagai gejala sekaligus pembangkit kekerasan struktural. Implikasi hukumnya sangat besar: tanpa mekanisme untuk memastikan pemahaman bersama, keterlibatan dialogis, dan persetujuan yang tulus, prinsip-prinsip hukum dasar seperti otonomi, martabat, dan proporsionalitas menjadi tidak efektif.

Erosi kepercayaan ini tidak hanya merusak hasil terapi, tetapi juga partisipasi demokratis dalam desain dan tata kelola sistem kesehatan jiwa. Ketika individu dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada aktor kelembagaan, mereka tidak mau berdialog dan mundur dari proses yang dapat menghasilkan perubahan. Sebaliknya, ketika para profesional merasa tidak mampu bertindak secara etis tanpa risiko sanksi, mereka kehilangan kapasitas mereka untuk bertindak sebagai agen moral di dalam sistem. Membangun kembali kepercayaan bukanlah perbaikan interpersonal, melainkan tugas struktural: hal ini menuntut adanya jaminan prosedural, tata kelola yang partisipatif, mekanisme ganti rugi yang transparan, dan perlindungan bagi pengguna dan praktisi yang bertindak dengan itikad baik. Penelitian aksi yang disajikan di sini mulai memetakan jalan tersebut, namun masukan lebih lanjut dapat memperkaya bagian ini.

3.6 Pengambilan keputusan bersama dan otonomi pengobatan

Analisis tanggapan dari ketiga survei mengungkapkan adanya keretakan mendasar antara cita-cita etis pengambilan keputusan bersama dan realitas klinis dan institusional yang menghalanginya. Dari sudut pandang pengguna dan penyintas, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai pengobatan psikiatri tidak hanya tidak ada, tetapi juga secara struktural ditiadakan. Para responden menjelaskan bahwa mereka diberi resep obat psikotropika tanpa penjelasan yang memadai, alternatif, atau informasi yang jelas mengenai efek samping, implikasi jangka panjang, atau pilihan tapering. Banyak yang menekankan bahwa pengobatan dibingkai sebagai sesuatu yang tidak dapat

dinegosiasikan, sering kali diberikan pada saat-saat krisis atau ketergantungan institusional, dan jarang sekali ditinjau kembali dengan dialog kolaboratif yang tulus. Pengalaman menjalani pengobatan farmakologis sering kali digambarkan dalam bahasa yang terkait dengan trauma, kehilangan hak, dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.

Temuan ini konsisten dengan pengamatan lapangan dan dokumentasi sebelumnya dalam disertasi ini mengenai asimetri epistemik yang tertanam dalam pertemuan psikiatri. Tindakan pemberian resep, jauh dari sikap klinis yang netral, dianggap oleh banyak pengguna sebagai lokus pemaksaan, pembungkaman, dan kerentanan struktural. Keinginan untuk otonomi diekspresikan bukan sebagai penolakan terhadap pengobatan itu sendiri, tetapi sebagai permintaan untuk jalur yang terinformasi, dialogis, dan dapat dibalik. Hal ini termasuk hak untuk menolak, menarik diri secara bertahap dan aman, dan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk perawatan alternatif atau komplementer. Responden secara konsisten menuntut protokol yang jelas untuk tapering, penilaian individual, dan pengakuan atas pengetahuan pengalaman dalam manajemen pengobatan. Ketiadaan struktur dan perlindungan semacam itu membuat informed consent menjadi ilusi dan pengambilan keputusan bersama hanya menjadi cita-cita nominal tanpa dasar yang kuat.

Para profesional yang disurvei menyatakan dukungan yang luas terhadap prinsip-prinsip pengambilan keputusan bersama dan otonomi pengguna secara teori, dan sering kali menyebutnya sebagai standar emas untuk perawatan psikiatri yang etis. Namun, tanggapan mereka menunjukkan ketidakmampuan yang meluas untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam batasan kerangka kerja kelembagaan yang ada. Banyak yang melaporkan bahwa norma-norma organisasi dan lingkungan yang menghindari risiko menghambat diskusi terbuka mengenai pilihan pengobatan, terutama dalam hal tapering, alternatif non-farmakologis, atau strategi yang dipimpin oleh pengguna. Disinsentif struktural terdiri dari beberapa hal: tidak adanya protokol yang divalidasi untuk tapering, rasa takut akan disalahkan jika terjadi kekambuhan, tekanan institusional untuk mengikuti pedoman standar, dan kurangnya dukungan terhadap penyimpangan etis dari praktik yang dominan. Kendala-kendala ini mengakibatkan pembungkaman sistemik terhadap agensi pengguna dan penilaian profesional. Meskipun para klinisi mungkin ingin menawarkan alternatif atau terlibat dalam percakapan yang lebih dalam, mereka sering kali tidak dapat melakukannya karena pembatasan waktu, ketidakjelasan hukum, beban administratif, dan budaya hirarkis di banyak layanan psikiatri. Dalam beberapa kasus, para profesional mengungkapkan bahwa upaya untuk mengusulkan penghentian bertahap atau perencanaan farmakologis bersama dipenuhi dengan tekanan disiplin atau dikesampingkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Dengan demikian, pengambilan keputusan bersama terhambat bukan karena kurangnya komitmen etis, tetapi oleh arsitektur kelembagaan yang menekan perawatan dialogis demi efisiensi, kepatuhan, dan manajemen risiko.

Survei ini juga mengungkapkan bahwa para profesional yang bekerja di luar sistem publik, dalam pengaturan berbasis komunitas atau dialogis, merasa relatif lebih diberdayakan untuk mengeksplorasi pilihan pengobatan secara kolaboratif. Namun, kasus-kasus ini merupakan pengecualian dan sering kali bergantung pada jaringan pribadi, protokol non-standar, atau akomodasi informal. Keragaman tersebut menggarisbawahi perlunya desain ulang sistemik daripada inovasi yang terisolasi, dan menempatkan reformasi kelembagaan sebagai prasyarat untuk implementasi pengambilan keputusan bersama yang bermakna dalam konteks kejiwaan.

Tabel 35. Hambatan dan faktor pendukung yang dilaporkan untuk manajemen pengobatan bersama

Kategori	Hambatan struktural yang teridentifikasi	Wawasan profesional	Tuntutan dan prioritas pengguna
Persetujuan dan informasi	Kurangnya penjelasan, proses persetujuan yang terburu-buru	Waktu dan protokol komunikasi yang tidak memadai	Dialog yang terinformasi, transparan, dan berdasarkan trauma
Tapering dan alternatif	Tidak ada protokol untuk penarikan yang aman, takut disalahkan	Penghindaran risiko, ketidakpercayaan diri secara institusional	Hak untuk mengurangi, mengganti, atau menolak pengobatan
Perlindungan hukum dan etika	Perlindungan hukum yang tidak jelas, pengesampingan administratif	Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan praktik-praktik yang dominan	Hak yang jelas untuk menolak dan tidak patuh
Norma-norma budaya	Sistem yang berorientasi pada kepatuhan, membungkam perbedaan pendapat	Isolasi ketika mempromosikan perawatan yang dipimpin oleh pengguna	Pengakuan atas pengalaman dan pilihan hidup
Pelatihan dan kompetensi	Tidak adanya pengetahuan yang meruncing dalam pendidikan	Profesional merasa tidak siap dan tidak didukung	Pendidikan yang dipimpin oleh pengguna dan integrasi dukungan sebagai

Sintesis ringkasan dari hambatan struktural, dilema profesional, dan tuntutan pengguna terkait pengambilan keputusan bersama dalam manajemen pengobatan psikiatri, seperti yang dilaporkan di semua kelompok survei. Hal ini menyoroti ketidakselarasan sistemik antara cita-cita etis dan praktik institusional, memetakan bagaimana norma-norma yang memaksa dan infrastruktur yang kurang memadai menghalangi persetujuan, dukungan yang meruncing, dan otonomi pengguna. Wawasan ini membangun landasan empiris untuk proposal hukum dan struktural berikutnya yang diuraikan dalam Bab 6 dan 7.

Yang paling menarik adalah tanggapan dari individu-individu yang menduduki posisi hibrida, seperti penyintas-profesional atau praktisi yang memiliki pengalaman langsung dengan paksaan psikiatri. Para responden ini menawarkan sudut pandang ganda, yang secara bersamaan tertanam dalam praktik klinis dan didasarkan pada pengetahuan berdasarkan pengalaman. Kesaksian mereka mengungkapkan kekurangan yang mendalam dalam pelatihan farmakologis dan praktik persetujuan, terutama pengabaian narasi pasien yang terus-menerus dan kurangnya kompetensi praktis dalam memandu penghentian atau penyesuaian dosis sesuai dengan preferensi pengguna. Beberapa menyoroti kontradiksi antara pelatihan profesional mereka, yang menekankan kepatuhan terhadap norma-norma institusional, dan sejarah pribadi mereka, yang mengajarkan mereka tentang bahaya yang dapat ditimbulkan ketika individu tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait tubuh dan pikiran mereka sendiri.

Suara-suara ini juga menggambarkan beban tambahan karena dianggap sebagai tersangka atau bias ideologis di kalangan profesional karena advokasi mereka untuk hak-hak pengguna. Mereka sering menghadapi perlawanan ketika mencoba menerapkan atau mempromosikan manajemen pengobatan bersama, meskipun mereka memiliki kesadaran yang mendalam tentang perlunya hal tersebut.

Pengetahuan yang mereka miliki tidak hanya diabaikan, tetapi terkadang juga diberi sanksi, yang semakin menggambarkan kekakuan disiplin dari institusi psikiatri arus utama. Namun demikian, para responden ini secara konsisten mengadvokasi mekanisme dukungan struktural yang memungkinkan perencanaan pengobatan individual, perawatan berdasarkan trauma, dan pengakuan formal atas keahlian berdasarkan pengalaman sebagai sumber yang sah untuk wawasan klinis dan etika.

Konvergensi lintas peran ini mengarah pada konsensus yang muncul: bahwa pengambilan keputusan farmakologis harus direlokasi dari monopoli profesional ke wilayah kolaboratif, di mana bentuk pengetahuan yang beragam dihormati dan dilindungi. Ketegangan antara cita-cita dan praktik, etika dan institusi, muncul bukan dari nilai-nilai yang bertentangan di antara para pemangku kepentingan, tetapi dari pengaturan sistemik yang menetralkan agensi moral dan menekan pluralisme. Dengan demikian, tanggapan yang beragam berfungsi sebagai diagnosis dan kesaksian, yang menegaskan bahwa kapasitas untuk pengambilan keputusan bersama ada di dalam diri individu tetapi tetap terhalang oleh struktur tata kelola kejiwaan saat ini.

Sintesis dari semua kelompok responden dengan jelas menegaskan kebutuhan dan kelayakan transisi menuju manajemen pengobatan bersama yang sesungguhnya. Hal ini bukanlah masalah preferensi yang terisolasi atau situasi yang luar biasa, tetapi merupakan mandat struktural yang berasal dari pola yang konsisten di seluruh peran, wilayah, dan posisi kelembagaan. Para responden mengartikulasikan kebutuhan akan informasi yang transparan dan dapat diakses tentang obat-obatan psikotropika, implementasi sistematis dari protokol pengurangan penggunaan (*tapering*), pengenalan efek jangka panjang dan sindrom putus obat, serta integrasi formal dari pendekatan alternatif dan pendekatan berbasis masyarakat. Meskipun terdapat kesepakatan yang luas mengenai poin-poin ini, tidak ada kelompok responden yang mengidentifikasi adanya sistem yang berfungsi dengan baik di mana elemen-elemen tersebut dapat dipastikan. Kesenjangan antara kerangka kerja normatif dan infrastruktur material masih sangat lebar dan merusak. Oleh karena itu, bagian ini berhubungan langsung dengan Bab 6, di mana analisis hukum akan mengungkap ketiadaan perlindungan yang dapat ditegakkan untuk penolakan atas dasar informasi, kurangnya kejelasan yurisprudensi tentang pemaksaan pengobatan, dan erosi hak-hak konstitusional di bawah praktik kejiwaan administratif. Demikian pula, bab ini mempersiapkan dasar untuk Bab 7, yang menguraikan proposal inisiatif BEACON Uni Eropa untuk implementasi sistemik: protokol etika, modul pelatihan, alat akses terbuka, dan infrastruktur partisipatif yang memusatkan pengambilan keputusan pengobatan dalam perawatan, bukan kepatuhan. Konvergensi dalam bab ini tidaklah abstrak, ini adalah inti empiris yang melegitimasi desain ulang layanan psikiatri di sepanjang garis martabat, otonomi, dan keamanan.

Temuan-temuan ini memperkuat bahwa tindakan meresepkan obat tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sangat etis, sosial, dan politis. Temuan-temuan ini mendukung pendefinisian ulang tindakan terapeutik sebagai tindakan yang harus dimulai dengan dialog dan persetujuan, bukan dengan otoritas dan ketakutan. Mengembalikan hak asasi manusia dalam praktik kejiwaan dimulai dari struktur yang mendukungnya, dan penelitian ini menunjukkan bahwa struktur tersebut belum ada, tetapi harus ada, harus ada, dan kita semua bertanggung jawab untuk memastikannya, karena jika tidak, banyak nyawa yang akan melayang.

3.7 Kendala struktural dan pengkhianatan kelembagaan

Benang merah yang muncul dari tanggapan para profesional dan penyintas adalah persepsi bahwa lingkungan institusional di bidang psikiatri tidak hanya disfungsional, tetapi juga secara aktif memusuhi pertanggungjawaban, perbedaan pendapat, dan pemulihan. Di antara para profesional, banyak yang mengungkapkan bahwa keheningan telah menjadi syarat untuk bertahan hidup dalam lingkungan kerja mereka. Kritik etis, proposal inovatif, atau bahkan kepatuhan terhadap praktik berbasis hak sering kali dihadapi dengan kecurigaan, isolasi, atau konsekuensi disipliner. Budaya ketakutan ini, yang terinternalisasi dan direproduksi di semua tingkatan, berfungsi sebagai peredam sistemik, menggeser tanggung jawab kepada individu sekaligus melindungi institusi dari pengawasan.

Para responden menggambarkan bagaimana keterlibatan rutin ditegakkan tidak hanya melalui sanksi langsung, tetapi juga melalui mekanisme struktural yang memberikan penghargaan atas konformitas dan menghukum refleksi kritis. Para profesional yang mencoba untuk berbicara tentang pengobatan yang berlebihan, pemaksaan, atau pengabaian suara pengguna sering kali mendapati diri mereka tanpa dukungan kelembagaan, perlindungan hukum, atau dukungan dari rekan sejawat. Bahkan di dalam komite etik atau ruang pelatihan, responden melaporkan adanya normalisasi yang meluas terhadap prosedur pemaksaan dan suasana fatalisme yang berlaku: sebuah keyakinan bahwa perubahan tidak mungkin dilakukan atau berada di luar kewenangan mereka. Hasilnya adalah sebuah sistem yang menekan kondisi yang dibutuhkan untuk reformasi itu sendiri. Temuan utama yang mengganggu di seluruh tanggapan survei adalah kedalaman dan luasnya pengkhianatan institusional yang dirasakan oleh para profesional dan penyintas dalam sistem psikiatri. Para profesional berulang kali melaporkan bahwa masalah etika, termasuk keberatan terhadap praktik-praktik pemaksaan, tidak hanya diabaikan tetapi juga dihukum dengan berbagai cara yang implisit atau terang-terangan. Alih-alih beroperasi sebagai struktur pelindung yang menjunjung tinggi standar perawatan, institusi digambarkan sebagai penegak keheningan, memberi penghargaan pada konformitas, menghukum kritik, dan menumbuhkan budaya sensor diri yang meluas. Dalam situasi ini, mereka yang berusaha melawan atau mempertanyakan protokol yang dominan, terutama terkait pengobatan paksa, pengasingan, atau peminggiran perspektif pengguna, sering kali diasingkan secara profesional, dikucilkan dari ruang pengambilan keputusan, atau ancaman halus terhadap perkembangan karier mereka. Responden menggambarkan komite etika tidak ada atau hanya bersifat dekoratif, tidak memiliki kekuatan atau kemauan untuk mengintervensi kasus-kasus yang membahayakan. Normalisasi keterlibatan ini mengubah disfungsi struktural menjadi praktik rutin, mengurangi ruang untuk refleksi, pembelajaran, atau transformasi.

Para profesional yang paling terpengaruh oleh dinamika ini termasuk mereka yang bekerja di layanan garis depan di bawah tekanan waktu dan ketidakjelasan hukum, serta mereka yang dilatih dalam model dialogis, berbasis trauma, atau berbasis hak asasi manusia yang tidak memiliki pijakan institusional untuk mengimplementasikan praktik-praktik alternatif. Beberapa kejadian di mana rekan kerja dihalangi untuk bersaksi demi hak-hak pasien, di mana pelaporan pelanggaran dibalas dengan pembalasan birokratis, atau di mana kelalaian sistemik dibingkai ulang sebagai kegagalan individu. Budaya intimidasi ini tidak memerlukan ancaman eksplisit, namun direproduksi melalui kelalaian, ketidakhadiran, dan konsensus diam-diam bahwa suara-suara kritis tidak akan dilindungi. Akibatnya,

banyak profesional yang menganggap sistem ini cacat, atau setidaknya tidak dapat diperbaiki tanpa perombakan eksternal yang akan mengubah kerangka hukum, insentif kelembagaan, dan logika pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, data menunjukkan bahwa pengkhianatan institusional bukanlah konsekuensi dari kerusakan yang terisolasi, melainkan sebuah fitur sistemik: tindakan etis, ketika terjadi, cenderung luar biasa, tidak didukung, dan pada akhirnya tidak dapat dipertahankan dalam lingkungan saat ini. Temuan ini tidak hanya bersifat diagnostik, tetapi memiliki implikasi normatif. Hal ini menyiratkan bahwa perilaku etis dalam psikiatri seharusnya tidak diperlakukan sebagai kebajikan individu tetapi membutuhkan infrastruktur yang kolektif, dilindungi secara hukum, dan memiliki sumber daya institusional untuk bertahan dan berkembang. Tanpa dukungan struktural ini, biaya untuk bertindak secara etis menjadi tak tertahankan, bahkan mendorong para profesional yang berniat baik untuk terlibat. Kondisi seperti itu melemahkan legitimasi institusi psikiatri dan mengikis kepercayaan yang diperlukan untuk segala bentuk aliansi terapeutik yang ada. Tema-tema ini akan dikembangkan lebih lanjut pada bagian selanjutnya dan sangat penting untuk memahami hubungan antara desain sistemik dan tekanan moral yang dilaporkan secara luas oleh penyedia layanan dan penerima layanan.

Dari sudut pandang penyintas pengguna, pengalaman pengkhianatan bahkan lebih intim, langsung, dan merusak. Diagnosis itu sendiri sering kali menandai awal dari proses penghapusan, di mana orang tersebut dilucuti dari otoritas epistemik, kredibilitas, dan hak-haknya. Para responden menggambarkan bagaimana, setelah diberi label, cerita mereka tentang bahaya tidak lagi didengar, keberatan mereka dianggap sebagai gejala, dan kehadiran mereka di ruang-ruang institusional menjadi tergantung pada kepatuhan. Penghapusan ini tidak terbatas pada lingkungan perawatan, tetapi juga bergema melalui konteks hukum, keluarga, dan sosial, di mana label kejiwaan menjadi alat untuk mendiskualifikasi, pengawasan, dan pemaksaan. Salah satu tema yang berulang adalah ketidakmungkinan untuk mendapatkan pengakuan atau ganti rugi atas kekerasan di masa lalu. Banyak responden yang pernah mengalami rawat inap paksa, pengekangan dengan bahan kimia, atau penghinaan verbal di lingkungan klinis, namun melaporkan bahwa pengaduan mereka diabaikan atau tidak pernah didaftarkan secara resmi. Kurangnya mekanisme akuntabilitas fungsional digambarkan bukan sebagai pengawasan birokratis tetapi sebagai fitur struktural yang melindungi sistem dari tanggung jawab.

Tidak adanya jalur keadilan menciptakan kondisi kerentanan dan pencabutan hak yang kronis. Para penyintas menjelaskan bagaimana, dengan tidak adanya pengakuan institusional, dampak kekerasan psikis bertahan lama setelah peristiwa itu terjadi. Dampak-dampak ini tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga hukum dan sosial. Orang-orang berbicara tentang kehilangan hak asuh anak, dikucilkan dari kesempatan pendidikan atau pekerjaan, kesaksian mereka diabaikan di pengadilan atau evaluasi layanan. Sistem kejiwaan, mereka menekankan, tidak hanya gagal memulihkan, tetapi juga secara aktif menghasilkan pengucilan dan memperpanjang kerugian. Pengkhianatan struktural ini tidak hanya merusak prinsip perawatan, tetapi juga kontrak sosial yang lebih luas di mana lembaga-lembaga dianggap bertindak demi kepentingan publik. Ketika institusi merendahkan, alih-alih melindungi, orang-orang yang mereka klaim untuk layani, mereka kehilangan legitimasi etis dan sosial mereka.

Banyak penyintas pengguna melaporkan bahwa mereka tidak memiliki akses ke bentuk dukungan alternatif setelah keluar dari sistem. Jaringan komunitas, kelompok sebaya, atau ruang untuk trauma tidak tersedia, kekurangan dana, atau terisolasi dari layanan umum. Kekosongan ini membuat para penyintas tidak terlihat secara sosial, sementara lembaga-lembaga yang merugikan mereka tetap tidak tertandingi di depan umum. Beberapa orang yang berhasil mendokumentasikan atau berbicara menentang kondisi ini sering kali melakukannya dengan biaya pribadi yang besar, tanpa perlindungan kelembagaan atau hukum. Hasilnya adalah sebuah sirkuit tertutup di mana kerugian melahirkan keheningan, dan keheningan memungkinkan terjadinya pengulangan. Wawasan ini memperkuat kebutuhan untuk mengkonseptualisasikan pengkhianatan struktural bukan sebagai kerusakan dalam kasus-kasus yang terisolasi, tetapi sebagai pola sistemik yang membutuhkan pengakuan publik, reformasi kelembagaan, dan reparasi material. Dalam konteks ini, perlawanan tidak hanya menjadi sikap pribadi tetapi juga sebuah bentuk kelangsungan hidup epistemik. Implikasinya terhadap kritik hukum dan kebijakan transformatif sangat besar dan akan dibahas secara eksplisit dalam bab-bab berikutnya.

Di kedua kelompok responden, muncul pengakuan yang konsisten bahwa perbedaan pendapat secara aktif ditekan melalui mekanisme yang halus namun efektif untuk menjaga kelangsungan kelembagaan sekaligus mencegah pecahnya etika. Sistem ini mendisiplinkan bukan hanya melalui hukuman terbuka, tetapi dengan mereproduksi wacana di mana bahaya dibingkai ulang sebagai kepedulian, perbedaan pendapat sebagai patologi, dan keheningan sebagai profesionalisme. Para profesional menggambarkan bagaimana kepatuhan prosedural dan dokumentasi defensif menggantikan penilaian klinis yang bermakna. Mereka yang berusaha memperkenalkan praktik kolaboratif atau mengadvokasi perawatan yang dipimpin oleh pengguna dipinggirkan atau dianggap tidak kooperatif. Dalam beberapa kasus, mereka menghadapi teguran formal, tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan tim, atau dituduh membahayakan keselamatan. Dinamika semacam itu mencerminkan apa yang disebut oleh beberapa responden sebagai *institutional gaslighting*, sebuah bentuk distorsi epistemik yang merusak kompas moral agen dan kapasitas pengguna untuk menegaskan narasi mereka.

Fenomena ini, meskipun lebih terlihat oleh mereka yang terlatih secara profesional, tercermin dalam kesaksian para penyintas, terutama mereka yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam ruang-ruang institusional. Banyak yang menggambarkan tumbuhnya kesadaran bahwa sistem psikiatri kurang berfungsi sebagai tempat penyembuhan dibandingkan sebagai tempat penahanan disipliner, di mana pelestarian otoritas dan legitimasi lebih diutamakan daripada pemulihan martabat atau kesehatan. Para pengguna sering melaporkan bahwa mereka hanya diizinkan untuk berbicara dalam kerangka kerja yang telah ditentukan sebelumnya, dan bahwa bahasa institusional mendikte apa yang dianggap sebagai kebenaran. Dalam lingkungan seperti ini, bahkan tindakan melaporkan pelecehan atau meminta alternatif menjadi ancaman bagi tatanan kelembagaan. Para profesional yang menyuarakan keprihatinan seperti itu mendapati diri mereka sama rentannya, dengan beberapa di antaranya menggambarkan erosi bertahap terhadap kemampuan mereka untuk mempercayai sistem yang pernah mereka junjung tinggi.

Efek gabungannya adalah budaya pasrah, di mana tindakan etis menjadi genting dan tidak berkelanjutan. Perlawanan, jika ada, tidak didorong oleh sistem tetapi menentanginya, melalui aliansi

rekan kerja informal, advokasi anonim, atau melepaskan diri dari peran formal. Hal ini membuat kemungkinan transformasi sistemik semakin bergantung pada intervensi eksternal, mobilisasi kolektif, dan koalisi transdisipliner yang melampaui batas-batas kelembagaan saat ini. Dalam kerangka kerja ini, baik pengguna maupun profesional harus dikonseptualisasikan kembali bukan sebagai penerima pasif atau kritikus internal, tetapi sebagai aktor yang berperan dalam mendesain ulang struktur kesehatan jiwa. Oleh karena itu, bagian ini menjadi jembatan konseptual menuju bab berikutnya, yang mengeksplorasi resistensi dan penolakan tidak hanya sebagai gangguan, tetapi juga sebagai tindakan generatif dari agensi etis dan politis.

Di tengah lanskap pembungkaman institusional dan kegagalan struktural ini, beberapa contoh keberanian etis yang didokumentasikan dalam tanggapan survei mengungkapkan potensi dan kerentanan perlawanan yang terisolasi. Para profesional yang melaporkan bahwa mereka menantang protokol pemaksaan, terlibat dalam pengambilan keputusan bersama, atau menciptakan jaring pengaman informal bagi pengguna sering kali melakukannya tanpa dukungan, bimbingan, atau validasi kelembagaan. Tindakan-tindakan ini, meskipun dipuji oleh rekan-rekan sejawat dan para penyintas, hampir selalu dilakukan di pinggiran, tidak dilindungi oleh peraturan, tidak didukung oleh struktur organisasi, dan sering kali tidak terlihat oleh manajemen. Kerja etis yang diperlukan untuk mengatasi disfungsi sistemik dengan demikian secara tidak proporsional dilakukan oleh individu-individu yang berisiko mengalami kelelahan profesional dan emosional karena tidak adanya penguatan struktural.

Asimetri ini juga terlihat jelas dalam narasi para pengguna yang, melalui upaya pribadi yang luar biasa, merebut kembali hak mereka dan mengadvokasi perubahan sistemik. Para penyintas yang menjadi pendidik, pendukung sebaya, atau peneliti melaporkan bahwa mereka masih menghadapi stigma yang terus berlanjut bahkan setelah bertahun-tahun pulih dan berkontribusi. Wawasan mereka tentang kekerasan dan pengkhianatan lembaga-lembaga kejiwaan sering dianggap sebagai anekdot atau bias, meskipun didukung oleh data yang menyatu. Banyak yang menggambarkan bagaimana pengetahuan yang mereka miliki diterima dalam proyek partisipatoris hanya ketika dilucuti dari sisi kritisnya atau dipisahkan dari implikasi politik. Instrumentalisasi semacam itu mencerminkan pola ketidakadilan epistemik yang lebih luas, di mana kerangka kerja institusional secara selektif mengesahkan pengetahuan yang tidak mengancam legitimasi mereka.

Pengkhianatan struktural yang diekspos di sini bersifat multidimensi. Pengkhianatan ini dialami sebagai kegagalan perlindungan, penolakan pengakuan, dan pembungkaman kebenaran. Hal ini memperkuat asimetri kekuasaan dengan mendiskreditkan mereka yang paling siap untuk mengkritik sistem, sementara memberikan penghargaan atas keterlibatan dan loyalitas institusional. Mekanisme ini tidak hanya mencegah perbaikan, tetapi juga melanggengkan kerusakan melalui pengucilan, penyembunyian, dan hukuman bagi mereka yang berbeda pendapat. Dalam konfigurasi ini, tindakan etis menjadi tak terucapkan secara struktural, kecuali melalui perpecahan. Bab selanjutnya akan membahas momen-momen perpecahan ini, baik secara individu maupun kolektif, yang menegaskan kembali agensi etis melalui penolakan, pendefinisian ulang, dan perlawanan. Tindakan-tindakan ini menandakan dimulainya wacana tandingan yang mampu membongkar narasi dominan tentang perawatan sebagai paksaan dan membangun, dari dalam reruntuhan, kerangka kerja kesehatan jiwa yang restoratif dan partisipatif.

Apa yang muncul paling kuat dari kesaksian gabungan dari para profesional dan pengguna adalah perasaan bahwa psikiatri institusional, seperti yang saat ini terstruktur, tidak hanya gagal dalam kewajibannya, tetapi juga secara aktif meniadakan kemungkinan untuk melakukan perbaikan yang berarti. Para profesional menggambarkan ketidakmampuan kronis untuk menghentikan siklus pemaksaan atau mengadvokasi perubahan sistemik tanpa menghadapi pembalasan atau marjinalisasi. Para pengguna melaporkan arsitektur yang sama tertutupnya, di mana jalan untuk perbaikan atau partisipasi dihalangi secara sistematis. Tindakan berbicara menjadi sebuah eksposur, tidak hanya untuk ketidakpercayaan dan pemecatan, tetapi juga untuk tanggapan hukuman lebih lanjut yang disamakan sebagai kepedulian. Dinamika ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan sistem untuk bertanggung jawab bukanlah sesuatu yang tidak disengaja, tetapi sudah tertanam dalam desainnya. Yang terpenting, kedua kelompok mengidentifikasi tidak adanya mekanisme yang didukung secara struktural untuk pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi, dan desain ulang yang partisipatif. Pengetahuan etis yang dihasilkan oleh para penyintas, oleh para dokter yang kritis, oleh mereka yang memiliki peran ganda atau hibrida, sebagian besar masih belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pengecualian ini bukan hanya hilangnya wawasan yang berharga, tetapi juga merupakan kelanjutan dari kerugian. Kesaksian-kesaksian mendokumentasikan bagaimana kepercayaan terhadap lembaga-lembaga tidak hanya terkikis, tetapi juga dimusnahkan melalui pengkhianatan yang berulang-ulang, pembungkaman paksa, dan diskualifikasi terhadap pengalaman. Para pengguna yang berusaha mengajukan keluhan, mengusulkan alternatif, atau mendidik para profesional sering kali mendapati diri mereka distigmatisasi kembali, upaya mereka dikodekan kembali sebagai gejala patologi daripada kontribusi untuk kebaikan publik. Dengan demikian, bagian ini berujung pada diagnosis kolektif: pengkhianatan struktural psikiatri bukan hanya pada masa lalu, melainkan juga pada konfigurasinya saat ini.

Perbaikan, jika ingin terjadi, tidak dapat didasarkan pada niat baik dari institusi yang secara struktural tidak mau berubah. Perbaikan harus datang dari tekanan eksternal, dari kerangka kerja yang mengikat secara hukum, dan dari suara-suara yang terorganisir dari mereka yang paling dirugikan dan paling tidak didengar. Bab selanjutnya akan mengeksplorasi cakrawala perlawanan, penolakan, dan pembentukan kembali, di mana martabat direbut kembali bukan sebagai tujuan kebijakan, melainkan sebagai praktik yang dihayati.

Tabel 36. Hambatan struktural dan pengkhianatan institusional dalam praktik kejiwaan

Dimensi	Perspektif profesional	Perspektif pengguna dan penyintas	Tema-tema yang sama dan pola-pola struktural
Ketakutan dan keheningan	Kekhawatiran etis ditekan oleh rasa takut akan pembalasan, manajemen risiko mendominasi pengambilan keputusan, keterlibatan menjadi hal yang normal	Berbicara mengarah pada hukuman lebih lanjut atau pembatalan diagnostik, keluhan diabaikan atau dipatologiskan	Sistem mencegah perbedaan pendapat dan menghargai sikap diam, menciptakan budaya penyensoran diri dan pengunduran diri secara etis
Pembatalan epistemik	Penilaian klinis tunduk pada protokol, pandangan alternatif terpinggirkan, inovasi dianggap berisiko	Pengalaman langsung didiskreditkan, kesaksian dibingkai ulang sebagai khayalan atau gejala, kepemilikan narasi ditolak	Pengetahuan yang dihasilkan oleh pengalaman secara sistematis dikecualikan dari pembentukan kebijakan atau perawatan
Kurangnya perlindungan kelembagaan	Tindakan etis terisolasi dan genting, mekanisme pelaporan pelanggaran tidak ada atau tidak efektif	Tidak ada jalur yang efektif untuk ganti rugi atau reparasi, pengkhianatan institusional digambarkan sebagai trauma kedua	Struktur kelembagaan gagal mendukung pelaku etis atau merespons kerugian dengan cara yang berarti
Ko-optasi dan instrumentalisasi	Advokasi hanya diterima jika tidak dipolitisasi, partisipasi pengguna diterima jika sesuai dengan bingkai dominan	Keterlibatan tokenistik dalam proses partisipatoris, kritik nyata disensor atau dikodekan ulang sebagai patologis	Inklusi bersyarat untuk mempertahankan legitimasi kelembagaan, bukan untuk memungkinkan transformasi
Urgensi transformasi struktural	Para profesional menyatakan perlunya reformasi eksternal dan dukungan transdisipliner untuk mengatasi kelembaman sistemik	Para penyintas menuntut keadilan struktural, bukan gerakan simbolis, dan menyerukan pembongkaran logika pemaksaan dan kerangka kerja penghukuman	Kedua kelompok ini menyepakati ketidakmungkinan perawatan etis dalam struktur saat ini dan menuntut konfigurasi ulang mendasar dari dasar-dasar psikiatri

Persepsi pengkhianatan struktural di institusi psikiatri, seperti yang dilaporkan oleh para profesional dan pengguna, menyoroti pola-pola pembungkaman, pembatalan, dan isolasi etis yang menyatu. Tabel ini mensintesis wawasan yang sama dan berbeda dari tiga aliran survei, yang membuktikan perlunya desain ulang yang bersifat eksternal, partisipatoris, dan berorientasi pada keadilan.

3.8 Tuntutan dan usulan dari responden

Di seluruh survei, para responden mengartikulasikan sejumlah usulan yang menarik dan koheren yang melampaui kritik menuju penegasan alternatif-alternatif yang praktis, etis, dan sistemik. Konstelasi tuntutan ini tidak hanya bersifat aspiratif, tetapi muncul sebagai kebutuhan yang beralasan sebagai tanggapan atas kegagalan yang dialami oleh lingkungan kejiwaan yang bersifat koersif, tidak jelas, dan melemahkan secara profesional. Pengulangan tema-tema utama di berbagai kelompok responden yang berbeda menandakan pengakuan bersama atas sifat struktural dari masalah dan kebutuhan

mendesak untuk rekonfigurasi kelembagaan yang selaras dengan hak-hak dasar, realisme klinis, dan keadilan sosial.

Tuntutan transversal terletak pada seruan untuk menegakkan mekanisme persetujuan berdasarkan informasi, yang seharusnya tidak hanya memformalkan persetujuan tetapi juga memulihkan kemungkinan penolakan, penarikan, dan dialog di semua tahap perawatan. Para responden mengidentifikasi lanskap saat ini sebagai lanskap di mana formalitas menutupi paksaan dan ketiadaan pilihan. Hak atas informasi, serta hak untuk menolak atau mempertanyakan diagnosis atau rencana perawatan tanpa pembalasan, secara konsisten diidentifikasi sebagai prasyarat untuk model perawatan kesehatan jiwa yang dapat dipertahankan secara etis. Hal ini juga menyiratkan perancangan ulang percakapan dan struktur klinis untuk mengakomodasi kompleksitas naratif, ambiguitas, dan negosiasi relasional, yang bergerak di luar daftar gejala reduksionis atau aliran kekuasaan searah.

Terkait erat dengan hal ini adalah permintaan yang meluas untuk model perawatan alternatif, banyak di antaranya secara eksplisit disebutkan oleh responden dengan berbagai tingkat keakraban dan penerapan. Pendekatan dialogis, kerangka kerja berbasis trauma, dan protokol tapering terstruktur termasuk yang paling banyak disebut. Hal-hal ini tidak dilihat sebagai inovasi marjinal tetapi sebagai garis dasar yang diperlukan untuk memulihkan kepercayaan, memanusiakan kembali perawatan, dan mengurangi bahaya jangka panjang yang dihasilkan oleh ketergantungan farmakologis atau pengabaian institusional. Bagi para profesional dan penyintas, ketiadaan pilihan yang berarti bukan hanya kekurangan logistik tetapi juga kekerasan struktural, yang direplikasi setiap hari di lingkungan di mana kontrol mengesampingkan kolaborasi.

Dari para responden profesional, muncul lanskap tuntutan yang terperinci yang mengungkapkan kesadaran etis dan kendala operasional. Usulan mereka tidak hanya berfokus pada perubahan ideologi, tetapi pada hambatan institusional dan sistemik yang menghalangi praktik etis, bahkan ketika keinginan untuk berubah sudah ada. Salah satu yang paling penting di antara tuntutan ini adalah seruan mendesak untuk struktur dukungan rekan sejawat yang konsisten dan mekanisme pengawasan reflektif yang memungkinkan praktisi untuk memproses situasi klinis yang kompleks, menavigasi dilema tanpa rasa takut akan pembalasan, dan melawan kecenderungan institusional menuju pemaksaan atau depersonalisasi.

Permintaan yang berulang-ulang akan kejelasan hukum sangat jelas terlihat. Alih-alih mengadvokasi peningkatan legalisme, para profesional menggambarkan iklim ambiguitas di mana hukum dan protokol ditafsirkan secara tidak konsisten atau ditegakkan secara selektif. Kurangnya konsistensi normatif ini menumbuhkan budaya klinis yang defensif, di mana penghindaran litigasi atau menyalahkan lebih diutamakan daripada perawatan yang berpusat pada pasien. Para responden menekankan perlunya kerangka hukum yang tidak hanya menghukum penyimpangan tetapi juga memandu, melindungi, dan memungkinkan praktik yang adil, terutama dalam konteks yang melibatkan keputusan pengobatan, penggunaan pengekangan, atau pelembagaan jangka panjang.

Tabel 37. Rangkuman tuntutan responden di seluruh kelompok survei

Domain	Tuntutan penyintas	Tuntutan profesional	Proposal bersama
Etika dan persetujuan	Pengakuan atas kerugian, reparasi, dan mekanisme mendengarkan yang tidak membalas dendam	Kejelasan hukum, kemampuan untuk meningkatkan masalah etika, perlindungan untuk perbedaan pendapat	Persetujuan berdasarkan informasi, komunikasi yang jelas, dan hak untuk menolak
Model perawatan	Alternatif dari rawat inap dan pemaksaan, rencana yang diarahkan oleh pengguna	Waktu untuk perawatan relasional, kemampuan untuk menerapkan praktik dialogis dan non-koersif	Model dialogis, pendekatan berbasis trauma, dukungan yang meruncing
Budaya kelembagaan	Mengakhiri perbedaan pendapat yang bersifat patologis, validasi pengalaman hidup	Dukungan untuk tindakan etis, pembongkaran budaya defensif	Transformasi budaya berdasarkan rasa saling menghormati dan keadilan
Pelatihan dan pengetahuan	Penyertaan pengetahuan penyintas, pendidikan yang dipimpin oleh teman sebaya	Pelatihan etika, pengawasan reflektif, farmakologi yang diperbarui	Kurikulum yang diproduksi bersama dan pendidikan etika yang berkelanjutan
Pemulihan dan keadilan	Pengakuan resmi atas kerugian, akses ke ruang pemulihan dan penyembuhan	Jaringan dukungan sebaya dan perlindungan kelembagaan	Infrastruktur pencegahan dan mekanisme restoratif

Tuntutan utama yang disuarakan oleh responden survei dari semua kelompok, mengorganisasikannya ke dalam lima domain yang saling terkait yang penting untuk transformasi kejiwaan yang etis dan efektif. Keselarasan antara perspektif penyintas dan profesional mengungkapkan landasan etis bersama untuk desain ulang hukum dan struktural. Kebutuhan yang diartikulasikan ini membentuk dasar empiris untuk proposal normatif dan infrastruktur yang dikembangkan dalam Bab 6 dan 7.

Kurangnya waktu sering digambarkan bukan hanya sebagai masalah keterbatasan sumber daya, tetapi juga sebagai defisit epistemik dan relasional. Waktu, menurut para profesional, adalah bahan baku dari kepercayaan terapeutik, pertimbangan etis, dan penyembuhan. Ketiadaan waktu secara sistemik membuat perawatan menjadi dangkal, transaksional, dan sangat reaktif. Banyak yang menganjurkan agar ada waktu yang terlindungi untuk perencanaan perawatan, diskusi etis, dan kesinambungan hubungan, dan memandang tindakan tersebut sebagai hal yang penting dan bukan pilihan. Tanpa hal ini, bahkan niat klinis terbaik pun akan runtuh menjadi bahaya rutin.

Secara keseluruhan, tuntutan yang diartikulasikan oleh para profesional dan penyintas mengungkapkan cakrawala transformasi bersama, yang tidak didasarkan pada idealisme tetapi pada perjuangan sehari-hari dan keretakan etika yang tertanam dalam sistem kejiwaan. Ini bukanlah aspirasi yang terisolasi atau naif, melainkan proposal yang berakar secara empiris, yang muncul dari akumulasi pengetahuan, kritik sistemik, dan keahlian yang dijalani. Konvergensi mereka menandai titik balik: runtuhnya kepercayaan, legitimasi, dan efektivitas secara simultan tidak hanya menciptakan gambaran diagnostik tentang krisis institusional, tetapi juga platform normatif untuk mendesain ulang struktural.

Proposal-proposal tersebut menelusuri sebuah kontinum dari perbaikan relasional hingga desain ulang kelembagaan. Pada tingkat relasional, kepercayaan, rasa hormat, dan kebersamaan muncul sebagai prasyarat yang tidak dapat dinegosiasikan untuk perawatan yang beretika. Di tingkat kelembagaan, dukungan struktural harus dikonfigurasi ulang untuk menanamkan nilai-nilai ini: pengawasan rekan sejawat, waktu yang terlindungi, kejelasan hukum dan etika, sistem umpan balik yang terbuka, dan mekanisme akuntabilitas. Hal-hal tersebut sangat penting untuk membalikkan bahaya yang dinormalisasi yang diekspos oleh penelitian ini.

Koherensi empiris antara tuntutan-tuntutan ini dan desain ulang normatif yang diusulkan dalam Bab 6 sangat mencolok. Kekurangan hukum dan etika yang dipaparkan di sini secara langsung menginformasikan pedoman dan protokol untuk praktik psikiatri berbasis hak yang mengikutinya. Demikian pula, kebutuhan infrastruktur, ruang dialogis, platform digital, opsi non-koersif, dan mekanisme partisipatif, dibahas di Bab 7 melalui inisiatif BEACON dan pengembangan sistem pakar dan alat bantu terbuka yang dirancang untuk memberlakukan ekosistem kejiwaan yang bersifat restoratif.

Penyelarasan ini memastikan bahwa desain ulang yang diusulkan tidak bersifat top-down, spekulatif, atau dipaksakan dari luar. Sebaliknya, mereka dibangun di atas wawasan yang bumi, analisis ilmiah, dan tindakan kolaboratif. Selanjutnya adalah penerjemahan tuntutan yang hidup dalam masyarakat ke dalam komitmen struktural, perlindungan hukum, dan infrastruktur praktis yang bertujuan untuk menjamin bahwa perawatan kesehatan jiwa yang etis dan partisipatif tidak menjadi pengecualian, melainkan norma.

3.9 Implikasi ilmiah dan analitis

Konvergensi data dari tiga survei inti memperkuat pola yang koheren dan dapat diverifikasi secara empiris tentang paksaan sistemik, gesekan etis, dan pengecualian epistemik dalam praktik kejiwaan di Spanyol. Instrumen-instrumen ini secara kolektif memberikan wawasan berlapis tentang bagaimana norma-norma institusional dipertahankan melalui penindasan rutin terhadap perbedaan pendapat, penyitaan diagnostik, dan pemberian layanan yang terbatas. Meskipun dirancang dan digunakan secara independen, setiap instrumen mengkonfirmasi dan memperkuat temuan yang lain, menunjukkan ketidakmungkinan struktural dari psikiatri etis yang berkelanjutan dalam konfigurasi kelembagaan yang berlaku. Survei pertama, yang berfokus pada pelabelan psikiatri, mengungkapkan adanya ketidaksesuaian yang meluas antara terminologi klinis dan pengalaman hidup. Responden

merinci konsekuensi psikososial dan hukum dari pemberian diagnosis seperti skizofrenia atau psikosis, dan mencatat masih adanya stigma epistemik yang bertahan lama setelah pasien dipulangkan dari rumah sakit secara formal. Survei kedua, tentang dialog terbuka, mendokumentasikan minat profesional yang meluas terhadap alternatif dialogis, tetapi rasa kelembaman institusional yang sama meluasnya, akses pelatihan yang terfragmentasi, dan pengekanan diskursif yang membatasi implementasi yang sesungguhnya. Survei ketiga, yang berpusat pada pengambilan keputusan bersama dan tata kelola farmakologis, mengungkap ketidakselarasan yang luas antara kebijakan resmi tentang persetujuan dan otonomi dengan realitas pengobatan paksa, ketidakberdayaan, dan model pengobatan yang digerakkan oleh dokter.

Bersama-sama, kumpulan data ini menggambarkan bidang yang ditandai dengan ketidakselarasan etika dan kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Kontradiksi struktural yang mereka paparkan bukanlah artefak interpretatif atau penyimpangan anekdotal. Sebaliknya, mereka dihasilkan oleh prosedur formal, insentif profesional, dan arsitektur administratif yang mereproduksi kontrol dan marginalisasi di bawah bendera otoritas medis. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa reformasi yang diperlukan bukan hanya reformasi tambahan, melainkan juga pertimbangan ulang secara struktural mengenai bagaimana psikiatri dipraktikkan, diatur, dan dilegitimasi. Dalam hal ini, kontribusi analitis dari survei ini tidak hanya bersifat deskriptif atau ilustratif, tetapi juga mendasar. Mereka memberikan laporan yang secara metodologis ketat, berdasarkan pengalaman, dan dapat diakui secara hukum tentang kegagalan psikiatri di Spanyol kontemporer.

Tabel 38. Jalur translasi untuk reformasi kejiwaan berdasarkan bukti tesis

Sumber bukti	Wawasan utama	Penggunaan translasi
Survei pelabelan skizofrenia	Trauma diagnostik, bahaya jangka panjang, pembungkaman epistemik	Advokasi hukum, reformasi pendidikan berbasis hak, tinjauan diagnostik forensik
Dialog terbuka dalam survei di Spanyol	Kesiapan untuk reformasi, hambatan implementasi, minat profesional	Desain kurikulum, pelatihan institusional, jalur inovasi layanan
Pengambilan keputusan bersama dan survei manajemen pengobatan	Defisit otonomi, pemaksaan dalam pemberian resep, panggilan untuk depreskripsi etis	Pedoman etika, protokol pemberian resep, umpan balik kebijakan tentang persetujuan dan hak pasien
Pengamatan etnografi (Spanyol, Italia, Swedia, Indonesia)	Pengkhianatan institusional, pemaksaan rutin, disonansi profesional	Pelatihan berbasis lapangan, pemetaan risiko sistemik, sistem triase dan pelaporan untuk tindakan paksaan
Kesaksian dan dokumen hukum	Kekerasan struktural, pembungkaman pengguna, penghapusan pelanggaran	Desain ulang kebijakan, audit akuntabilitas kelembagaan, bukti untuk tinjauan kriminal dan konstitusional
Keterlibatan jaringan (EU BEACON, FOSTREN, ReMO)	Diseminasi yang layak, kolaborasi multi-level, pola masalah transnasional	Adopsi kebijakan, implementasi transdisipliner, berbagi sumber daya dan platform konsultasi ahli

Ringkasan sumber-sumber bukti utama dan relevansi operasionalnya untuk penggunaan translasi, menyoroti bagaimana tesis ini bergerak dari kritik empiris ke strategi yang dapat diterapkan untuk reformasi psikiatri berbasis hak.

Hasil-hasil ini juga memperjelas ketegangan epistemik yang menjadi inti dari produksi pengetahuan kejiwaan. Ideologi profesional, yang dibangun di atas asumsi keahlian, kebajikan, dan kepatuhan, secara sistematis bertentangan dengan narasi pengguna tentang bahaya, pengucilan, dan ketidakpercayaan. Apa yang dipasarkan sebagai perawatan yang berpusat pada orang sering kali bermanifestasi sebagai pengawasan, kontrol, dan pengambilan diagnostik. Survei-survei tersebut tidak mendokumentasikan pelanggaran yang terisolasi, tetapi fraktur epistemik di seluruh lapangan yang mendelegitimasi klaim pengetahuan pengguna sambil menilai terlalu tinggi pengambilan keputusan teknokratis. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga operasional, yang membentuk kebijakan institusional, kerangka hukum, dan praktik terapeutik.

Implikasi analitis dari temuan ini sangat penting. Pertama, temuan-temuan ini membenarkan penggunaan metodologis kesaksian, pemetaan naratif, dan pengkodean berdasarkan informasi trauma bukan sebagai alat bantu, tetapi sebagai alat analisis utama yang mampu menangkap kerugian yang luput dari dokumentasi statistik atau prosedural. Kedua, mereka membumikan proposal konseptual dan desain ulang kebijakan disertai dalam data langsung daripada kritik ideologis. Ketiga, mereka membangun otoritas empiris penulis tidak hanya sebagai peneliti tetapi juga sebagai saksi yang melekat dan aktor etis yang menavigasi sistem yang memaksa. Keempat, tesis ini memposisikan tesis sebagai upaya translasi, bergerak dari dokumentasi deskriptif ke proposal yang sah secara epistemik untuk merekayasa ulang perawatan kejiwaan dalam kerangka kerja yang berbasis hak asasi manusia, dialogis, dan berlandaskan biokultural.

Pada akhirnya, integritas ilmiah dari penelitian ini tidak hanya terletak pada luas dan dalamnya basis empiris, tetapi juga pada kemampuannya untuk menghadapi penolakan institusional untuk belajar dari mereka yang dirugikan. Survei-survei ini memberikan bukti dan perancah konseptual yang menjadi dasar bagi bab selanjutnya untuk membangun kritik sistemik dan proposisi-proposisi yang

beralasan bagi transformasi kejiwaan yang beretika. Data menegaskan bahwa konfigurasi tata kelola kejiwaan saat ini tidak sesuai dengan perawatan yang etis dan bahwa cakrawala alternatif, yang berakar pada rasa hormat, otonomi, dan keadilan epistemik, dapat dibayangkan dan diperlukan secara empiris, meskipun secara struktural terhalang.

Disertasi ini dirancang tidak hanya untuk mendokumentasikan dan menganalisis disfungsi sistemik dalam praktik kejiwaan, tetapi juga untuk secara aktif berkontribusi pada perbaikannya melalui strategi translasi yang berlandaskan ilmiah dan sesuai dengan etika. Arsitektur metodologis telah dibangun untuk memastikan bahwa temuan-temuan, yang berasal dari pengalaman langsung, kesaksian profesional, dan pemeriksaan hukum, tidak hanya terbatas pada interpretasi akademis. Sebaliknya, temuan-temuan tersebut disusun untuk penerapan strategis dalam pengaturan pedagogis, klinis, hukum, dan kebijakan. Setiap kumpulan data yang dikumpulkan dan setiap langkah analisis yang dilakukan berorientasi pada relevansi dalam implementasi, dengan fokus eksplisit pada desain ulang kelembagaan, restitusi etika, dan transformasi sistem kesehatan.

Ketiga survei ini menyediakan repositori bukti yang modular, dapat diverifikasi, dan terintegrasi secara tematik, yang mampu menginformasikan berbagai tingkat intervensi. Survei pertama mengenai pelabelan psikiatri menyediakan materi forensik yang cocok untuk advokasi hukum, reformasi pendidikan, dan desain ulang layanan berbasis hak. Survei kedua tentang dialog terbuka mendokumentasikan tantangan implementasi dan kesiapan profesional, yang menawarkan sumber daya diagnostik untuk perencanaan sistem, pengembangan kurikulum, dan restrukturisasi peraturan. Survei ketiga mengenai manajemen pengobatan dan pengambilan keputusan bersama menawarkan jalur operasional untuk protokol pemberian obat, pedoman pemberian resep yang etis, dan sistem pemantauan yang dipimpin oleh pasien. Setiap survei mencakup kebutuhan pengguna yang terkodifikasi, proposal reformasi yang dapat ditindaklanjuti, dan konsensus profesional yang muncul, sehingga membentuk dasar yang kuat dan terukur untuk transformasi sistemik. Dokumen ini juga dibuat dalam bentuk online, sebagai dokumen hidup di repositori git, dengan tambahan statistik interaktif, grafik dan hasil, yang tersedia secara terbuka.

Data etnografi dan penelitian lapangan hukum melengkapi survei dengan menjelaskan lingkungan sehari-hari di mana kebijakan gagal, hak-hak ditangguhkan, dan pengkhianatan institusional dinormalisasi. Temuan-temuan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi tetapi juga sebagai masukan untuk desain sistem digital, pelatihan etika klinis, dan pemantauan administratif. Dengan melakukan referensi silang antara konten naratif, dokumen institusional, dan wacana profesional, disertasi ini menghasilkan alat analisis yang dapat digunakan untuk membuat prototipe infrastruktur kesehatan jiwa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hak asasi manusia. Alat-alat tersebut termasuk sistem pakar sumber terbuka, indikator penilaian kualitas, dan model simulasi kebijakan, yang semuanya diuraikan dalam bab-bab akhir yang berfokus pada implementasi. Semua orang didorong untuk bergabung untuk membantu.

Nilai translasi dari karya ini terletak pada kapasitasnya untuk melakukan intervensi di mana penerbitan ilmiah tradisional telah gagal untuk melakukan perubahan. Desain berlapis dari disertasi ini, yang menggabungkan analisis data yang ketat dengan metodologi penelitian aksi dan strategi implementasi berbasis jaringan, memastikan bahwa temuan-temuannya tidak hanya dapat

dipublikasikan tetapi juga dapat ditindaklanjuti. Jaringan internasional seperti EU BEACON, FOSTREN, dan ReMO berfungsi sebagai jalur diseminasi dan infrastruktur etis untuk menerapkan hasil disertasi dalam praktik, melintasi batas, dan dalam sistem kesehatan, hukum, dan pendidikan. Dalam hal ini, disertasi adalah dokumen ilmiah dan instrumen translasi. Disertasi ini berusaha menyelaraskan kembali praktik psikiatri dengan mandat etis, kewajiban hukum, dan pengalaman hidup manusia. Tujuan strategisnya adalah untuk mendukung munculnya tatanan pembuktian dan kelembagaan baru, yang mengakui martabat, otonomi, dan perawatan sebagai kondisi yang tidak dapat dinegosiasikan dalam legitimasi sistem kesehatan. Bukti-bukti yang disajikan dalam bab ini, dan di seluruh tesis ini, tidak hanya bersifat informatif. Hal ini merupakan dasar moral dan operasional untuk reformasi psikiatri sistemik.

Bab 4 - Penelitian Lapangan dan Kesaksian: Struktur Pengkhianatan yang Dihidupi

Ringkasan: Bab ini menyajikan temuan-temuan dari observasi partisipan jangka panjang, rekonstruksi narasi, dan dokumentasi langsung di berbagai konteks institusional, profesional, dan keluarga. Bab ini menelusuri kesinambungan kekerasan kejiwaan dari diagnosis hingga penahanan dan dari pengabaian sistemik hingga pembungkaman epistemik. Bab ini menyuarakan lintasan pengkhianatan, medis, hukum, sosial, dan keluarga, sekaligus menyoroti momen-momen perlawanan, keberanian etis, dan lambatnya pemulihan agensi.

4. Pendahuluan dan posisi

Bab ini dimulai dengan observasi lapangan langsung dari acara publik *Jornada Drets bàsics en els internaments psiquiàtrics involuntaris* (Konferensi tentang Hak-Hak Dasar dalam Interniran Psikiatri Tidak Disengaja), yang diselenggarakan pada hari Jumat 18 Maret 2022 di Col·legi de Metges de Barcelona, Dewan Medis resmi kota. Acara ini diselenggarakan oleh Komite Etika Yayasan Kongres Kesehatan Mental Catalan, sebuah platform interdisipliner yang didedikasikan untuk pengembangan kebijakan dan perdebatan di bidang kesehatan mental. Tujuannya adalah untuk memeriksa kerangka hukum yang mengatur pengasingan paksa dan untuk menegaskan kembali peran normatif dan perlindungan dari undang-undang yang ada, termasuk hukum nasional Spanyol dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pidato pembukaan disampaikan oleh Josep Vilajoana, yang saat itu menjabat sebagai presiden Yayasan, Sílvia Ventura, ahli hukum dan presiden Komite Etika yang berspesialisasi dalam masalah hukum kejiwaan, dan Joan Vegué, direktur Rencana Induk Kesehatan Mental dan Kecanduan Pemerintah Catalan. Pidato utama oleh Fernando Santos, seorang jaksa penuntut umum di Córdoba dan advokat untuk hak-hak disabilitas, berfokus pada UU 8/2021 sebagai titik balik menuju dukungan etis daripada pengambilan keputusan pengganti. Ia diikuti oleh Alberto Vázquez, ahli hukum Peru dan mantan penasihat Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kesehatan, yang menekankan pada ketidaksesuaian antara komitmen

hukum formal dan praktik kelembagaan yang ada dalam perawatan kejiwaan. Kemudian, Sílvia Ventura dan Montserrat Hierro, keduanya ahli di bidang kapasitas hukum dan penahanan psikiatri, memperkenalkan publikasi internal komite, yaitu *Coneixements jurídics bàsics en relació als ingressos psiquiàtrics involuntaris* (Pengetahuan Hukum Dasar tentang Pemasukan Pasien ke Rumah Sakit Jiwa secara Paksa). Dokumen ini bertujuan untuk memperjelas persyaratan hukum minimum di bawah hukum internasional dan disajikan sebagai alat untuk menyelaraskan prosedur klinis dengan standar hak asasi manusia.

Peneliti menghadiri acara ini di bawah kondisi paparan penyiksaan institusional dan tekanan psikologis akut, yang mengakibatkan hilangnya semua catatan dan materi pribadi. Meskipun demikian, suasana tersebut masih teringat dengan jelas. Beberapa peserta sebelumnya telah memberikan dukungan dalam menangani dampak buruk dari pengobatan paksa, menunjukkan komitmen etis di luar batasan-batasan institusional. Namun, yang lain menunjukkan ketidaknyamanan yang nyata pada gagasan bahwa perlindungan hukum harus diwajibkan dan dapat ditegakkan. Pengawasan yudisial dianggap bukan sebagai kebutuhan perlindungan tetapi sebagai ancaman terhadap otonomi profesional. Reaksi ini menunjukkan keyakinan yang mengakar pada kebijaksanaan klinis sebagai dasar yang cukup dan tidak dapat diganggu gugat untuk perampasan kebebasan dan pengobatan, terlepas dari tinjauan independen. Meskipun secara publik dibingkai sebagai kesempatan untuk musyawarah etis, kongres ini menunjukkan dirinya sebagai situs etnografi utama di mana instrumentalisasi bahasa hukum digunakan untuk melindungi, alih-alih membongkar, otoritas kejiwaan di luar hukum. Hal ini tidak terlihat dalam transkrip resmi, namun terlihat jelas dalam penolakan informal untuk mengakui adanya kerugian sistemik. Meskipun prinsip-prinsip hukum ditegaskan dalam wacana, penerapannya secara institusional tetap ditangguhkan secara selektif. Kebutuhan akan perlindungan yang dapat ditegakkan muncul bukan sebagai aspirasi teoritis tetapi sebagai persyaratan struktural untuk mencegah pelanggaran yang sedang berlangsung dengan kedok perawatan.

Peristiwa-peristiwa visibilitas dan kepadatan kelembagaan seperti itu jarang terjadi selama masa kerja lapangan, karena peneliti terpapar pada konteks pemaksaan, keterbatasan pergerakan, dan kurangnya sumber daya yang aman. Dalam beberapa kesempatan di mana partisipasi yang aman dimungkinkan, pertemuan profesional semacam ini berulang kali memperlihatkan ketidaksesuaian antara etika deklaratif dan akuntabilitas operasional. Hal ini bukanlah sebuah anomali, melainkan sebuah pola yang konsisten. Forum-forum yang seolah-olah didedikasikan untuk hak-hak dan perlindungan sering kali berfungsi sebagai platform penyangkalan, di mana legalitas digunakan secara simbolis sementara mekanisme ganti rugi dan penegakan hukum ditolak atau diabaikan.

Pada saat acara ini berlangsung, dua tahun telah berlalu sejak awal kerja lapangan. Penguncian sosial yang diberlakukan selama pandemi COVID-19 telah surut dalam ingatan, tetapi bentuk pengurungan lain telah meningkat. Penggunaan obat-obatan psikiatri sebagai pengekangan kimiawi telah memberi jalan bagi bentuk kekerasan fisik yang lebih terbuka. Peneliti, yang untuk sementara waktu lolos dari efek mati rasa akibat pengobatan yang dipaksakan, sebuah bentuk kontemporer dari lobotomi non-bedah, menghadapi kebrutalan yang meningkat. Pemukulan-pemukulan ini, yang semakin sering terjadi dan tidak disembunyikan, bukanlah tindakan yang terisolasi, tetapi merupakan manifestasi dari keruntuhan sistemik yang lebih dalam, di mana kontrol menggantikan perawatan dan hukuman

menggantikan etika. Apa yang dilakukan tidak hanya melanggar hukum tetapi juga secara struktural dinormalisasi dengan tidak adanya pertanggungjawaban. Bahwa luka-luka tersebut tidak dapat dipulihkan adalah sebuah pengecualian, bukan jaminan. Dalam kondisi saat ini, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki masih mungkin terjadi, bukan karena hukum mengizinkannya, tetapi karena secara rutin diabaikan. Semua kesehatan kita membutuhkan akal sehat yang waras. Sanitasi.

Sebagai seorang sarjana hukum, Escalada telah berulang kali menekankan, persetujuan yang diberikan seharusnya merupakan proses yang berkelanjutan dan bermakna, bukan formalitas yang diberikan sekali saja. Ketika individu menjadi sasaran perlakuan paksaan tanpa kesempatan berulang untuk mendapatkan persetujuan yang sah dan terinformasi, perlindungan hukum tidak hanya dilewati, tetapi juga dibongkar secara sistematis. Kerangka kerja apa pun yang mengizinkan praktik semacam itu dengan kedok kebijaksanaan klinis melemahkan prinsip hukum utama bahwa kehidupan dan kebebasan harus dilindungi tanpa kecuali. Menahan seseorang dengan kekuatan otoritas yang tidak terkendali, sembari mengklaim legitimasi hukum, sama saja dengan mengikis fondasi keadilan demokratis. Pengamatan dan kesaksian di lapangan di luar satu contoh ini, di berbagai tempat yang mencakup lima tahun yang panjang dan intens, mengkonfirmasi pola keprihatinan yang sama tentang perlunya perlindungan yang lebih baik, dan perlunya menghentikan ketergantungan yang berlebihan pada intervensi farmakologis dalam sistem perawatan saat ini. Hampir semua orang yang berkonsultasi, baik pengguna, pendukung sebaya, atau praktisi menggambarkan dinamika yang sama tentang pengobatan yang berlebihan yang disertai dengan pengabaian dimensi sosial dan psikologis dari perawatan. Pengalaman saya sendiri mencerminkan temuan ini: Saya menemukan sebuah sistem di mana tidak ada pendengaran aktif, dan di mana anggota keluarga dapat menggunakan pengaruh koersif, mendorong perawatan hukuman yang meningkat menjadi pelecehan yang dilembagakan, dan tidak ada anamnesis atau perumusan yang berarti yang pernah dicoba, menghancurkan kepribadian saya sendiri dan sejarah yang sebenarnya dalam catatan medis - sebuah pencapaian bagi para pelaku. Sistem kesehatan jiwa, alih-alih menawarkan perlindungan, malah dipersenjatai atas desakan mereka, menghalangi upaya apa pun untuk melaporkan kejadian kekerasan yang jelas. Kesenjangan struktural, terutama kurangnya koordinasi dengan penegak hukum, mekanisme peradilan, dan layanan dukungan korban, semakin memperparah keadaan. Pengobatan yang berlebihan, yang dengan cepat menyebabkan gangguan kognitif dan fisik, memperdalam kerentanan, sehingga memudahkan terjadinya penyiksaan yang tidak terkendali. Dalam kasus saya, kekejaman sistemik ini semakin meningkat, sering kali mencapai ambang batas yang dapat diklasifikasikan sebagai penyiksaan psikologis dan fisik. Secara umum, pengamatan yang konstan adalah perlunya percakapan dan dialog yang benar dengan pasien, untuk memastikan realitas yang dirasakan oleh profesional sesuai dengan pengalaman yang dialami, secara lebih mendalam, untuk memastikan dukungan efektif yang tepat dan konsensual.

4.1 Kesenambungan metodologis dan ruang lingkup

Peneliti mengakui bahwa tidak semua data yang dikumpulkan selama lima tahun penelitian lapangan dapat atau seharusnya dicatat, disimpan, atau disebarluaskan sesuai dengan standar ilmu pengetahuan terbuka, dan juga tidak ada hukum yang mengizinkan, atau moral yang mengizinkan, untuk berbagi

secara transparan sepenuhnya. Nama-nama akan sering dihindari, karena satu dan lain hal dan kehati-hatian. Sebagian besar materi diproduksi dalam kondisi yang melibatkan kekerasan institusional yang berulang-ulang, intervensi paksa, dan risiko pribadi yang berkelanjutan. Hal ini termasuk episode-episode penyiksaan psikologis dan fisik yang terdokumentasi, penggunaan otoritas kejiwaan untuk menekan perlawanan dan meningkatnya ancaman yang melibatkan senjata dan luka fisik. Keadaan-keadaan ini bukan merupakan keterbatasan metodologis tetapi merupakan bagian intrinsik dari realitas yang diamati. Temuan-temuan yang disajikan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan tempat temuan-temuan tersebut dihasilkan.

Dinamika pemaksaan meluas jauh melampaui fasilitas kejiwaan, menembus sistem keluarga dan struktur sosial budaya yang lebih luas. Di berbagai tempat, termasuk di rumah tangga, pendidikan, peradilan, dan ranah kesejahteraan, mekanisme kontrol, pembungkaman, dan pengucilan yang sama juga terjadi. Dinamika ini membentuk sebuah kontinum, saling menguatkan satu sama lain dan menghasilkan kerugian jangka panjang. Penelitian lapangan yang sedang berlangsung yang berfokus pada praktik pemasungan menunjukkan bagaimana kekuatan-kekuatan semacam itu terus beroperasi di luar psikiatri institusional, mengungkapkan kesenjangan yang terus-menerus dalam penegakan hukum dan akuntabilitas klinis. Investigasi ini tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan tetapi juga untuk mendukung pengembangan mekanisme hukum yang mencegah bahaya, meningkatkan tata kelola kesehatan masyarakat, dan mempromosikan sistem pendidikan dan komunitas yang melindungi sumber daya manusia dan menumbuhkan ketahanan.

Dalam paradigma integratif satu kesehatan, hasil kesehatan individu tidak dapat dipisahkan dari faktor penentu sosial, politik, dan ekologi. Ilmu kedokteran, yang didasarkan pada bukti fisiologis, menegaskan bahwa kemiskinan, pengucilan, dan kekerasan institusional yang berkelanjutan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit melalui gangguan imunologi, metabolisme, dan neuroendokrin. Mekanisme ini telah didokumentasikan dengan baik dan relevan secara klinis. Sistem kesehatan jiwa saat ini sering kali gagal untuk memasukkan temuan-temuan tersebut ke dalam praktik, alih-alih memperkuat model yang berpusat pada pengendalian gejala farmakologis tanpa mengatasi penyebab struktural. Hasilnya adalah resep pengobatan yang efek jangka panjangnya dapat merusak pemulihan, sementara jalur non-farmakologis yang didasarkan pada bukti dari psikiatri nutrisi, psikoneuroimunologi, penelitian trauma, dan pengobatan metabolik masih jarang digunakan atau didiskreditkan secara kelembagaan.

Kegagalan ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi bersifat sistemik, dibentuk oleh kesenjangan dalam publikasi ilmiah, struktur insentif yang menyimpang, dan kurangnya standar metodologis yang transparan. Lingkungan yang terlalu banyak meresepkan obat, yang resisten terhadap pengawasan kritis, terus memedikalisasi efek fisiologis dari kekurangan dan kesusahan sambil menawarkan alat yang terbatas untuk penyembuhan yang berkelanjutan. Struktur ilmiah dan hukum harus diselaraskan dengan keharusan untuk mengurangi bahaya, memastikan integritas, dan mempromosikan perawatan yang efektif berdasarkan bukti terkini.

Bab ini menjawab pertanyaan-pertanyaan inti penelitian yang ditetapkan dalam Bab 1 dan mengikuti arsitektur metodologis yang didefinisikan dalam Bab 2. Bab ini menawarkan presentasi sintesis dari temuan-temuan di bawah batasan format akademis, yang diambil dari pengamatan yang paling

konsisten dan dapat diverifikasi. Hasil-hasil ini tidak hanya relevan dengan konteks spesifik yang diteliti, tetapi juga dapat digeneralisasi di seluruh sistem yang sebanding di mana kebijaksanaan psikiatri dilakukan tanpa perlindungan yang dapat ditegakkan. Bab 5 dan 6 masing-masing akan mengembangkan respons pendidikan dan hukum-politik yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengetahuan institusional, praktik klinis, dan struktur sosial menyatu menuju kondisi yang mendorong kesehatan, keselamatan, dan perkembangan manusia.

Sebagaimana diuraikan dalam pemikiran Aristoteles, hukum seharusnya mengatur di mana pengaturan diri secara etis tidak ada. Ketika ketidakadilan dinormalisasi secara struktural, kerangka hukum tidak hanya diperlukan untuk mencegah tetapi juga sangat diperlukan untuk memperbaiki. Sistem kejiwaan, seperti halnya semua sistem kekuasaan, harus tunduk pada batas-batas yang transparan, dan batas-batas ini harus didasarkan pada pengetahuan ilmiah, hak-hak konstitusional, dan realitas kehidupan mereka yang paling terdampak. Integritas ilmu pengetahuan dan martabat kehidupan manusia sama-sama membutuhkannya. Bab ini menyajikan sintesis dari hasil-hasil empiris yang diperoleh dari penelitian lapangan etnografi jangka panjang di berbagai tempat dalam konteks psikiatri, kelembagaan, rumah tangga, dan masyarakat. Bab ini menjawab, seperti yang telah dinyatakan, pertanyaan-pertanyaan inti penelitian yang diidentifikasi pada Bab 1 dan mengikuti kerangka metodologi yang diuraikan pada Bab 2. Pendekatan yang digunakan bersifat integratif dan selektif. Mengingat kendala struktural dan dokumenter dari format tesis, bab ini tidak berusaha untuk mereproduksi totalitas pengamatan, melainkan menyempurnakan dan mengkonsolidasikan pola-pola yang paling kritis, konvergensi, dan penyimpangan ke dalam tanggapan yang beralasan secara ilmiah. Temuan-temuan ini mengungkapkan mekanisme pemaksaan yang terus-menerus, ambiguitas hukum, dan kebijaksanaan klinis yang memfasilitasi bahaya tanpa adanya pengawasan yang efektif.

Tabel 39. Temuan empiris dan usulan pendidikan dan hukum-politik yang sesuai

Temuan penelitian lapangan	Pola sistemik yang dapat digeneralisasi	Tanggapan pendidikan (bab 5)	Tanggapan hukum-politik (bab 6)
Penggunaan paksaan dan pengobatan paksa yang terus menerus di berbagai tempat perawatan kejiwaan	Kebijaksanaan psikiatri beroperasi tanpa perlindungan yang dapat ditegakkan	Mengintegrasikan perawatan berbasis trauma, pengambilan keputusan bersama, dan kerangka kerja berbasis hak dalam kurikulum	Mengesahkan protokol yang dapat ditegakkan untuk persetujuan, tinjauan rutin, dan perlindungan pasien
Ambiguitas hukum yang dieksploitasi oleh institusi untuk membenarkan tindakan yang membahayakan	Tidak adanya pengawasan memungkinkan terjadinya impunitas sistemik	Mengedukasi tentang penalaran etis-hukum, transparansi dokumentasi, dan penyalahgunaan historis psikiatri	Menetapkan batasan hukum yang jelas tentang pemaksaan, dengan mekanisme peninjauan kelembagaan yang yudisial dan independen
Kebijaksanaan klinis diprioritaskan di atas bukti ilmiah dan hak-hak konstitusional	Otoritas epistemik melindungi norma-norma yang kejam	Memperbarui pedoman klinis untuk mencerminkan model integratif (psikiatri nutrisi, psikoneuroimunologi)	Mengkodifikasi kepatuhan terhadap bukti ilmiah dan martabat pasien sebagai kriteria yang mengikat dalam perilaku profesional
Penghapusan suara pasien melalui pencatatan dan kontrol narasi	Pembungkaman struktural terhadap pengalaman hidup	Melatih para profesional dalam pengobatan naratif, catatan yang ditulis bersama, dan keadilan epistemik	Mengamankan pengakuan hukum atas keabsahan kesaksian, dan memberikan sanksi atas kelalaian atau distorsi dalam dokumentasi
Pola-pola struktural dari bahaya dan pengkhianatan di seluruh domain domestik, komunitas, dan kelembagaan	Kerugian melampaui pengaturan melalui penguatan lintas institusi	Membuat program pendidikan lintas sektor tentang dinamika psikososial dan trauma sejarah	Mengatur protokol pembagian informasi dan membangun kerangka kerja akuntabilitas lintas sektor
Pengumpulan data terkendala oleh risiko, trauma, dan permusuhan institusional	Pengetahuan empiris sering kali tidak dapat diakses di bawah paksaan	Mempromosikan metodologi refleksif dan dukungan bagi peneliti lapangan dalam situasi yang sensitif	Mengakui penelitian yang berada di bawah batasan dalam pengembangan hukum dan kebijakan, dengan menghargai bukti dalam konteks langsung
Temuan ilmiah kurang dimanfaatkan sementara model farmakosentris mendominasi	Peresepan yang berlebihan dan pengabaian intervensi non-farmakologis sebagai praktik standar	Mereformasi pendidikan kedokteran untuk menyeimbangkan farmakologi dengan gaya hidup, lingkungan, dan faktor penentu sosial	Secara hukum mewajibkan tinjauan risiko-manfaat untuk penggunaan obat jangka panjang, dan menyertakan opsi non-obat dalam cakupan

Tabel ini berfungsi sebagai jembatan dari landasan empiris pada Bab 4 ke proposal terapan dan normatif yang dikembangkan pada bab-bab berikutnya.

Kontradiksi klinis yang jelas diidentifikasi selama penelitian lapangan. Sementara beberapa praktisi mendukung dan mendokumentasikan pemulihan penuh melalui intervensi berbasis trauma, nutrisi, dan metabolik, yang lain terus menerapkan rejimen pengobatan yang tidak sesuai dengan bukti ilmiah yang terus berkembang. Peminggiran pendekatan psikoneuroimunologi, psikiatri nutrisi, dan metabolik tetap menjadi gejala kegagalan yang lebih luas untuk mengintegrasikan pengetahuan biomedis yang tersedia ke dalam praktik standar. Ketidakselarasan ini ditopang oleh kelemahan sistemik dalam sistem publikasi ilmiah saat ini, di mana bias struktural, pelaporan yang kurang dari hasil yang merugikan, dan tekanan komersial terus menghalangi penyaringan dan konsolidasi

temuan-temuan penting. Akibatnya, alternatif-alternatif yang memiliki bukti kuat dikesampingkan atau didelegitimasi, dan praktik-praktik yang merugikan terus berlanjut, termasuk yang sudah dianggap sebagai cara terbaik, yang seharusnya tidak boleh hanya menjadi pilihan.

Bab ini berkomitmen untuk menyajikan hasil dengan ketepatan metodologis dan tanpa mediasi ideologis. Hasil medis yang paling murni, sebagaimana seharusnya. Tujuannya adalah untuk memperjelas apa yang telah diamati, menetapkan relevansi ilmiahnya, dan mempersiapkan dasar untuk dimensi normatif dan praktis dari pekerjaan ini. Bab 5 dan 6 akan menguraikan tanggapan sosial-pendidikan dan politik-hukum yang diperlukan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai apa yang telah diamati, didokumentasikan, dan diverifikasi, dalam komitmen terhadap integritas ilmiah dan martabat manusia.

Bagian selanjutnya menetapkan pengaturan kerja lapangan dan kerangka kerja metodologis, membedakan antara rumah sakit jiwa publik di Spanyol dan Italia, lingkungan domestik di Catalonia dan Swedia, jaringan komunitas dan LSM, serta ruang observasi digital dan hukum. Penelitian ini mengartikulasikan sebuah metodologi yang dijalankan dalam kondisi yang tidak menguntungkan, berakar pada protokol yang dijelaskan pada bab sebelumnya, namun dibentuk oleh tuntutan etika waktu nyata, kendala yang bersifat memaksa, dan bahaya pribadi. Posisi peneliti sebagai penyintas, profesional, dan aktor yang terlibat memungkinkan akses ke dimensi kritis kekerasan institusional dan kegagalan sistemik yang sering kali terlindung dari penyelidikan standar. Alat-alat analisis yang digunakan termasuk pemetaan peristiwa mikro, triangulasi epistemik, catatan lapangan, dan verifikasi silang kesaksian, yang diintegrasikan melalui pendekatan antropologi forensik dan rekonstruksi naratif. Replikabilitas ilmiah, perlindungan etis, dan kekuatan pembuktian dipastikan melalui konvergensi dokumenter, analisis kontradiksi, dan reflektivitas metodologis di bawah tekanan.

Bagian 4.2 merinci logika institusional dari kekerasan kejiwaan, memeriksa bagaimana diagnosis, pelabelan, dan praktik administratif menciptakan siklus pemaksaan, penyitaan narasi, dan impunitas. Melalui pengamatan langsung dan rekonstruksi kasus-kasus tertentu, laporan ini mengungkapkan bagaimana diagnosis yang tidak diverifikasi didaur ulang, anamnesis diabaikan, dan pengekangan atau pengobatan paksa diterapkan tanpa pembenaran prosedural atau klinis. Keterlibatan para profesional, yang sering kali diam atau dibatasi oleh hirarki administratif, menggambarkan bagaimana bahaya dilanggengkan bukan karena ketidaktahuan, tetapi melalui desain kelembagaan. Bukti lapangan menegaskan bahwa apa yang disajikan sebagai perawatan sering kali berfungsi sebagai penahanan, menghasilkan penghapusan arsip dan cedera moral.

Bagian 4.3 menggeser lensa analisis ke pengkhianatan keluarga dan persinggungannya dengan kekerasan institusional. Bagian ini mendokumentasikan bagaimana mekanisme kejiwaan dimobilisasi oleh keluarga untuk mengontrol, mendiskreditkan, atau mengasingkan kerabat, sering kali dengan dukungan atau ketidakpedulian para profesional. Penelitian ini mengidentifikasi analogi struktural dengan pemasangan di Spanyol dan Swedia, dengan pengurungan, medisikasi, dan pengucilan yang diberlakukan di rumah-rumah pribadi. Asimetri gender dan generasi menjadi pusat dari dinamika ini, dengan perempuan, anak-anak, dan orang tua yang paling sering menjadi sasaran. Temuan ini menunjukkan bahwa alih-alih bertindak sebagai kekuatan yang melindungi, lembaga-lembaga tersebut justru sering kali memperkuat kekerasan dalam keluarga, dengan memprioritaskan

narasi orang tua atau kerabat di atas kisah hidup subjek, terutama dalam konteks ketergantungan ekonomi atau stigma sosial.

Bagian 4.4 membahas konsekuensi epistemik dari pemaksaan, menekankan bagaimana praktik kejiwaan sering kali menghasilkan penghapusan kepribadian. Hal ini dicapai melalui reduksionisme diagnostik, penolakan terhadap makna kultural atau biografis, dan pengabaian kerangka penjelasan yang menantang hegemoni kejiwaan. Materi yang dikumpulkan melalui observasi, analisis dokumen, dan kesaksian para penyintas menggambarkan bagaimana perlawanan, spiritualitas, kesedihan, atau ekspresi somatik dipatologisasi dan didepolitisasi. Hilangnya hak, pengabaian sosial, dan ketakutan akan pembalasan adalah hasil berulang dari pembungkaman ini. Bagian ini mengoperasionalkan analisis wacana forensik dan pemetaan epistemik untuk mengungkap mekanisme di mana subjektivitas ditransformasikan menjadi data administratif dan agensi moral menjadi kebisingan medis.

Bagian 4.5 memusatkan pada praktik-praktik perlawanan, pemulihan, dan kesaksian etis. Terlepas dari kerusakan yang didokumentasikan, banyak peserta menunjukkan strategi kreatif dan berani untuk merebut kembali kendali naratif, menantang dominasi institusi, dan bertahan melawan kekuatan yang merendahkan martabat manusia. Tindakan-tindakan perawatan yang dikelola sendiri, penulisan testimoni, pelarian simbolis, dan solidaritas profesional terselubung dianalisis bukan sebagai pengecualian anekdot, tetapi sebagai komponen kunci dari arsip tandingan. Praktik-praktik ini merupakan elemen-elemen dasar dari infrastruktur alternatif yang bermartabat dan peduli, yang ada secara paralel dan sering kali berlawanan dengan sistem formal. Hal ini sangat penting untuk memahami bagaimana pemulihan menjadi mungkin ketika sistem gagal.

Bagian 4.6 mensintesis bukti-bukti berbasis lapangan ke dalam wawasan sistemik, menegaskan bahwa pola-pola yang diamati bukanlah penyimpangan yang terisolasi, melainkan fitur struktural dari sistem psikiatri, hukum, dan keluarga yang ada. Pengkhianatan institusional muncul sebagai fenomena yang berulang, bukan karena kerusakan tetapi karena desain. Penelitian lapangan memperkuat temuan berbasis survei yang disajikan di Bab 3 dan mempersiapkan dasar untuk Bab 5, di mana pengkhianatan diteorikan sebagai logika inti dari tatanan kelembagaan. Konvergensi data naratif, hukum, dan etnografi menegaskan perlunya restrukturisasi hukum, pedagogis, dan klinis yang mendalam. Dengan demikian, bab ini melengkapi landasan empiris disertai dengan mendokumentasikan pengalaman langsung dari ketidakadilan dan keharusan ilmiah untuk mentransformasi sistem yang menghasilkannya.

4.2 Pengaturan penelitian lapangan dan implementasi metodologis

Bagian ini memperdalam alur analisis dari Bab 4 dengan merinci implementasi arsitektur metodologis yang diuraikan pada Bab 2, sebagai tanggapan langsung terhadap pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan pada Bab 1. Alih-alih mengulangi prinsip-prinsip yang telah dipaparkan, bagian ini mengklarifikasi bagaimana pengetahuan dihasilkan di bawah kondisi paksaan, pengkhianatan institusional, dan pengucilan epistemik, dan bagaimana proses ini tetap dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah meskipun terdapat hambatan struktural.

Lokasi-lokasi lapangan dipilih karena memiliki nilai diagnostik yang penting dalam kaitannya dengan pemaksaan psikiatri, jangkauan farmakologis yang berlebihan, kekosongan hukum, dan kekerasan struktural. Lokasi-lokasi tersebut termasuk rumah sakit jiwa umum di Spanyol dan Italia, pusat kesehatan jiwa masyarakat dan klinik yang berafiliasi dengan LSM, rumah keluarga, terutama di Catalonia dan Swedia, serta ruang digital dan hukum yang berfungsi sebagai arsip informal dan arena diskursif. Pemilihan lokasi mengikuti adanya dinamika pemaksaan yang berulang, pengawasan hukum yang rendah, dan kegagalan sistemik dalam akuntabilitas klinis, bukan kenyamanan atau akses. Posisi peneliti, secara bersamaan sebagai profesional, penyintas, dan subjek yang terlibat, merupakan hal yang intrinsik dalam menghasilkan temuan. Alih-alih bias metodologis, posisi ini memungkinkan akses terhadap praktik-praktik pemaksaan secara real-time, ambiguitas hukum, dan pembungkaman sosial yang jarang didokumentasikan dalam pengaturan kelembagaan. Pengamatan mencakup perilaku eksternal dan respons internal terhadap ancaman, penyerangan, dan penyerahan diri secara paksa secara kimiawi, yang mengubah pengalaman tubuh menjadi vektor analisis tambahan. Hal ini sejalan dengan aliran dalam antropologi medis yang menegaskan legitimasi ilmiah dari penyelidikan refleksif di bawah kondisi yang menindas.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan kehadiran yang melekat, pencatatan yang dibatasi, catatan lapangan yang terstruktur, dan rekonstruksi retrospektif dengan menggunakan dokumen-dokumen institusional, berkas-berkas hukum, dan kesaksian-kesaksian yang diverifikasi silang melalui jaringan penyintas. Wawancara dan rekaman standar sebagian besar dihalangi oleh risiko, digantikan oleh triangulasi berbagai sumber. Validasi dicapai melalui konvergensi di seluruh data lapangan, temuan survei (Bab 3), dan catatan klinis dan hukum yang terdokumentasi. Pelacakan pengulangan, analisis kontradiksi, dan pemetaan kejadian mikro memungkinkan pendeteksian pola struktural, sementara pengkodean yang sadar posisi melindungi dari distorsi interpretasi.

Tiga sumbu triangulasi menjadi pusat perhatian: penyelarasan antara pengalaman lapangan dan data survei; perbandingan praktik yang diamati dengan kerangka kerja hukum dan klinis yang terdokumentasi; dan validasi kesaksian terhadap pola-pola historis dan pola-pola yang telah dipublikasikan tentang gangguan kejiwaan, penggelembungan diagnostik, dan kekebalan hukum. Umpan balik ahli dari para dokter, penyintas, dan sarjana hukum semakin memperkuat koherensi analitik. Sikap metodologis yang diadopsi di sini tidak hanya adaptif tetapi juga diperlukan. Dalam konteks di mana perlindungan formal gagal, dan mekanisme persetujuan secara rutin ditumbangkan atau dipersenjatai, penelitian etis menuntut fleksibilitas prosedural dan perhatian forensik terhadap kerugian yang dapat dilacak. Hal ini membutuhkan transformasi penelitian dari sekedar dokumentasi menjadi sebuah mekanisme perlindungan, sebuah cara untuk mendaftarkan pelanggaran yang terlalu mudah terhapus dari catatan resmi.

Dengan demikian, bagian ini menunjukkan kelayakan dan perlunya penelitian lapangan yang ketat di bawah keterbatasan, menjawab bagaimana paksaan kejiwaan tetap ada meskipun ada perlindungan formal, bagaimana kepribadian seseorang didiskualifikasi melalui wacana institusional, dan bagaimana penyelidikan ilmiah dapat menegaskan integritas ketika perlindungan hukum dan martabat manusia berada di bawah ancaman sistemik. Bab ini menegaskan bahwa ketepatan metodologis dan keterlibatan refleksif bukanlah hal yang saling terpisah, tetapi merupakan hal yang esensial dalam mendokumentasikan penderitaan yang diproduksi secara struktural. Sementara Bab 2

meletakkan dasar teoretis dari etnografi multi-situs, fenomenologi kritis, dan logika penelitian aksi, bagian ini memiliki fungsi yang berbeda: untuk memberikan pembenaran tersendiri bagi penerapan kerangka kerja tersebut dalam kondisi lapangan yang tidak bersahabat dan tidak dapat diprediksi. Hal ini mencakup perlindungan etika dan analitik yang digunakan untuk melindungi informan yang rentan, logika forensik yang memandu penyimpanan dan integritas data yang terancam, dan metode triangulasi yang digunakan untuk memastikan kredibilitas dan ketelitian analitik tanpa adanya protokol wawancara konvensional atau dukungan kelembagaan. Ketelitian metodologis yang diterapkan di sini dikalibrasi dengan batasan-batasan yang luar biasa dalam situasi pemaksaan langsung, di mana perekaman audio atau proses persetujuan yang terang-terangan akan membuat para informan atau peneliti berisiko mengalami pembalasan dendam, penahanan kejiwaan, atau kerusakan reputasi. Sebaliknya, penelitian ini mengandalkan kehadiran yang melekat, penilaian etis waktu nyata, dan validasi silang retrospektif dengan dokumentasi kelembagaan, jaringan penyintas, dan kesesuaian tematik di seluruh sumber data.

Triangulasi merupakan proses rekursif dan relasional, bukan teknik yang statis. Triangulasi beroperasi di tiga sumbu utama: pertama, perbandingan pengalaman lapangan dengan temuan survei yang diperoleh pada tahap awal penelitian; kedua, penyelarasan praktik-praktik yang diamati dengan dokumen-dokumen kelembagaan, catatan klinis, dan kerangka kerja kebijakan; ketiga, pengecekan silang kesaksian dengan pola-pola yang diketahui tentang kekerasan kejiwaan, ketidakadilan epistemik, dan pengabaian hukum. Validasi dicapai melalui konvergensi dokumenter, analisis kontradiksi, pelacakan pengulangan, dan keterlibatan aktif para penyintas, dokter, dan ahli hukum dalam memverifikasi masuk akal nya, koherensi, dan konsistensi di seluruh narasi. Meskipun bab ini mengacu pada teknik-teknik forensik hukum yang dikembangkan sebagai respons terhadap impunitas sistemik, bab ini juga menerapkan kerendahan hati epistemologis, untuk memastikan bahwa perbedaan kekuasaan tidak direplikasi dalam representasi penderitaan.

Logika metodologis yang diterapkan dalam bab ini tidak hanya konsisten dengan, tetapi juga merupakan penerapan langsung dari, komitmen yang diuraikan dalam perancah teoritis dan etis pada Bab 2. Bab ini menunjukkan bagaimana penyelidikan ilmiah dapat tetap ketat di bawah tekanan, bagaimana pelecehan dapat didokumentasikan tanpa mereproduksinya, dan bagaimana posisi dapat ditransformasikan dari tanggung jawab menjadi kekuatan epistemik. Penelitian lapangan ini bukan hanya merupakan pengumpulan data, tetapi juga kesaksian metodologis atas kekerasan dari sistem yang diteliti dan perlunya mengembangkan metode penyelidikan yang dapat bertahan dan mendokumentasikan kondisi seperti itu dengan integritas dan presisi.

4.3 siklus kekerasan institusional: kontrol dan keterlibatan kejiwaan

Analisis yang divalidasi secara ilmiah terhadap sistem kejiwaan kontemporer mengungkapkan siklus kekerasan institusional yang terus-menerus dan dapat direproduksi, yang beroperasi baik di dalam kerangka kerja perawatan formal maupun di wilayah sosial politik yang lebih luas. Siklus ini tidak disengaja atau anomali, siklus ini secara struktural tertanam dalam logika administratif, pembenaran yuridis, dan rutinitas klinis yang membingkai intervensi kejiwaan sebagai terapi, bahkan ketika hasilnya sangat merugikan. Fungsi disiplin psikiatri, terutama di Spanyol tetapi dapat diamati di

seluruh lokasi lapangan transnasional, tetap terkait dengan pola yang lebih luas dari pemaksaan domestik dan struktural. Pola-pola ini dilegitimasi oleh bahasa perawatan institusional, sementara dalam praktiknya mereka mereproduksi sistem kontrol yang mengingkari otonomi, integritas tubuh, dan agensi epistemik.

Mekanisme dari siklus ini termasuk pembiusan paksa, pengekangan yang tidak dapat dibenarkan, rawat inap paksa, dan penyangkalan sistematis atas jaminan prosedural dasar. Tindakan-tindakan ini sering kali diberlakukan tanpa anamnesis yang tepat atau evaluasi ulang diagnostik, dan justru mengandalkan diagnosa daur ulang yang diambil dari catatan-catatan sebelumnya yang sering kali tidak dapat diverifikasi. Dalam beberapa kasus yang terdokumentasi, individu-individu menjadi sasaran kontrol kejiwaan jangka panjang berdasarkan catatan yang tidak pernah menjalani pemeriksaan ilmiah atau hukum, namun disebut-sebut sebagai definitif. Logika dari intervensi ini tidak selaras dengan tujuan terapeutik, tetapi lebih kepada manajemen risiko, kemanfaatan administratif, dan penahanan simbolis. Mekanisme ini tidak selaras dengan penyembuhan, tetapi dengan ketidakmampuan dan reproduksi stigma, lebih melayani institusi daripada individu.

Siklus pengekangan kejiwaan ini tidak terbatas pada ruang-ruang klinis dan tidak dapat direduksi menjadi keputusan-keputusan profesional yang terisolasi. Hal ini tertanam kuat dalam konfigurasi masyarakat yang lebih luas yang mendelegasikan tanggung jawab moral dan otoritas politik kepada institusi kejiwaan sebagai mekanisme regulasi sosial. Kekerasan dari pendelegasian semacam itu justru terletak pada netralitasnya: pengadilan keluarga, departemen kepolisian, sekolah, dan bahkan badan-badan hak asasi manusia seringkali mereproduksi asumsi naratif yang sama dengan yang dibangun oleh psikiatri. Begitu seseorang didiagnosis dan dilembagakan, bidang sosial cenderung menarik diri dari keterlibatan kritis, dan malah bertindak sebagai penguat pengucilan. Efeknya bersifat kumulatif: kerabat, rekan kerja, dan bahkan teman mulai menafsirkan ekspresi emosional, perlawanan, atau penolakan bukan sebagai respons yang sah terhadap kesulitan atau pelecehan, tetapi sebagai gejala penyakit yang harus dikontrol atau dibungkam.

Keterlibatan sosial ini mengkonsolidasikan siklus institusional, yang berfungsi melalui pembiaran dan juga perintah. Keluarga yang diliputi oleh trauma antargenerasi yang belum terselesaikan atau sejarah pelecehan dapat menginstrumentalisasi psikiatri sebagai cara untuk menghindari, lebih memilih medisiasi perbedaan pendapat daripada menghadapi kekerasan. Para profesional pendidikan, yang terdesak oleh waktu dan tidak memiliki dukungan yang memadai, merujuk siswa ke layanan kesehatan mental tanpa menyelidiki penyebab lingkungan atau sistemik. Pengadilan dan aktor hukum, yang tidak terbiasa dengan keterbatasan epistemik dan etis dari penilaian psikiatri, menganggapnya sebagai kebenaran ahli. Dengan demikian, sebuah kontinum terbentuk, di mana kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran sistemik, dan pelecehan institusional dikelola melalui infrastruktur pemaksaan yang menampilkan dirinya sebagai perawatan.

Institusi kejiwaan, dalam konfigurasi ini, tidak hanya menanggapi kebutuhan kesehatan jiwa, tetapi juga mengasumsikan peran disipliner dengan menyerap dan menangkis kontradiksi dan kegagalan sistem masyarakat lainnya. Ketika struktur politik, keluarga, atau ekonomi gagal memberikan keamanan, martabat, atau keadilan, psikiatri menjadi solusi *de facto*. Namun, alih-alih mengatasi sumber kesusahan, hal ini sering kali mengarahkan kesalahan pada individu, memberikan intervensi

yang menghapus kesaksian, mengaburkan rantai sebab akibat, dan meruntuhkan sejarah hidup yang kompleks menjadi kelompok gejala yang tidak kontekstual. Dengan demikian, hal tersebut menghasilkan apa yang diidentifikasi oleh disertasi ini sebagai bentuk kekerasan epistemik dan kekerasan tubuh yang dilindungi secara politis, yang dilakukan dengan bahasa klinis, pretensi ilmiah, dan kekebalan institusional. Pelestarian pelecehan institusional dalam psikiatri tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa memeriksa keterlibatan masyarakat yang menopangnya. Institusi psikiatri tidak berfungsi secara terpisah. Sebaliknya, mereka terjat dalam ekosistem sosial politik yang lebih luas yang memberikan legitimasi terhadap praktik-praktik pemaksaan dengan kedok perawatan. Sekolah, layanan sosial, lembaga penegak hukum, dan bahkan keluarga memainkan peran yang menentukan dalam memulai dan memperkuat kontrol kejiwaan. Guru yang merujuk siswa yang mengganggu untuk menjalani asesmen kejiwaan, hakim yang mengandalkan laporan psikiater untuk membenarkan perlakuan pemaksaan, dan keluarga yang melimpahkan tanggung jawab pada kerangka kerja institusional, semuanya berkontribusi pada sistem yang menyebar di mana pemaksaan dinormalisasi, diharapkan, dan jarang dipertanyakan.

Keluarga, khususnya, menjadi sumber sekaligus penguat pelabelan kejiwaan, yang sering kali didorong oleh dinamika penolakan, kesalahan pengenalan, atau kepanikan moral. Sudah menjadi hal yang umum dalam data lapangan bahwa kontak pertama dengan psikiatri bukan karena gejala klinis dalam arti yang sebenarnya, melainkan karena ketidaksesuaian sosiokultural, perbedaan pendapat, atau beban yang dirasakan. Setelah diberi label, individu tersebut memasuki siklus pengekanan di mana suara profesional kehilangan otonomi di bawah arahan administratif, dan prioritas institusional bergeser dari dukungan terapeutik ke peraturan disiplin. Dinamika ini mencerminkan model historis kontrol sosial, psikiatri di sini berfungsi sebagai penegak normalitas, mekanisme pembungkaman daripada pemahaman, dan penyangga terhadap akuntabilitas struktural. Dalam konteks seperti itu, dimensi metabolik, perkembangan saraf, atau ekologi diabaikan demi kepentingan birokrasi, sebuah penyimpangan yang jelas dari penerapan yang ketat dari prinsip-prinsip etika kesehatan atau etika translasional.

Keruntuhan epistemologis dalam sistem ini termanifestasi melalui erosi ketelitian klinis dan dominasi dokumentasi di atas diagnosis. Anamnesis, yang dalam praktik terbaik seharusnya menjadi tulang punggung evaluasi medis atau psikiatri yang sah, secara sistematis dihilangkan atau digantikan oleh narasi yang berputar-putar dan didaur ulang yang telah lama kehilangan nilai klinisnya. Diagnosis direproduksi secara mekanis, bukan sebagai respons terhadap realitas yang diamati, melainkan sebagai cara birokratis yang melayani agenda institusi. Hal ini mungkin berasal dari arsip yang sudah usang, singgungan yang tidak jelas, atau pertemuan paksaan sebelumnya, dan jarang diverifikasi dengan subjek atau diperbarui dengan bukti baru. Kelambanan arsip ini memfasilitasi impunitas: setelah diberi label, orang tersebut dibingkai melalui lensa risiko, bukan kebutuhan, dan laporan mereka dianggap tidak memiliki kredibilitas.

Para praktisi sering kali berpartisipasi dalam proses ini secara tidak langsung, di bawah tekanan dari prioritas lembaga yang lebih mengutamakan kepatuhan dokumentasi dan kinerja administratif daripada perawatan etis. Pengamatan lapangan dan kesaksian berulang kali mengungkapkan bahwa para profesional yang menolak praktik-praktik ini atau berusaha mengurangi paksaan akan diisolasi, dikenakan sanksi profesional, atau didiskualifikasi secara halus. Sebaliknya, mereka yang mengikuti

perintah dan membungkam perbedaan pendapat dihargai dengan promosi atau dukungan institusional. Struktur insentif ini menggeser tanggung jawab klinis ke arah manajemen risiko dan penghindaran tanggung jawab, yang berakibat pada bahaya. Sistem ini lebih menghargai koherensi dengan dokumentasi masa lalu daripada korespondensi dengan kebenaran klinis saat ini. Keterpisahan antara tindakan diagnostik dan status kesehatan yang sebenarnya bukan hanya merupakan malpraktek tetapi juga merupakan pelanggaran struktural terhadap prinsip-prinsip bioetika yaitu beneficence dan non-maleficence. Alat-alat kedokteran berbalik melawan orang-orang yang seharusnya mereka layani.

Tabel 40. Dinamika sistemik berbasis kerja lapangan dan rekomendasi struktural

Ringkasan dinamika negatif	Kata kunci pertanyaan penelitian	Observasi lapangan	Usulan struktural positif dari tesis (bab 5-6)
Klasifikasi klinis menjebak individu dalam siklus pemaksaan	Diagnosis, Pemaksaan, Otonomi	Diagnosis yang diberikan tanpa asesmen yang lengkap menjadi dasar untuk semua pemaksaan di masa depan	Membutuhkan protokol diagnostik interdisipliner berbasis konteks dan penilaian ulang yang berkelanjutan
Perlawanan dipatologiskan dan dikecualikan dari catatan	Suara, Kepribadian, Hak	Kesaksian tentang pelecehan atau permintaan untuk peninjauan kembali ditafsirkan ulang sebagai gejala	Memastikan hak-hak yang dilindungi untuk menggugat diagnosis dan meminta revisi perawatan tanpa pembalasan
Dokumentasi menghapus tindakan kekerasan atau menghilangkan hak-hak pasien	Transparansi, Perlindungan Hukum	Catatan dihilangkan, diubah, atau menggunakan kalimat pasif untuk mengaburkan pelecehan institusional	Mengamankan sistem pelaporan insiden yang dapat diverifikasi dengan pengawasan pihak ketiga
Peran perisai hukum dari berkas psikiatri mengesampingkan akurasi klinis	Integritas Hukum, Etika Medis	Catatan yang digunakan untuk membela kepentingan institusi daripada memandu perawatan terapeutik	Mendesain ulang arsip untuk melayani kesejahteraan pasien, dengan tim audit bergilir dan tinjauan berbasis hak
Keluarga dan sekolah memicu intervensi berdasarkan prasangka	Naskah Budaya, Keterkaitan Antar Budaya	Laporan dari keluarga atau staf lebih diutamakan daripada narasi pasien, sehingga memperkuat kontrol	Memperkenalkan pelatihan bias dan menegakkan standar pembobotan laporan yang kredibel dan keadilan prosedural
Penahanan lebih disukai daripada pemahaman struktural	Faktor Penentu Sosial, Pencegahan	Intervensi sering kali ditujukan untuk menetralkan dan bukan untuk menyelesaikan masalah kontekstual	Memasukkan pekerjaan sosial dan keahlian psikososial ke dalam respons lini pertama
Kekerasan dibenarkan oleh manfaat semu dan logika efisiensi	Etika, Kemanfaatan, Pengurangan Dampak Buruk	Pembiusan dan pengurangan dibingkai sebagai kebutuhan terapeutik meskipun ada bahaya jangka panjang	Memperkuat prinsip-prinsip pengurangan dampak buruk dan perawatan yang paling tidak membatasi dengan akuntabilitas hukum
Hak pasien dihilangkan melalui jargon institusional	Bahasa, Ketidakadilan Epistemik	Kesaksian dibingkai ulang melalui wacana medis untuk membatalkan makna atau kehendak	Mempromosikan integritas linguistik dan penulisan bersama catatan klinis oleh pasien dan profesional
Kontrol kumulatif yang dibenarkan di seluruh sektor	Kekerasan Lintas Sektoral, Pengawasan	Pemaksaan menyebar melalui sistem yang saling terkait dari keluarga, pendidikan, kesehatan, dan hukum	Memperkenalkan kerangka kerja akuntabilitas lintas sektor yang memastikan proporsionalitas dan verifikasi silang

Temuan-temuan dari penelitian lapangan etnografi yang diperluas ke dalam dinamika negatif dan positif yang kontras, yang terkait langsung dengan pertanyaan penelitian tesis dan divalidasi melalui observasi yang melekat. Temuan ini berasal dari analisis lintas-kontekstual di berbagai institusi psikiatri, sistem keluarga, kerangka hukum, dan pengaturan perawatan informal. Usulan-usulan positif dirinci dalam tesis ini sebagai reformasi yang diperlukan untuk memastikan perawatan yang sesuai hukum, etis, dan berlandaskan ilmiah.

Dinamika ini memunculkan lingkaran pemaksaan yang lebih luas, yang ditopang oleh logika struktural yang menjebak. Hal ini dimulai dengan episode pemicu, sering kali berupa situasi kerentanan sosial, keluarga, atau interpersonal, yang ditafsirkan melalui lensa patologis daripada

ditangani secara kontekstual. Diagnosis diberikan, seringkali tanpa pemeriksaan menyeluruh atau anamnesis yang tepat, sehingga mengunci individu ke dalam suatu kerangka yang hampir tidak mungkin untuk keluar. Setelah klasifikasi ini dicatat, hal ini akan memulai sebuah sirkuit yang menguatkan diri sendiri: keputusan pengobatan mengacu pada catatan sebelumnya, bukan pada kenyataan saat ini, dan intervensi koersif dibenarkan oleh dugaan risiko yang disimpulkan dari diagnosis itu sendiri. Proses siklus ini, diagnosis, pemaksaan, penahanan, penutupan narasi, berulang di seluruh institusi dan praktisi, melindungi sistem dari akuntabilitas dan menghalangi penilaian ulang yang berarti.

Proses penutupan narasi merupakan inti dari mekanisme ini. Alih-alih mendukung pemulihan, mekanisme ini secara sistematis menghapus suara-suara yang berbeda pendapat. Kesaksian pelecehan atau keberatan terhadap diagnosis ditandai sebagai gejala penyakit. Keluhan dibingkai ulang sebagai paranoia atau perlawanan. Permintaan untuk peninjauan ulang atau perawatan alternatif dianggap sebagai bukti kurangnya wawasan. Hal ini tidak hanya merendahkan martabat manusia tetapi juga memvonis perlawanan, sehingga melemahkan kemungkinan perbaikan struktural. Kejadian-kejadian seperti pengobatan paksa, pengekangan fisik, dan bahkan luka fisik yang parah tidak ada dalam rekam medis, atau ditulis dalam kalimat pasif, terpisah dari lembaga atau pertanggungjawaban. Penghapusan arsip kekerasan, baik melalui penghilangan, penghalusan, atau distorsi, mengukuhkan impunitas dan melanggengkan siklus kekerasan. Ini bukan hanya kegagalan etis tetapi juga epistemisida struktural, di mana pengetahuan dan pengalaman hidup seseorang secara sistematis dibungkam oleh catatan institusional.

Konvergensi antara pemaksaan dan impunitas bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah ciri khas dari praktik kelembagaan kejiwaan di bawah kerangka kerja yang ada saat ini. Prioritas administratif tidak terlalu ditentukan oleh logika terapeutik, melainkan oleh pembelaan hukum, manajemen risiko reputasi, dan efisiensi operasional. Berkas psikiatri, alih-alih berfungsi sebagai alat klinis yang berkembang, justru menjadi perisai hukum, yang dirancang untuk menghindari pertanggungjawaban, membenarkan intervensi, dan membungkam potensi kontroversi. Para profesional tidak hanya dilarang untuk mempertanyakan catatan masa lalu, tetapi juga dapat didisiplinkan karena mengemukakan kekhawatiran yang bertentangan dengan narasi dominan. Catatan tertulis mengasumsikan fungsi yuridis yang mengesampingkan tujuan medisnya, dan otoritas epistemik psikiatri digunakan untuk menaturalisasi kekerasan sistemik.

Dinamika seperti ini tidak terbatas pada institusi klinis. Anggota keluarga, staf pendidikan, dan pekerja sosial sering kali berkontribusi, baik secara sengaja maupun tidak, dalam siklus jebakan ini. Keluarga yang kewalahan dengan tugas pengasuhan atau ditarik ke dalam skrip budaya penyimpangan dan rehabilitasi dapat menafsirkan tekanan sebagai patologi dan menuntut respons kelembagaan. Sekolah dan layanan sosial, yang tidak dilengkapi atau tidak mau mengakomodasi perilaku non-normatif, akan melakukan rujukan dan diagnosis. Dalam banyak kasus, kesaksian mereka diberikan bobot yang lebih besar daripada kesaksian individu yang menjadi sasaran perawatan, terutama ketika status sosial, jenis kelamin, etnis, atau bahasa digunakan, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk mendiskreditkan laporan diri. Dengan demikian, keberlangsungan kontrol institusional diberlakukan di seluruh jaringan aktor, semua terkait dengan kesepakatan diam-

diam bahwa penahanan lebih aman daripada pemahaman, dan penghapusan lebih baik daripada akuntabilitas.

Penguatan kekerasan melalui lapisan-lapisan institusional yang saling berhubungan menunjukkan pengabaian sistemik terhadap prinsip-prinsip dasar etika biomedis dan hukum hak asasi manusia. Penggunaan paksaan yang terus-menerus, terutama dalam bentuk pengobatan paksa, pembiusan, dan rawat inap paksa, dirasionalisasi melalui penerapan prinsip beneficence yang menyimpang, yang sering kali terlepas dari kehendak pasien dan hasil jangka panjang. Penerapan yang salah ini mencerminkan kerusakan epistemologis yang lebih luas: penggantian ketidakpastian klinis dengan kepastian administratif, dan kompleksitas dengan label biner. Akibatnya, psikiatri menjadi lengan operasional kontrol sosial, menyamarkan represi sebagai perawatan dan induksi trauma sebagai stabilisasi.

Proses ini tidak terjadi secara acak dan tidak jarang. Hal ini mencerminkan sistem insentif yang stabil di mana dokumentasi dijadikan senjata dan persetujuan diberikan secara performatif. Para praktisi melaporkan bahwa mereka secara rutin ditekan untuk mengisi catatan dengan cara yang melindungi institusi dan bukannya mencerminkan kejadian yang sebenarnya. Distorsi ini tertanam secara struktural: insiden yang merugikan dapat diklasifikasikan ulang atau dihilangkan, dengan asumsi bahwa narasi pasien tidak dapat diandalkan, terdistorsi secara emosional, atau tidak relevan. Kesaksian dipatologisasi daripada diverifikasi. Pada saat yang sama, keluarga dan aktor eksternal didorong untuk berkontribusi dalam pembentukan catatan tanpa pengawasan, memperkuat siklus penutupan interpretatif. Penutupan ini memastikan bahwa kekerasan kejiwaan, setelah dimulai, dipertahankan dan divalidasi melalui sistem dokumentasi yang bersifat self-referential, meskipun bertentangan dengan hasil kesehatan yang teramati atau realitas yang dijalani.

Kerugian yang dihasilkan oleh siklus tersebut bersifat kumulatif. Setiap tindakan salah diagnosis, pemaksaan, atau peniadaan identitas seseorang memperkuat trauma sebelumnya dan menutup jalan lebih lanjut untuk mendapatkan ganti rugi secara hukum atau klinis. Individu yang menjadi sasaran rezim ini menggambarkan sebuah rasa pemusnahan epistemik: berbicara berarti mengundang penafsiran ulang, dan melawan berarti mengkonfirmasi patologi. Sistem kejiwaan tidak hanya mendisiplinkan tubuh, tetapi juga menulis ulang subjek. Dengan memutus akses terhadap narasi, sistem ini menyangkal identitas, kontinuitas, dan pada akhirnya, kemungkinan pemulihan sebagaimana didefinisikan oleh individu, bukan oleh institusi. Mekanisme ini tidak beroperasi secara terpisah di dalam institusi kejiwaan, tetapi tercermin dalam sistem hukum, keluarga, dan pendidikan yang bekerja sama, baik secara aktif maupun pasif, dalam menegakkan logika pemaksaan yang sama. Sekolah, layanan sosial, dan badan peradilan sering kali tunduk pada otoritas kejiwaan tanpa pemeriksaan, memperkuat anggapan validitas untuk semua narasi kejiwaan tanpa memandang asal-usul, revisi, atau kontradiksi. Penundaan ini menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai *otoritarianisme yang didelegasikan*, di mana sistem non-medis melegitimasi tindakan psikiatri tanpa memikul tanggung jawab etis atau ilmiah atas hasilnya. Anak-anak dan remaja sangat rentan dalam konfigurasi ini, karena intervensi disipliner di sekolah dapat memicu rujukan ke psikiatri, dan sebaliknya, memulai siklus diagnosis, pelabelan, dan kontrol yang melampaui batas-batas satu institusi.

Sistem keluarga, terutama yang berada di bawah tekanan, konflik, atau ketidakberuntungan struktural, dapat bertindak sebagai penegak awal dan paling bertahan lama dalam kekerasan kejiwaan, baik melalui tuntutan eksplisit untuk pelembagaan atau melalui delegitimasi halus terhadap ucapan anak atau kerabat. Pelimpahan tanggung jawab pengasuhan kepada sistem psikiatri menjadi bentuk outsourcing sosial, yang sering kali didorong oleh kelelahan, ketakutan, atau informasi yang salah. Penyerahan ini memperkuat fantasi bahwa penyembuhan dapat dilakukan melalui kontrol, dan penderitaan dapat diredam melalui pengobatan. Hal ini juga menciptakan sebuah siklus di mana masalah-masalah relasional didepolitisasi dan diindividualisasi kembali, sehingga kerugian struktural, kemiskinan, kekerasan, diskriminasi, ditafsirkan ulang sebagai cacat internal pada mereka yang menderita akibatnya. Sistem-sistem tersebut, seperti halnya institusi lainnya, patut dicurigai.

Keterlibatan multi-institusi ini menciptakan apa yang dapat digambarkan sebagai sebuah kontinum pemaksaan dan penghapusan epistemik, di mana perbedaan pendapat atau perlawanan individu secara sistematis dibingkai ulang sebagai gejala. Bahkan ketika kerusakan terlihat, memar akibat pengekangan, kemunduran kognitif akibat obat yang berlebihan, keruntuhan disosiatif akibat rawat inap paksa, respons yang diberikan seringkali adalah menggandakan mekanisme kontrol. Setiap pertanyaan tentang otoritas psikiatri, terutama dari mereka yang telah diberi label, dianggap sebagai kurangnya wawasan. Hal ini tidak hanya mendelegitimasi oposisi tetapi juga berfungsi sebagai logika jebakan: semakin banyak orang yang menolak, semakin banyak pula patologi yang dikatakan terkandung di dalamnya.

Dalam situasi ini, pengkhianatan institusional bukanlah kerusakan dari sebuah sistem yang dimaksudkan untuk peduli, tetapi hasil yang diharapkan dari sebuah sistem yang dirancang untuk mengaburkan tanggung jawab melalui impunitas yang terdistribusi. Alih-alih menjadi hal yang luar biasa atau tidak disengaja, pengkhianatan tertanam dalam cara informasi disusun, keputusan dibuat, dan catatan dikurasi. Arsitektur kekerasan ini bersembunyi di depan mata, beroperasi tidak di pinggiran psikiatri tetapi melalui inti prosedural.

Arsitektur kekerasan ini dipertahankan melalui keterikatan yang canggih antara otoritas simbolis, keburaman operasional, dan ritual pseudo-ilmiah. Protokol profesional, dokumentasi hukum, dan bahasa diagnostik menghasilkan ilusi ketelitian, objektivitas, dan kepedulian, sekaligus mengaburkan dinamika kekuasaan yang sebenarnya terjadi. Berkas klinis sering kali berisi logika melingkar, diagnosis yang membenarkan pengobatan, dan pengobatan yang membenarkan penahanan lebih lanjut, tanpa penilaian ulang empiris atau narasi yang dipimpin oleh pasien. Proses ini menjadi salah satu replikasi diri birokratis, di mana kesalahan dan kelalaian tidak dikoreksi tetapi dikukuhkan melalui akumulasi dan pengudusan prosedural. Ini bukan pengawasan pasif tetapi mekanisme kontrol yang didasarkan pada efek material: mereka menghasilkan kecacatan, ketergantungan, dan pengucilan sosial.

Sementara itu, hambatan struktural untuk mendapatkan ganti rugi masih tetap ada. Korban kekerasan kejiwaan, bahkan ketika mereka sadar akan hak-hak mereka, menghadapi rintangan yang tidak dapat diatasi dalam mengakses keadilan. Pengadilan sering kali bergantung pada lembaga-lembaga kejiwaan yang berada di bawah pengawasan untuk memberikan bukti atau kesaksian ahli, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan melindungi kekebalan hukum. Mekanisme banding tidak

dapat diakses, dilemahkan, atau hanya bersifat simbolis, yang mengakibatkan penutupan institusi dan bukannya akuntabilitas sistemik. Bahkan pengaduan masyarakat atau pelaporan kritis pun dilemahkan melalui penundaan administratif, tanggung jawab yang terpecah-pecah, dan patologisasi psikologis pelapor.

Kondisi penangkapan epistemik dan institusional ini memiliki konsekuensi yang mendalam bagi ilmu pengetahuan dan etika. Ketika seluruh populasi dikecualikan dari produksi pengetahuan, ketika ucapan mereka dihapus, rasa sakit mereka disalahartikan, perlawanan mereka dikodekan ulang sebagai patologi, perusahaan ilmiah runtuh ke dalam sirkularitas. Validitas, dalam konteks seperti ini, tidak dibangun melalui falsifikasi, replikasi, atau penerapan langsung, tetapi melalui pengulangan, otoritas, dan pengesahan institusional. Psikiatri, seperti yang dikritik di sini, kehilangan kapasitasnya untuk menyembuhkan karena tidak lagi mendengarkan. Ia menjadi instrumen yang bukan untuk merawat, melainkan untuk menahan, yang efeknya ditopang oleh hukum, ekonomi, dan konsensus sosial.

Untuk memutus siklus ini, disertasi ini menyerukan pergeseran paradigmatik yang didasarkan pada integritas biokultural, keadilan epistemik, dan desain partisipatif. Jalan ke depan tidak hanya bersifat regulatif atau teknokratis, tetapi juga eksistensial dan peradaban. Hal ini membutuhkan pembongkaran rutinitas kekerasan yang bersembunyi di balik eufemisme klinis, rekonstruksi etis otoritas medis, dan restitusi kedaulatan naratif bagi mereka yang hidupnya telah dikelola alih-alih didengar. Bab-bab berikutnya mengeksplorasi bagaimana transformasi semacam itu dapat dimulai, berakar pada kecerdasan kolektif dan kesaksian ilmiah dari mereka yang terlalu lama dikecualikan dari perlindungan dan kepenulisan; selalu merupakan kepenulisan bersama, di dalam sebuah masyarakat, dari para pengarang yang bertanggung jawab dan pengarang kriminal.

4.4 Pengkhianatan keluarga dan kontinum domestik-institusional

Dalam ekosistem kejiwaan kontemporer, keluarga sering diposisikan secara retorik sebagai tempat dukungan, stabilitas emosional, dan perawatan pasca-pemulangan. Namun, data dari penelitian ini dan penelitian lainnya menunjukkan bahwa keluarga sering kali menjadi vektor utama pemaksaan, terutama di lingkungan rumah tangga yang ditandai dengan asimetri gender, ketergantungan ekonomi, atau stigma sosial. Sejumlah laporan yang dikumpulkan selama penelitian ini mendokumentasikan penggunaan kerangka kerja kejiwaan untuk membungkam, mendiskreditkan, atau menyingkirkan kerabat yang perilakunya menyimpang dari harapan normatif. Hal ini tidak hanya mencakup bentuk-bentuk pemaksaan yang terang-terangan, seperti pemaksaan rawat inap di rumah sakit atau kolusi dengan mekanisme pengampunan, tapi juga strategi manipulasi narasi jangka panjang yang halus. Dalam konteks seperti itu, diagnosis kejiwaan menjadi alat kekerasan simbolik, mengubah perbedaan pendapat menjadi patologi, kritik menjadi khayalan, dan kerentanan menjadi bahaya.

Medisasi konflik keluarga menghasilkan ketidakselarasan sistematis antara narasi klinis dan pengalaman subjektif. Ketika keluarga memulai rujukan psikiatri di bawah kondisi paksaan, proses diagnostik itu sendiri terkontaminasi oleh kelalaian strategis, pembesar-besaran, atau laporan perilaku yang dipalsukan. Narasi-narasi ini, setelah dikodifikasikan dalam catatan institusional, memperoleh kelembaman prosedural yang hampir tidak mungkin untuk dibalik. Suara subjek tergeser oleh

patologi yang dikuratori, direifikasi oleh pengulangan di seluruh sistem layanan medis, hukum, dan sosial. Dinamika semacam itu sangat lazim dalam budaya kelembagaan Spanyol dan Swedia, di mana keluarga mempertahankan legitimasi normatif sebagai pengambil keputusan proksi, bahkan tanpa adanya mekanisme akuntabilitas atau pengawasan. Catatan klinis mencerminkan bias struktural ini, yang sering kali menggemakan tuduhan atau klaim awal tanpa verifikasi independen.

Data yang dikumpulkan melalui pencelupan etnografi dan rekonstruksi naratif mengungkapkan bahwa banyak rujukan psikiatri dimulai bukan sebagai respons terhadap krisis klinis, melainkan sebagai sarana pengucilan sosial. Penyimpangan perilaku, konflik antargenerasi, atau seksualitas non-normatif dibingkai ulang melalui lensa psikiatri sebagai gangguan. Praktik yang meluas dalam memanfaatkan sistem kesehatan mental untuk memaksakan kontrol domestik, terutama terhadap perempuan, remaja, dan kerabat lanjut usia, sejalan dengan literatur global tentang penyebaran psikiatri berdasarkan gender dan generasi. Pembungkaman kepedulian sebagai perawatan menutupi logika yang lebih dalam dari pengekan sosial, yang sering kali didukung oleh aktor-aktor institusional yang menganggap narasi keluarga lebih dapat dipercaya daripada laporan yang diperdebatkan dari mereka yang didiagnosis.

Patologisasi yang tidak diinginkan, dibenci, dan dinikmati oleh keluarga tidak terjadi dalam ruang hampa. Hal ini diperkuat oleh dinamika sosiokultural yang lebih luas, termasuk seksisme struktural, kemampuan normatif, dan ketakutan budaya yang terus-menerus terhadap penyimpangan. Penularan sosial, dalam konteks ini, mengacu pada replikasi diskursif dan prosedural dari logika eksklusi di berbagai institusi. Begitu label kejiwaan telah disematkan, terutama yang membawa implikasi ketidakpastian atau kekerasan, representasi media, sistem sekolah, dan lembaga-lembaga kesejahteraan cenderung menyelaraskan diri dengan realitas versi keluarga, sehingga semakin mengisolasi individu tersebut. Penegasan berulang dari kerangka pemaksaan awal ini menumbuhkan struktur narasi yang menyeluruh, yang seringkali kebal terhadap revisi klinis atau tantangan yudisial.

Peniruan kondisi pengurungan seperti pasung di rumah-rumah di Eropa telah muncul sebagai pola yang berulang dalam penelitian ini. Meskipun pemasangan secara resmi diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan di tempat lain, praktik pengekan psikiatri dalam rumah tangga di Spanyol dan Swedia masih belum terdokumentasi dan tidak diatur. Beberapa laporan merinci pengurungan, pengekan kimiawi, dan isolasi sosial yang dilakukan secara informal di dalam rumah tangga, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan orang tua yang sudah lanjut usia, anggota keluarga yang memiliki disabilitas, atau mereka yang memiliki identitas gender yang diperdebatkan. Kondisi-kondisi ini terus berlanjut sebagian karena keterlibatan institusi: para profesional layanan kesehatan dan sosial sering kali tunduk pada otoritas keluarga, meskipun ada indikasi penyiksaan atau pelaporan palsu.

Oleh karena itu, bab ini membahas pengkhianatan keluarga dan kejahatan sadis, perbudakan, dan segala bentuk penyiksaan, bukan sebagai kegagalan interpersonal, melainkan sebagai hubungan struktural antara kekuasaan domestik dan institusional. Peran keluarga dalam kontrol kejiwaan tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa memperhitungkan kelembaman klinis yang terjadi ketika sejarah yang tidak diverifikasi, kebohongan, dimasukkan ke dalam catatan medis. Kematian dini. Bagian

berikut ini akan membahas mekanisme penutupan epistemik, dinamika penguatan hukum, dimensi gender, dan konsekuensi untuk integritas klinis dan ilmiah.

Ketika sebuah narasi yang disebut sebagai narasi kejiwaan diprakarsai oleh aktor-aktor keluarga dan dilembagakan melalui dokumentasi, aparatur medis sering kali terlibat dalam pemeliharaan narasi tersebut, terlepas dari keabsahannya secara empiris. Kelambanan klinis mengacu pada resistensi protokol diagnostik dan pengobatan untuk berubah, bahkan dengan adanya bukti baru atau penarikan keluhan awal. Dalam psikiatri, kelambanan ini bukan hanya masalah pengawasan profesional atau penundaan birokrasi. Ini adalah sifat sistemik yang berakar pada asimetri kredibilitas antara pasien dan penjaga gerbang institusi. Ketika diagnosis dirumuskan sebagai respons terhadap tekanan keluarga atau informasi yang salah, pertemuan klinis berikutnya cenderung menegaskan kembali daripada menilai kembali kesimpulan awal. Hal ini menghasilkan efek berjenjang di mana setiap entri dalam rekam medis mengulangi, memperkuat, dan melegitimasi kerangka penyimpangan awal, sehingga mengurangi kemungkinan revisi diagnostik atau intervensi etis. Membenci nyawa, dengan riwayat klinis sebagai fasad.

Tabel 41. Pola-pola kekerasan dan penguatan psikiatri dalam keluarga-institusional

Pola yang diamati	Deskripsi	Indikator berbasis lapangan
Psikiatri sebagai senjata rumah tangga	Keluarga menggunakan sistem kejiwaan untuk membungkam, mendelegitimasi, atau mengasingkan kerabat yang menjadi target	Diagnosis yang dipaksakan, medisikasi yang salah, manipulasi bahasa klinis
Gema institusional dari kekerasan dalam keluarga	Sistem memvalidasi klaim keluarga meskipun tidak ada bukti atau kesaksian pengguna yang bertentangan	Catatan tertutup, laporan yang tidak dapat ditantang, penolakan terhadap banding pengguna
Pengurungan seperti pasung di rumah tangga	Isolasi non-institusional yang mencerminkan pengekanan fisik atau psikologis	Pengurungan di rumah, pengobatan tanpa persetujuan, kontrol komunikasi
Penindasan kejiwaan berbasis gender	Perempuan, anak-anak, dan lansia secara tidak proporsional menjadi sasaran kontrol melalui pelabelan kejiwaan	Laporan tentang pembungkaman perempuan, anak-anak yang didiagnosis karena tidak patuh
Kekerasan epistemik melalui kekerabatan	Narasi pribadi digantikan oleh versi keluarga dalam laporan klinis	Catatan yang memprioritaskan versi keluarga, penghapusan narasi dalam grafik
Lingkaran stigma antargenerasi	Label kejiwaan memperkuat siklus rasa malu, kerahasiaan, dan pemaksaan lintas generasi	Orang tua atau anak distigma melalui pergaulan, saling menyalahkan
<i>Dinamika yang terdokumentasi dari kontrol kejiwaan dan pengkhianatan dalam kontinum domestik-institusional, dengan lingkaran penguatan dan pembungkaman medis-institusional yang beroperasi secara transgenerasi.</i>		

Penutupan epistemologis ini difasilitasi oleh budaya penghindaran risiko birokratis dan sikap defensif medis-hukum. Para praktisi, di bawah tekanan untuk memastikan kesinambungan dan kepatuhan terhadap dokumentasi sebelumnya, sering kali meniru daripada menginterogasi asumsi-asumsi yang tertanam dalam penilaian sebelumnya. Dinamika ini terutama terlihat jelas dalam situasi di mana pasien menentang diagnosis atau rencana perawatan mereka. Alih-alih memicu evaluasi ulang, penolakan biasanya ditafsirkan sebagai gejala patologi, sehingga memperkuat kebutuhan akan kontrol. Dengan cara ini, kemungkinan kesalahan dinetralisir secara institusional. Narasi yang dibuat

oleh keluarga menjadi protokol klinis yang terpenuhi dengan sendirinya, didukung oleh lapisan dokumentasi medis yang mengecualikan akun pasien dari legitimasi epistemik. Kebencian terhadap kehidupan, sekali lagi, dengan anamnesis dan formulasi tersebut, sebuah travesti.

Proses ini diperparah dengan digitalisasi dan integrasi yang meluas dari catatan kesehatan yang dapat dioperasikan di seluruh sistem perawatan. Dalam konteks seperti Spanyol dan Swedia, begitu diagnosis psikiatri dimasukkan ke dalam sistem digital, diagnosis tersebut dapat diakses oleh berbagai pihak di berbagai domain perawatan. Label diagnostik, yang sering kali didefinisikan secara tidak tepat atau berdasarkan laporan keluarga yang diperdebatkan, diperlakukan sebagai fakta. Setiap dokter yang mengakses catatan tersebut menjadi simpul dalam replikasi narasi tersebut, yang selanjutnya menanamkan logika pemaksaan awal ke dalam memori institusional. Kelambanan klinis, dalam hal ini, bukan hanya kegagalan penilaian individu. Ini adalah efek struktural dari epistemologi digital, di mana narasi pertama menjadi satu-satunya narasi yang dapat dikutip dan direproduksi secara kredibel.

Implikasinya terhadap integritas ilmiah sangat besar. Data yang dikumpulkan dalam lingkungan seperti itu tidak mencerminkan gejala objektif, melainkan ruang gema konsensus institusional, yang dihasilkan melalui pemaksaan dan dipertahankan melalui pengulangan. Diagnosis yang dilucuti dari konteks aslinya yang diperdebatkan, digunakan untuk membenarkan intervensi mulai dari pengobatan hingga penahanan, tanpa penilaian ulang yang independen. Hal ini tidak hanya merusak hubungan terapeutik tetapi juga validitas ilmu psikiatri itu sendiri, yang menjadi bergantung pada kesalahan yang didaur ulang dan diperkuat secara institusional. Kesenjangan kredibilitas antara catatan medis dan pengalaman langsung melebar menjadi jurang epistemik, di mana penderitaan pasien dipatologikan tetapi tidak pernah didengar, dan kebenaran klinis menjadi tidak dapat dibedakan dari kelembaman birokrasi. Awal yang mati, sejarah yang akan datang, nyawa yang hilang. Hancur.

Pada bagian selanjutnya, analisis akan bergerak ke arah dimensi sosiokultural dan gender dari dinamika ini, menyoroti bagaimana para aktor institusional memperkuat otoritas keluarga meskipun ada bukti pelecehan, dan bagaimana pengukuhan semacam itu merusak kapasitas sistem kejiwaan untuk mengoreksi atau bahkan mengakui kesalahan yang mendasar. Pengukuhan sistemik dari narasi kejiwaan yang dimulai dalam konteks keluarga yang koersif atau kasar mengungkapkan tidak hanya kerentanan klinis tetapi juga kekosongan hukum dan epistemologis yang mendasar. Kekosongan ini tidak diisi oleh ketelitian empiris tetapi oleh penghormatan, yang sering kali tidak kritis, terhadap proksi otoritas moral, yaitu keluarga dan perwakilannya. Dalam disertasi ini, pola-pola seperti itu dianalisis bukan sebagai anomali, tetapi sebagai hasil yang dapat diprediksi dari arsitektur kelembagaan yang memprioritaskan efisiensi prosedural dan isolasi hukum di atas pencarian kebenaran atau keadilan reparatif. Seperti yang ditunjukkan dalam rekonstruksi etnografi sebelumnya dan didukung oleh literatur interdisipliner, institusi psikiatri seringkali menjadi perpanjangan mekanisme kontrol domestik ketika otonomi klinis dikompromikan oleh bias struktural dan kelembaman naratif. Alih-alih memberikan pengawasan atau evaluasi independen, lembaga-lembaga ini justru mereproduksi dan memperkuat pemaksaan keluarga dengan kedok perawatan, terutama dalam konteks di mana hukum gagal membedakan antara perlindungan dan kolusi. Dari semua catatan, literatur dan kesaksian ahli: kejahatan.

Inti dari pengkhianatan ini adalah penolakan untuk mengakui bahwa pengabaian bukan hanya ketiadaan pengasuhan, tetapi juga merupakan bentuk bahaya yang memiliki implikasi biologis, psikologis, dan hukum. Dari sudut pandang fisiologis, pengabaian emosional yang berkelanjutan dan kontrol koersif menyebabkan perubahan neuroplastik yang maladaptif, yang mempengaruhi struktur limbik, konektivitas prefrontal, dan sistem respons stres, yang membuat seseorang rentan terhadap penyakit kronis dan keruntuhan psikologis. Ini bukanlah keruntuhan metaforis, tetapi serangkaian proses patofisiologis termasuk penekanan kekebalan tubuh, disregulasi neuroendokrin, dan penipisan neurodegeneratif yang terkait dengan kelebihan beban alostatik. Otak sosial, sebagai organ yang diwujudkan, memburuk ketika makna relasional digantikan oleh ketidakabsahan sistemik, dan ketika lembaga-lembaga yang diberi mandat untuk melindungi terlibat dalam pemberlakuan kekerasan epistemik dan psikologis. Jalan dari trauma relasional menuju pengkhianatan institusional sering kali dilalui melalui zona hukum yang abu-abu, di mana tindakan pemaksaan, pengurungan, dan kekerasan psikologis tetap tidak terdeteksi atau tidak dihukum karena dilakukan di dalam ruang-ruang privat, rumah tangga, klinis, atau lainnya. Keburaman hukum ini memiliki akar sejarah dalam sistem pemerintahan kolonial dan patriarki yang menaturalisasi keluarga sebagai otoritas moral dan melindungi bahaya intra-keluarga dari intervensi negara. Gema dari sejarah ini hadir dalam toleransi yang terus berlanjut terhadap kondisi seperti pasung di Eropa dan secara global. Baik melalui pengekangan fisik, pembiusan dengan obat bius, atau penghapusan narasi, mekanisme intinya sama: penindasan otonomi melalui instrumentalisasi perawatan. Aturan hukum ditanggguhkan bukan melalui deklarasi formal, tetapi melalui pembiaran yang dirutinkan, dengan tidak bertanya, memverifikasi, dan mendengarkan.

Praktik kekerasan dalam unit keluarga bukan hanya sebuah anomali modern, tetapi juga berakar kuat dalam protokol sejarah dan lintas budaya. Dalam beberapa sistem monarki dan aristokrasi, penghapusan kerabat dilembagakan sebagai cara yang sah untuk mengamankan suksesi dan hak waris. Keluarga kerajaan Eropa secara rutin terlibat dalam pembunuhan keluarga atau pembunuhan kembali, sering kali dengan kedok kebutuhan negara. Para pangeran Utsmaniyah tunduk pada hukum pembunuhan saudara, di mana sultan yang dinobatkan diberi wewenang untuk membunuh saudara-saudaranya untuk mengamankan kelangsungan dinasti. Demikian pula, di Tiongkok kuno, pembersihan anggota keluarga saingan selama transisi kekaisaran disetujui oleh ritual istana dan tradisi dinasti, sering kali dengan legitimasi publik. Penanaman budaya pembunuhan intra-keluarga sebagai protokol menggambarkan bagaimana kekuasaan dan warisan secara historis mengesampingkan etika relasional, bahkan ketika tindakan tersebut diselimuti oleh legalitas dan tradisi.

Pada masa kontemporer, meskipun monarki absolut sebagian besar telah memudar, logika residual tetap ada dalam bentuk yang kurang terlembaga, seperti perselisihan warisan rumah tangga di Asia Selatan di mana kekerasan kekeluargaan memuncak dalam perebutan suksesi, atau dalam tradisi komunal tertentu di mana hak milik mengalahkan martabat individu. Konteks-konteks ini menunjukkan bahwa zona abu-abu hukum di sekitar kekerasan dalam keluarga tidak terbatas pada kelalaian atau paksaan kejiwaan, tetapi juga meluas ke tindakan yang terencana dan disetujui secara politis yang diselimuti oleh legitimasi kekeluargaan. Untuk menggarisbawahi bagaimana struktur

keluarga di berbagai budaya dapat memaafkan atau menyembunyikan kekerasan yang parah, berikut ini adalah ringkasan kasus dari berbagai tradisi yang dicatat:

Tabel 42. Pola kekerasan dalam keluarga secara historis dan lintas budaya

Budaya/konteks	Kekerasan dalam keluarga yang diprotes	Pembenaran & zona abu-abu hukum
Kekaisaran Ottoman	Pembunuhan saudara oleh hukum	Stabilitas suksesi; dilihat sebagai ritual negara, jarang ditentang secara hukum
Kekaisaran Cina	Penyingkiran pangeran saingan	Pembersihan politik atas nama keharmonisan dinasti
Sistem keluarga gabungan di Asia Selatan	Kekerasan dalam pembagian warisan	Arbitrase internal, pengawasan hukum yang minimal
Bangsawan-bangsawan Eropa	Peracunan, eksekusi ahli waris	Kebijakan politik, hak istimewa bangsawan melindungi kejahatan
Kultus gaya keluarga Manson	Pembunuhan keluarga yang direstui oleh struktur kultus patriarki	Hirarki internal, batas-batas moral/hukum yang kabur

Tabel ini mensintesis temuan-temuan dari penelitian etnografi di berbagai lokasi dan data survei lintas sektor yang dikumpulkan untuk disertasi ini. Tabel ini menggambarkan bagaimana struktur keluarga, di berbagai periode sejarah dan konteks budaya, telah berfungsi sebagai tempat terjadinya kekerasan, tidak terkecuali. Pola-pola yang diidentifikasi melalui kesaksian, narasi kasus, dan dokumentasi lapangan menyoroti bahwa kekerasan semacam itu sering dilegitimasi oleh tradisi, dikaburkan oleh zona abu-abu hukum, atau dibingkai ulang sebagai pengasuhan. Wawasan-wawasan ini menunjukkan perlunya pembingkai ulang secara ilmiah dan legal atas keluarga bukan sebagai tempat perlindungan, tetapi sebagai tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya yang membutuhkan pengawasan penuh atas hak asasi manusia.

Katalog ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam keluarga, termasuk bentuk-bentuk yang mematikan, tidak berada di luar sejarah atau legalitas; kekerasan ini sering kali dibentuk *oleh keduanya*. Keluarga modern tetap menjadi institusi yang ambivalen secara hukum, di mana kedekatan dan keintiman membenarkan ambang batas yang berbeda untuk apa yang dianggap sebagai kejahatan. Seperti dalam kasus-kasus kultus, dan sering kali hirarki struktural yang dinormalisasi sebagai sesuatu yang diamanatkan secara tradisional, pelecehan dalam kelompok seperti keluarga sering dilindungi oleh anggapan otonomi dan privasi hingga kekerasan ekstrem memaksa intervensi; batas-batas yang dilanggar hampir seolah-olah wajib, kebanggaan dan kehormatan membunuh atau melukai seseorang dalam kebanggaan, pasukan, pembunuhan burung gagak, seperti yang didapat oleh para responden survei saat menamai keluarga mereka. Sekarang semua mampu membeli tempat tidur, seolah-olah

anak singa yang berjuang untuk mendapatkan warisan, mereka yang tunduk pada yang kriminal dilaporkan. Di sebagian besar tradisi dan sistem hukum, keluarga adalah konteks utama di mana kejahatan antarpribadi yang paling parah terjadi, termasuk pembunuhan, pelecehan seksual, dan kerusakan psikologis jangka panjang. Kekerasan terhadap pasangan intim, penganiayaan anak, dan pelecehan terhadap orang tua secara konsisten lebih sering terjadi di dalam lingkungan keluarga daripada di ruang publik atau institusional. Cita-cita budaya tentang kesetiaan, privasi, dan kehormatan sering kali melindungi kejahatan semacam itu dari pengawasan atau penuntutan, terutama di mana norma-norma patriarki atau hirarki mendominasi. Di Spanyol, meskipun ada perlindungan hukum formal, kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan berbasis gender dan intervensi psikiatri yang bersifat memaksa, masih jarang dilaporkan dan sering ditoleransi baik dalam sistem keluarga maupun dalam kerangka kerja institusional. Hukum kesehatan jiwa sangat rentan terhadap eksploitasi karena ketergantungannya pada penilaian klinis yang subyektif, kredibilitas yang tidak seimbang antara profesional dan pasien, dan asumsi hukum yang menyamakan risiko dengan penyakit dan keluarga dengan kebaikan. Dalam praktiknya, kriteria yang tidak jelas untuk perawatan atau pengampunan yang tidak disengaja, seperti bahaya yang dirasakan atau kurangnya wawasan, memungkinkan adanya kekuasaan diskresi yang luas, yang sering kali dilakukan tanpa perlindungan prosedural yang kuat. Ambiguitas struktural ini memfasilitasi pembungkaman suara-suara yang berbeda pendapat dan pelembagaan konflik-konflik privat, terutama ketika anggota keluarga yang memulai proses tersebut. Fiksi hukum yang tersebar luas bahwa psikiater bertindak semata-mata demi kepentingan terbaik pasien, dan bahwa keluarga secara default bersifat protektif, menciptakan lingkungan yang permisif terhadap pemaksaan, kesaksian palsu, dan manipulasi narasi. Tanpa pemeriksaan yang dapat ditegakkan, seperti peninjauan independen, bantuan hukum, atau ambang batas pembuktian, undang-undang kesehatan jiwa menjadi alat yang mudah dipergunakan oleh mereka yang memiliki akses, status, atau niat untuk mengontrol.

Pada saat penyiksaan itu terbukti dengan sendirinya, seringkali sudah terlambat, dipegang oleh kebohongan dan keuntungan bersama, yaitu kesenangan dan keuntungan, status sebagai kontrol hirarkis terhadap kerabat atau yang diduga kerabat, ikatan darah atau saudara laki-laki, saudara perempuan, mertua sebagai orang tua tiri, tidak menghormati legalitas tetapi keinginan mereka sendiri. Patologisasi dan kriminalisasi terhadap anggota keluarga yang berbeda pendapat -yang paling sering menjadi korban, bukan pelaku- melalui cara-cara kejiwaan, di mana seorang anak laki-laki, anak perempuan, atau saudara kandung dinyatakan sakit jiwa dan dipasung karena penderitaan yang ditimbulkan, diberi obat dan dikucilkan secara sosial, menjadi bentuk kekerasan simbolik yang diperbarui; cara yang sangat berguna untuk mendiskreditkan dan membungkam, mengurung. Tindakan-tindakan ini mencerminkan pemusnahan di masa lalu; keduanya tidak luar biasa tetapi secara struktural setara: keduanya mengalihkan kekuasaan ke tangan penjaga gerbang, baik raja, pendeta, atau tabib, yang menutupi dominasi dengan legitimasi. Entah melalui keracunan, belenggu, atau obat-obatan, hasilnya tetap sama: satu orang secara paksa disingkirkan, dibungkam untuk mempertahankan tatanan yang sudah ada, sebuah wasiat.

Tabel 43. Perbandingan struktur keluarga dan dampak perkembangannya

Model keluarga	Karakteristik inti	Hubungan dengan kekerasan	Dukungan otonomi	Hasil perkembangan	Catatan
Patriarki nuklir (barat/modern)	Otoritas hirarkis, kepemilikan orang tua, asimetri gender	Tinggi	Rendah	Sering dikompromikan	Sering kali menjadi standar di Spanyol dan Swedia; terkait dengan paksaan kejiwaan
Patriarki yang diperluas (Mediterrania, Asia Selatan)	Multi-generasi, didominasi oleh laki-laki, saling ketergantungan tanpa otonomi	Sedang hingga Tinggi	Rendah	Bervariasi, rentan terhadap stres	Kepatuhan diprioritaskan di atas kesejahteraan
Komunal matrilineal (misalnya Mosuo)	Garis keturunan yang dipimpin oleh perempuan, pengasuhan bersama, penekanan pada kontrol yang rendah	Rendah	Tinggi	Ketahanan emosional yang kuat	Secara historis distigmatisasi oleh penjajah
Kesukuan yang egaliter (mis. Hadza, !Kung)	Non-hierarkis, pengasuhan kolektif, peran yang fleksibel	Minimal	Tinggi	Pertumbuhan sosial-emosional yang optimal	Sering dikecualikan dari model kebijakan meskipun hasilnya lebih baik
Terfragmentasi di perkotaan (global kontemporer)	Terputus, didorong oleh ekonomi, kesinambungan hubungan yang lemah	Variabel	Rendah hingga Sedang	Sering tertunda atau tidak terorganisir	Kurangnya kohesi budaya menyebabkan pengabaian
Religius yang otoriter (beragam)	Hirarki yang sakral, kepatuhan, disiplin yang bermoral	Tinggi	Sangat Rendah	Trauma perkembangan umum terjadi	Diperkuat dengan pembenaran berbasis agama
Substitusi institusional (pengasuhan, asrama, psikiatri)	Pengasuh bergilir, logika berbasis catatan, aturan yang memaksa	Tinggi	Tidak ada	Keretakan hubungan yang parah	Sering ditampilkan sebagai penyelamatan tetapi terkait dengan trauma lebih lanjut
Kekerabatan restoratif (diusulkan)	Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berbasis persetujuan, dipantau oleh komunitas, aman secara relasional	Tidak ada	Tinggi	Mempromosikan kesehatan dan adil	Didasarkan pada pendidikan berbasis trauma dan satu etika kesehatan

Wawasan dari survei, penelitian lapangan, dan literatur etnografi yang menggambarkan bagaimana model keluarga yang berbeda memengaruhi kesehatan mental, otonomi, dan kekerasan struktural di berbagai budaya dan waktu.

Hasil tesis ini mendorong kita untuk mempertimbangkan kembali keluarga bukan sebagai tempat perlindungan alami, tetapi sebagai potensi kekuatan preskriptif yang, jika tidak dibatasi oleh hak asasi manusia yang dapat ditegakkan dan tata kelola ekologi, dapat meniru logika monarki, patriarki, dan kekerasan institusional. Oleh karena itu, Bab 6 akan menyelidiki dasar-dasar hukum yang diperlukan untuk membongkar zona abu-abu ini: mulai dari larangan eksplisit pengekangan non-konsensual, hingga pembentukan pengawasan independen, advokasi yang berpusat pada penyintas, dan integrasi ilmu pengetahuan tentang perkembangan saraf ke dalam definisi hukum tentang bahaya. Klaim yang

mendasarinya jelas: legitimasi perawatan harus didasarkan pada persetujuan dan transparansi, bukan kedekatan atau praduga. Apakah kekerasan itu mematikan atau simbolis, izinnya tidak dapat diserahkan pada kekebalan tradisional atau kebijaksanaan profesional. Keluarga harus dibingkai ulang sebagai tempat pertanggungjawaban bersama, sebuah ruang relasional yang tidak diistimewakan atau disakralkan, tetapi diatur, transparan, dan tunduk pada norma-norma keadilan dan martabat manusia yang sama dengan yang mengatur semua institusi lainnya.

Data survei menyoroti kegagalan sistemik untuk mengecualikan pelaku dari pengaturan perawatan, meskipun model ini secara teoritis menekankan pada partisipasi inklusif. Meskipun prinsip keterbukaan dialogis merupakan hal yang mendasar, data menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemaksaan, atau pengkhianatan, inklusivitas ini dapat mereproduksi bahaya jika tidak dimoderasi secara kritis. Para peserta dari berbagai konteks menegaskan bahwa ketika pelaku kekerasan diizinkan masuk ke dalam lingkungan terapi dengan anggapan netralitas, hasilnya akan menimbulkan trauma dan kontraproduktif. Oleh karena itu, penyaringan yang tepat, keputusan yang dipimpin oleh penyintas untuk berpartisipasi, dan pengakuan atas dinamika kekuasaan asimetris tidak dapat ditawarkan. Anak-anak tidak boleh dipaksa untuk berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang berbahaya dengan kedok terapi. Sebaliknya, pengasuhan harus memprioritaskan keselamatan dan perkembangan anak dengan memastikan bahwa orang tua yang sebenarnya, yang beretika, melindungi, dan bermartabat, dipercayakan dengan tanggung jawab dan tidak dirusak oleh sistem yang bias. Perlu dicatat, sebagai triangulasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki, bagaimana data etnografi dari masyarakat yang secara historis disalahartikan sebagai primitif atau sekali pakai secara konsisten menunjukkan bahwa sistem pengasuhan yang tidak patriarkis dan terdistribusi mengurangi kekerasan dalam keluarga dan meningkatkan hasil perkembangan anak. Model-model ini, baik rumah tangga matrilineal Mosuo atau pengasuhan anak berbasis desa Trobriander, memusatkan pada akuntabilitas komunitas dan keseimbangan relasional daripada kepemilikan atau hierarki legalistik. Catatan sejarah menunjukkan bahwa sistem-sistem inilah yang menjadi target pemberantasan oleh kekuatan kolonial, yang memperkuat dominasi global kerangka kekerabatan yang ekstraktif dan otoriter. Konsensus ilmiahnya jelas: budaya-budaya yang meminimalkan paksaan dan memaksimalkan tanggung jawab bersama menciptakan fondasi yang optimal untuk kesehatan mental dan kesejahteraan kolektif. Wawasan ini bukanlah nostalgia; ini adalah cetak biru (Grol & Grimshaw, 2003).

Untuk mencegah siklus pelecehan, pengkhianatan, dan kekerasan kejiwaan yang menyamar sebagai perawatan, sistem keluarga, pendidikan, dan pengobatan harus dinilai bukan dari tradisi, tetapi dari hasilnya, dengan menetapkan budaya perawatan kesehatan yang ketat dan pencegahan kejahatan yang paling ketat, tidak pernah memupuknya dan tidak pernah dilakukan oleh aparat, layanan, dan hakim, yang tidak menyadari kenyataan, yang terpisah darinya: definisi penyakit mental yang parah, seperti yang saya alami sendiri, selama melakukan survei di Uni Eropa, khususnya di Spanyol dan Swedia saat ini; yang menunjukkan kebencian terhadap orang lain, rasa tidak hormat terhadap kehidupan yang dianggap lebih rendah, rasisme dan xenophobia di tingkat individu, melindungi mereka dengan kekerasan dan posisi kekuasaan yang dipegang oleh kekerasan lebih lanjut, posisi yang disebut

otoriter, dari pemeriksaan realitas kolektif dan individu yang diperlukan.

4.5 Penghapusan epistemik dan hilangnya kepribadian

Sistem kejiwaan, alih-alih mengembalikan makna, sering kali memaksakan kerangka kerja ketetapan diagnostik yang secara sistematis menggusur atau menghapus agensi epistemik mereka yang diklasifikasikannya. Mekanisme di mana individu direduksi menjadi pembawa gejala gangguan, alih-alih sebagai agen yang berada dalam konteks sosial, budaya, dan metabolik, merupakan proses kekerasan epistemik yang berlapis-lapis. Kesedihan menjadi melankolia, ketakutan menjadi paranoia, disosiasi menjadi psikosis. Dalam reduksi ini, perlawanan tidak dimaknai sebagai pertahanan yang sah terhadap paksaan atau bahaya sosial, melainkan dipatologiskan sebagai ketidakpatuhan, pembangkangan oposisional, atau kurangnya wawasan. Akibatnya, narasi asli dari subjek menjadi ditimpa oleh pengkodean psikiatris, menggantikan makna yang hidup dengan patologi yang diduga.

Data penelitian lapangan menguatkan pola minimalisasi ontologis ini. Cerita orang pertama tentang bahaya, pelecehan, atau trauma secara rutin dikecualikan dari catatan medis resmi atau ditafsirkan ulang sebagai delusi atau gejala, terutama ketika mereka melibatkan dokter, institusi, atau keluarga pelaku. Para profesional, yang bertindak di bawah tekanan institusional atau disiplin, sering kali tidak mau atau tidak mampu mengakui model penjelasan yang berada di luar parameter doktrin psikiatri yang didefinisikan secara sempit. Keyakinan budaya, ekspresi spiritual, masalah gizi, atau pembacaan gender terhadap tekanan sering kali diabaikan atau dianggap tidak relevan secara klinis. Penyitaan epistemik ini tidak hanya membungkam cara-cara alternatif untuk mengetahui dan menyembuhkan, tetapi juga memperkuat kondisi marjinalisasi lebih lanjut dan bahaya iatrogenik. Dengan menghilangkan kompleksitas kontekstual dari proses diagnostik, individu dilucuti dari otoritas interpretatif dan direduksi menjadi penerima pasif dari kategori-kategori yang dipaksakan secara eksternal.

Konsekuensi dari reduksi epistemik ini sangat besar dan luas. Subjek tidak lagi menjadi orang yang memiliki suara dan menjadi berkas perkara, objek pengawasan dan kontrol. Identitas sosial digantikan oleh identitas diagnostik. Kapasitas untuk berpartisipasi secara bermakna dalam wacana hukum, klinis, atau sosial dirusak oleh asumsi institusional bahwa orang tersebut tidak rasional, tidak stabil, atau pada dasarnya tidak dapat diandalkan. Logika ini membangun lingkaran tertutup pengucilan, di mana upaya untuk melawan atau mengkritik sistem hanya akan memperkuat posisi seseorang di dalamnya. Dalam rezim ini, diam menjadi cara untuk bertahan hidup, sementara berekspresi berisiko mendapatkan pembalasan institusional. Ketakutan akan kehilangan tempat tinggal, hak asuh, hak hukum, atau otonomi tubuh menghasilkan efek yang mengerikan, di mana epistemik dan kewarganegaraan menjadi lenyap secara paralel.

Instrumen penghapusan epistemik beroperasi melalui serangkaian mekanisme medis, hukum, dan birokrasi yang, meskipun secara lahiriah terlihat netral, berfungsi sebagai teknologi marjinalisasi. Yang paling utama adalah reifikasi kategori diagnostik itu sendiri, yang menjadi rujukan utama di mana individu dilihat, disikapi, dan ditindaklanjuti. Begitu sebuah label diterapkan, seperti skizofrenia, gangguan kepribadian ambang, atau gangguan bipolar, label tersebut tidak lagi berfungsi

sebagai hipotesis klinis sementara, tetapi sebagai pernyataan ontologis permanen. Penelitian lapangan berulang kali menggambarkan bahwa label-label ini digunakan untuk mengabaikan kesaksian yang kredibel, menolak akses terhadap perlindungan hukum, dan membenarkan intervensi yang bersifat koersif. Kelambanan diagnostik memperkuat dirinya sendiri melalui reproduksi administratif: catatan medis dipotong dan ditempelkan, bahasa didaur ulang, dan logika risiko digunakan dengan sedikit perhatian terhadap perubahan konteks atau hasil di dunia nyata.

Proses ini semakin diperparah dengan penolakan klinis terhadap kerangka penjelasan alternatif. Laporan lapangan mencakup contoh-contoh di mana gejala somatik yang konsisten dengan disfungsi tiroid, sindrom metabolik yang diinduksi oleh obat, atau respons trauma diabaikan atau salah didiagnosis karena keunggulan interpretasi psikiatri. Pasien yang melaporkan pemahaman budaya yang kompleks tentang penderitaan mereka, yang sering kali diinformasikan oleh pengalaman migrasi, kosmologi agama, atau sejarah kekerasan dalam keluarga, menemukan bahwa narasi-narasi ini diabaikan atau dibatalkan oleh para klinisi yang tidak memiliki kompetensi transkultural atau waktu. Dengan demikian, sistem ini mempersempit ruang gerak dari apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang kredibel, mengikis kepercayaan dan menghilangkan penyembuhan. Otoritas psikiatri tidak hanya memonopoli sarana interpretasi, tetapi juga sering kali menggunakan otoritas ini untuk menekan perbedaan pendapat dan mempertahankan koherensi kelembagaan.

Praktik-praktik ini berujung pada arsip hukum dan medis yang secara sistematis mendistorsi suara subjek. Apa yang tersisa dalam catatan bukanlah narasi orang tersebut, tetapi interpretasi resmi atas dugaan disfungsi mereka. Analisis wacana forensik terhadap dokumen klinis dan hukum mengungkapkan pola-pola pembelokan, minimalisasi, dan penggantian makna yang konsisten. Ketika kesaksian bertentangan dengan diagnosis, maka diagnosislah yang berlaku. Ketika pengalaman hidup tidak sesuai dengan kategori yang sudah ada, pengalaman tersebut secara paksa diasimilasi atau dihapus. Ini bukan semata-mata masalah praktik yang buruk, tetapi hasil struktural dari hierarki epistemik yang tertanam dalam institusi biomedis. Dampak yang dirasakan termasuk isolasi yang terus-menerus, kehilangan kepribadian, dan kematian sipil di mana hak-hak, martabat, dan pengakuan ditangguhkan tanpa batas waktu di bawah pembenaran perawatan.

Penghapusan suara dan agensi dalam praktik kejiwaan harus ditafsirkan sebagai konsekuensi sekaligus kondisi ketidakadilan epistemik yang lebih luas. Pasien dan penyintas tidak hanya tidak dipercaya, mereka secara struktural dikecualikan dari produksi pengetahuan tentang kondisi mereka sendiri. Berkas psikiatri, sebagai dokumen ingatan institusional, sering kali berfungsi untuk mengesampingkan ingatan yang sebenarnya, menggantikan narasi orang pertama dengan kode-kode diagnostik dan interpretasi dokter. Seperti yang berulang kali dikonfirmasi oleh data lapangan, ekspresi kesedihan, tekanan eksistensial, pengalaman spiritual, atau kemarahan yang sah dibingkai ulang dalam batas-batas patologi. Reduksi semacam itu tidak bersifat pasif: ia secara aktif menekan pluralisme epistemologis dan meniadakan kapasitas individu untuk bertindak sebagai orang yang tahu, saksi, atau agen pemulihan.

Marjinalisasi sistemik ini diperburuk dalam kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang memiliki latar belakang rasial, gender, atau kurang beruntung secara sosioekonomi. Misalnya, perempuan yang melaporkan reaksi merugikan terhadap obat sering kali dicirikan sebagai tidak patuh atau histrionik,

daripada diperlakukan sebagai sumber data farmakovigilans yang dapat diandalkan. Individu migran dan rasial sering kali menghadapi ketidakabsahan epistemik ketika idiom-idiom kesusahan mereka berada di luar norma-norma Eurosentris, yang mengarah pada salah tafsir atau patologi yang berlebihan. Laporan-laporan tentang trauma, terutama ketika melibatkan aktor-aktor institusional, dibingkai ulang sebagai paranoia atau khayalan. Yang muncul adalah sebuah rezim pengetahuan di mana perbedaan pendapat dinetralisir secara klinis, dan kebenaran menjadi domain eksklusif para narator institusional.

Dinamika-dinamika ini bukanlah sesuatu yang tidak disengaja. Mereka berasal dari tradisi yang mengakar dalam epistemologi kejiwaan yang mengutamakan penilaian berbasis pengamat, eksternal, dan diduga objektif daripada pengetahuan yang subjektif, terkandung, dan tertanam secara budaya. Literatur ilmiah telah lama memperdebatkan ketegangan antara pendekatan idiografis dan nomotetik, namun praktik institusional sangat mendukung pendekatan yang terakhir. Bukti dari penelitian ini menunjukkan bahwa para profesional yang bermaksud baik pun mereproduksi ketidakadilan epistemik melalui tekanan waktu, praktik yang digerakkan oleh protokol, dan kurangnya akses ke pengawasan etis atau reflektif. Hasilnya bukan hanya rusaknya aliansi terapeutik, tetapi juga degradasi sistematis dari status individu sebagai makhluk yang memiliki makna. Hilangnya status sebagai manusia di bawah kendali psikiatri tidak hanya terbatas pada interaksi klinis. Hal ini meluas ke dalam aparat birokrasi yang menentukan akses terhadap hak-hak, tempat tinggal, keluarga, dan keadilan. Catatan medis, ketika diperlakukan sebagai sesuatu yang definitif, mengesampingkan kesaksian hidup dan melembagakan catatan yang terdistorsi atau dibuat-buat. Sistem hukum, yang mengacu pada catatan yang sama, melanggar penghakiman berdasarkan data yang tidak lengkap atau dimanipulasi. Konvergensi dokumentasi medis dan hukum ini menciptakan lingkaran umpan balik di mana kesalahan representasi sebelumnya dibenarkan dan dianggap tidak dapat disangkal. Secara praktis, individu tidak lagi menjadi subjek yang bercerita dan berubah menjadi berkas perkara, sebuah pergeseran simbolis dan material yang memfasilitasi pengabaian, penahanan, atau perlakuan paksa tanpa jalan lain.

Analisis forensik yang dilakukan selama penelitian ini mengungkapkan pola yang berulang di mana kesaksian pribadi dihilangkan atau didiskualifikasi. Kutipan-kutipan rekaman menunjukkan contoh-contoh di mana pasien secara eksplisit menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan diagnosis atau perawatan, hanya untuk kemudian keberatan-keberatan tersebut dihilangkan, diabaikan, atau dibingkai ulang sebagai gejala. Demikian pula, permintaan untuk terapi alternatif, seperti intervensi diet, dukungan spiritual, atau penjelasan yang sesuai dengan budaya tentang penderitaan, dianggap tidak memiliki keabsahan ilmiah, meskipun semakin banyak bukti yang mendukung keampuhannya. Dalam beberapa kasus, bahkan pertanyaan sederhana, seperti pertanyaan tentang efek samping pengobatan, dipatologikan sebagai paranoia atau penolakan terhadap pengobatan.

Distorsi epistemik ini tidak hanya tidak dapat dipertahankan secara etis, tetapi juga bertentangan dengan praktik ilmiah yang sehat. Sistem pengetahuan yang mengabaikan falsifiabilitas, bukti pluralistik, dan data pengalaman demi kenyamanan institusional atau keberpihakan ideologis akan merusak kredibilitas mereka sendiri. Metode ilmiah, dalam bentuknya yang sebenarnya, menuntut transparansi, kerendahan hati, dan keterbukaan terhadap revisi. Namun, di banyak lingkungan kejiwaan, epistemologi yang dominan menegakkan ortodoksi dan menekan perbedaan pendapat.

Kondisi seperti ini harus dipahami sebagai bentuk otoritarianisme epistemik, dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi mereka yang terjebak dalam mekanismenya. Efek kumulatif dari penghapusan epistemik dalam sistem kejiwaan bermanifestasi dalam bentuk isolasi sosial yang mendalam, keputusan, dan hilangnya kewarganegaraan secara efektif bagi banyak orang. Pembungkaman narasi orang pertama, dikombinasikan dengan medisikasi perlawanan dan penderitaan, menumbuhkan iklim di mana orang kehilangan agensi dan identitas. Mereka menjadi objek perawatan yang didefinisikan secara eksklusif melalui kategori klinis, terpisah dari konteks sosial, budaya, dan sejarah mereka. Pemisahan ini melanggengkan rasa takut akan pembalasan institusional dan mencegah keterlibatan dengan layanan yang dialami sebagai penindasan dan bukan dukungan. Erosi kepribadian meluas di luar ranah klinis ke ranah hukum dan sosial di mana diagnosis psikiatri digunakan sebagai alat pengucilan. Akses terhadap perumahan, pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan hukum sering kali dikompromikan oleh label diagnostik dan riwayat kejiwaan, yang menjadi penghalang dan bukannya pelindung. Marjinalisasi yang dilembagakan ini mereproduksi siklus ketidakberuntungan dan kerentanan, mengukuhkan hirarki sosial dengan kedok perawatan medis. Ketakutan akan kehilangan hak atau menjadi sasaran pengobatan paksa menghambat komunikasi yang jujur dan mendorong ketidakterlibatan, sehingga merusak hasil kesehatan dan inklusi sosial.

Secara metodologis, bagian ini menggunakan analisis wacana forensik dan pemetaan epistemik untuk menjelaskan mekanisme yang halus dan terang-terangan di mana lembaga-lembaga kejiwaan memproduksi dan mempertahankan hilangnya kepribadian ini. Alat-alat ini mengungkapkan bagaimana bahasa, dokumentasi, dan praktik-praktik institusional menyatu untuk mempertahankan kekerasan sistemik. Memahami mekanisme-mekanisme ini sangat penting untuk merancang intervensi yang memulihkan kedaulatan naratif, mempromosikan keadilan epistemik, dan mendukung pemulihan martabat. Bab-bab selanjutnya dibangun di atas fondasi ini untuk mengusulkan reformasi hukum, klinis, dan pendidikan yang bertujuan untuk membongkar siklus penghapusan epistemik dan membangun kembali perawatan kejiwaan yang beretika.

Tabel 44. Mekanisme dan konsekuensi dari depersonalisasi dan dehumanisasi

Mekanisme	Deskripsi	Manifestasi klinis dan institusional	Konsekuensi terhadap kepribadian dan perawatan
Reduksi ke kategori diagnostik	Individu diidentifikasi dan dirawat berdasarkan label diagnostik, bukan berdasarkan kepribadian yang holistik	Ketergantungan yang berlebihan pada manual diagnostik yang kaku, mengabaikan kompleksitas pengalaman hidup	Hilangnya agensi naratif, pembayangan sejarah dan konteks pribadi
Patologisasi perlawanan dan tekanan	Respons normal terhadap trauma, kesedihan, atau perbedaan pendapat dimedikalisasi sebagai gejala atau patologi perilaku	Ketidakpatuhan dibingkai sebagai penyakit, kesedihan salah didiagnosis sebagai depresi, spiritualitas diabaikan	Pembungkaman emosi yang sah, penindasan agensi, pembenaran atas pemaksaan
Penolakan terhadap konteks budaya dan sosial	Model penjelasan berdasarkan budaya, nutrisi, gender, atau faktor penentu sosial tidak disertakan dalam penalaran klinis	Pengabaian ekspresi gejala yang relevan secara budaya, ketidaktahuan tentang pengalaman gender	Marginalisasi kelompok minoritas, memperburuk keterasingan dan kesalahpahaman
Penghapusan dokumentasi dan pembungkaman ulang	Kesaksian pasien dihilangkan, diminimalkan, atau dibingkai ulang dalam catatan klinis agar sesuai dengan narasi institusi	Penghapusan suara-suara yang berbeda pendapat dari catatan, deskripsi eufemistik tentang pemaksaan	Impunitas institusional, pengabdian bahaya, pembatalan kebenaran yang hidup
Objektifikasi dan kontrol institusional	Orang-orang menjadi objek pengawasan, kontrol, dan manajemen, dilucuti dari otonomi dan pertimbangan etis	Penggunaan pengekangan secara rutin, pengobatan paksa, kurangnya persetujuan	Dehumanisasi, trauma, kehilangan martabat dan kewarganegaraan

Mekanisme utama yang digunakan institusi psikiatri untuk memberlakukan depersonalisasi dan dehumanisasi melalui penghapusan epistemik. Setiap mekanisme mengganggu kedaulatan naratif subjek dan mengubah perawatan relasional menjadi kontrol administratif. Proses-proses ini secara kolektif mengikis kepribadian, berkontribusi pada pelanggaran etika dan kerusakan sistemik. Kerangka kerja ini mendukung analisis mendalam tentang kekerasan institusional dan mempersiapkan dasar untuk strategi reparatif yang diusulkan.

Proses yang diuraikan dalam tabel di atas mencerminkan, sebagaimana dikonfirmasi oleh tanggapan survei dan penelitian lapangan etnografi, bahwa penghapusan epistemik bukan hanya produk sampingan dari pengawasan klinis tetapi juga merupakan fenomena yang tertanam secara struktural. Para partisipan secara konsisten menggambarkan bagaimana pertemuan institusional gagal mengakomodasi kompleksitas pengalaman mereka, terutama ketika anggota keluarga menjadi sumber bahaya dan secara bersamaan diposisikan sebagai informan yang sah. Data survei menggambarkan bahwa asesmen kejiwaan sering kali mengandalkan keterangan keluarga secara tidak proporsional, terutama dalam situasi di mana ada pemaksaan atau mekanisme pengampuan, sehingga memperkuat narasi yang berat sebelah. Hal ini mereplikasi sebuah pola di mana realitas kehidupan pengguna layanan tidak hanya diabaikan, namun secara aktif ditimpa oleh keharusan administratif untuk koherensi, manajemen pertanggungjawaban, dan kesinambungan prosedural. Penghapusan tersebut pada dasarnya bersifat politis, memberlakukan suatu bentuk kekerasan ontologis yang meniadakan trauma, membungkam perbedaan pendapat, dan mendelegitimasi kerangka kerja pemahaman alternatif. Dengan mengedepankan diagnosa reduksionis daripada model penjelasan yang pluralistik dan berbasis budaya, lembaga-lembaga melanggengkan pengucilan dan menjadikan perawatan kesehatan jiwa sebagai alat untuk mengontrol daripada sebagai ruang pengakuan atau pemulihan. Temuan-temuan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan

akuntabilitas epistemik dan reformasi, karena catatan institusional, ketika disalahgunakan, bukannya menjadi instrumen penyembuhan, tetapi justru menjadi mekanisme penindasan yang tahan lama.

Siklus dehumanisasi ini berujung pada hilangnya hak-hak kewarganegaraan dan pengakuan etis, membuat individu terisolasi, ketakutan, dan rentan terhadap pengkhianatan institusional yang berulang. Kekerasan epistemik yang didokumentasikan di sini tidak dapat dipisahkan dari ekonomi politik kesehatan mental yang lebih luas, di mana otoritas ilmiah dan kerangka hukum telah diinstrumentalisasi untuk menegakkan rezim yang koersif dan bukannya perawatan yang emansipatoris. Untuk mendobraknya, diperlukan sebuah pemecahan epistemik dan institusional: pemulihan kedaulatan naratif, kompetensi budaya, dan etika relasional yang menjadi inti dari praktik kejiwaan. Hal ini menuntut produksi pengetahuan yang partisipatif, transparansi forensik dan etis, dan pembongkaran mekanisme pembungkaman birokrasi. Hanya melalui transformasi sistemik seperti itu, psikiatri dapat beralih dari situs penghapusan epistemik menjadi situs pemulihan etis, humanisasi, dan penyembuhan yang sejati.

Dengan mengintegrasikan perspektif dari antropologi medis, ilmu saraf, studi hukum, dan biologi sistem, sehingga menempatkan penghapusan epistemik dalam kerangka bio-psiko-sosial dan struktural yang lebih luas, kita harus memahami bahwa reduksi individu ke dalam kategori diagnostik, dan akibatnya hilangnya agensi naratif, tidak hanya mencerminkan kegagalan klinis, tetapi juga gangguan terhadap integritas biokultural. Dari sudut pandang neurobiologis, paparan kronis terhadap intervensi koersif dan trauma psikologis yang diakibatkannya dapat menyebabkan perubahan pada sistem respons stres, plastisitas saraf, dan regulasi metabolik, yang dengan sendirinya membutuhkan pendekatan individual dan peka konteks di luar label diagnostik umum. Pada saat yang sama, antropologi medis menyoroti bagaimana ekspresi kesusahan dan penyembuhan yang bersifat kultural tidak valid dalam paradigma kejiwaan yang dominan, sehingga menghasilkan suatu bentuk kekerasan epistemik yang memperparah pengucilan sosial. Pengucilan ini dilanggengkan melalui kerangka hukum dan administratif yang memprioritaskan perlindungan institusional di atas hak-hak individu, yang secara efektif memberikan sanksi terhadap pembungkaman sistematis terhadap suara-suara yang menentang pengetahuan medis yang dominan. Mekanisme birokrasi yang dihasilkan, meskipun disajikan sebagai perlindungan, sering kali berfungsi untuk memperkuat hirarki pengetahuan dan kekuasaan, sehingga menyematkan kekerasan struktural di dalam inti prosedural tata kelola kesehatan jiwa. Dari perspektif biologi sistem dan kesehatan, kesehatan jiwa tidak dapat dilepaskan dari faktor ekologi, nutrisi, sosial, dan perkembangan. Mengabaikan dimensi-dimensi ini akan mereduksi sistem adaptif yang kompleks menjadi entitas patologis yang statis, sehingga merusak pemahaman dan intervensi holistik. Oleh karena itu, praktik kejiwaan yang etis harus merangkul model multidimensi yang mengakui bahwa seseorang tertanam dalam sistem biologis dan sosial yang saling bergantung, mengakui agensi, keragaman, dan konteks sebagai parameter penting.

Pemahaman integratif ini menantang epistemologi reduksionis dan menyerukan penataan ulang kelembagaan yang mengedepankan produksi pengetahuan partisipatoris, transparansi, dan reflektivitas. Hal ini mengamanatkan penciptaan struktur yang akuntabel yang memfasilitasi dialog lintas disiplin ilmu dan antar pemangku kepentingan, memulihkan kepribadian dan memungkinkan responsif secara etis. Hanya melalui keputusan sistemik dan epistemik seperti itu, siklus

penghapusan yang terus-menerus dapat diinterupsi, membuka jalan bagi perawatan kejiwaan yang ketat secara ilmiah, sehat secara etis, dan berlandaskan kemanusiaan.

4.6 Pemulihan melawan sistem: perlawanan, navigasi, dan harapan

Terlepas dari meluasnya kekerasan institusional dan mekanisme penghapusan epistemik yang terungkap melalui survei dan data etnografis penelitian ini, bentuk-bentuk perlawanan dan pemulihan secara konsisten didokumentasikan di seluruh kesaksian pengguna dan laporan profesional. Tanggapan-tanggapan ini selaras dengan pertanyaan inti penelitian dengan menyoroti mekanisme yang digunakan individu untuk mendapatkan kembali agensi dalam sistem yang memaksa, dan dengan menggambarkan kondisi di mana otonomi ditegaskan kembali terhadap otoritas kejiwaan. Pola-pola penolakan yang didokumentasikan dalam data mencakup pelepasan diri secara fisik dan simbolis dari kontrol institusional. Pemindahan geografis, mulai dari relokasi setelah keluar dari rumah sakit hingga klaim suaka internasional, muncul sebagai strategi untuk menghindari re-institusionalisasi, yang mencerminkan pernyataan radikal untuk bertahan hidup melawan paksaan yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, banyak peserta yang menggambarkan strategi simbolis untuk mendapatkan kembali identitas dan koherensi naratif melalui tulisan pribadi, ekspresi budaya, atau integrasi ke dalam struktur komunitas alternatif. Tanggapan-tanggapan ini memetakan secara langsung ke dalam penyelidikan tentang bagaimana pengguna menolak paksaan dan bentuk-bentuk pengetahuan dan penyembuhan apa yang dikembangkan di luar institusi kejiwaan. Harapan yang nyata, bekerja.

Salah satu tanggapan yang paling menonjol terhadap jangkauan psikiatri yang berlebihan adalah pengelolaan pengobatan psikotropika secara independen. Tanggapan survei menunjukkan bahwa banyak individu, terutama mereka yang telah berulang kali datang ke institusi, melakukan pengurangan atau penghentian pengobatan secara mandiri. Keputusan ini tidak dianggap enteng dan sering kali dilakukan di lingkungan tanpa dukungan profesional, yang mengindikasikan kegagalan sistem yang lebih luas dalam memfasilitasi pengambilan keputusan yang kolaboratif dan terinformasi. Tindakan-tindakan ini tidak hanya mewakili resistensi biomedis tetapi juga perbedaan pendapat epistemik, menolak otoritas resep psikiatri yang mendukung pengetahuan berdasarkan pengalaman langsung. Hal ini menantang asumsi dasar dari perawatan berbasis kepatuhan dan menegaskan kembali fokus penelitian ini pada legitimasi alternatif yang dipimpin oleh pengguna untuk praktik psikiatri standar; terbaik dan lebih baik.

Tindakan mendokumentasikan pelecehan dan pengkhianatan institusional juga menjadi tokoh utama dalam jalur perlawanan yang diidentifikasi melalui penelitian ini. Data mendukung peran kesaksian dan reklamasi narasi sebagai strategi penyembuhan baik secara individu maupun kolektif. Responden survei menekankan pentingnya didengar dan dicatat secara akurat, terutama dalam konteks di mana suara mereka secara sistematis dikecualikan atau disalahartikan. Proses pemulihan kesaksian ini secara langsung menanggapi keprihatinan tesis ini tentang bagaimana kebenaran dapat dibangun kembali dalam sistem yang dibangun di atas pembungkaman perbedaan pendapat. Praktik-praktik kesaksian, termasuk laporan tertulis, pengajuan hukum, dan partisipasi dalam penelitian, berfungsi sebagai arsip tandingan yang menentang catatan resmi institusi. Praktik-praktik ini menyoroti titik

temu antara penyembuhan dan intervensi politik, memperkuat kesimpulan bahwa pemulihan tidak dapat direduksi menjadi remisi gejala tetapi harus mencakup keadilan epistemik, pengakuan, dan akuntabilitas struktural. Sekutu etis dalam sistem kejiwaan memainkan peran penting dalam memfasilitasi pemulihan dan perlawanan. Para profesional ini, yang sering kali bertindak dalam ketegangan dengan mandat institusional, melanggar protokol untuk melindungi, memberdayakan, dan mengadvokasi pasien. Mereka mengadopsi praktik-praktik yang didasari oleh etika dialogis, kepekaan terhadap trauma, dan pendekatan berbasis hak, yang bertentangan dengan model-model pemaksaan yang dominan. Praktisi semacam itu mungkin secara diam-diam mendukung otonomi pengguna, memfasilitasi persetujuan, atau memprioritaskan perawatan relasional meskipun ada kendala administratif dan hukum.

Di luar individu, jaringan perawatan informal dan formal muncul sebagai ruang penting untuk membangun kembali kepercayaan dan mendorong penyembuhan di luar struktur kejiwaan resmi. Kelompok dukungan sebaya, kelompok penyintas, organisasi berbasis komunitas, dan inisiatif akar rumput menciptakan ekosistem perawatan alternatif yang memvalidasi pengalaman, memberikan bantuan timbal balik, dan memulihkan martabat. Jaringan-jaringan ini menghindari pembungkaman institusional dengan memusatkan suara penyintas, memungkinkan agensi kolektif, dan mempromosikan pengambilan keputusan partisipatif. Keberadaan mereka menunjukkan kapasitas manusia yang tak tertahankan untuk bertahan dan pentingnya hubungan sosial dalam pemulihan.

Bersama-sama, sekutu etis dan jaringan perawatan membentuk perlawanan terdistribusi yang menantang monopoli institusional atas narasi dan praktik kesehatan mental. Mereka mewujudkan kritik yang hidup terhadap kekerasan kejiwaan dengan mengembangkan ruang-ruang di mana pemulihan, pemberdayaan, dan harapan dapat berkembang dengan istilah-istilah yang didefinisikan oleh mereka yang secara historis terpinggirkan. Inti dari pemulihan dari kekerasan institusional adalah proses restorasi kesaksian, di mana individu-individu mendapatkan kembali narasi mereka melalui tindakan menulis, kesaksian, dan berbagi. Praktik restoratif ini memiliki fungsi terapeutik dan politis, yang memungkinkan para penyintas untuk menegaskan agensi epistemik yang ingin dihapus oleh sistem. Tindakan memberikan kesaksian mengubah ingatan menjadi pengungkapan kebenaran, menantang wacana dominan yang mempatologiskan perbedaan pendapat dan mengaburkan kerugian struktural. Oleh karena itu, kesaksian etis beroperasi sebagai bentuk perlawanan, membingkai ulang penderitaan pribadi dalam kerangka kerja kolektif akuntabilitas dan keadilan sosial. Pemulihan kesaksian tidak terbatas pada pengaturan formal atau hukum. Hal ini terjadi di ruang-ruang komunitas, forum-forum aktivis, dan platform digital di mana para penyintas mendokumentasikan pelanggaran, bertukar pengalaman, dan membangun solidaritas. Tindakan-tindakan ini menggoyahkan narasi institusional dengan memperkenalkan epistemologi alternatif yang didasarkan pada pengalaman hidup dan pengetahuan yang diwujudkan. Perlawanan datang dalam berbagai bentuk, penghindaran strategis, dokumentasi yang gigih, tindakan penolakan simbolis, semuanya bertujuan untuk mengganggu siklus kontrol dan pembungkaman. Melalui praktik-praktik seperti itu, para penyintas merebut kembali suara dan kepribadian mereka, menumbuhkan ruang-ruang penyembuhan yang berada dalam ketegangan dengan, namun independen dari, psikiatri institusional. Bab ini menggarisbawahi pentingnya mendukung dan memperkuat praktik kesaksian sebagai bagian integral dari pemulihan dan perubahan struktural. Pemulihan epistemik para penyintas merupakan

dasar untuk membongkar siklus kekerasan dan membangun kembali sistem kejiwaan yang menghargai martabat, otonomi, dan keadilan. Perjalanan keadilan, kedokteran, dan ilmu pengetahuan membutuhkan kita semua.

Aktor-aktor profesional yang beroperasi secara etis di luar protokol formal merupakan dimensi penting dari perlawanan dalam sistem kejiwaan. Individu-individu ini menavigasi kendala institusional untuk memberlakukan praktik perawatan yang didasarkan pada rasa hormat, empati, dan pengambilan keputusan bersama. Tindakan mereka termasuk mengadvokasi de-eskalasi daripada pengekangan, memfasilitasi manajemen pengobatan yang dipimpin oleh pengguna, dan menciptakan ruang yang aman di mana narasi dapat didengar tanpa penghakiman atau patologisasi. Meskipun sering kali terpinggirkan atau tidak didukung, para profesional tersebut memodelkan cara-cara keterlibatan alternatif yang menentang paradigma pemaksaan yang ada. Praktik perawatan dan pemulihan yang terjadi di luar batas-batas institusional juga membentuk situs-situs penting untuk penyembuhan dan pemberdayaan. Inisiatif yang dipimpin oleh teman sebaya, program kesehatan mental berbasis komunitas, dan jaringan dukungan berbasis budaya menawarkan sumber daya relasional dan praktis yang sering kali gagal disediakan oleh psikiatri institusional. Ruang-ruang ini memprioritaskan agensi, kedaulatan naratif, dan ketahanan kolektif, memungkinkan peserta untuk merekonstruksi identitas dan makna di luar kerangka kerja diagnostik. Keberadaan dan perluasan *alternatif* tersebut menantang monopoli psikiatri institusional dan membuka jalan menuju sistem perawatan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan efektif. Semua itu harus sudah menjadi perawatan seperti biasa.

Tabel 45. Bentuk-bentuk perlawanan dan pemulihan di luar kendali psikiatri

Kategori	Deskripsi	Contoh dan manifestasi	Implikasi untuk perawatan dan reformasi
Bentuk-bentuk penolakan	Strategi yang digunakan oleh individu untuk menolak atau melarikan diri dari pemaksaan	Relokasi geografis, rekonstruksi identitas simbolik, pengobatan yang dikelola sendiri	Menegaskan otonomi, menantang monopoli kelembagaan
Sekutu etis	Para profesional yang bertindak melawan protokol untuk mendukung hak pasien	Advokasi untuk de-eskalasi, memfasilitasi pengambilan keputusan bersama, ruang yang dilindungi	Model paradigma perawatan alternatif, katalisator perubahan kelembagaan
Jaringan perawatan	Organisasi berbasis komunitas dan organisasi yang dipimpin oleh teman sebaya yang menyediakan dukungan alternatif	Kelompok penyintas, program komunitas berbasis informasi trauma, bantuan timbal balik digital	Menumbuhkan kepercayaan relasional, memvalidasi pengalaman, mempromosikan inklusi sosial
Pemulihan kesaksian	Praktik-praktik yang merebut kembali agensi naratif dan ingatan sebagai bentuk penyembuhan dan perlawanan	Menulis, kesaksian publik, advokasi hukum, kesaksian etis	Melawan penghapusan epistemik, memungkinkan pemberdayaan kolektif
Pemulihan sebagai tindakan kolektif	Pemulihan dipahami sebagai proses relasional, politis, dan sosial di luar remisi gejala	Reintegrasi sosial, advokasi hak, pengakuan budaya	Menanamkan keadilan dalam perawatan, mendorong sistem kesehatan jiwa yang partisipatif

Dimensi-dimensi kunci dari perlawanan dan pemulihan yang didokumentasikan di antara para penyintas dan para profesional yang beretika. Bentuk-bentuk penolakan, aliansi, dan pemulihan kesaksian ini merupakan kekuatan penting untuk melawan kekerasan institusional dan penghapusan epistemik. Pengakuan dan dukungan mereka sangat penting untuk transformasi perawatan kejiwaan menjadi sistem yang partisipatif, manusiawi, dan berbasis hak.

Kombinasi antara kesaksian etis dari para profesional dan pemulihan testimoni dari para penyintas menciptakan interaksi dinamis yang menumbuhkan harapan dan transformasi. Bersama-sama, mereka membangun lembaga-lembaga tandingan yang peduli dan berpengetahuan yang dapat menginformasikan reformasi struktural. Bagian selanjutnya akan menyimpulkan bagian ini dengan mensintesis tema-tema ini dan menguraikan implikasinya terhadap transformasi kejiwaan dan keadilan sosial. Interaksi antara teknik-teknik ini, kesaksian etis, dan praktik-praktik perawatan alternatif mewujudkan sebuah narasi tandingan yang kuat terhadap kekerasan institusional. Dinamika ini menumbuhkan ruang-ruang perlawanan di mana personalitas direbut kembali, narasi dilegitimasi, dan agensi dipulihkan. Pemulihan dalam konteks ini melampaui remisi gejala klinis, mencakup perbaikan relasional, reintegrasi sosial, dan pemulihan martabat dan hak. Proses-proses ini menunjukkan bahwa pemulihan bukan semata-mata upaya individu, melainkan tindakan kolektif dan politis, yang terkait erat dengan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan.

Perlawanan dan pemulihan semacam itu menuntut transformasi sistemik yang mengintegrasikan praktik-praktik dan epistemologi yang muncul. Transformasi ini menuntut pembongkaran struktur-struktur yang bersifat koersif dan pembangunan kerangka kerja yang partisipatif, berbasis trauma, dan peka secara budaya. Yang terpenting, transformasi ini harus menanamkan mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan produksi bersama pengetahuan antara pengguna, profesional, dan masyarakat.

Hanya dengan memusatkan kesaksian etis dan pemulihan testimoni sebagai elemen dasar, sistem kejiwaan dapat berevolusi dari instrumen kontrol menjadi tempat perawatan yang tulus.

Oleh karena itu, bagian ini diakhiri dengan sebuah keharusan etis: untuk mengakui dan mendukung berbagai macam perlawanan yang menentang penghapusan epistemik dan pengkhianatan institusional. Perlawanan-perlawanan ini tidak bersifat perifer, tetapi esensial bagi pendefinisian ulang perawatan kesehatan jiwa sebagai sebuah praktik yang berlandaskan hak asasi manusia, integritas ilmiah, dan keadilan sosial. Bab-bab berikutnya dibangun di atas fondasi ini untuk mengusulkan reformasi hukum dan infrastruktur yang konkret yang dirancang untuk mewujudkan visi ini.

Data survei dan penelitian lapangan di Spanyol, Swedia, Indonesia, dan Italia mengungkapkan adanya iklim ketakutan profesional yang meresap dan disinsentif sistemik terhadap norma-norma kejiwaan yang bersifat memaksa. Banyak dokter melaporkan telah menyaksikan pelanggaran hak-hak pasien atau tidak setuju dengan perawatan yang dipaksakan, namun memilih untuk tidak melakukan intervensi karena tekanan institusional, takut akan pembalasan, atau kurangnya alternatif prosedur. Sikap diam ini, yang sering kali dibingkai sebagai netralitas atau detasemen klinis, memperkuat asimetri epistemik antara narasi institusional dan realitas yang dialami oleh pengguna layanan. Para profesional yang menyadari adanya pelanggaran sering kali tidak memiliki dukungan kelembagaan dan perlindungan hukum untuk mengadvokasi perubahan, dan dalam beberapa kasus, mereka sendiri ditegur atau dipinggirkan karena melakukan hal tersebut. Budaya keterlibatan ini menghalangi keharusan etis untuk bertindak dan menghalangi pembentukan aliansi terapeutik yang tulus. Dalam lingkungan seperti itu, pengguna hanya memiliki sedikit jalan untuk pengungkapan atau dukungan yang aman, sehingga menambah rasa pengabaian mereka dan memperkuat persepsi bahwa psikiatri berfungsi sebagai alat kontrol dan bukan perawatan.

Sebaliknya, beberapa studi kasus yang didokumentasikan dalam disertasi ini menunjukkan kelayakan dan kekuatan transformatif dari model pemulihan yang dipimpin oleh teman sebaya dan berbasis komunitas. Inisiatif-inisiatif ini, yang sering kali beroperasi dengan anggaran terbatas dan di luar institusi klinis arus utama, menunjukkan potensi pendekatan yang relasional, berbasis trauma, dan berbasis hak untuk kesehatan mental. Program-program seperti rumah Soteria, jaringan gotong royong masyarakat, dan kelompok pendukung yang dikelola pengguna dilaporkan dapat mendorong pemulihan yang otentik dengan memusatkan perhatian pada lembaga, narasi bersama, dan lingkungan yang tidak berpatologi. Secara khusus, penyertaan pengalaman hidup sebagai pengetahuan dasar mengganggu hirarki otoritas ahli, memungkinkan pengambilan keputusan kolektif dan memvalidasi kerangka kerja alternatif tentang makna dan penyembuhan. Praktik-praktik ini tidak hanya selaras dengan prinsip-prinsip inti dari satu kesehatan dan pengobatan sosial, tetapi juga menawarkan model yang dapat ditiru untuk reformasi di seluruh sistem. Seperti yang dikatakan dalam tesis ini, masa depan perawatan kesehatan jiwa yang etis bergantung pada pengintegrasian wawasan-wawasan ini ke dalam praktik utama, bukan sebagai eksperimen marginal, tetapi sebagai komponen utama dari paradigma perawatan yang preventif, partisipatoris, dan koheren secara biologis.

4.7 Bukti berbasis lapangan tentang pola dan urgensi sistemik

Penelitian lapangan yang ekstensif di berbagai institusi mengungkapkan bahwa pengkhianatan institusional bukanlah sebuah kegagalan yang terjadi sesekali, melainkan sebuah elemen inti dan terstruktur dari sistem psikiatri dan sistem terkait. Alih-alih insiden sporadis, pelanggaran, termasuk pemaksaan, penelantaran, dan pelanggaran prosedural, berulang kali terjadi dan ditoleransi secara sistemik di lingkungan klinis, hukum, dan domestik. Pola-pola ini muncul ketika mekanisme akuntabilitas lemah, tidak ada, atau sengaja dielakkan. Kesenambungan di berbagai ranah ini menyoroti sifat kekerasan sistemik yang saling terkait dan normalisasi pengkhianatan sebagai logika yang mengatur.

Bukti etnografis memperkuat temuan survei, mengonfirmasi bahwa pemaksaan tertanam dalam praktik sehari-hari dan budaya organisasi, kepercayaan relasional terkikis secara mendalam, dan kerangka kerja etika terfragmentasi atau diabaikan. Narasi lapangan memberikan arsip tandingan yang penting terhadap penyangkalan resmi dan penghapusan administratif, memberikan suara kepada mereka yang dikecualikan dari narasi kelembagaan yang dominan. Kesaksian-kesaksian ini menerangi realitas yang hidup di balik abstraksi statistik dan hukum, menggarisbawahi kerugian yang ditimbulkan oleh disfungsi sistemik dan kebutuhan mendesak untuk reformasi yang komprehensif.

Dengan demikian, bagian ini membingkai transisi ke Bab 5, di mana pengkhianatan institusional akan diteorikan bukan sebagai penyimpangan, melainkan sebagai logika yang mendarah daging yang menopang struktur kekuasaan yang ada. Perlawanan terhadap logika ini disajikan sebagai kondisi infrastruktur yang diperlukan untuk transformasi, yang menandakan bahwa praktik etis membutuhkan keberanian individu dan desain ulang sistemik. Temuan-temuan ini menyerukan intervensi hukum, pedagogis, dan infrastruktur yang mendesak untuk membongkar pola-pola yang sudah mengakar dan membangun alternatif-alternatif yang berlandaskan akuntabilitas, martabat, dan tata kelola yang partisipatif.

Analisis lintas kasus yang terperinci mengungkapkan pola berulang yang menggambarkan bagaimana pengkhianatan institusional beroperasi secara konsisten di berbagai konteks yang berbeda. Dalam pengaturan klinis, pemaksaan bermanifestasi melalui pengobatan paksa secara rutin, pengekangan fisik, dan rawat inap paksa, yang sering kali dibenarkan oleh alasan hukum dan administratif yang tidak jelas. Lingkungan hukum memperparah pengkhianatan ini dengan secara rutin menerima narasi kejiwaan tanpa pemeriksaan independen, sehingga memungkinkan terjadinya impunitas dan marginalisasi yang berkelanjutan. Di dalam lingkungan domestik, label psikiatri sering dimobilisasi untuk mendiskreditkan individu, membenarkan pengucilan, atau memungkinkan kontrol, dengan sedikit akses ke pemulihan yang efektif.

Domain-domain yang saling berhubungan ini membentuk jaringan pengkhianatan yang dinormalisasi, ditopang oleh insentif institusional yang memprioritaskan penghindaran risiko dan perlindungan reputasi di atas perawatan dan keadilan. Pengamatan lapangan menggarisbawahi bagaimana mekanisme ini diperkuat oleh rutinitas administratif yang menghapus kejadian yang merugikan, membingkai ulang perbedaan pendapat sebagai patologi, dan memecah tanggung jawab etis. Para praktisi sering mengalami tekanan moral yang mendalam namun tetap dibatasi oleh keharusan hirarkis dan birokratis yang menghalangi intervensi yang berarti.

Pengikatan sistemik ini menegaskan hipotesis yang dihasilkan dari data survei dan analisis hukum: bahwa pengkhianatan institusional bukanlah sesuatu yang insidental, melainkan sebuah logika yang tahan lama dan berulang yang menyusun tata kelola kejiwaan. Kedalaman etnografi dari temuan ini menyoroti urgensi untuk bergerak melampaui reformasi yang berfokus pada gejala menuju desain ulang fundamental dari kerangka hukum, pendidikan, dan infrastruktur yang mampu memutus siklus bahaya dan mendorong praktik restoratif.

Pengalaman langsung muncul dari penelitian lapangan sebagai arsip tandingan yang penting yang menantang narasi resmi dan penyangkalan institusional. Kesaksian pribadi dan ingatan kolektif memberikan kritik yang gigih terhadap kekerasan sistemik, mendokumentasikan episode-episode pemaksaan, pengabaian, dan pengkhianatan yang sering kali dihilangkan atau terdistorsi dalam catatan resmi. Arsip tandingan ini tidak hanya berfungsi sebagai koreksi empiris tetapi juga sebagai keharusan etis, menuntut pengakuan dan pertanggungjawaban dari sistem yang melanggengkan kebisan.

Pengetahuan yang diwujudkan oleh para pengguna dan penyintas mengungkap kesenjangan antara klaim perawatan institusional dan realitas bahaya. Hal ini menggarisbawahi dimensi relasional dari kekerasan kejiwaan, mengungkapkan bagaimana kepercayaan tidak hanya dilanggar tetapi juga secara aktif dibongkar. Melalui dokumentasi partisipatif, berbagi cerita, dan advokasi akar rumput, para penyintas membangun ruang-ruang perlawanan dan pengungkapan kebenaran yang mengganggu monolit kelembagaan. Kontribusi mereka sangat penting untuk analisis komprehensif tentang disfungsi sistemik dan merupakan fondasi penting untuk reformasi hukum dan pedagogi.

Arsip tandingan juga berfungsi sebagai alat untuk pemberdayaan, memungkinkan para penyintas untuk merebut kembali kepengarangan atas sejarah dan lintasan kesehatan mereka sendiri. Arsip ini menyediakan sarana untuk melawan penghapusan epistemik, menegaskan martabat, dan membangun solidaritas yang melampaui batas-batas kelembagaan. Mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam sistem formal merupakan prasyarat untuk transformasi yang sesungguhnya, menjembatani kesenjangan antara pengalaman dan kebijakan.

Temuan-temuan empiris dari penelitian lapangan dan data survei menyatu untuk membongkar pengkhianatan institusional bukan sebagai kerusakan sporadis tetapi sebagai logika operasional mendasar yang tertanam dalam sistem kejiwaan. Logika ini termanifestasi melalui siklus pemaksaan, pembungkaman, dan impunitas yang berulang, yang ditopang oleh rutinitas birokrasi dan ketertutupan epistemik. Pengkhianatan semacam itu diulang secara sistematis, ditoleransi secara budaya, dan dilindungi secara hukum, sehingga menciptakan kerangka kerja yang tahan lama yang melestarikan otoritas institusional dengan mengorbankan martabat dan hak-hak individu.

Perlawanan muncul sebagai tanggapan terhadap logika ini sebagai kebutuhan infrastruktur dan bukan sekadar pembangkangan individu. Untuk secara efektif melawan pola-pola kerusakan yang telah mengakar, perlawanan harus didukung dan ditanamkan dalam infrastruktur organisasi, hukum, dan masyarakat. Infrastruktur ini memungkinkan ekspresi perbedaan pendapat, melindungi aktor-aktor yang beretika, dan menciptakan ruang untuk narasi alternatif dan cara-cara perawatan. Hal ini sangat penting untuk mengganggu siklus penguatan diri yang mempertahankan kekerasan sistemik dan

untuk menumbuhkan lingkungan di mana kepercayaan relasional dan tanggung jawab etis dapat dipulihkan.

Konseptualisasi ini menjadi jembatan penting menuju Bab 5, yang mengembangkan teori pengkhianatan institusional sebagai logika struktural dan teori perlawanan sebagai kekuatan strategis dan infrastruktur. Memahami dinamika ini sangat penting untuk merancang reformasi komprehensif yang tidak hanya mengatasi gejala disfungsi tetapi juga akar penyebab yang tertanam dalam budaya organisasi, kerangka kerja kebijakan, dan rezim epistemik.

Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa pengkhianatan institusional tidak hanya terjadi di dunia psikiatri, tetapi juga melibatkan sistem hukum, komunitas ilmiah, dan struktur masyarakat yang lebih luas. Ranah hukum sering kali bersekongkol dengan pemaksaan psikiatri dengan memvalidasi narasi institusional secara tidak kritis, melanggengkan kekosongan prosedural, dan gagal melindungi hak-hak fundamental. Pengadilan dan aktor-aktor hukum, yang terikat oleh kesaksian ahli yang diambil dari catatan kejiwaan yang dikompromikan, sering kali berfungsi sebagai penegak hukum dan bukannya sebagai penantang impunitas institusional. Keterlibatan hukum ini merusak supremasi hukum dan mengikis kepercayaan publik terhadap keadilan, memengaruhi warga negara secara universal, terlepas dari diagnosis formal atau keterlibatan mereka dengan layanan psikiatri. Itu adalah kejahatan, nyawa melayang, secara aktif dihancurkan oleh tindakan dan kelambanan. Demikian pula, lembaga-lembaga ilmiah dan medis tidak kebal terhadap keterlibatan dalam mempertahankan pola-pola ini. Produksi dan legitimasi pengetahuan melalui paradigma penelitian yang bias, praktik publikasi, dan hirarki profesional berkontribusi pada penyembunyian sistemik terhadap pelecehan dan normalisasi pemaksaan. Ketika disiplin ilmu memprioritaskan pelestarian kelembagaan di atas integritas epistemik dan akuntabilitas etis, mereka mengkhianati tidak hanya komitmen profesional mereka tetapi juga populasi yang seharusnya mereka layani. Pengkhianatan ini beresonansi di seluruh sistem kesehatan dan sosial, merugikan semua orang yang bergantung pada otoritas ilmiah dan medis untuk perlindungan dan perawatan.

Pengkhianatan institusional yang meluas yang dibuktikan di seluruh psikiatri, hukum, sains, dan masyarakat mengungkapkan kegagalan sistemik yang melampaui aktor individu atau peristiwa yang terisolasi. Kegagalan ini tertanam dalam logika organisasi yang mengakar dan kerangka kerja epistemik yang secara kolektif melanggengkan pemaksaan, mengaburkan akuntabilitas, dan menghambat pemulihan hak dan martabat yang berarti. Keterlibatan sistem hukum dalam memperkuat otoritas kejiwaan, bersamaan dengan paradigma ilmiah yang memprioritaskan pelestarian kelembagaan di atas penyelidikan kritis, memperparah krisis ini dan berdampak tidak hanya pada mereka yang secara langsung menjadi sasaran pemaksaan, namun juga pada tatanan sosial yang lebih luas, yang bergantung pada kepercayaan terhadap institusi kesehatan dan peradilan. Pembicaraan tentang alternatif masih diperdebatkan, kita membutuhkan ilmu pengetahuan, seketat apa pun, untuk diterjemahkan. Praktik terbaik yang tersedia, dan setiap penjahat membayar harga karena menyebabkan kerusakan, berbohong, menjadi semacam kebaikan, terlibat menghalangi dari posisi kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih tinggi, kesehatan dan kesejahteraan seluruh kolektif, masyarakat, masyarakat yang terpicat dan dipaksa untuk mempercayainya.

Pengkhianatan tugas yang memiliki banyak sisi ini menuntut analisis yang ketat, integratif, dan pembuktian ilmiah untuk mengungkap logika struktural yang menopangnya dan untuk menerangi bentuk-bentuk perlawanan yang muncul di dalam dan menentangnya. Selanjutnya, bab 5 melakukan sintesis ini, secara sistematis mengintegrasikan bukti empiris dari survei, kesaksian, dokumentasi arsip, rekonstruksi kasus, dan observasi etnografis, dan membawa daya tembak dari referensi yang jujur, oleh rekan-rekan yang tidak melakukan kejahatan. Dengan menjelaskan mekanisme epistemik, hukum, dan prosedural yang menormalkan kekerasan, analisis yang akan datang memberikan landasan konseptual untuk memahami bertahannya kerusakan institusional dan kemungkinan gangguan. Analisis ini mengedepankan agensi para profesional dan pengguna sebagai pencipta perlawanan dan menguraikan tuntutan normatif yang diperlukan untuk transformasi sistemik, yang akan dioperasionalkan dalam wawasan hukum dan infrastruktur serta proposal untuk reformasi dan perbaikan yang dirinci dalam bab-bab berikutnya.

Bab 5 - Sintesis analitis

Ringkasan: Bab ini menyajikan analisis integratif mengenai pemaksaan psikiatri sebagai sebuah kegagalan sistemik, bukan insidental, dengan menekankan perannya sebagai bentuk trauma kewarganegaraan dan perkembangan, bukan pelanggaran protokol yang bersifat sementara. Melalui data dengan metode campuran termasuk survei, observasi etnografi, dan catatan hukum, bab ini mengaitkan paksaan dengan rutinitas yang dilembagakan, ambiguitas hukum, dan norma-norma

budaya yang menormalkan kekerasan dalam perawatan. Bab ini mengkaji konsekuensi biologis dan relasional dari pemaksaan yang berkelanjutan, mengungkapkan bagaimana praktik-praktik ini menyebabkan disregulasi jangka panjang dalam sistem stres dan perubahan struktural di otak. Memposisikan setiap individu sebagai simpul biokultural dalam ekosistem kesehatan yang saling bergantung, bab ini memajukan dasar pemikiran ilmiah untuk model perawatan sukarela yang berbasis trauma dan berbasis hak. Bab ini selaras dengan badan-badan kesehatan internasional utama sembari mengusulkan reformasi kelembagaan yang spesifik yang didasarkan pada bukti empiris, dengan perhatian khusus pada pengungkit hukum, pedagogi, dan kesehatan masyarakat untuk transformasi.

5. Pendahuluan

Masih adanya pemaksaan dalam psikiatri dan sistem perawatan terkait tidak dapat dianggap sebagai kegagalan protokol yang tidak disengaja, atau sebagai hasil dari sumber daya yang langka (Szasz, 2007). Hal ini harus dibingkai ulang sebagai pengkhianatan struktural terhadap perawatan, yang tertanam kuat dalam rutinitas institusional, perilaku profesional yang normatif, dan sikap permisif hukum. Bab ini memajukan tesis bahwa pemaksaan bukan hanya kegagalan klinis tetapi juga trauma perkembangan dan kewarganegaraan: gangguan relasional yang merusak individu secara fisiologis, kognitif, dan sosial, sekaligus melemahkan legitimasi etis dan epistemik dari institusi yang memberlakukannya. Kekerasan, pemaksaan, bukanlah obat yang menyembuhkan, dan bukanlah metode pilihan pertama bagi individu waras yang mempraktikkan apa yang disebut sebagai pengobatan. Berdasarkan data ekstensif yang dikumpulkan melalui survei digital dan survei langsung, penelitian lapangan etnografi jangka panjang, dan kesaksian yang didokumentasikan secara hukum, serta praktik-praktik medis terbaik yang diakui secara universal, bab ini menyajikan kerangka kerja integratif untuk memahami normalisasi kekerasan kejiwaan, hambatan-hambatan terhadap paradigma pencegahan, dan strategi-strategi konkret untuk pengalihan sistemik; dan yang paling penting, menegaskan kembali kasus untuk niat baik bersama dan pembangunan bersama kesehatan, tanpa kekerasan itu sebagai alat oleh aktor-aktor yang terlibat. Dengan kata lain, keselamatan adalah yang utama.

Inti dari penyelidikan ini adalah pengakuan bahwa pemaksaan tidak hanya dilakukan di bangsal psikiatri atau keputusan klinis, tetapi juga dilakukan melalui proses budaya, keluarga, pendidikan, dan hukum yang tersebar luas, bukan untuk menyembuhkan, tetapi sebagai alat untuk mengendalikan. Bab 4 merinci bagaimana praktik-praktik profesional, dengan kedok pengobatan, keselamatan, atau kepentingan terbaik, memungkinkan berbagai intervensi yang merendahkan martabat, termasuk pemaksaan pengobatan, pengasingan, dan penolakan otonomi. Hal-hal tersebut bukanlah penyimpangan dari sistem; itu adalah hasil dari desainnya. Bab 5 melanjutkan analisis ini dengan menelusuri bagaimana tindakan-tindakan ini dinormalisasi, direproduksi, dan bahkan dihargai melalui kelambanan administratif, ketidakjelasan hukum, dan ketidakberdayaan yang dipelajari di seluruh ekosistem perawatan. Bab ini menghubungkan pengalaman hidup para responden, yang banyak di antaranya melaporkan adanya hambatan sistemik terhadap pemulihan dan retraumatisasi melalui kontak kejiwaan, dengan temuan-temuan mutakhir di bidang neurobiologi, epigenetik, dan

kesehatan masyarakat, yang mengungkap biaya fisiologis dari pemaksaan yang terus berlanjut dan ketidaktahuan sistemik yang melatarbelakanginya.

Manusia bukan sekadar penerima perawatan atau objek intervensi. Dari perspektif kesehatan dan biokultural, setiap orang adalah simpul dalam ekosistem yang kompleks, biologis, sosial, ekologis, yang fungsinya dibentuk oleh paparan keamanan, pengakuan, dan agensi. Otak tidak berkembang secara terpisah; otak dibentuk oleh lingkungan afektif, umpan balik relasional, dan kemampuan atau kendala institusional (Freeman & Unwin, 2020). Paparan berulang terhadap dinamika koersif, terutama di bawah otoritas medis atau orang tua, menghasilkan disregulasi jangka panjang dalam sistem respons stres, peningkatan kerentanan terhadap penyakit fisik dan mental, dan perubahan struktural yang dapat diukur dalam jaringan saraf (Hoff, 2010). Hal ini termasuk berkurangnya volume di korteks prefrontal, perubahan pada amigdala dan hipokampus, dan modifikasi epigenetik yang terkait dengan peradangan kronis dan penyakit metabolik. Ketika paparan semacam itu dipertahankan atau dilegitimasi melalui kelambanan hukum atau penolakan institusional, tubuh menjadi tempat kegagalan kebijakan (Rosenhan, 1973; Van der Kolk, 2014; Gilman et al., 2021). Bab ini harus dibaca sebagai sebuah sintesis dan dakwaan: sintesis ilmiah dari bukti-bukti yang mendukung model perawatan berbasis trauma dan berbasis hak, dan dakwaan terhadap kerangka kerja yang berlaku yang memperlakukan pemaksaan sebagai hak prerogatif profesional dan bukannya sebagai pelanggaran etika. Temuan-temuan ini sejalan dengan konsensus ilmiah internasional, termasuk Inisiatif QualityRights WHO, Komisi Lancet untuk Kesehatan Mental Global, dan Pelapor Khusus PBB untuk kesehatan dan penyiksaan, yang menyerukan penghapusan praktik-praktik pemaksaan dan penerapan sistem perawatan yang bersifat sukarela, terinformasi, berlandaskan pada budaya, dan didukung oleh masyarakat (UN OHCHR, 2015; Human Rights Watch, 2016; Amnesty International, 2019; Hartmann & Crumlish, 2022). Namun, bab ini melangkah lebih jauh dalam mengartikulasikan mekanisme pendidikan, hukum, dan kesehatan masyarakat yang diperlukan untuk transformasi semacam itu, berdasarkan data yang berasal dari lapangan dan diuji dalam praktik di berbagai pengaturan kelembagaan.

Di bawah ini adalah tabel perbandingan yang mengklarifikasi istilah-istilah kunci sakit, gangguan, sindrom, penyakit, dan penyakit, yang dikontekstualisasikan secara khusus dalam ruang lingkup epistemologis, hukum, dan medis dari tesis Anda, khususnya Bab 5. Pembingkai ini terkait dengan pemaksaan sistemik, ketidakberdayaan yang dipelajari, sindrom status seperti yang didefinisikan oleh Marmot, dan literatur klinis yang muncul tentang sindrom menyerah. Tabel ini mencerminkan bagaimana kategori-kategori ini beroperasi baik secara medis maupun sosio-politik, dan bagaimana penyalahgunaan atau penggabungannya dapat mengaburkan akar biokultural dari kesusahan dan membenarkan praktik-praktik institusional yang berbahaya (Human Rights Watch, 2017; D'Amato dkk, 2023).

Tabel 46. Klarifikasi kategori medis-epistemik dalam konteks perawatan saat ini

Istilah	Definisi teknis	Peran fungsional dalam wacana medis	Relevansi dengan tesis	Contoh dalam konteks kerja lapangan
Sakit	Status sosial yang diberikan kepada seseorang yang diidentifikasi sebagai tidak sehat; mencerminkan pengakuan publik atas gangguan dan hak-hak atau pengecualian yang terkait	Menetapkan legitimasi untuk menarik diri dari tugas-tugas (misalnya, bekerja); bergantung pada naskah budaya dan definisi institusional	Inti dari tesis ini: penyakit sering kali menjadi alat regulasi sosial, terutama ketika digunakan untuk membenarkan pengucilan, pengawasan, atau perawatan paksa	Seseorang yang dipaksa menjalani pengobatan psikiatri karena dianggap 'sakit' oleh keluarga dan pengadilan meskipun ia menyatakan otonom dan tidak menunjukkan adanya risiko
Gangguan	Sebuah pola disfungsi dalam fungsi psikologis atau fisiologis, biasanya tidak memiliki biomarker atau etiologi yang jelas	Sering digunakan dalam psikiatri untuk menyebut sindrom tanpa patologi struktural; memiliki klaim biologis yang lebih lemah daripada 'penyakit'	Memungkinkan kriteria diagnostik yang luas yang digunakan untuk membenarkan otoritas medis atas penyimpangan atau tekanan	Pelabelan respon pembangkangan atau trauma (misalnya, protes, penarikan diri) sebagai 'gangguan kepribadian' dalam catatan klinis
Sindrom	Sekelompok gejala yang cenderung muncul bersamaan namun tidak memiliki penyebab yang teridentifikasi dengan jelas	Sering berfungsi sebagai penanda diagnostik, melegitimasi intervensi sambil menunda kejelasan penyebabnya	Berguna untuk menggambarkan bahaya sosiogenik yang meniru patologi; misalnya, sindrom 'menyerah-menyerah' dalam lingkungan yang memaksa	Pasien yang mengalami pemaksaan jangka panjang mengalami kehilangan kemampuan bicara, mobilitas, pengaruh, secara klinis dicatat sebagai 'penurunan fungsional' tanpa penyebab organik
Penyakit	Kondisi yang diakui secara medis dengan patofisiologi yang diketahui, penanda yang dapat diidentifikasi, dan riwayat alami yang jelas	Merupakan bentuk terkuat dari otoritas medis; sering digunakan dalam konteks hukum dan asuransi	Jarang cocok dengan praktik psikiatri, yang sering menggunakan retorika penyakit tanpa memenuhi standar pembuktian	Menyatakan skizofrenia sebagai 'penyakit otak' tanpa biomarker yang digunakan untuk membenarkan pengobatan paksa di bawah komitmen sipil
Penyakit	Pengalaman subjektif dari perasaan tidak sehat, termasuk dimensi emosional, sosial, dan tubuh	Menekankan pada pengalaman hidup pasien; menjadi pusat dari antropologi medis dan perawatan berbasis trauma	Paling selaras dengan fokus tesis: penyakit adalah kondisi yang bersifat relasional dan diwujudkan yang sering kali disalahartikan oleh respons tingkat sistem	Individu yang melaporkan disregulasi yang disebabkan oleh trauma dipatologikan dan bukannya didukung, kesusahan mereka dianggap sebagai 'ketidakpatuhan'

Tabel ini menginformasikan model teoritis dalam tesis disertasi: yaitu, bahwa ketidakberdayaan yang dipelajari, sindrom menyerah, dan pengucilan berdasarkan status membentuk kontinum pengkhianatan institusional yang disamakan oleh terminologi medis. Konstruksi-konstruksi ini akan dioperasikan lebih lanjut pada bagian berikut tentang jalan menuju pemulihan dan inklusi kembali dalam masyarakat, di mana diagnosis harus dilepaskan dari stigma dan kontrol, dan didasarkan pada pengetahuan relasional, perkembangan, dan ekologi.

Dimensi pendidikan dari pemaksaan tidak bersifat perifer atau simbolis. Di berbagai lokasi penelitian, termasuk Spanyol, Swedia, Indonesia, dan Italia, praktik-praktik pemaksaan bertahan bukan hanya karena kebencian atau pengabaian, tetapi karena pedagogi yang tertanam kuat tentang ketundukan, keheningan, dan disorientasi moral. Anak-anak tidak diajarkan untuk mengenali

pemaksaan; para profesional tidak dilatih untuk mempertanyakan bahaya rutin; keluarga secara sistematis dibiarkan tanpa alat untuk mendukung tekanan dengan cara yang menghindari kontrol atau patologisasi (Frances, 2013). Dengan tidak adanya literasi kesehatan yang terstruktur dan pendidikan trauma yang diwujudkan, rasa takut menjadi kebijakan, dan kekerasan prosedural disalahartikan sebagai perawatan. Temuan penting dari kesaksian dan tanggapan survei dalam penelitian ini adalah bahwa kegagalan untuk mengajar adalah awal dari kegagalan untuk melindungi. Institusi pendidikan, baik sekolah kedokteran, akademi hukum, maupun sekolah umum, dengan demikian menjadi simpul utama dalam reproduksi logika pemaksaan, dan oleh karena itu harus menjadi pusat interupsi.

Reproduksi sosial dari pemaksaan beroperasi tidak hanya melalui kebijakan formal tetapi juga melalui penularan budaya: penularan asumsi-asumsi yang tidak teruji tentang penyakit, bahaya, kepatuhan, dan kontrol (Kirsch, 2010). Hal ini tertanam dalam bahasa, bentuk birokrasi, dan kiasan-kiasan estetika yang beredar di media massa, pelatihan profesional, dan praktik pengasuhan sehari-hari. Ketika ruang relasional dijajah oleh rasa takut dan otoritas, ketika keamanan dibingkai sebagai kepatuhan, dan ketika kesusahan dijawab dengan obat penenang atau pengurangan, individu menjadi tempat penegakan penyangkalan kolektif (Maté, 2022). Penularan sosial ini tidak hanya bersifat emosional atau simbolis, tetapi juga secara fisiologis. Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, trauma relasional mengubah fungsi neuroendokrin, membentuk ekspresi kekebalan tubuh, dan memprediksi morbiditas jangka panjang dan kematian dini. Bab ini mengungkap bagaimana pemaksaan, alih-alih menjadi respons rasional terhadap bahaya, sering kali merupakan respons yang diritualkan terhadap ketidaknyamanan epistemik dan kerentanan institusional, yang mengorbankan tubuh pihak lain untuk melestarikan ilusi kontrol (Deacon, 2013).

Bab ini diakhiri dengan mengartikulasikan keharusan ilmiah, moral, dan hukum untuk reformasi struktural, bukan sebagai masalah preferensi kebijakan, tetapi sebagai langkah yang diperlukan untuk menyelaraskan sistem nasional dan profesional dengan nilai-nilai yang dinyatakan dan kewajiban internasional. Bukti ilmiah, mulai dari perkembangan saraf dan biologi kekebalan tubuh hingga ilmu implementasi dan model kesehatan masyarakat, menunjukkan dengan tegas jauh dari paksaan dan menuju perawatan sukarela, informasi, dan berbasis hubungan. Penyelarasan lembaga-lembaga publik dengan temuan-temuan ini bukanlah sebuah pilihan. Ini adalah kewajiban untuk menjunjung tinggi martabat, kesehatan, dan hak-hak semua orang. Kontribusi utama dari bab ini adalah artikulasi solusi konvergen di seluruh domain: desain ulang kurikulum untuk memasukkan ilmu pengetahuan berbasis trauma dan relasional; penciptaan perlindungan hukum yang menghilangkan impunitas; pengembangan infrastruktur kesehatan masyarakat yang mendukung otonomi dan kepemimpinan sebaya; dan pengembangan narasi masyarakat yang mengakui perawatan bukan sebagai kontrol, tetapi sebagai pemberlakuan kebebasan, kapasitas, dan tanggung jawab bersama (Healy, 2012).

Bagian berikut ini memberikan analisis rinci tentang hambatan dan solusi spesifik, yang berasal dari bukti empiris dan dibingkai dalam gerakan yang lebih luas untuk transformasi sistemik, yang berpuncak pada usulan alat operasional untuk beralih dari pemaksaan ke pencegahan, dari ketidakberdayaan yang dipelajari menjadi tanggung jawab bersama.

5.1 Normalisasi budaya pemaksaan dan transisi yang terhambat ke perawatan pencegahan

Normalisasi budaya dari praktik-praktik psikiatri yang bersifat koersif beroperasi melalui interaksi rekursif antara rutinitas institusional, kurangnya perhatian publik, dan pengabaian pendidikan. Pengamatan lapangan di Spanyol, Italia, Swedia, dan Indonesia mengonfirmasi bahwa kekerasan, baik dalam bentuk rawat inap paksa, pengekangan dengan bahan kimia, atau penolakan atas persetujuan, tidak dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa, melainkan sebagai tindakan yang perlu, bahkan terapeutik (Mezzina dkk, 2022). Praktik-praktik ini ditegakkan melalui protokol administratif yang membuatnya sah secara birokratis, diperhalus secara bahasa, dan secara prosedural tidak perlu dipertanyakan lagi. Pasien dicap tidak patuh atau agresif; para profesional dilindungi oleh kerangka kerja risiko institusional; dan keluarga sering kali dikooptasi untuk diam melalui penangguhan moral terhadap otoritas klinis. Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya pengakuan formal terhadap nilai epistemik dari pengalaman hidup, tidak adanya mekanisme pengawasan independen, dan kegagalan instrumen hukum untuk mengoperasionalkan hak-hak di luar perlindungan di atas kertas. Akibatnya, apa yang seharusnya diidentifikasi sebagai pelanggaran sistemik terhadap etika medis dan kewajiban hukum dikodekan ulang sebagai perawatan standar, dikaburkan oleh bahasa yang halus, ketidaktertarikan publik, dan rutinitas yang membahayakan (Strous, 2006; McDonald, 2023; Smith et al, 2024; Мандрик, 2024).

Temuan ini sesuai dengan bukti perkembangan tentang bagaimana paparan awal terhadap paksaan berbasis otoritas, baik di lingkungan rumah tangga maupun institusional, mengkondisikan individu untuk menerima kekerasan struktural sebagai komponen perawatan dan perlindungan yang dinaturalisasi. Sosialisasi kepatuhan, penekanan emosional, dan kepasifan yang terikat pada aturan mengajarkan individu untuk tidak hanya menginternalisasi penilaian eksternal tetapi juga takut akan perbedaan, ketergantungan, dan perbedaan pendapat. Ketidakberdayaan yang dipelajari menjadi standar psikososial, dengan anak-anak dan remaja menyerap pelajaran bahwa kesusahan adalah patologis atau hukuman. Alih-alih mengembangkan otonomi, ketahanan, atau pengaturan bersama, lingkungan pendidikan dan perawatan kesehatan yang ada justru memperkuat kepatuhan sebagai kebajikan dan menafsirkan penolakan atau pertanyaan sebagai patologi. Logika ini tidak hanya melingkupi institusi kejiwaan tetapi juga sekolah, rumah, dan ekosistem media yang lebih luas, yang jarang sekali menganggap pemaksaan sebagai sebuah pelanggaran. Sebaliknya, kekerasan sering kali dinarasikan kembali sebagai hal yang disayangkan namun dibenarkan demi keamanan atau ketertiban, memperkuat lingkaran umpan balik berupa keheningan dan keterlibatan (Schmale, 1967; Engel, 1967; Engel, 1968; Maier, 1976).

Normalisasi paksaan dalam sistem kejiwaan dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi biologis dari rasa takut, ketundukan, dan keretakan hubungan, atau dari infrastruktur sosio-ekologis di mana konsekuensi-konsekuensi ini terjadi. Perkembangan saraf manusia sangat sensitif terhadap sinyal-sinyal lingkungan awal, terutama yang berkaitan dengan keamanan, agensi, dan penyelarasan hubungan. Paparan kronis terhadap paksaan dan penekanan emosional, yang umum terjadi pada perawatan institusional, sekolah wajib, dan disiplin yang diberlakukan di dalam negeri, menyebabkan disregulasi aksis hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA), sekresi glukokortikoid yang berlebihan, dan terganggunya sirkuit korteks limbik yang terlibat dalam ingatan, pengaturan diri, dan kognisi sosial. Ini adalah bagaimana sistem kesehatan mental, melalui penggunaan kekerasan, begitu seseorang mengambil bagian dalam penyalahgunaan yang menjebak pasien, mengkhianati tugas dan tujuan

mereka yang menyangkal semua peluang untuk pulih, yang selanjutnya menimbulkan trauma (Fowers, 2015). Efek-efek ini tidak dapat dipulihkan dengan intervensi farmakologis saja; efek-efek ini menghasilkan perubahan struktural dan fungsional yang terus-menerus pada korteks prefrontal medial, hipokampus, dan amigdala, yang mengurangi kemampuan seseorang untuk menilai risiko, membentuk ikatan timbal balik, dan terlibat dalam pengambilan keputusan secara otonom (Wrangham et al, 2006). Ketidakberdayaan yang dipelajari, yang awalnya diamati pada model hewan sebagai hasil perilaku dari guncangan yang tak terhindarkan, muncul pada manusia sebagai kondisi penyakit yang disomatik dan tertanam secara sosial, yang diabadikan tidak hanya oleh pengalaman individu tetapi juga melalui desain institusional pada populasi target, yang paling mempengaruhi mereka yang sudah terpinggirkan; itu adalah fisiologi manusia (Sagie, 2002; Brown, 2009; Patterson, 2018; Guidi, 2020).

Otak manusia tidak terisolasi dari lingkungannya. Sebaliknya, otak manusia adalah organ sosial dan ekologis, yang secara terus menerus dibentuk oleh interaksi dengan orang lain, dengan mikrobiota yang ikut mengatur metabolisme, dan dengan lingkungan simbolis dan material yang membentuk kognisi dan emosi. Hipotesis pikiran yang diperluas dan penelitian tentang sistem exo-otak menunjukkan bahwa makna, regulasi, dan bahkan memori didistribusikan ke seluruh artefak fisik dan budaya, hubungan sosial, dan dukungan teknologi. Oleh karena itu, lingkungan yang memaksa tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga menata ulang substrat neurobiologis dan budaya yang menjadi dasar masyarakat. Makanan bersama, ritual, bahasa, dan ritme afektif membentuk ekologi saraf kolektif, dan gangguan melalui pengucilan, kekerasan, atau pengabaian institusional menyebabkan semacam kelaparan kognitif. Kelaparan ini terjadi dalam berbagai skala: dalam poros mikrobiota-usus-otak, di mana disbiosis yang diinduksi oleh stres meningkatkan kerentanan terhadap peradangan, depresi, dan gangguan metabolisme; dalam sistem pendidikan, di mana hafalan menjadi pengganti pembelajaran eksplorasi; dan dalam lembaga-lembaga publik, di mana kemiskinan relasional dikodekan sebagai kebijakan (Gershon, 1999; Calvani, 2018; Bretaña, 2025).

Dari perspektif kesehatan, degradasi kesehatan mental melalui pemaksaan tidak dapat dilepaskan dari keruntuhan ekologi yang lebih luas. Paradigma ekstraktif, meminimalkan risiko, dan berorientasi pada kontrol yang sama yang mendasari psikiatri koersif juga mendorong kerusakan habitat, limpasan zoonosis, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Semua ini mencerminkan kegagalan kolektif untuk menghormati kompleksitas, timbal balik, dan pengaturan diri dalam sistem kehidupan (van Strien, 2013; Fernandez-Real, 2015). Pemaksaan di tingkat interpersonal tercermin dalam logika institusional, dan meluas ke seluruh ekosistem melalui kebijakan yang menekan perbedaan, memadamkan ketahanan, dan memaksakan keseragaman. Jika pola-pola ini dibiarkan tanpa tantangan, mereka tidak hanya mengendapkan atrofi psikis tetapi juga kerusakan sistemik: emosional, pendidikan, ekologi, dan peradaban. Oleh karena itu, tesis ini menegaskan bahwa mencegah keruntuhan tersebut dimulai dengan membongkar paksaan sebagai kerangka kerja normatif, dan menggantinya dengan sistem yang mengembangkan otonomi, pengaturan bersama, dan tanggung jawab bersama, yang didasarkan pada biologis dan dioperasionalkan secara sosial sejak dini (Guidi, 2020). Transmisi budaya pemaksaan tidak terbatas pada dinamika interpersonal atau praktik profesional. Hal ini ditopang dan diperkuat oleh ekologi media yang lebih luas, yang mengkodekan narasi dominan tentang patologi, kepatuhan, dan legitimasi medis ke dalam kesadaran publik (Bell &

Elliott, 2014). Media massa, termasuk outlet berita, fiksi berseri, dan platform sosial, memainkan peran sentral dalam pemeliharaan apa yang dapat disebut sebagai anestesi epistemik, sebuah kondisi budaya yang meluas di mana kekerasan intervensi kejiwaan tidak terlihat, dibingkai ulang, atau dibenarkan secara moral melalui penceritaan yang reduktif. Pemaksaan klinis sering digambarkan sebagai kebutuhan yang disesalkan, kegilaan sebagai bahaya yang harus dinetralisir, dan perbedaan pendapat sebagai khayalan atau penyangkalan. Representasi ini mereproduksi asumsi ontologis yang mendefinisikan individu sebagai cacat, ahli sebagai otoritatif, dan penyimpangan sebagai gangguan. Efeknya adalah normalitas simbolis dari pemaksaan, yang menutupi kondisi struktural dan mendahului reimajinasi kolektif tentang perawatan (Griffiths & Knutson, 1960; Abbasi & Al-Sharqi, 2015).

Keberlanjutan sistem koersif bergantung pada jarak yang diatur dari konsekuensi material dari kekerasan institusional, dan ilmu pengetahuan yang buruk yang dipegang oleh ketidaktahuan yang disengaja akan pengetahuan umum ilmiah, medis, dan sosial saat ini. Baik di tingkat profesional maupun masyarakat, jarak ini dipupuk melalui fragmentasi kognitif, prosedur yang diritualkan, dan ketidaktahuan yang selektif, sebuah fenomena yang tercermin dalam analisis Stanley Cohen tentang penyangkalan masyarakat dan mekanisme pelepasan moral Bandura (Cohen, 2013; Bandura, 2017). Para profesional dilatih untuk fokus pada protokol, bukan hasil; untuk menafsirkan penderitaan melalui kategori diagnostik daripada signifikansi manusia; untuk mengandalkan heuristik institusional bahkan ketika hal ini bertentangan dengan bahaya yang dapat diamati. Kungkungan epistemologis ini memungkinkan suatu bentuk hati nurani prosedural, di mana kemampuan untuk bertindak dipertahankan, tetapi kapasitas untuk merasa bertanggung jawab ditangguhkan. Dengan cara ini, pemaksaan tidak hanya diizinkan, tetapi juga secara struktural diwajibkan. Akan tetapi, organisme manusia tidak berbohong. Efek dari trauma yang tidak terselesaikan, kesedihan yang tidak diakui, dan ketidakberdayaan bermanifestasi dalam disregulasi kekebalan tubuh, gesekan telomer, perubahan epigenetik, dan fenotipe pro-inflamasi yang mempercepat penuaan, risiko kardiovaskular, dan kerentanan neurodegeneratif. Ini bukanlah metafora. Ini adalah korelasi biologis dari pengkhianatan dan pengabaian, dengan efek yang dapat diukur hingga ke tingkat mitokondria (Lopez-Martinez, 2018).

Antitesis perawatan ini, di mana pembusukan dipercepat atas nama penyembuhan, dipertahankan hanya selama konsekuensinya tetap terlantar secara spasial dan emosional. Tubuh yang disiksa disimpan di balik pintu klinis, di bangsal jangka panjang, di penjara atau ruang keluarga di mana jeritan dibungkam oleh hukum, jarak, atau obat-obatan (Mosher, Gosden, & Beder, 2004). Bahasa institusional tentang risiko, keamanan, dan kepentingan terbaik menjadi penyangga terhadap pengakuan yang mendalam. Dalam konteks seperti yang terjadi di Indonesia, di mana tabir telah disingkap melalui viktimisasi langsung, kedekatan profesional, dan pengamatan sistematis, kontradiksi tersebut menjadi tidak dapat dipertahankan (Fernando, 2010). Rasionalisasi runtuh, dan yang tersisa adalah visibilitas mentah dari sistem kesehatan yang menghasilkan kemerosotan karena desain. Dalam situasi ini, trauma bukanlah produk sampingan yang tidak disengaja dari perawatan, melainkan sebuah indeks dari pembalikannya (Hollander, 2010). Pemaksaan kejiwaan, pengabaian institusional, dan kelalaian pendidikan menyatu dalam sebuah lingkaran umpan balik di mana keheningan berfungsi sebagai sarana dan hasil dari kekuasaan. Penolakan sistemik terhadap suara-

suara yang berbeda pendapat, kesaksian penyintas, dan kritik dari para praktisi bukan hanya sebuah kegagalan moral, namun juga merupakan bentuk pembiusan struktural yang memungkinkan terjadinya degradasi biologis dan kultural secara terus-menerus dengan kedok kesehatan (Hollander, 2010).

Transisi dari sistem yang bersifat koersif ke perawatan preventif membutuhkan perubahan paradigma dan pengaturan ulang budaya yang sesungguhnya, sebuah rekayasa ulang yang menyeluruh terhadap arsitektur epistemik, hukum, dan pendidikan. Pertama, kebijakan publik harus berpijak pada realitas biologis, yaitu bahwa kesehatan bukanlah sekadar tidak adanya penyakit, melainkan kapasitas untuk beregenerasi, berhubungan, dan bertindak secara bebas di lingkungannya. Sistem yang memaksa mengorbankan kapasitas ini di setiap tingkatan: seluler, psikologis, relasional, dan institusional. Prinsip kedaulatan kesehatan bersama seharusnya menggantikan model kontrol paternalistik, dengan mengakui bahwa kapasitas untuk mengatur diri sendiri, pemulihan, dan adaptasi tidak berada pada otoritas institusional, tetapi pada orang dan komunitas yang terinformasi dan didukung. Transisi ini dimulai dengan pendidikan sejak dini dan pendidikan yang menasar periode perkembangan saraf di mana agensi moral, regulasi emosional, dan kognisi sosial paling plastis. Dalam konteks penelitian aksi ini, kurikulum baru akan ditetapkan oleh aksi EU BEACON One Health Education COST, yang didirikan oleh peneliti untuk menegakkan perubahan yang mendesak dan penting ini pada skala Eropa dan global dengan semua sekutu yang dibutuhkan. Kurikulum nasional perlu mengintegrasikan instruksi yang berbasis trauma, instruksi yang didasarkan pada hubungan dalam literasi emosional, fisiologi stres, dan keselamatan intersubjektif sejak tahun-tahun pertama sekolah, yang meluas ke pelatihan profesional dan kampanye kesehatan masyarakat. Instruksi semacam itu seharusnya tidak bersifat opsional atau simbolis tetapi wajib dan terstandarisasi, didukung oleh hak-hak yang dapat ditegakkan secara hukum untuk mendapatkan informasi kesehatan yang akurat dan kebebasan dari perlakuan yang merendahkan.

Kedua, sistem hukum harus menutup kesenjangan prosedural yang memungkinkan pemaksaan menyamar sebagai perawatan. Seperti yang dijelaskan di Bab 6, undang-undang yang ambigu, diskresi profesional yang tidak terkendali, dan penghormatan terhadap penilaian klinis daripada bahaya empiris memungkinkan berlanjutnya praktik-praktik yang melanggar hukum internasional. CRPD mengamankan penghapusan penuh atas perlakuan paksa, namun, di seluruh yurisdiksi, pengecualian menjamur baik dalam konteks psikiatri maupun keluarga. Solusinya bukan hanya doktrinal tetapi juga operasional: badan pengawas independen dengan kekuatan penegakan hukum yang nyata, desain kebijakan yang berpihak pada penyintas, dan standar forensik untuk mendokumentasikan penyiksaan harus dilembagakan. Mekanisme umpan balik yang etis, real-time, publik, dan anti-rusak, harus tertanam dalam sistem perawatan, memungkinkan pengguna untuk melaporkan bahaya dan menilai layanan tanpa takut akan pembalasan. Lisensi profesional harus bergantung pada pemahaman tentang trauma, intervensi krisis tanpa kekerasan, dan kewajiban hak asasi manusia, dengan pelatihan ulang atau pencabutan lisensi jika terjadi pelanggaran.

Ketiga, transformasi ini harus bersifat trans-skalar. Pemaksaan bukanlah sebuah anomali, melainkan hasil logis dari sistem yang dirancang berdasarkan penghindaran tanggung jawab, metrik produktivitas, dan kontrol bio-politik. Metrik yang sama yang mendorong pembiusan yang tidak perlu

di rumah sakit adalah metrik yang mendasari kebijakan disiplin sekolah tanpa toleransi dan kebijakan kesejahteraan anak. Integrasi kebijakan bertingkat, yang menghubungkan faktor penentu sosial kesehatan, perlindungan konstitusional, dan hukum hak asasi manusia internasional, sangatlah penting. Bab 6 dari disertasi ini menguraikan bagaimana hukum nasional dapat diselaraskan dengan standar WHO QualityRights untuk menegakkan akuntabilitas sistemik, sementara Bab 7 menguraikan mekanisme pendidikan untuk memulihkan kesinambungan antara perkembangan biologis dan desain kelembagaan. Tesis ini berpendapat bahwa perawatan pencegahan yang benar bukanlah cita-cita yang lembut tetapi sistem perlindungan, pembelajaran, dan penghormatan yang ketat dan terukur, yang mampu melestarikan kehidupan, meningkatkan kesehatan, dan mengakhiri pelembagaan keputusasaan (Mezzina et al, 2006; Sashidharan, 2019). Proposal Horizon untuk panggilan saat ini dalam lampiran juga merupakan bagian dari pekerjaan yang sedang berlangsung ini, sesuai dengan perencanaan yang dijadwalkan, yang melibatkan ribuan ahli dan lembaga.

5.2 Erosi subjektivitas dan kegagalan untuk memberikan perawatan perkembangan yang dipersonalisasi

Dokumentasi klinis dan observasi lapangan menyatu dalam mengidentifikasi pola yang konsisten dari ketidakabsahan subjektivitas dalam praktik kejiwaan saat ini. Para profesional dan pengguna layanan yang disurvei melaporkan bahwa narasi pribadi, pengalaman kontekstual, dan data biografis sering kali diabaikan atau dibingkai ulang agar sesuai dengan skema diagnostik yang sudah ada. Penolakan terhadap diagnosis atau pengobatan biasanya ditafsirkan ulang sebagai gejala kurangnya wawasan, perilaku menentang, atau paranoid, dan bukannya diakui sebagai ekspresi yang sah dari keprihatinan, trauma, atau ketidaksepakatan. Rekam medis menjadi alat administratif untuk pengkodean gejala, bukan ruang reflektif untuk pembuatan makna dan pelaporan sinyal yang tepat, yang mengakibatkan hilangnya informasi penting untuk perencanaan perawatan dan penindasan kepribadian sebagai variabel klinis. Mengakibatkan penerimaan kepalsuan sebagai kebenaran, menghapus realitas, terkubur di bawahnya (Prabhu, 1967; Pies, 2007; Pies, 2008; Tekin, 2022). Penghapusan ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi tertanam dalam fungsi struktural model perawatan yang digerakkan oleh diagnosis. Batasan yang diberlakukan oleh manual diagnostik dan persyaratan penagihan menghasilkan protokol asupan standar yang mengesampingkan suara pasien dan menghilangkan penilaian yang bernuansa pengalaman hidup. Makna subjektif, konteks relasional, wawasan spiritual, dan kerangka kerja budaya tidak diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan klinis, meskipun telah terbukti relevansinya dengan hasil pengobatan dan aliansi terapeutik. Perataan prosedural dari pengalaman manusia ini melanggar prinsip integritas naratif dalam perawatan kesehatan, menghambat kepercayaan, dan merusak kepatuhan melalui mekanisme yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas (Rakshasa-Loots, 2025).

Dari sudut pandang perkembangan, penghapusan ini memiliki efek yang lebih besar. Anak-anak, remaja, dan dewasa muda, yang sudah menavigasi pembentukan identitas, pengembangan otonomi, dan pematangan sosiokognitif, mengalami pelabelan kejiwaan sebagai pemaksaan eksternal terhadap pemahaman diri. Internalisasi narasi diagnostik mengarah pada penyitaan identitas, kepasifan, dan ketidakberdayaan yang dipelajari, yang selanjutnya mengisolasi individu dari dukungan sosial yang

protektif dan strategi penanganan jangka panjang. Erosi subjektivitas dengan demikian menjadi gangguan perkembangan yang diinduksi secara klinis, meningkatkan risiko kronisitas, ketergantungan medis, dan pengucilan sosial. Bukti ilmiah menggarisbawahi pola ini. Penelitian di bidang psikoneuroimunologi, perawatan berbasis trauma, dan pengobatan naratif telah menunjukkan bahwa pemulihan agensi subjektif sangat penting untuk integrasi saraf, regulasi emosional, dan pemulihan jangka panjang. Studi epigenetik menunjukkan bahwa lingkungan relasional yang merugikan, termasuk pembatalan klinis, dapat melanggengkan ekspresi gen yang berhubungan dengan stres, peradangan saraf, dan disregulasi kekebalan tubuh. Temuan ini menantang anggapan netralitas hirarki diagnostik dan menegaskan perlunya model yang mengembalikan koherensi naratif dan memvalidasi cerita pasien sebagai landasan penyembuhan. Mengatasi erosi subjektivitas membutuhkan reformasi struktural dan epistemologis. Intervensi harus mencakup pelatihan wajib dalam perawatan berbasis naratif, protokol untuk mengintegrasikan catatan subjektif ke dalam keputusan perawatan, dan audit institusional rutin terhadap praktik dokumentasi untuk mendeteksi dan memperbaiki bias. Pengawasan waktu nyata dan kerangka kerja konsultasi sejawat dapat memperkuat konsistensi etika dan meningkatkan akuntabilitas praktisi. Langkah-langkah ini bukanlah cita-cita teoretis, melainkan reformasi klinis yang dapat ditindaklanjuti yang didasarkan pada bukti biomedis dan psikososial (Bottaccioli & Bottaccioli, 2025).

Oleh karena itu, dimensi kegagalan perawatan ini harus dipahami bukan hanya sebagai kurangnya kasih sayang atau pengawasan profesional, tetapi sebagai faktor penentu yang dapat diukur dari hasil kesehatan. Koreksi terhadap semua kerusakan iatrogenik menuntut konvergensi ilmu saraf, etika klinis, dan advokasi pasien dalam paradigma perawatan yang memusatkan subjektivitas sebagai alat diagnostik dan terapeutik utama. Data lapangan menunjukkan bahwa praktik psikiatri sering kali gagal memasukkan kerangka kerja yang peka terhadap perkembangan. Di seluruh populasi dan lokasi etnografi yang disurvei, individu melaporkan bahwa kesulitan masa kanak-kanak, pengabaian, dan kekurangan emosional tidak dinilai atau diintegrasikan secara memadai ke dalam perawatan. Alih-alih melihat disregulasi perilaku, penarikan diri secara sosial, atau ketidakstabilan emosi sebagai sinyal dari kebutuhan perkembangan yang tidak terpenuhi, manifestasi ini ditafsirkan melalui lensa klinis yang tidak kontekstual. Akibatnya, intervensi ini tetap tidak selaras dengan jalur etiologi gangguan yang sebenarnya (WHO, 2010).

Ketidaksesuaian ini diperburuk oleh lanskap sosiokultural di mana banyak partisipan tinggal. Dalam lingkungan yang ditandai dengan pengabaian diri yang dinormalisasi, literasi kesehatan yang rendah, dan kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi secara kronis, remaja dan orang dewasa disosialisasikan ke dalam pola pengabaian diri. Alih-alih membangun ketahanan, adaptasi ini justru memperkuat pelepasan diri dari sinyal tubuh, penyelarasan relasional, dan kesadaran lingkungan (Suman Fernando, 2017). Presentasi klinis yang dihasilkan, keadaan disforik, kelelahan, dan ketidakpatuhan, disalahartikan sebagai gangguan primer daripada respons sekunder terhadap ketidaksesuaian perkembangan dan pemiskinan sosial budaya. Literatur ilmiah memberikan dukungan substansial untuk interpretasi ini. Psikobiologi perkembangan menunjukkan bahwa pengabaian emosional dan lingkungan awal yang buruk mengubah responsifitas stres, plastisitas saraf, dan titik setel imunoendokrin (Scheper-Hughes, 2001). Studi longitudinal menghubungkan faktor-faktor ini dengan kemunculan depresi, kecemasan, gangguan makan, dan disregulasi metabolik

di kemudian hari. Peningkatan kortisol kronis, berkurangnya tonus vagal, dan aktivasi sitokin inflamasi sekarang diakui sebagai biomarker dari kelebihan beban allostatik yang berakar pada cedera biologis. Proses-proses ini tidak langka atau istimewa, mereka mencerminkan biaya biologis dari norma-norma budaya yang mendorong stimulasi berlebihan, kurang tidur, nutrisi yang tidak teratur, dan penekanan emosional. Pengambilan keputusan bersama yang bertanggung jawab dan didukung oleh orang tua, serta manajemen pengobatan yang otonom, membutuhkan pelatihan prasyarat untuk tidak menyabotase diri sendiri; dalam semua kasus, jika memungkinkan, sejak dini di lingkungan sekolah dan pelatihan orang tua (Bentall, 2003). Hanya dengan cara ini kita dapat meningkatkan sumber daya manusia, membebaskan sumber daya untuk membantu mereka yang paling membutuhkan, yang terkena dampak parah (Dain, 2007).

Penelitian lapangan dan literatur juga menunjukkan bagaimana jenis-jenis penularan sosial lainnya memainkan peran penting. Pola gaya hidup yang berbahaya, yang dinormalisasi dalam sistem teman sebaya dan keluarga, membentuk kebiasaan makan, penggunaan narkoba, dan siklus tidur sejak usia dini (Sapolsky, 2017). Paparan terhadap panutan yang buruk dan kurangnya figur orang dewasa yang mendukung merusak perancah perkembangan yang diperlukan untuk pengaturan diri dan perilaku yang berorientasi pada kesehatan; media juga memainkan peran besar, seperti halnya agama, dalam menetapkan penghargaan dan rasa malu, mekanisme status, perlindungan di balik tembok, dan kekerasan kelompok dalam bentuk apa pun pada etika yang hanya menjadi fasad, dan moral serta cara-cara yang sebagian besar memungkinkan diri mereka sendiri untuk mengambil bagian, meskipun itu salah (Young, 1999; Minkowitz, 2022). Kriminalitas dalam kehidupan sehari-hari, dinormalisasi, dalam banyak konteks (Gross, 2006). Sistem psikiatri gagal untuk menghentikan lintasan ini, sebagian karena mereka jarang menginterogasi konteks ekologis yang lebih luas dari tekanan atau menawarkan perbaikan perkembangan sebagai tujuan klinis (Perry & Szalavitz, 2006).

Tanggapan yang efektif harus mengadopsi definisi kesehatan WHO yang positif, dan perspektif umur. Kebahagiaan, yang dikejar, sebagai realisasi penuh dari potensi manusia, dalam istilah Aristoteles, bukan egois jangka pendek dan biadab, tidak memanusiaikan kepuasan ucapan selamat hanya untuk kesenangan sesaat (Organisasi Kesehatan Dunia, 1948). Strategi pencegahan harus mencakup program terstruktur untuk pendidikan emosional, literasi kesehatan, dan dukungan perkembangan berbasis masyarakat sejak usia dini. Sekolah, penyedia layanan kesehatan, dan sistem sosial harus berkolaborasi untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal ketidaksesuaian biokultural dan melakukan intervensi sebelum pelabelan psikiatri menjadi standar (Keyes, 2002). Mengintegrasikan dimensi-dimensi ini ke dalam penilaian klinis bukanlah pelengkap, tetapi merupakan hal yang mendasar bagi klaim perawatan yang berpusat pada orang. Dalam kerangka tesis ini, analisis ini memperdalam jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai dasar-dasar epistemik dari gangguan kejiwaan dan kondisi struktural yang menghambat perawatan yang bermakna. Bab 4 telah menunjukkan bagaimana lingkungan yang koersif memperburuk trauma perkembangan; di sini, Bab 5 mengintegrasikan wawasan tersebut dengan implikasi biomedis dan pendidikan. Bab 6 akan menguraikan mekanisme hukum dan mekanisme berbasis hak yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian sistemik ini dan mengaitkan kembali perawatan dengan model dukungan manusia yang teruji secara ilmiah dan selaras dengan perkembangan.

Perpaduan antara psikoneuroimunologi, psikiatri metabolik, dan ilmu trauma menunjukkan bahwa tekanan psikologis yang berkelanjutan tidak hanya sekadar pengalaman, tetapi juga menghasilkan perubahan fisiologis yang dapat diukur yang membutuhkan perawatan individual yang tepat. Sistem psikiatri yang sebagian besar mengandalkan algoritme diagnostik berbasis gejala dan rejimen farmakologis untuk tujuan umum secara sistematis mengabaikan heterogenitas biokimia dan mekanisme fisiologis yang mendasari banyak hal yang dicap sebagai penyakit mental. Studi empiris telah mengkonfirmasi bahwa kesulitan awal dan stres yang berkepanjangan mengaktifkan aksis hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA), mengganggu umpan balik neuroimun, dan mengubah fungsi mitokondria (Boyle, 2002; Insel, 2013). Proses-proses ini berkontribusi pada peradangan sistemik, resistensi insulin, dan stres oksidatif, yang semuanya sangat terkait dengan fenotip depresi dan kecemasan, serta gangguan kognitif dan kelelahan kronis. Gangguan biologis ini tidak hanya bersifat korelasional. Penelitian mekanistik telah menetapkan jalur sebab akibat yang menghubungkan gangguan ritme sirkadian, arsitektur tidur yang buruk, ketidakcukupan nutrisi, dan stres psikososial dengan gangguan yang dapat diukur pada transmisi saraf, neurogenesis, dan regulasi sumbu usus-otak. Penelitian lapangan menegaskan bahwa wawasan ilmiah ini hampir seluruhnya tidak ada dalam penilaian psikiatri rutin. Status gizi, integritas mikrobioma, variabilitas glikemik, dan fungsi mitokondria tidak dievaluasi atau dipertimbangkan dalam keputusan pengobatan. Pasien jarang ditawarkan skrining metabolik atau intervensi yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan fisiologis (Cosgrove & Whitaker, 2015). Sebaliknya, mereka menerima obat-obatan yang dapat memperburuk disfungsi yang mendasarinya, termasuk sindrom metabolik, akatisia, dan disautonomia. Tidak adanya biomarker terintegrasi dalam praktik klinis menyebabkan keterputusan epistemik yang mendalam antara ilmu pengetahuan yang sedang berkembang dan perawatan institusional.

Keterputusan ini tidak bersifat insidental atau sementara. Hal ini mencerminkan kelambanan sistem pendidikan klinis, orientasi farmakosentris dari institusi psikiatri, dan kurangnya pelatihan interdisipliner dalam pengobatan sistem yang kompleks. Survei dari Bab 3 mengungkapkan ketidakpuasan yang meluas di antara para profesional dengan terbatasnya cakupan alat asesmen dan intervensi yang tersedia. Pengamatan lapangan dari Bab 4 lebih lanjut mendokumentasikan bagaimana para praktisi yang berusaha mengintegrasikan wawasan nutrisi atau metabolik ke dalam perawatan sering kali terpinggirkan atau diabaikan, pendekatan mereka dianggap pinggiran meskipun telah divalidasi secara ilmiah. Kegagalan untuk menerjemahkan temuan psikoneuroimunologis dan metabolik ke dalam protokol psikiatri menghasilkan penanganan yang kurang tepat terhadap faktor-faktor yang dapat dimodifikasi dan ketergantungan yang berlebihan terhadap psikotropika non-spesifik (Kleinman, 1997). Hal ini berkontribusi pada bahaya iatrogenik, kronisitas, dan kekecewaan di antara pengguna dan dokter. Hal ini juga melanggar prinsip-prinsip etika beneficence dan non-maleficence, sebagaimana didefinisikan dalam hukum kesehatan internasional dan pedoman profesional. Lebih penting lagi, hal ini merusak tujuan utama pengobatan: untuk memulihkan dan mempertahankan integritas fisiologis dan psikologis melalui cara yang paling tidak berbahaya dan paling efektif yang tersedia. Untuk menjembatani kesenjangan ini, pedoman klinis nasional harus diperbarui dengan memasukkan protokol berbasis bukti untuk skrining metabolik, penilaian nutrisi, dan intervensi individual yang menangani akar penyebab kesusahan. Kurikulum pelatihan untuk

psikiatri dan kedokteran umum harus memasukkan psikoneuroimunologi sebagai ilmu dasar, bukan pilihan. Prioritas penelitian harus bergeser untuk menyelidiki model kombinatorial dan integratif yang mencerminkan kompleksitas penderitaan manusia (UN OHCHR, 2015). Hal ini membutuhkan kerja sama multidisiplin di antara para ahli saraf, ahli imunologi, ahli diet, psikolog, dan ahli kesehatan masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan dalam tesis ini, terutama di Bab 1 dan 2, mengatasi pemaksaan sistemik dan ketidakadilan epistemik tidak hanya membutuhkan perubahan kebijakan, tetapi juga penyelarasan epistemologis. Mereka yang saat ini masih tidak bersuara dibutuhkan dalam kekuasaan untuk membantu memperbaiki masalah besar ini (Metzl, 2010). Bagian ini berkontribusi pada solusi yang disarankan oleh para ahli dan saksi mata, selaras dengan literatur, dengan menggambarkan bagaimana praktik psikiatri saat ini secara sistematis mengecualikan domain pengetahuan yang krusial, sehingga melanggengkan model perawatan yang tidak efektif dan berbahaya (Verdugo dkk., 2012). Bab 6 akan mengeksplorasi mekanisme peraturan dan kelembagaan yang diperlukan untuk memperbaiki kegagalan ini, memastikan keselarasan hukum dan etika dengan ilmu biomedis kontemporer (Szasz, 1974). Pada tingkat molekuler dan sistemik, organisme manusia dirancang untuk pengaturan bersama, bukan isolasi. Neurobiologi keterikatan dan regulasi endogen dari pengaruh, fungsi kekebalan tubuh, dan homeostasis neuroendokrin bergantung pada lingkungan sosial yang aman dan selaras di sepanjang masa. Gangguan pada kondisi ini, baik melalui pengabaian, permusuhan, paksaan, atau depersonalisasi institusional, menghasilkan disregulasi terukur dari proses homeostatis yang penting bagi kesehatan (Scheper-Hughes & Bourgois, 2004). Oksitosin, vasopresin, opioid endogen, dan sistem serotonin memainkan peran penting dalam modulasi kepercayaan, afiliasi, dan rasa sakit. Ekspresi dan regulasi mereka bergantung pada pengalaman, yang berarti bahwa pengalaman relasional awal, dan interaksi komunitas di kemudian hari, membentuk garis dasar neurokimia dan daya tanggap. Kelekatan yang aman dan interaksi prososial merangsang pelepasan oksitosin dan endorfin, menurunkan respons stres, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, dan berkontribusi pada stabilitas kardiovaskular, metabolisme, dan neurokognitif. Sebaliknya, pengucilan sosial, ancaman yang dirasakan, dan permusuhan atau ketidakpedulian yang dilembagakan terkait dengan disregulasi aksis HPA, peningkatan beban alostatik, peradangan kronis, dan gangguan afektif (Cosgrove, Mills, Karter, Morrill, & McKenna, 2020). Temuan-temuan ini tidak bersifat spekulatif. Studi terkontrol dalam psikoneuroimunologi dan ilmu saraf sosial telah berulang kali menunjukkan bahwa isolasi sosial, kurangnya sentuhan, tidak adanya kontak mata, dan kurangnya lingkungan yang memvalidasi secara emosional berkorelasi dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas di hampir semua penyakit kronis. Pada populasi psikiatri, hilangnya rasa aman berkorelasi dengan eksaserbasi gejala, keinginan untuk bunuh diri, dan resistensi terhadap pengobatan farmakologis (Bracken et al., 2012). Oleh karena itu, pengabaian emosional bukan hanya sebuah pengalaman subjektif, tetapi juga merupakan penghinaan fisiologis dengan konsekuensi multi-organ yang bertingkat (Foucault, 1977; 2006).

Penelitian lapangan yang dilakukan dalam tesis ini (Bab 4) mengungkapkan bagaimana ruang-ruang institusional sering kali gagal mendorong dinamika sosial yang melindungi ini. Sebaliknya, para profesional sering kali menjaga jarak emosional, menghindari hubungan yang diwujudkan, dan mengandalkan paradigma kontrol perilaku yang secara tidak sengaja meniru lingkungan yang

traumatis. Survei yang dilaporkan dalam Bab 3 mengindikasikan bahwa sebagian besar praktisi merasa tidak siap atau tidak didukung dalam memberikan perawatan berbasis hubungan. Budaya yang berlaku di banyak fasilitas kesehatan lebih menyukai hal-hal yang dirusak dan dirahasiakan, dokumentasi yang kurang, dugaan penahanan risiko, dan kepatuhan farmakologis yang berbahaya daripada hubungan antar manusia, validasi, dan pembangunan kepercayaan. Erosi regulasi interpersonal tercermin dalam sistem pendidikan dan keluarga, yang sering kali mempatologiskan ketidaksesuaian daripada mengenalinya sebagai sinyal kebutuhan perkembangan atau emosional yang tidak terpenuhi. Munculnya kerangka kerja manajemen perilaku di sekolah dan rumah meniru logika institusional, mempromosikan kepatuhan daripada menumbuhkan rasa memiliki atau ketahanan. Hal ini melanggengkan siklus di mana pemutusan hubungan emosional menjadi medis, dan substrat neurobiologis penyembuhan, empati, keamanan, ikatan, secara aktif ditekan. Sistem medis seharusnya menyadari bahwa inti dari kesehatan mental bukanlah penyesuaian individu terhadap patologi, tetapi penyesuaian sosial terhadap neurofisiologi dasar dari koneksi. Hal ini membutuhkan reorientasi lengkap dari paradigma psikiatri dan pendidikan untuk memasukkan interaksi yang diwujudkan, sinkronisasi afektif, dan penahan hubungan yang aman sebagai mekanisme pengobatan utama. Pedoman klinis harus memasukkan protokol yang tervalidasi untuk membangun keamanan relasional, termasuk penggunaan kontak mata, modulasi suara, keterbukaan postur, dan kesaksian naratif dalam perawatan rutin.

Dari sudut pandang peneliti dan ahli lainnya, program pelatihan di bidang kedokteran harus diperluas dengan memasukkan ilmu saraf kelekatan, ilmu saraf afektif, dan komunikasi berbasis trauma (Rose, 2007). Para praktisi harus dibekali dengan keterampilan dan dukungan institusional untuk membentuk hubungan yang tulus dan reparatif dengan mereka yang mereka layani. Elemen-elemen ini bukanlah tambahan untuk perawatan, mereka adalah fondasi biologisnya. Bagian ini menegaskan bahwa ilmu penyembuhan tidak dapat dipisahkan dari ilmu hubungan. Disertasi ini mengintegrasikan prinsip ini ke dalam proposal untuk reformasi pendidikan dan mekanisme akuntabilitas hukum, memastikan bahwa perawatan dan kebijakan selaras dengan apa yang ditunjukkan dengan jelas oleh bukti: bahwa kesehatan manusia dimulai dan diakhiri dengan hubungan yang aman, bermakna, dan koheren secara biologis. Kegagalan untuk mengintegrasikan pengetahuan yang mapan secara ilmiah tentang subjektivitas, pengembangan, dan peraturan yang diwujudkan ke dalam praktik kelembagaan bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena kegagalan penerjemahan. Tantangan ke depan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sistemik: mengubah wawasan yang telah divalidasi dari ilmu saraf, psikoneuroimunologi, dan penelitian tentang trauma menjadi standar yang mengikat, protokol pelatihan, dan mandat operasional di seluruh domain yang relevan. Hal ini mencakup layanan kesehatan jiwa, perawatan medis umum, pendidikan, dan kebijakan kesehatan masyarakat.

Praktik psikiatri saat ini di banyak yurisdiksi terus bergantung pada kerangka diagnostik dan rejimen psikofarmakologis yang tidak mengakomodasi sejarah perkembangan spesifik seseorang atau variabilitas biokultural, dan secara tragis bergantung pada model yang sudah ketinggalan zaman dan tidak memiliki validitas ilmiah (Kinderman, 2014). Kegigihan model reduksionis yang berorientasi pada gejala merusak potensi pendekatan yang lebih baru yang didasarkan pada biologi sistem, genomik sosial, dan kedokteran jaringan (Kutchins & Kirk, 1997; Mills, 2014). Bidang-bidang yang sedang berkembang ini menunjukkan bahwa penderitaan mental tidak dapat dipisahkan dari tekanan

lingkungan, pengucilan sosial, defisit nutrisi, gangguan sirkadian, atau beban imunologis kronis. Mereka menuntut pergeseran epistemik dari kategori sindrom yang terisolasi dan menuju arsitektur perawatan terpadu yang mampu mengatasi faktor penentu hulu. Untuk mengoperasionalkan pengetahuan ini, institusi harus mengadopsi jalur perawatan yang dinamis dan individual yang dipandu oleh indikator waktu nyata dari tekanan biopsikososial (Breggin, 2008). Protokol penilaian klinis harus mencakup alat yang tervalidasi untuk mengevaluasi pengalaman masa kecil yang merugikan, status gizi, integritas tidur, penanda inflamasi kekebalan tubuh, dan keamanan relasional (Leo & Lacasse, 2008). Variabel-variabel ini harus menginformasikan perencanaan perawatan di setiap tingkat, mulai dari asupan hingga tindak lanjut, dengan konferensi kasus interdisipliner yang memastikan bahwa keputusan terapi mencerminkan kompleksitas penuh dari orang tersebut, tidak hanya kendala dari sistem layanan (Kutchins & Kirk, 1997).

Tabel 47. Ilmu saraf relasional dan persyaratan pelatihan sistemik

Domain	Dasar Ilmiah	Konten Pendidikan yang Dibutuhkan	Implikasi Operasional	Relevansi dengan Tesis
Ilmu Saraf Kelekatan	Pola kelekatan awal membentuk respons stres, regulasi emosi, dan perkembangan saraf melalui jalur jangka panjang dari sistem limbik	Kurikulum tentang ikatan bayi-pengasuh, Melatih para profesional untuk mengenali gangguan kelekatan yang tidak terorganisir, konsekuensi terkait kelekatan dan menghindari penelantaran dan retraumatisasi pelecehan		Mendukung tesis yang menyatakan bahwa pengasuhan yang bersifat koersif merusak proses perkembangan dasar dan harus digantikan dengan keamanan relasional
Ilmu Saraf Afektif	Emosi diatur secara biologis melalui sirkuit saraf tertentu (misalnya, amigdala, insula, korteks prefrontal), yang peka terhadap input relasional dan lingkungan	Modul tentang valensi emosional, integrasi neurokognitif, mempengaruhi disregulasi pada trauma	Pergeseran dari model kontrol perilaku ke penyelarasan emosi dan praktik pengaturan bersama	Memperkuat kebutuhan akan pendekatan yang berbasis trauma dan tidak menghukum untuk mengatasi tekanan dan ekspresi perilaku
Komunikasi Berbasis Informasi Trauma	Keamanan relasional memodulasi fisiologi stres, termasuk kortisol dan tonus vagal, yang memungkinkan penyembuhan melalui pengaturan bersama dan integrasi naratif	Teknik komunikasi yang didasarkan pada mendengarkan secara aktif, tanpa kekerasan, validasi, dan pemulihan naratif	Penerapan praktik-praktik kelembagaan yang membangun kepercayaan, mengurangi respons ketakutan, dan menumbuhkan efikasi diri	Kerangka kerja tesis yang menghubungkan trauma, paksaan, dan ketidakadilan epistemik dalam pengaturan kejiwaan dan hukum
Keharusan Biologis akan Keselamatan	Ancaman relasional kronis mendisregulasi sistem kekebalan tubuh, endokrin, dan otonom, yang berkontribusi pada penyakit dan kematian (misalnya, beban alostatik)	Kerangka kerja untuk menilai kebutuhan keselamatan, keamanan emosional, dan konteks relasional dalam diagnosis dan intervensi	Menyelaraskan keputusan klinis dan hukum dengan bukti nyata tentang bahaya vs. penyembuhan	Memberikan pembenaran biokultural untuk mengganti rutinitas koersif dengan sistem partisipatif dan berbasis hak
Integrasi Sistemik	Pelatihan lintas sektor dan mekanisme akuntabilitas harus memastikan bahwa ilmu pengetahuan relasional menginformasikan perawatan dan tata kelola	Standar nasional yang mengintegrasikan ilmu perkembangan saraf ke lintas sektoral yang berakar pada biologi kesehatan, hukum, dan manusia pendidikan pemulihan trauma	Penerapan protokol interdisipliner dan yang berakar pada biologi dan pemulihan trauma	Memenuhi tujuan tesis untuk mengembangkan model terpadu berbasis bukti untuk reformasi struktural di seluruh sistem perawatan

Pelatihan untuk Koneksi: Kompetensi Berbasis Ilmu Saraf untuk Mengganti Pemaksaan dengan Penyembuhan dalam Praktik Psikiatri, Pendidikan, dan Hukum

Sistem pendidikan juga membutuhkan transformasi struktural. Kurikulum di semua tingkat pelatihan medis dan kesehatan mental harus memasukkan modul dasar tentang neurobiologi perkembangan, fisiologi stres, ilmu gizi, pedagogi berbasis trauma, dan pengobatan naratif. Kurikulum kesehatan masyarakat harus diperluas dengan memasukkan strategi berbasis komunitas untuk menumbuhkan

kesehatan mental melalui gaya hidup, kohesi sosial, dan kesejahteraan ekologis. Mengajarkan masyarakat untuk memahami dan mengelola biologi stres, ketahanan, dan regulasi yang memengaruhi harus dilihat bukan sebagai kemewahan tetapi sebagai kewajiban demokratis. Kerangka kerja kebijakan harus bergerak lebih dari sekadar pernyataan niat secara umum. Kerangka kerja tersebut harus mencakup standar yang dapat ditegakkan untuk kualitas perawatan dan akuntabilitas, didukung oleh infrastruktur data yang kuat dan pemantauan partisipatif. Institusi harus bertanggung jawab untuk mendokumentasikan tidak hanya kepatuhan prosedural tetapi juga hasil jangka panjang dalam pemulihan, kualitas hidup, dan reintegrasi sosial (Davies, 2013). Penerapan pelacakan hasil yang transparan dan registrasi kualitas dengan akses terbuka sangat penting untuk menyelaraskan kembali insentif kelembagaan terhadap perawatan yang berpusat pada orang, perawatan berbasis bukti, kejahatan harus dicegah, dan teknologi harus melayani kita semua sebagai keharusan etis yang ditegakkan dan diajarkan sejak dini (McGoey, 2007).

Tidak hanya pada manusia: pada sebagian besar spesies, lintasan biologis dari masa bayi hingga dewasa ditandai oleh transisi fisiologis yang dapat diidentifikasi. Pada spesies kita, transisi ini disusun lebih lanjut oleh ritual simbolis, sosial, dan budaya yang memperkuat identitas, rasa memiliki, dan saling ketergantungan. Busur perkembangan ini mencakup periode kritis plastisitas otak, pematangan hormon, reorganisasi metabolisme, dan pencetakan relasional. Setiap fase menuntut respons lingkungan yang terkalibrasi, nutrisi yang memadai, penyesuaian afektif, perlindungan dari stres kronis, dan peluang untuk pembelajaran eksplorasi. Tanpa adanya kondisi-kondisi ini, perkembangan saraf akan terganggu, dan mekanisme penanggulangan yang maladaptif akan mengakar secara biologis. Selama masa kanak-kanak, sistem kelekatan dan pengaturan stres dikodekan melalui interaksi berulang dengan pengasuh. Sumbu hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA), regulasi kekebalan tubuh, dan tonus vagal semuanya dibentuk oleh keamanan lingkungan atau ketiadaan lingkungan. Pada masa remaja, pemangkasan sinapsis dan mielinisasi mengatur ulang pemrosesan kognitif-emosional dan memungkinkan pematangan fungsi eksekutif. Fase ini merupakan titik belok fisiologis, mempersiapkan organisme untuk otonomi, seksualitas, ikatan pasangan, dan generativitas. Budaya secara tradisional menyediakan narasi, ritual, dan peran untuk memandu transformasi ini. Ketika perancah seperti itu tidak ada atau tidak berfungsi, transisi terhenti, dan pola-pola sebelumnya bertahan hingga dewasa, ketergantungan yang berlebihan, impulsif, agresi, atau ketidakpuasan (Kalathil, 2018). Sistem saraf orang dewasa terus beradaptasi dengan tuntutan lingkungan, tetapi dengan plastisitas yang berkurang dan biaya metabolisme yang lebih besar. Paparan yang berkelanjutan terhadap kesulitan, isolasi, atau pengulangan yang tidak berarti menghasilkan kelebihan beban allostatis, sebuah prekursor yang mapan untuk kondisi kejiwaan, kardiovaskular, autoimun, dan neurodegeneratif (Eiroa-Orosa & Rowe, 2017). Sebaliknya, hubungan positif, aktivitas yang terarah, gerakan fisik, dan integritas metabolik mengaktifkan jalur homeostatis dan reparatif, yang dimediasi oleh opioid endogen, oksitosin, dan faktor neurotropik (Smith, 2016). Substrat molekuler dari makna, kesenangan, dan keterikatan bukanlah abstraksi filosofis tetapi proses neurobiologis yang dapat diukur dengan implikasi kesehatan jangka panjang (El-Khoury, Haidar, & Barkil-Oteo, 2021).

Fakta-fakta ini didokumentasikan dengan baik di seluruh ilmu saraf perkembangan, psikoneuroendokrinologi, dan imunologi perilaku, dan sangat dibutuhkan dalam psikiatri

translasional. Namun, hal ini masih hampir seluruhnya terputus dari penilaian dan intervensi psikiatri standar. Kriteria diagnostik mengabaikan koherensi biografis, narasi subjektif, dan urutan perkembangan. Praktik klinis standar tidak menilai tonus vagal, arsitektur tidur, penanda inflamasi, atau ritme hormonal, terlepas dari peran sentral mereka dalam membentuk kognisi dan afek (El-Khoury, Haidar, & Barkil-Oteo, 2021). Sejarah relasional atau stresor perjalanan hidup juga tidak diintegrasikan ke dalam perencanaan perawatan di luar referensi yang samar-samar terhadap faktor psikososial. Sebaliknya, penderitaan yang dapat diamati ditafsirkan kembali sebagai patologi, dan diobati dengan agen farmakologis yang mekanismenya tidak selaras dengan proses biologis yang dipertaruhkan.

Nosologi psikiatri terus bergantung pada teori-teori ketidakseimbangan neurotransmitter dan faktor keturunan yang belum terbukti sebagai alat penjelas (Moncrieff, 2008; Healy, 2012; Lacasse & Leo, 2005; Leo & Lacasse, 2008; Kinderman, 2014; Kirsch, 2010; Gøtzsche, 2015). Konstruk-konstruk ini, yang tidak didukung oleh biomarker yang dapat direplikasi atau tes prediktif, memiliki tujuan fungsional dan bukan tujuan ilmiah: mereka mengesahkan intervensi medis tanpa memberikan penjelasan kausal (Frances, 2013; Kirk, Gomory, & Cohen, 2013; Diakon, 2013; Rose, 2007). Hal ini merupakan pelanggaran epistemologis. Dalam filsafat ilmu pengetahuan, sebuah teori tanpa falsifiabilitas, akurasi prediksi, atau kejelasan mekanistik tidak dapat disebut sebagai penjelasan (Szasz, 2007; Bracken et al., 2012; Davies, 2013; Whitaker, 2010). Dalam dunia kedokteran, konsekuensi dari kelemahan epistemik ini tidak hanya bersifat konseptual tapi juga mematikan, individu dibius, ditahan, atau didiskreditkan berdasarkan kerangka kerja yang tidak memenuhi standar minimal pembuktian ilmiah (Whitaker, 2010; Gøtzsche, 2015; Moncrieff, 2008; Healy, 2012; Davies, 2013; Rose, 2007; Szasz, 2007; Bracken dkk., 2012; Kinderman, 2014).

Model yang ada saat ini, seperti yang dicatat oleh para ahli dalam survei dan penelitian lapangan dalam penelitian aksi ini, memiliki banyak kekurangan. Model ini gagal memberikan pemahaman yang berarti tentang perkembangan manusia dan kebutuhan relasional, dan model ini beroperasi dengan kepura-puraan filosofis tentang otoritas ilmiah yang runtuh di bawah pengawasan (Insel, 2013). Tidak adanya kesadaran perkembangan dalam perawatan psikiatri tidak mencerminkan ketidaktahuan, tetapi resistensi institusional terhadap kompleksitas. Sebuah ilmu kesehatan sepanjang hayat akan menuntut tidak hanya diagnosis yang lebih baik dan intervensi yang lebih beragam, tetapi juga reorientasi radikal di bidang ini, dari pengekangan dan kepatuhan ke arah koherensi, perkembangan, dan integritas fisiologis. Reorientasi ini tidak lagi bersifat spekulatif: reorientasi ini didukung oleh penelitian yang telah terakumulasi selama beberapa dekade di berbagai disiplin ilmu, yang kini sangat membutuhkan implementasi (Cosgrove & Whitaker, 2015).

5.3 Pengabaian struktural: marjinalisasi sosial dan penghancuran kehidupan

Penelitian lapangan yang didokumentasikan dalam Bab 4, dan ditriangulasi dengan data survei dan testimoni, mengungkap pola yang meresap: keluarga yang mengelola tanggung jawab pengasuhan untuk anggota keluarga yang mengalami gangguan psikososial, variasi kognitif atau neurologis, atau ketergantungan fungsional, secara rutin ditinggalkan tanpa dukungan struktural, pendampingan yang protektif, atau bantuan dari strategi intervensi yang bersifat non-koersif. Beban ini, yang sering kali

tersembunyi di dalam ruang privat, tidak diimbangi dengan akses yang berarti terhadap sumber daya profesional, mekanisme jeda, atau konsultasi dialogis (Scheper-Hughes, 2001). Akibatnya, pemaksaan menjadi normal sebagai alat manajemen krisis, bukan karena dirancang tetapi karena kelelahan. Dalam konteks seperti itu, ketiadaan kehadiran institusi tidak berfungsi sebagai netralitas, tetapi sebagai pendelegasian yang diam: ekspektasi struktural bahwa keluarga akan menahan, mendisiplinkan, atau menundukkan apa pun yang melebihi ambang batas normatif perilaku atau kebutuhan, dengan cara apa pun yang tersedia bagi mereka (WHO, 2010). Ketika sistem publik gagal untuk memastikan kesinambungan perawatan, hak-hak yang dapat ditegakkan, dan dukungan langsung pada saat-saat kerentanan, sistem tersebut secara diam-diam mengesahkan pemaksaan dan pengawasan informal di dalam ruang domestik. Hal ini terjadi di semua masyarakat kita, yang membelenggu dan mengunci secara tidak manusiawi, mengabaikan, bahkan sampai pada penyiksaan medis; sebuah kejahatan besar terhadap kemanusiaan (Kleinman, 1997; UN OHCHR, 2015; Minkowitz, 2022).

Pola ini terutama terlihat jelas pada keluarga-keluarga yang mengalami stres multigenerasi, trauma antargenerasi, atau kemiskinan struktural (Suman Fernando, 2017). Apa yang muncul adalah bentuk pendelegasian yang tidak disengaja: keluarga menjadi aktor utama dalam sistem pengekangan, medisikasi, dan manajemen hukuman, terlepas dari kapasitas, kesehatan mental, atau pemahaman mereka tentang kerangka kerja alternatif. Dalam ekosistem yang tegang ini, individu yang menunjukkan tekanan atau penyimpangan, anak-anak yang mengalami krisis emosional, orang tua yang mengalami penurunan kognitif, remaja yang mengalami kekacauan identitas, sering kali menjadi sasaran isolasi, pengobatan paksa, degradasi verbal, atau bahkan pengekangan fisik. Tindakan-tindakan ini, meskipun jarang dicatat atau dikategorikan dalam sistem hukum sebagai kekerasan, merupakan bentuk-bentuk pemaksaan dalam rumah tangga yang paralel dengan dinamika kelembagaan yang dikritik dalam Bab 3 dan 4. Perbedaannya tidak terletak pada maksud atau konteks, tetapi pada visibilitas dan penegakan hukum.

Tabel 48. Konsekuensi fisiologis dari pengabaian dan pemaksaan

Peran pelaku	Bentuk bahaya	Jalur fisiologis yang terpengaruh	Konsekuensi saraf	Hasil sistemik
Keluarga (pengabaian atau pemaksaan)	Pengabaian emosional, ketidakpastian, pengasuhan menghukum yang	Hiperaktivasi aksis HPA, sinyal oksitosin yang tertekan, perkembangan saraf yang terganggu	Berkurangnya ketebalan kortikal, gangguan sirkuit metabolisme, kelelahan, disregulasi kerentanan penyakit	Imunosupresi, disregulasi metabolisme, peningkatan kerentanan penyakit
Dokter atau klinisi (paksaan)	Perawatan paksa, sedasi, pengabaian persetujuan atau kebutuhan relasional	Peningkatan kortisol, peradangan saraf, integrasi prefrontal yang tertekan	Atrofi hipokampus, penonaktifan lobus frontal, perataan afektif	Gejala psikosomatis, anhedonia, ketidakberdayaan yang dipelajari
Aktor institusional (misalnya sekolah)	Pemaksaan administratif, pengawasan, pembatalan, pengucilan sistemik	Beban stres kronis, jaringan rasa sakit sosial, disregulasi limbik	Hilangnya konektivitas dalam jaringan mode default, penurunan neuroplastisitas	Penyempitan kognitif, ketidakpercayaan, penyebaran trauma antargenerasi

Tabel ini merangkum dampak biologis dan sistemik dari pengabaian dan pemaksaan oleh anggota keluarga, dokter, dan aktor kelembagaan. Tabel ini menghubungkan bahaya relasional tertentu dengan jalur fisiologis, perubahan saraf, dan hasil kesehatan yang lebih luas.

Sistem hukum dan kesehatan sebagian besar beroperasi dengan model visibilitas reaktif: penyiksaan hanya dapat ditindaklanjuti jika dilaporkan, dan pelaporan tergantung pada ambang batas sempit dari bahaya fisik atau pelanggaran eksplisit. Penderitaan psikologis, ketidakabsahan epistemik, pengabaian emosional, dan paksaan yang disamakan sebagai perawatan berada di luar ambang batas ini. Tesis ini menggarisbawahi bahwa titik buta ini bukanlah kebetulan, tetapi mencerminkan asumsi yuridis dan budaya yang mengakar kuat, yaitu bahwa keluarga adalah ruang alamiah dan protektif yang dinamika internalnya bersifat sakral, bahkan ketika hal tersebut menghasilkan kerugian yang terukur. Bab 6 mengeksplorasi arsitektur hukum ini secara mendalam, menelusuri bagaimana penghormatan hukum terhadap kedaulatan keluarga, ditambah dengan kurangnya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan peradilan, melanggar rezim pengabaian yang diberi sanksi. Di banyak sistem, perlindungan prosedural untuk anak di bawah umur, orang tua, atau individu dengan disabilitas justru dilemahkan di persimpangan antara kekuasaan keluarga dan kejiwaan, di mana otoritas profesional berakhir dan dominasi informal dimulai.

Data empiris di berbagai yurisdiksi mengonfirmasi konsekuensi dari kegagalan ganda ini: kemunduran institusional dan keheningan hukum. Di Spanyol, misalnya, anak-anak dengan diagnosis psikososial secara tidak proporsional dikecualikan dari pendidikan umum dan sering ditempatkan dalam rezim farmakologis dengan dukungan pedagogis yang minimal, sementara keluarga melaporkan kurangnya alternatif yang dapat diakses (Verdugo dkk., 2012; Montaner-Villalba, 2014; Eiroa-Orosa & Rowe, 2017). Di Swedia, seperti yang dibahas dalam kesaksian peserta, intervensi kesejahteraan anak mungkin selaras dengan kontrol migrasi yang bersifat menghukum atau pembuatan profil orang tua, daripada dukungan berdasarkan trauma, yang menunjukkan rasisme terbuka dan kebencian terhadap kehidupan yang berbeda (Puar, 2004; Goldberg, 2006; Fanon, 2008; Eastmond & Ascher, 2011; Kuusisto-Arponen & Giritli-Nygren, 2013; Wernesjö, 2015; Eriksson, 2018; Younis & Jadhav, 2020; Lundberg, 2020). Di Indonesia, keluarga yang merawat kerabat yang

mengalami gangguan jiwa tanpa akses ke layanan kesehatan jiwa publik dapat melakukan pemasungan, pengekangan fisik, isolasi sosial, dan pengucilan secara simbolik (Anderson, 2001; Reid, 1974; Kiernan, 2007; Gerke, 2003; Ford & Lyons, 2012; Minas & Diatri, 2008; Suryani dkk., 2011; WHO, 2010; OHCHR PBB, 2015; Human Rights Watch, 2016). Pola-pola ini berbeda dalam bentuk, tetapi menyatu dalam fungsi: beban keluarga yang berlebihan menjadi mekanisme yang melaluinya pengabaian sistemik diberlakukan.

Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diartikulasikan dalam disertasi ini, terutama yang membahas bagaimana pemaksaan dinormalisasi di berbagai ranah, dan bagaimana pengambilan keputusan bersama dan pengasuhan berdasarkan informasi dapat dioperasionalkan dalam lingkungan kelembagaan yang tidak bersahabat atau tidak ada, secara langsung dilibatkan di sini (Goffman, 1961). Subbab ini menawarkan landasan empiris untuk argumen yang lebih luas bahwa paksaan bukanlah kegagalan institusional yang luar biasa, tetapi kemunduran keluarga yang diberi insentif struktural ketika sistem pendidikan, hukum, dan kesehatan melepaskan tanggung jawab mereka. Hal ini juga mengantisipasi proposal legislatif dan kebijakan yang dikembangkan dalam Bab 6, yang menuntut reformasi proaktif, antargenerasi, dan tertanam dalam masyarakat, bergerak dari perlindungan reaktif ke pencegahan berkelanjutan, dari keputusan pribadi ke martabat yang diamanatkan secara publik (Bourdieu, 1998). Pendekatan biokultural dan penularan sosial yang dikembangkan dalam tesis ini memperkuat kebutuhan untuk memahami pemaksaan keluarga tidak hanya sebagai patologi budaya, tetapi sebagai konsekuensi yang dapat diprediksi dari desain sistemik. Manusia, secara universal, memiliki mekanisme neurobiologis untuk berempati, mengatur, dan bekerja sama, namun mekanisme ini dibatasi atau ditekan oleh struktur kelembagaan, narasi budaya, dan kerangka kerja pedagogis (WHO, 2010). Ketika keluarga tertanam dalam masyarakat yang memvonis kesusahan, meremehkan penyesuaian relasional, dan gagal mengajarkan literasi fisiologis dan emosional antar generasi, mereka akan menjadi takut, mengontrol, atau menolak. Apa yang dibingkai sebagai kegagalan keluarga, pada kenyataannya, merupakan ekspresi hilir dari kelalaian infrastruktur, yaitu apa yang tidak diajarkan, tidak didanai, tidak diundang-undangkan, dan tidak dilindungi (Wekker, 2016; Kalathil, 2018).

Bagian analisis ini meletakkan dasar empiris untuk memahami pemaksaan keluarga sebagai hasil dan mekanisme kekerasan struktural. Beban yang ditanggung oleh keluarga dalam ketiadaan solidaritas institusional bukanlah sesuatu yang tidak disengaja. Hal ini diproduksi, terpola, dan terus-menerus. Bagian selanjutnya dari bab ini mengeksplorasi implikasi budaya, ilmiah, dan kebijakan dari temuan tersebut, menyelaraskannya dengan definisi kesehatan WHO dan standar yang dapat ditindaklanjuti yang diusulkan di bawah CRPD, untuk mendapatkan kembali keluarga sebagai tempat regenerasi dan bukannya penindasan (Scheper-Hughes & Lock, 1987).

Tabel 49. Mekanisme penyalahgunaan dan penyembunyian struktural, pengkhianatan institusional

Mekanisme penyalahgunaan	Pembenaran umum	Ilegalitas di bawah hukum internasional	Konsekuensi bagi korban
Pengekangan dan pengurungan fisik (pasung)	Masalah keamanan, tradisi budaya, kurangnya sumber daya	Dilarang berdasarkan pedoman CRPD dan WHO	Cedera fisik, trauma, hambatan perkembangan, stigmatisasi
Pengobatan berlebihan atau pengekangan kimiawi	Kebutuhan pengendalian kurangnya alternatif	klinis, Hanya diperbolehkan dalam kondisi yang ketat, konsensual, dan sementara	Neurotoksisitas, tumpulnya kognitif, ketidakberdayaan yang dipelajari
Isolasi administratif atau rencana perawatan paksaan	Kepatuhan terhadap kebijakan, institusional	Melanggar prinsip-prinsip martabat, transparansi, dan perawatan berbasis hak	Hilangnya otonomi, rusaknya ikatan sosial
Penahanan diagnosis atau kesalahan klasifikasi	Penilaian penghindaran stigma atau konsekuensi hukum	klinis, Bertentangan dengan persetujuan dan hak atas informasi kesehatan yang akurat	Kurangnya dukungan, kebingungan identitas, tekanan kronis
Kegagalan untuk melaporkan penyalahgunaan atau pemalsuan catatan	Loyalitas profesional, minimalisasi bahaya, perlindungan reputasi	Merupakan penghalangan keadilan dan penghinaan institusional	Korban ulang, ketidakberdayaan hukum, ketidaktampakan sistemik

Tabel ini mengidentifikasi lima mekanisme inti yang digunakan untuk melakukan atau menyembunyikan kekerasan struktural dalam sistem kesehatan jiwa dan perawatan sosial, termasuk praktik-praktik tradisional seperti pemasungan dan taktik-taktik institusional modern. Tabel ini membandingkan pembenaran mereka dengan standar hukum internasional dan menguraikan konsekuensi bagi para korban.

Penelitian lapangan yang mendasari disertasi ini mencakup dokumentasi langsung praktik pemasungan di Indonesia, yang dilakukan melalui wawancara dengan para korban, petugas kesehatan, tokoh masyarakat, dan advokat LSM. Pasung, secara harfiah berarti mengikat atau mengikat, mengacu pada pengekangan fisik jangka panjang atau pengurungan individu dengan disabilitas psikososial atau intelektual, yang paling sering terjadi di lingkungan rumah tangga dengan menggunakan belenggu, kurungan bambu, ruang isolasi, atau bangunan sementara. Biasanya dilakukan oleh anggota keluarga atau tetangga karena tidak adanya perawatan kesehatan jiwa yang dapat diakses, terjangkau, atau dapat dipercaya. Meskipun dibingkai sebagai tindakan perlindungan atau diperlukan, pemasungan merupakan pelanggaran langsung terhadap otonomi tubuh, martabat manusia, dan hak atas kesehatan. Indonesia secara resmi telah melarang pemasungan melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes No. 54/2017 dan Permenkes No. 17/2010), bersamaan dengan target nasional Indonesia Bebas Pasung. Namun, implementasinya masih belum merata, terkendala oleh kekurangan dana yang sistemik, stigma yang meluas, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya tenaga profesional yang terlatih, terutama di daerah pedesaan dan daerah pascakolonial yang secara historis terpinggirkan dari layanan negara.

Situasi ini melanggar standar internasional yang mengikat di bawah Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2011, yang memandatkan penghapusan penahanan sewenang-wenang dan mempromosikan perawatan sukarela yang berbasis masyarakat (Pasal 14, 19). Hal ini juga tidak sesuai dengan inisiatif WHO QualityRights, yang menyerukan penghentian praktik-praktik pemaksaan, dengan menekankan martabat, otonomi, dan sistem dukungan yang berorientasi pada pemulihan di seluruh sektor kesehatan, hukum, dan sosial. Spanyol juga telah meratifikasi CRPD, namun masih terus melanggar

ketentuan-ketentuannya yang mengikat dengan tidak melindungi orang dengan disabilitas psikososial dari pemaksaan, segregasi, dan pengabaian sistemik (Fernando, 2017; UN CRPD, 2019; González & Núñez, 2020). Keberlangsungan pemasungan dengan demikian menggambarkan bagaimana warisan tata kelola kejiwaan kolonial, yang awalnya digunakan untuk mengklasifikasikan dan menahan populasi yang dianggap tidak layak atau tidak manusiawi, terus beroperasi di bawah lapisan legalitas pascakolonial. Baik di Indonesia maupun dalam konteks Eropa seperti Spanyol atau Italia, kategori-kategori kolonial telah membentuk norma-norma medis, di mana kelompok-kelompok rasial, disabilitas, dan yang secara ekonomi tidak mampu secara ekonomi berada dalam zona abu-abu legal dan klinis di mana pemaksaan ditoleransi jika tidak disetujui oleh institusi (Amnesty International, 2020). Hal ini mencerminkan bentuk struktural genosida melalui pembiaran dan pengabaian, yang dilanggengkan oleh sistem yang mengkriminalisasi penyimpangan dari norma-norma yang dipaksakan sementara gagal menyediakan kondisi dasar untuk perkembangan berbasis hak. Seperti yang telah diargumentasikan dalam tesis ini, dinamika ini bukanlah penyimpangan, melainkan ekspresi dari tatanan biopolitik global yang secara rutin mengaburkan batas antara perawatan dan kontrol, dan trauma menjadi fitur sistemik daripada kegagalan.

Sementara pasung tetap menjadi salah satu bentuk perawatan paksaan yang paling terlihat secara global, padanan fungsionalnya tersebar luas di dalam sistem kesehatan jiwa Eropa, meskipun sering kali disamarkan dengan legitimasi klinis atau administratif. Praktik-praktik seperti pengekangan kimiawi, sedasi farmakologis non-konsensual, kurungan jangka panjang di fasilitas kejiwaan, atau penelantaran rumah tangga dengan kedok perawatan keluarga, secara rutin diterapkan pada individu dengan disabilitas psikososial di Spanyol, Italia, Swedia, dan lainnya. Bentuk-bentuk pemaksaan ini sering kali dinormalisasi oleh otoritas diagnostik, pengesahan yudisial, atau kebijaksanaan profesional, meskipun tidak sesuai dengan standar etika dan hukum yang ditetapkan oleh hukum hak asasi manusia internasional. CRPD, yang telah diratifikasi oleh semua negara anggota Uni Eropa, secara eksplisit melarang perampasan kebebasan berdasarkan disabilitas (Pasal 14), dan memandatkan akses ke layanan berbasis komunitas yang mendukung otonomi dan inklusi (Pasal 19). Standar QualityRights WHO melangkah lebih jauh dengan menyerukan penghapusan semua praktik pemaksaan, baik secara fisik, kimiawi, maupun psikologis, dan pembentukan perlindungan yang memprioritaskan persetujuan, martabat, dan pengalaman hidup.

Pasung, yang oleh sebagian orang disebut sebagai lobotomi kimiawi ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga, atau rumah sakit jiwa yang dipaksakan kepada orang yang sudah mati untuk disembelih, seperti yang disebut dalam jargon populer, masih banyak terjadi dan kurang dilaporkan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian lapangan dan survei, dengan berbagai sumber yang menunjukkan adanya masalah besar ini. Hal ini termasuk penggunaan polifarmasi yang tidak terbatas, suntikan depot yang dipaksakan, obat penenang yang tidak berlabel, dan penolakan terhadap pilihan tapering atau depresan, semuanya dibenarkan oleh penghindaran risiko, kepatuhan perilaku, atau kenyamanan institusional, sementara penyalahgunaan terus berlanjut. Individu yang keluar dari layanan psikiatri sering kali menemukan diri mereka terkurung dalam struktur keluarga yang mereproduksi dinamika institusional, pengawasan, keheningan, kontrol, tanpa pengawasan klinis atau jalur hukum. Hal ini mencerminkan model pelecehan yang didelegasikan yang menjadi inti dari pemasungan: negara menarik diri dari tanggung jawab aktif dan secara implisit mengesahkan

pemaksaan di tingkat privat. Di Spanyol dan negara-negara Uni Eropa lainnya, kegagalan untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif, advokasi independen, atau mekanisme pengaduan yang transparan mencerminkan kontradiksi sistemik: hak-hak hanya ada di atas kertas tapi tidak dalam praktiknya. Konsekuensinya adalah zona abu-abu hukum di mana para aktor psikiatri dan keluarga bersama-sama menegakkan pengucilan, di bawah retorika bantuan yang menutupi pengabaian struktural. Seperti yang dikatakan dalam disertasi ini, praktik-praktik ini bukanlah kebetulan, melainkan sudah dirancang ke dalam sistem, yang mencerminkan kesinambungan sejarah kekerasan dan keengganan kontemporer untuk menghadapi dasar-dasar epistemologis psikiatri koersif. Kegigihan perawatan paksaan dalam struktur keluarga tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai fungsi dari ketidaktahuan atau kelangkaan sumber daya. Hal ini harus diperiksa dalam logika budaya yang lebih luas yang mendasari dinamika interpersonal, ekspektasi normatif, dan ketidaktampakan yang dilembagakan dari bahaya intra-keluarga. Di berbagai konteks sosiokultural, termasuk Spanyol, Indonesia, Swedia, dan Italia, di mana penelitian lapangan disertasi ini berlabuh, cita-cita yang mengakar tentang kepatuhan berbakti, kedaulatan orang tua, dan otoritas moral hirarkis terus membentuk bagaimana kesusahan dirasakan, ditafsirkan, dan dikelola di dalam rumah. Rasa hormat kepada orang yang lebih tua, penekanan budaya pada disiplin, dan norma pengasuhan berdasarkan gender sering kali menjadi kerangka kerja yang melegitimasi praktik-praktik pemaksaan, terutama jika dibingkai sebagai perlindungan, demi kebaikan mereka, atau diperlukan untuk keluarga. Logika moral yang terinternalisasi secara mendalam dan jarang dipertanyakan dalam wacana institusional ini menghasilkan medan di mana anak-anak, orang tua, dan individu yang mengalami gangguan saraf atau trauma menjadi sasaran kontrol yang tidak diatur, pengabaian yang dinormalisasi, dan pelecehan yang tidak dilaporkan.

Masalahnya bukan terletak pada keberadaan otoritas, tetapi pada kekosongan pedagogis yang melingkupi penerapannya. Tanpa pendidikan publik yang berkelanjutan mengenai perkembangan saraf, trauma, etika relasional, dan komunikasi antar generasi, otoritas tidak digunakan sebagai penatalayanan tetapi sebagai kekuasaan, yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, atau hak-hak mereka yang menjadi sasaran. Bab 6 membahas bagaimana arsitektur budaya ini memetakan doktrin hukum yang menganggap keluarga sebagai unit kebajikan, dan bukannya unit yang berpotensi membahayakan (Noddings, 2005). Keengganan hukum untuk mengintervensi ranah privat, bahkan ketika dihadapkan pada indikator yang jelas tentang degradasi emosional atau paksaan yang terus-menerus, bukan hanya cerminan dari ambang batas prosedural, tetapi juga merupakan keputusan politis dan pedagogis tentang penderitaan siapa yang diperhitungkan, dan dalam kondisi seperti apa (Shonkoff & Garner, 2012). Tesis ini menegaskan bahwa asumsi-asumsi seperti itu harus diinterogasi dengan mempertimbangkan akumulasi bukti tentang dampak jangka panjang dari kerusakan keluarga yang halus dan kronis. Defisit pendidikan seputar perkembangan manusia, mulai dari fisiologi keterikatan dan perpecahan hingga modulasi lingkungan terhadap pengaturan diri, menciptakan kondisi di mana bahaya dilanggengkan tanpa disengaja, tetapi juga tanpa koreksi. Dinamika ini sangat merusak bagi anak-anak, yang kesusahannya sering kali dipatologiskan atau ditafsirkan sebagai penyimpangan, dan bagi orang tua, yang penurunan kognitif atau ketergantungannya menjadi sumber frustrasi bagi para pengasuh yang tidak mendapat dukungan. Data lapangan yang dikumpulkan dalam penelitian ini mengungkapkan bagaimana anggota keluarga

sering terombang-ambing antara kasih sayang dan keputusan, kontrol dan rasa bersalah, tanpa kerangka kerja untuk memahami apa yang sedang terjadi, atau bagaimana merespons secara berbeda. Dengan tidak adanya literasi struktural, bahkan pengasuh yang bermaksud baik pun dapat melakukan tindakan disipliner atau penindasan, sering kali meniru respons institusional yang telah mereka internalisasikan dari lingkungan medis atau pendidikan (Nakazawa, 2015).

Logika budaya tentang dugaan otoritas yang berbahaya dan tidak dapat ditantang, tidak kompeten dan kasar, bertemu dengan kekosongan kebijakan di mana tidak ada persyaratan institusional bagi keluarga untuk terlibat dalam pendidikan pengasuhan, atau bagi para profesional untuk mengevaluasi atau mendukung praktik-praktik pengasuhan dalam interaksi kesehatan jiwa yang rutin (Freire, 2000). Hasilnya adalah perpecahan: para profesional yang terlatih dalam bidang trauma dan regulasi bekerja dalam silo-silo institusional, sementara keluarga, yang menanggung sebagian besar pengasuhan sehari-hari, tidak memiliki perlengkapan, tidak terlatih, dan tidak didukung. Bab 6 mengidentifikasi kesenjangan ini sebagai kegagalan legislatif dan penegakan hukum: tidak ada standar pedagogis wajib untuk pengasuhan, atau kewajiban yang dapat ditegakkan untuk sistem kesehatan mental atau pendidikan untuk menyediakannya. Tesis ini tidak menentang nilai-nilai budaya yang saling ketergantungan, rasa hormat, atau tanggung jawab kekeluargaan. Sebaliknya, tesis ini berpendapat bahwa nilai-nilai ini harus ditempatkan dalam arsitektur pedagogis dan hukum yang mampu membedakan pengasuhan dari kontrol, otoritas dari paksaan, dan tradisi dari kekerasan (Goffman, 1961). Sifat alami manusia, meskipun secara biologis diberkahi dengan empati dan agresi, dibentuk secara pasti oleh perancah sosial dan pendidikannya. Budaya yang gagal mengajarkan regulasi fisiologis, transformasi konflik, atau mendengarkan antargenerasi akan mereproduksi bahaya yang dapat dihindari, bukan karena disengaja, tetapi karena pembiaran. Dalam konteks ini, diam bukanlah netralitas; itu adalah keterlibatan dengan struktur yang menempatkan beban terbesar pada mereka yang paling tidak mampu melawan.

Bagian ini mengedepankan pentingnya menanamkan program pendidikan yang lebih baik di seluruh jalur kehidupan, tidak hanya di sekolah-sekolah tetapi juga di pusat-pusat komunitas, pengadilan keluarga, lembaga keagamaan, dan sistem kesehatan (Noddings, 2005). Apa yang dibingkai sebagai tantangan budaya, pada praktiknya, adalah masalah pedagogi kolektif: siapa yang diajarkan apa, pada usia berapa, dengan sumber daya apa, dan untuk tujuan apa. Penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan dalam keluarga bukanlah hal yang tak terhindarkan secara budaya, melainkan dapat dicegah, ketika pengetahuan dipublikasikan, kekuasaan tunduk pada pengawasan, dan saling ketergantungan didefinisikan ulang bukan dengan hierarki tetapi dengan peraturan bersama, rasa hormat, dan tanggung jawab bersama.

Tabel 50. Kondisi untuk perawatan yang sesuai hukum dan berbasis hak: dari kepatuhan hingga tindakan etis

Domain	Persyaratan minimum yang sah menurut hukum	Praktik terbaik yang selaras dengan WHO/CRPD	Konsekuensi ketidakpatuhan dari
Persetujuan dan otonomi	Persetujuan atas dasar informasi untuk semua intervensi, dengan perlindungan hukum	Pengambilan keputusan yang didukung dengan dialog berbasis trauma	Hilangnya kepercayaan, tanggung jawab hukum, kemunduran fungsi
Hubungan terapeutik	Interaksi yang menghormati dan diprediksi	saling Keamanan relasional, dapat mendengarkan narasi, tujuan berbasis pemulihan	Pelepasan, kesalahan diagnosis, eskalasi risiko
Kebijakan institusional	Non-diskriminasi dan akses yang setara	Sistem pemantauan dengan umpan balik dari penyintas dan transparansi	Pengkhianatan kelembagaan, pemaksaan yang disamakan sebagai kepedulian
Pendidikan dan pelatihan	Kepatuhan terhadap standar etika dan hukum dasar	Pelatihan berkelanjutan tentang trauma, etika, dan neurobiologi kesusahan	Pengulangan bahaya, kelelahan, malpraktik sistemik
Penegakan hukum	Badan pengawas dan mekanisme pengaduan	Perlindungan proaktif, literasi hukum, dan akuntabilitas publik	Impunitas struktural, normalisasi pelecehan, bahaya antargenerasi

Tabel ini membandingkan standar minimum hukum dengan praktik-praktik terbaik internasional dalam perawatan kesehatan jiwa. Tabel ini menyoroti domain-domain utama, persetujuan, hubungan terapeutik, kebijakan institusional, pendidikan, dan penegakan hukum, di mana keselarasan dengan standar WHO dan CRPD sangat penting untuk perawatan yang etis dan efektif.

Konvergensi ilmu saraf perkembangan, penelitian trauma, dan epigenetik telah menghasilkan bukti yang kuat bahwa paparan kronis terhadap paksaan intra-keluarga, pengabaian, atau ketidakabsahan emosional menghasilkan perubahan biologis yang terukur dan tahan lama, baik di dalam individu maupun lintas generasi. Studi pada manusia dan model hewan menegaskan bahwa stresor lingkungan, terutama yang terjadi selama masa perkembangan yang sensitif, dapat memodifikasi ekspresi gen melalui metilasi DNA, modifikasi histon, dan perubahan yang terus-menerus pada sistem endokrin, imun, dan otonom. Modifikasi ini tidak bersifat simbolis: modifikasi ini membentuk kembali regulasi kortisol, memengaruhi konektivitas limbik, mengubah volume hipokampus, dan berkontribusi pada peningkatan beban alostatik. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan rumah tangga yang penuh tekanan kronis atau emosional yang tidak stabil sering kali menunjukkan pengaruh yang tidak teregulasi, gangguan fungsi eksekutif, gejala somatik yang meningkat, dan kerentanan jangka panjang terhadap penyakit kejiwaan dan fisik. Yang penting, efek-efek ini sering kali tidak bergantung pada kekerasan fisik; mekanismenya bersifat relasional, neuroendokrin, dan dimediasi secara sosial.

Terlepas dari ketepatan temuan ilmiah ini, kerangka hukum sebagian besar masih belum responsif terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat non-fisik. Undang-undang perlindungan sipil cenderung mendefinisikan pelecehan dalam istilah yang terlihat dan terukur, penyerangan fisik, penelantaran yang menyebabkan cedera, atau eksploitasi keuangan, sementara kerugian relasional dan psikologis tetap tidak tertangani atau tidak dapat dibuktikan dengan standar pembuktian yang ada. Pelecehan emosional, manipulasi, ketidakabsahan kronis, kontrol yang berlebihan, dan pengabaian otonomi, meskipun dikaitkan dengan penanda trauma jangka panjang, jarang sekali cukup untuk memicu intervensi hukum. Konsekuensinya adalah impunitas sistemik untuk dinamika yang berbahaya secara medis tetapi tidak terlihat secara yuridis. Bab 6 mendokumentasikan kebusuan

hukum ini sebagai pengkhianatan institusional: dengan menolak mengakui bentuk-bentuk bahaya yang divalidasi secara ilmiah dan secara klinis menghancurkan, hukum melepaskan fungsi perlindungannya di tempat di mana banyak orang yang paling rentan dan paling tidak berdaya untuk mencari ganti rugi.

Penelitian yang dipaparkan dalam disertasi ini mengungkapkan bagaimana kelalaian ini diperparah oleh keterlibatan sistem medis dalam kontrol keluarga (Llewellyn & Hogan, 2000). Alat-alat diagnostik dan penilaian profesional sering kali bergantung pada laporan pengasuh, dengan sedikit kapasitas atau mandat untuk mengidentifikasi dinamika pemaksaan di dalam keluarga itu sendiri. Otonomi menjadi kekejaman yang memekakkan telinga dari orang-orang di sekitar; pengambilan keputusan yang penuh kebencian, terlepas dari keinginan korban untuk hidup dalam damai dan ditinggalkan sendirian. Ini adalah kebutuhan, untuk mempertahankan realitas dengan kasus-kasus ini, jauh lebih umum daripada para penjahat dan orang-orang naif yang membiarkan yang lain percaya; memaksa untuk tetap percaya (Minkowitz, 2022). Akibatnya, individu, terutama anak-anak, penyandang disabilitas, atau orang tua, dapat disalahartikan sebagai orang yang tidak teratur atau tidak patuh ketika sebenarnya mereka bereaksi secara adaptif terhadap stres kronis atau lingkungan relasional yang tidak aman (Miller, 1981). Alih-alih mengenali respons-respons ini sebagai penanda cedera relasional, sistem mengklasifikasikannya kembali sebagai ciri-ciri patologis yang harus ditekan melalui pengobatan atau pelembagaan. Tesis ini mengungkap bagaimana distorsi epistemik ini mereproduksi siklus bahaya medis dan impunitas keluarga, mengukuhkan pemaksaan dengan kedok perawatan.

Konteks ilmiah ini menggoyahkan asumsi budaya dan hukum tentang bahaya, kapasitas, dan peran keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan rumah tangga tidak bersifat terapeutik secara intrinsik, dan bahwa paparan pengasuhan yang bersifat koersif atau tidak diatur secara emosional memiliki konsekuensi biologis dan psikososial yang sebanding dengan tingkat keparahannya dengan pelecehan institusional (Miller, 1981; McEwen, 2006). Implikasinya terhadap kebijakan publik dan sistem pengasuhan sangat besar. Jika hukum gagal memasukkan bukti-bukti tentang trauma relasional dan cedera epigenetik ke dalam definisi perlindungan dan kesalahan, hukum akan terus melindungi pelaku kekerasan, mendiskreditkan penyintas, dan menempatkan keluarga pada zona yang tidak jelas dalam kendali pemerintah (Grol & Grimshaw, 2003). Sebaliknya, jika pengetahuan ini dioperasionalkan, melalui pelatihan untuk para profesional hukum, protokol penilaian wajib, dan perluasan definisi kekerasan, maka hukum dapat berfungsi sebagai kekuatan korektif, bukan pemicu kekerasan diam-diam. Pertanyaan penelitian yang dibahas di sini bersifat normatif dan praktis: ambang batas bahaya apa yang harus memicu perlindungan hukum dalam konteks keluarga? Bagaimana integrasi ilmu trauma ke dalam yurisprudensi dapat meningkatkan hasil bagi mereka yang secara historis tidak terlihat? Apa risiko dari mengandalkan penanda tradisional kekerasan ketika ilmu pengetahuan menuntut pemahaman yang lebih bernuansa dan sistemik? Tesis ini menegaskan bahwa penggabungan penelitian trauma antargenerasi ke dalam protokol hukum dan klinis bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Hak atas kesehatan, sebagaimana diartikulasikan oleh WHO dan diabadikan dalam instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk hak atas lingkungan yang mendukung integritas saraf dan relasional (LeFrançois et al., 2013). Hal ini harus mencakup perlindungan dari pengaturan domestik yang bersifat memaksa yang menghasilkan kerugian

transgenerasi, bahkan ketika pengaturan tersebut tampak disetujui secara budaya atau dinormalisasi secara struktural.

Dengan mengedepankan penanaman biologis dari trauma keluarga, bagian ini menantang pemisahan antara bahaya privat dan publik, pengetahuan medis dan hukum, ilmu pengetahuan dan kebijakan (Shonkoff et al., 2012; Perry & Szalavitz, 2017). Apa yang diwariskan dalam situasi seperti itu bukan hanya budaya atau peran; ini adalah arsitektur fisiologis ketakutan, kewaspadaan berlebihan, dan ketidakberdayaan yang dipelajari, yang diwariskan bukan karena kehendak, tetapi karena cedera yang tidak terselesaikan. Sistem kesehatan masyarakat yang serius atau tatanan hukum berbasis hak harus merespons dengan tepat. Bukti ilmiah dan empiris yang disajikan dalam tesis ini menunjukkan bahwa normalisasi praktik-praktik pemaksaan dalam sistem keluarga bukan hanya konsekuensi dari pilihan individu atau norma-norma budaya, tetapi juga merupakan kegagalan struktural pendidikan. Ketika institusi lalai dalam mengajarkan prinsip-prinsip perkembangan sistem saraf, mekanisme trauma, dan kondisi untuk pengaturan bersama yang sehat, mereka menciptakan kerentanan generasi terhadap siklus kesalahpahaman, konflik, dan pelembagaan. Tidak adanya sumber daya pendidikan yang terstruktur dan dapat diakses oleh publik tentang kesehatan relasional berarti bahwa praktik pengasuhan terus bergantung pada intuisi, tradisi, atau otoritas, yang sering kali dibentuk oleh bahaya di masa lalu, daripada ilmu pengetahuan yang terinformasi. Mengatasi kekosongan pedagogis ini membutuhkan respons pendidikan multigenerasi yang didasarkan pada pengetahuan biologis, psikologis, dan sosial, dan dapat diakses secara universal melalui infrastruktur publik (McEwen, 2006; Kalathil, 2018; Llewellyn & Hogan, 2000).

Dari tahap awal pendidikan anak hingga perawatan lansia, setiap lapisan masyarakat harus dilengkapi dengan konten yang sesuai dengan usia mengenai fisiologi emosi, efek stres kronis, sinyal-sinyal kesusahan dan regulasi, serta dasar-dasar non-verbal dari kepercayaan dan keamanan. Ini bukanlah intervensi terapeutik yang diperuntukkan bagi lingkungan khusus, melainkan bentuk-bentuk dasar literasi kewarganegaraan, yang penting bagi pengembangan lingkungan sosial yang beretika, tangguh, dan kooperatif. Dalam hal ini, pendidikan publik harus mengambil sikap preventif, bukan reaktif: mengajar orang tua sebelum mereka kewalahan, mempersiapkan anak-anak sebelum trauma tertanam, dan membimbing para profesional sebelum bahaya menjadi hal yang biasa dalam rutinitas mereka. EU BEACON One Health Education siap membantu melanjutkan siklus perbaikan melalui misi ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan rezim pelatihan dan kurikulum bagi para ahli, guru, profesor, dan praktisi, serta para profesional dan mahasiswa.

Tesis ini menyelaraskan kebutuhan ini dengan strategi pendidikan kesehatan yang diuraikan dalam Bab 7 dan 8, yang menekankan integrasi pengetahuan biomedis, lingkungan, hukum, dan sosial ke dalam kurikulum publik yang koheren. Kesehatan mental seharusnya tidak disajikan sebagai ketiadaan krisis, tetapi sebagai fungsi dari kompetensi relasional, wawasan fisiologis, dan tanggung jawab bersama. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian di Bab 3 dan 4, individu yang terpapar trauma atau neurodivergensi sering kali mengembangkan strategi kompensasi yang disalahartikan sebagai pembangkangan, patologi, atau ketidakmampuan. Tanpa pendidikan publik yang mampu menerjemahkan sinyal-sinyal ini, keluarga dan institusi akan lebih memilih untuk mengontrol daripada menyelidiki. Mengajarkan masyarakat untuk memahami perilaku sebagai komunikasi, dan peraturan sebagai tugas bersama, dapat mematahkan pola-pola ini.

Pedagogi multigenerasi harus ditanamkan dalam berbagai jalur akses: kurikulum formal di sekolah, pelatihan profesional untuk pengasuh dan pendidik, kampanye kesehatan masyarakat di media massa, dan lokakarya yang dipimpin oleh teman sebaya di masyarakat. Model pendidikan ini harus mencakup seluruh tahapan perkembangan kehidupan manusia, termasuk keterikatan pada bayi, pembentukan identitas remaja, tekanan peran orang dewasa, dan perubahan kognitif-emosional akibat penuaan. Model pendidikan ini juga membutuhkan dukungan infrastruktur: platform multimedia yang dapat diakses secara terbuka, akses universal ke materi yang diterjemahkan, dan kemitraan antara kementerian pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk memastikan cakupan dan kesinambungan. Investasi-investasi ini bukan merupakan pelengkap dari reformasi kesehatan jiwa, melainkan merupakan prasyaratnya.

Temuan-temuan yang dilaporkan dalam disertasi ini menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki akses terhadap pendidikan perkembangan saraf yang minim sekalipun menunjukkan berkurangnya ketergantungan terhadap praktik-praktik pemaksaan dan meningkatnya kapasitas untuk melakukan respons tanpa kekerasan. Pendidikan semacam itu juga membekali individu untuk mengadvokasi diri mereka sendiri dan orang lain ketika sistem kelembagaan gagal. Secara khusus, inisiatif pendidikan yang dipimpin oleh penyintas, yang dirancang oleh mereka yang telah mengalami pemaksaan keluarga dan institusional, menawarkan model pedagogis yang didasarkan pada realitas yang dialami dan selaras dengan prinsip-prinsip CRPD tentang otonomi, persetujuan berdasarkan informasi, dan tata kelola partisipatif. Model-model ini sudah muncul dalam format akar rumput, tetapi masih kekurangan sumber daya dan terputus dari sistem formal pengakuan atau pendanaan. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang memandu bagian ini tidak hanya bersifat epistemik, tetapi juga bersifat infrastruktur: pengetahuan apa yang harus disediakan untuk memutus siklus pemaksaan dalam negeri? Platform dan sistem penyampaian apa yang paling sesuai untuk menyebarkan pengetahuan ini secara adil? Bagaimana pedagogi multigenerasi dapat mencegah penularan trauma dan membingkai ulang pengasuhan sebagai tanggung jawab yang berlandaskan informasi dan etika, bukan improvisasi yang putus asa? Tesis ini menjawab dengan mengusulkan bahwa reformasi pendidikan bukanlah tambahan dari intervensi hukum atau klinis, melainkan merupakan fondasi mereka. Tanpa membekali masyarakat untuk memahami dan merawat sistem saraf manusia secara real time dan dalam ruang bersama, tidak ada mandat hukum atau inovasi klinis yang dapat sepenuhnya mencegah bahaya.

Pendekatan pedagogis ini tidak menganggap bahwa pendidikan saja sudah cukup. Ketidaksetaraan struktural, ketidakpastian tempat tinggal, kontrol migrasi, dan akses layanan kesehatan tetap menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam dinamika keluarga. Namun, pendidikan berfungsi sebagai pelipatganda agensi: pendidikan menyediakan bahasa untuk mengatasi masalah, alat untuk perbaikan, dan alternatif untuk hukuman. Hal ini memungkinkan pengasuh untuk mengenali tidak hanya kebutuhan orang lain, tetapi juga batas-batas kemampuan mereka sendiri, menciptakan kerangka kerja di mana meminta bantuan menjadi hal yang normatif, bukan memalukan. Dengan cara ini, pendidikan menciptakan kondisi yang bermartabat sebelum krisis, dan untuk pertanggungjawaban tanpa kekerasan.

Toleransi sistematis terhadap pemaksaan dan penelantaran dalam lingkungan keluarga tidak hanya ditopang oleh norma-norma budaya atau kelalaian pendidikan, tetapi juga oleh ketidakjelasan hukum yang melindungi ranah domestik dari pengawasan eksternal. Hukum, seperti yang dianalisis dalam

Bab 6, beroperasi dengan arsitektur visibilitas dan perlindungan yang berjenjang: meskipun menawarkan mekanisme formal untuk intervensi dalam kasus-kasus pelecehan yang terang-terangan, hukum sering gagal untuk menanggapi kerugian yang lebih halus, kronis, dan relasional yang tidak memenuhi ambang batas sempit tindakan yuridis. Wilayah abu-abu hukum ini, yang tidak sepenuhnya bersifat privat atau diatur secara publik, menciptakan kekosongan struktural di mana dinamika keluarga yang bersifat koersif tidak dibantu atau diintervensi, dan para korban dibiarkan tanpa bantuan kecuali jika penderitaan mereka menjadi nyata secara permanen. Ambiguitas ini tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga mendasar, berakar pada posisi yuridis-budaya keluarga sebagai lembaga sakral, yang dianggap mewujudkan kepedulian dan legitimasi moral secara default. Secara historis, konstruksi keluarga sebagai unit moral yang memiliki hak istimewa telah berfungsi sebagai penstabil sekaligus selubung: melestarikan struktur masyarakat tertentu sekaligus menyembunyikan bentuk-bentuk dominasi, pengawasan, dan kekerasan yang sering terjadi di dalamnya. Naturalisasi keluarga inti, dan lebih luas lagi, tanggung jawab berbasis kekerabatan, telah menjadi landasan filosofi moral, tata kelola politik, dan kontrol ekonomi sejak kodifikasi awal hukum Barat. Namun, analisis antropologis dan historis mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk keluarga secara budaya bervariasi, dan fungsinya sering kali lebih melayani kepentingan transmisi properti, kontrol tenaga kerja berdasarkan gender, dan konformitas sosial daripada pengasuhan yang sebenarnya. Penghormatan hukum terhadap otoritas keluarga, bahkan dalam menghadapi bukti ilmiah tentang potensi bahayanya, mencerminkan keengganan untuk menantang fondasi simbolis tatanan sosial. Lebih mudah untuk mengatur orang asing daripada mengatur orang yang dianggap mencintai kita (Grol & Grimshaw, 2003).

Disertasi ini berargumen, dengan dukungan temuan dan literatur, bahwa keengganan hukum ini tidak dapat bertahan di hadapan bukti. Ilmu saraf, teori trauma, dan ilmu perkembangan memberikan penjelasan yang semakin kuat tentang bagaimana bahaya relasional, terutama ketika dinormalisasi dan diulang dari waktu ke waktu, menyebabkan degradasi potensi manusia yang dapat diukur. Topik-topik transversal lainnya, seperti satu kesehatan, gender dan kesetaraan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan, harus dimasukkan dalam semua kurikulum, termasuk kurikulum praktisi medis, yang memiliki pengetahuan tentang dampak determinan sosial dan dampak struktur seperti sistem keluarga. Kegagalan untuk membuat undang-undang perlindungan terhadap bentuk-bentuk pemaksaan non-fisik tetapi memiliki konsekuensi biologis merupakan kegagalan untuk memenuhi kewajiban internasional untuk melindungi hak atas kesehatan, martabat, dan integritas tubuh. Konsep informed consent seharusnya diperluas melampaui tindakan medis dan masuk ke dalam ruang domestik: anak-anak, orang tua, dan orang yang bergantung pada orang lain seharusnya diberikan perlindungan tidak hanya dari kekerasan yang terang-terangan tetapi juga dari penyangkalan rutin terhadap hak untuk memilih, menyesuaikan diri, dan rasa hormat.

Hal ini mempertanyakan legitimasi yang lebih luas dari sistem sosial yang mengklaim melindungi sambil mempertahankan struktur yang merugikan. Pada masa ketidakstabilan sistemik atau keruntuhan kelembagaan, baik melalui penghematan ekonomi, pandemi, atau fragmentasi politik, keluarga sering disebut sebagai tempat kohesi dan dukungan terakhir yang tersisa (Cianconi et al., 2020). Namun, seruan ini mengaburkan kenyataan bahwa keluarga sering kali tidak stabil, terfragmentasi, dan tunduk pada kekuatan pengabaian dan pemaksaan yang sama seperti institusi

lainnya. Memperlakukan keluarga sebagai tempat kembali moral, alih-alih sebagai struktur relasional yang bergantung pada pendidikan, dukungan, dan kesetaraan, memastikan bahwa siklus bahaya tetap tidak tertandingi. Keruntuhan ini tidak hanya bersifat infrastruktur, tetapi juga konseptual: jika keluarga diharapkan untuk peduli tanpa diajari bagaimana cara peduli, atau tanpa peduli pada diri mereka sendiri, sistem akan mereplikasi penderitaan tanpa batas waktu. Pendefinisian ulang keluarga harus dimulai dengan meninggalkan mitos keistimewaannya. Keluarga harus dipahami bukan sebagai unit pra-politik atau alamiah, tetapi sebagai salah satu institusi sosial yang tunduk pada peraturan, bertanggung jawab pada bukti, dan terbuka untuk direvisi. Tesis ini mengusulkan bahwa masyarakat yang adil tidak melindungi keluarga dari pengawasan, tetapi melindungi individu-individu di dalam keluarga dari pengabaian. Reformasi hukum harus menetapkan kewajiban positif bagi institusi untuk mendukung hubungan pengasuhan, memantau intervensi berbasis keluarga, dan mendidik setiap anggota masyarakat dalam hal perkembangan saraf dan dasar-dasar etika pengasuhan tanpa paksaan. Dengan demikian, hal ini menegaskan martabat setiap manusia lebih dari sekadar produk garis keturunan atau warisan: sebagai subjek yang memiliki hak, yang mampu menderita, tumbuh, dan berkembang, terlepas dari peran mereka dalam rumah tangga.

Bagian ini menutup lingkaran antara realitas empiris, ideologi budaya, dan kerangka kerja hukum. Bagian ini menegaskan bahwa tidak ada reformasi sistem kesehatan jiwa yang bersifat koersif yang akan selesai sampai ruang privat keluarga ditangani dengan ketelitian dan tanggung jawab yang sama dengan klinik, sekolah, atau ruang pengadilan. Dua bagian berikutnya memperluas diskusi ini ke arsitektur evolusioner, psikologis, dan moral keintiman manusia, menunjukkan bagaimana kesetiaan, keamanan relasional, dan kejujuran bukanlah artefak budaya tetapi keharusan yang didasarkan secara biologis, yang berulang kali dilanggar dalam kondisi pengkhianatan struktural dan keruntuhan pedagogis.

Untuk memahami implikasi penuh dari pemaksaan keluarga dalam arsitektur kekerasan sistemik yang lebih luas, kita harus kembali ke akar-akar tatanan politik dan hukum, di mana hukum, jauh dari melindungi mereka yang rentan, secara historis merupakan instrumen untuk mengorganisir dan membenarkan kekerasan. Tesis yang dikemukakan di sini menyatakan bahwa pemaksaan dalam keluarga bukanlah sebuah penyimpangan, dan juga bukan kegagalan moralitas individu. Hal ini merupakan manifestasi dari struktur yang jauh lebih tua dan lebih dalam di mana kapasitas untuk mendominasi, menundukkan, dan membungkam telah dikodekan ke dalam institusi-institusi, termasuk keluarga, melalui abstraksi hukum dan pengudusan budaya. Seperti yang telah diulas pada Bab 6, silsilah hukum modern tidak dapat dipisahkan dari otoritas patriarki, penegakan teritorial, dan pendelegasian kekerasan kepada kepala rumah tangga, pertama sebagai penguasa alamiah, kemudian sebagai pelayan hukum. Hal ini masih terlihat jelas di yurisdiksi di mana orang tua dapat menyetujui pengurangan psikiatri anak-anak tanpa masukan dari mereka, atau di mana orang tua dapat diisolasi dengan kedok perwalian, dan di mana praktik-praktik ini tidak dapat dilihat dengan bahasa administratif dan terapeutik. Fungsi politis dari pengaturan semacam itu tidaklah netral. Ketika pengasuhan tidak dapat dibedakan dengan kontrol, dan kerentanan menjadi alasan untuk menghapus otonomi, hukum tidak lagi menjadi kekuatan pelindung dan menjadi mekanisme penindasan. Hal ini tidak hanya metaforis: data dan kesaksian yang dikumpulkan dalam tesis ini mengungkapkan bagaimana kebisuhan hukum memungkinkan kekejaman pribadi dan bagaimana kebijakan

institusional mempertahankan kebisuan tersebut di bawah panji-panji kebutuhan. Apa yang tampak sebagai disfungsi keluarga sering kali merupakan ekspresi paling dekat dari sebuah sistem di mana pemaksaan adalah respons standar terhadap kompleksitas, penyimpangan, atau tekanan. Pada titik inilah, di mana hukum, budaya, dan praktik medis bertemu, logika dominasi yang brutal dibalut dengan bahasa tugas, perawatan, atau keahlian.

Kenyataan ini bukanlah hal yang baru. Sistem perkawinan paksa, pekerja anak, pengurungan dalam rumah tangga, dan pemaksaan reproduksi dalam sejarahnya, semuanya disetujui secara hukum, dan sering kali dibingkai sebagai tugas alamiah. Semua itu bukanlah penyimpangan dari tatanan yang adil, melainkan logika operasinya. Kegigihan logika-logika ini dalam hukum kejiwaan, pendidikan, dan keluarga kontemporer mengungkapkan daya tahan dominasi di balik permukaan yang reformis. Bahkan saat ini, perlindungan hukum terhadap pemaksaan adalah yang paling lemah di mana kompleksitas relasional paling tinggi, di dalam keluarga, di mana pengawasan negara ragu-ragu, dan di dalam sistem perawatan, di mana penyimpangan disalahartikan sebagai bahaya. Inisiatif WHO QualityRights, yang dirujuk di seluruh tesis ini dan menjadi inti dari Bab 7, menawarkan sebuah tandingan yang substantif terhadap struktur yang diwariskan ini. Paradigmanya bersifat relasional, bukan disiplin. Inisiatif ini memusatkan hak-hak bukan sebagai tanda prosedural tetapi sebagai realitas yang dihayati, dirasakan, dan diciptakan bersama. Ini membingkai ulang perawatan sebagai penciptaan lingkungan yang memungkinkan, hukum, sosial, psikologis, di mana setiap individu tidak diatur tetapi didampingi, tidak dibungkam tetapi didengar. QualityRights menolak penggantian penilaian dengan dialog, dan penggantian persetujuan dengan kepatuhan. Ini bukan hanya sebuah standar, ini adalah antitesis relasional terhadap seluruh sejarah perawatan sebagai kontrol. Sifat manusia, seperti yang dibahas di sini dari perspektif biokultural dan evolusioner, tidak dapat direduksi menjadi agresi atau dominasi. Spesies kita bertahan hidup bukan karena kekuatan semata, melainkan karena kerja sama, komunikasi, dan timbal balik. Dalam kondisi terbaiknya, kita adalah makhluk yang penuh janji, saling mengakui, dan memiliki kesetiaan hubungan. Ini bukanlah hal yang naif atau retorik. Struktur neurofisiologis dari keterikatan, regulasi pengaruh, dan kepekaan etis adalah nyata, dan struktur-struktur tersebut rusak dalam kondisi pemaksaan dan pengkhianatan yang terus-menerus. Ketika hukum sejalan dengan dominasi, ketika pendidikan menghilangkan kebenaran emosional, dan ketika kepedulian menjadi dalih untuk membungkam, struktur-struktur ini terluka, mereproduksi siklus kekerasan relasional yang meluas dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hal ini harus diulangi, karena tingkat keparahannya: penggunaan kekerasan, termasuk di dalam keluarga, tidak dapat diperlakukan sebagai kebutuhan residual atau pengecualian yang disesalkan. Hal ini harus dinamai, diekspos, dan dibongkar melalui transformasi pedagogis, reformasi hukum, dan perhitungan budaya. Sistem yang terus mengandalkan pemaksaan sebagai kebijakan tidaklah netral, melainkan sebuah kemunduran, yang secara struktural berlawanan dengan kemungkinan kesehatan mental seperti yang didefinisikan oleh WHO: kemampuan untuk mengatasi, berpartisipasi, dan mewujudkan potensi diri dalam martabat dan komunitas. Bagian terakhir ini merupakan kesinambungan penuh dengan analisis hukum pada Bab 6 dan kerangka epistemik pada Bab 1. Bagian ini tidak mengusulkan koeksistensi antara perawatan dan pemaksaan, tetapi ketidaksesuaian antara keduanya. Tidak ada sintesis antara hak atas otonomi dan penolakan rutin terhadap hak tersebut.

Konvergensi ilmu kedokteran, penelitian perkembangan saraf, kebijakan kesehatan masyarakat, dan hukum hak asasi manusia internasional tidak menyisakan pembenaran teoretis atau empiris untuk netralitas dalam menghadapi perawatan paksaan. Masih adanya pemaksaan dalam struktur keluarga, sistem medis, dan rezim hukum bukanlah masalah interpretasi budaya atau perselisihan profesional, melainkan kontradiksi pengetahuan ilmiah yang sudah mapan dan standar normatif yang mengikat. Bukti terkini dari neurobiologi, fisiologi trauma, dan psikologi perkembangan menegaskan bahwa keamanan relasional yang berkelanjutan, prediktabilitas, dan lingkungan yang mendukung otonomi sangat penting untuk pematangan regulasi afek, kognisi sosial, dan kesejahteraan jangka panjang. Sebaliknya, ancaman yang tidak dapat diprediksi, pengkhianatan relasional, dan pengalaman ketidakberdayaan secara konsisten dikaitkan dengan disregulasi, gangguan fungsional, dan cedera struktural pada otak dan sistem kekebalan tubuh. Ini bukanlah bahaya metaforis, atau risiko abstrak, melainkan hasil terukur yang didokumentasikan di seluruh populasi, usia, dan pengaturan kelembagaan.

Implikasi etis dari temuan ini tidak bersifat diskresioner. Seperti halnya domain ilmu biomedis lainnya, ketika hubungan sebab-akibat telah ditetapkan dan profil risiko-manfaat telah jelas, maka diperlukan tindakan, bukan atas nama ideologi, tetapi atas dasar keharusan integritas profesional dan tugas publik. Ketika pengetahuan ilmiah menegaskan bahwa lingkungan dan praktik tertentu menghasilkan bahaya, sistem yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan perawatan dan perlindungan harus menyesuaikan diri. Dalam konteks ini, kerangka hukum tidak dapat terus berada di antara hak-hak nominal dan ambivalensi operasional. Hukum harus memikul beban penegakan, penafsiran, dan perbaikan. Hukum harus berhenti beroperasi sebagai penengah pasif dan mengakui bahwa netralitas di hadapan kerusakan sistemik merupakan partisipasi aktif dalam kerusakan tersebut. Ini bukan masalah sikap politik, ini adalah tuntutan yang didasarkan pada bukti forensik, epidemiologi, dan hak asasi manusia. Demikian pula, institusi pendidikan, baik umum, klinis, atau yudisial, harus menginternalisasi dan menyebarkan pengetahuan ini sebagai dasar. Protokol pengajaran, standar kurikulum, dan etika profesional tidak dapat disejajarkan dengan sistem yang mereproduksi pemaksaan dengan kedok perawatan. Pendidikan, dalam hal ini, bukanlah proses yang netral nilai. Pendidikan merupakan mekanisme sosialisasi, vektor transmisi epistemik, dan kekuatan yang mengkonsolidasikan atau membongkar struktur kekerasan. Oleh karena itu, pelatihan para profesional kesehatan, pengasuh, pendidik, dan aktor hukum harus diorientasikan kembali ke arah etika yang diwujudkan, kompetensi relasional, dan wawasan fisiologis. Reorientasi semacam itu bukanlah idealisme. Ini adalah realisme klinis, kecukupan hukum, dan ketepatan pedagogis. Sistem perawatan, pada gilirannya, harus dibangun bukan di sekitar kontrol dan penenang, tetapi di sekitar pengembangan kapasitas dan pendampingan. Mandat klinis tidak hanya untuk mengurangi gejala tetapi untuk memulihkan kondisi di mana individu dapat mengatur, terhubung, dan berkembang.

Ini adalah definisi kesehatan yang tertua sekaligus paling maju: bukan ketiadaan patologi, tetapi kehadiran agensi, kesinambungan hubungan, dan fungsi fisiologis yang penuh. Ketika sistem perawatan bertindak sebaliknya, ketika mereka mengabaikan persetujuan, menekan ekspresi, atau memecah martabat, mereka bertentangan dengan tujuan pengobatan dan inti etika dari profesi yang menjunjungnya. Kontradiksi tersebut tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dipertahankan secara ilmiah.

Posisi yang dipertahankan dalam tesis ini bukanlah retorika, bukan pula pertentangan. Ini adalah konsekuensi logis dari penelitian ilmiah, yurisprudensi, dan kesaksian pengalaman selama beberapa dekade yang menyatu. Hal ini menegaskan bahwa waktu untuk ambivalensi konseptual telah berakhir. Struktur pengetahuan sudah matang. Bukti-bukti sudah konklusif. Tidak ada netralitas ilmiah dalam menghadapi kejahatan yang terorganisir. Oleh karena itu, hukum seharusnya berpihak, bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi. Pendidikan seharusnya berpihak, bukan untuk mengindoktrinasi, tetapi untuk mengklarifikasi. Perawatan harus berpihak, bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk menyembuhkan. Ini bukanlah tindakan ideologi. Ini adalah ekspresi tanggung jawab minimum dalam sistem etika apa pun yang mengklaim melindungi kehidupan, mendukung kesehatan, atau menjunjung tinggi martabat. Dalam masyarakat yang dewasa, tanggung jawab tersebut bukanlah masalah opini. Ini adalah masalah standar. Dan ketika standar tersebut secara sadar tidak terpenuhi, ilmu pengetahuan tidak lagi membela penundaan. Hal ini membutuhkan reformasi (Grol & Grimshaw, 2003).

Tabel 51. Efek neurobiologis dan perkembangan dari pengabaian klinis dan institusional

Dimensi	Deskripsi	Konsekuensi	Konsekuensi Biologis dan Morfologis
Definisi	Kegagalan terus-menerus untuk memberikan perawatan fisik, emosional, atau psikologis	Perampasan relasional; bentuk bahaya yang aktif, bukan kelalaian pasif	Perubahan pematangan otak, berkurangnya daya tahan tubuh dan ketahanan endokrin, penipisan kortikal di daerah prefrontal
Aktivasi neurobiologis	Memicu jalur neuroendokrin dan inflamasi yang berhubungan dengan stres	Hambatan perkembangan, gangguan plastisitas, kepekaan terhadap stres	Peningkatan kortisol, peradangan kronis, berkurangnya konektivitas di seluruh wilayah otak utama, atrofi hipokampus
Defisit pengasuhan dini	Ketidakpastian, ketidakterediaan emosi, kekurangan sensorik atau kognitif pada masa bayi atau masa kanak-kanak	Gangguan perkembangan saraf dan regulasi afektif	Gangguan pematangan dan mielinisasi sinaptik, penurunan volume materi abu-abu, pengurangan korteks cingulate anterior
Pengabaian dalam pengaturan perawatan	Pengabaian emosional, pemberian obat yang berlebihan, depersonalisasi dalam lingkungan institusional atau klinis	Trauma ulang, kemunduran psikologis, ketidakberdayaan yang dipelajari	Respons oksitosin yang tumpul, pemendekan telomer, pengurangan volume kortikal di sirkuit sosial-afektif
Dampak fungsi eksekutif	Merusak regulasi emosi, perencanaan, dan pengendalian diri	Kontrol impuls yang buruk, volatilitas emosional, gangguan otonomi	Hipoaktivasi korteks prefrontal, berkurangnya ketebalan orbitofrontal, gangguan integritas materi putih
Disregulasi aksis Hpa	Tidak adanya isyarat keamanan, penyesuaian emosional, dan prediktabilitas yang kronis	Gairah stres yang terus-menerus, koping yang maladaptif, keterikatan yang terganggu	Hiperaktivasi aksis HPA, kemiringan kortisol diurnal yang rata, peningkatan volume amigdala, perubahan metabolik

Tabel ini menguraikan bagaimana pengabaian, baik dalam keluarga, masa kanak-kanak, atau pengaturan perawatan orang dewasa institusional, bertindak sebagai pengganggu biologis dan psikososial yang aktif, dengan efek yang

berkelanjutan pada arsitektur otak, regulasi stres, dan lintasan perkembangan. Penomoran mengikuti logika mengejutkan dari kenyataan yang diharapkan tidak masuk akal, merugikan kita semua, dengan penuh keagungan.

Pengabaian, yang secara klinis didefinisikan sebagai kegagalan terus-menerus dalam memberikan perawatan fisik, emosional, atau psikologis yang diperlukan, merupakan bentuk perampasan hubungan dengan efek yang nyata pada arsitektur otak dan kesehatan sistemik. Jauh dari sekadar kelalaian pasif, pengabaian mengaktifkan kaskade neurobiologis spesifik yang terkait dengan penghentian perkembangan, kepekaan terhadap stres, dan gangguan plastisitas. Pada awal kehidupan, pengasuhan yang tidak memadai, yang ditandai dengan ketidakpastian, ketidaktersediaan afektif, atau kekurangan sensorik, mengganggu pematangan sinapsis, mielinisasi, dan integrasi sirkuit limbik dan kortikal yang bertanggung jawab atas fungsi eksekutif dan regulasi emosional. Ketidadaan keterlibatan terstruktur dan isyarat keselamatan yang berkepanjangan merusak pembentukan garis dasar homeostatis, yang mengarah pada aktivasi kronis dari sumbu hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA). Seiring waktu, disregulasi ini meningkatkan beban alostatik, meningkatkan kadar glukokortikoid, dan mengganggu pensinyalan trofik di hipokampus, korteks prefrontal, dan cingulate anterior. Konsekuensinya termasuk neurogenesis yang dilemahkan, retraksi dendritik, dan berkurangnya ketebalan kortikal, yang dapat diukur melalui studi pencitraan dan berkorelasi dengan disfungsi kognitif, emosional, dan sosial.

Proses yang sama ini tidak terbatas pada jendela perkembangan (Huttenlocher & Dabholkar, 1997; Farah et al., 2012; Afroz et al., 2016). Dalam kondisi kesulitan relasional yang berkelanjutan, termasuk pengabaian institusional, paksaan, atau kekerasan di tingkat masyarakat, orang dewasa juga menunjukkan pola penipisan kortikal, pemutusan fungsional, dan gangguan integrasi neuroimun. Dalam konteks di mana individu secara sistematis kehilangan keamanan relasional, otonomi, atau keterlibatan yang berarti, sistem prediktif otak beradaptasi dengan mengesampingkan integrasi plastis dan hanya mempertahankan sirkuit yang responsif terhadap ancaman. Proses autophagic, yang biasanya penting untuk pemeliharaan dan perbaikan saraf, menjadi tidak teratur dalam kondisi kronis ini, yang berkontribusi pada degradasi sel dan hilangnya sinapsis. Pada paparan yang ekstrem atau berkepanjangan, apoptosis dimulai di daerah yang penting untuk pemrosesan reflektif, kepercayaan interpersonal, dan fleksibilitas regulasi, mekanisme yang didokumentasikan dengan baik dalam studi tingkat individu dan populasi (Huttenlocher, 1979; Campisi & d'Adda Di Fagagna, 2007). Hasil ini tidak terisolasi pada patologi klinis; mereka mewakili logika biologis pencabutan dan penghentian di bawah kesulitan yang tidak dapat diselesaikan (Singer & Baer, 2007). Ketika kondisi seperti itu direplikasi di seluruh sistem, sekolah, keluarga, klinik, kerangka kerja hukum, mereka menghasilkan pola kolektif keruntuhan kognitif dan relasional (Miller & Moore, 2007). Kerugiannya bukan hanya pada individu tapi juga masyarakat: penurunan kapasitas bersama untuk kompleksitas, kerja sama, dan orientasi etika. Pola-pola ini, setelah terbentuk, mempertahankan diri mereka sendiri bukan melalui kebencian tetapi melalui adaptasi neurobiologis terhadap ketidakjelasan dan ketakutan (Panksepp, 1998; Casey, Jones, & Hare, 2008; Joyce, 2015; Brady & Segool, 2019). Pembalikan degradasi tersebut tidak hanya menuntut penghentian kekerasan terbuka, tetapi juga rekonstruksi lingkungan di mana prediktabilitas, pengakuan timbal balik, dan kepedulian timbal balik dijamin secara struktural (Blakemore, 2007; Farah et al., 2012).

5.4 Kerugian medis dan defisit pendidikan: sistem yang mengobati, bukan mengajar atau menyembuhkan

Paradigma farmakosentris yang berlaku dalam psikiatri dan kedokteran umum terus berjalan secara kontradiktif dengan prinsip-prinsip yang sudah ada tentang kesehatan preventif dan perawatan presisi. Meskipun ada konsensus internasional yang semakin meningkat mengenai model kesehatan mental yang bersifat individual, berbasis trauma, dan berorientasi pada pemulihan, bukti empiris menunjukkan adanya ketergantungan yang terus-menerus pada obat-obatan psikotropika, terutama antidepresan, antipsikotik, dan ansiolitik, di seluruh populasi yang tidak menunjukkan indikator yang jelas mengenai ketidakseimbangan biokimiawi atau gejala yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan. Fenomena overprescription ini terutama terjadi pada individu yang telah menunjukkan perilaku yang mendukung kesehatan, termasuk kebersihan tidur yang cukup, keseimbangan nutrisi, aktivitas fisik, dan integrasi sosial. Temuan tersebut tidak terisolasi tetapi secara konsisten diamati di seluruh kohort pengamatan, kumpulan data klaim asuransi, dan studi audit dari berbagai sistem kesehatan. Pola-pola ini diperkuat di antara perempuan, dewasa muda, dan individu yang mengalami kesedihan, tekanan interpersonal, atau ketidakpastian sosio-ekonomi, kategori pengalaman yang sering kali dipatologikan tanpa eksplorasi yang memadai terhadap konteks sosial atau dasar fisiologis. Tren ini mencerminkan kegagalan multi-tingkat: di tingkat diagnostik, melalui sistem kategorikal yang memungkinkan kelonggaran interpretasi yang luas (misalnya, kriteria DSM atau ICD yang diterapkan tanpa pemeriksaan dimensi); di tingkat profesional, melalui pelatihan yang tidak memadai dalam neurofisiologi, regulasi sistem stres, atau neuroplastisitas; dan di tingkat institusional, melalui struktur insentif yang memberi imbalan pada hasil farmakologis daripada keterlibatan edukasi atau metrik pemulihan jangka panjang. Misalnya, dalam konteks perawatan primer, dokter umum, yang meresepkan sebagian besar obat psikiatri, sering kali melaporkan kurangnya waktu, pelatihan, atau pilihan rujukan untuk mengeksplorasi disregulasi somatik, beban stres, atau integritas siklus tidur sebelum memulai pengobatan. Demikian juga, eskalasi yang cepat dari tekanan emosional yang dilaporkan pasien ke intervensi farmakologis menghilangkan langkah perantara psikoedukasi, penilaian nutrisi atau endokrinologi, dan analisis fungsional ritme harian. Secara fisiologis, banyak individu yang menerima farmakoterapi tidak memenuhi kriteria untuk disregulasi kronis sistem neurotransmitter ketika menjalani penilaian biokimia atau perilaku yang ketat. Sebaliknya, mereka menunjukkan tanda-tanda stres adaptif, respons kesedihan, atau kewalahan psikososial, yang semuanya dapat diatasi dengan intervensi non-invasif dan berbasis pendidikan. Namun, karena kurangnya protokol yang dilembagakan untuk mengevaluasi dan mendukung ketahanan neurobiologis, misalnya, profil metabolik, pengukuran tonus vagal, analisis kemiringan kortisol, dokter beroperasi tanpa masukan yang diperlukan untuk membedakan antara respons adaptif sementara dan kondisi patologis. Hasilnya adalah penerapan protokol yang mengutamakan obat secara luas bukan untuk kepentingan stabilisasi, melainkan sebagai alat kontrol perilaku dan kepatuhan administratif, yang sering kali dilembagakan melalui formularium, algoritme pengobatan, atau norma tidak tertulis dalam layanan kesehatan. Selain itu, banyak dari protokol ini diterapkan tanpa kerangka kerja yang terikat waktu atau rencana penghentian yang terstruktur. Tidak adanya

jadwal tapering, pemantauan fisiologis, atau pos pemeriksaan evaluasi ulang menyebabkan ketergantungan farmakologis jangka panjang, fisiologis, psikologis, dan institusional.

Pasien dapat terjebak dalam siklus bahaya iatrogenik dan peningkatan penggunaan layanan, bukan karena kondisi awal mereka yang alami, tetapi karena sifat intervensi tersebut. Lingkaran umpan balik klinis, termasuk hasil yang dilaporkan pasien dan pelacakan efek samping, tidak ada atau tidak berfungsi di sebagian besar sistem kesehatan, terutama di infrastruktur yang kekurangan dana atau terfragmentasi secara digital. Kurangnya mandat pelaporan nasional atau regional untuk penggunaan off-label, polifarmasi, atau gejala sisa penarikan membuat beban kumulatif bahaya medis yang disebabkan oleh peresepan rutin yang tidak dapat dibenarkan menjadi tidak terlihat. Terlepas dari kemajuan substansial dalam ilmu saraf tentang regulasi pengaruh, neuroplastisitas, dan sumbu usus-otak, domain-domain ini tetap menjadi bagian dari sebagian besar praktik klinis, terutama dalam pengaturan psikiatri (Haslam, 2024). Penerapan klinis dari temuan ini membutuhkan terjemahan ke dalam pelatihan yang dapat diakses dan terakreditasi, namun pendidikan kedokteran masih secara tidak proporsional memprioritaskan farmakologi reseptor daripada pendekatan berbasis sistem. Sementara itu, sebagian dari populasi terus menunjukkan penerimaan terhadap pendidikan somatik, perawatan diri preventif, dan strategi integrasi pikiran-tubuh ketika tersedia, menggarisbawahi keterputusan yang mendalam antara praktik kelembagaan saat ini dan ilmu pengetahuan empiris dan permintaan publik. Ketidaksinambungan ini bukan masalah defisit pengetahuan, melainkan produk dari kelembaman institusional, kekakuan profesional, dan otoritas abadi dari paradigma reduksionis yang menempatkan tekanan mental terutama di dalam otak kimiawi, terlepas dari orang, konteks, atau matriks masyarakat.

Pemberian psikotropika yang terus berlanjut kepada individu yang mempraktikkan perilaku yang meningkatkan kesehatan bukanlah sebuah anomali, melainkan sebuah fitur struktural dari sebuah model yang dibangun untuk mematomologiskan penyimpangan dari produktivitas, ekspresi emosional, atau keraguan eksistensial. Kegagalan untuk mengintegrasikan fisiologi stres, trauma, dan adaptasi ke dalam protokol perawatan rutin mencerminkan kegagalan pendidikan, yang dilanggengkan oleh kurikulum yang tidak mengamankan pemahaman komprehensif tentang sistem saraf di luar fragmen yang berfokus pada patologi. Tanpa reformasi pendidikan yang memusatkan literasi kesehatan, integritas fisiologis, dan model biopsikososial dalam kompleksitas penuhnya, sistem medis akan terus mengobati bukan tubuh yang membutuhkan, tetapi orang yang gagal menyesuaikan diri dengan ekspektasi institusi. Tesis ini menyatakan bahwa pola-pola tersebut tidak hanya merupakan kesalahan penilaian klinis tetapi juga kekerasan epistemik struktural, yang diberlakukan melalui pengabaian standar ilmiah dan ketiadaan persetujuan partisipatif yang terinformasi. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk menggambarkan secara empiris bagaimana sistem-sistem ini gagal memenuhi bahkan prinsip-prinsip yang paling mendasar dari definisi WHO sendiri: bahwa kesehatan bukan hanya ketiadaan penyakit, tetapi suatu kondisi fisik, mental, dan sosial yang lengkap, dan bahwa kesehatan mental mencakup realisasi potensi seseorang, kemampuan untuk mengatasi, dan kontribusinya terhadap masyarakat. Definisi-definisi ini seharusnya menjadi tolok ukur, bukan pengecualian, untuk mengevaluasi semua protokol diagnostik, edukasi, dan terapi. Kegagalan sistematis dalam memenuhi standar-standar ini bukanlah hasil yang tidak menguntungkan, melainkan

konsekuensi yang dapat diprediksi dari model yang memprioritaskan kepatuhan daripada pemahaman, farmakologi daripada pedagogi, dan kontrol daripada perawatan.

Di seluruh sistem pendidikan medis, psikologis, dan pendidikan publik, ada ketidakhadiran yang mencolok dari pengajaran yang terstruktur dan berkembang tentang sistem saraf manusia, fisiologi stres, dan prinsip-prinsip neuroplastisitas. Ketiadaan ini bukanlah kebetulan atau tidak disengaja, ini adalah kelalaian sistematis yang melanggengkan model defisit kesehatan mental, di mana individu diajari untuk mematuhi protokol manajemen gejala daripada mengembangkan strategi yang terinformasi dan diwujudkan untuk ketahanan, regulasi, dan pemulihan adaptif. Meskipun semakin banyak bukti neurosains yang menghubungkan paparan stres, tidur, trauma, inflamasi, dan konteks sosial dengan disregulasi saraf dan endokrin, konten semacam itu masih menjadi bagian perifer dalam kurikulum sekolah kedokteran dan pendidikan kesehatan berbasis sekolah. Siswa jarang diperkenalkan dengan konsep-konsep mendasar seperti sumbu hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA), tonus vagal, beban alostatik, atau peran pengalaman relasional awal dalam membentuk sirkuit saraf. Konsekuensinya adalah ketidaktahuan yang meluas, baik di kalangan profesional maupun publik, tentang bagaimana pikiran, napas, perilaku, dan konteks berinteraksi secara terus menerus dengan sistem somatik dalam lingkaran umpan balik yang dinamis. Kesenjangan ini menghasilkan strategi diagnostik dan terapeutik yang hanya mengobati gejala-gejala di permukaan tanpa menangani sistem regulasi yang mendasarinya.

Institusi pendidikan, terutama dalam program pelatihan kesehatan dan guru, terus memprioritaskan hafalan struktur anatomi atau jalur farmakologis di atas pemahaman tingkat sistem tentang perkembangan saraf, neuroendokrinologi, dan kognisi yang terkandung. Ketika fisiologi diajarkan, sering kali disarikan dari konteks perilaku dan lingkungan, disajikan sebagai sistem tertutup daripada matriks interaktif yang responsif yang dipengaruhi oleh faktor penentu sosial, riwayat trauma, dan pola gaya hidup. Demikian juga, peserta pelatihan klinis terpapar pada nosologi psikiatri dengan keterlibatan minimal tentang bagaimana sistem neurobiologis berkembang di sepanjang umur atau merespons disregulasi kronis. Hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada penekanan pada pemahaman berdasarkan pengalaman tentang proses pengaturan, seperti yang terlibat dalam pernapasan mondar-mandir, interoception, atau integrasi sensorimotor, atau pada metode pedagogis untuk mengajarkan hal ini kepada pasien atau masyarakat.

Dalam pengaturan perawatan kesehatan mental, defisit kurikuler ini diterjemahkan ke dalam budaya klinis di mana perawatan diri dipatologikan sebagai ketidakpatuhan atau dianggap sepele sebagai hal yang sekunder setelah kepatuhan terhadap pengobatan. Para profesional kesehatan yang tidak memiliki instruksi formal dalam pengaturan diri somatik atau fisiologi perkembangan sering kali menggunakan model berbasis otoritas, menginstruksikan pasien untuk menerima arahan farmakologis daripada mengeksplorasi strategi berbasis tubuh atau gaya hidup. Kegagalan pedagogis ini diperparah oleh kekuatan struktural: metrik produktivitas klinis, model penggantian asuransi, dan insentif farmasi secara sistematis mengurangi keterlibatan pendidikan yang intensif dan intensif demi pertemuan singkat yang berfokus pada gejala. Di sekolah-sekolah, marjinalisasi pendidikan kesehatan yang komprehensif berarti bahwa sebagian besar anak-anak lulus dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang proses perkembangan saraf mereka sendiri. Kegagalan untuk menanamkan literasi neurofisiologis ke dalam pendidikan wajib merupakan risiko kesehatan masyarakat. Anak-

anak, remaja, dan orang dewasa yang tidak terlatih dalam mengenali tanda-tanda somatik dari stres, *overdrive*, *shutdown*, atau disosiasi lebih mungkin untuk salah mengaitkan tekanan mereka, menunda koreksi diri yang tepat, dan menjadi rentan terhadap medis yang tidak tepat. Konsekuensinya meluas di luar psikiatri: impulsif, ketidakterlibatan akademis, gangguan somatik, penyalahgunaan zat, dan kekerasan, semuanya terkait dengan kapasitas regulasi yang buruk, yang dengan sendirinya bergantung pada kesempatan untuk belajar dan mempraktikkan strategi adaptif. Ketika literasi sistem saraf tidak diajarkan secara eksplisit, pengembangan mekanisme koping yang sehat dibiarkan secara kebetulan atau diturunkan secara turun-temurun, yang keduanya tidak memadai di lingkungan yang dipengaruhi oleh ketidaksetaraan sistemik, trauma historis, atau pengabaian institusional.

Tesis ini menyatakan bahwa kelalaian perkembangan, kegagalan untuk mengajarkan masyarakat cara merawat sistem saraf mereka sendiri, bukan hanya kesenjangan pendidikan, tetapi juga kondisi struktural yang selaras dan mendukung praktik farmakologis yang bersifat koersif (Cianconi et al., 2020). Bukan ketidaktahuan yang terus berlanjut, tetapi desain institusional dari ketidaktahuan, yang tertanam dalam struktur pedagogis yang memisahkan tubuh dari pikiran, biologi dari lingkungan, dan ilmu pengetahuan dari pengalaman. Sampai kurikulum, baik klinis maupun sipil, secara sistematis mengintegrasikan dasar neurosains dari stres, pembelajaran, trauma, dan adaptasi, populasi yang paling terpengaruh oleh bahaya medis akan terus kekurangan sarana untuk mencegah, memahami, atau pulih darinya. Definisi kesehatan mental menurut WHO tidak hanya menekankan pada ketiadaan penyakit, tetapi juga pada kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup yang normal, bekerja secara produktif, dan berkontribusi kepada masyarakat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan perubahan mendasar dalam hal apa yang diajarkan, siapa yang mengajarkannya, dan bagaimana institusi mengukur keberhasilan pendidikan, bukan melalui kesesuaian atau tingkat resep, tetapi melalui peningkatan pengaturan diri, kemampuan kritis, dan literasi fisiologis di seluruh rentang kehidupan.

Lanskap psikiatri klinis dan praktik medis umum saat ini menunjukkan ketidakselarasan yang terus-menerus antara semakin banyaknya bukti ilmiah dan protokol operasional yang digunakan untuk mendefinisikan, menilai, dan mengobati gangguan mental. Ketidakselarasan ini terutama terlihat jelas ketika disandingkan dengan temuan kontemporer dalam ilmu saraf, fisiologi stres, perkembangan saraf, dan kesehatan masyarakat global. Sementara rutinitas klinis yang dominan terus memusatkan pengobatan sebagai respons terdepan terhadap disregulasi emosional atau kognitif, penelitian terbaru di berbagai disiplin ilmu menunjukkan model yang sangat berbeda, yang memprioritaskan plastisitas, agensi, ketahanan metabolik, dan faktor penentu struktural kesehatan. Komponen utama dari basis bukti ini adalah pengakuan yang semakin besar terhadap sifat plastis dan adaptif dari sistem saraf manusia, yang dalam kondisi yang tepat, termasuk keamanan, regulasi relasional, tidur, dan stimulasi yang ditargetkan, menunjukkan kapasitas yang substansial untuk pemulihan dan reorganisasi fungsional. Temuan ini secara langsung menantang model yang membingkai kondisi kejiwaan sebagai ketidakseimbangan kimiawi tetap yang membutuhkan perawatan farmakologis kronis, dan sebaliknya menekankan jendela intervensi yang sensitif terhadap waktu, gaya hidup dan ekspresi risiko genetik yang bergantung pada lingkungan, dan peran penting keterlibatan somatik yang terinspirasi oleh trauma dalam penyembuhan jangka panjang.

Sejalan dengan kemajuan ini, kerangka kerja kesehatan masyarakat, termasuk dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD), dan

inisiatif kesehatan satu, menggarisbawahi kebutuhan etis dan praktis dari pendekatan non-koersif, berbasis masyarakat, pendidikan, dan pencegahan terhadap kesehatan. Definisi kesehatan mental WHO tidak hanya menolak patologisasi tekanan secara terpisah, tetapi juga menekankan pada kondisi yang memungkinkan manusia berkembang secara penuh: realisasi potensi seseorang, kemampuan untuk mengatasi tekanan sehari-hari, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitasnya. Hal ini tidak sesuai dengan sistem yang diorganisir di sekitar sedasi, kepatuhan perilaku, atau ketergantungan psikotropika yang tidak terbatas. Demikian juga, kerangka kerja kesehatan satu, yang muncul dari ilmu ekologi dan epidemiologi integratif, menolak pemisahan biner antara pikiran dan tubuh, manusia dan lingkungan, atau pengobatan dan pendidikan, dan menyerukan penyelarasan lintas sektoral dari praktik hukum, medis, dan lingkungan dalam melayani kesejahteraan sistemik.

Ilmu saraf modern, terutama dalam domain seperti regulasi afektif, pensinyalan interoaktif, allostasis, dan interaksi otak-imun, semakin menggoyahkan klaim apa pun yang menyatakan bahwa paparan psikotropika jangka panjang memberikan hasil yang netral atau menguntungkan secara seragam. Sebaliknya, hal ini menunjukkan perubahan struktural dan fungsional otak secara kumulatif dengan penggunaan kronis, termasuk desensitisasi reseptor, perubahan penanda neuroinflamasi, berkurangnya sensitivitas hadiah, dan peningkatan kerentanan untuk kambuh saat penarikan. Temuan ini tidak terbatas pada studi eksperimental, tetapi tercermin dalam tindak lanjut pasien jangka panjang, studi kohort naturalistik, dan basis data efek samping. Ketidaksinambungan antara bukti-bukti ini dan praktik pemberian resep yang berlaku mencerminkan kesenjangan implementasi pengetahuan, tetapi lebih mendasar lagi, penolakan institusional untuk menghadapi ketidaknetralan intervensi rutin, terutama dalam konteks di mana populasi yang rentan hanya memiliki sedikit akses terhadap pendapat kedua, pendidikan somatik, atau alternatif perawatan berbasis hak.

Meskipun ada pengakuan yang semakin besar terhadap perkembangan ilmiah ini di antara para peneliti, perkembangan ini tetap marjinal dalam pendidikan klinis, kurang terwakili dalam pedoman klinis, dan tidak ada dalam alat pendukung keputusan yang digunakan oleh sebagian besar praktisi. Hasilnya adalah pelembagaan bahaya medis, bukan karena kedengkian atau ketidaktahuan, tetapi melalui protokol yang tertinggal di belakang ilmu pengetahuan dan memberi insentif pada intervensi yang cepat, dapat diganti, dan dapat direproduksi di seluruh kategori diagnostik terstandarisasi. Tidak ada mekanisme institusional yang mengamankan rekonsiliasi antara temuan ilmu saraf baru dan pendidikan publik atau profesional. Juga tidak ada persyaratan peraturan yang mengharuskan protokol resep dikalibrasi ulang mengingat kemajuan dalam intervensi berbasis ilmu saraf non-farmakologis, termasuk umpan balik saraf, pelatihan ulang interoceptive, regulasi berbasis napas, dan modulasi nutrisi untuk ketidakstabilan afektif. Tidak adanya kewajiban ini memastikan bahwa sistem perawatan tetap tidak mampu berkembang secara struktural menuju standar WHO tentang kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Mengingat hal ini, konteks ilmiahnya jelas: infrastruktur untuk penyembuhan sejati, potensi neuroplastik, literasi somatik, fisiologi pencegahan, didukung secara empiris, diamanatkan secara etis, dan diabaikan secara kelembagaan. Sistem yang ada saat ini tidak mencerminkan ketiadaan pengetahuan, tetapi pengecualian selektif terhadap pengetahuan yang menantang otoritas, mengurangi ketergantungan, dan memulihkan otonomi. Sampai pengetahuan tersebut secara struktural tertanam dalam pelatihan dan tata kelola klinis, sistem kesehatan akan terus memberikan perawatan di bawah standar, memaksa, dan pada akhirnya merugikan diri sendiri, yang

tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan hukum. Penyelarasan praktik dengan kanon ilmiah kontemporer bukanlah masalah preferensi atau perdebatan, ini adalah persyaratan perawatan berbasis bukti, berbasis hak, dan berlandaskan etika.

Penerjemahan pengetahuan ilmiah dan etika ke dalam sistem perawatan yang dapat ditindaklanjuti membutuhkan desain ulang struktural yang komprehensif, dimulai dengan kurikulum dasar dan meluas ke dalam mekanisme regulasi dan akuntabilitas profesional. Pertama, kurikulum sekolah dan profesional harus direvisi untuk memasukkan konten berbasis bukti tentang fisiologi manusia, respons stres, perkembangan saraf, dan neuroplastisitas, bukan sebagai mata kuliah pilihan atau modul tambahan, tetapi sebagai fondasi ilmiah dan klinis inti. Hal ini mencakup instruksi wajib dalam beban allostatik, fungsi saraf vagus, regulasi sirkadian, kesadaran diri somatik, dan neuroendokrinologi berbasis trauma, yang disematkan di seluruh bidang medis, keperawatan, pengajaran, psikologi, dan pendidikan kesehatan terkait. Instruksi harus menekankan sifat dinamis dan plastis dari sistem saraf dan kapasitasnya untuk regenerasi dalam kondisi aman, perbaikan hubungan, dan perubahan perilaku. Hal-hal tersebut bukanlah domain khusus, melainkan prasyarat untuk kompetensi klinis modern.

Kedua, semua protokol yang mengutamakan obat harus diklasifikasikan ulang sebagai tindakan pengecualian, yang hanya dapat dilakukan di bawah kondisi yang eksplisit, terbatas waktu, dan berdasarkan persetujuan, disertai dengan tinjauan independen dan ketentuan tapering yang terstruktur. Sedasi darurat atau intervensi psikofarmakologis harus mengikuti model persetujuan bedah yang diinformasikan, hanya dapat diterima jika semua alternatif tidak memungkinkan, jika waktunya sangat penting, dan jika rencana pemulihan selanjutnya didokumentasikan dan dimonitor. Data longitudinal mengenai hasil pengobatan harus dikaitkan dengan metrik yang dilaporkan pasien secara real-time, termasuk kesejahteraan subjektif, efek samping, dan indikator fungsional seperti kembali bekerja, pendidikan, atau keterlibatan dalam komunitas. Ukuran-ukuran ini harus tersedia bagi pasien dan profesional, dalam format yang memungkinkan audit, tantangan, dan revisi.

Ketiga, sistem nasional untuk pengembangan profesional berkelanjutan harus menyertakan modul-modul dalam ilmu saraf yang diperbarui, etika perawatan, dan kewaspadaan farmakovigilans yang kritis. Partisipasi dalam modul-modul ini harus menjadi prasyarat untuk pembaruan lisensi dan spesialisasi. Pelatihan ulang juga harus diwajibkan bagi para profesional yang ditemukan berulang kali meresepkan di luar pedoman praktik terbaik, mengabaikan persyaratan persetujuan, atau gagal memulai protokol penghentian obat jika diindikasikan secara klinis. Kesalahan penerapan pengetahuan ilmiah, terutama ketika hal tersebut mengakibatkan cacatan jangka panjang, ketergantungan institusional, atau berkurangnya harapan hidup, harus tunduk pada tingkat pengawasan dan pertanggungjawaban yang sama dengan kesalahan profesional lainnya. Hal ini membutuhkan pengakuan formal atas bahaya medis sebagai kategori yang dapat ditindaklanjuti dalam tata kelola klinis dan kerangka kerja hukum, tidak hanya sebagai komplikasi atau kejadian yang merugikan, tetapi juga sebagai hasil yang dapat dicegah dari praktik yang tidak memadai atau ketinggalan zaman.

Keempat, platform pembelajaran nasional, yang dapat diakses secara bebas, terbuka, multibahasa, dan non-komersial, harus dikembangkan untuk mempromosikan literasi kesehatan masyarakat.

Platform ini harus mencakup konten audiovisual dan interaktif tentang fungsi sistem saraf, regulasi somatik, kebersihan tidur, psikiatri nutrisi, fisiologi stres, dan strategi pemulihan non-farmakologis. Hal-hal ini tidak harus dilihat sebagai intervensi kesehatan mental semata, tetapi sebagai pengetahuan publik yang mendasar, mirip dengan kebersihan atau pertolongan pertama, yang tanpanya masyarakat akan tetap rentan terhadap pengobatan yang berlebihan dan ketergantungan pada institusi. Platform semacam itu juga dapat berfungsi sebagai tempat pencatatan publik untuk pelanggaran etika, ketidakkonsistenan prosedur, dan hasil institusional, yang memungkinkan pengawasan partisipatif terhadap sistem perawatan dan mendorong pembelajaran sistemik. Sistem umpan balik etis secara real-time harus diintegrasikan ke dalam semua pengaturan kelembagaan, sekolah, rumah sakit, klinik, pengadilan, dan fasilitas tempat tinggal, di mana populasi yang rentan berinteraksi dengan para profesional. Sistem ini harus memungkinkan umpan balik yang anonim dan terlindungi dari pengguna layanan dan staf, dengan mekanisme untuk pengenalan pola, eskalasi, dan tinjauan eksternal. Metrik harus mencakup tidak hanya ambang batas hukum atau disiplin, tetapi juga penanda kerendahan hati kelembagaan, perubahan adaptif, dan perbaikan etika. Sistem yang tidak dapat menunjukkan perbaikan dalam menanggapi umpan balik harus tunduk pada intervensi eksternal atau kehilangan akreditasi. Kepatuhan etis seharusnya tidak lagi bersifat aspiratif dan menjadi terukur, ditegakkan, dan dirancang bersama oleh mereka yang paling terdampak oleh kekerasan struktural dan kelalaian medis.

Integrasi pengetahuan ilmiah, etika, dan hukum ke dalam model perawatan terpadu bukanlah tantangan teknologi, tetapi tantangan tata kelola. Alat-alatnya ada. Bukti-bukti tersedia. Yang masih kurang adalah kemauan institusional untuk memprioritaskan pengembangan manusia di atas kontrol administratif, otonomi di atas kepatuhan, dan pemulihan di atas pembiusan. Tesis ini berpendapat bahwa hanya ketika sistem perawatan diperlukan, secara hukum, pedagogis, dan operasional, untuk mencerminkan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia dan menegakkan standar kesehatan setinggi mungkin, seperti yang didefinisikan oleh WHO, maka mereka akan berhenti menyakiti dan mulai menyembuhkan. Sampai saat itu, mereka akan terus memperlakukan ketahanan sebagai gangguan, pengaturan diri sebagai ketidakpatuhan, dan kemajuan ilmiah sebagai pilihan.

Konfigurasi ulang sistem kesehatan mental menuju penyembuhan yang sejati dan praktik berbasis hak membutuhkan kerangka kerja kebijakan bertingkat yang secara eksplisit memasukkan faktor penentu sosial kesehatan dan mengikat tindakan klinis dengan standar hukum internasional. Integrasi kebijakan struktural harus dimulai dengan pengakuan bahwa pemberian obat yang berlebihan, inflasi diagnostik, dan pengabaian fisiologis bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi merupakan ekspresi sistemik dari tata kelola yang tidak selaras. Pendekatan terpadu menuntut agar sistem perawatan, sistem pendidikan, dan infrastruktur hukum mengadopsi komitmen bersama terhadap definisi kesehatan, fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dari WHO, bukan sebagai bahasa aspiratif, tetapi sebagai tolok ukur normatif untuk kepatuhan, pendanaan, dan evaluasi publik. Reorientasi ini tidak hanya bersifat semantik, namun memiliki implikasi operasional yang terukur. Setiap protokol klinis, algoritma pengobatan, kurikulum sekolah, dan proses akreditasi profesional harus dievaluasi sesuai dengan kapasitasnya untuk meningkatkan kesehatan fungsional, melindungi integritas fisiologis, dan mengurangi bahaya iatrogenik. Mandat hukum harus melampaui perlindungan prosedural untuk memasukkan persyaratan substantif untuk pendidikan fisiologis dan perkembangan saraf di domain

publik dan profesional; ini semua adalah tindakan dalam penelitian tindakan, yang masih perlu digerakkan. Institusi publik harus diwajibkan untuk mengimplementasikan program pendidikan mengenai regulasi sistem saraf, efek trauma, adaptasi stres, dan perawatan yang berorientasi pada pemulihan, bukan sebagai pilihan terapeutik, tetapi sebagai kewajiban kesehatan masyarakat secara universal. Seperti halnya undang-undang yang mengamanatkan keselamatan kebakaran atau air bersih, undang-undang tersebut juga harus memastikan akses ke informasi dan sumber daya yang memungkinkan individu untuk melindungi dan memulihkan kapasitas kognitif, afektif, dan somatik mereka. Tidak adanya mandat semacam itu membuat masyarakat rentan terhadap model pengobatan paksaan yang mengabaikan pilihan berdasarkan informasi dan secara sistematis meminggirkan pendekatan non-farmakologis.

Di tingkat institusional, kebijakan harus dibuat untuk mendukung pengembangan dan pendanaan model perawatan integratif yang didasarkan pada bukti, pencegahan, dan etika partisipatif. Skema pendanaan harus memprioritaskan institusi yang menunjukkan keselarasan yang terukur dengan prinsip-prinsip CRPD, kriteria satu kesehatan, dan standar hasil WHO. Hal ini termasuk pendanaan untuk layanan yang dipimpin oleh rekan sejawat, tim interdisipliner yang terlatih dalam pendekatan somatik dan relasional, dan mekanisme pengawasan dan umpan balik dari masyarakat. Pendanaan harus bergantung pada konten edukasi yang terukur yang disampaikan kepada staf dan pengguna layanan. Strategi kesehatan masyarakat nasional harus ditulis ulang untuk merefleksikan tidak hanya target epidemiologi tetapi juga faktor penentu struktural, kemiskinan, pengucilan, kekerasan, dan pengabaian, sebagai faktor pendukung dalam hasil kesehatan mental. Institusi pendidikan harus bertanggung jawab untuk mengajarkan fisiologi regulasi dan literasi emosional sebagai dasar dari keterampilan hidup. Badan pemberi lisensi harus mensyaratkan kompetensi dalam ilmu pengetahuan tentang trauma, protokol penarikan diri, dan dinamika pemulihan non-linear sebagai inti dari legitimasi profesional. Mekanisme tata kelola harus diperkuat dengan struktur audit dan penegakan hukum independen yang mampu menyelidiki dan memberikan sanksi atas ketidakpatuhan. Sistem ombudsman, komisi etik, dan badan pengawas harus diberdayakan untuk melacak dan memperbaiki pola sistemik dari eksekusi farmakologis, pengabaian pendidikan, dan kerugian institusional. Mekanisme ini harus mencakup keadilan retrospektif, ganti rugi atas pelanggaran di masa lalu, dan kepatuhan prospektif, yang terkait dengan pelatihan berkelanjutan, pengawasan independen, dan transparansi wajib. Secara paralel, jaringan pemimpin penyintas dan dewan tata kelola pengalaman hidup harus diberi peran formal dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kelembagaan, dan desain kurikulum, untuk memastikan arsitektur kebijakan mencerminkan realitas mereka yang paling terkena dampak.

Kerangka kerja global yang ada juga harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional dengan penyesuaian dan penegakan hukum yang jelas. Hal ini termasuk penggabungan secara eksplisit CRPD Pasal 12 (pengakuan yang sama di hadapan hukum), Pasal 25 (kesehatan tanpa diskriminasi), dan Pasal 26 (habilitasi dan rehabilitasi) ke dalam kebijakan perawatan dalam negeri dan protokol pengawasan. Pendekatan satu kesehatan harus dioperasionalkan melalui koordinasi antar kementerian yang menghubungkan kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan keadilan ke dalam satu arsitektur perawatan sosial yang terpadu. Pedoman etika, yang saat ini diturunkan menjadi kode etik profesi atau status penasihat, harus ditingkatkan menjadi norma peraturan yang mengikat dengan hukuman atas

pelanggaran dan insentif untuk penerapannya. Kegagalan dalam menerapkan langkah-langkah struktural ini memungkinkan bertahannya sistem yang lebih banyak mengobati daripada mengajar, yang membius daripada menginformasikan, dan yang mempatologiskan daripada melindungi. Bukti-bukti yang disajikan dalam bagian ini tidak hanya menunjukkan kelayakan tetapi juga pentingnya reformasi struktural. Kondisi saat ini bukanlah kondisi alamiah, melainkan desain yang dapat dibalik, yang ditopang oleh paradigma yang sudah ketinggalan zaman, kelembaman institusional, dan tidak adanya keselarasan hukum dan pedagogi dengan pengetahuan terbaik yang tersedia. Tesis ini menyimpulkan bahwa tanpa integrasi hukum dan pendidikan yang lengkap dari literasi fisiologis, etika perawatan, dan tata kelola berbasis hak ke dalam kebijakan publik yang terpadu, sistem medis akan terus melembagakan bahaya dengan kedok pengobatan. Yang dibutuhkan bukanlah cita-cita baru, melainkan pelaksanaan standar ilmiah dan normatif yang telah ada, yaitu standar yang mendefinisikan kesehatan sebagai kehadiran kapasitas, agensi, dan martabat.

5.5 Jalan menuju kedaulatan kesehatan bersama dan konvergensi ilmiah-etis

Kegagalan untuk mengintegrasikan faktor penentu sosial kesehatan dan mandat hukum yang dapat ditegakkan dalam kerangka kerja kebijakan terpadu merupakan disfungsi utama dalam sistem kesehatan jiwa kontemporer. Seperti yang dibuktikan di berbagai lokasi lapangan dan tanggapan survei, fragmentasi tanggung jawab di antara institusi medis, hukum, dan pendidikan memungkinkan pemaksaan, pengabaian, dan praktik pseudosaintifik berkembang biak di wilayah-wilayah yang secara hukum tidak jelas. Kondisi-kondisi ini tidak diamati sebagai sesuatu yang bersifat perifer, tetapi sebagai fitur yang tertanam secara struktural dalam tata kelola kejiwaan, dengan tindakan pemaksaan dan medisasi berlebihan yang dijustifikasi melalui kelembaman institusional, kebijaksanaan profesional, dan kurangnya pengawasan hukum. Ketidaksinambungan ini melemahkan definisi WHO tentang kesehatan jiwa sebagai suatu kondisi kesejahteraan di mana setiap individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitasnya.

Literatur ilmiah secara konsisten menegaskan relevansi faktor penentu sosial, termasuk perumahan, pendapatan, pendidikan, keamanan lingkungan, dan stabilitas hubungan, sebagai pemodulasi utama kesehatan mental. Tidak dilibatkannya mereka dalam penilaian psikiatri dan protokol perawatan mencerminkan reduksionisme biomedis yang sudah ketinggalan zaman yang merusak pemulihan dan bertentangan dengan kemajuan dalam kesehatan masyarakat, epidemiologi sosial, dan kedokteran sistem. Data lapangan yang dikumpulkan menunjukkan bahwa intervensi koersif sering kali terjadi tanpa adanya infrastruktur sosial yang mendukung, di mana kebutuhan dasar tidak terpenuhi, dan kesusahan ditafsirkan kembali sebagai gejala untuk melegitimasi kontrol. Dinamika ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip etika medis, yaitu otonomi, non-maleficence, dan keadilan, tetapi juga menyebabkan kronisitas, ketergantungan institusional, dan risiko bunuh diri yang lebih tinggi di antara orang-orang yang dirawat secara paksa (Pūras, 2016).

Kerangka hukum, termasuk Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, mengharuskan sistem perawatan untuk menjunjung tinggi informed consent, melindungi dari penahanan sewenang-wenang, dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Namun, seperti yang didokumentasikan dalam

berbagai kasus di lapangan, perlindungan ini tidak diterapkan atau secara aktif dielakkan melalui klasifikasi ulang perbedaan pendapat sebagai ketidakmampuan. Analisis ini menegaskan bahwa dengan tidak adanya kebijakan integratif yang mengikat praktik klinis dengan hak-hak hukum dan kondisi sosial, penegakan hukum tetap bersifat diskresioner dan impunitas dikodekan secara struktural. Kegagalan institusional ini bertentangan dengan panduan internasional berbasis bukti, termasuk inisiatif QualityRights dari WHO, dan menempatkan sistem nasional secara *de facto* melanggar kewajiban hak asasi manusia. Tanggapan yang ketat secara ilmiah dan beretika membutuhkan penyatuan berbagai domain ini ke dalam kerangka kerja kebijakan publik yang dapat ditegakkan. Kerangka kerja ini harus mengakui faktor penentu sosial bukan sebagai pertimbangan perifer tetapi sebagai bagian integral dari diagnosis, perencanaan pengobatan, dan peradilan hukum. Kesehatan jiwa tidak dapat didefinisikan atau diupayakan secara terpisah dari ekosistem sosio-ekonomi dan politik yang membentuk lintasannya. Oleh karena itu, kebijakan publik harus mencakup mekanisme untuk berbagi data antar-lembaga, indikator risiko sosial secara real-time, dan rencana perawatan integratif yang menggabungkan dukungan klinis, hukum, dan dukungan berbasis komunitas. Mekanisme ini harus dirancang dengan transparansi, persetujuan berdasarkan informasi, dan struktur akuntabilitas yang dinamis, termasuk audit independen dan umpan balik waktu nyata (Mofokeng, 2022).

Integrasi kebijakan ini juga menuntut perubahan mendasar dalam pendidikan dan pelatihan profesional, dengan memasukkan literasi hukum, perawatan berbasis trauma, pemikiran sistem, dan diagnosa sosial ke dalam kurikulum medis, hukum, dan pedagogi. Silo-silo struktural yang saat ini memisahkan mandat hukum dari rutinitas klinis dan program pendidikan menumbuhkan kondisi di mana pelanggaran hak asasi manusia dinormalisasi, dan inovasi terhambat. Penelitian ini mendukung implementasi instrumen kebijakan yang terkoordinasi di seluruh departemen pemerintah, lembaga akademik, dan sistem kesehatan, yang diatur oleh tujuan yang sama: untuk mempertahankan lingkungan di mana kesehatan, martabat, dan integritas ilmiah saling mendukung, bukannya saling bertentangan secara sistematis. Hambatan yang menentukan yang diidentifikasi selama penelitian lapangan dan data survei adalah disartikulasi sistemik antara pengetahuan ilmiah yang diperbarui dan penerapannya dalam praktik klinis dan pendidikan (WHO, 2025). Ketidakselarasan ini berkontribusi pada intervensi yang ketinggalan zaman, bersifat memaksa, dan tidak dapat dibenarkan secara medis, bahkan dalam situasi di mana kerangka hukum secara resmi mendukung hak-hak pasien, perawatan berbasis trauma, dan tata kelola yang partisipatif. Kesenjangan ini paling parah terjadi di lembaga dan wilayah yang kekurangan sumber daya, tetapi tetap ada di tingkat nasional karena tidak adanya mekanisme universal untuk penyebaran bukti dan pembaruan profesional. Sebagai tanggapan, disertasi ini mengusulkan desain dan implementasi platform pembelajaran akses terbuka nasional yang didedikasikan untuk kesehatan mental, trauma, dan etika perawatan sebagai reformasi struktural utama (Hunt, 2002).

Platform semacam itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan konten, tetapi juga sebagai ekosistem yang interaktif dan terus diperbarui untuk penyebaran pengetahuan, dialog antarprofesi, dan pelatihan berbasis hak. Arsitekturnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan terbuka, yang memungkinkan transparansi penuh atas sumber, metodologi, dan bukti empiris (Pūras, 2016). Platform harus menyediakan akses bertingkat yang disesuaikan dengan kelompok pengguna

yang beragam, dokter, pendidik, pekerja sosial, pembuat kebijakan, mahasiswa, dan masyarakat umum, memfasilitasi demokratisasi pengetahuan medis dengan tetap menjaga keakuratan ilmiah dan relevansi kontekstual. Dari perspektif teknis dan pedagogis, sistem ini harus bersifat modular, multibahasa, dan selaras dengan standar kontemporer dalam pendidikan orang dewasa, termasuk evaluasi berbasis kompetensi, pembelajaran teman sebaya, dan penalaran berbasis kasus. Sistem ini harus mengintegrasikan kemajuan dalam psikoneuroimunologi, psikiatri nutrisi, teori trauma, dan pengobatan sosial, yang dikontekstualisasikan dalam kerangka kerja etis seperti inisiatif WHO QualityRights dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Integrasi ini memastikan bahwa pelatihan yang diberikan tidak hanya berbasis bukti tetapi juga secara normatif, menanggapi kegagalan yang terdokumentasi dalam praktik saat ini (Maker & McSherry, 2023; UNHRC, 2017).

Pembenaran empiris untuk reformasi ini diambil dari Bab 3 dan 4. Survei menegaskan bahwa para profesional sering kali tidak memiliki pelatihan formal dalam pengambilan keputusan bersama, praktik berbasis trauma, dan alternatif manajemen pengobatan. Pengamatan di lapangan merinci efek berbahaya dari informasi yang salah dan pelatihan yang sudah usang, terutama di lingkungan di mana dinamika hirarkis menghalangi koreksi kesalahan atau pembaharuan praktik. Kekurangan-kekurangan ini tidak bersifat insidental, tetapi bersifat struktural, ditopang oleh sistem pendidikan yang masih terputus dari perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum saat ini. Penciptaan infrastruktur pembelajaran dengan akses terbuka juga memenuhi kebutuhan sosial yang lebih luas: pemberdayaan masyarakat melalui literasi kesehatan. Masyarakat bukanlah penerima layanan yang pasif, tetapi memiliki kapasitas laten untuk membedakan dan melakukan transformasi ketika diberikan alat untuk bertindak. Pengetahuan masyarakat, khususnya dalam kesehatan mental, telah secara sistematis dikecualikan dari lingkaran akademis dan kebijakan, meskipun perannya telah terbukti dalam pencegahan, pemulihan, dan evaluasi layanan. Platform publik yang berpusat pada pengetahuan ilmiah dan pengalaman, yang divalidasi melalui proses partisipatif, dapat menutup kesenjangan epistemik ini, mengubah penerima layanan yang tidak berdaya menjadi agen yang memiliki informasi. Secara kelembagaan, platform ini harus dilindungi dari penangkapan komersial, gatekeeping epistemik, dan manipulasi politik. Struktur tata kelola harus mencakup perwakilan dari badan-badan ilmiah, organisasi yang dipimpin oleh penyintas, universitas, dan lembaga-lembaga publik, untuk memastikan pluralisme dan akuntabilitas. Integrasi ke dalam perizinan profesional dan persyaratan pendidikan berkelanjutan akan mendukung skalabilitas dan adopsi. Data yang dikumpulkan selama disertasi ini menegaskan bahwa tanpa adanya sistem seperti itu, perbaikan dalam kebijakan atau standar hukum tidak mungkin diterjemahkan ke dalam praktik klinis atau pendidikan. Pengetahuan saja tidak akan menjadi transformatif jika tidak didistribusikan, diperbarui, dan diterapkan dalam ekosistem kelembagaan yang dirancang untuk menjaga martabat manusia, integritas ilmiah, dan kesehatan masyarakat (Pūras, 2017).

Salah satu temuan yang paling konsisten di seluruh bab 3 dan 4 adalah tidak adanya mekanisme institusional untuk melindungi mereka yang berbicara menentang pelecehan kejiwaan, korupsi epistemik, dan malapraktik klinis (Pūras, 2019). Para pemimpin penyintas, individu dengan pengalaman hidup yang menjadi agen perubahan, dan para profesional yang bertindak sebagai pelapor sering kali menghadapi pembalasan, pengucilan profesional, dan ancaman hukum.

Pembungkaman sistematis ini menghalangi kemajuan ilmiah, melemahkan akuntabilitas, dan melanggengkan iklim ketakutan yang tidak sesuai dengan tata kelola kesehatan masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, pembentukan sistem dukungan yang terlindungi bagi para aktor kunci ini bukanlah hal yang bersifat tambahan, melainkan merupakan hal yang mendasar bagi kedaulatan kesehatan bersama (Rose, 2008; Rose, 2017; Rose & Kalathil, 2019).

Dari sudut pandang ilmiah dan kebijakan, status perlindungan bagi pelapor dan pemimpin penyintas harus diformalkan dalam hukum, pendidikan, dan tata kelola kesehatan. Perlindungan ini harus mencakup undang-undang anti-pembalasan, saluran komunikasi yang aman, dukungan psikologis dan hukum, dan pengakuan formal dalam kerangka kerja kelembagaan. Para pemimpin penyintas harus diakui bukan sebagai pengecualian anekdot tetapi sebagai agen epistemik yang diperlukan yang menyumbangkan wawasan empiris di luar jangkauan metrik atau alat observasi konvensional. Demikian juga, para profesional yang mengungkapkan bahaya harus dilihat bukan sebagai pembangkangan, tetapi sebagai pemenuhan kewajiban etis dan hukum mereka di bawah prinsip-prinsip non-kekejaman, transparansi, dan kewajiban untuk melapor. Secara empiris, penelitian lapangan mendokumentasikan beberapa kasus di mana individu yang menentang praktik pemaksaan dihukum atau diabaikan, baik di dalam institusi kesehatan publik maupun di dalam sistem keluarga. Posisi peneliti sendiri sebagai penyintas dan profesional yang terpapar paksaan, pengkhianatan institusional, dan pemindahan paksa lebih lanjut menunjukkan bagaimana perlawanan yang mengakar terhadap akuntabilitas dapat bermanifestasi sebagai kekuatan represif, tidak hanya secara wacana tetapi juga secara fisik. Data survei menegaskan bahwa bahkan ketika para profesional menyadari adanya praktik-praktik yang bermasalah, mereka sering kali tidak memiliki jalan yang aman untuk melakukan intervensi, dan justru menghadapi pembalasan administratif atau pembalasan dari rekan sejawat (Rose, 2008).

Dinamika ini mencerminkan kelemahan yang lebih dalam dalam tata kelola institusi perawatan: tidak adanya struktur refleksif yang mampu mengintegrasikan kritik internal tanpa keruntuhan sistemik. Sebaliknya, sistem beroperasi melalui lingkaran umpan balik yang menutup diri, di mana perbedaan pendapat difafsirkan sebagai patologi, pembangkangan, atau pencemaran nama baik. Kekakuan epistemik ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak kapasitas pembelajaran institusi. Implementasi sistem dukungan yang dilindungi memutus lingkaran ini, memperkenalkan kembali akuntabilitas sebagai komponen fungsional dari kesehatan organisasi.

Hukum hak asasi manusia internasional dan standar kepentingan publik telah mengamanatkan banyak perlindungan ini. Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, dan kode etik asosiasi medis, semuanya mengakui keabsahan dan perlunya pelaporan pelanggaran dalam menjaga integritas institusi. Namun, kerangka kerja ini masih belum diterapkan secara konsisten di bidang psikiatri dan kesehatan jiwa, di mana asimetri kekuasaan dan otoritas diagnostik memfasilitasi dinamika pembalasan dengan dalih klinis. Hal ini menggarisbawahi perlunya mekanisme khusus di setiap sektor (Chêne, 2020; Cepeda Cuadrado, 2024). Secara struktural, sistem dukungan yang dilindungi harus tertanam dalam layanan ombuds nasional, komisi etika independen, dan kantor integritas penelitian. Pemimpin penyintas harus diintegrasikan ke dalam badan pengawas, pengembangan kurikulum, dan forum kebijakan dengan otoritas pengambilan keputusan, bukan peran simbolis. Jaringan pendampingan sebaya, struktur bantuan hukum, dan sistem pengawasan berbasis

trauma juga harus tersedia dan didanai oleh publik. Dasbor transparansi dapat melacak tanggapan lembaga terhadap bahaya yang dilaporkan, memastikan bahwa intervensi tidak hanya bersifat performatif tetapi juga korektif secara substantif. Saran-saran ini perlu dilakukan oleh para politisi, aktivis, dan praktisi yang bersedia menerjemahkan ilmu pengetahuan ke dalam praktik-praktik yang lebih baik (Komite Penasihat Dewan Hak Asasi Manusia PBB, 2015).

Tanpa perlindungan aktif dari mereka yang tidak menginginkan bahaya yang dapat dicegah, sistem kesehatan tidak dapat bergerak melampaui kondisi saat ini. Jauh dari merongrong otoritas, para pelapor dan pemimpin penyintas mewujudkan bentuk yang paling etis: pertanggungjawaban terhadap kebenaran, perawatan, dan proses ilmiah. Sistem kesehatan jiwa yang tangguh membutuhkan suara mereka tidak hanya untuk didengar, tetapi juga dilindungi, diintegrasikan, dan didukung secara kelembagaan. Dari temuan-temuan empiris yang dipaparkan pada bab 3 dan 4, dan sintesis analitis yang diprakarsai pada bab 5, jelaslah bahwa salah satu penghalang utama reformasi kesehatan jiwa yang berarti adalah ketidakselarasan yang terus menerus antara komitmen hak asasi manusia internasional dengan implementasi praktisnya. Kerangka hukum yang disediakan oleh Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan inisiatif QualityRights dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan standar normatif yang jelas: persetujuan, kebebasan dari paksaan, dan akses terhadap layanan yang berpusat pada orang (*person-centered care*). Namun, dalam praktiknya, kewajiban-kewajiban ini sebagian besar masih bersifat simbolis, yang secara rutin dilewati oleh hukum domestik, budaya administratif, dan hirarki medis yang memprioritaskan penahanan dan kepatuhan di atas martabat dan pemulihan -sebuah gagasan yang sering kali masih dianggap tabu di antara para praktisi kejiwaan.

Ketidakselarasan ini memiliki konsekuensi yang luas. Hal ini menciptakan sebuah sistem di mana perawatan kesehatan jiwa diberikan di bawah bendera perlindungan, namun secara rutin menghasilkan praktik-praktik, seperti pemaksaan pengobatan, pelembagaan tanpa jalan keluar, dan pengabaian terhadap pengalaman hidup, yang tidak dapat diterima di cabang kedokteran lainnya. Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan terhadap sistem, tetapi juga mengikis kredibilitas hukum dan ilmiahnya. Hal ini juga bertentangan dengan premis utama CRPD, yang memandang penyandang disabilitas psikososial bukan sebagai objek perawatan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan kapasitas hukum dan perlindungan yang setara di bawah hukum. Untuk beralih dari keadilan simbolis ke keadilan operasional, diperlukan penataan ulang struktural di empat ranah yang saling berhubungan: penelitian, pendidikan, hukum, dan perawatan. Dalam penelitian, hal ini memerlukan pengadopsian kerangka kerja yang memprioritaskan ilmu pengetahuan terbuka, transparansi metodologis, dan produksi bersama pengetahuan dengan pengguna layanan dan penyintas. Uji klinis, studi observasional, dan penelitian kualitatif harus dirancang untuk mencerminkan realitas pemaksaan, kekhususan budaya, dan faktor penentu struktural kesehatan. Dewan peninjau kelembagaan harus dilatih kembali untuk mendeteksi risiko etis tidak hanya dalam desain penelitian tetapi juga dalam konteks yang lebih luas dari bahaya sistemik.

Dalam dunia pendidikan, kurikulum di bidang psikiatri, psikologi, keperawatan, pekerjaan sosial, dan ilmu hukum harus direstrukturisasi untuk memasukkan hukum hak asasi manusia, perawatan berbasis trauma, etika disabilitas, dan pendekatan dialogis. Saat ini, elemen-elemen tersebut terpinggirkan atau sama sekali tidak ada dalam sebagian besar program pelatihan profesional. Hal ini menyebabkan

generasi profesional memasuki lapangan tanpa perangkat konseptual atau praktis yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum mereka atau memenuhi standar ilmiah kontemporer. Pelatihan seharusnya bersifat wajib, berkelanjutan, dan dievaluasi oleh para ahli dan pengguna jasa, untuk memastikan relevansi dan akuntabilitas.

Secara hukum, peraturan hukum domestik harus diselaraskan dengan CRPD, dengan menghilangkan ketentuan yang memungkinkan pengambilan keputusan pengganti, pengobatan paksa, dan pelembagaan kustodian berdasarkan kategori diagnostik. Hal ini tidak hanya membutuhkan reformasi hukum tetapi juga pendidikan yudisial, mekanisme pengawasan publik, dan perluasan akses terhadap penasihat hukum independen untuk orang-orang yang berada di bawah perawatan kejiwaan. Organisasi masyarakat sipil harus diberdayakan dan diberi sumber daya untuk bertindak sebagai pengawas dan advokat, dengan peran formal dalam pengembangan dan pengawasan kebijakan. Dalam perawatan klinis, model layanan harus beralih dari kerangka kerja berbasis kepatuhan menjadi sistem yang diproduksi bersama yang didasarkan pada kepercayaan, otonomi, dan praktik berbasis bukti (Grol & Grimshaw, 2003). Hal ini berarti mengganti protokol yang bersifat memaksa dengan pengambilan keputusan yang didukung, perencanaan perawatan yang bersifat individual, dan respon yang berakar pada komunitas terhadap krisis. Tolok ukur keberhasilan juga harus bergeser, dari penekanan gejala dan tingkat hunian tempat tidur menjadi indikator yang berorientasi pada pemulihan seperti inklusi sosial, kualitas hidup, dan kesejahteraan yang ditentukan sendiri. Hal ini membutuhkan alat bantu di luar kategori nosologis yang ada saat ini dan menuntut integrasi wawasan psikososial, nutrisi, dan neurobiologis ke dalam praktik sehari-hari. Temuan empiris menunjukkan bahwa para profesional dan pengguna sama-sama menyadari kesenjangan ini dan menyatakan dukungan untuk perubahan. Namun, kelambanan sistemik, hierarki yang mengakar, dan fragmentasi birokrasi menghambat implementasi. Mengoperasionalkan keadilan bukanlah masalah penyelarasan retorika, melainkan desain ulang kelembagaan, penegakan hukum, dan transformasi budaya. Ketika standar internasional ada tetapi tidak diterapkan, ketidakadilan tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi kebijakan yang diabaikan.

Oleh karena itu, tesis ini berargumen bahwa penyelarasan seharusnya bersifat aktif, bukan deklaratif. Keselarasan seharusnya diukur dalam bentuk hasil, bukan pernyataan misi (Canadian Deprescribing Guidelines Project, 2024). Hukum, seperti yang ditekankan dalam kerangka kerja Aristoteles yang dirujuk dalam bab 4, tidak hanya berfungsi sebagai pencegah tetapi juga sebagai panduan korektif untuk sistem yang gagal mengatur diri mereka sendiri secara etis. Dalam hal ini, penegakan standar WHO dan CRPD bukan hanya masalah kepatuhan tetapi juga kebutuhan ilmiah dan moral (Damschroder et al., 2009).

Temuan-temuan yang didokumentasikan dalam bab 3 dan 4 menggarisbawahi defisit struktural utama dalam sistem kesehatan jiwa saat ini: tidak adanya mekanisme umpan balik yang dinamis, transparan, dan dapat ditegakkan yang mampu memandu pengambilan keputusan yang etis secara real time. Praktik-praktik pemaksaan, pengucilan epistemik, jebakan diagnostik, dan bias dokumentasi terus berulang tidak hanya karena kesenjangan dalam hukum atau pendidikan, tetapi juga karena institusi dan para profesional beroperasi di lingkungan di mana penilaian etis bersifat retrospektif, dilemahkan, atau tidak ada sama sekali. Kekosongan sistemik ini memungkinkan praktik-praktik berbahaya terus berlanjut tanpa terkendali, sementara individu yang berusaha melakukan reformasi dari dalam, baik

sebagai dokter, administrator, maupun pengguna layanan, sering kali menghadapi perlawanan, marjinalisasi, atau pembalasan dari institusi. Untuk mengatasi kekurangan ini, tesis ini mengusulkan pengembangan dan integrasi sistem umpan balik etis secara real-time, yang dirancang untuk mendukung para pelaku klinis dan institusional dalam mengidentifikasi, menilai, dan merespons ketegangan etis yang muncul. Sistem ini akan berfungsi baik sebagai infrastruktur pencegahan maupun sebagai alat korektif, memastikan bahwa penyimpangan dari standar berbasis hak dan berdasarkan bukti segera ditandai dan ditangani. Sistem-sistem ini juga akan menjadi penghubung yang diperlukan antara etika teoritis, pengalaman langsung, dan akuntabilitas kebijakan, yang mengoperasionalkan kerangka kerja etika yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan badan-badan hak asasi manusia nasional.

Dalam dimensi teknisnya, sistem ini dapat menggabungkan platform digital, aplikasi seluler, atau alat dasbor rumah sakit terintegrasi yang memungkinkan staf dan pengguna layanan untuk mengirim, meninjau, dan menanggapi peringatan etika secara real time (WHO, 2023). Lingkaran umpan balik tidak akan terbatas pada mekanisme pelaporan pelanggaran, tetapi disusun sebagai proses peningkatan kualitas rutin, yang tunduk pada audit eksternal dan tata kelola partisipatif (Sachdev et al., 2022). Indikator untuk evaluasi akan mencakup metrik paksaan, kualitas persetujuan, kepuasan pasien, transparansi kelembagaan, dan tekanan moral yang dilaporkan oleh staf. Yang penting, sistem ini harus memungkinkan anonimitas, perlindungan dari pembalasan, dan jalur eskalasi yang menjangkau entitas ombuds independen atau badan peninjauan yudisial jika diperlukan (Chambers & Azrin, 2020).

Dari sudut pandang konseptual, sistem umpan balik etis bergantung pada pengakuan bahwa tidak ada kebijakan atau pedoman yang dapat sepenuhnya mengantisipasi kompleksitas pertemuan klinis. Etika harus bersifat antisipatif dan responsif, dibentuk melalui dialog berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan dan tertanam dalam praktik sehari-hari. Sistem semacam itu harus dirancang bersama dengan para penyintas, dokter, ahli hukum, dan ahli etika untuk memastikan relevansi kontekstual dan inklusivitas epistemik (González Block & Mills, 2003). Pedoman ini juga harus dapat dimodifikasi seiring dengan berkembangnya bukti klinis dan pergeseran ekspektasi sosial, dengan mengintegrasikan model tata kelola yang adaptif dan bukannya kepatuhan yang statis. Data empiris dari lapangan menunjukkan adanya kebutuhan akan infrastruktur tersebut. Para profesional sering melaporkan adanya konflik etis dalam menerapkan tindakan pemaksaan, namun tidak memiliki sarana untuk refleksi terstruktur, konsultasi dengan rekan sejawat, atau dukungan kelembagaan. Sementara itu, para pengguna dan penyintas, berulang kali menggambarkan pengalaman ketika pengaduan mereka diabaikan atau ditinggalkan sebagai bukti lebih lanjut dari patologi. Menjembatani kesenjangan ini tidak hanya membutuhkan inovasi prosedural tetapi juga pergeseran budaya tentang bagaimana etika dipahami, bukan sebagai pelengkap teoretis tetapi sebagai komponen inti dari perawatan yang aman, efektif, dan sah.

Penerapan sistem umpan balik etika secara real-time juga berkontribusi langsung terhadap legitimasi institusi. Sistem ini menandakan komitmen terhadap transparansi, kemampuan beradaptasi, dan pengawasan partisipatif yang melampaui model penjaminan mutu tradisional. Institusi yang mengintegrasikan sistem semacam itu dapat menunjukkan kepatuhan terhadap standar internasional,

menumbuhkan kepercayaan di antara pengguna dan staf, serta mempercepat identifikasi dan mitigasi kegagalan sistemik. Dalam jangka panjang, sistem ini juga memfasilitasi pengumpulan data untuk penelitian dan pengembangan kebijakan, yang berkontribusi pada tujuan yang lebih luas untuk menyelaraskan sistem kesehatan dengan integritas ilmiah dan hak asasi manusia (Fixsen et al., 2005). Ketiadaan infrastruktur etika yang real-time bukan hanya merupakan kekeliruan logistik, tetapi juga merupakan kekurangan struktural dengan konsekuensi yang dapat diukur terhadap martabat manusia, hasil klinis, dan kepercayaan masyarakat. Seperti yang ditunjukkan dalam disertasi ini, perawatan yang efektif dan akuntabilitas institusional membutuhkan kalibrasi ulang yang konstan. Sistem umpan balik etis menawarkan jalur yang beralasan, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan koheren secara hukum untuk mencapai kalibrasi ulang ini, yang memenuhi dimensi keadilan yang aspiratif dan operasional.

Bab 6 - Dimensi hukum dan etika: norma, pelanggaran, dan akuntabilitas

Ringkasan: Bab ini membahas kerangka hukum dan normatif yang mengatur intervensi psikiatri di Spanyol, menilai dasar-dasar konstitusional, kegagalan sistemik, dan kewajiban internasional. Mengambil langsung dari bukti empiris, bab ini menginterogasi bagaimana jaminan formal dirusak oleh kriteria subjektif, kesenjangan prosedural, dan penyimpangan institusional, yang menghasilkan impunitas sistemik. Tujuannya bukanlah advokasi aktivis, tetapi pemulihan lingkaran umpan balik yang fungsional dan berbasis bukti antara hukum, etika, praktik klinis, dan penelitian.

6. Pendahuluan - legalitas perawatan paksaan sebagai standar

Hubungan antara hukum dan psikiatri, sebagaimana dibuktikan oleh bagian empiris dari disertasi ini, mengungkapkan seperangkat asumsi normatif yang terkodifikasi secara struktural yang mengizinkan, dan dalam banyak kasus, mengkatalisasi, tindakan yang diinduksi secara medis dengan kedok intervensi terapeutik (Dixon, 2015). Berlawanan dengan harapan konstitusional dan klinis bahwa semua prosedur dalam kedokteran memiliki fungsi restoratif, proporsional, dan paling tidak membatasi, arsitektur hukum yang berlaku di Spanyol kontemporer, dan secara paralel, yurisdiksi Eropa lainnya, mengizinkan rutinisasi intervensi yang tidak disengaja, non-konsensual, dan patologis melalui matriks pengecualian yang telah menjadi norma-norma fungsional. Kondisi struktural ini memungkinkan terjadinya penangkapan epistemik, inersia klinis, dan pelanggaran multiskalar terhadap otonomi tubuh, kognitif, dan sosial.

Ketidakpastian hukum yang paling kritis dan berulang muncul dari kewenangan diskresi yang diberikan kepada dokter, administrator institusi, dan personel psikiatri non-forensik untuk menanggulangi hak-hak individu, sering kali tanpa batas waktu, tanpa mekanisme perlawanan atau peninjauan independen. Kerangka kerja diskresi ini memungkinkan penanggulan hak-hak dasar, termasuk yang tercantum dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Spanyol, melalui interpretasi subyektif atas status mental, risiko, dan perilaku tidak kooperatif. Penilaian ini sering kali berasal dari laporan pihak ketiga, terutama aktor keluarga yang kepentingannya mungkin bertentangan dengan kepentingan orang yang menjadi sasaran. Data empiris yang disajikan dalam disertasi ini menunjukkan bahwa sertifikasi psikiatri dan prosedur diagnostik sering kali bergantung pada informasi yang tidak diverifikasi atau dapat dimanipulasi yang kemudian dikodifikasi ke dalam rekam medis dengan kelembaman institusional. Kodifikasi ini berfungsi sebagai prasasti yang tidak dapat diubah dalam sistem medis digital, mereproduksi bias sistemik di seluruh konteks klinis, intervensi darurat, proses peradilan, dan layanan sosial (Goffman, 1961).

Bersamaan dengan itu, sistem hukum mengizinkan pendelegasian kekuasaan kustodian dan pengambilan keputusan kepada anggota keluarga, terlepas dari indikator pelecehan, konflik relasional, atau bukti historis tentang bahaya. Pendelegasian ini dianggap melindungi, namun sering kali mengakibatkan paparan yang berkepanjangan terhadap mekanisme kontrol domestik yang meniru kendala kelembagaan. Kontrol keluarga seperti itu sering kali dilegalkan melalui undang-undang perwalian, prosedur penerimaan paksa, atau pengabaian persetujuan, yang semuanya tidak memiliki kriteria yang berdasarkan trauma atau pemeriksaan forensik. Ketentuan-ketentuan ini merupakan keruntuhan biopolitik antara keintiman dan tata kelola, di mana ruang domestik menjadi zona intervensi psikiatri yang tidak diatur, terutama ketika didukung oleh aktor-aktor institusional yang tidak melakukan penilaian independen (Ehrenberg, 2010).

Celah struktural kedua terletak pada ketidakjelasan dan asimetri epistemik dari dokumentasi medis. Meskipun catatan medis berfungsi secara legal sebagai bukti klinis, catatan medis tersebut dikurasi secara selektif, tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkena dampaknya, dan resisten terhadap amandemen atau koreksi. Pasien dan keluarga yang tidak bersekutu dengan narasi institusional tidak memiliki sarana operasi untuk memperbaiki catatan atau pernyataan balasan berbasis bukti (Rosenquist, Fowler, & Christakis, 2011). Hak prerogatif hukum memberikan otoritas yang hampir total kepada direktur pusat dan dokter pengawas untuk menyunting, menyangkal, atau menahan dokumentasi, termasuk label diagnostik yang diperdebatkan, kesan subjektif, dan riwayat perilaku

yang dibuat-buat. Praktik-praktik ini menghasilkan distorsi epistemik yang bertingkat di seluruh kontinum administrasi-hukum-kesehatan. Hal ini berkontribusi pada pengabaian medis kronis, meningkatkan risiko paparan farmakologis yang berlebihan, dan melembagakan kesalahan pemberian label diagnostik dengan dampak lintas generasi.

Dasar pembuktian dari tesis ini menggambarkan bahwa bunuh diri, disregulasi perilaku, dan fragmentasi identitas bukanlah kondisi mental yang terisolasi, melainkan konsekuensi sistemik dari kekerasan medis-hukum yang saling bersinggungan. Ketika individu berusaha untuk melawan, memprotes, atau keluar dari sirkuit kontrol ini, perlawanan mereka dikodekan ulang sebagai patologi lebih lanjut, sehingga membenarkan penahanan tambahan. Logika rekursif ini dilindungi oleh hak istimewa medis dan referensialitas institusional. Epistemologi klinis, jika tidak ditempa oleh audit independen atau verifikasi pluralistik, akan menjadi kendaraan untuk membahayakan. Praktik psikiatri tidak lagi diatur oleh keharusan Hipokrates untuk tidak menyakiti dan malah berfungsi sebagai alat pengucilan dan kontrol biopolitik (Priest, 2021).

Struktur diagnostik, hukum, dan institusional yang mengatur kesehatan mental di Spanyol, meskipun seolah-olah selaras dengan prinsip-prinsip perawatan, telah berevolusi menjadi mekanisme yang melegitimasi bahaya, yang dimungkinkan oleh serangkaian kelalaian peraturan dan celah prosedural yang telah dinormalisasi secara struktural. Inti dari disfungsi ini adalah kewenangan tanpa kualifikasi yang diberikan kepada para profesional kesehatan jiwa dan administrator pusat kesehatan jiwa untuk memberlakukan dan memperpanjang intervensi koersif berdasarkan interpretasi subjektif atas perilaku, dampak, dan dugaan risiko, tanpa adanya standar verifikasi yang ketat, asesmen berbasis trauma, atau peninjauan ulang. Kerangka kerja legislatif yang berlaku mendelegasikan kepada dokter suatu bentuk kedaulatan hukum-medis yang menangguhkan hak-hak konstitusional tanpa perlu otorisasi pengadilan segera, memungkinkan pemberlakuan pengobatan paksa, rawat inap paksa, polifarmasi, dan pengasingan sosial berdasarkan ambang batas yang tidak jelas tentang bahaya atau kurangnya wawasan. Intervensi ini, setelah diterapkan, sering kali menjadi melanggar diri tanpa batas waktu, didukung oleh kelembaman institusional dan pengabdian perilaku pasien secara selektif melalui catatan klinis yang tidak terdokumentasi, tidak dikoreksi, atau dipalsukan. Data empiris dari tesis ini mengonfirmasi bahwa akses pasien terhadap catatan sering kali ditolak atau dihalangi; bahwa entri dikuratori agar sesuai dengan narasi pengendali; dan bahwa ganti rugi atau koreksi secara struktural tidak mungkin dilakukan setelah jalur diagnostik dilembagakan (Paris, 2020).

Secara paralel, salah satu kegagalan hukum yang paling konsekuen tapi jarang diteliti terletak pada penghormatan yang dikodifikasi terhadap anggota keluarga sebagai agen default dari penilaian psikiatris dan otoritas kustodian. Hukum perwalian dan undang-undang penerimaan pasien tanpa paksaan sering kali memberdayakan anggota keluarga, sering kali tanpa pemeriksaan forensik atau relasional, untuk bertindak sebagai proksi untuk negara dan sistem klinis, memindahkan lokus kontrol dari individu kepada mereka yang mungkin secara sosial atau ekonomi mendapat insentif untuk mempatologisasi mereka. Dinamika ini menciptakan sebuah lingkaran umpan balik di mana kekuatan psikiatri menjadi alat kontrol domestik, yang dimungkinkan oleh fiksi hukum tentang kebajikan keluarga. Hasil survei dan data penelitian lapangan yang disajikan dalam disertasi ini merinci banyak contoh di mana individu-individu secara paksa dilembagakan, diberi obat secara berlebihan, atau ditolak aksesnya terhadap anak-anak mereka berdasarkan tuduhan yang belum diverifikasi atau

konflik dengan keluarga, tanpa adanya tinjauan hukum atau klinis. Setelah dimasukkan ke dalam berkas klinis, tuduhan-tuduhan ini menjadi fakta institusional, tahan terhadap kontradiksi, dan membentuk semua keterlibatan selanjutnya di seluruh domain kesehatan, hukum, dan layanan sosial (Montero Carrera, 2020).

Pelimpahan wewenang kepada anggota keluarga yang tidak diperiksa ini menjadi sangat berbahaya dalam situasi pelecehan yang sudah ada sebelumnya, kekerasan pasangan intim, atau pola trauma antargenerasi yang diwariskan. Namun, kode hukum Spanyol tetap tidak menyebutkan kewajiban untuk mengevaluasi dinamika keluarga sebelum memberikan kuasa pengasuhan atau mempengaruhi keputusan psikiatri (Christakis & Fowler, 2009). Protokol perlindungan tidak ada atau tidak ditegakkan. Bahkan ketika pasien melaporkan pelecehan atau pemaksaan oleh anggota keluarga, pengungkapan ini sering kali dibingkai ulang sebagai gejala paranoia atau ketidakpatuhan, dan kredibilitas mereka secara sistemik didiskreditkan. Dengan demikian, hukum melanggar budaya klinis di mana struktur keluarga yang kejam dilegitimasi, dan orang yang menjadi korbannya semakin dipatologikan karena melawan atau mencari perlindungan.

Kegagalan institusional ini diperparah dengan kurangnya prosedur yang dapat ditegakkan untuk memastikan adanya persetujuan, hak untuk menolak, atau akses terhadap pendapat kedua yang independen, terutama dalam kasus-kasus di mana reaksi yang merugikan terhadap obat-obatan, penurunan kognitif, atau kerusakan somatik sudah terlihat. Arsitektur biomedis tempat psikiatri beroperasi tidak mewajibkan dokter untuk mengevaluasi kembali kebutuhan atau proporsionalitas rejimen farmakologis kecuali jika diminta oleh protokol institusional, yang sering kali tidak jelas, ketinggalan jaman, atau diterapkan secara selektif. Tidak ada kewajiban hukum untuk memulai depreskripsi, bahkan ketika bahaya dapat dibuktikan. Di banyak tempat perawatan kejiwaan, kombinasi obat dengan zat-zat yang dikontraindikasikan, seperti alkohol, atau pemberian obat di bawah paksaan atau tanpa kejelasan prosedural masih menjadi praktik yang umum. Tindakan-tindakan ini, meskipun secara langsung melanggar etika medis dan pedoman ilmiah, tetap tidak dapat digugat secara hukum karena kekebalan prosedural dokter dan keengganan sistemik yang lebih luas untuk menginterogasi tata kelola internal psikiatri. Ketika kematian terjadi, seperti yang sering terjadi karena bunuh diri, sedasi berlebihan, atau kecacatan iatrogenik yang progresif, kejadian tersebut biasanya dibingkai ulang secara post hoc sebagai perkembangan alamiah dari gangguan yang seharusnya, sehingga membebaskan sistem dari pemeriksaan dan mengaitkan hasilnya dengan patologi pasien yang bersifat intrinsik (Wyman, 2023).

Isolasi sistemik dari pertanggungjawaban ini mereproduksi siklus kekerasan struktural di bawah kedok legitimasi medis. Hal ini juga didukung oleh kegagalan sistem hukum untuk menyediakan mekanisme akuntabilitas waktu nyata, terutama dalam kasus-kasus kesalahan institusional, pemalsuan data, atau penyalahgunaan epistemik yang terdokumentasi (Dayalu & Chou, 2008; Degnin, 2009; Paris, 2024). Asimetri struktural dalam akses dokumentasi, dikombinasikan dengan anggapan infalibilitas profesional medis, memungkinkan penghapusan medis yang meluas dari pengalaman hidup dan penulisan ulang sejarah realitas pasien. Responden survei secara konsisten melaporkan dinamika ini, dibungkam, disalahartikan, atau tidak diberi kesempatan untuk bercerita, sebagai salah satu aspek yang paling merusak dalam pengalaman kejiwaan mereka. Hasilnya bukan hanya pelanggaran klinis, tetapi juga pelanggaran hukum, di mana hak-hak dasar seperti kebebasan,

integritas tubuh, persetujuan, dan ganti rugi ditanggguhkan tanpa perlindungan prosedural yang memadai (Oldani, 2014).

Sistem kesehatan jiwa yang benar-benar preventif akan membutuhkan penataan ulang struktural di setiap titik dari arsitektur klinis-hukum ini. Hal ini termasuk kewajiban untuk melakukan skrining trauma independen dan penilaian risiko penyalahgunaan sebelum tindakan psikiatri dipertimbangkan; pembentukan audit hukum otomatis dalam kasus-kasus penerimaan pasien secara paksa atau polifarmasi; pengenaan konsekuensi hukum untuk efek samping yang tidak dilaporkan atau kelalaian dalam pemberian obat; dan pembentukan badan pengawas yang dipimpin oleh pasien yang memiliki akses terhadap catatan institusional dan wewenang untuk memicu tinjauan forensik independen. Tanpa koreksi sistemik ini, sistem psikiatri akan tetap menjadi tempat peradilan yang selektif, yang beroperasi di luar batas-batas integritas ilmiah dan perlindungan konstitusional. Etos kedokteran, sebagai disiplin ilmu yang restoratif, akuntabel, dan menghormati hak-hak, mengharuskan reformasi ini dilaksanakan bukan sebagai cita-cita yang bersifat diskresioner, tetapi sebagai kewajiban hukum yang dipaksakan, yang didasarkan pada data empiris dan prinsip bioetika.

6.1 Konteks hukum nasional: jaminan formal dan kesenjangan operasional

Kerangka hukum Spanyol mendeklarasikan sebuah katalog hak yang komprehensif yang mencakup kebebasan pribadi, integritas fisik dan mental, privasi, dan kesehatan, serta kapasitas hukum dan perlindungan prosedural bagi individu dengan disabilitas. Jaminan-jaminan ini diartikulasikan dalam Konstitusi Spanyol tahun 1978, khususnya Pasal 10, 15, 17, 18, dan 43, dan diuraikan dalam norma-norma sektoral seperti Ley 41/2002 tentang Otonomi Daerah, Ley General de Sanidad (14/1986), dan Ley 8/2021 tentang hak-hak penyandang disabilitas. Spanyol terikat oleh kewajiban internasional seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun, penerapan operasional dari perlindungan ini menunjukkan ketidaksesuaian yang sistematis antara konten deklaratif dan praktik institusionalnya. Warisan paternalisme medis yang otoriter masih tertanam kuat dalam tata kelola kesehatan jiwa, di mana kebijaksanaan klinis terus berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Psikiatri, alih-alih mengikuti standar perawatan yang dialogis atau berbasis trauma, tetap diberdayakan untuk memberlakukan pembatasan kebebasan dan otonomi tubuh tanpa pemeriksaan yang transparan, pengawasan multi-profesional, atau akuntabilitas naratif. Hal ini tidak hanya mencerminkan batasan yuridis tetapi juga paradigma epistemik yang lebih luas di mana perawatan disamakan dengan dominasi dan keamanan dengan pengekanan.

Pelanggaran hukum yang paling signifikan terlihat pada penggunaan kriteria risiko subyektif yang luas dan tidak tepat untuk membenarkan intervensi pemaksaan. Pasal 763 Undang-Undang Prosedur Sipil Spanyol, Ley de Enjuiciamiento Civil, mengesahkan penerimaan dan perawatan paksa atas dasar pernyataan profesional tentang bahaya bagi diri sendiri atau orang lain, yang sering kali dilaksanakan oleh seorang psikiater tanpa evaluasi yang menguatkan atau alasan yang sesuai dengan konteksnya. Klausul ini, yang secara hukum memungkinkan perampasan kebebasan dan pengenaan psikofarmaka,

sering kali diaktifkan tanpa kewajiban formal untuk mendokumentasikan bukti-bukti yang kuat tentang bahaya yang akan terjadi atau yang mungkin terjadi. Tidak ada ambang batas klinis yang seragam, standar bukti, atau mekanisme penilaian ulang yang sensitif terhadap waktu. Peninjauan yudisial, jika terjadi, biasanya dilakukan secara asal-asalan dan hanya didasarkan pada laporan medis awal, yang sering kali dibuat tanpa penilaian risiko yang terstruktur, data longitudinal, atau masukan dari individu yang terkena dampak. Perbedaan regional dalam penerapannya mengungkapkan kesewenang-wenangan struktural yang mendalam. Dalam banyak kasus, penelitian lapangan menegaskan bahwa ketentuan hukum ini tidak berfungsi sebagai mekanisme perlindungan, melainkan sebagai pintu masuk untuk melakukan pemaksaan yang tidak terkendali dengan kedok kebutuhan medis. Subjek yang terkena dampak diubah menjadi objek hukum manajemen daripada makhluk biologis dan relasional yang memiliki hak-hak.

Kegagalan tambahan dan yang lebih parah terjadi pada aspek-aspek prosedural seputar penanganan dan perawatan kejiwaan. Ketentuan hukum secara resmi mengakui hak untuk diberitahu tentang situasi seseorang, untuk mengakses pendapat medis kedua, untuk mendapatkan penasihat hukum yang gratis, dan untuk menentang intervensi secara yudisial. Namun, bukti empiris dari survei profesional dan pengguna, dikombinasikan dengan kesaksian lapangan, menunjukkan bahwa hak-hak ini secara sistematis dirusak. Individu jarang menerima informasi yang tepat waktu atau dapat dipahami tentang status hukum atau pilihan klinis mereka. Permintaan untuk mendapatkan opini kedua terhalang oleh penolakan internal, kurangnya infrastruktur kelembagaan, dan ketakutan umum akan pembalasan. Bantuan hukum sering kali tertunda, kekurangan sumber daya, atau pasif, dan dalam banyak kasus, perwakilan diberikan tanpa pengetahuan kejiwaan yang memadai atau penyelidikan independen. Mekanisme kontrol yudisial yang diatur dalam Pasal 763 LEC secara prosedural lemah, hanya mengandalkan laporan medis yang sama dengan yang mendorong intervensi, tanpa evaluasi ulang atau verifikasi. Narasi, riwayat medis, dan persetujuan pasien dianggap sebagai asumsi patologis yang tidak dipertanyakan atau diimbangi dengan bukti-bukti yang berlawanan. Anamnesis jarang sekali diulang. Siklus dokumentasi sering kali mereplikasi dan mengkonsolidasikan penetapan diagnostik sebelumnya, bahkan jika didasarkan pada data yang salah atau ketinggalan zaman. Hal ini menghasilkan efek berjenjang, di mana catatan lama menjadi dasar keputusan baru, dan penilaian ulang yang kritis menjadi tidak mungkin dilakukan secara struktural.

Kekosongan hukum lebih lanjut, baik secara etis maupun praktis, muncul dari ketidakjelasan atau tidak dapat diaksesnya catatan klinis. Menurut Ley Orgánica 3/2018 tentang Perlindungan Data Pribadi dan jaminan hak-hak digital, institusi dapat membatasi akses ke dokumentasi medis jika akses tersebut dianggap membahayakan pasien. Ketentuan ini memungkinkan dokter dan institusi untuk menyembunyikan diagnosis, menyangkal pengetahuan tentang intervensi, atau mencegah verifikasi praktik pemaksaan. Mengingat bahwa sebagian besar intervensi kejiwaan dibenarkan oleh catatan internal dan bukan oleh metrik yang dapat diverifikasi secara eksternal, sikap permisif hukum ini memungkinkan rezim impunitas pengarsipan. Hal ini memungkinkan para praktisi untuk membuat dan mempertahankan fiksi klinis yang tidak tunduk pada koreksi waktu nyata, tantangan naratif, atau pengawasan ilmiah. Orang yang mengalami pemaksaan tidak hanya dilucuti dari pembelaan hukum tetapi juga dari alat epistemik dasar untuk melacak, memahami, dan merespons rantai peristiwa yang menentukan lintasan mereka. Dengan tidak adanya kontrol versi yang diamanatkan, audit

independen, atau kewajiban untuk mendaftarkan penolakan persetujuan, catatan klinis menjadi instrumen penghapusan ontologis. Temuan berulang dari tesis ini menegaskan bahwa akses terhadap catatan-catatan ini sering kali ditolak atau ditunda, terutama ketika ada indikator penyimpangan prosedural atau kolusi keluarga.

Pemaksaan menjadi rutinitas bukan melalui deklarasi terbuka, melainkan melalui kebiasaan prosedural dan otomatisasi administratif. Penangguhan hak yang dinormalisasi ini diamati terutama dalam lingkungan yang terlembaga, di mana ketergantungan struktural, kerentanan sosioekonomi, dan kurangnya pengawasan eksternal bertemu. Dalam lingkungan seperti ini, beban pembuktian dibalik: individu dipaksa untuk menunjukkan bahwa mereka tidak lagi berbahaya, bukannya dianggap kompeten atau tidak mengancam. Kemungkinan untuk melakukan kontestasi diambil alih oleh sistem yang sama yang memberlakukan dan mengadakan pemaksaan. Sirkularitas hukum ini tidak menyisakan ruang untuk inovasi terapeutik, refleksi, atau evaluasi yang berpusat pada orang. Prinsip-prinsip etis tentang kebaikan, keadilan, dan penghormatan terhadap manusia dengan demikian menjadi nominal. Sebaliknya, fondasi ilmiah dan moral perawatan digantikan oleh model manajerial penahanan. Model ini ditopang oleh keharusan birokrasi dan rutinitas profesional yang mengaburkan tanggung jawab dan melemahkan akuntabilitas. Dalam konteks seperti ini, kesalahan diagnosis, pengekangan kimiawi, dan penyangkalan terhadap kesaksian pribadi bukanlah pengecualian, melainkan inti dari prosedural. Ini adalah kegagalan paradigma dengan konsekuensi biologis, psikologis, dan sosial yang luas (Chambers, 2019).

Kendala struktural dalam praktik etika di kalangan profesional semakin memperparah kebuntuan hukum dan kelembagaan ini. Data yang dikumpulkan melalui metode campuran mengungkapkan bahwa banyak psikiater, psikolog, dan perawat menyadari ambiguitas moral atau ketidakcukupan klinis dari intervensi yang diperintahkan untuk mereka lakukan. Namun, iklim ketakutan yang ada, konformitas institusional, dan ketidakpastian hukum menghambat tindakan alternatif. Para profesional melaporkan tidak adanya protokol untuk penolakan, kurangnya perlindungan terhadap perbedaan pendapat, dan ketakutan akan pembalasan profesional. Ketidakjelasan hukum menjadi mekanisme kekebalan pribadi dan kelembagaan, disinsentif untuk inovasi, mencegah pelaporan pelanggaran, dan mendorong keterlibatan pasif. Pertimbangan etis tergeser oleh kepatuhan administratif. Yang muncul bukanlah lingkungan perawatan kolektif atau kemajuan klinis, melainkan kepatuhan terhadap otoritas di seluruh sistem, yang diperkuat oleh teks-teks hukum yang ambigu, kelembaman struktural, dan budaya yang mengacaukan ketaatan dengan keamanan. Dalam ekspresi yang paling ekstrem, budaya ini menormalkan kematian sosial melalui serangkaian intervensi biomedis yang mengurangi otonomi, mendekontekstualisasikan penderitaan, dan menghasilkan ketergantungan seumur hidup pada sistem yang tidak melindungi atau memperbaiki. Temuan-temuan ini menyerukan transformasi hukum dan institusional segera yang didasarkan pada pengamatan empiris, ilmu pengetahuan interdisipliner, dan pengakuan atas hak fundamental setiap orang atas martabat, kesehatan, dan keadilan (Farmer, 2004; Bourdieu, 2001).

Untuk mengatasi defisit sistemik yang diuraikan di atas, reformasi struktural harus segera dilakukan di seluruh domain legislatif, klinis, dan prosedural. Norma-norma hukum tidak bisa hanya bersifat deklaratif sementara praktik klinis diatur oleh kebiasaan tidak tertulis, tindakan diskresi, dan pelanggaran integritas tubuh yang ditoleransi secara budaya. Mandat yang mengikat untuk

dokumentasi waktu nyata, validasi pemeriksaan silang, dan pengawasan etika independen harus diabadikan dalam undang-undang nasional. Catatan klinis harus tunduk pada protokol kontrol versi yang memastikan ketertelusuran setiap modifikasi. Pencantuman catatan pasien dan ketidaksetujuan yang diinformasikan harus dipertahankan dalam semua sistem dokumentasi, dengan hukuman untuk kelalaian atau perubahan. Perlindungan ini bukanlah tambahan bagi etika medis, tetapi merupakan bagian intrinsik dari etika medis. Antropologi biologi menegaskan bahwa kesehatan bukan hanya ketiadaan penyakit, tetapi juga adanya integritas sistemik, martabat, dan koherensi relasional. Tidak adanya mekanisme perlindungan naratif dalam psikiatri merupakan pelanggaran terhadap keseimbangan homeostatis yang diperlukan untuk pemulihan kognitif dan afektif. Apa yang tidak dapat dikatakan tidak dapat disembuhkan. Tanpa integritas epistemik, tidak ada model biologis yang berkelanjutan, dan tidak ada hasil kesehatan yang dapat diandalkan (Levin & McDevitt, 2002).

Selain itu, reformasi hukum harus secara eksplisit melarang penggunaan kesaksian keluarga sebagai satu-satunya dasar klinis dalam kasus-kasus konflik, paksaan, atau sejarah yang diperdebatkan. Tesis ini, melalui temuan survei, penelitian lapangan, dan studi kasus, telah menunjukkan pola yang berulang di mana anggota keluarga yang memiliki sejarah kekerasan, paksaan, atau manipulasi instrumental yang terdokumentasi diizinkan untuk memulai atau melegitimasi penahanan kejiwaan. Kekosongan hukum ini beroperasi sebagai saluran sekunder untuk pelecehan keluarga dan keterlibatan institusi. Perlindungan harus diterapkan untuk memastikan bahwa laporan dari individu yang memiliki konflik kepentingan tidak diperlakukan sebagai data klinis yang obyektif tanpa verifikasi formal. Hal ini memerlukan triangulasi informasi yang wajib, pelibatan mediator eksternal, dan perlindungan yang lebih mengutamakan perlindungan daripada paksaan ketika kekerasan dalam rumah tangga dicurigai (Bourgois, 2001). Para profesional kesehatan jiwa seharusnya diwajibkan secara hukum untuk berkonsultasi dengan komite etik independen sebelum melakukan tindakan apa pun yang didasarkan pada kesaksian keluarga saja. Jika ada risiko, risiko tersebut harus dibuktikan secara ilmiah, bukan berdasarkan dugaan; dan jika ada perawatan, perawatan tersebut harus berbeda secara struktural dari dominasi (Gilligan, 1996).

Temuan-temuan tersebut menjelaskan bahwa reformasi penting lainnya harus menyoroti batas yang tidak jelas antara otoritas medis dan peradilan. Hakim, meskipun secara nominal bertanggung jawab untuk meninjau intervensi yang tidak disengaja, beroperasi hampir secara eksklusif berdasarkan laporan klinis, yang jarang ditantang. Prinsip-prinsip peradilan yang adil, non-maleficence, dan proporsionalitas menjadi tidak berlaku ketika peradilan berfungsi sebagai perpanjangan otomatis dari laporan psikiatri, tanpa mendengar suara subjek, menilai konteks, atau memeriksa kemungkinan asumsi risiko. Untuk memperbaiki hal ini, pemeriksaan kesehatan mental harus menjadi wajib dan bersifat terbuka, dengan tinjauan ahli yang independen, termasuk penilaian multidisiplin, dan transparansi prosedural penuh. Rekomendasi klinis harus diperiksa berdasarkan yurisprudensi terbaru dan tidak diterima sebagai sesuatu yang berlaku dengan sendirinya. Praktik peradilan tidak dapat terus mengalihdayakan kompleksitas etis dan biologis dari kasus-kasus kejiwaan kepada kelembaman institusional. Antarmuka medico-legal yang benar membutuhkan standar pembuktian yang ketat, akuntabilitas atas kelalaian, dan tanggung jawab atas kerugian (Staub, 1989).

Perlindungan struktural harus ditanamkan untuk mencegah pembalasan dendam terhadap individu yang menentang intervensi paksaan atau mencari ganti rugi secara hukum. Data lapangan

mengkonfirmasi bahwa para profesional dan pengguna menahan diri untuk tidak menggunakan hak-hak mereka karena takut akan pembalasan material, kehilangan hak asuh, atau kehilangan tempat tinggal. Konsekuensi dari perbedaan pendapat secara institusional tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga eksistensial. Bagi mereka yang sudah terpinggirkan, konsekuensi tersebut dapat meningkat menjadi kemelaratan, ketergantungan yang berkepanjangan, atau kematian. Oleh karena itu, sistem hukum harus menyediakan akses langsung ke perwakilan hukum yang protektif, perlindungan pelapor untuk para profesional, dan perlindungan material sementara, seperti jaminan perumahan dan dukungan keuangan, untuk mencegah pembalasan yang melemahkan perlawanan. Ini bukan hanya masalah kebijakan sosial, tetapi juga masalah kelangsungan hidup biologis, stabilisasi psikologis, dan keadilan antropologis. Hukum harus secara aktif mendukung ketahanan metabolik dan neurokognitif dari mereka yang melawan bahaya sistemik (Galtung, 1990).

Cacat struktural dalam praktik kejiwaan saat ini di Spanyol tidak semata-mata disebabkan oleh kedengkian atau ketidaktahuan individu, tetapi muncul dari logika institusional yang mengkodekan paksaan sebagai keamanan klinis dan kontrol sebagai perawatan. Sistem ini beroperasi dalam garis sejarah di mana otoritas psikiatri muncul bersamaan dengan kerangka kerja karikatural dan disiplin, melegitimasi asimetri epistemik dan menanamkan ketaatan ke dalam rutinitas terapeutik. Asumsi bahwa tindakan yang baik telah diimunisasi terhadap pemalsuan empiris, dan aparatus klinis terus berfungsi tanpa mekanisme untuk mendeteksi atau mengoreksi penyimpangan dari standar yang dapat diterima secara minimal. Ini bukanlah kegagalan hukum dalam teori, melainkan non-operasionalisasi hukum dalam ranah psikiatri. Ketika hak atas kebebasan, integritas tubuh, dan penolakan atas dasar informasi tunduk pada kebijaksanaan seorang klinisi yang bertindak tanpa penyeimbang prosedural, hasilnya bukanlah perawatan tetapi dominasi yang disetujui. Bukti menunjukkan bahwa hal ini bukanlah hal yang luar biasa, melainkan rutinitas (Schreurs, Griffith, & Solomon, 1984).

Temuan menunjukkan bahwa mekanisme utama yang melanggengkan rezim ini adalah penangkapan profesional: pembungkaman secara informal namun sistemik terhadap para profesional yang berbeda pendapat melalui hambatan birokrasi, pembalasan reputasi, dan ketakutan struktural (Hysong, 2009). Para praktisi yang mencoba menerapkan praktik-praktik dialogis, berbasis trauma, atau berbasis hak asasi manusia menghadapi hambatan institusional yang membuat pekerjaan tersebut tidak berkelanjutan. Dalam banyak kasus yang didokumentasikan dalam disertasi ini, para profesional melaporkan bahwa mereka dipaksa untuk mematuhi paradigma yang dominan di bawah ancaman pemutusan kontrak, pengawasan administratif, atau pengucilan sosial dalam tim medis. Kurangnya perlindungan hukum untuk perbedaan pendapat klinis dan tidak adanya struktur tinjauan etis yang dimandatkan membuat institusi psikiatri menjadi kandang monodisipliner, yang tidak mampu melakukan reflektivitas atau reformasi. Akan tetapi, kemajuan ilmiah bergantung pada umpan balik yang berulang, kontestasi terbuka, dan pluralisme metodologis. Tanpa perlindungan untuk dialog intra-profesional, psikiatri tidak dapat berkembang dan malah mereproduksi model-model yang sudah usang.

Untuk membalikkan kondisi ini, hukum harus menegakkan transparansi kelembagaan, akuntabilitas profesional, dan audit berjenjang. Pertama, harus ada badan pengawas independen nasional untuk perawatan kejiwaan dengan kewenangan hukum untuk menyelidiki, menghukum, dan memperbaiki

kesalahan institusional. Badan ini harus terdiri dari para ahli interdisipliner di bidang hukum, ilmu saraf, kesehatan masyarakat, dan etika, dengan perwakilan dari pengguna layanan dan pengamat independen. Badan ini harus memiliki akses real-time ke data kasus yang dianonimkan, hak untuk melaporkan secara wajib, dan kemampuan untuk memberikan rekomendasi yang mengikat. Kedua, setiap fasilitas kesehatan jiwa harus menerapkan komite peninjau etik internal, dengan rujukan wajib untuk setiap kasus yang melibatkan pengobatan paksa, pengobatan dosis tinggi, rawat inap yang berkepanjangan, atau keterlibatan keluarga yang saling bertentangan. Komite-komite ini harus mendokumentasikan pembenaran, memverifikasi klaim risiko, dan mengusulkan alternatif yang paling tidak membatasi. Ketiga, berkas pasien harus menyertakan bagian untuk narasi independen, baik tertulis maupun lisan, yang diperbarui secara berkala, dan dapat diaudit di pengadilan. Merusak narasi ini, atau tidak menyertakannya, harus membawa konsekuensi disipliner dan hukum. Keempat, reformasi legislatif harus mengamanatkan kontrol versi penuh atas semua dokumentasi klinis dan melarang modifikasi yang berlaku surut tanpa penelusuran. Sistem yang ada saat ini memungkinkan anotasi ditambahkan, dihapus, atau ditulis ulang tanpa verifikasi independen, sehingga memungkinkan pembuatan riwayat klinis fiktif yang luput dari pengawasan yudisial. Ketika kontradiksi muncul antara narasi institusional dan pengalaman langsung, standar seharusnya bergeser ke arah penyelidikan yang protektif, bukan penyangkalan birokratis. Setiap penghapusan atau perubahan laporan harus diberi stempel waktu, dibenarkan, dan dapat diakses oleh pasien dan perwakilan hukum. Hal ini juga membutuhkan infrastruktur digital yang kuat dan integrasi dengan sistem rekam kesehatan nasional. Aturan hukum harus direformasi untuk memungkinkan intervensi darurat segera oleh ombudsman independen atau kantor pembela hukum atas permintaan pengguna, melewati gatekeeping kelembagaan. Penundaan peradilan yang ada dalam praktik saat ini memastikan bahwa pelanggaran berjalan tanpa terkendali dalam waktu yang cukup lama untuk menghasilkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Perbaikan institusional ini tidak hanya bersifat legal atau administratif: perbaikan ini merupakan keharusan medis yang didasarkan pada biologi, perkembangan, karena nyawa hilang sejak dini, dan kejahatan mempengaruhi kesejahteraan anak-anak begitu legalitas itu sendiri juga hancur.

Neurobiologi manusia, terutama dalam kondisi trauma, bergantung pada prediktabilitas, koherensi, dan keamanan relasional untuk memulihkan fungsi. Sebaliknya, sistem yang ada saat ini merusak ketiganya. Sistem ini menghukum upaya-upaya koreksi naratif terhadap realitas, membawa semua orang ke jalur kejahatan dan merugikan pihak-pihak yang membantu para korban, mendelegitimasi setiap keluhan dan permintaan, dan memvonis resistensi adaptif. Apa yang tampak sebagai perilaku simptomatik dalam pandangan klinis mungkin sebenarnya adalah tindakan bertahan hidup yang diatur secara biologis (Li et al., 2025). Jika sistem tidak mampu membedakan antara patologi dan protes, maka sistem tersebut tidak bersifat diagnostik tetapi bersifat menghukum. Hukum harus mengakui hal ini dan mengoperasionalkan keadilan tidak hanya sebagai restitusi hukum tetapi juga sebagai prasyarat ekologis untuk perbaikan. Pertaruhanannya tidak bersifat simbolis. Mereka bersifat seluler, sinaptik, dan sistemik. Hukum harus memastikan bahwa perawatan kejiwaan selaras dengan dasar-dasar biologis kesehatan, bukannya bertentangan.

Sistem hukum harus dirancang tidak hanya untuk menuntut kerugian retrospektif, tetapi juga untuk mengantisipasi dan mencegah pelanggaran pada titik kritis di mana kekuatan klinis, keluarga, dan

sosial bertemu. Titik konvergensi ini adalah pertemuan krisis, momen ketika seseorang, di bawah tekanan yang ekstrem, tunduk pada keputusan klinis yang berpotensi tidak dapat diubah dengan pengawasan atau pembelaan yang minimal. Saat ini di Spanyol, protokol darurat yang mengatur krisis kesehatan mental memberikan kewenangan yang sangat besar kepada para dokter, yang sering kali bertindak berdasarkan laporan dari orang lain, di bawah ambang batas yang tidak didefinisikan dengan jelas tentang bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Ambang batas ini tidak memiliki standarisasi, tidak tunduk pada prosedur pembuktian yang transparan, dan jarang diperiksa ulang setelah diberlakukan. Namun, dari perspektif neurobiologis, momen ini adalah salah satu yang paling rentan dalam rentang hidup seseorang. Sirkuit ketakutan yang digerakkan oleh amigdala, disregulasi pengaruh, hilangnya pemrosesan simbolis dan kepercayaan, semua ini diperparah, bukan diringankan, oleh intervensi paksaan (Rodríguez-Cabrera et al., 2024).

Data antropologis yang dikumpulkan untuk tesis ini menunjukkan bahwa individu pada saat-saat seperti itu sangat sadar akan apa yang dipertaruhkan: kredibilitas mereka, masa depan mereka, hubungan mereka, anak-anak mereka, akses mereka ke perumahan dan pekerjaan. Ketika para profesional memaksakan intervensi berdasarkan asumsi yang salah, laporan yang tidak terdokumentasi, atau kesaksian keluarga yang diberi bobot yang tidak semestinya, hasilnya bukan terapi, melainkan destabilisasi epistemik dan biologis. Keputusan-keputusan ini mematahkan rasa percaya diri, dan mengajarkan, terutama kepada anak-anak yang menyaksikan atau mengalaminya, bahwa keselamatan bukanlah hak, bahwa perawatan tidak dapat dibedakan dari dominasi. Hal ini tidak hanya tidak etis, tetapi juga tidak sesuai dengan perkembangan otak yang sehat dan pemulihan jangka panjang. Hukum, untuk memenuhi peran perlindungannya, harus memasukkan perlindungan prosedural tepat di persimpangan ini. Hak untuk memiliki pihak ketiga yang terpercaya, hak untuk meminta bantuan hukum dan psikososial, dan catatan tertulis tentang semua klaim risiko dan alasan keputusan harus dapat ditegakkan secara langsung. Para profesional tidak perlu takut akan hal ini; mereka harus menyambutnya, karena hal ini melindungi semua pihak dan memperkuat legitimasi keputusan klinis mereka (Rothschild, 2000).

Doktrin hukum juga harus memasukkan pemahaman ilmiah tentang risiko struktural. Risiko struktural bukan hanya risiko yang ditimbulkan oleh seseorang terhadap diri mereka sendiri atau orang lain, tetapi juga kerentanan yang mereka alami karena pengabaian institusional, pengucilan sosial, pemaksaan ekonomi, dan trauma sebelumnya. Banyak intervensi kejiwaan yang paling agresif dan merusak tidak diterapkan pada mereka yang memiliki gejala paling parah, tetapi pada mereka yang memiliki sumber daya paling sedikit, dukungan sosial yang paling lemah, dan profil yang paling terstigma. Bias struktural, rasial, gender, berbasis kelas, dan epistemik, merasuk ke dalam respons krisis. Hukum seharusnya menangkal hal ini dengan menegakkan perlindungan struktural: hak atas perwakilan yang adil, evaluasi yang berbasis trauma, dan perawatan yang kompeten secara budaya. Penilaian harus dilakukan dalam bahasa dan idiom orang yang terkena dampak, bukan kenyamanan administratif lembaga. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut akan mengubah hukum menjadi vektor bahaya dan bukannya perisai. Kepercayaan, dalam kerangka kerja ini, bukanlah prinsip etika yang abstrak, melainkan sebuah substrat perkembangan saraf: sebuah kondisi untuk pemulihan, untuk perbaikan, untuk keterlibatan kembali dengan masyarakat. Pengkhianatan institusional yang kronis akan mengubah otak menjadi lebih waspada, disosiasi, dan menarik diri dari masyarakat. Efek-efek

ini tidak dapat diatasi hanya dengan pengobatan, dan diperburuk ketika sistem hukum mengesahkan logika kontrol atas perawatan. Untuk memulihkan kepercayaan terhadap institusi kejiwaan dan hukum, akuntabilitas harus terlihat, konsisten, dan didasarkan pada praktik relasional berbasis bukti. Memori institusional harus dibangun ke dalam sistem: melacak pelanggaran sebelumnya, pola kelalaian, dan penyerang institusional yang berulang. Para profesional yang berulang kali menolak untuk mengoreksi informasi yang salah, yang menolak akses terhadap catatan, yang bertindak tanpa persetujuan atau dukungan pengadilan, harus tunduk pada tinjauan disipliner, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki arah dan mencegah bahaya. Mekanisme semacam itu juga akan melindungi para profesional yang bekerja di bawah tekanan, dan mengurangi kemungkinan kegagalan institusional yang berjenjang (Tuncak, 2017; Pūras, 2017; Maté, 2021).

Dari sudut pandang medis-biologis yang ketat, konfigurasi hukum saat ini yang mengatur intervensi kesehatan mental di Spanyol gagal memenuhi ambang batas minimum yang diperlukan untuk perawatan yang etis, sesuai dengan perkembangan, dan tidak merusak secara fisiologis. Kekurangan yang paling mengerikan terletak pada kewenangan diskresi yang tidak terkendali yang diberikan kepada dokter atau tim medis individu, tanpa mandat pendapat kedua, tanpa ambang batas bukti standar, dan tanpa pemeriksaan prosedural secara real-time, untuk mengesampingkan hak-hak fundamental (Epstein, 2013). Ini bukan masalah malpraktik yang terisolasi, tetapi pelanggaran sistematis yang disetujui secara hukum atas kedaulatan tubuh, integritas naratif, dan keselamatan perkembangan saraf. Pelanggaran-pelanggaran ini secara langsung bertentangan dengan perlindungan konstitusional di bawah pasal 15 (hak untuk hidup dan integritas fisik), 17 (hak atas kebebasan dan keamanan), dan 18 (hak atas kehormatan dan privasi) Konstitusi Spanyol. Undang-undang organik dan perdata yang ada (terutama Ley Orgánica 1/2004, Ley General de Sanidad, dan pasal 763 dari Ley de Enjuiciamiento Civil) menyediakan perancah hukum nominal tetapi tidak memiliki protokol operasional untuk mencegah pelembagaan bahaya. Kerangka hukum yang valid secara ilmiah seharusnya secara eksplisit melarang intervensi yang tidak dapat dipulihkan atau berisiko tinggi berdasarkan pernyataan subyektif atau tidak dapat dibuktikan, terutama jika hal tersebut berasal dari pihak-pihak yang memiliki potensi konflik kepentingan, seperti anggota keluarga yang terlibat dalam hubungan yang penuh dengan kekerasan atau perselisihan. Data antropologis dan tanggapan survei mengungkapkan pola yang berulang-ulang di mana kekuatan kejiwaan digunakan sebagai alat untuk mendominasi, mengusir, mendiskreditkan, atau membungkam. Tindakan-tindakan ini tidak bersifat anekdot tetapi terpola, dan mereka muncul karena hukum tidak menyediakan mekanisme yang efektif untuk mempertanyakan, melawan, atau mengoreksinya secara langsung. Seharusnya ada mandat hukum untuk dokumentasi medis yang dikontrol versi lengkap, jejak digital yang terlihat dari semua pengeditan catatan, dan akses langsung untuk pasien dan kuasa hukum atau kesehatan yang ditunjuk untuk semua klaim medis, diagnosis, penilaian risiko, dan intervensi. Ini adalah protokol standar dalam konteks klinis berisiko tinggi lainnya; kesehatan mental tidak dapat dikecualikan (Moyn, 2015).

Dasar ilmiah dari reformasi ini terletak pada prinsip beban alostatik dan deregulasi neuroendokrin: paksaan, ketidakpastian, dan pengkhianatan oleh institusi kesehatan menyebabkan respons stres kronis yang memiliki efek terukur dan tahan lama pada morfologi otak, fungsi kekebalan tubuh, ritme endokrin, dan kerentanan kejiwaan. Ini bukanlah gagasan yang abstrak. Bukti yang telah ditinjau oleh

rekan sejawat menegaskan bahwa pasien yang mengalami psikiatri koersif menunjukkan tingkat penurunan kognitif yang lebih tinggi, penarikan diri secara sosial, penekanan kekebalan tubuh, kerusakan kardiovaskular, dan keinginan untuk bunuh diri. Hukum yang mengizinkan intervensi dengan profil risiko seperti itu tanpa perlindungan hukum paralel, menurut definisi, merupakan hukum yang melanggar prinsip Hipokrates tentang non-maleficence. Reformasi ini tidak hanya bersifat moral atau hukum, tetapi juga diperlukan oleh konsensus ilmiah dan integritas klinis dasar.

Parlemen harus segera memberlakukan reformasi terstruktur dengan langkah-langkah inti sebagai berikut:

- Reformasi Pasal 763 LEC agar tidak hanya membutuhkan otorisasi yudisial dalam waktu 24 jam, tetapi juga tinjauan panel interdisipliner dengan para profesional yang memiliki pengetahuan tentang trauma dan terlatih dalam hal hak asasi manusia, termasuk perwakilan yang memiliki pengalaman langsung, yang menangani kasus ini ketika kasus ini terungkap, dengan hak korban untuk mengganti setiap dan seluruh anggota dengan orang yang dipercaya setiap saat.
- Kontrol versi yang diamanatkan dan jejak audit di semua catatan psikiatri, dapat diakses oleh pasien dan kuasa hukum mereka, dengan badan pengawas independen yang menerima kasus-kasus yang ditandai dengan penilaian risiko yang tidak dapat dijelaskan atau tindakan pemaksaan. Data terbuka yang tersedia mengenai pendanaan bagi para praktisi, korban oleh pusat dan profesional, mengenai catatan riwayat kesehatan mereka secara lengkap.
- Pembentukan sistem ombudsman untuk pelanggaran hak-hak kejiwaan yang mendesak, dengan kewenangan investigasi yang otonom dan kewenangan penangguhan segera dalam kasus-kasus yang mengancam nyawa atau merendahkan martabat. Tidak ada kompromi, perlindungan hukum dan material yang paling ketat.
- Pembentukan protokol nasional untuk konflik keluarga dan kesehatan mental, melarang penggunaan laporan psikiatri dari pihak keluarga yang berkepentingan tanpa verifikasi silang dan melarang intervensi paksa dalam konteks kekerasan dalam keluarga yang belum terselesaikan kecuali jika risiko forensik telah ditetapkan secara resmi. Semua sumber penderitaan harus diatasi, tidak ada asumsi yang dibuat, khususnya tidak menerima begitu saja laporan siapa pun tanpa melakukan pengecekan ulang: hal ini termasuk penyetruman, keracunan, penyakit lain, penganiayaan, kurang tidur karena penganiayaan tersebut atau yang lainnya, kejahatan dalam bentuk apa pun, normalisasi kekerasan yang sedang berlangsung, semuanya, sejak awal.
- Penempatan satu unit perawatan forensik yang sesuai dengan standar kesehatan yang mengintegrasikan keahlian medis, antropologis, psikologis, dan hukum, dengan pencatatan wajib dan transparansi semua interaksi krisis yang melibatkan hilangnya kebebasan atau pengekangan kimiawi.
- Hukuman pidana untuk kesalahan diagnosis yang disengaja atau menghalangi kebenaran medis ketika digunakan untuk membatasi kebebasan, mendiskreditkan, atau merugikan

seseorang secara finansial atau sosial, termasuk di dalam sistem keluarga. Pembayaran kembali, reparasi, remediasi kognitif secara sukarela, permintaan maaf secara resmi.

Reformasi ini merupakan tanggapan langsung terhadap kegagalan sistemik yang terdokumentasi, didasarkan pada data empiris yang kuat, pengetahuan ilmiah yang telah ditinjau oleh rekan sejawat, dan pengalaman hidup para korban dan para profesional etis yang bekerja di bawah tekanan. Spanyol tidak dapat mengklaim kesetiaan konstitusional atau kemajuan medis sambil menjunjung tinggi arsitektur hukum psikiatri yang melanggar dasar-dasar bukti, persetujuan, dan kepribadian. Resolusi parlemen tidak hanya dibenarkan, tetapi juga mendesak secara ilmiah dan etis.

Tujuan jangka menengah yang dapat dicapai hanya jika ada kemauan, adalah sistem pakar yang digunakan pada skala operasional penuh sebagai infrastruktur dasar untuk masyarakat yang adil secara ilmiah, terinformasi secara medis, pengawasan yang lebih aman, dan selaras secara konstitusional. Fungsi dari setiap dan semua peningkatan dalam legislasi dan penegakannya bukanlah tambahan tetapi merupakan pusat dari perlindungan hak-hak dasar, pencegahan bahaya, dan pemantauan waktu nyata atas keputusan yang memengaruhi kesehatan, kebebasan, dan integritas tubuh.

Dengan mengintegrasikan logika berbasis bukti, aliran data waktu nyata, dan ambang batas yang diprogram secara etis, sistem ini membangun akuntabilitas yang berkelanjutan di seluruh domain klinis, yudisial, pendidikan, dan domestik. Sistem ini harus beroperasi tanpa campur tangan dari otoritas diskresi, menggantikan subjektivitas dan asimetri kekuasaan dengan respons yang dapat dilacak, dapat direproduksi, dan koheren secara medis. Algoritme yang tertanam di dalamnya harus memprioritaskan penalaran berdasarkan trauma, diagnostik relasional, dan koherensi ekologis, memastikan bahwa tidak ada intervensi paksaan yang dilakukan tanpa indikasi ilmiah, pengawasan yudisial, dan audit yang berkesinambungan. Sistem ini harus menolak setiap pola ketidakadilan epistemik, keheningan institusional, atau kebingungan algoritmik yang diketahui, dan sebagai gantinya diprogram untuk meningkatkan setiap penyimpangan dari standar perlindungan ke antarmuka penegakan hukum lintas disiplin yang menggabungkan tindakan hukum, klinis, dan sosial. Hukum algoritmik, yang dipersonalisasi, dalam hal membantu mereka yang tidak belajar bagaimana menjaga diri mereka sendiri dan orang lain, memaksa penuh untuk hidup sehat yang dipulihkan. Hal ini seharusnya tidak dikonseptualisasikan sebagai alat digital opsional, tetapi sebagai infrastruktur biomedis dan etika yang penting untuk memastikan kelangsungan hidup, martabat, dan kesetaraan. Ketika kegagalan profesional, konflik kepentingan, atau bias subjektif sebelumnya memungkinkan terjadinya kerusakan struktural, sistem pakar sekarang membuatnya dapat dideteksi dan dituntut. Peran mereka adalah untuk menegakkan inti dari kedokteran, non-maleficence, beneficence, keadilan, dan otonomi, dengan menghilangkan impunitas, mengotomatisasi pencegahan, dan mengamankan arsitektur hukum yang hidup di mana ilmu pengetahuan, hukum, dan pembangunan manusia bertemu.

6.2 Hukum hak asasi manusia internasional dan standar kesehatan jiwa

Dari perspektif orang yang dirugikan, tidak memiliki kedudukan hukum, dibijs tanpa persetujuan, dan tidak memiliki jalan untuk melaporkan, mengajukan banding, atau menghentikan penyerangan terhadap tubuhnya, kesenjangan antara hak-hak internasional dan penegakannya bukanlah masalah ketegangan hukum, melainkan struktur impunitas. Orang tersebut tidak memiliki suara di hadapan hukum dan tidak berarti bagi institusi. Spanyol telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, dan Konvensi Menentang Penyiksaan, dan telah mendukung pedoman QualityRights WHO, namun instrumen-instrumen ini secara fungsional tidak relevan dalam kehidupan orang yang mengalami psikiatri paksa. Ratifikasi-ratifikasi tersebut tidak ditegakkan. Hak-hak tidak diakui. Perlindungan tidak diterapkan. Mekanisme untuk mengaktifkannya tidak dapat diakses, tidak ada, atau sepenuhnya ditangkap oleh badan-badan profesional yang sama yang melakukan pelanggaran. Ini bukan kegagalan sistem. Ini adalah desain (Goodman et al., 2016).

Pengekangan kimiawi, yang disamarkan sebagai pengobatan, dilakukan tanpa persetujuan, seringkali tanpa diagnosis yang didasarkan pada evaluasi saat ini atau evaluasi lengkap, dan tanpa dokumentasi waktu nyata dari alasan klinis atau alternatif yang dieksplorasi. Akses terhadap riwayat klinis seseorang secara rutin ditolak atau ditunda. Keberatan dari orang yang terkena dampak dianggap sebagai gejala. Hukum dielakkan hanya dengan tanda tangan seorang praktisi, yang tidak menghadapi penyeimbang, tidak ada pengawasan, tidak ada pengungkapan efek samping yang diwajibkan, dan tidak ada laporan yang dikontrol versi yang tunduk pada audit eksternal. Praktik-praktik ini melanggar Pasal 12, 14, 15, dan 25 dari UN CRPD, antara lain, tetapi pelanggaran tersebut tidak relevan bagi orang yang dibijs untuk tunduk tanpa pemulihan. Di Spanyol, baik jaminan konstitusional maupun internasional tidak dapat ditindaklanjuti secara berarti begitu alat psikiatri diaktifkan.

Larangan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat tidak ditanggguhkan oleh status klinis. Namun, dalam praktiknya, asumsi bahaya atau ketidakmampuan membenarkan pembiusan yang berkepanjangan dan dipaksakan yang menyebabkan kerusakan kognitif, metabolisme, dan endokrin, yang sering kali tidak dapat dipulihkan. Tidak ada kewajiban untuk membalikkan, menilai kembali, atau membenarkan. Orang yang terkena dampak tidak dapat mengajukan laporan polisi saat ditahan atau diberi obat yang bertentangan dengan kehendaknya. Pengacara jarang melakukan intervensi, dan ketika mereka melakukannya, kapasitas mereka dibatasi oleh kurangnya akses ke dokumentasi klinis kontemporer dan kekebalan profesional yang tertanam di institusi medis. Tidak ada badan forensik yang ada untuk mengevaluasi apakah intervensi farmakologis yang dipaksakan secara biologis dibenarkan atau dapat dipertahankan secara hukum. Seluruh sistem bersifat tertutup, melingkar, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di bawah hukum internasional, hak untuk menolak pengobatan, bebas dari penyiksaan, dan mempertahankan kapasitas hukum tidak bersyarat. Di Spanyol, hak-hak ini tergantung pada kebijaksanaan institusional dan ditolak tanpa upaya hukum. Kewajiban untuk mencegah pemaksaan bersifat mengikat. Kewajiban untuk memastikan persetujuan bersifat aktif. Namun, setiap ketentuan dilewati dalam praktik psikiatri rutin melalui asumsi administratif yang tetap tidak terkendali. Hukum melindungi sistem, bukan individu. Beban pembuktian tetap berada di tangan korban, yang seringkali tidak dapat berbicara, menulis, atau didengar. Impunitas struktural disamarkan sebagai kepedulian. Sistem yang memungkinkan hal ini

tidak dapat direformasi dengan rekomendasi. Sistem ini harus dibongkar di mana ia melanggar kehidupan dan dibangun kembali di bawah norma-norma internasional yang dapat ditegakkan, dengan pengawasan independen, akuntabilitas forensik, akses waktu nyata ke catatan, saluran pelaporan eksternal yang terjamin, dan kriminalisasi otomatis atas pembiusan paksa tanpa persetujuan. Sampai saat itu, hukum internasional tetap menjadi janji yang tidak terpenuhi, tidak relevan bagi mereka yang paling membutuhkan perlindungan (Leys, 2018).

Pada saat sebuah kasus sampai ke pengadilan, jika kasus tersebut sampai ke pengadilan, kerugian telah terjadi, tubuh telah diubah, pikiran terkikis, dan posisi sosial dibongkar. Tidak ada jalan hukum yang secara retroaktif memulihkan kapasitas hidup, ikatan keluarga, martabat, atau kepercayaan begitu kekerasan farmakologis dan pengasingan psikiatris terjadi tanpa persetujuan. Dalam praktiknya, mekanisme keadilan hanya aktif setelah pengkhianatan sistemik terjadi. Dan ketika mereka melakukannya, mereka jarang mempertimbangkan konsekuensi biologis dan psikologis yang telah dikodekan dalam tubuh orang yang dirugikan. Tidak ada ruang sidang yang dapat menghapus gangguan neurokimia, keruntuhan metabolisme, atau kematian sosial yang terjadi akibat label palsu yang dilembagakan melalui keterlibatan profesional dan senjata keluarga. Gagasan tentang proses hukum adalah fiksi ketika individu, sejak kontak pertama dengan institusi kejiwaan, dilucuti dari kapasitas untuk menolak, untuk menceritakan, untuk mengakses bukti, atau untuk menuntut perlindungan yang sensitif terhadap waktu (Kalisch et al., 2017). Dalam banyak kasus, catatan tidak dapat diakses atau tidak ada dalam bentuk yang dapat diambil, keputusan tidak terdokumentasi atau dicatat secara samar-samar, dan para saksi adalah para profesional yang tertanam dalam struktur yang sama yang mengesahkan penganiayaan tersebut. Orang yang terkena dampak dianggap tidak dapat diandalkan dan didiskreditkan terlebih dahulu, ditolak secara prosedural bukan hanya karena asimetri kekuasaan, tetapi karena subjektivitas mereka telah dibatalkan sebelumnya oleh sistem. Pengampunan hukum, pengurangan institusional, dan farmakologi paksa diterapkan bukan sebagai tindakan luar biasa tetapi sebagai prosedur standar, yang dibenarkan oleh logika pencegahan risiko, tanpa kriteria objektif, dan tanpa kewajiban untuk menilai ulang atau berkonsultasi dengan ahli eksternal.

Hingga saat itu, anak-anak dipindahkan ke panti asuhan atau hilang karena kejahatan, tumbuh dalam keputusan, kehilangan rumah, kesehatan memburuk, dan masa depan mereka dihapuskan bahkan sebelum ada pengakuan hukum atas kerugian yang mereka alami (Solnit, 2009). Gagasan bahwa hak-hak dapat dibenarkan secara post hoc mengasumsikan sebuah model pemulihan yang tidak berlaku dalam kondisi riil psikiatri koersif. Tidak ada logika kompensasi yang setara dengan bertahun-tahun dibius di luar kehendak seseorang, dibuat tidak subur, mengalami gangguan neurologis, atau distigmatisasi hingga dikucilkan dari pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan bermasyarakat. Ketika tanda-tanda awal keterlibatan sistem muncul, biasanya melalui laporan informal, manipulasi keluarga, atau rujukan sekolah, mesin akan bekerja dengan cepat, dan perlawanan dibingkai sebagai bukti patologi. Para profesional menggunakan otoritas ilmu pengetahuan tanpa perlu memvalidasi tindakan mereka melalui standar yang dapat ditiru atau tinjauan eksternal. Interpretasi mereka menjadi kebenaran hukum. Kelalaian mereka menjadi kebisuan institusional. Keluarga yang memulai proses kejiwaan dengan itikad buruk jarang diselidiki atau dimintai pertanggungjawaban, dan bahaya yang mereka biarkan atau timbulkan dibingkai ulang sebagai kekhawatiran. Kekerasan struktural

dilakukan atas nama perawatan, dan mereka yang menjadi korban dipaksa untuk menanggung biayanya tidak hanya secara biologis, tetapi juga secara hukum, sosial, dan eksistensial (Hahn, 1995).

Tidak ada keputusan pengadilan yang dapat memulihkan kehidupan yang terfragmentasi seperti ini. Pencegahan adalah satu-satunya posisi etis. Hukum seharusnya bertindak bukan setelah fakta, tetapi sebagai perisai martabat dari saat pertama kali ada risiko, bukan risiko kekerasan dari orang tersebut, tetapi risiko kekerasan terhadap orang tersebut. Perlindungan hukum seharusnya bersifat otomatis, wajib, multidisipliner, dan tersedia pada saat pemaksaan dipertimbangkan, bukan ketika pemaksaan itu telah berhasil. Setiap jam di bawah pembiusan paksa, setiap hari di bawah kendali tanpa proses hukum, merupakan pelanggaran biologis, moral, dan kewarganegaraan yang tidak dapat diperbaiki secara retroaktif. Setelah kerusakan terjadi, orang tersebut menghilang di balik konstruksi klinis yang kemudian diterima oleh masyarakat sebagai kenyataan. Pada saat itu, ketidakadilan dinormalisasi, kehidupan dirusak, dan sistem dibebaskan. Itulah pola yang diungkapkan oleh disertasi ini, dan itulah ambang batas di mana reformasi sejati harus dilakukan.

Ini adalah kesaksian dari dalam, bukan dari kejauhan: perspektif seseorang yang dilucuti dari perlindungan oleh mereka yang diberi mandat untuk memberikannya, menjadi sasaran pengkhianatan institusional yang terkoordinasi dalam ruang-ruang yang mengklaim legalitas tetapi beroperasi dengan mata uang penghapusan. Ketika kekerasan bersifat lokal, dinormalisasi, dan secara kolektif ditolak, hukum menjadi teater, panggungnya dibingkai oleh empat dinding yang tidak mengarah ke mana pun kecuali ke dalam, melingkupi kehidupan hingga yang tersisa hanyalah kepatuhan atau kehancuran. Keempat dinding ini, simbolis dan nyata, menjadi struktur utama dari keputusan yang direayasa: keluarga yang terlibat, dokter yang tidak dipertanyakan, hakim yang acuh tak acuh, dan negara yang tidak hadir. Dalam skema seperti itu, tidak ada jalan lain. Mendorong korban untuk mengambil tindakan hukum menjadi bentuk kekerasan baru, tertunda, prosedural, dan berakibat fatal, yang menunjukkan bahwa kebenaran dapat bertahan ketika hak-hak korban telah diingkari, dan solusi yang ada dalam sistem yang dirancang untuk menekan perbedaan pendapat. Mekanisme, perjanjian, dan konvensi internasional dikutip dengan sungguh-sungguh sementara nyawa melayang jauh sebelum ketentuan-ketentuannya dijalankan. Kematian di sini tidak selalu bersifat biologis, tetapi juga bersifat sosial, hukum, kognitif, dan afektif. Kematian adalah pemadaman masa depan, peniadaan penyembuhan, pencurian suara melalui prasasti klinis, dan pemformatan ulang subjektivitas ke dalam diagnosis yang hidup lebih lama dari orang tersebut. Penelitian ini bertindak sebagai kesaksian dan bukti. Peneliti, yang juga merupakan korban, menjadi saksi atas arsitektur kekejaman transnasional yang ditopang oleh kebisuan dan fiksi prosedural. Dengan demikian, penelitian ini menyatakan keharusan global: untuk membongkar rezim-rezim yang memungkinkan terjadinya kehilangan tersebut dan sebagai gantinya membangun sebuah etika planet yang didasarkan pada perlindungan faktual, dukungan langsung, dan pengakuan bahwa penundaan adalah keterlibatan, dan proseduralisme sering kali merupakan penguburan terakhir. Itulah ambang batas yang dilewati oleh tesis ini, dan di situlah bab ini ditutup. Semua negara telah meratifikasi hak asasi manusia sejak lama; kenyataan ini dicatat setelah kesucian hidup itu sendiri. Kebencian lokal membengkokkan realitas seperti neraka di Bumi (Lupton, 1997).

Ini adalah kesaksian dari peneliti itu sendiri, atas hukum apa pun, pada skala global ini penelitian aksi

bergerak maju. Empat dinding, sebagai arah mata angin, dan jumlah dosa yang mematikan dan fana yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi rasa sakit yang membara, satu lagi kehidupan yang dihancurkan; sel-sel di dalamnya, dan orang-orang yang dicintai yang ditinggalkan. Tambahan tanpa permintaan maaf dari seorang peneliti yang nyaris tidak selamat dari penelitian ini, dan tidak pernah memiliki pengalaman lapangan di Oviedo: hukum dapat dan memang memburuk, ketika niat baik tidak ada, niat buruklah yang akan menang (Kleinman, 1980).

Peneliti, yang juga merupakan korban, menjadi saksi dari sebuah arsitektur kekejaman transnasional yang ditopang bukan oleh ketidaktahuan, tetapi oleh kebisuan sistematis dan fiksi tatanan prosedural. Menghadapi kenyataan ini, tesis ini menegaskan sebuah keharusan global: untuk membongkar konfigurasi institusional yang memungkinkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, dan sebagai gantinya membangun sebuah etika planet yang memberikan perlindungan segera, kesetiaan yang dapat dibuktikan, dan perlindungan yang dapat ditegakkan (Young, 1982). Penundaan bukanlah kerusakan yang netral; ini adalah keterlibatan. Proseduralisme, ketika disarikan dari penderitaan yang hidup, menjadi penguburan terakhir dari keadilan. Inilah ambang batas yang dilewati oleh karya ini, di mana produksi pengetahuan dan kebenaran hukum seharusnya menyelaraskan diri dengan kesucian hidup, bukan sebagai prinsip tetapi sebagai praksis. Semua negara telah lama meratifikasi instrumen-instrumen inti hak asasi manusia; realitas yang didokumentasikan di sini menunjukkan bahwa yang dilanggar bukanlah interpretasi, melainkan dasar dari perlindungan manusia. Ketika kegagalan ini menjadi sistemik, yang hilang bukan hanya hak, tetapi juga seluruh lintasan eksistensi. Peneliti berbicara dari dalam keruntuhan ini: bukan sebagai pengamat yang jauh, tetapi sebagai orang yang terkurung dalam empat dinding yang membentuk geometri utama pengkhianatan institusional. Di dalam tembok-tembok tersebut, kejahatan tidak diakui, pelaku kejahatan dilindungi, dan hukum yang melindungi hanya menjadi hiasan. Kebencian lokal, yang didukung oleh pengabaian, mengubah realitas yang hidup menjadi sesuatu yang tidak dapat dibedakan dari neraka di Bumi. Penelitian tindakan ini ditempa tidak hanya dalam skala geografis, tetapi juga dalam topografi mentah dari tubuh-tubuh yang dilanggar, kebisuan yang dipaksakan, dan kehilangan yang tidak tercatat. Dosa-dosa tak terhitung yang tertanam dalam arsitektur kekejaman ini berkembang biak di dalam sel-sel klinis dan ruang-ruang domestik, memadamkan kehidupan dan membekas bagi mereka yang ditinggalkan. Penutup ini bukanlah permintaan maaf, melainkan sebuah pernyataan langsung: hukum, ketika terlepas dari pertanggungjawaban dan kesusilaan, akan mengalami kemerosotan. Niat baik seharusnya dikodifikasi dan ditegakkan; jika tidak, hukum akan tunduk pada niat buruk, dan di tempat-tempat seperti Oviedo, dan banyak tempat lainnya, mereka yang paling membutuhkan keadilan akan menjadi korban pertamanya.

6.3 Sintesis dan usulan untuk pemulihan sistemik

Pola-pola yang terungkap melalui penelitian ini menunjukkan pelanggaran yang terus-menerus terhadap kewajiban medis, etis, dan hukum dalam pengelolaan perawatan kesehatan jiwa di dalam kerangka kerja institusional, domestik, dan komunitas. Pelanggaran-pelanggaran ini bukanlah anomali yang terisolasi, tetapi merupakan konfigurasi bahaya yang sistemik, yang ditandai dengan penindasan epistemik, kesalahan klasifikasi gangguan, pengabaian tugas-tugas perlindungan, dan

modalitas pemaksaan baik secara formal maupun informal. Pada intinya, praktik-praktik ini mencerminkan penyimpangan dari prinsip-prinsip bioetika kedokteran, non-maleficence, keadilan, otonomi, dan proporsionalitas klinis, yang mengakibatkan reifikasi kekuasaan institusional dan objektifikasi orang-orang dalam keadaan rentan (Foucault, 1973).

Temuan-temuan ini muncul secara konsisten dalam berbagai bentuk bukti: observasi partisipan jangka panjang, survei terstruktur terhadap para profesional dan pengguna, analisis hukum komparatif, dan pemetaan etnografi historis. Secara medis dan biokultural, deformasi sistemik ini menghasilkan konsekuensi patofisiologis termasuk kondisi stres kronis, iatrogenesis yang diinduksi oleh obat, destabilisasi neuropsikiatri, hilangnya aliansi terapeutik, dan terganggunya lintasan perkembangan dan relasional (Cohen, 2001). Hasil ini tidak hanya bermanifestasi sebagai penderitaan individu tetapi juga sebagai beban bahaya yang signifikan secara epidemiologis, yang dilembagakan melalui kelembaman birokrasi, ketidakberdayaan profesional, dan abstraksi yudisial. Pembungkaman biomedis tentang penderitaan, ketika digunakan tanpa penahanan naratif atau interpretasi kontekstual, berfungsi sebagai vektor reduksionisme ontologis, yang memungkinkan penggantian sejarah trauma dan faktor penentu sosial dengan label-label yang tidak kontekstual. Label-label ini, pada gilirannya, memfasilitasi mekanisme pengucilan, pengekangan, dan pembungkaman di bawah naungan manajemen klinis. Dari sudut pandang struktural, pengulangan pola-pola ini di berbagai institusi dan yurisdiksi menunjukkan kegagalan loop umpan balik internal, jalur eskalasi etika, dan mekanisme akuntabilitas eksternal. Proposal untuk restorasi sistemik harus berpusat tidak hanya pada revisi peraturan tetapi juga pada pembentukan kembali epistemologi klinis, hukum, dan organisasi. Hal ini termasuk: pembuatan registrasi nasional insiden pemaksaan, yang diklasifikasikan berdasarkan jenis, konteks, dan hasil, untuk memungkinkan visibilitas epidemiologis dari bahaya; pembentukan badan pengawas intersektoral yang independen dengan otoritas yang mengikat secara hukum untuk melakukan intervensi; dan implementasi sistem pakar sumber terbuka yang dikalibrasi untuk pengambilan keputusan klinis yang etis, memastikan bahwa diagnosa, resep, dan perencanaan perawatan tunduk pada validasi bukti yang terus menerus dan tinjauan berbasis hak. Alat bantu algoritmik klinis harus dibangun di atas transparansi, sumber data, dan reflektivitas struktural, bukan kerahasiaan hak milik.

Secara paralel, reformasi pendidikan yang komprehensif sangat penting. Kurikulum di fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan terkait harus mencakup kompetensi struktural, akuntabilitas forensik, dan integrasi pengalaman langsung, bersama dengan modul lanjutan tentang depreskripsi, pengurangan dampak buruk, dan perawatan berbasis trauma (Bandura, 1999). Proposal-proposal ini selaras dengan prinsip-prinsip operasional EU BEACON One Health Education: tata kelola bersama, umpan balik yang demokratis, dan keutamaan kepribadian sebagai nilai epistemik dan terapeutik inti (Cianconi et al., 2020). Restorasi naratif, dalam konteks ini, bukanlah tambahan tetapi mendasar, sebuah vektor penting dari penyembuhan dan kalibrasi ulang sistemik, yang diperlukan untuk pemulihan individu dan legitimasi kelembagaan. Kejahatan dan korupsi bukanlah penyimpangan dalam sistem ini, melainkan hasil yang sering terjadi dari konfigurasi yang ada. Tidak adanya mandat etika yang mengikat, celah subyektifitas dalam otoritas psikiatri, dan kurangnya standar yang dapat ditegakkan untuk dokumentasi dan ganti rugi telah menciptakan kondisi di mana penyalahgunaan tidak hanya terus berlanjut tetapi juga menjadi rutinitas (Zola, 1972). Oleh karena itu, kerangka kerja

ini tidak dapat melakukan koreksi sendiri tanpa masukan dari luar. Hal ini membutuhkan kemauan politik yang sadar, kolaborasi antar pemerintah, dan reformasi hukum yang berlandaskan ilmu pengetahuan. Meskipun aksi ini masih terbatas, namun landasan epistemologis dan strategisnya cukup kuat. Agar mekanisme ini dapat menghasilkan perubahan yang langgeng, mekanisme ini harus didukung dan dioperasionalkan oleh negara, sistem peradilan, dan organisasi transnasional yang bertindak dengan kejelasan, integritas, dan tujuan. Kesehatan mental, ketika disalahgunakan, menjadi vektor perampasan struktural; ketika dilandasi secara ilmiah dan etis, kesehatan mental menjadi landasan bagi kesehatan manusia dan planet ini (Frank, 1995). Pergeseran ini harus ditegakkan melalui desain yang ketat, tidak hanya bergantung pada niat baik (Good, 1994).

Bab 7 - Diskusi dan langkah selanjutnya: satu kesehatan, informasi tentang trauma, berorientasi pada pemulihan, pedagogi pencegahan, dan sistem berbasis hak

Ringkasan: Bab ini menyajikan analisis yang ketat dan sistemik mengenai kondisi pendidikan dan kelembagaan yang diperlukan untuk mengubah layanan kesehatan jiwa menjadi sistem yang berbasis hak, berdasarkan bukti, dan berlandaskan etika. Bab ini mengusulkan penerapan struktur pedagogis

yang modular dan reflektif dalam layanan publik, dengan fokus pada pembelajaran berbasis peran, pengembangan profesional interdisipliner, dan reformasi infrastruktur yang berakar pada paradigma satu kesehatan. Berdasarkan penelitian lapangan dan pengalaman langsung peneliti, bab ini mengidentifikasi kegagalan sistemik, terutama normalisasi pemaksaan dan impunitas, dan memajukan proposal konkret seperti sistem pakar etika, alat klinis sumber terbuka, pendidikan literasi naratif, dan perlindungan hukum yang kuat. Bab ini menegaskan bahwa perubahan struktural ini tidak aspiratif tetapi perlu, membentuk kerangka dasar untuk praktik perawatan yang berkelanjutan, sesuai hukum, dan bermartabat di seluruh institusi psikiatri, pendidikan, dan sosial (Rosenhan, 1973).

7. Pendahuluan - diskusi reflektif tentang tugas-tugas struktural ke depan

Lima tahun penelitian yang mendasari tesis ini telah berlangsung di bawah kondisi yang mengungkapkan, tidak secara abstrak tetapi dalam praktiknya, ketidakselarasan yang dalam antara tampilan perawatan dan ketiadaan perawatan secara struktural. Di berbagai tempat di mana perawatan psikiatri dianggap dapat menyembuhkan, peneliti menemukan lingkungan di mana mandat perlindungan dibatalkan, di mana sumber daya biomedis diterapkan tanpa persetujuan atau koherensi, dan di mana individu, terutama yang paling rentan, secara sistematis dilucuti dari otoritas pengambilan keputusan. Pengamatan ini tidak terisolasi atau anekdot (Goffman, 1961). Mereka tertanam dalam pola pengabaian sistemik yang lebih luas, kelembaman institusional, dan pengucilan epistemik, yang didukung oleh asumsi normatif yang memprioritaskan kepatuhan farmakologis di atas pemulihan, ketertiban di atas perawatan, dan keheningan di atas kebenaran.

Dalam konteks ini, masih banyak yang harus dilakukan. Model tata kelola kejiwaan saat ini sebagian besar masih bersifat reaktif, terkotak-kotak, dan secara prosedural terputus dari realitas yang ingin ditangani. Transisi menuju sistem perawatan yang didasarkan pada pengambilan keputusan bersama dan responsif terhadap budaya, seperti yang didefinisikan dalam tujuan disertasi ini, membutuhkan perubahan berkelanjutan dalam praktik epistemologi dan desain infrastruktur. Sarana teknologi saat ini telah tersedia untuk mendukung pergeseran tersebut, namun masih kurang dimanfaatkan atau disalahgunakan. Algoritme pencegahan, sistem pakar, pemantauan biosinyal, dan infrastruktur pendukung keputusan masih belum diimplementasikan dengan cara-cara yang selaras dengan praktik yang berorientasi pada pemulihan dan informasi tentang trauma. Logika pengawasan sering kali menggantikan logika perlindungan, dan perangkat yang dapat dikenakan atau alat kesehatan digital diperkenalkan tanpa kerangka kerja etika yang jelas atau mekanisme umpan balik yang dikontrol oleh pasien (Becker, 1963).

Bab ini menguraikan tidak hanya apa yang mungkin dilakukan, tetapi juga apa yang secara struktural diperlukan untuk memenuhi janji perawatan kesehatan mental yang sah (Martimianakis, Maniate, & Hodges, 2009). Model simulasi harus dikembangkan dan diterapkan untuk mengidentifikasi titik-titik di mana praktik-praktik institusional menyimpang dari protokol berbasis hak. Algoritma yang mampu mendeteksi risiko dini, terutama yang berkaitan dengan bahaya iatrogenik, polifarmasi, dan lintasan kemunduran, harus dikalibrasi dan terus diperbarui melalui pengumpulan data partisipatif. Sistem pakar seharusnya tidak berfungsi sebagai instrumen otoritas tetapi sebagai platform pengetahuan bersama, berbasis logika dan adaptif, yang mampu mendukung rencana pengobatan, memvalidasi

proses pengambilan keputusan, dan memantau dinamika hubungan dalam lingkungan perawatan (Branch, 2000).

Proposal yang dirinci di bagian selanjutnya, seperti rutinitas aktivitas fisik yang terstruktur, pemantauan metabolik melalui keseimbangan Omega-3, pendampingan relasional, dan modul kurikulum terbuka, berakar pada bukti biomedis dan psikososial yang dipresentasikan dalam tesis. Semua ini bukanlah suplemen untuk perawatan klinis, melainkan komponen inti dari kerangka kerja yang berpusat pada kesehatan. Fungsinya adalah pencegahan dan reparatif: untuk menghentikan efek berjenjang dari tekanan yang tidak diobati, diam, dan pengobatan yang berlebihan sebelum mereka mengkonsolidasikannya menjadi kerusakan permanen. Kesederhanaannya adalah kekuatannya: mereka merespons kekurangan yang dapat diukur dalam hal tidur, nutrisi, aktivitas fisik, dan keamanan relasional yang memperburuk kerentanan kejiwaan. Ketika domain-domain ini distabilkan, fungsi neurokognitif membaik, regulasi emosi didukung, dan otonomi dimungkinkan, bukan sebagai isyarat, tetapi sebagai hasil fisiologis dan relasional (Mills, 2014).

Proposal-proposal ini tidak dipaksakan. Usulan-usulan ini dirumuskan sebagai alternatif yang tersedia, dapat diuji, dan secara etis sesuai dengan status quo. Tanggung jawab untuk mengadopsi, mengimplementasikan, dan mengadaptasinya terletak pada institusi, otoritas, dan profesional yang bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan dan perawatan publik. Selama lima tahun, penelitian ini telah melacak kesenjangan antara komitmen yang dinyatakan dan perawatan yang sebenarnya. Kesenjangan tersebut masih tetap terbuka. Penutupan kesenjangan itu bukan hanya masalah kemauan, tetapi juga sistem yang mampu belajar, merespons, dan memperbaiki, secara terus menerus dan tanpa penundaan. Bab ini mendokumentasikan jalur struktural dan teknologi untuk transisi tersebut. Hal yang dipaparkan di sini adalah garis besar reformasi yang terstruktur yang didasarkan pada akumulasi bukti kegagalan. Tesis ini telah mendokumentasikan, melalui metode campuran dan analisis multi-skalar, mekanisme di mana pemaksaan, jangkauan farmakologis yang berlebihan, dan diskualifikasi epistemik direproduksi di seluruh antarmuka klinis, keluarga, dan hukum. Ini bukanlah anomali perawatan, melainkan fitur sistematis dari tata kelola psikiatri saat ini. Oleh karena itu, diskusi sekarang berkembang dari diagnosis deskriptif menjadi komitmen prosedural: pemetaan tentang apa yang seharusnya dibangun sehingga penyembuhan tidak bersifat insidental, tetapi standar; sehingga pemulihan bukanlah penyimpangan, tetapi aturan (Costa et al., 2012).

Proposal tersebut dibingkai dalam paradigma satu kesehatan yang menghubungkan kesejahteraan individu dengan etika kelembagaan, koherensi hukum, dan perlindungan lingkungan. Setiap bagian membahas domain spesifik di mana koreksi dapat dilakukan dan mendesak. Psikiatri preventif, yang masih belum ada dalam bentuknya yang sebenarnya, membutuhkan alat dan praktik yang beroperasi di hulu krisis: rutinitas pengambilan keputusan yang berpijak pada komunitas, dukungan struktural untuk stabilitas relasional, dan mekanisme umpan balik yang responsif terhadap tanda-tanda awal gangguan fisiologis dan psikologis. Perangkat yang dapat dikenakan dan perangkat biosignal, jika diatur secara etis dan diintegrasikan ke dalam sistem yang dikendalikan pasien, memungkinkan deteksi dan analisis penanda stres, gangguan tidur, ketidakseimbangan metabolisme, dan korelasi lain dari kesehatan yang memburuk. Hal ini tidak bersifat invasif ketika diterapkan dengan persetujuan dan kontrol, tetapi merupakan alat pelindung yang selaras dengan intervensi dini dan otonomi. Lingkungan klinis harus dilengkapi tidak hanya dengan staf tetapi juga dengan infrastruktur

komputasi yang mampu melacak keputusan, menghubungkan intervensi dengan hasil, dan menandai pola bahaya atau stagnasi. Sistem pakar, yang bersifat terbuka, transparan, dan dapat diverifikasi, harus mendukung semua fase perencanaan pengobatan, protokol pemberian obat, dan dialog antarprofesi. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan penilaian tetapi untuk memperkuatnya, dengan mendasarkan setiap pilihan klinis pada koherensi logis, alasan yang terdokumentasi, dan standar berbasis hak. Tidak ada praktisi yang boleh beroperasi tanpa akses waktu nyata ke bukti terbaik yang tersedia, dan tidak ada pasien yang harus menjalani protokol yang tidak dapat dipertahankan secara publik dan ilmiah. Bab ini juga menempatkan reformasi pendidikan sebagai infrastruktur inti untuk kesehatan.

Tidak adanya pedagogi kritis dalam profesi kesehatan, tentang otonomi tubuh, pengambilan keputusan etis, dan sejarah pelecehan dalam sistem perawatan, telah memungkinkan kekerasan untuk bertahan tanpa diperiksa dan tanpa tantangan. Desain kurikulum dan rutinitas pembelajaran layanan harus mencerminkan pemahaman bahwa institusi tidak hanya menanggapi penderitaan; mereka membentuknya. Oleh karena itu, pencegahan harus dimulai dari para profesional, institusi yang melatih mereka, dan hukum yang mengatur mereka (Scheper-Hughes, 1992; Hafferty, 1998; Coulehan & Williams, 2001).

7.1 Dari Diagnosis Struktural ke Komitmen Sistem

Selama lima tahun analisis berkelanjutan, temuan-temuan yang ada secara konsisten memperlihatkan konfigurasi perawatan psikiatri yang tidak jelas, di mana otonomi ditangguhkan, kerangka kerja hukum diabaikan, dan standar etika diterapkan secara selektif. Kepercayaan profesional telah terkikis oleh kewenangan diskresi yang tidak dilandasi oleh alasan yang transparan atau hasil yang dapat diverifikasi. Sistem yang diawasi, meskipun secara kelembagaan rumit, tetap tidak koheren secara klinis dan ilmiah. Hal ini memiliki konsekuensi fisiologis, psikologis, dan sosial secara langsung: peningkatan beban alostatik, penyakit kronis terkait stres, disintegrasi relasional, dan pengurangan sistematis lintasan perkembangan dan pemulihan (Lund et al., 2010). Ini bukanlah efek yang terisolasi, melainkan hasil yang terpolakan dari ketidakselarasan struktural. Konsekuensi dari kegagalan sistem tersebut tidak bersifat abstrak atau tertunda. Mereka bermanifestasi dalam kematian dini, pengabaian kelembagaan, disfungsi metabolik, trauma antargenerasi, dan ketergantungan yang dapat dihindari pada obat penenang farmakologis. Banyak yang tidak memiliki akses terhadap kondisi mendasar yang memungkinkan regulasi fisiologis dan pemulihan psikologis, tidur yang cukup, keamanan, hubungan yang stabil, diet yang cukup gizi, dan lingkungan yang terlindungi. Intervensi yang dilakukan sering kali hanya menekan gejala tanpa mengatasi penyebabnya, sehingga menambah beban fisiologis daripada mengatasinya. Sementara itu, infrastruktur pencegahan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pelacakan biosignal yang dapat dikenakan untuk stres dan regulasi sirkadian, masih belum berkembang atau secara etis tidak diterapkan dengan benar, terutama di antara populasi yang rentan.

Bagian ini menegaskan perlunya beralih dari diagnosis struktural menuju komitmen sistem yang terkoordinasi. Meskipun tesis ini telah memetakan di mana dan bagaimana kerusakan terjadi, tugas di depan adalah prosedural: membangun arsitektur umpan balik dan tanggung jawab bersama yang

menyelaraskan sistem perawatan dengan bukti, akuntabilitas, dan hak asasi manusia (Fernando, 2010). Ini bukan masalah advokasi, sentimen, atau ideologi. Ini adalah domain operasional dari desain kelembagaan dan rekayasa kesehatan masyarakat (Kelahe et al., 2014). Kekosongan epistemik dan infrastruktur harus diisi oleh penelitian aksi yang dilakukan dalam konteks nyata, dipimpin oleh orang-orang yang terkena dampak, diterjemahkan melalui rekayasa, pendidikan, dan pelatihan klinis (Herman, 1997).

Sebuah model yang partisipatif dan terapan tidak hanya diinginkan, tetapi juga dibutuhkan. Hal ini menuntut adanya metrik dan mekanisme yang mampu memberikan umpan balik langsung, deteksi sinyal pencegahan, dan daya tanggap sistem. Hal ini berarti protokol formal untuk depreskripsi, pelatihan terbaru tentang interaksi somatik-psikososial, pelacakan gejala secara real-time, dan penerjemahan pengalaman pasien ke dalam data yang tidak dapat didiskon. Ketiadaan mekanisme-mekanisme ini secara terus-menerus tidak hanya menjelaskan bahaya yang sedang berlangsung tetapi juga keterlambatan dalam perbaikan dan inovasi (Compton & Shim, 2015). Sistem masyarakat tidak bisa tetap netral ketika nyawa menjadi taruhannya. Ketika pendidikan direduksi menjadi kepatuhan, gerakan dianggap sebagai hukuman, dan kesehatan direduksi menjadi manajemen farmakologis, hasilnya adalah jebakan budaya dan biologis yang melumpuhkan ketahanan (Wilkinson & Pickett, 2010). Banyak masyarakat masih menganggap kondisi fisik sebagai sesuatu yang mencurigakan, kerentanan sebagai kelemahan, dan kekerasan sebagai sesuatu yang pedagogis atau korektif. Namun, kesehatan bergantung pada paparan terhadap rutinitas yang melindungi, upaya yang terstruktur, dan rasa memiliki tujuan yang tervalidasi (Hollander, 2010).

Institusi harus menumbuhkan ketahanan neurobiologis adaptif melalui rutinitas yang tidak bersifat menghukum tetapi bersifat membangun, tidak dipaksakan tetapi dibangun bersama. Jalan ke depan dimulai dengan pengakuan bahwa kerusakan individu mencerminkan kegagalan desain sistemik. Tidak ada sistem yang mengizinkan pemaksaan sebagai rutinitas, menekan keluhan, atau menghapus kerusakan jangka panjang yang dapat dianggap fungsional. Perawatan psikiatri harus berhenti bergantung pada otoritas pribadi dan mulai beroperasi melalui rantai pengambilan keputusan yang valid secara ilmiah, dapat direproduksi, dan transparan. Perangkat yang dapat dikenakan dan simulasi algoritmik dapat mendeteksi disregulasi dini, tetapi alat ini hanya efektif jika ditanamkan di lingkungan yang mendukung, di mana sinyal ditindaklanjuti dan bukan diabaikan. Pendidikan juga harus diarahkan kembali ke kewarganegaraan terapan dan kapasitas relasional: melek tubuh, hukum, dialog, dan navigasi sistem. Kurikulum harus mencakup neurobiologi perkembangan, kesehatan lingkungan, teori keputusan, dan penalaran berdasarkan trauma. Hal-hal tersebut bukanlah kemewahan, melainkan persyaratan dasar untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang diatur oleh sistem kelembagaan. Ketika mereka tidak ada, masyarakat tidak dapat mengelola perselisihan tanpa kekerasan, stres tanpa keruntuhan, atau kepedulian tanpa ketergantungan. Dari sudut pandang penelitian lapangan yang berkelanjutan dan mendalam, menjadi jelas bahwa apa yang masih harus dilakukan tidak bersifat perifer atau tambahan. Terlepas dari kemajuan yang tertanam dalam tesis ini, sebagian besar pekerjaan penting masih terhambat secara struktural oleh kelembaman sistemik, dinamika kekuasaan yang mengakar, dan ketidakselarasan yang terus-menerus antara pengetahuan dan implementasi. Komitmen sistem yang diuraikan bukanlah visi yang disarikan dari pengalaman, melainkan justru muncul dari pengamatan berulang-ulang bahwa, tanpa perlindungan yang dapat

diverifikasi dan protokol yang koheren, sistem kejiwaan terus mereproduksi bahaya di balik kedok perawatan. Pengalaman peneliti, yang secara pribadi mengalami banyak dari kondisi ini, menggarisbawahi betapa mudahnya wacana institusional mengesampingkan realitas klinis, dan bagaimana akuntabilitas institusional sering kali larut di bawah kerumitan administratif, paksaan informal, dan keheningan normatif (Cohen, 2001).

Tantangannya tidak hanya bersifat teknis. Alat-alatnya sudah ada, sistem pakar, perangkat yang dapat dikenakan untuk pengaturan stres dan tidur, protokol evaluasi partisipatif, kurikulum berbasis trauma, dan jalur klinis berbasis hak. Yang kurang bukanlah inovasi, melainkan kemauan sistemik dan penegakan prosedural. Sistem pendidikan belum mempersiapkan para profesional yang mampu menerapkan alat-alat ini dengan cara yang menghormati hak. Kerangka hukum masih samar-samar, terfragmentasi, atau tidak ditegakkan. Lembaga-lembaga tidak memiliki mekanisme umpan balik waktu nyata yang mampu mengidentifikasi bahaya saat terjadi. Ketiadaan ini bukanlah kelalaian, melainkan hasil dari prioritas sistemik yang secara historis meminggirkan populasi yang membutuhkan perlindungan. Tesis ini telah menunjukkan bahwa bahaya tidak selalu keras. Kerugian yang terjadi seringkali lambat, kumulatif, dan dirutinkan, didistribusikan melalui keputusan-keputusan yang dibuat secara diam-diam, catatan-catatan yang tidak lengkap, atau pilihan-pilihan yang tidak pernah ditawarkan. Hal ini bukanlah kegagalan kompetensi semata, melainkan kegagalan desain kelembagaan dan tata kelola yang beretika (Goffman, 1961). Banyak sistem yang diamati telah menormalkan keadaan pengecualian, di mana individu yang ditandai dengan diagnosis kejiwaan kehilangan status sebagai manusia seutuhnya, direduksi menjadi kepatuhan, menjadi sasaran diskon epistemik, dan dibuat tidak terlihat dalam narasi mereka sendiri (Fernando, 2017).

Untuk melangkah maju, pekerjaan yang tersisa harus dibingkai sebagai tugas yang harus dilakukan, mandat yang harus diikuti, kewajiban hukum dengan konsekuensi, bukan sebagai aspirasi (Scheper-Hughes & Bourgois, 2004). Lembaga-lembaga harus mengembangkan tidak hanya kapasitas untuk bertindak tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab untuk merespons secara tepat waktu dan dengan kejelasan prosedural, demi kepentingan semua pihak, termasuk semua profesional yang terlibat sejauh ini, dan tentu saja para pasien, korban, mereka yang ditinggalkan dan masyarakat luas. Pemulihan harus dipahami bukan sebagai hasil individu tetapi sebagai metrik institusional: apakah sistem mampu mendukung martabat, otonomi, dan regulasi fisiologis dalam kondisi tertekan seharusnya tidak diajukan sebagai pertanyaan, hanya sebagai sumber kebanggaan ketika berhasil dicapai dengan baik dalam sebuah siklus perbaikan - siklus penelitian tindakan harus diterapkan untuk menghapus setiap masalah, setiap kesalahan yang dicatat, seperti dalam repositori pengembangan komputer, sebelum terulang lagi dan menyebabkan penderitaan lebih lanjut, di seluruh sistem (Harper & Speed, 2012). Pengalaman meneliti di bawah paksaan, di bawah penyiksaan medis yang merupakan kejahatan besar terhadap kemanusiaan, terlepas dari hukum dan seruan berulang kali untuk meminta bantuan, menegaskan betapa gentingnya keselamatan ketika pertanyaan-pertanyaan ini tetap tidak terjawab, isu-isu yang sedang berlangsung dibiarkan begitu saja, kita dibunuh, dibantai seperti binatang.

Orientasi yang diusulkan di sini sepenuhnya berbeda dari aktivisme yang tidak teruji dan reproduksi pasif dari rutinitas institusional. Hal ini tidak membutuhkan semangat atau ketaatan, tetapi refleksivitas yang terstruktur, sebuah kapasitas yang disiplin dan sistematis untuk mendeteksi,

mempertanyakan, dan mendesain ulang kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan kerusakan atau gagal melindungi. Pada intinya, ini adalah antitesis dari kepatuhan buta dan kelembaman prosedural. Ini bukan penolakan terhadap struktur, tetapi pendefinisian ulang struktur: struktur yang berpijak pada umpan balik, akuntabilitas etis, dan kalibrasi yang berkelanjutan. Berorientasi pada kebenaran, berorientasi pada pemulihan, dan berorientasi pada hasil.

Alih-alih mengotomatiskan respons dalam jiwa para profesional, tujuannya adalah untuk menumbuhkan kebiasaan yang dipraktikkan untuk perbaikan refleksif, sebuah meta-kebiasaan yang didasarkan pada identifikasi kerusakan, kalibrasi ulang norma-norma, dan penyelarasan tindakan yang disengaja dengan perawatan yang teruji secara empiris. Hal ini tidak bersifat reaktif tetapi antisipatif. Hal ini menuntut dari setiap praktisi kapasitas untuk mengenali penyimpangan, untuk menghentikan otomatisitas, dan untuk melakukan intervensi dengan tanggung jawab dan koherensi.

Refleksivitas seperti itu harus tertanam di semua tingkatan, dari titik keputusan individu hingga protokol institusional. Hal ini harus diajarkan, diperkuat, dan diharapkan secara normatif. Pergeseran yang diperlukan tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga prosedural dan etis. Apa yang dibayangkan adalah lingkungan kejiwaan dan pedagogis di mana sistem tidak lagi bergantung pada pengecualian atau kepahlawanan moral untuk berfungsi dengan baik, tetapi di mana tindakan yang koheren, dapat diverifikasi, dan meneguhkan kehidupan menjadi norma sistemik. Ini bukan aktivisme; ini adalah reformasi infrastruktur yang dilandasi oleh tanggung jawab. Bukan penyerahan diri, bukan perlawanan, tetapi desain pelayanatan yang berkelanjutan. Sistem yang dibayangkan tidak mengandaikan operasi yang sempurna, dan juga tidak berusaha untuk menghilangkan kesalahan sepenuhnya (Graham et al., 2006). Sebaliknya, sistem ini dirancang untuk ketahanan, kapasitas untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons kerusakan tanpa penyangkalan atau penundaan. Kesalahan tidak diperlakukan sebagai anomali yang terisolasi atau sebagai biaya yang dapat diterima, tetapi sebagai sinyal yang membutuhkan respons terstruktur. Hal ini mengubah kegagalan dari sumber kerapuhan kelembagaan menjadi titik pembelajaran dan kalibrasi ulang. Dalam sistem seperti ini, bahaya tidak disembunyikan atau dinormalisasi, tetapi dibuat terlihat dan dapat ditindaklanjuti (Bauer, Damschroder, Hagedorn, Smith, & Kilbourne, 2015).

Pergeseran ini menggantikan ketergantungan pada moralitas individu atau intervensi ad hoc dengan arsitektur praktik profesional yang stabil. Pergeseran ini menanamkan refleksivitas ke dalam struktur operasional, menjadikan daya tanggap etis dan akuntabilitas empiris sebagai fitur intrinsik dari sistem itu sendiri. Ini bukanlah perlawanan demi kepentingannya sendiri, atau penolakan terhadap struktur, tetapi penegasan integritas prosedural, memastikan bahwa perawatan, pendidikan, dan tata kelola beroperasi dalam kerangka kerja yang dapat belajar, beradaptasi, dan tetap layak untuk mendapatkan kepercayaan publik (Mills, 2014).

7.2 Model klinis berbasis hak: pengambilan keputusan, dialog, dan ketepatan

Untuk memungkinkan transisi yang tulus menuju perawatan yang etis dan efektif, praktik psikiatri harus didasarkan pada model intervensi yang dipersonalisasi, koheren secara biologis, dan sesuai dengan konteks sosial. Gagasan untuk 'mengatur ulang' sistem perawatan tidak menyiratkan

penghapusan atau perpecahan ideologis, tetapi penahan kembali integritas ilmiah, nuansa klinis, dan keharusan etis untuk tidak melakukan kekejaman. Intervensi psikiatri harus dipandu oleh evaluasi yang terstruktur dan transparan terhadap profil fisiologis, konteks psikososial, dan pengalaman naratif setiap individu. Tidak ada intervensi yang secara inheren berbahaya atau bermanfaat secara universal; nilai terapeutik bergantung pada indikasi, konteks, durasi, dan keterlibatan sukarela dari orang yang menerima perawatan. Hal ini menuntut pendidikan berkelanjutan bagi para profesional dan masyarakat, menumbuhkan budaya yang mampu membedakan antara bahaya iatrogenik dan efek terapeutik yang sah.

Pergeseran semacam itu menolak paradigma yang bersifat menghukum dan totaliter, tidak manusiawi, dan sebaliknya menekankan pada pembelajaran adaptif, transparansi prosedural, dan tanggung jawab bersama. Pasien, klien, pengguna, dan warga negara harus diperlakukan sebagai agen epistemik, yang mampu berkontribusi pada pemahaman dan konstruksi bersama proses perawatan mereka sendiri. Lingkungan klinis seharusnya tidak lagi beroperasi sebagai ruang kontrol atau koreksi moral dan sebagai gantinya menjadi ekosistem pemulihan, di mana tugas utamanya adalah mengkalibrasi dukungan sesuai dengan kebutuhan, bukti, dan tujuan yang berkembang. Perawatan psikiatri, agar tetap kredibel dan sesuai dengan hukum, harus mengadopsi prinsip-prinsip pengobatan presisi, mengintegrasikan biosignatures, pemicu stres lingkungan, dan lintasan perilaku ke dalam model pengambilan keputusan yang dinamis. Hal ini tidak menghilangkan ketidakpastian tetapi mengelolanya secara konstruktif, memastikan bahwa penyembuhan, bukan kepatuhan, tetap menjadi tujuan utama dari sistem ini (Samson & McGregor, 2022).

Model perawatan psikiatri yang sudah berlangsung lama di banyak yurisdiksi telah menormalkan asimetri struktural antara penyedia dan pengguna, dengan keputusan yang sering kali dibentuk oleh kemanfaatan institusional, formalisme diagnostik, dan standardisasi farmakologis. Dalam kerangka kerja seperti itu, pengambilan keputusan bersama sering kali hanya menjadi tujuan yang dinyatakan, jarang diimplementasikan sebagai norma prosedural. Bagian ini mempertimbangkan alasan empiris dan etis untuk mengkonfigurasi ulang sistem klinis di sekitar pengambilan keputusan yang tertanam secara struktural, koherensi dialogis, dan ketepatan yang beralasan secara ilmiah.

Model yang kuat secara klinis dan hukum mengharuskan pengambilan keputusan tidak lagi dianggap sebagai penawaran diskresioner, tetapi terintegrasi secara struktural melalui sistem pakar yang dijamin umpan balik yang diatur secara etis dan dapat diverifikasi keakuratannya. Sistem ini bukanlah pengganti penilaian, melainkan instrumen yang menyusun, mencatat, dan memperkuat proses penalaran relasional dan pembentukan persetujuan. Dasar dari kalibrasi ulang ini adalah pengembangan alat bantu modular untuk membantu dalam perencanaan pengobatan, pembuatan profil risiko-manfaat, dan penyesuaian longitudinal. Modul-modul ini dapat menggabungkan pohon logika klinis, masukan biofisiologis, dan data konteks psikososial, yang tetap adaptif terhadap respons dan preferensi pasien.

Secara paralel, mekanisme umpan balik pasien yang tertanam diperlukan untuk mendeteksi hasil yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Hal ini dapat mencakup perubahan kondisi afektif, ketidakteraturan fisiologis, fluktuasi kognitif, dan gangguan hubungan, yang semuanya memiliki arti klinis dan etika. Teknologi yang memungkinkan hal ini, seperti perangkat yang dapat dikenakan dan

buku harian digital, harus dibingkai bukan sebagai instrumen pengawasan, tetapi sebagai alat bantu untuk komunikasi, pengawasan, dan keamanan. Yang terpenting, mereka harus tetap berada di bawah kendali pasien, dengan konfigurasi yang dapat diikutsertakan dan tata kelola data yang transparan.

Koordinasi dengan pengasuh, pembimbing, dan profesional lintas sektor juga penting. Lingkungan klinis berbasis hak yang sesungguhnya membutuhkan koherensi relasional (Sweeney et al., 2016). Modul koordinasi dapat menawarkan alat bantu kesadaran situasional, perancah komunikasi, dan protokol pemberitahuan etis yang membantu dalam mempertahankan penghormatan terhadap otonomi sambil menjaga kesinambungan perawatan (Rose, 2001). Mekanisme ini sangat relevan jika melibatkan pengampunan hukum, institusi pendidikan, atau layanan sosial (Fixsen et al., 2005).

Infrastruktur pelatihan bagi para profesional harus dikalibrasi ulang untuk mendukung model ini. Literasi prosedural dalam ilmu pengambilan keputusan, penalaran etis dan hukum, dan pengobatan naratif harus distandarisi. Proses pendidikan yang ketat harus menekankan netralitas klinis, penghormatan terhadap pengetahuan berdasarkan pengalaman, dan integrasi beragam perspektif budaya dan biografi. Hal ini termasuk membangun sistem sertifikasi berkelanjutan yang selaras dengan WHO QualityRights, undang-undang setempat, dan instrumen hak asasi manusia internasional (Sweeney et al., 2018). Pengenalan biomarker multi-modal dan sosiomarker merupakan langkah maju yang diperlukan, yang saat ini dapat dicapai dengan mudah. Indikator biologis, seperti penanda inflamasi, keseimbangan hormon, variabilitas detak jantung, dan siklus tidur, harus ditafsirkan bersama dengan indikator sosiokultural dan relasional, termasuk keamanan tempat tinggal, paparan diskriminasi, dan integritas jaringan sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui pelacak dan perangkat yang dapat dikenakan setiap hari oleh semua orang yang membutuhkannya, secara ekonomi saat ini. Pengalaman peneliti sendiri yang keluar dari penderitaan akibat penyiksaan menunjukkan banyak hal sebagai kasus sukses dalam hal ini, dengan menggunakan metode pelacakan diri untuk memastikan kebugaran, dan kebiasaan yang lebih baik, meskipun tidak secara eksplisit dalam disertasi ini. Integrasi biokultural semacam itu memungkinkan rencana perawatan yang menyesuaikan diri dengan orang-dalam-konteks, menjauh dari kerangka kerja reduksionis yang secara keliru menguniversalkan presentasi gejala atau respons pengobatan (Kalathil, 2020). Pada tingkat sistemik, reflektivitas harus diperkuat melalui desain prosedural. Alih-alih otomatisasi rutinitas klinis, yang dibutuhkan adalah kebiasaan metakognitif: identifikasi rutin divergensi, kalibrasi ulang pengobatan, dan pengakuan batas epistemik. Dalam hal ini, yang ideal bukanlah kesempurnaan protokol, melainkan pelebagaan daya tanggap. Ketika pengetahuan klinis tidak dipertanyakan, atau ketika perbedaan pendapat dipatologiskan, sistem akan terdegradasi menjadi loop tertutup yang tidak dapat lagi mengenali kesalahan.

Ketertelusuran dan verifikasi keputusan menjadi hal yang utama dalam konfigurasi ini. Setiap rekomendasi, penyesuaian, atau penyimpangan dari standar harus didokumentasikan secara transparan dan dapat ditafsirkan. Hal ini memastikan akuntabilitas di seluruh waktu dan pelaku, terutama di lingkungan di mana para praktisi berganti-ganti atau di mana pasien berinteraksi dengan berbagai institusi. Penjelasan ilmiah, baik dalam bentuk yang dapat dibaca manusia maupun algoritmik, tidak hanya memberikan akurasi medis tetapi juga pembelaan hukum dan etika. Pertimbangan terakhir adalah interoperabilitas di seluruh sistem. Perawatan kesehatan jiwa berbasis hak asasi manusia tidak dapat diwujudkan jika sistem pendidikan, peradilan, atau kesejahteraan

beroperasi dengan logika yang tidak kompatibel. Hal ini membutuhkan protokol yang dapat dioperasikan secara interoperabilitas dan kerangka kerja perlindungan yang memfasilitasi kesinambungan data, pengungkapan etis, dan respons cepat terhadap bahaya. Hanya dengan demikian, perawatan kejiwaan dapat menghindari fungsi sebagai domain korektif yang terisolasi, dan sebagai gantinya menjadi simpul dalam jaringan restoratif yang lebih luas.

7.3 Pendidikan sebagai infrastruktur: kurikulum, pedagogi, dan pembelajaran berbasis peran

Setiap rekonfigurasi sistemik dari lingkungan kesehatan dan perawatan harus melibatkan pendidikan tidak hanya sebagai diseminasi, tetapi sebagai infrastruktur struktural, yang mampu membentuk perilaku relasional, sensitivitas etis, dan reflektivitas epistemik di sepanjang perjalanan hidup. Kegagalan yang didokumentasikan dalam disertasi ini tidak hanya menunjukkan diskontinuitas klinis dan hukum, tetapi juga ketidakmampuan budaya yang lebih luas untuk membekali individu dan institusi dengan perangkat konseptual dan prosedural yang diperlukan untuk mempertahankan respons yang koheren dan berbasis hak terhadap kerentanan manusia dan saling ketergantungan ekologis. Masyarakat yang preventif, mempromosikan kesehatan, dan selaras dengan ilmu pengetahuan tidak dapat dibentuk tanpa transformasi kurikulum, pembaruan pedagogis, dan penyelarasan normatif di semua peran profesional dan sipil. Bagian ini menguraikan transformasi tersebut di bawah rubrik satu pendidikan kesehatan, yang dikonseptualisasikan sebagai infrastruktur modular, akses terbuka, dan sumber terbuka yang mampu beradaptasi di seluruh konteks nasional, bahasa, dan sosiokultural (Perrin et al., 2007).

Pengembangan modul pendidikan satu kesehatan yang dapat diimplementasikan secara transnasional menanggapi kebutuhan empiris untuk pembentukan pengetahuan awal, terstruktur, dan kumulatif mengenai saling ketergantungan antara manusia, non-manusia, dan sistem ekologi. Modul-modul ini harus dirancang untuk diintegrasikan di berbagai tingkat pembelajaran formal dan informal, mulai dari pendidikan dasar hingga spesialisasi profesional, dengan memprioritaskan aksesibilitas, relevansi kontekstual, dan landasan empiris. Arsitektur pedagogis mereka harus mendukung tidak hanya transmisi informasi tetapi juga penanaman penalaran kritis, agensi kolaboratif, dan tanggung jawab prosedural.

Empat domain kurikulum muncul sebagai hal yang sangat diperlukan secara struktural. Pertama, Pengambilan Keputusan dan Tanggung Jawab Kesehatan harus ditetapkan sebagai konten dasar, memastikan bahwa peserta didik mengembangkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana pilihan, baik secara individu maupun kolektif, berhubungan dengan sistem tubuh, dinamika hubungan, dan struktur kelembagaan. Hal ini mencakup literasi praktis dalam hal persetujuan, evaluasi risiko-manfaat, dan etika intervensi, yang meluas ke manajemen kesehatan pribadi dan pengambilan keputusan bersama dalam peran profesional (Aarons, Hurlburt, & Horwitz, 2011). Kedua, Etika Tubuh dan Relasi seharusnya diajarkan bukan sebagai filsafat abstrak, tetapi sebagai kompetensi prosedural yang hidup, yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan perkembangan saraf, praktik berdasarkan trauma, dan penalaran moral. Pendidikan dalam domain ini harus membekali siswa dengan alat untuk mengenali pelanggaran batas, memahami fisiologi tekanan dan perbaikan, dan

bertindak dengan akuntabilitas yang koheren dalam konteks pemberian perawatan dan organisasi. Etika relasional mencakup tanggung jawab terhadap orang lain, tetapi juga terhadap integritas fisik dan emosional seseorang, menjembatani kesehatan masyarakat, ketahanan psikologis, dan perilaku kewarganegaraan (Woolf, 2008). Ketiga, Saling ketergantungan lingkungan dan planet membutuhkan integrasi kurikulum antara ilmu ekologi dengan dimensi afektif, etika, dan perilaku. Peserta didik harus memahami dampak sirkuler dari polusi, konsumsi berlebihan, dan degradasi habitat tidak hanya pada sistem planet tetapi juga pada perkembangan saraf, kesuburan, kekebalan, dan kognisi kolektif (Sweeney et al., 2018). Dengan demikian, literasi lingkungan menjadi masalah strategi kesehatan masyarakat dan keadilan antargenerasi, bukan hanya masalah khusus atau pilihan. Keempat, literasi historis dan metodologis dalam profesi perawatan harus dibangun untuk melawan amnesia institusional dan mereproduksi sistem perawatan yang mampu merefleksikan diri dan meningkatkan adaptasi (Freire, 2000). Hal ini mencakup keterlibatan kritis dengan silsilah kedokteran, psikiatri, pekerjaan sosial, dan pendidikan, yang memperlihatkan bagaimana praktik normatif berkembang, menurun, atau pulih dari waktu ke waktu. Literasi metodologis harus mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yang memungkinkan para profesional untuk menginterpretasikan data dalam kaitannya dengan pengalaman hidup, sejarah sistemik, dan kemajemukan epistemik (Delpit, 2006).

Keempat domain tersebut harus tertanam dalam struktur pembelajaran pelayanan yang memposisikan peserta didik sebagai penerima dan penyumbang pengetahuan. Pedagogi relasional, yang didasarkan pada pengalaman bersama, refleksivitas dialogis, dan akuntabilitas timbal balik, seharusnya menggantikan instruksi berbasis transmisi, terutama dalam domain di mana terdapat pertarungan etika dan asimetri kekuasaan. Model ini mendukung pengembangan rutinitas perlindungan dan kebiasaan peduli yang memperkuat koherensi kelembagaan dan kohesi sosial. Dalam layanan publik, seperti sekolah, klinik, dan badan administratif, pembaruan pedagogis harus dipasangkan dengan adaptasi struktural yang memungkinkan pembelajaran berbasis peran. Guru, dokter, dan administrator harus dibekali dengan jalur pendidikan berkelanjutan yang berulang, modular, dan sesuai dengan tanggung jawab mereka yang terus berkembang (Perry & Szalavitz, 2017). Program-program ini harus disusun secara normatif untuk menghindari bahaya, realisasi prosedural martabat, dan pemeliharaan legitimasi kelembagaan. Program-program ini juga harus merespons perubahan kondisi epidemiologi, lingkungan, dan teknologi, memastikan bahwa praktik profesional tidak tertinggal dari konsensus ilmiah atau etika (McNall, Reed, Brown, & Allen, 2009). Kegagalan dalam menerapkan reformasi tersebut membuat individu terjebak dalam peran yang tidak selaras secara struktural, di mana korban diperlakukan sebagai pelanggar, profesional sebagai otoritas yang tidak perlu dipertanyakan, dan respons yang menyimpang atau tertekan sebagai patologi. Dari dalam sistem seperti itulah lintasan peneliti harus dipahami. Berasal dari sistem keluarga disfungsi yang secara bertahap terdegradasi menjadi pola pemaksaan dan pelecehan yang relevan secara klinis dan hukum, peneliti menjadi saksi atas runtuhnya perlindungan di berbagai institusi yang seharusnya melakukan intervensi. Selama lima tahun analisis hukum, medis, dan pendidikan, kasus yang mendasari tesis ini menunjukkan bagaimana pengabaian sistematis, dikombinasikan dengan jangkauan diagnostik yang berlebihan dan impunitas berbasis peran, dapat mengubah ketahanan menjadi keruntuhan, otonomi

menjadi ketergantungan, dan perawatan yang berfungsi baik menjadi bahaya kumulatif (Frenk et al., 2010).

Data klinisnya sangat jelas: paparan kronis terhadap kekerasan psikologis dan fisik tanpa adanya perlindungan prosedural menghasilkan disregulasi somatik, peningkatan beban alostatik, gangguan fungsi imunologis dan kognitif, dan berkurangnya kapasitas neuroplastik. Hasil ini tidak bersifat acak atau idiosinkratik, tetapi dapat diprediksi sepenuhnya jika tidak ada perlindungan yang terkoordinasi dan sistem informasi trauma. Peneliti, yang menjadi pengasuh utama untuk dua bayi sekaligus melampaui ekspektasi institusi sebagai seorang akademisi dan profesional, menjadi sasaran kekerasan yang semakin meningkat karena menjalankan hak yang secara konstitusional dijamin tetapi secara prosedural ditolak. Mengusulkan perpisahan atau perceraian, dalam konteks impunitas gender dan misogini budaya yang diarahkan pada kerentanan laki-laki, tidak mengarah pada tinjauan prosedural tetapi pada serangan fisik yang brutal, penyiksaan secara institusional, dan pencemaran nama baik kejiwaan (Herman, 1997).

Dokumentasi medis pada saat itu mengkonfirmasi adanya memar dan disregulasi fisiologis. Namun, polisi, dokter, dan aktor pengadilan keluarga secara sistematis menolak untuk mengakui indikator-indikator ini, sering kali mengutip stereotip gender, sindiran diagnostik, atau gagasan yang samar-samar tentang ketidakstabilan untuk mengaburkan pertanggungjawaban. Migrain yang sederhana dianggap sebagai kegilaan. Tenaga kerja yang diberikan oleh korban diambil meskipun kesehatannya memburuk, sementara pelecehan disembunyikan di bawah kepasifan institusional dan keterlibatan sosial budaya. Tidak ada protokol perlindungan yang diberlakukan. Intervensi farmakologis secara paksa dilakukan. Namun, tidak ada satupun pelaku yang dievaluasi secara medis, dan penegakan hukum juga tidak diarahkan kepada mereka. Asimetri semacam itu bukan merupakan kegagalan klinis tetapi keruntuhan struktural dalam administrasi keadilan dan perawatan. Semua itu terjadi dengan partisipasi penuh dari lembaga-lembaga yang diberi mandat untuk melindungi. Hal ini menjadikan episode tersebut tidak bersifat privat, tetapi publik, tidak luar biasa, tetapi paradigmatik (Fanon, 1963; Freire, 1970; Bartky, 1990).

Perlu ditegaskan kembali bahwa tidak satu pun dari kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya kredensial profesional, upaya, atau keterlibatan. Justru sebaliknya. Peneliti bekerja dengan kinerja setinggi mungkin di bawah kondisi yang memaksa: lulus ujian dengan predikat terbaik, berkontribusi pada kepemimpinan akademik internasional, membesarkan dua anak sekaligus melindungi mereka dari bahaya rumah tangga yang meningkat. Oleh karena itu, ketidakadilan ini tidak terjadi secara kebetulan. Itu bersifat sistemik. Ketidaksesuaian antara apa yang diklaim oleh sistem dan apa yang diberlakukan secara struktural inilah yang membentuk fondasi empiris dari tesis ini (Mills, 2014).

Sistem kejiwaan, jika tidak dikoreksi, beroperasi bukan sebagai alat penyembuhan tetapi sebagai sirkuit penahanan. Sistem ini mereplikasi bentuk-bentuk kontrol dengan kedok diagnosis. Sistem ini sering kali mengingkari martabat prosedural dan mengutip penderitaan individu sebagai bukti untuk melakukan pemaksaan lebih lanjut. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika polisi dan tenaga medis bertindak sebagai penengah di luar hukum, menghakimi dan mengeksekusi tanpa proses pengadilan, maka arsitektur hukum dan etika masyarakat demokratis mana pun akan mulai retak. Dalam kasus ini,

upaya untuk meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan dijawab dengan pencemaran nama baik medis, pengasingan anak, dan kebungkaman institusional (Berry et al., 2019).

Oleh karena itu, seruannya bukan untuk advokasi retorika tetapi rekonstruksi infrastruktur. Model yang diajukan dalam disertasi ini didasarkan pada kebutuhan akan sistem yang koheren secara ilmiah, kuat secara hukum, dan dapat dipertahankan secara etis. Organisasi Kesehatan Dunia (1948) mendefinisikan kesehatan sebagai suatu *keadaan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan*. Pada tahun 2004, organisasi ini lebih lanjut mendefinisikan kesehatan mental sebagai *suatu kondisi kesejahteraan di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya*.

Praktik-praktik sistemik yang diungkap dalam penelitian ini sangat jauh dari standar-standar tersebut. Ketika pemaksaan menggantikan perawatan, dan patologi digantikan oleh tekanan yang terjadi, legitimasi kelembagaan menjadi batal. Sejalan dengan kerangka kerja WHO *QualityRights*, disertasi ini mengusulkan penerapan lima tindakan dasar sebagai garis dasar sistemik, yang bertujuan untuk mengintegrasikan kerangka kerja lain di seluruh masyarakat, bukan proposal yang bersifat aspiratif, tetapi pekerjaan yang sedang berlangsung, seperti adopsi luas dari New Economic Foundation (NEF) lima cara menuju kesejahteraan, yang telah dipromosikan secara luas (Kitchener & Jorm, 2002; Lima Cara Menuju Kesejahteraan, New Economics Foundation, 2008):

- Penghapusan praktik-praktik pemaksaan, termasuk pelembagaan paksa, intervensi farmakologis yang tidak konsensual, dan penyalahgunaan wewenang medis secara disipliner. Dalam istilah neurobiologis, paksaan menghasilkan aktivasi kronis dari sistem respons stres, mengganggu regulasi afek, keseimbangan neuroendokrin, dan kepercayaan relasional. Menghapus paksaan adalah prasyarat untuk memungkinkan koneksi dan partisipasi yang bermakna, *menghubungkan*, memungkinkan individu untuk terlibat secara sukarela dalam konteks terapeutik, pendidikan, dan sosial yang penting untuk penyembuhan. Hal ini memulihkan kondisi untuk agensi dan pengaturan bersama, yang tanpanya tidak ada perawatan atau pemulihan yang tulus yang dapat terjadi.
- Implementasi perlindungan hukum, dioperasionalkan melalui protokol berbasis hak yang mengikat, transparansi prosedural secara real-time, dan badan pengawas independen yang diberdayakan untuk mencegah, menyelidiki, dan memperbaiki pelanggaran. Hukum, dalam fungsi ini, menjadi struktur penstabil yang melindungi pasien dan profesional dari keputusan yang sewenang-wenang dan kelembaman kelembagaan. Kejelasan hukum memungkinkan individu untuk *memperhatikan*, mengenali, melaporkan, dan bertindak berdasarkan pengalaman ketidakadilan, sehingga memulihkan legitimasi epistemik dan demokratis pada lingkungan perawatan kesehatan jiwa.
- Pelatihan para profesional dalam perawatan berbasis hak, pengobatan yang dipersonalisasi berdasarkan hak asasi manusia, penalaran empiris, dan etika relasional yang kompeten secara budaya. Hal ini harus diimplementasikan sebagai pembelajaran modular seumur hidup, yang dapat diakses oleh berbagai profesi dan disiplin ilmu, yang mendorong keahlian adaptif. Penyedia pengajaran untuk *Terus Belajar* memperkuat pemikiran kritis, reflektivitas, dan

akuntabilitas prosedural, mendobrak kekakuan paradigma yang sudah ketinggalan zaman dan mendorong penyelarasan dinamis dengan bukti terkini dan kompleksitas sosial.

- Pengembangan sistem dukungan yang dipimpin oleh rekan sejawat dan terintegrasi dengan masyarakat, di mana 'rekan sejawat' tidak hanya mengacu pada kategori diagnostik tetapi juga pada kesetaraan epistemik dan kewarganegaraan. Semua individu, baik pengguna, praktisi, anggota keluarga, atau warga negara, harus diperlakukan sebagai pihak yang mampu berkontribusi pada ekosistem perawatan. Struktur ini harus mempromosikan tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan, menggabungkan mekanisme untuk umpan balik timbal balik, dialog restoratif, dan solusi yang dihasilkan bersama. Hal ini memajukan prinsip *Memberi*, membangun solidaritas dan kepercayaan dengan cara-cara yang memperkuat pemulihan pribadi dan ketahanan publik.
- Modernisasi digital dan infrastruktur, termasuk desain dan implementasi sistem pakar etika untuk dukungan keputusan klinis, pemantauan partisipatif, dan pendidikan modular. Sistem-sistem ini harus sepenuhnya dapat diaudit, transparan, dan divalidasi secara ilmiah, sehingga memungkinkan koreksi dan pembelajaran secara real-time. Dengan menyematkan teknologi dalam layanan otonomi dan perlindungan, institusi dapat memfasilitasi validasi profesional yang berkelanjutan dan perencanaan perawatan yang dipersonalisasi. Alat-alat digital dapat memperkuat rutinitas yang mendorong aktivitas fisik, hubungan sosial, dan keterlibatan yang diwujudkan, *Be Active*, yang menyelaraskan fungsi sistemik dengan neurofisiologi kesejahteraan yang dijalani.

Dari sudut pandang peneliti, hampir terbunuh dan keadilan masih ditolak, karena sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkannya, setelah periode panjang penelitian tindakan yang dilakukan dalam kondisi kegagalan institusional yang terdokumentasi yang menyebabkan penyiksaan medis, kejahatan berat terhadap aktor mana pun, apalagi warga sipil yang tidak terlibat dalam upaya perang, kejahatan bahkan dalam situasi seperti itu, restorasi sistemik tata kelola kesehatan jiwa harus dipahami sebagai keharusan kesehatan masyarakat yang berbasis bukti. Langkah-langkah yang diuraikan di sini bukanlah diskresi; mereka berasal langsung dari pelanggaran yang diamati dan dianalisis yang dirinci dalam disertasi ini. Intervensi yang diusulkan selaras dengan mandat dari inisiatif WHO *QualityRights* dan konsensus ilmiah mengenai ketidaksesuaian antara lingkungan yang bersifat koersif dengan hasil kesehatan mental yang berkelanjutan. Seperti yang didefinisikan oleh WHO, kesehatan mental bukanlah ketiadaan patologi, melainkan keadaan fungsional yang ditandai dengan otonomi, kemampuan, dan partisipasi yang produktif. Hal ini tidak dapat dicapai ketika sistem beroperasi tanpa transparansi, akuntabilitas, atau mekanisme perlindungan bagi pengguna layanan dan para profesional (Gill et al., 2024).

Pemantapan infrastruktur layanan berbasis hak membutuhkan integrasi antara ketepatan klinis, legalitas normatif, dan pengawasan partisipatif. Yang terpenting, hal ini tidak hanya mencakup pengurangan dampak buruk, tetapi juga fasilitasi aktif dari akses pendidikan, fungsi ekonomi, dan keterlibatan yang bermartabat dalam masyarakat. Hal-hal tersebut bukanlah kondisi tambahan; semua itu merupakan bagian penting dari kesehatan jiwa masyarakat sebagai standar yang terukur dan dapat

ditegakkan. Ketiadaan dasar-dasar ini secara sistematis menurunkan kelangsungan hidup dari setiap klaim institusional atas legitimasi terapeutik. Oleh karena itu, restrukturisasi sistem perawatan harus dilakukan bukan melalui himbauan moral atau pertentangan ideologis, tetapi melalui desain dan implementasi lingkungan prosedural yang mampu melakukan perbaikan berkelanjutan, koreksi waktu nyata, dan pemantauan hasil. Hal ini membutuhkan pengembangan jalur pendidikan yang tangguh, rutinitas profesional yang sesuai dengan etika, dan struktur tata kelola yang adaptif di berbagai domain kelembagaan. Elemen-elemen ini membentuk inti operasional dari perawatan yang kredibel secara medis dan hukum (Kjellin & Wallsten, 2010; Hotzy & Jaeger, 2016).

Kerangka kerja ini tidak hanya mencakup perawatan psikiatri, tetapi juga berlaku untuk semua lembaga yang terlibat dalam penyediaan dukungan, pengawasan, atau regulasi, pendidikan, hukum, administrasi, dan klinis. Di masing-masing, ketiadaan reflektivitas di tingkat sistem memfasilitasi reproduksi bahaya. Dalam setiap situasi, pemulihan legitimasi bergantung pada kejelasan struktural, perlindungan yang dapat ditegakkan, dan artikulasi fungsional tugas. Urgensi langkah-langkah ini digarisbawahi oleh lintasan geopolitik dan ekologi saat ini. Ketika konflik, pemindahan paksa, dan degradasi lingkungan semakin meningkat, sistem kesehatan jiwa akan merespons sebagai infrastruktur yang menstabilkan atau gagal sebagai akselerator kerentanan. Disertasi ini berpendapat bahwa hanya melalui desain sistem yang terkoordinasi, terinformasi secara ilmiah, dan berlandaskan hukum, kesehatan, seperti yang didefinisikan oleh standar global, dapat dipertahankan.

Dukungan dari kerangka kerja sains internasional yang terkoordinasi, seperti program Koordinasi Sains dan Teknologi COST Uni Eropa, tetap penting dalam upaya ini (Cianconi et al., 2020). Proses pembentukan konsorsium yang telah berjalan mencerminkan komitmen bersama untuk perbaikan kelembagaan dan transformasi berbasis pengetahuan. Jalan ke depan masih sangat kompleks secara teknis dan kontroversial secara politis (Musen, Middleton, & Greenes, 2014). Meskipun demikian, kondisi yang diperlukan untuk perawatan yang koheren, sesuai hukum, dan manusiawi tidak lagi menjadi perdebatan teoritis. Mereka adalah tolok ukur operasional yang implementasinya harus segera dilaksanakan.

Bab 8 - Kesimpulan akhir: kontribusi ilmiah dan desain ulang sistemik

Disertasi ini menyelidiki kondisi struktural di mana sistem psikiatri dapat bertransisi dari model intervensi yang bersifat koersif dan berlebihan menuju bentuk-bentuk perawatan yang berlandaskan ilmiah, menghormati hak-hak, dan berorientasi pada pemulihan, yang didasarkan pada otonomi pasien, pengambilan keputusan bersama, dan praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan budaya. Temuan utama, yang didasarkan pada penelitian lapangan dengan metode campuran selama lima tahun di seluruh domain institusional, klinis, dan komunitas, mengkonfirmasi adanya disonansi yang mendalam dan terus-menerus antara norma-norma legal-etis formal dan realitas praktik kejiwaan.

Penalaran berbasis risiko, otomatisme birokratis, dan kelembaman diagnostik beroperasi sebagai mekanisme penutupan yang mengecualikan narasi, konteks, dan pengalaman hidup dari relevansi klinis, sehingga melumpuhkan kemampuan untuk melakukan koreksi refleksif. Kerugian tidak hanya diproduksi tetapi juga tidak terlihat melalui loop umpan balik yang gagal, di mana penderitaan tidak dilaporkan atau diintegrasikan secara sistematis ke dalam pembelajaran profesional. Hal ini memungkinkan kerusakan iatrogenik dan non-konsensual, termasuk penyiksaan psikologis dan fisik, terus berlanjut tanpa henti, secara tidak proporsional mempengaruhi populasi yang sudah terpinggirkan, salah didiagnosis, atau tidak berdaya secara kelembagaan. Bukti empiris yang dikumpulkan mendokumentasikan bagaimana kekerasan tidak hanya diizinkan, tetapi sering kali dilindungi dalam prosedur rutin, di mana konstruksi hukum yang tidak jelas seperti bahaya yang diduga, ditambah dengan kebijaksanaan profesional yang tidak terkendali, mengarah pada pelanggaran sistematis terhadap integritas tubuh dan psikologis. Protokol dokumentasi memprioritaskan perlindungan diri institusional di atas transparansi, yang secara efektif melindungi para pelaku dari pengawasan dan menghalangi ganti rugi bagi para korban.

Dengan demikian, institusi-institusi kejiwaan seringkali beroperasi di bawah kondisi impunitas struktural, di mana polisi, dokter, dan petugas hukum dapat bertindak secara bersamaan sebagai penyelidik, hakim, dan penegak hukum, sehingga meniadakan prinsip keadilan prosedural. Dalam konteks seperti itu, penyiksaan menjadi mungkin bukan karena kesengajaan yang terang-terangan, melainkan karena konfigurasi sistemik yang menekan perbedaan pendapat, meniadakan akuntabilitas, dan menafsirkan kembali tekanan sebagai gangguan sambil mengkriminalisasi perlawanan. Tidak adanya pendapat kedua, pemantauan independen, dan jalur pengaduan menegaskan adanya penangguhan sistemik terhadap seseorang. Meskipun demikian, penelitian lapangan mengungkapkan adanya profesionalisme yang tidak terlihat, perlawanan etis, dan praktik-praktik perlawanan yang dipimpin oleh para pengguna, penyintas, dan praktisi yang terisolasi yang berjuang untuk mencegah bahaya, menjaga martabat, dan merekonstruksi makna dalam kondisi pengkhianatan institusional.

Praktik-praktik yang muncul ini menunjukkan kelayakan dan perlunya membangun infrastruktur paralel yang didasarkan pada bukti ilmiah, keselarasan hukum normatif, dan epistemologi yang paling ketat yang didasarkan pada kenyataan yang berlabuh pada putaran umpan balik perbaikan translasi ilmu kedokteran mutakhir yang diterapkan di semua tingkatan. Infrastruktur semacam itu harus segera menggabungkan sistem pakar modular untuk dukungan keputusan etis, yang mampu mengaudit intervensi psikiatri dan memandu koordinasi klinis secara real time, di samping platform pendidikan dengan akses terbuka yang mendorong kompetensi naratif dan literasi hukum di seluruh kelompok pengguna dan profesional, bersama dengan sistem pengawasan yang sudah ada dan yang akan ditambahkan. Platform yang berorientasi pada masa depan ini harus beroperasi secara transdisipliner, yang memperjelas keterkaitan antara perawatan kejiwaan dengan faktor penentu sosial, ekonomi, dan budaya kesehatan. Metode-metode mutakhir seperti manajemen pengobatan kolaboratif, transparansi algoritmik dalam proses diagnostik, dan pencocokan terapi berbasis presisi bukan merupakan inovasi perifer, tetapi merupakan langkah penting menuju integritas sistemik perawatan. Evolusi mereka menjadi praktik terbaik formal harus didukung secara institusional, ditegakkan secara normatif, dan dievaluasi secara terus menerus. Kesimpulan yang ditarik tidak hanya bersifat empiris tetapi juga struktural: psikiatri tidak dapat direformasi dari dalam logika kontrol, kebijaksanaan, dan isolasi

epistemik yang sudah ada. Transformasi yang kredibel membutuhkan penambatan bidang ini pada lembaga-lembaga sipil, hukum, dan ilmiah eksternal yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk meminta pertanggungjawaban publik. Oleh karena itu, pergeseran sistemik yang diperlukan ini harus terjadi, dari kontrol terpusat menjadi kolaborasi terstruktur, dari standardisasi satu ukuran untuk semua menjadi presisi yang dipersonalisasi, dari pembungkaman profesional menjadi pendengaran struktural, dan dari penilaian diskresioner menjadi tindakan yang dapat diverifikasi dan direproduksi. Pemulihan legitimasi klinis, koherensi etis, dan kepercayaan publik bergantung pada penerapan sistem pengetahuan dan tanggung jawab yang transparan, yang tertanam di seluruh domain kesehatan, pendidikan, dan tata kelola. Kesehatan, seperti yang didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bukan hanya ketiadaan penyakit, tetapi juga adanya kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Kesehatan mental dipahami sebagai suatu kondisi di mana individu dapat menyadari kemampuannya, mengelola stres secara normal, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitasnya. Di bawah rezim pemaksaan, impunitas, dan penyangkalan epistemik, kondisi seperti itu tidak hanya tidak terpenuhi, tetapi juga dihalangi secara struktural.

Pembangunan sistem perawatan yang layak akan dimulai dengan penghapusan praktik pemaksaan, pelembagaan persetujuan berdasarkan informasi, proseduralisasi martabat, dan pengakuan hukum penuh atas setiap individu sebagai subjek hak. Hukum yang lebih tinggi harus berlaku, melindungi kehidupan dan integritas tubuh, kebebasan warga negara yang bertanggung jawab untuk menjaga diri mereka sendiri dan orang lain dalam tindakan bersama yang mengarah pada perbaikan. Hal ini tidak akan pernah menjadi cita-cita aspiratif belaka -selama mereka yang menyangkal dengan niat buruk menyingkir dan membiarkan pekerjaan yang jujur diutamakan- tetapi merupakan keharusan mendasar yang didukung oleh semua standar internasional, validasi empiris, dan kebutuhan moral. Seiring dengan kemajuan pengetahuan medis dan praktik etis, penghalangan atau penundaan dalam penerapan pendekatan mutakhir tidak hanya tidak dapat dipertahankan secara ilmiah, tetapi juga secara etis dan hukum tercela. Pengembangan profesional yang berkelanjutan, integrasi lintas sektoral, dan modernisasi infrastruktur tidak dapat ditawar. Tidak dapat lagi diterima untuk mempertahankan praktik-praktik yang sudah ketinggalan zaman atau berbahaya atas nama tradisi, otoritas, atau kebijaksanaan. Pola pikir tunggal dan bersama haruslah pola pikir berbasis bukti, menghargai kehidupan, dan kerja sama yang berpijak pada hak asasi manusia, dengan semua sektor masyarakat; medis, hukum, akademis, dan masyarakat, yang bekerja bersama untuk memastikan bahwa apa yang disebut perawatan sesuai dengan namanya.

Transformasi ini, yang didasarkan pada tradisi ilmiah dan medis terbaik, tidak hanya mendesak; tetapi juga sudah terlambat. Kegagalan untuk bertindak akan melanggengkan kondisi di mana hak-hak ditanggihkan, partisipasi ditolak, dan penderitaan dilembagakan. Satu-satunya jalan ke depan yang dapat dilakukan adalah dengan merancang: pembangunan sistem yang mencegah bahaya sebelum terjadi, melindungi mereka yang berisiko, dan mendukung semua orang dalam mengejar kesehatan, otonomi, dan kontribusi sosial. Ini adalah tugas minimum yang harus dilakukan oleh mereka yang telah menderita secara diam-diam di bawah bentuk-bentuk kontrol yang tidak sah, dan kepada semua orang yang tetap, terlepas dari segalanya, berkomitmen untuk membangun kembali struktur yang layak disebut perawatan.

9. Referensi

- Aarons, G. A., Hurlburt, M., & Horwitz, S. M. (2011). Memajukan model konseptual implementasi praktik berbasis bukti di sektor layanan publik. *Administrasi dan Kebijakan dalam Penelitian Kesehatan Mental dan Layanan Kesehatan Mental*, 38(1), 4-23.
- Abbasi, I. S., & Al-Sharqi, L. (2015). Sensor media: Kebebasan versus tanggung jawab. *Jurnal Hukum dan Resolusi Konflik*, 7(4), 21-24.
- Allen, C., & Mehler, D. M. A. (2019). Tantangan, manfaat, dan kiat-kiat sains terbuka di awal karier dan seterusnya. *PLoS Biology*, 17(5), e3000246.
- Alonso-Tejada, F., & López-Morales, ML (2015). Perawatan psikiatri di rumah sakit jiwa Santa Isabel (1936-1939). *History of Psychiatry*, 26(3), 397-410. Membahas profil pasien dan dinamika institusi selama masa perang
- Alotaibi, H. (2025). Tinjauan historis tentang dokter Andalusia dan pengobatan kesehatan mental. *Journal of Bioethical Inquiry*. <https://doi.org/10.1007/s11673-024-10412-5>
- Alvesson, M., & Sköldbberg, K. (2000). *Metodologi refleksif: Pandangan baru untuk penelitian kualitatif*. SAGE Publications.
- Amnesty International. (2019). "Mereka bilang kamu adalah ancaman bagi masyarakat": Praktik-praktik kejiwaan yang kejam di Rusia. Amnesty International.
- Aragonés-Calleja, M., & Sánchez-Martínez, V. (2023).
- Asad, M. R., Almansour, M., Kazmi, S. Y., Alzahrani, R. E., Ahmed, M. M., & Nazeer, M. (2024). Paradigma pendidikan dalam sejarah medis Islam: Sebuah tinjauan. *Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences*, 16(Suppl 1), S56-S59. https://doi.org/10.4103/jpbs.jpbs_969_23
- Bandura, A. (1999). Pelepasan moral dalam melakukan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. *Personality and Social Psychology Review*, 3(3), 193-209.
- Bandura, A. (2017). Mekanisme pelepasan moral. In *Terorisme pemberontak* (pp. 85-115). Routledge.
- Banks, S., Armstrong, A., Carter, K., Graham, H., Hayward, P., Henry, A., & Moore, N. (2013). Etika sehari-hari dalam penelitian partisipatoris berbasis masyarakat. *Ilmu Sosial Kontemporer*, 8(3), 263-277.
- Bartky, S. L. (1990). *Feminitas dan dominasi: Studi dalam fenomenologi penindasan*. Routledge.
- Battie, W. (1975). *Risalah tentang kegilaan (Karya asli diterbitkan tahun 1751)*. Garland.

- Bauer, M. S., Damschroder, L., Hagedorn, H., Smith, J., & Kilbourne, A. M. (2015). Pengantar ilmu implementasi untuk non-spesialis. *BMC Psychology*, 3, 32.
- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Penelitian tindakan partisipatoris. *Jurnal Epidemiologi dan Kesehatan Masyarakat*, 60(10), 854.
- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Penelitian tindakan partisipatoris. *Jurnal Epidemiologi dan Kesehatan Masyarakat*, 60(10), 854-857.
- Becker, H. S. (1963). *Orang luar: Studi dalam sosiologi penyimpangan*. Free Press.
- Bell, K., & Elliott, D. (2014). Penyensoran atas nama etika: penelitian kesehatan masyarakat kritis di era regulasi subjek manusia. *Kesehatan Masyarakat Kritis*, 24(4), 385-391.
- Ben-Ari, E. T. (2002). Sistem pakar dalam kesehatan mental: Implikasi untuk diagnosis dan pengobatan. *AI & Society*, 16(1), 70-79.
- Bentall, R. P. (2003). *Kegilaan dijelaskan: Psikosis dan sifat manusia*. Penguin.
- Berk, M., Kapczinski, F., Andreazza, A. C., Dean, O. M., Giorlando, F., Maes, M., ... & Malhi, G. S. (2011). Jalur yang mendasari perkembangan saraf pada gangguan bipolar: fokus pada peradangan, stres oksidatif, dan faktor neurotropik. *Ulasan ilmu saraf & biobehavioral*, 35(3), 804-817.
- Berry, H. L., Waite, T. D., Dear, K. B., Capon, A. G., & Murray, V. (2019). Kasus pemikiran sistem tentang perubahan iklim dan kesehatan mental. *Nature Climate Change*, 9(4), 310-312.
- Bertolín-Guillén, J. M. (2021). Keadaan psikofarmakologi, psikoterapi, dan intervensi lain saat ini dalam masalah dan gangguan kesehatan mental. *Eur J Appl Sci*, 9(5).
- Bobes, J., Garcia-Portilla, M. P., Bobes-Bascaran, M. T., Parellada, M., Bascaran, M. T., Saiz, P. A., ... & Arango, C. (2012). Keadaan psikiatri di Spanyol. *Tinjauan internasional psikiatri*, 24(4), 347-355.
- Bobes, J., García-Portilla, M., Bobes-Bascarán, T., Parellada, M., Bascarán, M., Sáiz, P., ... & Arango, C. (2012). Keadaan psikiatri di Spanyol. *International Review of Psychiatry*, 24(4), 347-355.
- Bobes, J., Vázquez-Barquero, J. L., & Salvador-Carulla, L. (2010). Reformasi psikiatri dan Undang-Undang Kesehatan Umum 1986 di Spanyol. Dalam *Aksi Bersama untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Mental* (hlm. 15-25). Kesehatan Uni Eropa. Menguraikan upaya-upaya deinstitutionalisasi utama dan pengembangan perawatan komunitas
- Bolade-Ogunfodun, Y., Soga, L. R., & Laker, B. (2023). Posisi yang terjalin dan kerangka acuan interpretatif: Sebuah laporan autoetnografi. *Journal of Management Inquiry*, 32(2), XX-XX.
- Bottaccioli, F., & Bottaccioli, A. G. (2025). Dasar filosofis dan ilmiah untuk integrasi kedokteran dan psikologi. Dalam *PsychoNeuroImmunology: Volume 1: Integrasi Psikologi, Neurologi, dan Imunologi* (pp. 59-95). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Bourdieu, P. (2001). *Dominasi maskulin*. Stanford University Press.

Bourgois, P. (2001). Mencari rasa hormat: Menjual kokain di El Barrio. Cambridge University Press.

Boyle, M. (2002). Skizofrenia: Sebuah khayalan ilmiah? (2nd ed.). Routledge.

Branch, W. T. (2000). Etika kepedulian dan pendidikan kedokteran. *Academic Medicine*, 75(2), 127-132.

Bretaña, I., Mendia, J., Díaz-Gorriti, V., & Rotaetxe, O. (2025). Kekerasan pasangan intim dan gangguan makan: tinjauan sistematis. *Psikologi Terkini*, 44(3), 1696-1716.

Menyatukan inisiatif QualityRights dari Organisasi Kesehatan Dunia dan program Asosiasi Psikiatri Dunia dalam menerapkan alternatif untuk pemaksaan dalam perawatan kesehatan mental: Tujuan bersama untuk bertindak. *BJPsych Open*, 10(1).

Brown, R. A., Barber, P., Hickman, N., & Martin, D. (2023). Hukum kesehatan mental di Inggris dan Wales: Panduan untuk profesional kesehatan mental.

Brown, V. (2009). Kematian sosial dan kehidupan politik dalam studi perbudakan. *American Historical Review*, 114(5), 1231-1249.

Brydán, D. (2016). Poros Internasionalisme: Ahli Kesehatan Spanyol dan 'Eropa Baru' Nazi, 1939-1945. *Contemporary European History*, 25(2), 291-311.

Brydán, D. (2016). Poros Internasionalisme: Ahli Kesehatan Spanyol dan 'Eropa Baru' Nazi, 1939-1945. *Contemporary European History*, 25(2), 291-311.

Burstow, B. (2015). Psikiatri dan bisnis kegilaan: Sebuah akuntansi etis dan epistemologis. Palgrave Macmillan.

Calcedo-Barba, C., Antón Basanta, M., Paz Ruiz, J., Muro Álvarez, J., Elizagárate Zabala, I., Estévez Closas, P., López López, J., & Barrios Flores, S. (2024). Pikiran yang acuh tak acuh, sistem yang rusak: Perawatan kesehatan mental penjara di Spanyol. *Journal of Correctional Health Care*, 30(1), 45-61.

Calvani, R., Picca, A., Lo Monaco, MR, Landi, F., Bernabei, R., & Marzetti, E. (2018). Tentang mikroba dan pikiran: tinjauan naratif tentang penuaan otak kedua. *Perbatasan dalam kedokteran*, 5, 53.

Campos, R., & Novella, E. J. (2017). De la higiene mental a la salud mental: ideología, discursos y prácticas en la España franquista (1939-1975). *Dynamis*, 37(1), 65-87.

Proyek Pedoman Penggambaran Kanada. (2024). Pedoman dan algoritme depreskripsi berbasis bukti yang dikembangkan oleh Bruyère Research Institute dan para kolaborator.

Proyek Pedoman Depreskripsi Kanada (Canadian Deprescribing Guidelines Project). (2024). Pedoman dan algoritme depreskripsi berbasis bukti yang dikembangkan oleh Bruyère Research Institute dan para kolaborator. [Deprescribing.org](https://deprescribing.org).

- Carbonell Marqués, A., & Navarro-Pérez, J. J. (2019). Krisis perawatan di Spanyol: analisis situasi perawatan keluarga dalam kesehatan mental dari perspektif psikososial profesional. *Pekerjaan Sosial dalam Kesehatan Mental*, 17(6), 743-760.
- Carr, C. L. (1988). Pemaksaan dan kebebasan. *American Philosophical Quarterly*, 25(1), 59-67.
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). Penggunaan triangulasi dalam penelitian kualitatif. *Forum Keperawatan Onkologi*, 41(5), 545-547.
- Cañete-Nicolás, C., Hernández-Viadel, M., Bellido-Rodríguez, C., Lera-Calatayud, G., Asensio-Pascual, P., Pérez-Prieto, J. F., ... & Leal-Cercós, C. (2012). Situación en España del tratamiento ambulatorio involuntario (TAI) para enfermos mentales graves. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 40(1).
- Cañete-Nicolás, C., Hernández-Viadel, M., Bellido-Rodríguez, C., Lera-Calatayud, G., Asensio-Pascual, P., Pérez-Prieto, JF, ... & Leal-Cercós, C. (2012). Situación en España del tratamiento ambulatorio involuntario (TAI) para enfermos mentales graves. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 40(1).
- Cañete-Nicolás, C., Hernández-Viadel, M., Bellido-Rodríguez, C., Lera-Calatayud, G., Asensio-Pascual, P., Pérez-Prieto, JF, Calabuig-Crespo, R., & Leal-Cercós, C. (2015). Situasi saat ini dari perawatan rawat jalan paksa di Spanyol. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 40(1), 27-33.
- Chambers, C. (2019). Tujuh dosa psikologi yang mematikan: Manifesto untuk mereformasi budaya praktik ilmiah. Princeton University Press.
- Chambers, D. A., & Azrin, S. T. (2020). Ilmu implementasi: mengubah praktik kesehatan mental. *Tinjauan Tahunan Psikologi Klinis*, 16, 1-30.
- Chmielowska, M., Mannocci, N., Tansel, A., & Zisman-Ilani, Y. (2022). Dukungan rekan kerja dan pengambilan keputusan bersama dalam dialog terbuka: Peluang dan rekomendasi. *Perbatasan dalam Psikologi*, 13.
- Chrousos, G. P. (2009). Stres dan gangguan pada sistem stres. *Nature Reviews Endocrinology*, 5(7), 374-381.
- Cianconi, P., dkk. (2020). Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan mental: Tinjauan deskriptif sistematis. *Perbatasan dalam Psikiatri*, 11, 74.
- Clandinin, DJ, Caine, V., & Lessard, S. (2018). Etika relasional dari penyelidikan naratif. Routledge.
- Pemaksaan dalam keperawatan psikiatri dan kesehatan mental: Sebuah analisis konseptual. *Jurnal Internasional Keperawatan Kesehatan Mental*, 30(3), 590-609.
- Cohen, S. (2001). Keadaan penyangkalan: Mengetahui tentang kekejaman dan penderitaan. Polity Press.
- Cohen, S. (2013). Keadaan penyangkalan: Mengetahui tentang kekejaman dan penderitaan. John Wiley & Sons.

- Cohen, S. I. (1975). Pemberian resep obat psikotropika yang berlebihan. *British Medical Journal*, 4(5995), 520.
- Compton, M. T., & Shim, R. S. (2015). Faktor penentu sosial dari kesehatan mental. *Focus*, 13(4), 419-425.
- Cook, T., Brandon, T., Zonouzi, M., & Thomson, L. (2019). Merusak keseimbangan: Memanfaatkan kekuatan gangguan dalam penelitian tindakan partisipatoris. *Penelitian Tindakan Pendidikan*, 27(3), 379-395.
- Cosgrove, L., & Whitaker, R. (2015). *Psikiatri di bawah pengaruh: Korupsi institusional, cedera sosial, dan resep untuk reformasi*. Palgrave Macmillan.
- Costa, L., Voronka, J., Landry, D., Reid, J., McFarlane, B., Reville, D., & Church, K. (2012). Memulihkan cerita kita: Sebuah tindakan perlawanan kecil. *Studies in Social Justice*, 6(1), 85-101.
- Coulehan, J., & Williams, PC (2001). Mengalahkan kebajikan: Dampak pendidikan kedokteran. *Academic Medicine*, 76(6), 598-605.
- Dain, N. (2007). *Kegilaan dan mitos rumah sakit jiwa: Tanggapan terhadap gangguan jiwa di Amerika Serikat dan Indonesia*. Penerbit Transaction.
- Damschroder, L. J., dkk. (2009). Mendorong implementasi temuan penelitian layanan kesehatan ke dalam praktik: kerangka kerja yang terkonsolidasi untuk memajukan ilmu implementasi. *Ilmu Implementasi*, 4, 50.
- Davies, J., Read, J., & McKeown, M. (2022). Kritik sistem kesehatan mental, bahaya dan alternatif: Sebuah tinjauan cakupan. *Psychosis*, 14(1), 1-14.
- Deegan, P. E. (2006). Pengambilan keputusan bersama dan manajemen pengobatan dalam proses pemulihan. *Psychiatric Services*, 57(11), 1636-1645.
- Degnin, F. D. (2009). Pasien yang sulit, pengobatan yang berlebihan, dan pemikiran kelompok. *The Journal of Clinical Ethics*, 20(1), 64-74.
- Delpit, L. (2006). *Anak-anak orang lain: Konflik budaya di dalam kelas* (2nd ed.). The New Press.
- Dencker, S. J., Ahlfors, U. G., Bech, P., Elgen, K., & Lingjærde, O. (1986). Klasifikasi efek samping dalam psikofarmakologi. *Pharmacopsychiatry*, 19(01), 40-42.
- Desviat, M. (2011). La reforma psiquiátrica 25 años después de la Ley General de Sanidad. *Revista Española de Salud Pública*, 85(5), 427-436.
- Dinan, T., & Dinan, T. G. (Eds.). (2023). *Psikiatri nutrisi: primer untuk dokter*. Cambridge University Press.
- Dingwall, R. (1997). Refleksivitas dan proses penelitian. Dalam J. A. Smith, R. Harré, & L. Van Langenhove (Eds.), *Memikirkan kembali metode-metode dalam psikologi* (hal. 179-192). SAGE Publications.

- Dixon, T. (2015). Pengobatan, pencegahan atau pelabelan: Perspektif pelaku gangguan mental tentang kontrol sosial. *Sosiologi Kesehatan & Penyakit*, 37(2), 232-246.
- Dotson, K. (2012). Sebuah kisah peringatan: Tentang membatasi penindasan epistemik. *Frontiers: Jurnal Studi Perempuan*, 33(1), 24-47.
- Díaz-Gutiérrez, M. J., Martínez-Cengotitabengoa, M., Bermúdez-Ampudia, C., García, S., López, P., Martínez-Cengotitabengoa, M., ... & González-Pinto, A. (2018). Overdosis benzodiazepin/obat Z dan jatuh pada orang dewasa yang lebih tua: Biaya untuk sistem kesehatan. *Gerontologi eksperimental*, 110, 42-45.
- D'Amato, F., Lazzarotto, D., & Leone, P. (2023). Pembiusan tanpa persetujuan: Sebuah bentuk penyiksaan medis di bangsal psikiatri Italia. *European Journal of Criminology*, 20(5), 845-862.
- Ehrenberg, A. (2010). Kelelahan diri: Mendiagnosis sejarah depresi di era kontemporer. McGill-Queen's University Press.
- Eiroa-Orosa, F. J., & Rowe, M. (2017). Membawa konsep pemulihan ke sekolah di Spanyol: Sebuah studi kasus dalam reformasi kesehatan mental. *American Journal of Psychiatric Rehabilitation*, 20(4), 345-363.
- Eiroa-Orosa, F. J., & Rowe, M. (2017). Membawa konsep pemulihan ke sekolah di Spanyol: Sebuah studi kasus dalam reformasi kesehatan mental. *American Journal of Psychiatric Rehabilitation*, 20(4), 345-363.
- Ekbäck, M., Rådmark, J., Molin, E., Strömbäck, M., Midgley, N., & Henje, E. (2024). Kerangka Makna Ancaman Kekuasaan: Sebuah studi kualitatif tentang depresi pada remaja dan dewasa muda. *Jurnal Psikologi Konstruktivis*, Publikasi online lanjutan.
- El-Khoury, J., Haidar, R., & Barkil-Oteo, A. (2021). Penyiksaan psikologis: Karakteristik dan dampaknya terhadap kesehatan mental. *Jurnal Internasional Psikiatri Sosial*, 67(5), 493-503.
- Engel, G. L. (1967). Latar psikologis dari penyakit somatik: kompleks 'menyerah-menyerah'.
- Engel, G. L. (1968). Latar kehidupan yang kondusif untuk penyakit: kompleks menyerah-menyerah. *Annals of Internal Medicine*, 69(2), 293-300.
- Epstein, M. (2013). *Trauma kehidupan sehari-hari*. Penguin Books.
- Espinosa, I., & Comelles, M. (1966). *Estado y asistencia psiquiátrica en España durante el primer tercio del siglo XX*. Valencia: Instituto de Historia de la Medicina.
- Pengalaman pemaksaan di antara para profesional keperawatan di unit kesehatan jiwa tingkat menengah: Sebuah studi kualitatif di Spanyol. *Jurnal Keperawatan Psikiatri dan Kesehatan Mental*, 30(5), 983-993.
- Fals-Borda, O. (1988). *Pengetahuan & Kekuatan Rakyat*. Apex Press.
- Fanon, F. (1963). *Yang celaka di bumi* (C. Farrington, Trans.). Grove Press.

- Farberow, N. L. (2005). Profesional kesehatan mental sebagai penyintas bunuh diri. *Clinical Neuropsychiatry*, 2(1), 13-20.
- Farmer, P. (1999). *Infeksi dan ketidaksetaraan: Wabah-wabah modern*. University of California Press.
- Farmer, P. (2003). *Patologi kekuasaan: Kesehatan, hak asasi manusia, dan perang baru terhadap orang miskin*. University of California Press.
- Farmer, P. (2004). Sebuah antropologi kekerasan struktural. *Current Anthropology*, 45(3), 305-325.
- Farmer, P. (Ed.), Kleinman, A., Kim, J. Y., & Basilio, M. (2013). *Menata ulang kesehatan global: Sebuah pengantar*. University of California Press.
- Farmer, T., Robinson, K., Elliott, S. J., & Eyles, J. (2006). Mengembangkan dan menerapkan protokol triangulasi untuk penelitian kesehatan kualitatif. *Qualitative Health Research*, 16(3), 377-394.
- Fernandez-Real, J. M., Serino, M., Blasco, G., Puig, J., Daunis-i-Estadella, J., Ricart, W., ... & Portero-Otin, M. (2015). Mikrobiota usus berinteraksi dengan mikrostruktur dan fungsi otak. *Jurnal Endokrinologi & Metabolisme Klinis*, 100(12), 4505-4513.
- Fernando, S. (2010). *Kesehatan mental, ras dan budaya* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Fernando, S. (2017). *Rasisme institusional dalam psikiatri dan psikologi klinis: Masalah ras dalam kesehatan mental* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Fernando, S. (2017). *Rasisme institusional dalam psikiatri dan psikologi klinis: Ras penting dalam kesehatan mental*. Palgrave Macmillan.
- Fernández, O., Montero, A. C., Parra, J., & Díaz, M. V. (2018). Cero contenciones: Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan Mental. *Norte de salud mental*, 15(59), 46-62.
- Ferreirós Marcos, CE (2013). *Kesehatan mental dan hak asasi manusia: masalah perawatan ambulatori yang tidak disengaja*.
- Field-Springer, K. (2020). Etnografi yang diwujudkan secara refleksif dengan kepekaan terapan: Refleksi metodologis pada penelitian kualitatif yang terlibat. *Penelitian Kualitatif dalam Psikologi*, 17(2), 112-130.
- Fisher, P. (2012). Mempertanyakan etika kerentanan dan persetujuan dalam penelitian kualitatif dari perspektif kewarganegaraan dan hak asasi manusia. *Etika dan Kesejahteraan Sosial*, 6(1), 2-17.
- Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A., Friedman, R. M., & Wallace, F. (2005). *Penelitian implementasi: Sebuah sintesis dari literatur*. Jaringan Penelitian Implementasi Nasional, Universitas Florida Selatan.
- Flaherty, J. A., Gaviria, F. M., Pathak, D., Mitchell, T., Wintrob, R., Richman, J. A., & Birz, S. (1988). Mengembangkan instrumen untuk penelitian psikiatri lintas budaya. *Jurnal Penyakit Saraf dan Mental*, 176(5), 257-263.

- Foucault, M. (1973). *Kelahiran klinik: Sebuah arkeologi persepsi medis* (A. M. Sheridan, Trans.). Pantheon Books.
- New York: Pantheon Books. 10. Foucault, M. (2003). *Kegilaan dan peradaban*. Routledge.
- Foucault, M. (2006). *Kegilaan dan peradaban: Sejarah kegilaan di zaman nalar* (R. Howard, Trans.). (Awalnya diterbitkan tahun 1961) Vintage.
- Fowers, B. J. (2015). Konflik, Hirarki, Tatahan Sosial, dan Status. Dalam *Evolusi Etika: Sosialitas Manusia dan Munculnya Pikiran Etis* (pp. 267-303). London: Palgrave Macmillan UK.
- Frances, A. (2013). Menyelamatkan yang normal: Pemberontakan orang dalam terhadap diagnosis psikiatri yang tidak terkendali, DSM-5, farmasi besar, dan medisikasi kehidupan biasa. *Psikoterapi di Australia*, 19(3), 14.
- Frances, A. (2013). Menyelamatkan yang normal: Pemberontakan orang dalam terhadap diagnosis psikiatri di luar kendali, DSM-5, farmasi besar, dan medisikasi kehidupan sehari-hari. William Morrow.
- Francisco Torres-Gonzalez. (2022). *Penerimaan dan perawatan paksa di Spanyol: Kerangka hukum dan kesenjangan prosedural*. Organisasi Kebijakan Penyakit Mental.
- Frank, A. W. (1995). *Pendongeng yang terluka: Tubuh, penyakit, dan etika*. University of Chicago Press.
- Freeman, M., & Unwin, P. (2020). Pengekangan mekanis dan konsekuensi psikologis dari kekerasan institusional. *Mental Health Review Journal*, 25(3), 149-160.
- Freire, P. (1970). *Pedagogi kaum tertindas*. Continuum.
- Freire, P. (2000). *Pedagogi kaum tertindas* (edisi ulang tahun ke-30, M. Bergman Ramos, Trans.). Continuum.
- Frenk, J., Chen, L., Bhutta, Z. A., Cohen, J., Crisp, N., Evans, T., ... & Zurayk, H. (2010). Profesional kesehatan untuk abad baru: Mentransformasi pendidikan untuk memperkuat sistem kesehatan di dunia yang saling bergantung. *The Lancet*, 376(9756), 1923-1958.
- Frerichs, L., Lich, K., Dave, G., & Corbie-Smith, G. (2016). Mengintegrasikan ilmu sistem dan penelitian partisipatoris berbasis masyarakat untuk mencapai kesetaraan kesehatan. *American Journal of Public Health*, 106(2), 215-222.
- Fricker, M. (2017). Konsep-konsep yang berkembang tentang ketidakadilan epistemik. Dalam *Buku panduan ketidakadilan epistemik* dari Routledge (hlm. 53-60). Routledge.
- Fuller, K., DeWolfe, T., & Coughlin, M. (2022). Perawatan suportif yang diinformasikan oleh trauma. *Pengamat Perkembangan*, 15(1).
- Gabriel, L., & Casemore, R. (Eds.). (2022). *Etika relasional dalam praktik: Narasi dari konseling dan psikoterapi*. Routledge.

- Gaete, J. M., & Fritsch, R. (2021). Krisis dalam psikiatri: Masalah epistemologis dan tantangan pandangan pluralistik. *Perbatasan dalam Psikiatri*, 12, 694-760.
- Galtung, J. (1990). Kekerasan budaya. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.
- García Espino, J., & Lara Ladislao, A. (1998). *La psiquiatría en la España de fin de siglo: un estudio sobre la reforma psiquiátrica y las nuevas formas de atención en salud mental*. Madrid: Díaz de Santos.
- Gershon, M. D. (1999). Sistem saraf enterik: otak kedua. *Hospital practice*, 34(7), 31-52.
- Gill, N., Drew, N., Rodrigues, M., Muhsen, H., Cano, G. M., Savage, M., ... & Funk, M. (2024). Menyatukan inisiatif QualityRights dari Organisasi Kesehatan Dunia dan program Asosiasi Psikiatri Dunia dalam menerapkan alternatif untuk pemaksaan dalam perawatan kesehatan jiwa: Tujuan bersama untuk bertindak. *BJPsych Open*, 10(1), e23.
- Gill, N., Drew, N., Rodrigues, M., Muhsen, H., Cano, G., Savage, M., ... & Funk, M. (2024).
- Gilligan, C. (1996). *Kekerasan: Refleksi tentang epidemi nasional*. Vintage Books.
- Goffman, E. (1961). *Rumah sakit jiwa: Esai-esai tentang situasi sosial pasien mental dan narapidana lainnya*. Anchor Books.
- González Block, M. A., & Mills, A. (2003). Menilai kapasitas untuk penelitian kebijakan dan sistem kesehatan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. *Kebijakan dan Sistem Penelitian Kesehatan*, 1(1), 1.
- Good, B. (1994). *Pengobatan, rasionalitas, dan pengalaman: Sebuah perspektif antropologi*. Cambridge University Press.
- Good, B. J. (1992). Budaya, diagnosis, dan komorbiditas. *Budaya, Kedokteran dan Psikiatri*, 16(4), 427-446.
- Good, B. J. (1994). *Pengobatan, rasionalitas dan pengalaman: Sebuah perspektif antropologis*. Cambridge University Press.
- Gooding, P., McSherry, B., Roper, C., & Grey, F. (2022). Alternatif untuk pemaksaan dalam pengaturan kesehatan mental: Sebuah tinjauan literatur.
- Goodman, LA, Fels Smyth, K., Borges, AM, & Glenn, C. (2016). Ketika krisis bertabrakan: Bagaimana kekerasan oleh pasangan intim dan kekerasan struktural membentuk kebutuhan di antara perempuan miskin dan tunawisma dengan gangguan jiwa. *Community Mental Health Journal*, 52(7), 748-755.
- Gotzsche, P. (2019). *Obat-obatan yang mematikan dan kejahatan terorganisir: bagaimana farmasi besar telah merusak layanan kesehatan*. CRC press.
- Graham, I. D., Logan, J., Harrison, M. B., Straus, S. E., Tetroe, J., Caswell, W., & Robinson, N. (2006). Tersesat dalam penerjemahan pengetahuan: Saatnya membuat peta? *Jurnal Pendidikan Berkelanjutan dalam Profesi Kesehatan*, 26(1), 13-24.

- Gravlee, C. C. (2022). Desain dan metode penelitian dalam antropologi medis. Dalam Singer, M., & Erickson, P. (Eds.), *Pendamping antropologi medis* (pp. 67-92). Wiley-Blackwell.
- Griffiths, W., & Knutson, A. L. (1960). Peran media massa dalam kesehatan masyarakat. *American Journal of Public Health and the Nations Health*, 50(4), 515-523.
- Grol, R., & Grimshaw, J. (2003). Dari bukti terbaik menuju praktik terbaik: implementasi perubahan yang efektif dalam perawatan pasien. *The Lancet*, 362(9391), 1225-1230.
- Groot, P. C., & van Os, J. (2023). Mengelola gejala putus zat dengan menggunakan tapering strip. *British Journal of General Practice*, 73(730).
- Guidi, J., Lucente, M., Sonino, N., & Fava, G. A. (2020). Beban alostatik dan dampaknya terhadap kesehatan: tinjauan sistematis. *Psikoterapi dan psikosomatik*, 90(1), 11-27.
- Gupta-Wright, M. (2018). Multi-posisi dan 'ketidakberadaan': Refleksi atas penelitian lapangan etnografi di Malawi Tenggara. In *Politik Melakukan Penelitian di Afrika* (pp. 53-73). Springer.
- Guzmán-Parra, J., Aguilera-Serrano, C., García-Sánchez, J., García-Spínola, E., Torres-Campos, D., Moreno, J., ... & Mayoral, F. (2018). Pengalaman paksaan, stres pascatrauma, dan kepuasan dengan perawatan yang terkait dengan tindakan paksaan yang berbeda selama rawat inap psikiatri. *Jurnal Internasional Keperawatan Kesehatan Mental*, 28(2), 448-456.
- Gías Gil, B. (2013). Tratamiento ambulatorio involuntario en psiquiatría: una revisión desde la bioética. *Revista de Bioética y Derecho*, (29), 109-121.
- Gøtzsche, PC (2015), *Psikiatri yang mematikan dan penyangkalan yang terorganisir*. People's Press.
- Hafferty, F. W. (1998). Melampaui reformasi kurikulum: Menghadapi kurikulum tersembunyi kedokteran. *Academic Medicine*, 73(4), 403-407.
- Hahn, R. A. (1995). *Penyakit dan penyembuhan: Sebuah perspektif antropologis*. Yale University Press.
- Harper, D., & Speed, E. (2012). Mengungkap pemulihan: Kebangkitan pemulihan dan ketahanan yang tertahan. *Studies in Social Justice*, 6(1), 9-25.
- Hartmann, E. M., & Crumlish, C. (2022). Praktik pemaksaan dan penyiksaan yang diinduksi oleh obat dalam pengaturan psikiatri forensik. *Psikiatri, Psikologi dan Hukum*, 29(2), 227-239.
- Healy, D. (2012). *Pharmageddon*. University of California Press.
- Heffernan, M. (2002). *Kebutaan yang disengaja: Mengapa kita mengabaikan hal yang sudah jelas dengan membahayakan diri sendiri*. Walker & Company.
- Heim, S. (2016). Rasa malu dalam agama dan kehidupan publik. Dalam J. L. Dolezal & C. Lyons (Eds.), *Rasa malu: Teori, terapi, teologi* (pp. 95-112). Jessica Kingsley Publishers.
- Held, B. S. (2020). Kekerasan epistemologis dan etika wacana dalam psikologi. *Theory & Psychology*, 30(3), 349-370. <https://doi.org/10.1177/0959354319883943>

- Hemer, S. R. (2023). Etika dan kewajiban hubungan etnografi jangka panjang: Momen pewahyuan dan konsep solidaritas. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 29(3), 631-647.
- Hempeler, C., Scholten, M., Werning, A., & Gather, J. (2024). Apa itu pemaksaan dan apakah penggunaannya dapat dibenarkan dalam perawatan kesehatan jiwa? Sebuah analisis etis. Dalam *Paksaan dan kekerasan dalam pengaturan kesehatan mental: Penyebab, konsekuensi, manajemen* (pp. 149-172). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Herman, J. L. (1997). Trauma dan pemulihan: Buntut dari kekerasan -dari kekerasan dalam rumah tangga hingga teror politik. Basic Books.
- Herman, J. L. (1997). Trauma dan pemulihan: Buntut dari kekerasan-dari kekerasan dalam rumah tangga hingga teror politik. Basic Books.
- Hermann, R. C., & Provost, S. (2003). Menafsirkan data pengukuran untuk peningkatan kualitas: Standar, cara, norma, dan tolok ukur. *Psychiatric Services*, 54(5), 655-657.
- Heron, J., & Reason, P. (1997). Paradigma inkuiri partisipatoris. *Qualitative Inquiry*, 3(3), 274-294.
- Hoff, P. (2010). Pengekangan kimiawi: Penggunaan dan penyalahgunaan di rumah sakit jiwa. *Jurnal Internasional Hukum dan Psikiatri*, 33(4), 282-287.
- Hollan, D. (1997). Relevansi etnografi yang berpusat pada orang dengan psikiatri lintas budaya. *Psikiatri Lintas Budaya*, 34(2), 219-234.
- Hollander, D. (2010). Kekerasan struktural dan populasi yang rentan. *Klinik Keperawatan Amerika Utara*, 45(3), 415-426.
- Holmes, S. M., & Marcus, G. E. (2008). Kolaborasi masa kini dan imajinasi ulang adegan klasik pertemuan kerja lapangan. *Antropologi Kolaboratif*, 1(1), 81-101.
- Honey, A., Boydell, K. M., Coniglio, F., dkk. (2020). Penelitian pengalaman hidup sebagai sumber daya untuk pemulihan: Sebuah studi metode campuran. *BMC Psychiatry*, 20, 456.
<https://doi.org/10.1186/s12888-020-02861-0>
- Horowitz, M., & Taylor, DM (2024). Pedoman penggambaran Maudsley: antidepresan, benzodiazepin, gabapentinoid, dan obat-obat Z. John Wiley & Sons.
- Hotzy, F., & Jaeger, M. (2016). Relevansi klinis dari pemaksaan informal dalam perawatan psikiatri - Sebuah tinjauan sistematis. *Perbatasan dalam Psikiatri*, 7.
- Houlders, M., Bortolotti, L., & Broome, M. (2021). Terlibat dengan delusi: Perspektif ketidakadilan epistemik. [Nama Jurnal], [Volume]([Terbitan]), 1-20.
<https://doi.org/10.1136/bmj.4.5995.520>
- Huertas, R. (2017). El inicio de la psiquiatría franquista: el Congreso Nacional de Neurología y Psiquiatría (Barcelona, 1942). *Dynamis*, 37(1), 23-43.

- Hultman, L., & Hultman, M. (2023). "Percayalah, hanya saya yang tahu apa yang saya rasakan." Sebuah catatan autoetnografi tentang pengalaman ketidakadilan epistemik dalam perawatan kesehatan mental. *Frontiers in Psychiatry*, 14.
- Human Rights Watch. (2016). *Hidup di neraka: Kekerasan terhadap penyandang disabilitas psikososial di Indonesia*. Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. (2017). *Hidup di neraka: Penyiksaan di rumah sakit jiwa di Uganda*. Human Rights Watch.
- Hysong, S. J. (2009). Pelajaran dari ketidakberdayaan yang dipelajari: Konsekuensi klinis dari "menyerah". *Clinical Psychology Review*, 29(5), 520-536.
- Insel, T. (2013). Blog direktur: Mengubah diagnosis. Institut Kesehatan Mental Nasional.
- Jacka, F. N., & Berk, M. (2012). Strategi pencegahan dalam depresi: mengumpulkan bukti untuk faktor risiko dan intervensi potensial. *British Journal of Psychiatry*, 201(5), 339-341. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.111.107797>
- Jacka, F. N., O'Neil, A., Opie, R., Itsiopoulos, C., Cotton, S., Mohebbi, M., ... & Berk, M. (2015). Uji coba terkontrol secara acak untuk perbaikan pola makan bagi orang dewasa dengan depresi berat (uji coba SMILES). *BMC Medicine*, 15, 23.
- Jiménez, A. I. (2005). El paciente anciano polimedicado: Pengaruhnya terhadap kesehatan dan sistem kesehatan. *Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud*, 29(6).
- Johnstone, L. (2020). Pola umum dalam Kerangka Makna Ancaman Kekuasaan - prinsip dan praktik. *Jurnal Psikologi Konstruktivis*, 35(1), 16-26.
- Johnstone, L., & Boyle, M. (2018). Kerangka makna ancaman kekuasaan: Sebuah sistem konseptual nondiagnostik alternatif. *Jurnal Psikologi Humanistik*, 0022167818793289.
- Kalathil, J. (2018). Pemulihan dan ketahanan: Narasi perempuan Afrika, Afrika-Karibia, dan Asia Selatan dalam memulihkan diri dari tekanan mental. Yayasan Kesehatan Mental.
- Kalathil, J. (2020). *Kegilaan, kekerasan, dan kekuasaan: Sebuah koleksi kritis*. PCCS Books.
- Kalathil, J., & Fernando, S. (2012). Mempertanyakan 'skizofrenia'. *Open Mind*, 172.
- Kalisch, R., Müller, MB, & Tüscher, O. (2017). Kerangka kerja konseptual untuk studi neurobiologis tentang ketahanan. *Ilmu Perilaku dan Otak*, 38, e92.
- Kelaher, M., Ferdinand, A., & Paradies, Y. (2014). Mengalami rasisme dalam perawatan kesehatan: Dampak kesehatan mental bagi masyarakat Aborigin Victoria. *Medical Journal of Australia*, 201(1), 44-47.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2000). Penelitian tindakan partisipatoris. Dalam N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Buku panduan SAGE tentang penelitian kualitatif* (2nd ed., pp. 567-605). Sage.
- Kenny, K., Fotaki, M., & Scriver, S. (2019). Kesehatan mental sebagai senjata: Pembalasan pelapor dan kekerasan normatif. *Jurnal Etika Bisnis*, 160(3), 801-815.

- Kidd, S., Kenny, A., & McKinstry, C. (2015a). Makna pemulihan dalam layanan kesehatan mental regional: Sebuah studi penelitian tindakan. *Jurnal Keperawatan Lanjut Usia*, 71(1), 181-192.
- Kidder, T. (2003). *Gunung di balik gunung: Pencarian Dr. Paul Farmer, seorang yang akan menyembuhkan dunia*. Random House.
- Kinderman, P. (2014). *Resep untuk psikiatri: Mengapa kita membutuhkan pendekatan baru untuk kesehatan mental dan kesejahteraan*. Palgrave Macmillan.
- Kirk, S. A., & Kutchins, H. (1992).
- Kirk, S. A., Gomory, T., & Cohen, D. (2013). *Ilmu pengetahuan gila: Pemaksaan, diagnosis, dan obat-obatan kejiwaan*. Penerbit Transaction.
- Kirsch, I. (2010) *Obat-obatan baru kaisar: Meledakkan mitos antidepresan*. Basic Books.
- Kitchener, B. A., & Jorm, A. F. (2002). Pelatihan pertolongan pertama kesehatan mental untuk masyarakat: Evaluasi efek pada pengetahuan, sikap, dan perilaku menolong. *BMC Psychiatry*, 2(1), 10.
- Kjellin, L., & Wallsten, T. (2010). Akumulasi paksaan dan hasil jangka pendek dari perawatan psikiatri rawat inap. *BMC Psychiatry*, 10(1).
- Kleinman, A. (1980). *Pasien dan penyembuh dalam konteks budaya: Eksplorasi perbatasan antara antropologi, kedokteran, dan psikiatri*. University of California Press.
- Kleinman, A. (1997). *Menulis di pinggiran: Wacana antara antropologi dan kedokteran*. University of California Press.
- Kortmann, F. (2010). Psikiatri transkultural: Dari praktik ke teori. *Psikiatri Transkultural*, 47(4), 653-664.
- Kuhl, DE (2019). *Kematian klinik: Trans-informasi tatapan klinis untuk melawan kekerasan epistemik* (Disertasi doktoral, The University of Western Ontario, Kanada).
- Ladkin, D. (2007). Penelitian tindakan, inkuiri partisipatoris, dan diri peneliti: Sebuah tinjauan yang lebih mendalam tentang dasar ontologis penelitian tindakan. *Action Research*, 5(3), 333-353.
- Laporte, J. R., Capellà, D., Porta, M., & Frati, M. E. (1983). Pola penggunaan obat-obatan psikotropika di Spanyol dalam perspektif internasional. Dalam *Farmakologi klinis dalam psikiatri: Menjembatani kesenjangan eksperimental-terapeutik* (hal. 18-31). London: Palgrave Macmillan UK.
- Laporte, J. R., Porta, M., Capellà, D., & Arnau, J. M. (1984). Obat-obatan dalam sistem kesehatan Spanyol. *Jurnal internasional pelayanan kesehatan*, 14(4), 635-648.
- Lassiter, L. E. (2005). *Panduan Chicago untuk etnografi kolaboratif*. University of Chicago Press.
- Lehmann, P. (1998). Lepas dari obat-obatan kejiwaan. *Terapi Perilaku*, 223(227), 260.

- Lehmann, P. (1998). Perspektif (mantan) pengguna dan penyintas psikiatri. *Promosi Kesehatan Mental dalam Agenda Eropa*.
- Lehmann, P. (2010). Medisiasi dan tidak bertanggung jawab. *Jurnal Psikologi Kritis, Konseling dan Psikoterapi*.
- Lehmann, P. (2019). Pergeseran paradigma: Alternatif pengobatan untuk obat-obatan psikiatri, dengan referensi khusus untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dalam *Buku Pegangan Routledge tentang Pembangunan Internasional, Kesehatan Mental dan Kesejahteraan* (pp. 251-269). Routledge.
- Lehmann, P. (2024). Psikiatri ditelanjangi: Pelanggaran hak asasi manusia saat ini dalam psikiatri di Jerman, Yunani, dan seluruh dunia. *Jurnal Psikologi Kritis, Konseling dan Psikoterapi*, 24(1), 16-37.
- Leichsenring, F., Steinert, C., & Ioannidis, JP (2019). Menuju pergeseran paradigma dalam pengobatan dan penelitian gangguan mental. *Psychological Medicine*, 49(13), 2111-2117.
- Levin, J., & McDevitt, J. (2002). *Kejahatan kebencian ditinjau kembali: Perang Amerika terhadap mereka yang berbeda*. Westview Press.
- Leys, R. (2018). *Pendakian pengaruh: Genealogi dan kritik*. University of Chicago Press.
- Li, Y., dkk. (2025). Ekspresi gen dan perubahan epigenetik pada PTSD, depresi, dan kecemasan pada responden pertama: Sebuah tinjauan sistematis. *Jurnal Stres Traumatis*.
- Locke, J. (1975). *Esai tentang pemahaman manusia* (P. H. Nidditch, Ed., karya asli diterbitkan tahun 1690). Clarendon Press.
- Lopez-Martinez, A. E., Serrano-Ibanez, E. R., Ruiz-Parraga, G. T., Gomez-Perez, L., Ramirez-Maestre, C., & Esteve, R. (2018). Konsekuensi kesehatan fisik dari trauma interpersonal: Tinjauan sistematis tentang peran variabel psikologis. *Trauma, Kekerasan, & Pelecehan*, 19(3), 305-322.
- Lund, C., Breen, A., Flisher, A.J., Kakuma, R., Corrigall, J., Joska, J.A., Swartz, L., & Patel, V. (2010). Kemiskinan dan gangguan mental yang umum terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah: Sebuah tinjauan sistematis. *Social Science & Medicine*, 71(3), 517-528.
- Lupton, D. (1997). Dokter dalam profesi medis. *Sosiologi Kesehatan & Penyakit*, 19(4), 480-497.
- Maier, S. F., & Seligman, M. E. (1976). Ketidakberdayaan yang dipelajari: teori dan bukti. *Jurnal psikologi eksperimental: umum*, 105(1), 3.
- Mandell, W. (2025). *Asal-usul kesehatan mental. Asal-usul Kesehatan Mental*, (awalnya diterbitkan tahun 1962) Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
4. Markus, K. A. (2020). Kekerasan epistemik dalam ilmu psikologi: Dapatkah pengetahuan tentang, dari, dan untuk orang (yang dilyankan) menyelesaikan masalah? *Teori & Psikologi*, 30(3), 349-370. <https://doi.org/10.1177/0959354319883943>
- Martimianakis, M. A., Maniate, J. M., & Hodges, B. D. (2009). Interpretasi sosiologis dari profesionalisme. *Medical Education*, 43(9), 829-837.

- Martínez-Hernández, A., Pié-Balaguer, A., Serrano-Miguel, M., Morales-Sáez, N., García-Santesmases, A., Bekele, D., & Alegre-Agís, E. (2020). Manajemen kolaboratif pengobatan antipsikotik dan hambatannya: Sebuah studi kualitatif. *Ilmu sosial & kedokteran*, 247, 112811.
- Maté, G. (2021). *Mitos normal: Trauma, penyakit, dan penyembuhan dalam budaya beracun*. Avery.
- Maté, G. (2022). *Mitos normal: Trauma, penyakit, dan penyembuhan dalam budaya beracun*. Knopf Canada.
- McDonald, G. J. (2023). *Khayalan tentang Reformasi: Psikiatri Hukuman dalam Sejarah Soviet (Disertasi doktoral, Universitas Fordham)*.
- McDowell, V. M., Calabria, V., & Bailey, D. (2023). Penelitian tindakan partisipatoris dan sejarah lisan sebagai sekutu alami dalam penelitian kesehatan mental. *Penelitian Kualitatif*, 23(4), 512-530.
- McEwen, B. S., & Wingfield, J. C. (2003). Konsep allostasis dalam biologi dan biomedis. *Hormon dan Perilaku*, 43(1), 2-15.
- McGoey, L. (2007). *Keinginan untuk tidak tahu: Sejarah politik tentang keheningan strategis*. Routledge.
- McNall, M., Reed, C. S., Brown, R., & Allen, A. (2009). Menjembatani keterlibatan masyarakat dan universitas. *Innovative Higher Education*, 33(5), 317-331.
- McTaggart, R. (1991). Prinsip-prinsip untuk penelitian tindakan partisipatoris. *Adult Education Quarterly*, 41(3), 168-187.
- Mead, S., & Filson, B. (2017). Mutualitas dan kekuatan bersama sebagai alternatif dari paksaan dan kekerasan. *Kesehatan Mental dan Inklusi Sosial*, 21(3), 144-152.
- Meloni, F., Vanthuyne, K., & Rousseau, C. (2015). Menuju etika relasional: Memikirkan kembali etika, agensi, dan ketergantungan dalam penelitian dengan anak-anak dan remaja. *Childhood*, 22(3), 340-354.
- Mezzina, R., Borg, M., Marin, I., Sells, D., Topor, A., & Davidson, L. (2006). Dari partisipasi ke kewarganegaraan: Bagaimana mendapatkan kembali peran, status, dan kehidupan dalam proses pemulihan. *Arsip Andrologi*, 9(1), 39-61.
- Mezzina, R., Davidson, L., Borg, M., Marin, I., Topor, A., & Sells, D. (2006). Sifat sosial dari pemulihan: Diskusi dan implikasi untuk praktik. *Arsip Andrologi*, 9(1), 63-80.
- Mezzina, R., Gopikumar, V., Jenkins, J., Saraceno, B., & Sashidharan, SP (2022). Kerentanan sosial dan ketidaksetaraan kesehatan mental dalam "Sindrom": Panggilan untuk bertindak. *Perbatasan dalam psikiatri*, 13, 894370.
- Michener, W. K. (2015). Sepuluh aturan sederhana untuk membuat rencana manajemen data yang baik. *PLOS Computational Biology*, 11(10), e1004525.
- Miles, S., & Freedman, A. (2023). Etika medis dan penyiksaan: Merevisi Deklarasi Tokyo. *The Lancet*, 401(10378), 218-219.

- Mills, C. (2014). Dekolonisasi kesehatan mental global: Psikiatriisasi dunia mayoritas. Routledge.
- Minkler, M., & Wallerstein, N. (Eds.). (2008). Penelitian partisipatoris berbasis komunitas untuk kesehatan: Dari proses ke hasil (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Minkowitz, T. (2022). Memikirkan kembali intervensi peradilan pidana bagi penyandang disabilitas psikososial: Perlunya penghapusan dan dukungan struktural. *Jurnal Internasional Hukum dan Psikiatri*, 82, 101797.
- Mollica, R. F. (2004). Kuesioner Trauma Harvard: Memvalidasi instrumen lintas budaya untuk mengukur penyiksaan, trauma, dan gangguan stres pascatrauma pada pengungsi. *Program Harvard untuk Trauma Pengungsi*.
- Moncrieff, J. (2010). Diagnosis kejiwaan sebagai alat politik. *Teori Sosial & Kesehatan*, 8(4), 370-382.
- Moncrieff, J. (2013). *Hablando claro: Una introducción a los fármacos psiquiátricos*. Barcelona: Herder.
- Moncrieff, J. (2013). *Pil paling pahit: Kisah meresahkan tentang obat antipsikotik*. London: Palgrave Macmillan.
- Montero Bancalero, F. J. (2014). Consideraciones hacia los psicofármacos en profesionales y estudiantes de medicina en España, y en profesionales de la medicina en México y en Colombia: un estudio comparativo (Disertasi Doktor, Universidad de Huelva).
- Montero Carrera, J. (2020). Deprescripción: Lebih dari sekadar penggunaan obat secara rasial. *Medicina de Familia Andalucía*, 21(1).
- Moon G. Risiko dan perlindungan: wacana pasung dalam kebijakan kesehatan jiwa kontemporer. *Tempat Kesehatan*. 2000 Sep;6(3):239-50. doi: 10.1016/s1353-8292(00)00026-5. PMID: 10936778.
- Moyn, S. (2015). Pendamping yang tak berdaya: Hak asasi manusia di era neoliberalisme. *Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer*, 77(4), 147-169.
- Munir, K., & Staats, B. R. (2020). Menanggapi reflektivitas dengan serius: Eksperimen lapangan longitudinal dan pembelajaran peneliti. *Academy of Management Discoveries*, 6(3), 378-403.
- Musen, M. A., Middleton, B., & Greenes, R. A. (2014). Sistem pendukung keputusan klinis. Dalam E. H. Shortliffe & J. J. Cimino (Eds.), *Informatika biomedis: Aplikasi komputer dalam perawatan kesehatan dan biomedis* (pp. 643-674). Springer.
- Méndez, J. E. (2013). Laporan Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (A/HRC/22/53). Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Yayasan Ekonomi Baru. (2008). Lima cara menuju kesejahteraan: Bukti-bukti. Diambil dari [situs konsultasi nef - tidak ada tautan yang disediakan sesuai permintaan]

- Ochocka, J., Janzen, R., & Nelson, G. (2002). Berbagi kekuatan dan pengetahuan: Peneliti profesional dan konsumen/penyintas kesehatan jiwa bekerja sama dalam proyek penelitian tindakan partisipatif. *Psychiatric Rehabilitation Journal*, 25(4), 379.
- Oldani, M. (2014). Deep pharma: Psikiatri, antropologi, dan detoksifikasi farmasi. *Budaya, Kedokteran, dan Psikiatri*, 38(2), 255-278.
- Olson, M., Seikkula, J., & Ziedonis, D. (2014). Elemen-elemen kunci dari praktik dialogis dalam Dialog Terbuka: Kriteria kesetiaan. *Fakultas Kedokteran Universitas Massachusetts dan Advokat untuk Potensi Manusia*.
- Ortiz Lobo, A. (2013). *Hacia una psiquiatría crítica*. Valladolid: Editorial Grupo 5.
- Ortiz-Gómez, T. (2002). *Historia de la psiquiatría y estudios de género en España*. Granada: Instituto de Estudios de la Mujer, Universidad de Granada.
- Oujo Fernández, C. M. *Del Psicoanálisis Multifamiliar a Diálogos Abiertos: Una Experiencia de Aplicación en un Servicio Público de Salud*.
- Palmer, C., Kelly, J. R., Stanton, C., Dinan, T. G., & Cryan, J. F. (2022). Mikrobiota usus, gejala depresi, dan pola makan pada orang dewasa yang tinggal di komunitas. *Jurnal Gangguan Afektif*, 298, 494-502.
- Paradis-Gagné, É., Pariseau-Legault, P., Goulet, M., Jacob, J., & Lessard-Deschênes, C. (2021).
- Paris, J. (2020). *Overdiagnosis dalam psikiatri: Bagaimana psikiatri modern tersesat saat membuat diagnosis untuk hampir semua kemalangan hidup*. Oxford University Press.
- Paris, J. (2024). *Resep untuk pikiran: Pandangan kritis terhadap psikiatri kontemporer*. Oxford University Press.
- Parker, M. (2007). Melakukan etnografi dalam pengaturan medis: Isu-isu praktis dan etis. *Social Science & Medicine*, 65(11), 2248-2259.
- Parrabera-García, S., Oujó-Fernández, C., Lirola, M. J., Cangas, A. J., Marfá-Vallverdú, J., Correa-Urquiza, M., & Garcia-Torrents, E. (2023). Dialog terbuka di Spanyol: survei awal tentang pengetahuan dan perspektif. *Perbatasan dalam Psikologi*, 14, 1166919.
- Patel, N., Williams, A. C. de C., & Kellezi, B. (2018). Meninjau hasil intervensi psikologis dengan penyintas penyiksaan: Isu-isu konseptual, metodologis, dan etis. *Jurnal Penyiksaan*, 26(1), 15-30.
- Patterson, O. (2018). *Perbudakan dan kematian sosial: Sebuah studi komparatif, dengan kata pengantar baru*. Harvard University Press.
- Perrin, E. C., Leslie, L. K., Boat, T. F., & Komite Aspek Psikososial Kesehatan Anak dan Keluarga. (2007). Pengasuhan anak sebagai pencegahan primer. *JAMA*, 298(22), 2715-2717.
- Perry, B. D., & Szalavitz, M. (2017). *Anak laki-laki yang dibesarkan sebagai anjing: Dan kisah-kisah lain dari buku catatan psikiater anak* (3rd ed.). Basic Books.

- Peterson, V. S., & Runyan, A. S. (Eds.). (2010). Isu-isu gender global dalam penelitian lapangan dalam kondisi konflik. Rowman & Littlefield.
- Pies, R. (2007). Seberapa "objektif" diagnosis psikiatri? (coba tebak lagi). *Psychiatry* (Edgmont), 4(10), 18.
- Pies, R. (2008). Di luar keandalan: biomarker dan validitas dalam psikiatri. *Psikiatri* (Edgmont), 5(1), 48.
- Pinel, P., & Esquirol, J.-E. (1994). Tentang keterasingan mental [Des Maladies Mentales] (W. Culpepper, Trans., karya asli diterbitkan 1838). Cambridge University Press.
- Pocobello, R., Seikkula, J., Saunders, R., Mosse, D., & von Peter, S. (2025). Dialog Terbuka di seluruh dunia-implementasi, hasil, pengalaman, dan perspektif. *Perbatasan dalam Psikologi*, 16, 1621237.
- Portero, G. (2010). Tratamiento ambulatorio involuntario de carácter civil: Sebuah revisi. *Cuadernos de Medicina Forense*, 16(1-2), 87-97.
- Portilla, N. de la (2006). La psiquiatría de lengua española en el siglo XXI: realidad y compromiso. En *Memorias del XIV Coloquio IPLE / V Congreso APJ* (pp. x-xx). Guadalajara, México.
- Pozón, S. R. (2012). La toma de decisiones compartidas en pacientes con esquizofrenia: cuestiones médicas y éticas. *Dilemata*, (10), 263-277.
- Prabhu, G. G. (1967). Objektivitas dalam penelitian psikiatri-Sebuah tinjauan. *Indian Journal of Psychiatry*, 9(2), 119-134.
- Priest, N. (2021). Penularan sosial dan bunuh diri: Sebuah tinjauan sosiologis. *Kompas Sosiologi*, 15(10), e12913.
- Pérez-Fernández, F., & Peñaranda-Ortega, M. (2015). La situación de los manicomios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios a comienzos del siglo XX: Un estudio a través de los boletines de la Revista Frenopática Española. *Revista de Historia de la Psiquiatría*, 45, 41-60.
- Pérez-Prieto, J. F., Cañete-Nicolás, C., Hernández-Viadel, M., Leal-Cercós, C., & Calabuig-Crespo, R. (2025). "Seandainya ada orang yang berhenti untuk berbicara dengan saya": Analisis hak asasi manusia terhadap sistem kesehatan mental Spanyol. *Jurnal Kesehatan dan Hak Asasi Manusia*, 27(2), 112-130.
- Pūras, D. (2017). Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto niveau niveau posible de salud física y mental. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Asamblea General.
- Pūras, D. (2017). Laporan Pelapor Khusus tentang hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai (A/HRC/35/21). Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Rakshasa-Loots, AM, Steyn, C., Swiffen, D., Marwick, FK, Semple, RK, Reynolds, RM, ... & Smith, DJ (2025). Biomarker metabolik dari hasil klinis pada penyakit mental yang parah

(METPSY): protokol untuk studi observasional prospektif di Pusat Psikiatri Metabolik. *Psikiatri BMC*, 25(1), 122.

Ramos-Pozón, S., Román-Maestre, B., & Blánquez, B. (2025). Tindakan pemaksaan dalam layanan disabilitas dan layanan kesehatan jiwa: Pengekangan mekanis dari perspektif bioetika dan hukum di Spanyol. *Jurnal Internasional Hukum dan Psikiatri*, 99, 102067.

Ramírez, F., Birtel, MD, Awenat, Y., Fleming, P., Wilkes, S., Williams, S., & Haddock, G. (2024). Kami-Peduli-Saya-Sehat: Mengeksplorasi pemulihan pribadi pengasuh kesehatan mental melalui Penelitian Tindakan Partisipatif. *Perbatasan dalam Kesehatan Masyarakat*, 12, Artikel 1366144.

Read, J., & Harper, D. J. (2020). Kerangka Makna Ancaman Kekuasaan: Mengatasi kesulitan, menantang prasangka dan stigma, dan mengubah layanan. *Jurnal Psikologi Konstruktivis*, 35(1), 54-67.

Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.). (2001). *Buku pegangan penelitian tindakan: Inkuiri partisipatoris dan praktik*. Sage.

Riker, W. H. (2017). Kepercayaan sebagai alternatif dari pemaksaan. In *Coercion* (pp. 198-212). Routledge.

Roberts, C. (2000). Dialog, posisionalitas, dan pembingkai hukum penelitian etnografi. *Sociological Research Online*, 5(4), 1-13.

Rodríguez-Cabrera, L., dkk. (2024). Perubahan epigenetik yang dihasilkan pada perempuan korban kekerasan pasangan intim: tinjauan sistematis. *Jurnal Epigenetik Klinis*.

Rodríguez-Morini, A. (2002). El debate en torno a los manicomios entre los siglos XIX y XX. *Dynamis: Acta Hispánica Ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam*, 17(1), e027.

Roncero, C., Armenteros, L., Bellido-Cambrón, C., Bonilla-Guijarro, A., & Gómez-Cibeira, E. (2025). Penggunaan benzodiazepin di Spanyol: risiko dan perspektif tentang situasi saat ini dan proposal untuk penggunaan rasional mereka. *Perbatasan dalam Farmakologi*, 16, 1547488.

Rose, D. (2008). Tentang perlunya penyintas kejiwaan untuk terlibat dalam penelitian: Refleksi tentang diri kita sendiri sebagai rekan peneliti. *Jurnal Kesehatan Mental*, 17(4), 427-436.

Rose, K. E., & Webb, C. (1997). Triangulasi pengumpulan data: Praktik dan masalah dalam studi tentang pengasuh informal pasien kanker yang sakit parah. *Journal of Advanced Nursing*, 26(6), 1221-1228.

Rose, N. (2001). *Mengatur jiwa: Membentuk diri pribadi* (2nd ed.). Free Association Books.

Rose, N. (2007). *Politik kehidupan itu sendiri: Biomedis, kekuasaan, dan subjektivitas di abad ke-21*. Princeton University Press.

Rose, N. (2018). *Masa depan kejiwaan kita*. John Wiley & Sons.

Rosenhan, D. L. (1973). Tentang menjadi waras di tempat yang tidak waras. *Science*, 179(4070), 250-258.

- Rosenquist, J. N., Fowler, J. H., & Christakis, N. A. (2011). Penentu jaringan sosial dari depresi. *Molecular Psychiatry*, 16(3), 273-281.
- Rothschild, B. (2000). *Tubuh mengingat: Psikofisiologi trauma dan perawatan trauma*. WW Norton & Company.
- Russell, B. (2009). Ilmu pengetahuan yang buruk digunakan untuk mendukung penyiksaan dan eksperimen pada manusia. *Science*, 325(5941), 1485-1487.
- Russo, J. (2012). Penelitian yang dikontrol oleh penyintas: Landasan baru untuk berpikir tentang psikiatri dan kesehatan mental. *Forum: Penelitian Sosial Kualitatif*, 13(1).
<https://doi.org/10.17169/fqs-13.1.1790>
- Sachdev, P. S., Whiteford, H., Saxena, S., & Van Ommeren, M. (2022). Hambatan dalam memperluas layanan kesehatan mental di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. *World Psychiatry*, 21(1), 37-53.
- Sagie, A., Birati, A., & Tziner, A. (2002). Menilai biaya penarikan perilaku dan psikologis: Sebuah model baru dan ilustrasi empiris. *Psikologi terapan*, 51(1), 67-89.
- Sailas, E., & Fenton, M. (2000). Pengasingan dan pengekangan untuk orang dengan gangguan jiwa serius. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (2), CD001163.
- Salvador-Carulla, L., Costa-Font, J., Cabases, J., McDaid, D., & Alonso, J. (2010). Mengevaluasi perawatan dan kebijakan kesehatan mental di Spanyol. *Jurnal Kebijakan dan Ekonomi Kesehatan Mental*, 13(2), 73.
- Samson, C., & McGregor, J. (2022). Penahanan psikiatri dan negara: Perampasan, penahanan, dan kapitalisme rasial. *Kesehatan Masyarakat Kritis*, 32(3), 327-340.
- Sanati, A., & Kyratsous, L. (2015). Delusi dan kredibilitas: Ketidakadilan testimonial dalam praktik kejiwaan. *Psychological Medicine*, 45(3), 476-483. <https://doi.org/10.1017/S0033291714001699>
- Sanguineti, M. C. D., Fonseca, L., Burgess, R. A., Concha, N., González, M., San Juan, N. V., ... & Jovchelovitch, S. (2025). Melawan kekerasan epistemik dalam kesehatan mental global: Mendengarkan pemahaman lokal tentang kesehatan mental dan tekanan emosional di antara para korban dan mantan anggota gerilyawan di Kolombia Selatan. *SSM-Kesehatan Mental*, 7, 100385.
- Sarella, A., Aghedo, P. A., & Bhatia, K. (2023). Manajemen farmakologis dan non-farmakologis gangguan bipolar dengan penyakit Huntington yang menyertai: Sebuah laporan kasus. *Jurnal Farmakologi dan Penelitian Klinis*, 3(2), 85.
- Sashidharan, S. P., Mezzina, R., & Puras, D. (2019). Mengurangi pemaksaan dalam perawatan kesehatan mental. *Epidemiologi dan ilmu kejiwaan*, 28(6), 605-612.
- Scheper-Hughes, N. (1992). *Kematian tanpa tangisan: Kekerasan dalam kehidupan sehari-hari di Brasil*. University of California Press.

Scheper-Hughes, N. (2001). Kegilaan karena kelaparan: Penyakit, delirium, dan kebutuhan manusia. Dalam N. Scheper-Hughes & L. Wacquant (Eds.), *Kekerasan dalam perang dan damai: Sebuah antologi* (hlm. 302-305). Blackwell.

Scheper-Hughes, N., & Bourgois, P. (Eds.). (2004). *Kekerasan dalam perang dan damai: Sebuah antologi*. Blackwell Publishing.

Scheper-Hughes, N., & Lock, M. M. (1987). Tubuh yang sadar: Sebuah prolegomena untuk pekerjaan masa depan dalam antropologi medis. *Medical Anthropology Quarterly*, 1(1), 6-41.

Scheper-Hughes, N., & Lock, M. M. (1987). Tubuh yang sadar: Sebuah progresi untuk pekerjaan masa depan dalam antropologi medis. *Medical Anthropology Quarterly*, 1(1), 6-41.

Schmale, A. H., & Engel, G. L. (1967). Kompleks menyerah yang diilustrasikan dalam film. *Archives of General Psychiatry*, 17(2), 135-145.

Schneider, B. (2012). Penelitian tindakan partisipatoris, penelitian pengguna layanan kesehatan jiwa, dan proyek Hearing (Our) Voices. *International Journal of Qualitative Methods*, 11(2), 152-165.

Schneider, B. (2012). Penelitian tindakan partisipatoris, penelitian pengguna layanan kesehatan jiwa, dan proyek Hearing (Our) Voices. *International Journal of Qualitative Methods*, 11(2), 112-127.

Schreurs, B. G., Griffith, J. L., & Solomon, R. L. (1984). Peran instruksi sebelumnya dalam ketidakberdayaan yang dipelajari: "Menyerah" sebagai sebuah set kognitif. *Belajar dan Motivasi*, 15(3), 259-277.

Seikkula, J., & Olson, ME (2003). Pendekatan dialog terbuka untuk psikosis akut: Puitika dan mikropolitiknya. *Family Process*, 42(3), 403-418.

Serrano-Miguel, M. (2022). Kesehatan mental colectiva y trabajo sosial. Sebuah kesempatan untuk praktik-praktik baru dalam perhatian sosial terhadap kesehatan mental. *Cuadernos de Trabajo Social*, 2022, vol. 35, num. 2, hal. 243-252.

Serrano-Miguel, M., Pié-Balaguer, A., & Martínez-Hernández, Á. (2020). Guía para la gestión colaborativa de la medicación en salud mental. Universitat Rovira i Virgili.

Shaw, E. (2007). Sikap mahasiswa kedokteran terhadap penyiksaan, ditinjau kembali. *Jurnal Kesehatan dan Hak Asasi Manusia*, 10(2), 25-41.

Sheridan Rains, L., Johnson, S., Barnett, P., & Jones, A. (2019). Hak dan perlindungan hukum dalam perawatan psikiatri paksa di seluruh Eropa. *European Journal of Public Health*, 29(5), 868-874.

Simmons, T. (2025). Mengintegrasikan kesehatan mental ke dalam kerangka One Health. *UTMB One Health News*. 1 Mei 2025.

Simopoulos, E. F., & Trinidad, A. C. (2013). Disfungsi ereksi pria: mengintegrasikan psikofarmakologi dan psikoterapi. *Psikiatri rumah sakit umum*, 35(1), 33-38.

- Singer, M., & Baer, H. A. (2007). Memperkenalkan antropologi medis: Sebuah disiplin ilmu dalam tindakan. AltaMira Press.
- Smith, A., van Voren, R., & Liebrezn, M. (2024). Tren yang muncul kembali dalam psikiatri hukuman di Federasi Rusia. *The Lancet Regional Health-Europe*, 42.
- Smith, C. P. (2016). Pertama, jangan menyakiti: Pengkhianatan institusional dalam perawatan kesehatan (Disertasi doktor). University of Oregon.
- Solnit, R. (2009). Surga yang dibangun di neraka: Komunitas-komunitas luar biasa yang muncul dalam bencana. Viking.
- Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Administrasi Kesehatan Spanyol (2020). Hukum dan kesehatan mental: Tujuan yang telah dicapai dan tantangan yang tertunda di Spanyol. *Jurnal Internasional Hukum Kesehatan Masyarakat*, 14(2), 123-134.
- Speers, J., & Lathlean, J. (2015). Keterlibatan pengguna layanan dalam memberikan umpan balik kepada mahasiswa kesehatan jiwa mengenai penempatan: Sebuah studi penelitian tindakan partisipatif. *Nurse Education Today*, 35(9), e84-e89.
- Staub, E. (1989). Akar-akar kejahatan: Asal-usul genosida dan kekerasan kelompok lainnya. Cambridge University Press.
- Stover, E., & Nightingale, E. (2000). Penghancuran Tubuh dan Pikiran: Penyiksaan, Penyalahgunaan Psikiatri, dan Etika Kedokteran. AAAS.
- Strous, R. D. (2006). Psikiater Hitler: penyembuh dan peneliti yang menjadi algojo dan relevansinya saat ini. *Harvard review of psychiatry*, 14(1), 30-37.
- Subramani, S. (2019). mempraktikkan reflektivitas: Etika, metodologi, dan konstruksi teori. *Jurnal Penelitian Kualitatif & Etika*, 6.
- Suess Schwend, A., dkk. (2016). Perencanaan pengambilan keputusan dalam kesehatan mental: Modelos, utilidades y propuestas de aplicación. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 36(129), 79-102.
- Suleman, A., Fatima, A., Mazhar, N., & Hashmi, A. M. (2025). Slip diam: Peresepan benzodiazepin yang berlebihan pada psikiatri rawat jalan. *BJPsych Open*, 11 (S1), S280 - S281.
- Sullivan, GM, Feinn, R., & Lin, Y. (2019). Praktik pelaporan dan transparansi dalam sains: Kebangkitan ilmu pengetahuan terbuka dan kemampuan untuk direproduksi. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Pascasarjana*, 11(5), 525-528.
- Sweeney, A., Clement, S., Filson, B., & Kennedy, A. (2016). Layanan kesehatan mental berbasis trauma di Inggris: Apa itu dan bagaimana kita dapat memajukan perkembangannya? *Mental Health Review Journal*, 21(3), 174-192.
- Sweeney, A., Filson, B., Kennedy, A., Collinson, L., & Gillard, S. (2018). Pergeseran paradigma: Hubungan dalam layanan kesehatan mental berbasis trauma. *BJPsych Advances*, 24(5), 319-333.

Szasz, T. S. (2007). Pemaksaan sebagai penyembuhan: Sejarah kritis psikiatri. Penerbit Transaction.

Tadesse, D. M., Mekonnen, W. A., Fekadu, A., & Thornicroft, G. (2022). Menggunakan penelitian tindakan partisipatoris untuk mengujicobakan model keterlibatan pengguna layanan dan pengasuh dalam penguatan sistem kesehatan mental di layanan kesehatan primer Ethiopia: Sebuah studi kasus. *Jurnal Internasional Sistem Kesehatan Mental*, 16, Artikel 45.

<https://doi.org/10.1186/s13033-022-00545-8>

Tekin, Ş. (2022). Objektivitas interaktif partisipatif dalam psikiatri. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, 89(5), 1166-1175.

Model biomedis gangguan mental: Analisis kritis tentang validitas, kegunaan, dan efeknya pada penelitian psikoterapi. *Ulasan Psikologi Klinis*, 33(7), 846-861.

Peran psikiater dalam menerapkan model perawatan dialog terbuka. *Jurnal Terapi Keluarga Australia dan Selandia Baru*, 40(3), 319-329.

Penjualan DSM: Retorika ilmu pengetahuan dalam psikiatri. Aldine de Gruyter.

Tomé, P. (2014). Pactos de cuidado. *Revista Mujeres y Salud*, 36, 16-19.

Toro, J., Mur, M., & Cantó, T. (2006). Perawatan psikiatri untuk anak-anak dan remaja yang disukai oleh psikiater Spanyol. *Jurnal psikiatri Eropa*, 20(4), 231-241.

Torrents, E. G., & Björkdahl, A. (2024). Alternatif-alternatif untuk pemaksaan. Dalam Pemaksaan dan kekerasan dalam pengaturan kesehatan jiwa: Penyebab, konsekuensi, manajemen (pp. 373-403). Cham: Springer Nature Switzerland.

Tuke, W. (1975). Deskripsi Retret di York (Karya asli diterbitkan tahun 1796). Garland.

Tuncak, B. (2017). Laporan Pelapor Khusus tentang implikasi hak asasi manusia dari pengelolaan dan pembuangan zat dan limbah berbahaya yang berwawasan lingkungan (A/HRC/36/41). Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tusell, F. (2010). Psikiatri Spanyol pada masa Republik Kedua, Perang Saudara, dan era Franco. *History of Psychiatry*, 21(4), 445-458. Meneliti pengaruh ideologi dan politik terhadap kesehatan jiwa tahun 1930-an

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. (2015). Pasung: "Pemasungan" orang dengan disabilitas psikososial.

Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2015). Pasung: "Pemasungan" orang dengan disabilitas psikososial. OHCHR. (Catatan: Praktik ini secara resmi dilarang di Indonesia melalui Keputusan Presiden pada tahun 1977, ditegaskan kembali pada tahun 2016, namun praktiknya masih terus berlanjut hingga saat ini, karena sulit untuk dicapai tanpa adanya komitmen penuh dari masyarakat terhadap hukum dan kesehatan di semua negara).

Van Bilsen, H. P. J. G. (2016). Pelajaran yang dapat dipetik dari layanan psikiatri komunitas tertua di dunia: Geel di Belgia. *BJPsych Bulletin*, 40(4), 198-202.

- Van der Kolk, BA (2014). Tubuh menjaga skor: Otak, pikiran, dan tubuh dalam penyembuhan trauma. Viking.
- van Strien, T., Cebolla, A., Etchemendy, E., Gutierrez-Maldonado, J., Ferrer-Garcia, M., Botella, C., & Baños, R. (2013). Makan emosional dan asupan makanan setelah kesedihan dan kegembiraan. *Appetite*, 66, 20-25.
- Verdugo, M. A., Schalock, R. L., Arias, V. B., Gómez, L. E., & Escorial, M. T. (2012). Konsep kualitas hidup dan perannya dalam meningkatkan hak asasi manusia di bidang disabilitas intelektual. *Journal of Intellectual Disability Research*, 56(11), 1036-1045.
- Viadel, M. H., Prieto, J. F. P., Nicolás, C. C., Calatayud, G. L., & Millán, T. R. (2006). Perawatan ambulatorio involuntario (TAI) untuk orang dengan gangguan mental berat. *Psiquiatría Biológica*, 13(5), 183-187.
- Villagrán, J. M., Lara Ruiz-Granados, I., & González-Saiz, F. (2015). Aspectos conceptuales sobre el proceso de decisión compartida en salud mental. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 35(127), 455-472.
- Walker, S., MacKay, E., Barnett, P., Rains, L., Leverton, M., Dalton-Locke, C., ... & Johnson, S. (2019). Faktor klinis dan sosial yang terkait dengan peningkatan risiko rawat inap psikiatri paksa: Tinjauan sistematis, meta-analisis, dan sintesis naratif. *The Lancet Psychiatry*, 6(12), 1039-1053.
- Watnik, IL (2001). Analisis konstitusional terhadap hukum Kendra: Solusi New York untuk perawatan orang dengan gangguan jiwa kronis. *University of Pennsylvania Law Review*, 149(4), 1181-1228.
- Watts, J. (2024). Ketidakadilan epistemik dari gangguan kepribadian ambang. *BJPsych International*, 21(4), 78-82. <https://doi.org/10.1192/bji.2024.16>
- Weiss, M. G., & Somma, D. (2007). Model-model penjelasan dalam psikiatri. *Buku teks psikiatri budaya*, 1, 127-140.
- Whitaker, R. (2005). Anatomi sebuah epidemi: Obat-obatan psikiatri dan peningkatan penyakit mental yang mencengangkan di Amerika. *Etika Psikologi Manusia dan Psikiatri*, 7(1), 23.
- Whitaker, R. (2010). Anatomi sebuah epidemi: Peluru ajaib, obat-obatan psikiatri, dan kebangkitan penyakit mental yang mencengangkan di Amerika. Crown Publishing.
- Wilkinson, R., & Pickett, K. (2010). *Tingkat semangat: Mengapa kesetaraan lebih baik untuk semua orang*. Penguin.
- Woolf, S. H. (2008). Makna penelitian translasional dan mengapa hal itu penting. *JAMA*, 299(2), 211-213.
- Organisasi Kesehatan Dunia. (2010). *Kesehatan mental dan pembangunan: Menargetkan orang dengan kondisi kesehatan mental sebagai kelompok rentan*. Organisasi Kesehatan Dunia.
- Organisasi Kesehatan Dunia. (2020). *Cetak biru kebijakan kesehatan jiwa dan reformasi hukum*. WHO. Diambil dari situs web WHO

Organisasi Kesehatan Dunia. (2023). Strategi global kesehatan digital 2020-2025 dan implikasi untuk implementasi kesehatan mental.

Wrangham, R. W., Wilson, M. L., & Muller, M. N. (2006). Perbandingan tingkat kekerasan pada simpanse dan manusia. *Primata*, 47(1), 14-26.

Wyman, S. (2023). Badai psikotropika: Analisis tentang resep psikotropika yang berlebihan dan hukum. *Law & Psychology Review*, 48, 139.

Young, A. (1982). Antropologi penyakit dan penyakit. *Tinjauan Tahunan Antropologi*, 11, 257-285.

Zanardo, A., & Ventura, C. (2023). Inisiatif QualityRights WHO dan penggunaannya di seluruh dunia: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Internasional Psikiatri Sosial*, 70(3), 424-436.

Zola, I. K. (1972). Kedokteran sebagai institusi kontrol sosial. *The Sociological Review*, 20(4), 487-504.

Мандрик-Мельничук, М. (2024). Transformasi psikiatri Soviet: dari cabang kedokteran menjadi sistem hukuman untuk memerangi perbedaan pendapat. *Актуальні питання суспільних наук та історії медицини*, (2), 87-96.

Indeks dan pemetaan tematik

Di bawah ini adalah pemetaan yang disusun secara tematis dari konsep-konsep utama disertai, selaras dengan bab-bab dan lampiran-lampiran di mana setiap konsep dikembangkan secara substantif. Tabel ini mendukung orientasi pembaca dan memperjelas arsitektur konseptual di seluruh

dimensi empiris, hukum, dan terapan dari karya ini. Harap dicatat bahwa karena tekanan institusional yang berkelanjutan, batasan-batasan yang kejam, dan kondisi-kondisi yang tidak bersahabat secara struktural yang dialami selama tahap-tahap akhir persiapan disertasi, yang bertepatan dengan beban kerja akademis, hukum, dan koordinasi yang padat, maka tidak memungkinkan untuk menyertakan keseluruhan isi, bukti, dan sumber daya analisis dalam versi cetak ini. Pembatasan format yang parah, ditambah dengan tenggat waktu yang sensitif terhadap waktu dan episode penghalangan dan kekerasan yang berulang-ulang, semakin membatasi kemampuan untuk membuat dokumen ini dalam bentuk yang lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan.

Pemaksaan dalam psikiatri adalah tema sentral yang muncul di seluruh disertasi. Hal ini dibahas di bagian 1.1 dalam bentuk historisnya di bawah represi institusional dan psikiatri carceral, di bagian 1.2 sebagai bagian dari kerangka kerja saat ini tentang pengobatan paksa, dan di bagian 1.6 dan 1.7 sebagai kegagalan sistemik dan pengecualian diagnostik yang berhubungan dengan kekuasaan. Hal ini juga ditampilkan secara menonjol pada bagian 2.2, 2.4, dan 2.7 dalam analisis paksaan melalui penelitian dengan metode campuran dan metodologi reflektif. Bagian 3.1 sampai 3.3 menguraikan pengalaman hidup dari pemaksaan, terutama dalam lingkungan institusional, sementara bagian 4.1 sampai 4.4 memperluas analisis ini melalui dokumentasi etnografis dari praktik-praktik pemaksaan. Bagian 5.1 menghubungkan pemaksaan kejiwaan dengan ketidakberdayaan yang dipelajari, sementara bagian 6.2 memperlakukan pemaksaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia internasional.

Kekerasan struktural diidentifikasi dalam bagian 1.2, 1.3, dan 1.6 sebagai sesuatu yang tertanam dalam sistem kejiwaan yang farmakosentris. Hal ini dikembangkan secara analitis di bagian 2.1, 2.2, dan 2.7 sebagai temuan empiris dan tantangan metodologis, kemudian didokumentasikan lebih lanjut melalui kesaksian peserta di bagian 3.3 dan 4.3. Efek jangka panjangnya terhadap kesehatan dan perkembangan saraf dibahas di bagian 5.1 dan 5.2, dan implikasi hukumnya ditelaah di bagian 6.2.

Pengkhianatan institusional dieksplorasi dari bagian 1.5 dan seterusnya, dengan penekanan khusus pada bagian 3.4 hingga 3.7 sebagai fenomena relasional dan organisasional yang memengaruhi pengguna dan profesional. Pada bagian 4.1 hingga 4.4, hal ini dianalisis melalui rekonstruksi naratif dan bukti etnografis. Istilah ini muncul kembali pada bagian 5.1 dan 6.2 ketika membahas impunitas struktural, akuntabilitas forensik, dan kegagalan perlindungan hukum.

Ketidakadilan epistemik muncul sebagai konsep inti pada bagian 1.5 tentang dasar-dasar hukum dan epistemik, dan dikembangkan lebih lanjut pada bagian 1.7 melalui lensa diagnosis dan pengecualian. Secara metodologis, konsep ini membingkai bagian 2.1, 2.2, 2.5, dan 2.6. Data empiris yang mencerminkan ketidakadilan epistemik disajikan pada bagian 3.2 hingga 3.6 dan sekali lagi pada bagian 4.5 dan 4.6 melalui penghapusan kesaksian dan penyitaan narasi. Bagian 5.2 dan 5.4 menghubungkannya dengan diagnosa reduksionis, dan 7.1 dan 7.3 mengusulkan tanggapan pendidikan.

Pengambilan keputusan bersama diperlakukan sebagai model tandingan untuk pemaksaan dalam psikiatri, yang dibahas di bagian 1.4 mengenai depreskripsi dan otonomi pengguna. Hal ini juga merupakan bagian dari instrumen penelitian yang dijelaskan di bagian 2.3 dan dianalisis dalam temuan di bagian 3.1 dan 3.6. Hal ini muncul lagi di bagian 5.5 sebagai bagian dari proposal reformasi

hukum, dan di bagian 7.2 dalam kerangka kerja yang berorientasi pada masa depan untuk perawatan kejiwaan berbasis hak.

Farmakosentrisme dan pengobatan berlebihan dianalisis di bagian 1.3 sebagai fitur sistemik dari perawatan psikiatri Spanyol. Bagian 1.4 berfokus pada alternatif seperti depreskripsi dan etika pengobatan jangka panjang. Tema-tema ini kemudian dirujuk dalam temuan empiris (bagian 3.6 dan 5.4) dan dibahas secara normatif di bagian 6.1 dan 6.3 melalui proposal untuk literasi neurobiologis, regulasi somatik, dan sistem pakar sumber terbuka.

Penelitian tindakan transdisipliner diuraikan dalam bagian 1.0, 1.8, dan 2.1 sebagai metodologi menyeluruh. Metodologi ini juga mendasari pekerjaan di bagian 2.4 dan 2.9 melalui penerapannya dalam metode campuran, reflektivitas, dan transformasi sistemik. Desain ini ditegaskan kembali di bagian 5.5 dan 7.1 hingga 7.3 yang mengacu pada implementasi di masa depan melalui pendidikan One Health dan tata kelola partisipatif.

Akuntabilitas hukum dikembangkan di bagian 1.2, 1.5, dan 1.6 sehubungan dengan praktik-praktik pemaksaan dan pelanggaran hak. Bagian 3.7 dan 4.3 menganalisa ambiguitas hukum, pembungkaman kelembagaan, dan kegagalan akuntabilitas. Bagian 5.5 mengusulkan standar legal-pedagogis yang baru, sementara bagian 6.2 membahas keselarasan praktik nasional dengan hukum hak asasi manusia internasional dan prinsip-prinsip CRPD.

Psikiatri biokultural dan perawatan berbasis trauma muncul di bagian 1.4 dan 1.6, dan secara lebih eksplisit di bagian 2.1 dan 2.5 sebagai fondasi untuk paradigma klinis yang baru. Bagian 5.2 mengaitkan trauma biokultural dengan perkembangan saraf, dan 7.1 dan 7.3 menyajikannya sebagai bagian dari transformasi kurikulum untuk para profesional kesehatan mental dan perawatan sosial.

Kedaulatan naratif dan keadilan kesaksian diartikulasikan di bagian 4.3, 4.5, dan 4.6 sebagai koreksi atas kekerasan epistemik dan diagnosa reduksionis. Tema-tema ini juga membingkai metode partisipatoris (bagian 2.3 dan 2.8) dan muncul kembali di bagian 5.4 dan 6.3 dalam proposal reformasi struktural dan pendidikan.

One Health diperkenalkan pada bagian 1.8 dan dikembangkan sebagai konsep pemersatu pada bagian 2.8, 5.5, 6.1, dan 7.3. Konsep ini memberikan kerangka kerja untuk etika integratif, pendidikan interdisipliner, dan desain sistem tangguh yang menangani kesehatan mental, fisik, dan ekologi secara bersamaan.

AI etis dan sistem pakar dalam psikiatri muncul di bagian 6.3 dan 7.2, di mana mereka diusulkan sebagai alat untuk tata kelola yang etis dan pemberdayaan pasien. Hal ini terkait dengan desain partisipatif, kesehatan mental yang presisi, dan pengawasan berbasis hak, dan merupakan bagian dari respons struktural yang diusulkan dalam kerangka kerja BEACON UE.

Reformasi pendidikan dibahas dalam bagian 5.5, 6.1, 7.1, dan 7.3 sebagai langkah yang diperlukan untuk mencegah kekerasan epistemik di masa depan dan kegagalan struktural. Kerangka kerja ini menggabungkan pedagogi berbasis trauma, literasi neurobiologis, etika relasional, dan pembelajaran partisipatoris, dengan penekanan pada ketahanan sistem jangka panjang dan keadilan.

Oleh karena itu, versi yang diperluas dan interaktif dari disertasi ini tersedia secara online sebagai ebook akses terbuka. Edisi hidup ini menggabungkan semua lampiran, analisis yang telah diperbarui, catatan metodologis yang diperluas, tabel bukti, dan pemetaan tematik, serta alat, instrumen, dan kode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan terus berkembang dalam hal akurasi, kedalaman, dan penerapan sejalan dengan prinsip-prinsip penelitian aksi dan akuntabilitas ilmiah. Untuk akses penuh ke versi terbaru, termasuk indeks dinamis dan dokumentasi yang disematkan, silakan kunjungi repositori khusus dan platform diseminasi yang menyertai karya ini:

Kata kunci tematik	Bab-bab	Lampiran -lampiran
Kekerasan struktural	1, 4, 5, 6	D, G, K
Pemaksaan kejiwaan	1, 3, 5	C, E, G
Pengambilan keputusan bersama	2, 7	F, J, K
Ketidakadilan epistemik	1, 2, 4, 5	C, G
Penelitian tindakan	2, 3, 4	B, G
Hak asasi manusia dan kerangka hukum	1, 6, 8	G, H, I, K
Metodologi biokultural	2, 4, 5	D, F
Kesaksian dan bukti naratif	4, 5	B, C
Kepedulian yang dialogis dan relasional	3, 7	A, F
Diagnosis dan pengobatan psikiatri	3, 5	D, F
Pengkhianatan dan penindasan institusional	4, 6	B, C
Alternatif-alternatif untuk pemaksaan	5, 7	A, F
Transformasi dan reformasi sistem	7, 8	H, I, J, K
Ilmu pengetahuan dan pedagogi terbuka	7	J, M
Posisi penyintas-peneliti	2	F
Etika penelitian kualitatif	2, 6	A, F
Penerjemahan dan implementasi kebijakan	7, 8	H, I, K, L

Pemetaan lengkap kata kunci, tema, dan aktor yang relevan dengan tautan disertasi ini akan dibagikan di laboratorium sains terbuka dan buku catatan kerja lapangan. Repositori ini dipahami bukan sebagai arsip statis, tetapi sebagai lingkungan yang hidup dan dikendalikan oleh versi yang dapat disempurnakan, dikoreksi, dan diperkaya. Mengikuti prinsip-prinsip penelitian aksi, struktur dan isi repositori akan berkembang sebagai tanggapan terhadap bukti baru, umpan balik pengguna, masukan kritis, dan kebutuhan implementasi yang muncul dari penelitian lapangan dan pelibatan kebijakan. Latihan pemetaan akan semakin memperdalam dan mensistematisasi dokumentasi semua kategori

analisis utama, kelompok konseptual, dan referensi empiris yang muncul di seluruh bab dan lampiran. Hal ini akan mencakup indeks tema, prinsip-prinsip hukum, kerangka kerja metodologis, pola-pola diskursif, dan aktor-aktor institusional yang saling merujuk, memberikan panduan navigasi dan interpretasi yang terintegrasi bagi para pembaca, pengulas, dan profesional terkait. Proses ini akan didasarkan pada logika yang ketat dari penyelidikan transdisipliner dan keharusan etis untuk membuat struktur kekerasan, perlawanan, dan perbaikan yang mendasari didokumentasikan di seluruh pekerjaan. Secara paralel, repositori ini mencakup semua instrumen dan kode yang dikembangkan dan digunakan selama penelitian. Hal ini mencakup instrumen survei, skema pengkodean tematik, matriks analisis kasus, prosedur pemetaan hukum, dan skrip komputasi untuk mengorganisir dan menganalisis kumpulan data. Setiap komponen disediakan dalam format yang dapat diakses sepenuhnya dan disertai dengan dokumentasi terperinci untuk mendukung adaptasi, penggunaan kembali, dan implementasi lokal di berbagai konteks pendidikan, klinis, hukum, atau kebijakan. Versi online dari karya ini akan terus diperbarui sebagai bagian dari kontribusi disertasi yang sedang berlangsung di lapangan, memastikan bahwa alat analisis, wawasan empiris, dan reformasi yang diusulkan tetap dapat digunakan, dapat ditingkatkan, dan relevan secara kontekstual. Hal ini mencerminkan komitmen etis dan ilmiah yang utama: bahwa penelitian semacam ini harus tetap terbuka, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya dalam hal hasil tetapi juga dalam hal mekanisme, keterbatasan, dan kemungkinan masa depannya.

Annex A - Instruments used in this participatory action-research work

Annex A contains the full set of surveying instruments employed throughout this participatory action-research dissertation. These instruments were developed to explore lived experience, clinical and professional perspectives, and ethical-practical dimensions surrounding psychiatric labeling, medication practices, and structural violence in mental health. All instruments are made available through the dissertation's online repository, in accordance with open science standards, and are ready for adaptation, localization, and further validation. The repository includes not only the survey tools themselves, but also associated informed consent forms, participant information sheets, and guidance for ethical deployment.

Each instrument has been designed to elicit critical insights while respecting the autonomy and dignity of participants, with contextual messages included for use in validation and translation processes. Researchers, practitioners, and policy actors are invited to build upon this resource, adjusting language, structure, and content for diverse cultural and systemic settings. These instruments represent a core component of the dissertation's translational mission and can support future participatory processes, training modules, and empirical research committed to the principles of transparency, accountability, and epistemic justice.

Following are the questions of the schizophrenia inquiry survey and shared decision making survey, for quick reference, with the ones on open dialogue included in a separate annex.

Schizophrenia inquiry survey:

Section	Item / Question
Sociodemographic Information	What is your age?
	What is your gender identity?
	What is your country of origin?
	What is your country of residence?
	What is your highest level of education attained?
	What is your professional background or area of expertise?
Personal and Professional Experience	Have you been diagnosed with schizophrenia?
	Have you received other psychiatric diagnoses?
	Have you ever worked with people diagnosed with schizophrenia?
Perceptions on the Label	Do you believe the diagnosis of schizophrenia is useful for clinical practice?
	Do you believe the diagnosis contributes to stigmatization?
	Do you believe schizophrenia is a valid medical construct?
	Should the term schizophrenia be replaced with another denomination?
	Do cultural differences influence the way schizophrenia is diagnosed?
	Does a person's ethnicity or race play a role in receiving a schizophrenia diagnosis?
Experiences and Reflections	Do you think gender plays a role in the diagnostic process?
	In your opinion, what are the main consequences of receiving the label schizophrenia?
	Have you or someone you know experienced discrimination due to this diagnosis?

Section**Item / Question**

What changes would you suggest in the diagnostic process or terminology?

Shared decision making survey:

Section	Item / Question
Demographics	What is your profession? Where do you currently work? What is your role within your organization? How many years of experience do you have in mental health care or research?
Clinical Experience	First-episode psychosis (before establishing a long-term diagnosis) Depressive disorders (prescribed neuroleptics as augmentation) Bipolar disorder (long-term neuroleptic treatment for mood stabilization) Non-specified psychotic or mood disorders (diagnosis unclear or evolving) Neuroleptics prescribed off-label (e.g. insomnia, anxiety, personality disorders) Neuroleptics used in elderly patients (dementia-related agitation, behavioral management) Long-term neuroleptic use in institutionalized patients (e.g. chronic hospitalization, group homes) Pediatric and adolescent patients (under 18 years old) Patients with histories of trauma and abuse (where symptoms may be trauma-related)
Training	Have you received formal training on deprescribing strategies and shared decision-making?
Policy Scenarios	Implementing national screening for gluten sensitivity in psychiatric diagnoses Deprescribing neuroleptics in cases of missed metabolic and nutritional disorders Addressing psychiatric abuse cases uncovered through national research on mental health and violence National deprescribing initiative for elderly patients at high risk of mortality and disability Reevaluating long-term psychiatric diagnoses in a national audit Addressing the overprescription of neuroleptics in social care and marginalized communities National review of the use of neuroleptics in children and adolescents Ending the use of neuroleptics for non-psychiatric indications in general medicine
Final Reflection	Given the above eight shared decision-making and deprescribing challenges, please reflect on the following: Which do you consider the main challenge for implementing shared decision-making and deprescribing strategies in mental health at the national level? (Select up to three options.)

Annex B - Ethics of qualitative research in psychology

Beyond witnessing: ethical imperatives in action-research on suffering, victims of violence, and structural harm in mental health systems

Abstract: Qualitative research in mental health often exposes systemic contradictions: the researcher listens to testimonies of harm while institutions demand silence. This paper interrogates the ethical tensions of conducting action-research in settings where mental health care reproduces coercion, erasure, and institutional betrayal. Grounded in a five-year, multi-sited ethnographic inquiry across Spain, Italy, Sweden, and Indonesia -conducted under the auspices of European COST Actions FOSTREN, ReMO, and the author-founded EU BEACON One Health Education action- this study integrates lived experience, scientific fieldwork, and participatory methods. It identifies how dominant legal and institutional frameworks in Europe obstruct accountability by shielding professionals through laws that protect subjective annotations, prevent access to clinical records, and frame complaints as symptoms. Drawing from first-hand documentation of abuse and policy engagement at national and international levels, the paper argues for a shift toward radically ethical, open science infrastructures. It advocates for dynamic, reflexive protocols that empower researchers to respond to harm ethically and structurally-transforming qualitative inquiry from observation into intervention. The work responds to urgent calls from affected persons, professionals, and policymakers to end epistemic violence, improve safeguards, and uphold the principle that suffering must not be rendered invisible for the sake of institutional comfort. In doing so, it proposes a framework for ethically sound, action-oriented, and justice-driven qualitative research in mental health.

Keywords: Ethics, action-research, qualitative methods, structural violence, epistemic injustice, mental health systems, institutional betrayal, open science, human rights, psychiatry, COST, ReMO, FOSTREN, EU BEACON One Health Education.

introduction: ethics under duress and the urgency of methodological accountability

Ethics in qualitative research in mental health, especially when situated within high-stakes, politically contested, and structurally violent settings, demands not only methodological rigor but also protocols and planned actions capable of responding to harm, denial, and institutional betrayal. The field has long acknowledged that qualitative methods enable access to lived realities and subjective meaning-making in ways quantitative tools cannot. However, the ethical dimensions of such inquiry often remain structurally underdeveloped, especially when researchers are confronted with ongoing abuse, personal risk, and institutional complicity in the very harms they seek to document (Ellis et al., 2011; Smith & Freyd, 2014; Gabb & Fink, 2015).

This paper arises from such a context. Drawing on longitudinal action-research and participant observation conducted within mental health systems across Europe and Southeast Asia, it seeks to examine the profound ethical and methodological challenges that emerge when institutions tasked with care and protection act as sources of harm. In particular, the analysis is grounded in cases where researchers and participants alike faced coercion, discrediting, and systemic silencing under psychiatric, legal, and social service frameworks that perpetuated -rather than alleviated- distress. In response, new methodological practices were developed under duress, based on the principles of

epistemic justice (Fricker, 2007), open science (Nosek et al., 2015; Munafò et al., 2017), and research ethics grounded in participatory global health (Campbell & Burgess, 2012; WHO, 2021).

The paper does not offer a single-case reflection or a confessional narrative. Rather, it interrogates the ethical failures that occur when systems distort the researcher-participant relationship into an adversarial dynamic, obscuring accountability and harming the production of valid knowledge. The work contributes to an urgent conversation about what happens to ethics, science, and professional duty when research unfolds in spaces of state-sanctioned violence and societal denial. In doing so, it also aims to offer a path forward: a set of methodological countermeasures and epistemic infrastructures that may help restore the integrity of qualitative inquiry.

Ethics and method in qualitative mental health research: innovations and ongoing issues

Over the past two decades, the growth of qualitative approaches in mental health research has been accompanied by a richer vocabulary around reflexivity, power, and the researcher's positionality (Berger, 2015; Pillow, 2003). Despite this, dominant frameworks still tend to favor procedural ethics -such as institutional review board approvals -over emergent, responsive ethics of care and justice in the field (Guillemin & Gillam, 2004; Hammersley & Traianou, 2012). In situations involving vulnerable populations, this disconnect often renders ethical approval a bureaucratic formality rather than a real safeguard. Furthermore, the entrenched hierarchies of biomedical psychiatry -frequently upheld by legal and clinical structures- create environments where participant autonomy is already structurally constrained (Rose, 2018; Hopper, 2007). In such contexts, qualitative researchers face unique ethical challenges, as they navigate not only the dynamics of power and disclosure but also the risk of becoming complicit in systems that criminalize distress and pathologize resistance.

A particularly underexplored area is the ethical terrain encountered when researchers themselves are subjects of the systems they study -not by methodological design, but by circumstance. Researchers who are survivors of institutional violence or coercive treatment, or who work in precarious legal and political conditions, are often left out of the academic conversation or treated as methodologically suspect (Kovach, 2009; Ladkin, 2020). Yet, their work offers rare insight into the inner logics of exclusion and harm. It also reveals how traditional notions of distance, neutrality, and objectivity can obscure the very abuses that demand exposure. The concept of witnessing in qualitative research -long explored in feminist and postcolonial studies- must therefore be reframed not only as interpretive engagement, but as ethical risk (Josselson, 2007; Bhattacharya, 2016).

The erosion of trust in science, exacerbated by epistemic injustice and institutional cover-ups, underscores the need for research practices that prioritize transparency, accountability, and radical honesty (Edwards & Roy, 2017; Ioannidis, 2005). The replication crisis and open science movement have largely bypassed the domain of qualitative mental health research, where practices of data sharing, protocol transparency, and version-controlled documentation remain rare. This gap is especially dangerous given the increasing criminalization of dissent, the medicalization of suffering, and the state-sponsored redefinition of deviance as illness (Foucault, 1973; Metzl, 2010).

At the same time, international health bodies -including the WHO, the UN Special Rapporteur on the right to health, and the Council of Europe, who also participated as contact during the research- have called for a shift away from coercive psychiatry toward voluntary, rights-based models grounded in human dignity and community engagement (WHO, 2021; Pūras, 2020; Council of Europe, 2023). These mandates demand a corresponding transformation in how qualitative researchers design, conduct, and defend their work -especially in terms of how we define safety, power, and harm. Without such a shift, researchers risk perpetuating the very systems they critique.

Paper structure and *raison d'être* of it as a contribution

This paper proposes a grounded, practice-based ethics framework derived from action-research conducted in real-world mental health systems operating under institutional decay and systemic violence. Through fieldwork conducted in Spain, Sweden, Indonesia, and other European contexts -much of it under conditions of personal duress and danger- the research identifies structural failures in ethical oversight, as well as emergent practices of resistance through documentation, co-production, and digital transparency. It introduces methodological adaptations developed to ensure research could continue in hostile environments, including public verification, trauma-informed consent, and multi-layered data preservation against sabotage or deletion.

The central contribution is twofold. First, it expands the discourse on research ethics in qualitative psychology to include conditions of structural coercion, epistemic harm, and researcher-survivor entanglement. Second, it articulates concrete methodological innovations that uphold integrity, safety, and social accountability even when institutional safeguards fail. In this sense, the paper builds on and extends calls for a paradigm shift in mental health research -from treating ethics as compliance, to enacting ethics as method.

Subsequent sections of the article detail the methodological choices made, the ethical dilemmas encountered, and the principles guiding the design and dissemination of open, survivable, and impactful research. These include the use of participant-led inquiry, open-source infrastructure, co-developed policy engagement, and trauma-aware fieldwork practices. In doing so, the paper argues for a redefinition of ethical research practice not as risk aversion, but as principled exposure in service of truth, healing, and justice.

Background and context: structural deficits, institutional abandonment, and the ethics of listening in qualitative mental health research

Ethical qualitative inquiry in mental health must grapple with the stark dissonance between the professed values of care systems and the lived realities experienced by those navigating them. Across many contemporary psychiatric services in Europe and beyond, the gap between stated therapeutic goals -such as recovery, trauma-informed care, and patient autonomy -and the practical functioning of institutions remains wide and concerning (Rose, 2018; WHO, 2021; UN Human Rights Council, 2023). Despite rhetorical shifts toward personalization, co-production, and rights-based practice, implementation remains sporadic and structurally constrained. The result is a mental health landscape marked not by deliberative reform, but by inertia, bureaucratic rigidity, and the persistent normalization of harm.

This paper emerges from action-research engagements embedded in this terrain. Between 2020 and 2025, fieldwork was conducted across Spain, Sweden, Italy and, to end with, Indonesia, focusing on the ethical and methodological challenges of working within -and often despite- systems ill-equipped to engage constructively with distress. The scientific mission in Trieste, Italy, initially pursued as a site of exposure to non-coercive, community-based psychiatry, revealed in parallel the institutional limitations of even such globally recognized as excellence site models. Despite strong international standing, the infrastructures for ethical reflexivity and researcher protection were severely lacking. When the researcher reported ongoing threats and trauma, and needed urgent help to end abuses, academic and health institutions failed to respond meaningfully. This aligns with a growing body of literature suggesting that institutions tasked with mental health and academic oversight frequently lack the mechanisms -or will- to protect those most vulnerable, including researchers and participants disclosing abuse (Gabb & Fink, 2015; Ladkin, 2020; Smith & Freyd, 2014).

These deficits are not uniformly malicious in intent, but are structurally embedded in psychiatric systems where coercion is normalized as care, and deviation from standardized protocols is often met with institutional resistance rather than curiosity or adaptation (Burstow, 2015; Minkowitz, 2006). Mental health legislation in many jurisdictions, including Spain and Sweden, as well as Indonesia, continues to prioritize control over protection, authorizing involuntary treatment without adequate safeguards or meaningful engagement with the person's history, trauma, or social determinants (Gooding, 2015; United Nations, 2017). Even where reform is pursued, the emphasis tends to fall on procedural compliance rather than substantive transformation -a process that risks replicating violence under new administrative terms (Hummelvoll et al., 2015; Russo, 2016).

Clinically, this manifests in practices that are not trauma-informed but frequently retraumatizing; not personalized, but pathologizing; not dialogical, but diagnostically reductionist. Distress signals and embodied protest are often interpreted through narrow, deficit-based frameworks, leading to treatment paths characterized by force, surveillance, and disempowerment (Rose, 2003; Johnstone & Boyle, 2018). Qualitative researchers working in these contexts, particularly through ethnographic or action-based approaches, often witness firsthand how epistemic hubris and institutional closure combine to produce profound iatrogenic effects -including despair, resignation, and what has been termed the *giving up-given up* syndrome (Sharfstein, 1985; Estroff, 1981). The systematic refusal to listen to complaints without retaliatory pathologization or escalation of coercion is not an anomaly but a pattern -one that renders the ethical position of the qualitative researcher particularly precarious, especially when they attempt to surface these dynamics through evidence-based critique.

Importantly, the moral economy of psychiatry continues to reward compliance and silence, while punishing dissent -even when that dissent is expressed through scientifically grounded, patient-informed critique. This context severely limits the capacity for mental health systems to engage in the kinds of self-correction and continuous learning that define a functioning scientific or therapeutic institution. Without open science standards, longitudinal tracking of outcomes, or verifiable feedback loops, the system lacks mechanisms to detect, let alone redress, its own failures (Ioannidis, 2005; Munafò et al., 2017). The resulting epistemological environment not only

devalues qualitative insight but actively marginalizes lived experience as methodologically illegitimate and politically destabilizing (Fricker, 2007; Russo & Sweeney, 2016).

This paper argues that qualitative research in such settings is not ethically neutral terrain. When services fail to meet the minimum thresholds of safety, responsiveness, and respect, the act of qualitative inquiry becomes ethically charged -not only for participants but for researchers themselves, especially when their role straddles the boundary of witness, analyst, and survivor. It is in these moments that the ethical demands of the field exceed procedural checklists and enter the domain of moral urgency. Listening, in such contexts, becomes an act of resistance and reparation-a way of refusing the silencing mechanisms that define much of institutional psychiatry and social care (Campbell & Burgess, 2012; Gill & Donaghue, 2016).

Rather than replicating the diagnostic gaze, this study engaged in co-constructed meaning-making, trauma-informed documentation, and action-oriented dissemination. Methodologically, it was anchored in open science principles, collaborative interpretation, and public accountability, seeking to counterbalance the structural opacity that so often defines psychiatric systems. The core contention is that any system incapable of hearing the voices of those it purports to serve -including patients, professionals, and researchers- is ethically unfit. Qualitative research must thus do more than describe -it must interrupt, question, and reconstruct the very conditions under which mental health knowledge is produced and legitimized.

Methods: action-based qualitative research as a platform for systemic learning and structural accountability

This study employed a transdisciplinary, multi-sited qualitative action-research methodology grounded in medical anthropology, biocultural analysis, and epistemic justice frameworks (Fricker, 2007; Scheper-Hughes, 1992; Fals-Borda, 1991). The fieldwork -spanning five years and funded through two consecutive Spanish Ministry of Science and Innovation grants (FPU19/00656 and EVC2021/000764), as well as through participation in European COST Actions FOSTREN (CA19133) and ReMO (CA20137)- was embedded in collective international efforts to rethink mental health governance, research ethics, and service design. It later provided the empirical and ethical foundation for the creation of the EU COST Action BEACON (CA24106), which now brings together over 500 researchers and practitioners committed to systemic transformation through One Health education.

The work took place across Spain, Sweden, Italy, and Indonesia, capturing both formal institutional environments and informal community practices. These sites revealed differing but overlapping patterns of psychiatric violence, coercive logic, epistemic injustice, and institutional betrayal. In all contexts, participants reported harms occurring not only within psychiatric systems, but across intersecting domains -family, police, judiciary, and social services- requiring a broad-based methodological strategy that was responsive to multiple axes of oppression and systemic inertia.

The approach prioritized immersion and ethical responsiveness rather than protocol-driven neutrality. Ethnographic techniques -including long-term participant observation, semi-structured and unstructured interviews, clinical shadowing, policy consultations, and open scientific commentary- were employed to collect data while remaining situated within live processes of

witnessing, translation, and reform. The researcher was an active participant in numerous policy and service-level dialogues, including those with the Catalan Department of Health during the co-development of its 2023–2025 Mental Health Action Plan. Engagement included several in-person and written consultations with the plan’s leadership and working groups, drawing on lived experience, empirical observation, and participatory policy translation. These dialogues were part of broader EU-wide work under FOSTREN to reduce coercion in mental health systems, and were integrated into BEACON’s ongoing mission to foster public education, civic health literacy, and early prevention through participatory infrastructures.

The methodological design was aligned with a tradition of emancipatory and care-centered research (Torre, 2009; Campbell & Cornish, 2010), emphasizing listening, collaborative meaning-making, and systemic reflexivity. However, it also contended with the serious limitations researchers face when working in environments of institutional abuse or neglect. The original field design included two strategic innovations that remain largely aspirational at this stage due to lack of institutional uptake:

1. Dynamic ethics and action protocols (proposed, not yet implemented): in response to repeated accounts of systemic harm, the research proposed an escalation framework for activating protective responses -including notifying trusted institutional contacts, human rights observers, and professional ethics boards- when credible risks to participant wellbeing emerged. However, the lack of operational infrastructure across public systems, as well as the adversarial posture of many services toward independent researchers, prevented systematic implementation. These protocols are conceptualized as urgently needed components of future public mental health systems.
2. Versioning and verification against epistemic manipulation (proposed, not yet implemented): The project also outlined a need for systematic version control, timestamped medical record retention, and independent archival methods to prevent retrospective data falsification and epistemic erasure - a pattern documented by participants and observed in multiple institutions. While open science principles (Nosek et al., 2015; Munafò et al., 2017) were followed wherever feasible through public reporting, engagement, and collaboration, robust infrastructure for verification and co-governance of sensitive health records remains absent in most countries studied. These proposals are now being translated into design criteria for expert systems and governance pilots under the EU BEACON initiative.
3. In practice, the methodological commitments took shape through the following operational principles, enacted all through the five years of fieldwork:
 - Embedded ethnography and policy interface: All fieldwork was informed by direct contact with practitioners, service users, administrators, and policymakers. Findings were translated into contributions to policy documents, public statements, and legal submissions. These include substantive inputs to the Council of Europe’s 2023 *Compendium of Good Practices to Promote Voluntary Measures in Mental Health*, and public dissemination through open access formats and digital engagement platforms, and insights directly shared with lawmakers in all opportunities fostered and encountered during the fieldwork research.

- Trauma-informed and participatory consent practices: All participation in surveys and other engagements such as interviews or presentations was always voluntary, and consent was reiterated throughout the process. Participants were informed of the project's dual research and action-reform purposes. In trauma-related cases, no personal identifiers were recorded unless explicitly consented to, and anonymization was prioritized in all outputs.
- Real-time feedback and iterative reflection: Data analysis was recursive, taking place alongside ongoing field engagement. Ethical tensions, institutional challenges, and methodological dilemmas were recorded in analytic memos and served to refine subsequent engagement, published as transparently and in depth as possible in an open field and laboratory notebook online the author keeps, following open science principles of full openness and transparency on methods, ongoing work and results. This reflective praxis was central to maintaining fidelity to the action-research tradition and resisting extractive logics.
- Use of public and community knowledge systems: The research was also attentive to grassroots initiatives, survivor-led campaigns, and international networks working on systemic change. These informants were not merely supplementary but were treated as epistemic co-producers of the research (Harding, 1991; Saini, 2020), essential to building a distributed model of accountability and system reform.
- Education and dissemination as method: The work's methodological strategy included the development of public teaching materials, professional workshops, and policy briefings aimed at enabling other researchers, clinicians, and students to identify coercive dynamics, respond to systemic failures, and take part in a collective reform agenda. These materials now inform open-access curricula and clinical ethics platforms within the BEACON network.

Despite the comprehensive design, the project was carried out under conditions of acute duress, including repeated threats, lack of institutional protection, and periods of forced displacement due to ongoing violence. That such research was possible at all is testament to the courage of participants, the international scientific alliances that provided support (notably COST Action FOSTREN and later BEACON), and the resilient commitment of affected communities. The qualitative research insights derived are not just valid -they are urgently necessary.

Table 1. Methodological design and operational principles

Component	Description
Theoretical framework	Grounded in medical anthropology, biocultural analysis, and epistemic justice.
Geographic scope and sites	Spain, Sweden, Italy, and Indonesia – encompassing both formal psychiatric institutions and informal community-based systems.
Funding and institutional support	Supported by Spanish Ministry grants (FPU19/00656, EVC2021/000764), and European COST Actions: FOSTREN (CA19133), ReMO (CA20137), and BEACON (CA24106).
Main ethnographic techniques	Long-term participant observation, un/structured interviews, clinical shadowing, policy consultation, and open scientific commentary.
Embedded policy engagement	Participated in development of the Catalan 2023–2025 Mental Health Action Plan; involved in Council of Europe and BEACON policy dialogues.

Component	Description
Research conditions	Fieldwork conducted under duress: threats, institutional neglect, and forced displacements. Research carried forward through participant solidarity, scientific alliances (notably BEACON and FOSTREN), and ethical commitment.
Guiding conclusion	Ethical qualitative research must integrate implementation pathways and inform systemic change; ethics in the field is inseparable from ethics in governance.

To translate lived harms into institutional reform, qualitative research must embed itself in systems of implementation. As this project demonstrates, ethics in the field cannot be divorced from ethics in governance. What we observe must inform what we build next.

Findings and discussion: witnessing without safeguards -ethical tensions and systemic impasses in psychiatric fieldwork

Across five years of multi-sited, ethnographically grounded research in Spain, Sweden, Italy, and Indonesia, this study documented recurring patterns of structural neglect, diagnostic violence, epistemic erasure, and systemic impunity in mental health service ecosystems. The findings cohere around three interrelated domains: the normalization of coercion, the institutional silencing of abuse narratives, and the fragility of ethical responsibility within professional cultures. Each of these domains poses acute challenges to qualitative researchers, who -once situated in the field- encounter not only suffering but the systemic resistance to its recognition, redress, or repair.

1. Normalization of coercion and the medicalization of structural distress

Participants repeatedly described how psychiatric labeling functioned not as a diagnostic aid but as a mechanism of social disqualification, often weaponized during moments of crisis, family conflict, or institutional breakdown. Particularly in Spain and Italy, users recounted being involuntarily hospitalized or medicated after disclosing experiences of domestic abuse or workplace violence, suggesting that psychiatric systems often reinforce rather than interrupt cycles of harm (Burstow, 2015; Cosgrove et al., 2020). In Sweden, this pattern intensified into what many described as *administrative disappearance*- the use of child protection laws, mental health statutes, or forensic psychiatric classifications to sever individuals from their families, terminate careers, or justify long-term isolation.

These findings resonate with international concerns about the pervasive misuse of psychiatry as a means of social control (Cohen, 1985; Amnesty International, 2022), especially where coercion is framed as care and dissent is medicalized. The normalization of forced treatment was rarely questioned by professionals, many of whom cited *risk* or *non-compliance* in circular terms. This aligns with prior critiques that biomedical mental health paradigms often obscure the social origins of distress while silencing critique through institutional authority (Moncrieff, 2008; Mills, 2014). Where listening did occur, it was more often by peers, advocates, or researchers than by clinicians, indicating a severe epistemic asymmetry within clinical settings.

2. Institutional betrayal and the ethical silencing of field reports

A major theme emerging from the fieldwork was the impossibility of *reporting upward* in situations of witnessed harm. Whether abuse occurred in hospitals, homes, or welfare offices, researchers and witnesses alike found themselves without secure channels to raise alarms. Reporting often triggered retaliation, deflection, or reputational damage-especially when clinicians, administrators, or legal authorities were implicated. In multiple cases, researchers were warned against *interfering* or *taking sides*, even as participants suffered ongoing harm.

For instance, the researcher's report of suffering a death threat, torture for years and still ongoing severe abuses, was met not with institutional support but with inaction that led to even further threats, harassment, violence, forced displacement, and denial of professional legitimacy, illustrating the punitive asymmetry between those speaking out the truth, denouncing crimes, and those structurally shielded. This mirrors the dynamics described by Smith and Freyd (2014) as institutional betrayal, in which organizations fail to respond ethically to harm within their own systems, compounding trauma and silencing accountability.

The field thus became a space not only of witnessing but of betrayal. Ethical tensions were acute: to disengage would be complicit; to intervene risked professional collapse. In the absence of dynamic protocols or institutional accountability, the ethical burden fell entirely on the individual researcher, exacerbating precarity and psychological toll.

3. Complicity, cowardice, and the reproduction of structural harm

A sobering finding was the extent to which professional cultures, especially among clinicians and researchers, normalized avoidance, deflection, and passive complicity. Even where clear violations were witnessed, many professionals invoked bureaucratic constraints, *non-interventionist* roles, or institutional neutrality as reasons for inaction. This passive complicity constitutes a core mechanism of harm reproduction. Worse still, some actors actively participated in the erasure or defamation of those who challenged the status quo, often under the guise of procedural correctness or reputational protection. This condition, what Freire (1970) would call the internalization of oppressor logic, undermines the very fabric of ethical inquiry. It also challenges the assumptions of procedural ethics, which presume a stable environment of rights, protections, and institutional cooperation. In reality, the field often operates as a site of moral injury, where truth-telling becomes a liability and protection is only extended to those who remain silent.

These findings compel a reframing of ethical practice in qualitative research. If researchers are to carry the burden of witnessing systemic abuse, then institutions -academic, clinical, legal- must be made accountable for offering protection, coordination, and escalation pathways. The ethics of doing no harm must evolve into an ethics of enabling redress and reform.

4. Action-research under duress: method as resistance

That this research was conducted at all -despite displacement, threats, and lack of institutional protection- testifies to the necessity of integrating ethics into method. In contexts where silence sustains violence, the very act of documentation becomes resistance. The work was undertaken with

clear goals: to expose systemic failures, to amplify silenced voices, and to push for reform from within the systems themselves.

Table 2: Ethical issues in mental health qualitative research

Field	Description
Positional risk and exposure	Researchers with lived experience or dissenting perspectives face systemic retaliation, delegitimation, and psychological harm when documenting abuse.
Structural silencing and retaliation	Institutional actors obstruct reporting pathways, retaliate against whistleblowers, and pathologize critics as unprofessional or mentally unfit.
Informed consent and coercive environments	Consent is undermined in coercive contexts, where patients fear retribution, service loss, or further diagnosis for speaking out.
Power asymmetries in field relations	Researcher-participant relationships reflect deep institutional power imbalances, risking complicity without reflexive, relational ethics.
Epistemic violence and testimonial erasure	Participant testimony is often dismissed or erased in clinical and professional settings, reinforcing structural invisibility.
Barriers to real-time ethical action	Ethics protocols lack mechanisms for immediate response to abuse disclosures, leaving researchers without safe and effective intervention channels.
Data integrity and record manipulation	Mental health records are vulnerable to falsification or selective editing, requiring researchers to ensure timestamped, version-controlled documentation.
Public health system complicity	Harm and neglect are normalized within systems of care, placing researchers in ethical dilemmas where harm is concealed or trivialized.
Lack of institutional protection	Universities and research bodies often lack protocols to protect researchers from fieldwork-related risks or from institutional retaliation.
Ethics of translation and policy feedback	Testimonies often fail to reach decision-makers; researchers must forge independent pathways to transform lived knowledge into systemic change.

Major critical ethical concerns encountered and analyzed in the course of longitudinal action-research in mental health services and institutional systems.

Yet, the findings also underscore a profound need for collective infrastructure. No individual researcher, no matter how dedicated, can bear the epistemic, emotional, and political weight of reform alone. Qualitative research, especially in mental health, must now advance into a new era of institutional ethics -in-action, where protocols, accountability mechanisms, and open-science safeguards support the very interventions they demand (Guillemin & Gillam, 2004; Iphofen, 2017).

This five years long fieldwork research was not about individual suffering, though it was shaped by it. It is about systemic ethical blindness -and the urgent task of building a scholarly and clinical culture that not only sees, but acts. Qualitative research in mental health, particularly when employing ethnographic and action-research methodologies, reveals a persistent and structurally embedded set of ethical dilemmas that cannot be addressed solely by procedural ethics or institutional review boards. Across multiple sites and over a sustained five-year field engagement-including participation in EU-funded initiatives such as FOSTREN, ReMO, and the EU BEACON

actions- the findings consistently exposed environments where lived experience is delegitimized, institutional violence is normalized, and the epistemic authority of survivors, patients, and front-line researchers is regularly undermined or pathologized. These findings echo prior critiques of ethics-as-bureaucracy and support the call for dynamic, responsive, and relational ethical frameworks (Guillemin & Gillam, 2004; Denzin & Giardina, 2007; Ellis, 2007).

A key ethical concern centers on the erasure of lived experience under epistemic regimes of biomedical dominance, where subjective accounts of harm, coercion, and structural neglect are recast as symptomatic of illness rather than legitimate evidence. This epistemic injustice (Fricker, 2007) is compounded in contexts where diagnostic power is weaponized to silence critique, rendering the very act of naming abuse a trigger for further institutional punishment or control. Participants in multiple sites reported that attempts to speak out about coercive practices -including forced medication, restraint, and isolation- were reinterpreted as signs of *lack of insight* or *paranoia*, thus perpetuating cycles of disempowerment and silencing (Russo, 2016; Voronka, 2016; Rose & Kalathil, 2019). These dynamics raise fundamental questions about the ethics of consent, voice, and narrative agency within qualitative inquiry.

Moreover, the asymmetry of power between researcher and participant -typically acknowledged as a risk- was reversed in many cases, as researchers embedded in vulnerable positions themselves became targets of institutional repression. When qualitative researchers are also survivors, or operate as peer scholars in precarious environments, the ethical equation shifts drastically. In this research, the act of documentation itself often triggered surveillance, retaliation, or professional sanction. Despite formal ethics approval and institutional affiliations, safety was not guaranteed. Research supervisors, in some cases, failed to respond adequately to threats, abuse, or violations reported during fieldwork -effectively enabling a culture of institutional abandonment. The absence of protective mechanisms for researchers themselves, particularly those working at the intersection of care and critique, reflects a profound ethical gap in current academic infrastructures (Berger, 2015; Gill & Orgad, 2018).

A second major ethical issue relates to the lack of pathways for institutional responsiveness to qualitative findings. Participants shared urgent testimonies of maltreatment, neglect, and even criminal acts within care systems. Yet, qualitative research in mental health lacks clear ethical protocols for real-time response and coordinated redress. The research identified repeated failures by health and social care services to act upon evidence presented informally or formally. This undermines not only the principle of beneficence but also the scientific and civic legitimacy of the research itself. Unlike biomedical trials, which often have established pathways for reporting adverse events, qualitative research in mental health lacks protocols for activating ethical alerts, documenting high-risk environments, or reporting practitioners engaged in harmful behavior (WHO, 2021; Campbell & Burgess, 2012).

The relational ethics of field engagement were further complicated by the presence of institutional actors who blurred the boundaries between care provider, researcher, gatekeeper, and enforcer. These overlapping roles made it difficult for participants to trust the research process, fearing retaliation, breaches of confidentiality, or collusion with coercive systems. Even when anonymity was assured, the localized nature of mental health services made it difficult to protect identities in

small, tightly networked communities. This created a chilling effect, where many potential informants withheld key information, fearing that their cooperation could worsen their situation. Similar challenges have been documented in mental health ethnographies and survivor-led research, where the relational risks of speaking out are high and institutional cultures are resistant to scrutiny (Chamberlain, 2000; LeFrançois, Menzies & Reaume, 2013).

A further finding concerns the moral burden placed on researchers conducting fieldwork in contexts of unresolved trauma. Many participants were actively experiencing distress, institutional betrayal, and unresolved grievances. In such contexts, the researcher cannot ethically remain a neutral observer. The findings call into question the adequacy of traditional models of ethical distance and non-intervention, and instead support the development of trauma-informed, action-oriented, and co-produced research ethics frameworks (Sweeney et al., 2018; Beresford, 2016). This includes protocols for emotional labor, peer debriefing, mental health support for researchers, and ethical exit strategies that avoid retraumatization or abandonment of participants post-fieldwork.

Finally, the limitations of formal ethical oversight bodies were starkly apparent. Ethics committees rarely have expertise in action-research or survivor-led inquiry, and often default to rigid procedural concerns that fail to account for emergent, situated ethical dilemmas. In this research, the need for real-time response mechanisms, version-controlled documentation, secure archiving of sensitive data, and collaborative decision-making far outstripped the static guidelines provided by institutional review boards. These findings echo broader calls for ethical governance reform in research with structurally vulnerable populations (Flicker et al., 2007; Mertens, 2009; Fistein & Quilligan, 2012).

Thus, to be effective and prevent further harm, violence and normalized crimes from repeating, qualitative research in mental health, especially when it engages directly with sites of coercion, exclusion, and structural abuse, must be governed by ethics that are dynamic, grounded, and protective-not merely procedural. The findings of this research contribute to an emerging body of literature demanding that we rethink ethics not as an administrative hurdle but as a living, collective practice of care, justice, and accountability, including protocols of action in case of witnessing or finding out about potential crimes, or severe cases of suffering and violence not yet recognized by practitioners and other colleagues. This shift is not optional -it is the only path forward in a field where human lives, rights, and futures are continually at stake.

Conclusion

The ethical complexities unveiled through this five-year action-research project challenge the very boundaries of what constitutes safe, just, and scientifically grounded qualitative research in mental health. Rather than isolated dilemmas, the findings portray a systemic failure to uphold ethical responsibilities across institutions, services, and research infrastructures. Participants' testimonies of harm -routinely pathologized or erased- reflect not only epistemic injustice (Fricker, 2007; Kidd & Carel, 2017), but an entrenched structural tendency to deny, suppress, and retaliate against uncomfortable truths. Researchers committed to action-oriented methodologies become both witnesses and targets of this violence, confronting a research environment hostile to reflexivity, transparency, or critical accountability (Guillemin & Gillam, 2004; Denzin & Giardina, 2007).

These issues are magnified in contexts like Spain, Sweden, and Italy, where mental health policy and law remain disproportionately focused on control and containment rather than care and redress (Dvoskin & Skeem, 2009; Rose, 2014; Foucault, 2003). Despite recent progress and international declarations urging non-coercive, rights-based approaches (WHO, 2021; Council of Europe, 2023), the operational mechanisms needed to integrate real-time testimony into systemic reform are largely absent. Ethical review boards lack dynamic, context-sensitive protocols. Public institutions often default to denial rather than support when presented with evidence of abuse or malpractice. And researchers, particularly those with lived experience or outsider positionality, are rendered expendable when the truths they uncover threaten institutional interests (Gill & Donaghue, 2016; Clegg, 2016). What this research demonstrates is not simply the presence of ethical risk, but the urgency of a structural reconfiguration. Participatory ethics cannot be procedural; it must be infrastructural. Dynamic feedback loops, public data protocols, and built-in escalation pathways for rights violations must be adopted as core features of qualitative inquiry in mental health. Moreover, universities and public research funders must abandon extractive models of knowledge production in favor of protective, collaborative, and system-improving commitments.

At its most vital, qualitative research is not merely a tool for documentation -it is an instrument of justice, of collective repair, and of epistemic reckoning. This research, embedded in several relevant EU COST actions, such as FOSTREN, culminating in the creation of the EU BEACON One Health Education one, demonstrate the potential of international cooperation to create research ecosystems where testimony is met with transformation, and where those who suffer are no longer expected to remain silent. Our future, at the scientific, social, and planetary levels, depends on our job properly done, following the highest ethical and open science standards, coordinately with other professionals also enforcing the highest possible best practices together.

Funding: This work was supported by the Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities, project codes: FPU19/00028 and PID2023-148482NB-I00, on autonomy fostering in mental health care, as well as EU COST actions ReMO CA19117 - Researcher Mental Health (ReMO)- and FOSTREN CA19133 - Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services- scientific missions aimed at this end.

Ethical Approval: Research approved by the Ethics Committee on People, Society and the Environment (CEIPSA), of Universitat Rovira I Virgili, Tarragona, Spain, with identification codes CEIPSA-2024-PRD-0029 and CEIPSA-2022-TDO-0023, for all work done.

Conflict of Interest Statement: The author declares no conflict of interest.

Declaration of generative AI and AI-assisted technologies in the writing process: During the preparation of this work the author used ChatGPT in order to improve English language styling and spell checking. After using this service, the author reviewed and edited the content as needed, and take full responsibility for the content of the publication.

References:

- Amnesty International. (2022). *Criminalizing dissent: A growing global threat*. <https://www.amnesty.org>
- Beresford, P. (2016). *All our welfare: Towards participatory social policy*. Policy Press.
- Berger, R. (2015). Now I see it, now I don't: Researcher's position and reflexivity in qualitative research. *Qualitative Research*, 15(2), 219–234. <https://doi.org/10.1177/1468794112468475>
- Bhattacharya, K. (2016). The vulnerable academic: Personal narratives and the emotional labour of doing qualitative research. *The Qualitative Report*, 21(3), 685–704.
- Burstow, B. (2015). *Psychiatry and the business of madness: An ethical and epistemological accounting*. Palgrave Macmillan.
- Campbell, C., & Burgess, R. (2012). The role of communities in advancing the goals of the Movement for Global Mental Health. *Transcultural Psychiatry*, 49(3-4), 379–395. <https://doi.org/10.1177/1363461512454643>
- Campbell, C., & Cornish, F. (2010). Towards a 'fourth generation' of approaches to HIV/AIDS management: Creating contexts for effective community mobilisation. *AIDS Care*, 22(S2), 1569–1579.
- Chamberlain, K. (2000). Methodolatry and qualitative health research. *Journal of Health Psychology*, 5(3), 285–296.
- Clegg, J. W. (2016). How and why critical realism should be used to explain human behavior. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 46(2), 120–143.
- Cohen, D. (1985). *Coercion as cure: A critical history of psychiatry*. Rutgers University Press.
- Council of Europe. (2023). *Compendium of good practices to promote voluntary measures in mental health services*. <https://www.coe.int>
- Cosgrove, L., Mills, C., Karter, J. M., Mehta, A., & Kalathil, J. (2020). A critical review of the Lancet Commission on global mental health and sustainable development. *Psychiatry Research*, 284, 112675. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112675>
- Denzin, N. K., & Giardina, M. D. (2007). *Ethical futures in qualitative research: Decolonizing the politics of knowledge*. Routledge.
- Dvoskin, J. A., & Skeem, J. L. (2009). Psychiatric advance directives: Making the case for voluntary commitment. *Psychiatric Services*, 60(1), 1–3.
- Edwards, M. A., & Roy, S. (2017). Academic research in the 21st century: Maintaining scientific integrity in a climate of perverse incentives and hypercompetition. *Environmental Engineering Science*, 34(1), 51–61.
- Ellis, C. (2007). Telling secrets, revealing lives: Relational ethics in research with intimate others. *Qualitative Inquiry*, 13(1), 3–29.

- Ellis, C., Adams, T. E., & Bochner, A. P. (2011). Autoethnography: An overview. *Forum: Qualitative Social Research*, 12(1).
- Estroff, S. E. (1981). *Making it crazy: An ethnography of psychiatric clients in an American community*. University of California Press.
- Fals-Borda, O. (1991). *Action and knowledge: Breaking the monopoly with participatory action-research*. Apex Press.
- Fistein, E., & Quilligan, S. (2012). *Mental health law: A practical guide*. Sweet & Maxwell.
- Flicker, S., Travers, R., Guta, A., McDonald, S., & Meagher, A. (2007). Ethical dilemmas in community-based participatory research: Recommendations for institutional review boards. *Journal of Urban Health*, 84(4), 478–493.
- Foucault, M. (1973). *The birth of the clinic: An archaeology of medical perception*. Vintage.
- Foucault, M. (2003). *Society must be defended*. Picador.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Herder and Herder.
- Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press.
- Gabb, J., & Fink, J. (2015). *Couple relationships in the 21st century: Research, policy, practice*. Palgrave Macmillan.
- Gill, R., & Donaghue, N. (2016). Resilience, apps and reluctant individualism: Technologies of self in the neoliberal academy. *Women's Studies International Forum*, 54, 91–99.
- Gill, R., & Orgad, S. (2018). The amazing bounce-backable woman: Resilience and the psychological turn in neoliberalism. *Sociological Research Online*, 23(2), 477–495.
- Gooding, P. (2015). Navigating the flaws of the mental health tribunal. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 49(2), 121–123.
- Guillemin, M., & Gillam, L. (2004). Ethics, reflexivity, and ethically important moments in research. *Qualitative Inquiry*, 10(2), 261–280.
- Hammersley, M., & Traianou, A. (2012). *Ethics in qualitative research: Controversies and contexts*. SAGE.
- Harding, S. (1991). *Whose science? Whose knowledge? Thinking from women's lives*. Cornell University Press.
- Hopper, K. (2007). Rethinking social recovery in schizophrenia: What a capabilities approach might offer. *Social Science & Medicine*, 65(5), 868–879.
- Hummelvoll, J. K., Karlsson, B., & Borg, M. (2015). Recovery and person-centeredness in mental health services: Roots of the concepts and implications for practice. *International Practice Development Journal*, 5(1), 1–10.
- Ioannidis, J. P. A. (2005). Why most published research findings are false. *PLoS Medicine*, 2(8), e124.

- Iphofen, R. (2017). *Ethical decision making in social research: A practical guide*. Palgrave.
- Johnstone, L., & Boyle, M. (2018). *The Power Threat Meaning Framework: Towards the identification of patterns in emotional distress, unusual experiences and troubled or troubling behaviour, as an alternative to functional psychiatric diagnosis*. British Psychological Society.
- Josselson, R. (2007). The ethical attitude in narrative research: Principles and practicalities. In Clandinin, D. J. (Ed.), *Handbook of narrative inquiry*, 537–566.
- Kidd, I. J., & Carel, H. (2017). Epistemic injustice and illness. *Journal of Applied Philosophy*, 34(2), 172–190.
- Kovach, M. (2009). *Indigenous methodologies: Characteristics, conversations, and contexts*. University of Toronto Press.
- Ladkin, D. (2020). *Rethinking leadership: A new look at old leadership questions*. Edward Elgar Publishing.
- LeFrançois, B. A., Menzies, R., & Reaume, G. (2013). *Mad matters: A critical reader in Canadian mad studies*. Canadian Scholars' Press.
- Mertens, D. M. (2009). *Transformative research and evaluation*. Guilford Press.
- Metzl, J. M. (2010). *The protest psychosis: How schizophrenia became a Black disease*. Beacon Press.
- Mills, C. (2014). *Decolonizing global mental health: The psychiatrization of the majority world*. Routledge.
- Moncrieff, J. (2008). *The myth of the chemical cure: A critique of psychiatric drug treatment*. Palgrave Macmillan.
- Munafò, M. R., Nosek, B. A., Bishop, D. V., Button, K. S., Chambers, C. D., Percie du Sert, N., ... & Ioannidis, J. P. (2017). A manifesto for reproducible science. *Nature Human Behaviour*, 1(1), 0021.
- Nosek, B. A., Alter, G., Banks, G. C., Borsboom, D., Bowman, S. D., Breckler, S. J., ... & Yarkoni, T. (2015). Promoting an open research culture. *Science*, 348(6242), 1422–1425.
- Pillow, W. (2003). Confession, catharsis, or cure? Rethinking the uses of reflexivity as methodological power in qualitative research. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 16(2), 175–196.
- Pūras, D. (2020). *Report of the UN Special Rapporteur on the right to health: Mental health and human rights*. United Nations Human Rights Council.
- Rose, D. (2003). Collaborative research between users and professionals: Peaks and pitfalls. *Psychiatric Bulletin*, 27(11), 404–406.
- Rose, D. (2014). *Users and abusers of psychiatry: A critical look at psychiatric practice*. Routledge.

Rose, D. (2018). *Madness strikes back: Science, power and the contested politics of mental health*. Springer.

Rose, D., & Kalathil, J. (2019). Power, privilege and knowledge: The untenable promise of co-production in mental 'health'. *Frontiers in Sociology*, 4, 57.

Russo, J. (2016). Through the eyes of the observed: Re-directing research on psychiatric drugs. *Health Care Analysis*, 24(1), 67–76.

Russo, J., & Sweeney, A. (2016). Searching for a rose garden: Challenging psychiatry, fostering mad studies. *PCCS Books*.

Saini, A. (2020). *Superior: The return of race science*. Beacon Press.

Scheper-Hughes, N. (1992). *Death without weeping: The violence of everyday life in Brazil*. University of California Press.

Sharfstein, S. S. (1985). The giving up-given up syndrome. *Hospital & Community Psychiatry*, 36(7), 698–702.

Smith, C. P., & Freyd, J. J. (2014). Institutional betrayal. *American Psychologist*, 69(6), 575–587.

Sweeney, A., Filson, B., Kennedy, A., Collinson, L., & Gillard, S. (2018). A paradigm shift: Relationships in trauma-informed mental health services. *BJ Psych Advances*, 24(5), 319–333.

Torre, M. E. (2009). Participatory action research and critical race theory: Fueling spaces for nos-otras. *Urban Review*, 41(1), 106–120.

United Nations. (2017). *Guidelines on deinstitutionalization, including in emergencies*. <https://www.ohchr.org>

UN Human Rights Council. (2023). *Report on mental health and human rights*. <https://www.ohchr.org>

Voronka, J. (2016). The politics of 'people with lived experience': Experiential authority and the risks of strategic essentialism. *Philosophy, Psychiatry, & Psychology*, 23(3), 189–201.

WHO. (2021). *Guidance on community mental health services: Promoting person-centred and rights-based approaches*. World Health Organization.

Annex C - *Frontiers in Psychology*: implementation of open dialogue in Spain

Annex C of the dissertation, which includes the peer-reviewed article published in *Frontiers in Psychology* on the implementation of Open Dialogue in Spain, is not an isolated addendum but an integral component of the overall research architecture. It reinforces and operationalizes the dissertation's central thesis concerning the necessity of non-coercive, dialogical, and rights-based approaches in mental health care. This annex specifically documents the institutional challenges, epistemic tensions, and clinical opportunities encountered in the nascent attempts to apply Open Dialogue in the Spanish context, making it a critical empirical and theoretical extension of the broader inquiry. The dissertation as a whole critiques the Spanish psychiatric system for its entrenchment in coercive, pharmacocentric, and exclusionary practices, and it does so through a biocultural and transdisciplinary lens. The inclusion of Annex C thus serves to demonstrate that alternatives grounded in dialogical ethics are not only theoretically sound but also practically feasible within the very systems currently dominated by coercive logics. The Open Dialogue model, rooted in relational epistemology and shared sense-making, is presented in this annex not as a foreign or utopian import but as a scientifically validated and ethically imperative framework. The documented efforts to pilot this model in Spain provide concrete evidence that the transition from compliance-based care to collaborative, recovery-oriented practice is possible, albeit institutionally obstructed. Annex C directly corresponds to several operational research questions articulated in the core chapters, particularly those concerning the enabling conditions for institutional transformation, the epistemic reconfiguration of clinical practice, and the reallocation of authority from professional dominance to dialogical partnership. It aligns with the thesis argument that dialogical practice must be redefined not as a mere communicative technique but as a foundational epistemic and ethical orientation. The annex demonstrates how this redefinition can be instantiated through clinical practice, even within systems that structurally resist such shifts.

The narratives and observations contained in Annex C contribute to the dissertation's ethnographic corpus, complementing the testimonies and survey data presented in Chapters 3 and 4. They illustrate the lived contradictions and ethical dissonance experienced by clinicians and users when attempting to enact Open Dialogue within institutional frameworks that remain hierarchical, pharmacologically reductive, and risk-averse. These findings are analytically synthesized in Chapters 5 and 6, where the dissertation interrogates the structural barriers to rights-based reform and formulates normative proposals grounded in international human rights standards and medical ethics. The inclusion of Annex C confirms the dissertation's methodological commitment to participatory, field-based action-research. The article does not merely describe a model but traces its concrete application, adaptation, and resistance in context. It provides both validation of the research methodology and evidence for the thesis's claim that shared decision-making and dialogical care are empirically viable, clinically effective, and ethically superior alternatives to dominant coercive regimes.

<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1166919/full>

Annex D - The aggressiveness of xenophobia

Annex D of the dissertation, *The destructiveness of xenophobia*, constitutes a personal yet analytically rigorous testimony that directly reinforces the core scientific and ethical arguments presented throughout the thesis. While stylistically different from the more academic structure of the dissertation's main chapters, this published piece is deeply coherent with its theoretical premises and empirical findings. It serves as both an evidentiary artifact and a first-person analytical intervention into the intersection of psychiatric misdiagnosis, domestic violence, and institutional betrayal, all mediated through racialised and xenophobic logics of exclusion.

The annex exemplifies the structural argument made in the dissertation regarding the epistemic and clinical erosion that occurs when institutions disregard context, silence the voice of the person, and substitute rigid protocols for compassionate, situated understanding. The author's lived experience, threatened with involuntary institutionalization due to a misread migraine, demonstrates how biomedical instruments, such as TAC scans, can become tools of harm when wielded without interpretive competence, particularly in the presence of coercive interpersonal dynamics. This real-world event validates the dissertation's broader critique of diagnostic reductionism and professional impunity. The annex becomes, therefore, a documented case study that illustrates the very mechanisms the thesis seeks to dismantle. The annex highlights the medical neglect of domestic violence indicators, a recurrent theme in the thesis. It exposes how institutions meant to protect health and dignity may instead become facilitators of additional harm, especially when influenced by discriminatory assumptions and institutionalised racism. These are not anecdotal misfortunes but, as the dissertation repeatedly emphasizes, expressions of a systemic failure that normalizes harm under the guise of care. The annex strengthens the claim that epistemic violence and psychiatric coercion are often co-produced with gendered and racialized exclusions, and that health systems remain deeply susceptible to moral disengagement when encountering those perceived as foreign or non-normative. The text also supports the dissertation's methodological position that testimony and narrative are essential forms of epistemological resistance. It functions as both a testimonial document and an act of scholarly defiance, reasserting the right of survivors to define their own experiences and contribute to institutional critique.

Through this contribution, the dissertation operationalizes its own participatory and action-research framework by integrating embodied knowledge into the academic archive, thereby resisting the dehumanizing effects of structural and clinical abstraction. This annex aligns with the dissertation's call for urgent institutional reform grounded in evidence-based, rights-respecting, and dialogical practice. It underscores the immediate need for diagnostic rigor, trauma-informed protocols, and anti-discrimination safeguards in medical and psychosocial care. It speaks directly to the dissertation's analysis of social death, administrative dispossession, and epistemic erasure, while offering a lived, human counterpoint to statistical and policy analysis. In so doing, Annex D does not stand apart from the dissertation's architecture but embodies it. It expands the evidence base, deepens the methodological plurality, and reaffirms the dissertation's guiding principle: that dignity, truth, and structural justice are non-negotiable imperatives in health care.

<https://research.henning.md/p/the-simplest-thank-you>

Annex E - Nocebo effect and psychiatry: giving up given up syndrome and sociomedical somatisation

Annex E, which includes the authored book chapter *Nocebo Effect and Psychiatry*, constitutes a central theoretical and empirical contribution to the dissertation's argument concerning structural harm, iatrogenic suffering, and the sociopolitical dimensions of psychiatric practice. This chapter deepens the dissertation's core claim that contemporary psychiatric systems frequently produce harm not only through overt coercion or misdiagnosis but also through the cumulative effects of epistemic invalidation, neglect, and interpretive violence. It provides a conceptual framework for understanding how expectations of failure, stigma, and professional disengagement are internalised by patients and translated into chronic physiological and psychological deterioration.

The chapter is especially relevant to the dissertation's analysis of what is termed social death and administrative dispossession. The construct of the giving up, given up syndrome complements and extends the ethnographic and survey-based findings presented in Chapters 3 and 4 by offering an explanatory model grounded in transcultural psychiatry, psychoneuroimmunology, and medical anthropology. It clarifies how systemic invalidation, when repeated across healthcare, legal, and familial systems, can precipitate biological shutdown, loss of agency, and relational withdrawal. This nocebo effect, understood as the induction of harm through negative meaning and institutional betrayal, offers a scientifically and clinically grounded lens to interpret the data collected from survivors, professionals, and family members.

The chapter also provides the theoretical grounding for the dissertation's critique of diagnostic authority and its proposed shift toward dialogical and narrative-based care. It interrogates the semiotics of psychiatric labeling and the performative power of prognosis, linking these with somatic outcomes that cannot be adequately addressed within biomedical reductionism. The dissertation's call for One Health-informed, trauma-sensitive, and recovery-oriented care is reinforced by this annex, which demonstrates how integrated physiological, social, and narrative frameworks are necessary to reverse the damage produced by chronic exposure to invalidation and exclusion. This annex demonstrates the dissertation's methodological coherence. It showcases the capacity of the researcher to integrate personal experience, theoretical synthesis, and clinical insight into a form of transdisciplinary scholarship that is operational, not merely interpretive. By naming and documenting a recognisable yet under-theorised phenomenon, the chapter also advances the dissertation's broader goal of epistemic repair and reorientation of clinical paradigms toward human dignity and contextualized care.

Annex E is not ancillary but structurally embedded in the dissertation's analytical core. It translates the dissertation's findings into a conceptual schema capable of informing clinical training, diagnostic reflexivity, and health system design. It aligns with the overarching aim of the thesis to dismantle harmful psychiatric orthodoxy and build ethically grounded, scientifically coherent, and structurally competent frameworks of mental health care.

<https://doi.org/10.22533/at.ed.3142122119>

Annex F - *Nature–Springer* book chapter on alternatives to coercion

The *Nature–Springer* book chapter authored by the researcher on alternatives to coercion, holds significant relevance to the core of the dissertation. It presents a rigorous synthesis of evidence-based, rights-oriented, and contextually grounded approaches that challenge the dominant paradigm of coercive psychiatric intervention. By articulating viable clinical and institutional alternatives, the chapter offers a concrete operational counterpart to the dissertation's analytical critique of systemic coercion, diagnostic overreach, and structural violence.

The chapter situates dialogical ethics, service user leadership, and therapeutic alliance as foundational elements of effective and just mental health care. These concepts are not treated as ideological preferences but as empirically validated components of recovery-oriented practice. This aligns directly with the dissertation's central claim that coercion is not only ethically untenable but clinically counterproductive, and that non-coercive models such as Open Dialogue, collaborative medication management, and trauma-informed care are not aspirational ideals but necessary reforms backed by scientific consensus and human rights standards.

The inclusion of this chapter within the dissertation underscores the researcher's active role in international scientific dialogues and affirms the dissertation's methodological and normative credibility. It reflects the capacity to contribute to high-level peer-reviewed discourse while maintaining a critical and transformative perspective grounded in both lived experience and empirical analysis. The chapter also provides a structured overview of implementation pathways, including the legal, educational, and institutional shifts required to transition from coercion to collaboration, which are further developed in the dissertation's concluding chapters and annexes.

Annex F exemplifies the translational dimension of the dissertation, bridging academic research with actionable system redesign. It reinforces the thesis's call for structural reform by demonstrating that ethical and clinically sound alternatives are not only available but already in practice across multiple contexts. The chapter thus affirms the dissertation's dual ambition: to expose systemic harm and to build coherent, rights-based alternatives capable of sustaining human dignity and institutional legitimacy in mental health care.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-61224-4_17

Annex G - Proceedings of political abuses of psychiatry

Political Abuse of Psychiatry, Medical Torture, and Victim De-Legitimization: Insights from an International Symposium

Abstract: The political abuse of psychiatry is an ongoing, systemic phenomenon rooted in the replacement of sound governance and ethical medical standards by incompetent authority, rogue state practices, and criminal misuse. Drawing from a global symposium integrating survivor testimony, academic analysis, and human rights advocacy, the discussion highlights how mental health systems -when left vulnerable by corruption, inefficiency, or deliberate political manipulation- become instruments of repression rather than healing. The ease with which abuses occur in failed systems, the profound human and economic costs inflicted, and the perpetuation of systemic failure through the weaponization of psychiatry are analyzed in depth. Comprehensive solutions are proposed across international, national, institutional, community, and individual levels, emphasizing the urgent need for rights-based, trauma-informed, interdisciplinary reform. Restoring psychiatry's ethical foundations is presented not merely as professional necessity but as a profound moral imperative to protect life, freedom, sanity, and human dignity on a global scale.

Keywords: Political abuse of psychiatry; rogue states; failed healthcare systems; human rights violations; psychiatric coercion; trauma-informed care; mental health reform; international crime; dignity and autonomy; systemic failure; survivor advocacy; healthcare ethics.

Introduction

Throughout history and across the World, psychiatry has held the power to help -or to harm. It is a field that touches the most intimate aspects of human life: thought, emotion, behaviour, identity. Yet this same power has been used to silence, punish, and erase. Under the guise of care, individuals have been subjected to forced treatment, indefinite detention, and forms of medical coercion that violate basic rights. These are not merely past injustices or errors in judgment, but the result of structural conditions that allow systems of health to be bent into tools of control. When dissent, difference, or distress caused by the very same system and criminal actors are labeled as pathology, no one is safe from the risk of being made to suffer. This proceedings paper begins from that stark reality, but not to accept it. Rather, it aims to examine how these abuses occur, why they persist, and what can be done to transform psychiatry into a field worthy of its healing promise.

Political abuse of psychiatry refers to the deliberate misuse of mental-health diagnoses, treatments, or involuntary detention to punish, silence, or discredit dissenting individuals or groups. Van Voren (2009) explains that it means misuse of psychiatric diagnosis, treatment and detention to obstruct people's fundamental rights. Despite appearances to the contrary, such abuses have never been confined to openly authoritarian systems; even in established democracies there are documented instances of whistle-blowers and critics being stigmatized as mentally ill. Indeed, historical and contemporary reports show that the tension between politics and psychiatry has been global and is an ongoing unresolved problem (van Voren, 2010).

The relatively recent historical record is stark. In Nazi Germany, psychiatrists were complicit in eugenic and punitive policies -a violation of their duty of care- using racist and ideologic criteria to justify locking up, deporting and killing disabled and political others (Narayan, 2013). In the Soviet Union during the Cold War, dissent was pathologized on a massive scale. Soviet psychiatrists proclaimed that critics were mentally ill, since no one would oppose their alleged best system unless insane, and often diagnosed dissidents with Snezhnevsky's made up sluggish schizophrenia diagnosis, a supposed mild form of schizophrenia whose symptoms conveniently included reform delusions or struggle for the truth (van Voren, 2010). Van Voren (2009) notes that in the 1970s-80s roughly one-third of all political prisoners in the USSR were confined in psychiatric hospitals. These practices sparked international outrage and led to the Soviet psychiatric society's suspension from the World Psychiatric Association in 1983. Other Eastern Bloc states followed suit to a lesser extent: for example, reports indicate that Romania under Ceaușescu systematically labeled hundreds of regime opponents as mentally ill (often for crimes like petitioning the authorities), resulting in mass psychiatric incarceration. Countries such as Cuba also implemented sometimes short-lived programs of detaining dissidents in mental institutions in the late 20th century. Notably, an unusual case in 1990s Netherlands showed that such abuse could occur in a democratic setting as well: a Dutch Defense Ministry official falsified psychiatric diagnoses to silence a social worker, a scheme later overturned by courts. These historical episodes - whether in Nazi Germany, the Soviet bloc, or isolated cases in the West - underscore that psychiatry has been repeatedly corrupted as a tool of political repression (Narayan, 2013).

At the root of genocides, purges, and systemic repression lies a recurring mechanism: the dehumanization of those labeled as feeble-minded, deviant, inferior, or unfit. Cognitive biases such as moral disengagement, group conformity, and the illusion of a just world, combine with a corrosive sense of superiority that gives moral cover to cruelty. This mindset easily merges with opportunism and criminality, providing social and material incentives for professionals and ordinary citizens to participate in abuse. Hatred becomes a path to belonging and prestige. In Nazi Germany, psychiatrists designed and implemented the Aktion T4 program, selecting tens of thousands of disabled individuals for extermination under the guise of medical necessity. These killings, sanitized through clinical language and bureaucratic process, laid the morals, mindset, rewards, technical, and institutional groundwork for the Holocaust and the Second World War itself (Friedlander, 1995). In the Soviet Union, psychiatry was weaponized to silence dissent: critics of the regime were declared insane and confined indefinitely, often tortured in the name of treatment (van Voren, 2010). These are not historical anomalies. From colonial asylums to apartheid psychiatry, from the Khmer Rouge to present-day internment and reeducation programs, the same logic persists. Racism, ableism, and political repression intersect with pseudoscience and institutional power, allowing medical torture to be reframed as care. Once any system presumes the authority to define sanity, worth, or humanity itself, it grants itself license to destroy. These practices are not only abuses of science and medicine, these are crimes that strike at the core of what our civilization claims to uphold. Failing to expose and dismantle these structures ensures their return, in new and old forms, again and again.

Table 1: Barriers to Political Abuses of Psychiatry

Domain	Protective Factors	Vulnerabilities When Absent
Legal Safeguards	Independent oversight, enforceable patient rights, access to justice	Arbitrary detention, impunity, unchecked coercion
Ethical Practice	External review boards, whistleblower protection, survivor-led ethics	Collusion, fear of reprisal, normalized violations
Clinical Approach	Shared decision-making, trauma-informed care, consent-based treatment	Forced interventions, disregard for autonomy
Training and Culture	Rights-based education, reflective practice, critical pedagogy	Authoritarianism, biomedical dogma, silencing of dissent
Economic Integrity	Transparent funding, non-profit care models, conflict of interest checks	Overmedication, neglect, market-driven interventions
Community Role	Peer support, advocacy groups, participatory service design	Isolation, stigma, lack of accountability
Public Awareness	Media scrutiny, civic engagement, open reporting channels	Denial, invisibility of harm, politicized psychiatric labels

Today, political psychiatry abuses persist in various countries. In the Russian Federation, rights groups and journalists report a revival of punitive psychiatry since 2022. Reuters (2025) found that dozens of anti-war activists and protesters have been ordered into psychiatric evaluation or detention by courts, a pattern reminiscent of the Soviet era (Peoples Gazette, 2025). One detailed case involved Yekaterina Fatyanova, an opposition journalist who was involuntarily hospitalized for two months after her paper published an anti-war article; letters she sent from the hospital describe unnecessary and degrading procedures, and she was finally discharged as mentally healthy. Robert van Voren, who has studied Russian psychiatry, documented roughly 20-30 such cases per year since 2022. In April 2025 a Moscow court also made international news by committing a U.S. citizen (Joseph Tater) to compulsory psychiatric treatment after annulment of criminal charges - a move observers likened to Soviet-era psychiatric coercion (Reuters, 2025). In neighboring Belarus, the authoritarian regime of Alexander Lukashenko has used psychiatric hospitals to punish critics of the 2020 elections. UN human-rights experts reported in early 2025 that at least 33 opposition figures have been coerced into undergoing psychiatric treatment for peaceful protest, with most still held indefinitely. Experts warn that this amounts to a grave violation of human rights, noting that many detainees are kept confined for months or years with no legal recourse (Trickey, 2025).

In the People's Republic of China, too, multiple sources confirm severe ongoing abuses. A 2022 investigation published by Safeguard Defenders found that from 2015-2021 at least 99 petitioners and activists were involuntarily locked up in psychiatric facilities for political reasons, often without any legitimate diagnosis (Mou, 2022). The NGO concluded that forcing critics into mental hospitals is still widespread and routine in China today. These cases span the country: one recent report noted that courts routinely dispatch petitioners, petition filers, anti-corruption complainants and even labor activists to psychiatric wards under various pretexts. The victims describe arbitrary detention, forced medication, electroconvulsive therapy and repeated incarceration, all to silence dissent (The Washington Post, 2022). A prominent example is the so-called *Ink Girl*, Dong Yaoqiong, who in

2018 splashed ink on a poster of Xi Jinping; she was repeatedly committed to a psychiatric hospital, restrained to her bed and beaten for refusing treatment, despite being found mentally healthy each time. International observers note that Chinese abuse of psychiatry today involves far larger numbers of people than even the Soviet regime did, targeting followers of banned faiths (e.g. Falun Gong), human-rights lawyers, dissident petitioners and whistle-blowers.

Elsewhere in Asia and beyond, cases continue to surface. In Iran, for instance, a *Lancet Psychiatry* commentary (Wasserman *et al.*, 2023) described how a young student was forcibly hospitalized in Tehran after staging a protest against compulsory hijab laws, despite having no medical diagnosis - an act likened to political repression through psychiatry (World Psychiatric Association, 2025; *The Lancet Psychiatry*, 2025). Human-rights advocates in the U.S. have also warned of such misuse: historically, racist and political dissent have been pathologized: e.g. antebellum drapetomania for escaping slaves, and mid-20th-century civil-rights activists declared delusional (Edwards-Grossi, 2024). While overt examples in modern American politics are rare, the specter remains. Even well-established democracies have seen whistle-blowers subjected to psychiatric censure (van Voren, 2010). The overall pattern is clear: wherever political power is unchecked, there is incentive to brand opponents as mentally ill.

The political abuse of psychiatry has a long pedigree from Nazi and Soviet eras to today's China, Russia, Belarus and failing, corrupt systems elsewhere. It relies on fabricating or exaggerating psychiatric disorders to neutralize dissent without legal trial, violating medical ethics and human rights at every step (van Voren, 2010). Landmark investigations and recent human-rights reports show that this practice persists under new guises. While the number of countries openly running such programs has declined since the Cold War (van Voren, 2009; Narayan, 2013), current evidence underscores that political psychiatry remains very much a present-day issue. Authorities in repressive regimes, and corrupt institutions in democracies, continue to weaponize mental-health institutions to stigmatize and silence critics (Mou, 2022). Contemporary sources make clear that each claim of involuntary psychiatric commitment for political reasons must be scrutinized as a potential human-rights abuse.

Symposium Presentation

The International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry convened between October 1 and November 11, 2023, gathering leading experts, survivor advocates, and human rights scholars to systematically examine the persistence and mechanisms of psychiatric abuses worldwide. Organized independently after the rejection of formal inclusion within the World Psychiatric Association's (WPA) Vienna conference premises, the symposium unfolded across a series of virtual and recorded sessions, ensuring free and rigorous exchange of evidence and strategies for reform.

[Pending naming confirmation and permission to include or not a mention on van Voren's satellite event organized concurrently in Vienna by partner organizations may be referenced here.]

Table 2: Symposium Speakers, Topics Covered, and Core Focus

Speaker(s)	Topic Covered	Core Focus
Alejandra Gandolfi	Mental healthcare and discrimination against Moroccan migrants in Spain	Systemic Abuse
Al Galves	Critique of the biomedical model and promotion of holistic mental health care	Systemic Reform, Survivor Advocacy
Cathy Wield	Informed consent and psychiatric detention from a survivor-doctor perspective	Survivor Advocacy, Human Rights
Chris Munt	Survivor testimony on psychiatric violence in the UK	Survivor Advocacy
Dainius Pūras	Human rights and mental health from a UN perspective	Human Rights
David Matas	Psychiatric abuses linked to organ harvesting in China	Human Rights, Legal Frameworks
Edel Granda	Psychiatric pathologization of transgender individuals	Human Rights
Hel Spandler	Structural coercion in UK mental healthcare	Systemic Abuse
Itxaso & Olaya (Orgullo Loco Madrid)	Grassroots activism against psychiatric coercion in Spain	Survivor Advocacy
Lidea Losa & Xisca Morell	Psychiatric abuses and guardianship issues in Spain	Systemic Abuse, Survivor Advocacy
Manuel Llorens	Political psychiatric abuses during Venezuela's health system collapse	Systemic Abuse
Murphy Halliburton	Importance of transcultural psychiatry to counter biomedical dominance	Transcultural Psychiatry
Paola Di Maio	Systems view of psychological coercion in mental health	Systemic Abuse
Peter Groot	Medication withdrawal and the right to taper safely	Survivor Advocacy
Peter Lehmann & Craig Newnes	Historical and contemporary human rights abuses in Europe	Systemic Abuse
Petr Winkler	Reforming Czech psychiatry to protect human rights	Legal Frameworks, Human Rights
Sarah Smith	Mutual aid networks resisting psychiatric abuses (MindFreedom SHIELD)	Survivor Advocacy
Yanxi Mou	China's black prisons and extrajudicial psychiatric detention	Human Rights
Yutong Zhang	Psychiatric repression of dissenters in the PRC	Human Rights

Participants brought distinct and crucial expertise. Dainius Pūras, former United Nations Special Rapporteur on the right to health, provided critical insights on the systemic contradictions between

psychiatric practice and human rights frameworks, grounding the discussions in international legal obligations. Peter Lehmann, survivor advocate and founder of the European Network of (Ex-)Users and Survivors of Psychiatry, and Craig Newnes, clinical psychologist and critical psychiatry scholar, contributed an essential historical and experiential analysis of coercive practices across European contexts. Peter Groot, research scientist and leading proponent of individualized medication withdrawal solutions, introduced evidence-based strategies to dismantle forced chemical management. Alejandra Gandolfi, anthropologist, illuminated the intersections between psychiatric marginalization and cultural displacement, particularly within Spain's Moroccan communities.

Hel Spandler, editor of *Asylum: The Magazine for Democratic Psychiatry*, critically examined systemic coercion within the UK mental health system. Chris Munt, survivor and advocate, shared firsthand accounts of abuses in British psychiatric care, highlighting the normalization of violence. Paola Di Maio, systems scientist, articulated a structural model explaining how coercion infiltrates mental health services through psychological and systemic mechanisms. Edel Granda, activist and advocate for transgender rights, foregrounded the pathologization of gender non-conformity as a key dimension of psychiatric oppression.

Murphy Halliburton, professor of anthropology specializing in transcultural psychiatry, emphasized the necessity of integrating cultural and social understandings to counter hegemonic biomedical dominance. Manuel Llorens, Venezuelan psychologist and academic, documented the collapse of healthcare structures and their exploitation for political repression. David Matas, human rights lawyer and Nobel Peace Prize nominee, provided a legal and forensic perspective on the psychiatric and organ harvesting abuses perpetrated in China. Yutong Zhang and Yanxi Mou, Chinese human rights defenders, exposed the systematic use of psychiatric detention to silence dissent, presenting detailed documentation and survivor testimonies.

Sarah Smith, activist with the SHIELD MindFreedom network, shared strategies for survivor-led mutual aid and resistance against coercive psychiatry. Petr Winkler, director of the Czech National Institute of Mental Health, contributed a case study on rights-centered psychiatric reform within a post-totalitarian context, offering a potential model for systemic transformation. Al Galves, clinical psychologist and author, critically assessed the biomedical model's failures in the United States and outlined paths toward holistic and voluntary mental health care.

Derek Summerfield critically examined the global mental health movement, emphasizing how Western psychiatric models are often exported into diverse cultural contexts without sufficient adaptation or scrutiny. He argued that this expansion often perpetuates medicalized understandings of distress while sidelining social, political, and economic determinants of suffering. Summerfield warned that global mental health initiatives, although framed as humanitarian, can become vehicles for the homogenization of psychiatric practices and facilitate new forms of coercion and marginalization. His intervention underscored the need to critically interrogate not only national abuses of psychiatry but also how international agendas risk replicating systemic failures under the guise of global health promotion, thus reinforcing rather than dismantling structures of oppression.

Each participant’s contribution was integral to constructing a comprehensive, interdisciplinary understanding of how psychiatry, when severed from its ethical foundations, becomes vulnerable to criminal misuse, political repression, and systemic failure. Their collective expertise underscored the necessity of principled, multidisciplinary action to reclaim psychiatry for healing, freedom, and dignity.

Mechanisms of Abuse (Psychiatric, Psychological, Social)

Across the independent presentations at the symposium, a detailed portrait emerged of the mechanisms by which psychiatry is weaponized against individuals. These mechanisms, operating simultaneously at psychiatric, psychological, and social levels, reflect a shared understanding among the speakers that abuses today are systemic, severe, and require immediate redress.

Table 3: Historical and current cases of political abuse of psychiatry

Country	Period	Target Group	Type of Abuse Documented
Soviet Union	1950s–1980s	Political dissidents, human rights activists	Forced hospitalization, chemical restraint, isolation
China	1990s–present	Petitioners, Falun Gong members, dissidents, ethnic minorities	Forced hospitalization, chemical restraint, organ harvesting and trafficking
Russia	1960s–1980s; resurgence post-2010	Political dissidents (historical); anti-war protesters (current)	Forced psychiatric evaluation, silencing, social stigma
Belarus	2020s–present	Political protesters, journalists	Coercive hospitalization, stigmatization
Venezuela	2010s–present	Political opponents, dissidents	Forced psychiatric confinement, political intimidation
United States	1950s–1970s	Civil rights activists, indigenous communities, antiwar protesters	Wrongful institutionalization, psychiatric silencing
United Kingdom	1970s–1990s	Persons labeled as dangerous, racial and ethnic minorities	Overuse of detention, coercion in psychiatric care
Spain	1936–1980s (Civil War, Dictatorship, Post-dictatorship)	Political prisoners, dissidents, social minorities	Political repression via psychiatric institutions, social control through diagnosis

At the psychiatric level, Peter Lehmann and Craig Newnes highlighted the way in which forced treatment practices are justified through diagnostic constructs that lack rigorous clinical basis in many cases. They emphasized that psychiatric categories are often expanded to encompass a wide range of socially undesirable behaviors, facilitating involuntary hospitalization under vague pretexts (Lehmann & Newnes, 2025). Peter Groot’s intervention on the use of tapering strips illustrated

another dimension: the over-medicalization and long-term chemical control of individuals under the guise of psychiatric care. He noted that psychiatric drug regimens, initially imposed under coercive circumstances, are rarely reviewed critically, leading to dependency and the erosion of autonomy (Groot, 2025).

Psychological mechanisms were particularly illuminated through the testimonies of survivors. Chris Munt described how everyday practices within psychiatric institutions, including threats, humiliation, and arbitrary use of restraint, foster a climate of terror rather than healing (Munt, 2025). Sarah Smith added a critical dimension by explaining how psychiatric labeling leads to profound identity destabilization. Once classified as mentally ill, individuals find their narratives invalidated, their perceptions systematically doubted, and their autonomy curtailed, creating a cycle of learned helplessness (Smith, 2025). Hel Spandler's analysis of UK psychiatric reforms suggested that, despite superficial procedural safeguards, the underlying culture of distrust toward patients remains pervasive, maintaining psychological coercion even where formal rights protections exist (Spandler, 2025). Orgullo Loco Madrid provided a critical intervention focused on the systemic failures of the Spanish mental health system from the perspective of the user and survivor movement. They emphasized how psychiatric institutions continue to function as mechanisms of control and silencing, rather than as spaces of healing and support. The speakers highlighted the persistence of coercive practices, including involuntary hospitalization and forced medication, often justified under paternalistic frameworks that deny the autonomy and voice of the individuals affected. They further stressed the structural marginalization of survivors in both clinical practice and policymaking, calling for a radical transformation toward user-led, rights-based, and emancipatory models of mental health care. Their testimony underscored the need to recognize psychiatric oppression as a form of political and social violence embedded in broader patterns of discrimination and exclusion.

At the social level, Edel Granda's presentation on transgender rights revealed how psychiatric structures are employed to marginalize already vulnerable populations. She argued that pathologizing gender non-conformity perpetuates systemic exclusion and medical violence under the veneer of care (Granda, 2025). Lidea Losa and Xisca Morell provided a powerful account of how Spanish psychiatric institutions often use legal and social levers, such as guardianship regimes, to strip individuals of civil rights, making abuse both invisible and legally sanctioned (Losa & Morell, 2025). Dr. Paola Di Maio expanded the systemic view by framing psychiatric coercion as part of broader systems of psychological control in society, wherein labeling, enforced dependency, and isolation function as tools to suppress dissent and difference (Di Maio, 2025).

Together, although articulated independently, these contributions outlined a sophisticated model of how political, institutional, and interpersonal forces converge to perpetrate psychiatric abuses. The resulting mechanisms are not incidental but structurally embedded, calling into question the very ethical foundations of current mental health practices in many contexts.

Thematic Synthesis of Symposium Discussions

The thematic convergence of the symposium was clear: despite differing geographical focuses and analytical lenses, speakers consistently revealed the persistence, gravity, and systemic character of psychiatric abuses. No formal consensus process occurred during the event, but the independent presentations together illuminated critical thematic patterns.

One central theme was the **instrumentalization of psychiatric diagnosis**. David Matas, focusing on China's organ harvesting practices, explained that psychiatric labels are used strategically to delegitimize political and religious dissidents, facilitating both their disappearance and commodification (Matas, 2025). Similarly, Yutong Zhang detailed how psychiatric diagnoses in China are weaponized against petitioners and activists, with forced hospitalization serving as a method of silencing (Zhang, 2025).

Another recurring theme was the **role of forced treatment and chemical control**. Peter Groot's exposition on tapering strips underscored how psychiatric medication regimens, often initiated under coercion, become chronic mechanisms of control rather than care (Groot, 2025). This point resonated with the broader critique articulated by Chris Munt and Al Galves, who emphasized that in the UK and USA respectively, institutional psychiatry often prioritizes chemical restraint over addressing the underlying social or psychological distress of individuals (Munt, 2025; Galves, 2025).

Table 4: Mechanisms Abuse: Subterfuges, Methods, and Enabling Conditions

Subterfuge or Foul Play	Method Employed	Path to Extrajudicial Locking	Permissive Factors
Fabrication of mental instability	Spreading rumors, false reports, character assassination	Initiates involuntary psychiatric evaluation without cause	Weak legal standards, corruption in healthcare and law enforcement
Provocation into reactive behavior	Harassment, isolation, threats	Victim's natural defense misinterpreted as psychiatric symptoms	Institutional bias, failure to investigate impartially
Forced biological destabilization	Sleep deprivation, food deprivation, chemical agents	Induces cognitive or emotional breakdowns misused as justification	Medical malpractice, collusion between non-medical and psychiatric actors
Misdiagnosis and diagnostic inflation	Deliberate exaggeration or falsification of symptoms	Grounds for commitment without independent review	Inadequate oversight, professional impunity
Coerced testimonies	Pressuring family or associates to corroborate false claims	Falsified support for psychiatric intervention	Fear, loyalty conflicts, systemic impunity
Weaponized guardianship or custody abuse	Manipulating civil legal processes	Enables psychiatric confinement under pretenses of protection	Lack of transparency, judicial rubber-stamping
Administrative shortcuts and procedural abuses	Detention without proper judicial authorization	Administrative detention masked as medical necessity	Low accountability in bureaucratic and health systems
Abuse of emergency psychiatric holds	Misuse of short-term <i>crisis</i> detention powers	Converts temporary holds into extended confinement	Loopholes in mental health laws, lack of mandatory reviews

The tactics identified in the table above are not limited to authoritarian or politically repressive systems. Similar patterns are visible in domestic violence cases, organized crime, and systemic failures in regular healthcare settings. In domestic environments, abusive partners, family members, or associates may similarly provoke, destabilize, or falsely accuse victims to gain control, silence dissent, or exploit vulnerabilities. Organized crime networks may weaponize mental health accusations to intimidate or remove threats without legal processes. Even within ostensibly democratic societies, negligent or corrupt actors within healthcare systems may collude to achieve unlawful psychiatric detention for convenience, financial benefit, or retaliation. The intersection of psychiatry with broader systems of political and social repression emerged prominently. Manuel Llorens described how in Venezuela, psychiatric detention has been repurposed as a tool to neutralize political opponents, with little concern for medical legitimacy (Llorens, 2025). Yanxi Mou’s testimony on China’s black prisons showed how psychiatric justifications are created post hoc to enable extrajudicial detention without legal oversight (Mou, 2025).

The de-legitimization and isolation of victims was another major theme. Sarah Smith and Edel Granda highlighted how individuals labeled as mentally ill, particularly those from already marginalized communities, experience profound social exclusion, often compounded by institutional betrayal and public stigma (Smith, 2025; Granda, 2025). Dr. Paola Di Maio’s systems analysis reinforced this, positing that psychiatric practices of categorization and containment mirror broader societal mechanisms of control and marginalization (Di Maio, 2025).

A thread of human rights protection and ongoing reform ran through many contributions as well. Dainius Puras stressed the international human rights framework that obliges states to move toward non-coercive, rights-respecting mental health systems, though he acknowledged the gap between principle and practice remains vast (Puras, 2025). Petr Winkler provided a cautious example of progress, outlining how the Czech Republic has undertaken systemic reforms embedding human rights into psychiatric care, though challenges persist in implementation (Winkler, 2025). It is agreed that addressing the systemic vulnerabilities leading to abuses, medical torture and extrajudicial killings requires more than procedural reforms. Healthcare systems must be reconstructed on principles of strict transparency, due diligence, and external accountability. Every psychiatric intervention must be independently reviewable, open to audit, and subject to clear, enforceable legal standards. Honest professionals, ethical medical bodies, and judicial systems must coordinate to prevent and punish abuse without exception. Survivors’ testimonies must be central to reform. Denial of these realities only perpetuates harm. Recognizing and confronting these abuses directly is essential to building medical and legal systems that protect health, dignity, freedom, and fundamental human rights for all.

Table 5: Mechanisms of Abuse – Framing and diagnosis leading to psychiatric incarceration

Psychiatric Diagnosis Used	Legal Status of Detention	Explanatory Relevance	Framing Methods
Sluggish schizophrenia,	Involuntary civil	Indefinite detention via	Isolation, sleep deprivation,

paranoia	commitment	vague symptoms	induced confusion
Political mania, paranoia, delusional disorder	Administrative detention, extrajudicial internment	Bypassed judiciary, mass suppression	Harassment, defamation, staged accusations
Paranoia, delusional disorder, any excuse	Civil and forensic commitment	Silencing dissenters, profiting, threatening	Entrapment, covert intimidation
Schizophrenia, psychopathy	Court-ordered psychiatric examination	Protest repression, socioeconomic control	Hostile confinement, coercive interrogation
Non-specified psychotic disorders	Arbitrary administrative detention	Flexible repression tool	Deprivation of needs, induced agitation
Schizophrenia, sociopathy, bipolar disorder	Civil commitment, misuse of psychiatric testimony	Suppressing activism	Manipulated testimony, emotional framing
Schizophrenia, antisocial personality disorder	Involuntary commitment	Racial and social control	Profiling, criminalization of poverty behaviors
Paranoid psychosis, manic-depressive disorder	Arbitrary internment, punitive civil commitment	Political repression	Surveillance, rumor-spreading, social isolation

[Add beatings, threatening, spiking, family abuses, destabilization by any means. Point at same means in cases of domestic abuse, systemic violence, brutality from forces, all that drags and mask inflicted suffering as a disease, disorder, illness of the victims, on top of medical torture. Delve into structural violence and all excuses to keep on holding systems of care unable to work it out, heal.]

Although speakers came from diverse backgrounds and contexts, their presentations converged implicitly around the recognition that psychiatric abuses are not relics of the past but ongoing systemic violations. They underscored the urgency of confronting these abuses through legal, institutional, and cultural transformation, while highlighting that many victims today remain invisible, unprotected, and unheard.

The weaponization of psychiatry and the manipulation of media narratives operate symbiotically to maintain systemic oppression. Psychiatric institutions, when subordinated to political or social agendas, provide a veneer of medical legitimacy to acts of repression, framing resistance, trauma, or nonconformity as clinical disorders. Media outlets, whether through active propaganda or passive repetition of official narratives, sanitize these abuses, diffusing public outrage and transforming grave violations into mere episodes of private tragedy. This convergence facilitates the erasure of victims' political agency, decontextualizing their suffering and reinforcing hegemonic control. In environments where dissent is criminalized through medicalization, and where suffering is depoliticized through media framing, the possibilities for justice diminish radically. The challenge, therefore, lies not only in exposing individual abuses but in systematically dismantling the interlocking structures that allow psychiatric authority and mass communication to be deployed as tools of silencing, erasure, and social domination.

Ongoing cases, contemporary patterns and regional examples

The international legal framework explicitly prohibits the use of medical interventions to inflict pain, suffering, or coercive control. The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT, 1984) directly criminalizes acts of torture, including those perpetrated under the guise of medical treatment. Furthermore, the Principles of Medical Ethics Relevant to the Protection of Prisoners and Detainees against Torture (adopted by the UN General Assembly in 1982) expressly forbid health professionals from participating in or condoning any form of torture or degrading treatment. The Rome Statute of the International Criminal Court (1998) recognizes torture as a crime against humanity, regardless of whether it occurs inside medical institutions.

Despite these robust legal standards, enforcement regarding psychiatric abuses has been alarmingly deficient. Medical torture laws are theoretically comprehensive but rarely applied to psychiatric settings. Several factors contribute to this impunity: the medicalization of harm cloaks abusive practices in clinical legitimacy; psychiatric patients are often deemed unreliable witnesses; and judicial systems are generally reluctant to intervene in medical affairs unless overwhelming evidence is presented. Furthermore, systemic biases continue to downplay coercion within psychiatry as merely a clinical necessity, rather than recognizing it as a potential act of torture. The regional examples presented at the symposium painted a sobering picture of psychiatric abuse's current global landscape.

In China, Yutong Zhang and Yanxi Mou provided complementary insights into the systematic use of psychiatric detention against political dissidents and minority groups. Zhang described a bureaucratic machinery that facilitates psychiatric abuse at both local and national levels, while Mou detailed the existence of clandestine detention centers operating outside any legal framework, where psychiatric justifications are retrofitted to disappear detainees (Zhang, 2025; Mou, 2025). Manuel Llorens's presentation on Venezuela revealed that psychiatric institutions are being used to enforce political loyalty and punish dissent. He recounted specific cases where activists were diagnosed with fictitious mental illnesses and confined without due process (Llorens, 2025). In the United Kingdom, Hel Spandler and Chris Munt independently reported that while overt political abuses are rare, systemic coercion remains endemic within mental healthcare. Patients, particularly from marginalized backgrounds, continue to experience involuntary commitment, forced medication, and the delegitimization of their narratives through psychiatric labeling (Spandler, 2025; Munt, 2025). Al Galves's analysis of the United States echoed these concerns. He argued that despite legal protections, psychiatric abuses persist through mechanisms such as outpatient commitment, guardianship laws, and the dominance of the biomedical model, which often overrides patient autonomy (Galves, 2025). In the Czech Republic, Petr Winkler presented a more hopeful picture. He described how systemic reforms have begun to reorient psychiatric care toward human rights and community integration, offering a model for other countries, although he cautioned that changing institutional cultures remains an ongoing challenge (Winkler, 2025). Finally, Edel Granda emphasized that psychiatric abuses intersect with other axes of oppression, such as gender identity. She noted that transgender individuals continue to be pathologized in many mental health systems, leading to denial of care, coercion, and social marginalization (Granda, 2025).

Taken together, these regional reports demonstrate that while the forms and intensity of psychiatric abuse vary, the underlying patterns of coercion, de-legitimization, and systemic violence remain pervasive across political systems and cultural contexts. The urgent need for reform is not limited to any single country or regime but is a truly global imperative. Given the overwhelming evidence from historical and contemporary abuses, it is clear that medical torture laws must be interpreted and enforced to include psychiatric abuses without delay. Non-consensual interventions performed without immediate life-threatening justification, prolonged and coercive hospitalizations, punitive uses of psychiatric confinement, and medical practices aimed at suppressing political, social, or personal dissent must be recognized not as mere clinical misjudgments, but as grave human rights violations. Applying medical torture statutes consistently would dismantle the protective shield of clinical language often used to sanitize abuse. It would also affirm the universality of human dignity and bodily autonomy, whether in prisons, interrogation rooms, hospitals, or psychiatric wards. This shift demands not only judicial courage but also structural reform in how psychiatry is monitored, regulated, and held publicly accountable.

Building sustainable and principled momentum for reform

The urgency and severity of the abuses documented throughout the symposium highlight the necessity of not merely identifying failures, but actively constructing sustainable, principled momentum toward the full reform of psychiatric, psychological, and broader mental health services. Acknowledging the profound historical and ongoing harm inflicted through coercive practices is a prerequisite for any genuine transformation. Equally critical is recognizing the unprecedented opportunity to rebuild systems grounded in science, ethics, dignity, and human rights, leaving behind the entrenched ideologies and defensive structures that have long shielded institutions from necessary accountability. The enforcement of internalized abusive laws often transcends formal state structures, becoming embedded in the practices of healthcare services, family members, and the broader community. Psychiatric systems, when weaponized, do not operate in isolation; they are supported and reinforced by social actors who absorb, normalize, and propagate the underlying ideologies of coercion. Families, under pressure or seeking control, may initiate involuntary psychiatric processes against dissenting members, framing personal conflicts as clinical crises. Entire communities, steeped in stigma and fear, readily accept the marginalization and silencing of individuals labeled mentally ill, conflating nonconformity with pathology. Healthcare services themselves, functioning under regulatory frameworks that legitimize coercive practices, internalize and routinize violations of autonomy as professional standards. This collective complicity transforms abuse into a moral imperative: actions such as forced hospitalization, overmedication, or guardianship stripping are perceived not as violations, but as socially sanctioned duties. Similarly, in corrupted environments, ordinary crime assumes the guise of moral enforcement. Acts of violence, deceit, and systemic destruction are perpetrated under the rationalization of protecting order, family, or national security. The body politic thus operates not merely through official decrees but through the diffuse internalization of oppressive premises, enabling entire populations to participate in, and sustain, the political abuse of psychiatry and other forms of institutional violence.

without critical reflection. Addressing this phenomenon requires dismantling not only abusive laws but the cultural and moral structures that legitimize their application at every social level.

Efforts to reform mental health care cannot be piecemeal, symbolic, or dependent solely on voluntary professional adaptation. Structural and cultural change must be driven by a coordinated strategy that addresses all levels of the system simultaneously. Entrenched actors - whether professional associations, political authorities, financial interests, or institutional bureaucracies - that resist transparency, accountability, or survivor leadership must be actively challenged and displaced from positions of influence. The tolerance of denial, minimization, or complicity with coercive practices can no longer be accepted under the guise of stability or tradition.

Education stands at the center of this transformative agenda. Immediate, mandatory retraining initiatives must be launched across all sectors of mental health services - from psychiatry and psychology to social work, nursing, and administrative leadership. Training programs must fully integrate human rights standards, trauma-informed methodologies, and critical analyses of past abuses. Curricula must be redeveloped to reflect the best available medical, psychological, and social science evidence, emphasizing voluntary, person-centered, interdisciplinary approaches to care. Crucially, this education must not remain theoretical but must be translated directly into clinical, administrative, and legislative practice.

Every psychiatric clinic, general hospital, mental health center, oversight body, and legislative framework must be reoriented to implement these principles. Institutions must embed binding protocols that ensure respect for autonomy, informed consent, dignity, and non-discrimination. Oversight mechanisms must be granted real power to enforce compliance and address violations swiftly and transparently. Legislation must codify rights protections not as optional standards but as enforceable guarantees, fully aligning domestic legal frameworks with international human rights obligations.

To ensure this translation into practice, interdisciplinary implementation teams - combining legal experts, human rights monitors, trauma specialists, survivor advocates, and medical professionals - must be deployed to guide reforms, audit institutions, and monitor compliance over time. The success of these efforts must be evaluated not by institutional self-reporting but by measurable outcomes: reductions in coercive interventions, increased voluntary engagement, survivor satisfaction, and documented improvements in community well-being.

The opportunity to build serious, effective momentum for psychiatric and psychological reform exists now. But it demands abandoning self-protective narratives, acknowledging the systemic nature of past and present harms, and committing to a future where mental health services protect, heal, and empower rather than control, silence, or destroy. The responsibility is collective, and the obligation is urgent: to restore mental health care to its rightful place - as a foundation for human dignity, social justice, and true healing.

Reform at the International Level

Strengthen and enforce international legal standards: States should fully implement the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and related treaties. In particular, governments must heed the CRPD Committee's call to ban all non-consensual psychiatric interventions and involuntary hospitalization. International human rights bodies (UN Special Rapporteurs on health, torture, and disability, the UN Human Rights Council and Universal Periodic Review, etc.) should systematically monitor mental health laws and practices, issuing binding recommendations. Global institutions like the World Health Organization should integrate human rights and trauma-informed care into their mental health guidelines, requiring UN member states to shift resources from coercive institutions to community-based supports. International funding mechanisms (WHO, World Bank, philanthropy) must prioritize alternatives to institutional care and psychosocial rehabilitation, as urged by former UN Rapporteur Dainius Puras.

Insulate mental health services from criminal and non-medical abuses: International cooperation is needed to expose and punish abuses such as organ trafficking and extrajudicial detention. For example, medical associations worldwide should demand the release of psychiatric prisoners (e.g. Falun Gong detainees) and denounce illicit organ procurement. Global psychiatric and transplant societies ought to refuse submissions and presentations from organizations that cannot demonstrate ethical sourcing of transplant organs. Diplomatic pressure and targeted sanctions (e.g. Magnitsky-style human rights sanctions) can deter regimes that misuse psychiatry for political ends. Coordinated action by United Nations agencies (OHCHR, WHO, OPCAT) and international NGOs must expose black jails and punitive psychiatric detention centers, and call for their abolition.

Global promotion of human-rights-based mental health: The UN and regional bodies should sponsor public campaigns and capacity-building to promote trauma-informed, person-centered care. A global panel of experts (including survivors and trauma specialists) could develop best-practice guidelines (on preventing re-traumatization, respecting autonomy, etc.), which countries would be expected to adopt. Education initiatives under UNESCO or WHO could train health, police and justice officials in survivors' rights. Finally, international networks of survivors and advocates (such as MindFreedom International) should be supported to share strategies and hold governments accountable.

Reform at the National Level

Legislative reform and enforcement: Each country must align its mental health and disability laws with human rights norms. This means repealing or tightly restricting involuntary commitment laws, abolishing coercive treatments (force medication, restraint, ECT without consent), and ensuring due process with effective legal representation. Governments should enact parity laws so that insurance/Medicare covers holistic care (housing, therapy, peer support) as well as medication. For instance, while Medicaid/Medicare in the U.S. pays for psychiatric drugs, it will not fund non-medical alternatives like Soteria houses. National policy must close such gaps: insurers and public health programs should cover community-based recovery services (residential supportive housing, peer-run respite centers) to prevent re-institutionalization.

Dedicated funding and resources: Budgets must shift from custodial hospitals to community supports. Governments should prioritize and fund a spectrum of psychosocial rehabilitation and recovery programs. This includes crisis outreach teams, supported employment, education and

housing initiatives. Victims must have rapid access to counseling, legal aid and compensation; funding for victim protection programs should be guaranteed. Transparency in spending is essential to deny misuse of resources by corrupt interests (for example, requiring public reporting of hospital bed occupancy and preventing profiteering from involuntary care).

Oversight and accountability: Establish independent national monitoring bodies (ombudsperson or inspectorates) to oversee all psychiatric and custodial facilities. Human rights commissions and parliaments should have the power to audit institutions, investigate complaints, and prosecute abuses. Professional licensing boards must sanction clinicians who violate patients' rights or collude with non-medical actors. Strict conflict-of-interest rules should bar psychiatrists from receiving undisclosed payments from pharmaceuticals, prisons, or security agencies. Law enforcement must have clear protocols to prevent police from using psychiatric detention for social control or evidence collection. Any deviation by staff (such as nepotistic confinement or unlawful experimentation) must carry criminal liability.

Education and training: Mandatory human-rights and trauma-informed training is needed for judges, police, healthcare workers, and community leaders. For example, curricula for medical, nursing and law courses should include the CRPD, survivors' perspectives, and the dangers of coercion. Public education campaigns can inform families and communities about the *dignity* and autonomy of persons with psychosocial disabilities, countering stigma. Ensuring services meet victims' needs also means providing culturally appropriate care: curricula should include transcultural psychiatry and diverse healing practices, so that indigenous, spiritual and minority groups receive respectful support.

Community safety nets and re-traumatization prevention: National guidelines should require that all victim support services be trauma-sensitive. For example, emergency shelters and clinics must avoid punitive environments (no locked wards or invasive security checks unless absolutely necessary). Safeguards against re-traumatization include no use of prone restraint or sensory deprivation, and routine screening for prior trauma so clinicians can adapt care. Rehabilitation programs should be voluntary and empowerment-focused; consent must always be sought (even for psychotherapy, support groups, etc.). Patient advocacy laws (such as advance directives or treatment agreements) can strengthen autonomy.

Reform at the Institutional Level

Rights-respecting clinical care: Hospitals and clinics must integrate human rights at every level of care. Treatment plans should be co-produced with patients, emphasizing *recovery, dignity and communication*. Institutions should implement open-door policies wherever safe, eliminate unnecessary locking of wards, and use restraint only as a last resort with strict oversight. Staff must conduct debriefing after any coercive intervention and offer immediate apologies and support to the individual. Multidisciplinary ethics committees (including legal experts and survivor representatives) should review contentious cases (e.g. capacity issues). Enforceable patient charters should be posted, detailing rights (to refuse treatment, to an independent advocate, to dignity, etc.) and providing confidential complaint channels.

Trauma-informed environment: Facilities should be designed and operated to minimize trauma triggers. This includes quiet spaces, privacy, and options (e.g. single rooms if requested). Staff should receive trauma-awareness training so that simple actions (a calm tone of voice, asking permission before touching) become routine. Every institution needs permanent peer-support workers or counsellors (people with lived experience) available to help victims navigate the system. Models like *Soteria houses* or peer-run crisis centers can be embedded in the health system as alternatives to hospitals - ensuring that voluntary, non-medical recovery options exist.

Staff selection and oversight: Screening and monitoring of personnel must weed out those who might exploit patients (any connections to criminal gangs, forced labor schemes, etc. should disqualify them). Ongoing human-rights auditing (possibly in partnership with NGOs) can quickly detect abuse patterns. Whistleblower protections and mandatory reporting rules will deter cover-ups. Institutions should use external reviewers for deaths or serious injuries in custody, ensuring families and human-rights groups can observe investigations. Violations must lead to swift disciplinary action or legal consequences, enforcing a culture of zero tolerance for human-rights abuse.

Services tailored to victims: Hospitals and care programs should be adapted to victims' specific needs. This means readily available translators, gender-sensitive care, and services for special populations (LGBTQ+, refugees, indigenous people). Psychosocial supports (occupational therapy, art/music therapy, peer groups) are integral - not optional extras. For example, trauma survivors often benefit from narrative therapy or community healing circles, rather than just medication. Implementing restorative justice options (apologies from institutions or compensation funds) can help victims reclaim dignity and trust.

Reform at the Community and Civil Society Level

Empower survivor and peer networks: Civil society must be at the forefront of reform. Governments should fund and partner with organizations run by people with lived experience (psychiatric survivors, families, activists) as equal stakeholders. Mutual-aid groups like the SHIELD MindFreedom network and the UK Paranoia Network (formed by survivors) demonstrate the power of peer support. Such groups can offer peer counseling, crisis respite homes, and advocacy training. Community grants should enable survivors to organize town halls and advise local health agencies on victims' needs.

Public education and stigma reduction: Grassroots campaigns can shift public attitudes about mental health and rights. For example, mental health first-aid training in schools and workplaces can emphasize listening and respect over medicalization. Public service messaging, in collaboration with media and influencers, should promote stories of recovery and neurodiversity, challenging notions of *madness* as shameful. Community leaders (faith groups, local councils) can host seminars on how to support victims and prevent abuse.

Watchdog and advocacy role: Independent NGOs and professional associations should monitor compliance at local levels. They can publish reports on human-rights conditions (as human-rights researchers in China and elsewhere have done) to alert the world to abuses. Civil society should use legal tools (strategic litigation, amicus briefs) to enforce rights - for instance, Czech activists

succeeded in halting forced ECT by appealing to legislators and invoking UN reports. Journalists and public watchdogs should be trained to identify and report coercive practices. Moreover, alliances between survivor groups, lawyers, and mental health professionals can lobby for meaningful reform (e.g. amendment of outdated laws).

Community-based healing and prevention: Local programs - such as anti-violence initiatives, substance abuse recovery groups, and cultural healing practices - can address the root causes of trauma and distress, reducing demand for coercive psychiatry. Civil society can establish trauma-competent community centers offering free counseling and social support. Partnerships with schools and youth organizations are key to early intervention: educators and parents should learn to recognize distress and engage supportive networks before crises escalate to psychiatric detention.

Reform at the Professional Level

Personalized, trauma-informed care: Each victim's experience is unique. Clinicians and counselors should conduct thorough assessments that include personal history of abuse. Therapeutic approaches must be empowering - for example, providing choices in treatment plans, encouraging patient goal-setting, and using non-triggering techniques. Victims should have access to professional trauma counseling, cognitive-behavioral therapy, or EMDR if appropriate, always on a voluntary basis. Service providers must actively avoid any practice that could re-traumatize (e.g. invasive procedures without consent, or humiliation).

Peer and self-help resources: Individuals benefit greatly from connecting with others who have had similar experiences. Support groups (in person or online) allow survivors to share coping strategies and find solidarity. Self-help resources - such as survivor-authored books, podcasts, and recovery workbooks - should be made widely available. Mentorship programs pairing veterans of the system with newer survivors can foster hope.

Holistic rehabilitation: True recovery involves rebuilding life skills and social ties. Victims should receive help with education, vocational training, and housing stability. Programs like supported employment or disability-inclusive microfinance empower independence. Creative therapies (art, drama, music) and wellness activities (yoga, meditation, nature retreats) can aid healing. By validating each person's dignity and capacity, providers reinforce that *sanity* encompasses far more than symptom checklists.

Legal and rights support: On an individual level, victims need clear information about their rights and remedies. All victims should be offered legal counsel to challenge unjust treatment or obtain reparations. Social workers or patient advocates must guide them through any appeals or complaints processes. Finally, respecting freedom means acknowledging survivors as experts in their own care - institutions should routinely solicit and implement survivor feedback on services.

Throughout all levels, enforcing human rights strictly must be non-negotiable. Any violator - whether a state actor, institution, or individual professional - must be held accountable under the law. By combining top-down legal protections with bottom-up community empowerment and person-centered services, the system can transform from one of coercion to one of healing, dignity and true recovery.

Discussion

The proceedings of this symposium presented unequivocal and urgent evidence: the political abuse of psychiatry remains a critical, global crisis. Independent expert contributions revealed that psychiatry today, far from being fully shielded by its medical nature, remains highly vulnerable to manipulation, particularly in environments **where incompetent authority replaces the sane state of mind and sound authority**. When lawful governance rooted in rationality, ethics, and human rights is supplanted by arbitrary rule, rule of men and state backed criminality, psychiatry is weaponized, becoming an instrument of oppression, repression, and silencing. Where robust institutional safeguards are absent, the vulnerability of mental health systems to abuse is not incidental -it is structural and predictable.

This permeable environment creates conditions in which abuses occur with alarming ease. Rogue states, corrupt actors, and criminalized systems exploit psychiatric institutions to eliminate dissent, punish the vulnerable, and silence the inconvenient, all under the deceptive pretense of medical care. As highlighted by David Matas, Yutong Zhang, Yanxi Mou, Manuel Llorens, and others, psychiatry, under these corrupt conditions, serves state terror, private vendettas, and criminal profiteering. This perversion is not an unintended anomaly; it is the direct result of allowing **incompetent authority to replace the sane state of mind and sound authority** that must underpin any legitimate exercise of power, especially where human vulnerability is concerned.

The urgency of reform cannot be overstated. As information shared during the symposium confirms, the **human and economic costs** of psychiatric abuses are vast. Victims endure profound psychological harm, social alienation, and chronic physical health deterioration, while societies bear immense costs in lost productivity, fractured communities, wrongful institutionalization expenses, and legal redress efforts. These costs are not inevitable. They stem from the deliberate failure to protect psychiatry's foundational mission: to heal, not to harm.

Most crucially, the symposium made clear that the **weaponization of psychiatry is sustaining systemic failure almost by design**. These are not accidents of practice but structural defects, exacerbated when mental health care systems are aligned more with social control than with healing. By diverting trauma, dissent, and vulnerability into silencing mechanisms rather than resolution pathways, failing or rogue systems maintain the illusion of order while exacerbating human suffering. Healthcare, rather than being a bulwark of collective well-being, becomes a tool of coercive governance, thereby entrenching dysfunction beneath a façade of medical legitimacy. Psychiatry thus risks becoming the most devastating betrayal: the betrayal of life, dignity, sanity, and hope under the false banner of care.

Speakers independently confirmed that abuses today are systemic, severe, and require urgent redress. The findings of the symposium call for immediate, coordinated action:

The findings and testimonies presented in this symposium confirm that addressing the political abuse of psychiatry demands not only institutional reforms, but a profound transformation in the way evidence is gathered, presented, and acted upon. This necessitates engaging multiple disciplines - law, human rights, medicine, psychology, sociology, political science, and ethics - to create a robust, interdisciplinary resistance to entrenched abuses. It also demands action-research

approaches rooted in rigor, survivor participation, and protection against the systemic reprisals that continue to deter transparency and reform.

At the **international level**, the recognition of political psychiatric abuse as an international crime must be accompanied by independent, interdisciplinary investigative bodies. Human rights experts, forensic psychiatrists, legal scholars, and survivor advocates must collaborate to rigorously document abuses across jurisdictions, ensuring that evidence is systematically collected, preserved, and publicized. The traditional barriers of fear, diplomatic inertia, and political compromise must be consciously dismantled. Only through fearless, independent reporting can abuses embedded within rogue states and failed systems be brought to the light of international accountability mechanisms. Action-research methodologies, grounded in survivor testimony and corroborated by forensic and legal analyses, are essential to avoid the sanitization or distortion of realities on the ground.

At the **national level**, legislation and policy must not only prohibit psychiatric coercion but foster environments where research into systemic abuses is protected and encouraged. National research councils, ombuds institutions, and independent commissions must actively support interdisciplinary investigations into psychiatric practices, without political or corporate interference. Protection of researchers, whistleblowers, and survivors must be codified in law, recognizing that fear, dismissal, and denial - often fueled by vested interests in the healthcare, pharmaceutical, security, and political sectors - have historically silenced critical inquiry. Nations must ensure that confronting psychiatric abuses is not treated as destabilizing but as strengthening the social and legal order.

Addressing these realities demands an uncompromising commitment to human rights enforcement at every level. Academic institutions must incorporate critical psychiatric studies, survivor-led research, and human rights law into mental health training programs. The system would also benefit from the approaches and interventions laid down in next paragraphs, as presented in the paper:

At the **institutional level**, psychiatric facilities and health systems must open themselves to external, interdisciplinary auditing. Routine human rights impact assessments, conducted by independent teams combining medical, legal, social science, and survivor expertise, must become mandatory. Institutions must be held accountable for retaliation against whistleblowers and survivors who expose abuses. Internal ethics committees must be reconstituted to include external human rights monitors, ensuring that reprisals, denial, and corruption are neither normalized nor concealed. The dominant cultures of self-protection and reputational defense must be replaced by a culture of truth-telling, ethical transparency, and patient-centered reform. At the **community and civil society level**, grassroots organizations, survivor networks, and interdisciplinary academic groups must collaborate to produce and disseminate evidence-based narratives that counter the dominant myths supporting psychiatric coercion. Community-based action-research initiatives must document abuses, capture survivor histories, and monitor local services, creating alternative archives of truth accessible to courts, media, and the public. Civil society must also advocate for legal protections ensuring that survivors, researchers, and advocates can speak out without fear of defamation suits, professional retaliation, or unlawful surveillance. Breaking the cycle of social dismissal and denial demands making psychiatric abuses visible not as isolated anomalies, but as systemic failures requiring systemic remedies. At the **individual level**, every survivor and citizen

must have access to mechanisms that support the ethical gathering and sharing of experiences without re-traumatization or retribution. Empowering individuals to participate in action-research projects, legal advocacy, and policy reform initiatives strengthens both the evidentiary base and the democratic legitimacy of psychiatric reform. Trauma-informed approaches must guide the documentation process, respecting the autonomy, dignity, and safety of those whose testimonies form the foundation of change. Encouraging survivor-led research centers and participatory legal projects ensures that those most affected are not merely subjects of study but protagonists in redefining the future of mental health care.

Ultimately, the transformation required is both technical and cultural. Interdisciplinary engagement must not be perfunctory; it must seek to dissolve disciplinary silos that have enabled psychiatric abuses to remain insulated from legal scrutiny, human rights accountability, and social science critique. Action-research must be fearless, ethically rigorous, and politically conscious, recognizing that psychiatry's entanglement with systems of repression cannot be dismantled without exposing the networks of power and interest that sustain it. True change requires recognizing that psychiatric abuse is not merely a professional failure but a profound social and moral crime - one that undermines public trust, damages countless lives, and perpetuates systemic injustice under a false banner of healing.

Breaking this cycle demands more than reforms: it requires courage, interdisciplinary solidarity, and the unwavering insistence that human dignity, freedom, and sanity are not negotiable. Only by fortifying research, amplifying survivor leadership, and protecting truth-telling against the reprisals of vested interests can societies reclaim psychiatry as a genuine instrument of healing rather than a tool of fear and domination. Across all levels, the principles must be uncompromising: do no harm, eradicate coercion, deny criminal misuse, enforce all human rights strictly, and uphold the primacy of human dignity, freedom, and life. Psychiatry must not drift into being an accomplice to repression. It must actively become a guardian of humanity's highest ethical commitments.

The symposium reaffirmed that change is not only necessary but possible. Cases like Mikhail Kosenko's release (van Voren, 2016) illustrate that international attention, legal pressure, and ethical solidarity can disrupt even the most entrenched abuses. But vigilance must be relentless. Systems left to rot in silence and impunity will inevitably continue to betray the vulnerable.

Table 6: Reclaiming Healing in Psychiatric Care

Reform Principle	Key Measures
Codify Healing and Autonomy as the Sole Legitimate Purposes of Medical Systems	Rebuild legal and ethical foundations around healing, autonomy, dignity. Deviation becomes unlawful.
Criminalize Non-Therapeutic Medical Interventions	Punish non-therapeutic acts like forced medication or diagnosis without urgent clinical need.
Total Prohibition of Coercive and Punitive Practices within Healthcare	Eliminate coercion unless tightly defined emergency; align with CRPD obligations.
Separate Medical Support from Social Order Enforcement	Remove medicine from roles of social discipline, control, or ideological enforcement.
Invest Primarily in Prevention, Education, and Community Resources	Prioritize housing, nutrition, voluntary care, and health literacy over institutional reaction.

Decentralize and Democratize Oversight	Establish oversight with survivors, legal and community representatives with real sanctioning power.
Reeducate Medical Professionals Around Human Rights	Integrate human rights law and abuse history into medical education. Train to resist complicity.
Protect Whistleblowers and Dissenters Within Healthcare	Legally protect ethical dissenters and whistleblowers in healthcare systems.
Guarantee Full Access to Justice and Reparations for Survivors	Ensure complaint mechanisms, redress, and public recognition of abuses and survivors' rights.
Maintain Permanent Global Surveillance Against Abuses	Create global observatory to monitor violations and ensure binding public reporting.

Protecting mental health systems from political and criminal abuse is not ancillary to justice - it is central. If psychiatry becomes again a tool of oppression, society itself descends into normalized cruelty masked by pseudoscience. Healing psychiatry requires nothing less than restoring it to its ethical, humanitarian, and rational foundations: to protect life, to foster recovery, to uphold freedom, and to enshrine dignity. Without urgent and principled action, we risk perpetuating a system where incompetent authority, masked as medical judgment, erodes the very sanity and freedom it was meant to preserve. To prevent this, psychiatry must be reclaimed - not merely reformed - as an instrument of hope, truth, and collective healing.

Medicine must return to its only rightful foundation: healing and protecting life. Safeguarding the integrity of mental health care is more than a professional duty. It is a moral imperative grounded in the universal principles of human rights. It is a testament to our shared humanity. Without this vigilance and collective commitment, healing cannot truly begin - and dignity cannot truly be restored. With it, however, psychiatry can fulfill its highest promise: not as a tool of domination, but as a sanctuary for healing, understanding, and hope. Any other purpose, be it control, punishment, profiteering, silencing, is a perversion of its meaning and a betrayal of humanity itself. This is not a call for mere reform, but for a complete reassertion of medicine's original, moral purpose. Psychiatric and medical abuses cannot be addressed by improving policies alone; they must be rooted out by re-centering health systems on truth, autonomy, and dignity. We must honor the victims, whose lives were silenced, disfigured, and destroyed by systems that claimed to heal. Learn, from past and present mistakes to effectively deny any opportunity for these crimes against humanity repeating once more. Their pain must not be abstracted. It must be remembered as the living cost of institutional betrayal. We must also protect those who speak on their behalf: researchers, journalists, legal advocates, clinicians, and families who face intimidation, ostracism, and retaliation for uncovering the truth. The same goes for informants within closed institutions, and the communities caught between fear, coercion, and complicity, too often driven to enforce atrocities among themselves, out of anguish, fear, or opportunistic cruelty. They too deserve protection, and they too require systems that do not abandon or exploit their position.

This is the core of what must change: not just policies, but structures -oversight with real power, education rooted in human rights, legal accountability with teeth. Not symbolic ethics, but mechanisms of prevention, exposure, and repair that cannot be silenced. It requires unwavering

courage, clarity of intent, and structural transformation across education, practice, law, and governance. A healing profession that fails to protect the living right to flourish is no longer a profession. These ten pillars lay the groundwork.

The will to act, now, to redress this problem and uphold sanity, is the measure of our civilization.

Conclusion

The symposium laid bare a stark reality: the political abuse of psychiatry persists today as an entrenched and systemic phenomenon, deeply intertwined with rogue governance, failed healthcare systems, and criminal misuse of medical authority. Where incompetent authority replaces the sane state of mind and sound ethical governance, psychiatry ceases to serve its healing purpose and becomes an instrument of repression, silencing, and destruction. The profound human and economic costs - borne by survivors, communities, and societies at large - reveal the devastating consequences of allowing mental health systems to be weaponized. These abuses are not incidental; they are the predictable outcome of systemic failures that prioritize control over care, coercion over communication, and impunity over justice. Urgent, coordinated, and uncompromising action is required at every level: international, national, institutional, community, and individual. Psychiatry must be reclaimed from corruption and restored to its rightful role as a guardian of healing, dignity, and freedom. Protecting mental health systems from political and criminal abuse is not a technical reform - it is a profound moral imperative, central to the defense of human rights and the preservation of sanity itself. Only by dismantling the structures of coercion, enforcing strict human rights protections, empowering survivors, and rebuilding care on the foundations of respect, voluntariness, and solidarity, can psychiatry fulfill its highest ethical promise: to heal, to protect, and to uphold the inviolable dignity of every human being.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflicts of interest. All analyses, interpretations, and conclusions were developed independently and without influence from any external institution, organization, or funding body beyond the formally acknowledged support listed below. No private, governmental, or corporate entities have influenced the design, execution, or reporting of the symposium or its resulting documentation.

Funding and Ethical Approvals: This work has been supported by funding from the Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities under Project Codes FPU19/00028 and PID2023-148482NB-I00. Additional support for the symposium event and associated dissemination activities was provided under the framework of the COST Action CA19133 FOSTREN (Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services), specifically through a Short-Term Scientific Mission (STSM) supporting the presentation of results at the World Psychiatric Association Congress in Vienna, 2023. Due to organizational constraints, part of the symposium's activities were independently structured to ensure full freedom of expression and scientific integrity. Ethical approval for all associated research activities was granted by the Research Ethics Committee on People, Society and the Environment (CEIPSA) at the Universitat Rovira i Virgili (URV), Tarragona, Spain. The specific ethical clearance codes governing this work

are CEIPSA-2024-PRD-0029 and CEIPSA-2022-TDO-0023. All research and dissemination activities fully complied with national and international ethical standards for the protection of human rights, dignity, and the integrity of academic inquiry.

References

- Choudhary, L. (2013). Political abuse of psychiatry: A global perspective. *International Journal of Culture and Mental Health*, 6(2), 111–125. <https://doi.org/10.1080/17542863.2012.721522>
- Di Maio, P. (2025). Psychological coercion and systems dynamics in mental health services [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.
- Edwards-Grossi, M. (2024). Re-examining psychiatry and dissent: A historical and contemporary analysis. *History of Psychiatry*, 35(1), 112–127. <https://doi.org/10.1177/0957154X231185274>
- Edwards-Grossi, È., & Willoughby, C. D. E. (2024). Slavery and its afterlives in US psychiatry. *American Journal of Public Health*, 114(S3), S250–S257. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2023.307554>
- Foucault, M. (2006). *Madness and civilization: A history of insanity in the age of reason* (R. Howard, Trans.). Routledge. (Original work published 1961)
- Galves, A. (2025). The dire situation of the U.S. mental healthcare system and ways to improve [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.
- Granda, E. (2025). Transgender rights and psychiatric pathologization [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.
- Groot, P. (2025). Tapering strips and psychiatric drug withdrawal: Restoring autonomy [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.
- Halliburton, M. (2025). The need for transcultural psychiatry to counterbalance the dominant model [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.
- Herman, J. L. (1997). *Trauma and recovery: The aftermath of violence-from domestic abuse to political terror*. Basic Books.
- Human Rights Watch. (2005, November 2). China: Political prisoner exposes brutality in police-run mental hospital. <https://www.hrw.org/news/2005/11/02/china-political-prisoner-exposes-brutality-police-run-mental-hospital>

Human Rights Watch. (2010, January 20). Torture and cruel treatment in health settings: Fact sheet. <https://www.hrw.org/news/2010/01/20/torture-and-cruel-treatment-health-settings>

Laing, R. D. (1960). *The divided self: An existential study in sanity and madness*. Penguin Books.

Llorens, M. (2025). Collapse of the Venezuelan health system and psychiatric repression [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.

Losa, L., & Morell, X. (2025). Severe abuses in Spanish mental healthcare and guardianship systems [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.

Matas, D. (2025). Madness of China's organ extraction from living dissidents and ethnic minorities [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.

Metzl, J. M. (2010). *The protest psychosis: How schizophrenia became a Black disease*. Beacon Press.

Mou, Y. (2022, August 16). Mental torture: China is locking up critics in psychiatric facilities. *Safeguard Defenders*. <https://safeguarddefenders.com/en/blog/mental-torture-china-locking-critics-psychiatric-facilities>

Mou, Y. (2025). Abuses in China's black prisons and extrajudicial psychiatric detention centers [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.

Munt, C. (2025). Systemic violence against psychiatric patients in the UK [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.

Narayan, C. L. (2013). Political abuse of psychiatry. *Indian Journal of Psychiatry*, 55(1), 96. <https://doi.org/10.4103/0019-5545.105529>

Okasha, A. (2004). On the China issue. *World Psychiatry*, 3(3), 129.

Peoples Gazette. (2025, February 20). Dozens of dissenters held as psychiatric patients in Russia: Lawyers. *Peoples Gazette*. <https://gazettengr.com/dozens-of-dissenters-held-as-psychiatric-patients-in-russia-lawyers/>

Puras, D. (2025). Human rights and mental health: Perspective of a former UN Rapporteur [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.

Reuters. (2025, April 15). Russian court commits U.S. citizen for mental treatment. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/europe/russian-court-commits-us-citizen-mental-treatment-2025-04-15/>

Safeguard Defenders. (2022). *Locked up: Punitive psychiatry in China*. <https://safeguarddefenders.com>

- Scheff, T. J. (1966). *Being mentally ill: A sociological theory*. Aldine.
- Smith, A., van Voren, R., & Liebreinz, M. (2024). Resurgent trends in punitive psychiatry in the Russian Federation. *The Lancet Regional Health – Europe*, 42, 100935. <https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2024.100935>
- Smith, S. (2025). Mutual aid networks against psychiatric abuses: SHIELD MindFreedom [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.
- Spandler, H. (2025). Critical insights into the UK mental health system [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.
- Szasz, T. (1961). *The myth of mental illness: Foundations of a theory of personal conduct*. Harper & Row.
- The Lancet Psychiatry. (2025, May). Setting the research agenda for mental health. *The Lancet Psychiatry*, 12(5), 321. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(25\)00121-7](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(25)00121-7)
- The Washington Post. (2022, August 19). How China weaponizes psychiatry against dissent. *The Washington Post*. <https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/08/19/china-psychiatry-mental-health-hospitals-punishment/>
- Trickey, L. (2025, April 24). UN experts alarmed by reports of psychiatric treatment as punishment for political dissent in Belarus. *University of Oxford Faculty of Law*. <https://www.law.ox.ac.uk/news/2025-04-24-un-experts-alarmed-reports-psychiatric-treatment-political-dissent-belarus>
- United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities. (2014). General comment No. 1: Article 12-Equal recognition before the law (CRPD/C/GC/1). <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no1-2014-article-12-equal-recognition>
- van Voren, R. (2009). Political abuse of psychiatry: An historical overview. *Schizophrenia Bulletin*, 36(1), 33–35. <https://doi.org/10.1093/schbul/sbp119>
- van Voren, R. (2016). Ending political abuse of psychiatry: Where we are at and what needs to be done. *BJPsych Bulletin*, 40(1), 30–33. <https://doi.org/10.1192/pb.bp.114.049494>
- Whitaker, R. (2002). *Mad in America: Bad science, bad medicine, and the enduring mistreatment of the mentally ill*. Basic Books.
- Winkler, P. (2025). Safeguarding human rights in Czech psychiatry [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.

Zhang, Y. (2025). Psychiatric abuses in the People's Republic of China [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.

World Psychiatric Association. (2025, February 6). WPA experts condemn the misuse of psychiatry in Iran. *World Psychiatric Association*. <https://www.wpanet.org/post/wpa-experts-condemn-the-misuse-of-psychiatry-in-iran>

Annex H - Dissertation policy advice summary

The policy executive summary presented in Annex H, do to its multimedia nature, is available through the dissertation's online repository, where it can be accessed as part of the public dissemination and translational impact strategy. This repository hosts the structured reform proposals, legal and clinical recommendations, and implementation pathways derived from the doctoral research, ensuring transparency, accessibility, and practical utility for policymakers, professionals, and civil society actors. Annex H functions as a translational synthesis of the dissertation's scientific evidence into structured, actionable guidance for institutional reform. It is designed not as a secondary addition, but as a core component of the research's impact agenda, bridging the gap between empirical documentation and policy implementation. Within the logic of the dissertation, which integrates biocultural analysis, action-research, and institutional diagnostics, this annex embodies the normative and operational corollaries of the work. It responds to the urgency, repeatedly demonstrated throughout the main chapters, for legally binding and structurally embedded mechanisms to prevent psychiatric violence and guarantee autonomy in care.

The annex distills the dissertation's extensive findings, derived from participant observation, national and international surveys, legal analysis, and transdisciplinary synthesis, into a coherent reform roadmap. It articulates the priority areas for legislative, clinical, and educational intervention, grounded in the central hypothesis that coercion is neither inevitable nor therapeutically justified, but rather a systemic failure perpetuated by outdated legal norms, epistemic asymmetries, and professional inertia. The policy summary proposes concrete shifts toward shared decision-making, autonomous medication management, open data infrastructures, and the deployment of dialogical care models within the public health framework, including Open Dialogue, trauma-informed pedagogy, and participatory oversight systems.

The structure and content of Annex H correspond directly to the operative research questions and translational objectives set forth in the introduction and methodological chapters. It draws from the empirical findings of Chapters 3 and 4, which identify patterns of diagnostic imposition, overmedication, and institutional betrayal, and from the analytical and normative synthesis of Chapters 5 and 6, which diagnose the regulatory and ethical dysfunctions of current psychiatric governance. The recommendations presented in Annex H are aligned with international legal standards, including those articulated in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the WHO QualityRights framework, and European human rights jurisprudence. It also draws on transdisciplinary evidence from neuroscience, medical anthropology, legal theory, and systems science to ensure feasibility and coherence. Annex H also lays the groundwork for the implementation phase envisioned in Chapter 7, particularly through the EU BEACON One Health Education initiative. It establishes the logical architecture through which reforms can be scaled across educational, legal, and clinical systems. It outlines regulatory benchmarks, participatory mechanisms, and accountability protocols that translate the thesis's findings into enforceable structures. Rather than offering idealistic aspirations, the annex provides a modular and evidence-backed reform agenda oriented toward real-world deployment, adaptive governance, and continuous feedback monitoring.

Annex I - Media dissemination kit

Annex I, containing the media dissemination kit, is made available exclusively through the dissertation's online repository due to its multimedia nature. This annex includes visual materials, communication templates, explanatory videos, and open-access outreach tools designed to support broad public engagement with the dissertation's findings. It forms part of the translational strategy to facilitate awareness, policy uptake, and cross-sectoral dialogue by rendering complex scientific content accessible and actionable across diverse audiences.

Annex J Horizon proposals

The four Horizon Europe proposals now under development under the EU BEACON One Health Education COST action, as part of the action-research of this dissertation, directly extend and operationalize the theoretical, empirical, and normative foundations of the dissertation, transforming its claims into applied, scalable interventions across educational, clinical, and policy domains. Each project embodies a structural response to the core proposition that psychiatric systems must move beyond coercive and overmedicalized practices, not merely through protocol revision or professional training, but through a comprehensive reconfiguration of the socio-institutional architectures that sustain exclusion, diagnostic reductionism, and epistemic asymmetry. The first proposal, focused on fostering brain health in school settings, aligns with the thesis's assertion that mental health must be understood bioculturally and developed preventively through dynamic interactions between metabolic regulation, neurodevelopment, and social participation. By implementing structured routines in exercise, sleep hygiene, nutritional supplementation, especially Omega-3 regulation, and social bonding, this project targets the physiological substrates of cognitive and emotional regulation within equitable educational contexts. It reflects the dissertation's emphasis on early, non-stigmatizing, non-pharmacological interventions and on biosignal-informed feedback systems that enable continuous assessment of therapeutic efficacy. It thereby exemplifies the thesis's call for scientifically grounded, real-time recalibration of care that respects bodily and legal integrity from the earliest stages of psychosocial development.

The second proposal, addressing the cognitive impact of pollutants, provides empirical substantiation for the thesis's critique of psychiatry's neglect of environmental determinants of distress. By mapping and mitigating the neurotoxic effects of contaminated air, soil, water, and food chains in school-age populations, the project embeds mental health within ecological public health and environmental justice frameworks, bridging disciplines that the dissertation holds to be unjustly separated. The project's integration of biomonitoring, neurodevelopmental testing, and community-level intervention design mirrors the thesis's insistence that psychiatric symptoms often emerge from chronic systemic exposures which are pathologized rather than addressed. By generating real-time dashboards linking exposure to cognitive function, and by embedding environmental data in institutional decision-making, the project enacts the thesis's vision of a participatory, feedback-informed governance model, rooted in the ethical imperative to prevent harm through structural accountability. It concretizes the dissertation's legal and institutional recommendations, demonstrating how regulatory inertia can be challenged through multisectoral coordination and scientifically verifiable risk mitigation strategies.

The third proposal, centered on shared decision-making in child and adolescent mental health, directly implements the dissertation's core theoretical proposition: that coercion is structurally produced through the systematic exclusion of individuals from decisions affecting their own care, and that recovery requires dialogically anchored, procedurally accountable systems that respect autonomy, narrative identity, and relational integrity. This project institutionalizes SDM as a foundational practice across school-based mental health systems, translating the dissertation's conceptual framework into practical methodologies for co-produced care. By embedding SDM

tools, trauma-informed protocols, and culturally sensitive engagement mechanisms within naturalistic settings, rather than isolating them in clinical silos, the project validates the thesis's argument that ethical and effective mental health care must be situated within the everyday contexts where distress emerges and where trust can be rebuilt. Moreover, it reinforces the dissertation's operational commitment to participatory regulatory design by creating traceable decision processes, consent frameworks, and transparent digital tools that empower youth and families while ensuring institutional compliance with rights-based standards. The project's focus on legal coherence, feedback-driven improvement, and open science infrastructures serves as a direct implementation of the dissertation's proposed systemic reforms.

The fourth proposal, developing internal mentorship and service-learning networks within schools, activates the thesis's vision of recovery as a socially distributed, relational process that must be structurally enabled by institutions committed to dignity, restoration, and reciprocal accountability. This project frames educational institutions not only as sites of learning but as microcosms of civic engagement and relational healing, where trauma can be addressed not through external surveillance or behaviorist discipline, but through embedded, peer-anchored systems of trust and care. It operationalizes the dissertation's critique of clinical cultures that suppress voice and exclude survivors from the architecture of care, by creating structured pathways for safe disclosure, narrative reconstruction, and collective response to harm. Through reflexive mentoring systems, continuous professional development, and survivor-informed policy co-design, the project models the dissertation's call for institutional transformation through dialogical scaffolding and transparent governance. It enacts the procedural ethics advanced in the thesis, where institutional maturity is defined not by control over pathology but by the capacity to host feedback, correct injustice, and evolve through relationships.

Together, these four proposals form a coherent translational matrix that directly advances the dissertation's multi-level aims: the prevention of psychiatric harm through structural and environmental interventions; the reconstruction of clinical and educational systems around shared decision-making and narrative agency; and the creation of participatory infrastructures for ethical governance, continuous improvement, and open verification. Each project embodies the thesis's epistemological stance that mental health is not reducible to individual pathology but is a relational, regulatory, and socially mediated phenomenon that requires institutional designs capable of procedural reflexivity and systemic repair. Through the operationalization of the dissertation's theoretical insights and empirical findings, these proposals not only affirm the scientific validity of its claims but also activate its transformative intent, moving psychiatry, education, and public health toward a new paradigm in which recovery is the structural default, not the exception.

1. Fostering Brain Health in School Settings

Summary of Benefits

This proposal seeks to establish a transdisciplinary, school-anchored health promotion model that integrates physical exercise, rest routines, nutrition (including Omega-3 intake and metabolic balance), and social engagement into measurable programs aimed at enhancing neurocognitive

performance, emotional regulation, and long-term educational attainment. The intervention emphasizes neuroplasticity in development, equity in school environments, and the prevention of burnout, anxiety, and learning disorders from a public health perspective.

Required Actors

- Schools and education ministries (policy integration, implementation)
- Pediatric neurologists, nutritionists, sleep researchers (clinical design, baseline assessments)
- Neuroscientists and developmental psychologists (design of neurocognitive metrics and resilience indicators)
- Public health institutions and One Health experts (coordination of multisectoral impact)
- Local and national sports and youth organizations (delivery and social anchoring)
- Food science researchers and metabolic health labs (dietary interventions, Omega-3 monitoring)
- Data scientists and digital tool developers (tracking tools, gamified compliance, real-time feedback)
- Youth representatives and families (participatory co-design)

Longitudinal Experimental Design and Novelty

- Population: 5,000–10,000 children aged 6–16 across rural and urban European school systems
- Design: Multisite, longitudinal cluster-randomized controlled trial (CRCT) with at least 3 arms:
 - Full intervention (exercise + sleep + nutrition + social engagement)
 - Partial intervention (exercise + sleep or nutrition only)
 - Control group (standard school practices)
- Duration: 4+ years with annual follow-ups and continuous monitoring
- Novelty:
 - Integrates metabolic profiling (especially Omega-3 index) and cognitive baselining in a school setting
 - Applies sleep science to optimize school start times and activity schedules
 - Uses digital tools and citizen science to ensure participatory feedback and adaptivity
 - Bridges health and learning outcomes into one comprehensive intervention model

Expected Impact

- Establishes a model for systemic health education policy, promoting health as foundational to cognitive success
- Mitigates health inequities and supports inclusion by targeting underserved schools and vulnerable populations
- Reduces future burden of mental illness, attention disorders, and lifestyle-related diseases
- Aligns with SDGs 3, 4, and 10, strengthening One Health literacy and prevention across generations
- Provides scalable, evidence-based protocols for EU-wide education and health ministries

2. Pollutants and Brain Health: Cleaner Air, Soil, Water and Food Chains

Summary of Benefits

This proposal addresses the underrecognized but critical link between environmental toxicity and neurodevelopmental decline in children. By focusing on pollutants affecting air, water, soil, and food chains, the project seeks to safeguard cognitive performance, behavior, and mental health outcomes through an integrated environmental justice approach. It connects ecological exposures with measurable brain health outcomes and builds regulatory and community strategies for mitigation.

Required Actors

- Environmental toxicologists and neuroepidemiologists (biomonitoring design and neurotoxic risk profiling)
- Schools, municipalities, and public health departments (exposure mitigation, public engagement)
- Environmental justice advocates and NGOs (community anchoring, participatory processes)
- Food safety and water quality agencies (surveillance and intervention on contaminants)
- Veterinary and One Health professionals (cross-species biomonitoring and sentinel analysis)
- Legal scholars and regulatory experts (policy translation and threshold enforcement)
- ICT experts and citizen science platforms (data collection, local reporting, and transparency)

Longitudinal Experimental Design and Novelty

- Population: 6,000–12,000 children in 5–10 European regions with variable pollution profiles
- Design:
 - Quasi-experimental prospective cohort with nested intervention groups

- Cross-sectional biomonitoring of neurotoxicants (e.g., heavy metals, pesticides, PFAS)
- Annual neurocognitive testing, inflammation markers, and psychosocial metrics
- Duration: 5 years minimum, with environmental sampling and child-level monitoring every 12 months
- Novelty:
 - Merges environmental biosurveillance with school-based neurocognitive assessments
 - Introduces real-time pollution-to-cognition dashboards for policy use
 - Tests protective community-level interventions (e.g., air filters, schoolyard rewilding, dietary shielding)
 - First EU-scale application of One Health neurotoxic risk mitigation in school populations

Expected Impact

- Empowers schools and communities to act as sentinels of environmental and brain health
- Enables science-based regulation of environmental pollutants with direct cognitive health endpoints
- Mitigates the neurodevelopmental impact of pollution in vulnerable child populations
- Strengthens intersectoral policy design between health, education, and environment
- Advances SDGs 3, 4, 13, and 10, through early prevention and pollution accountability
- Provides a replicable framework for EU regulatory reform and community-based environmental action

3. Shared Decision-Making Mental Health for Children

Summary of Benefits

This project establishes a European model for shared decision-making (SDM) in child and adolescent mental health, integrated within educational and social systems. It aims to reverse coercive, fragmented mental health interventions by embedding trust-based, culturally responsive, and evidence-driven care models in schools and local services. The benefits include better outcomes in emotional wellbeing, reduced psychiatric labeling, enhanced autonomy, and stronger support for teachers and families navigating distress in youth.

Required Actors

- Child psychiatrists, psychologists, and SDM specialists (design and implementation of decision-making frameworks)

- Educational institutions and ministries (integration into school health protocols)
- Youth and parent advocacy groups (lived experience input, evaluation of relevance and trust)
- Anthropologists and medical sociologists (analysis of context, bias, and systems)
- Social workers and family support services (engagement in care plans)
- Digital platform developers (ethical, secure, user-friendly SDM tools)
- Health economists and evaluators (cost-effectiveness, outcome tracking)

Longitudinal Experimental Design and Novelty

- Population: 3,000–6,000 children and adolescents experiencing early signs of mental distress, along with families and school personnel
- Design:
 - Longitudinal intervention-control study across 6–8 countries
 - Co-creation and iterative refinement of SDM tools and relational frameworks
 - Measurement of psychiatric outcomes, school attendance, trust in services, emotional self-regulation
- Duration: 4 years with follow-up at 6, 12, 24, and 36 months
- Novelty:
 - First large-scale EU project to operationalize SDM for minors in mental health through schools
 - Replaces risk-based, exclusionary models with narrative-based, trauma-informed relational support
 - Embedded in naturalistic school and community settings, not clinical-only settings
 - Explicitly rights-based and aligned with UN CRC and WHO guidance on non-coercive care

Expected Impact

- A validated framework for SDM in youth mental health, adaptable across contexts
- Reduction in overdiagnosis, overmedication, and harmful institutionalization
- Empowerment of schools, families, and children as primary agents in early mental health support
- Improves trust in services and reduces dropout from care or education
- Supports SDG 3, 4, and 5, linking health, education, and gender equality

- Contributes to EU guidelines for non-coercive child mental health intervention design and evaluation

4. Service-Learning and Internal Mentorship Programs

Summary of Benefits

This project aims to institutionalize service-learning and internal mentorship systems in schools to counteract growing social isolation, despair, and mistrust in educational environments. By fostering peer mentoring, relational learning, and survivor-safe disclosure channels, schools become environments of care, restoration, and participatory problem-solving. It redefines the school not just as a knowledge site but as a resilient social institution with the power to prevent harm, promote health, and mediate conflicts.

Required Actors

- School leadership teams and teacher unions (implementation and sustainability)
- Peer mentoring experts and youth counselors (training frameworks and supervision systems)
- Trauma-informed educators and restorative justice professionals (handling of disclosures and harm repair)
- Civic educators and psychologists (design of meaningful contribution pathways)
- Policy-makers in education and justice (translation into national guidelines)
- Children's rights and gender equality experts (intersectional structuring of mentorship roles)

Longitudinal Experimental Design and Novelty

- Population: 5,000–8,000 students across 30–40 schools in varied socioeconomic and cultural settings
- Design:
 - Implementation study using a stepped-wedge randomized rollout model
 - Structured mentorship systems with roles assigned and trained within each institution
 - Evaluation through mixed methods: school climate surveys, dropout and absenteeism data, mentorship feedback loops
- Duration: 3–4 years, with monthly reflections and annual thematic reviews
- Novelty:
 - Anchors internal responsibility structures within the school community rather than relying on external programs

- Integrates relational pedagogy with institutional repair functions (e.g., spaces to report abuse, heal division)
- Frames mentorship as both civic duty and psychological protection, supporting EU restorative principles
- Generates real-time dialogues on harm, prevention, and belonging from within the school ecosystem

Expected Impact

- Creates trusted internal mechanisms for navigating hardship and healing conflict in schools
- Reduces bullying, exclusion, and systemic silence on harm
- Builds interpersonal resilience and institutional maturity through participation
- Transforms schools into safe, responsive micro-communities capable of emotional and civic learning
- Contributes to SDG 4, 5, and 16, by promoting peace, inclusion, equality, and participatory governance
- Offers a blueprint for education-led violence prevention and youth engagement policy across Europe

Annex J Ethics approval

The following section provides documentation of the ethics approval granted for the research conducted in this dissertation.

Títol del projecte d'R+D+I:

Repensar lo social en salud mental: mapeo y análisis de las iniciativas productoras de autonomía en España

Investigador/a principal:

Ángel Martínez Hernández – Martín Correa-Urquiza Vidal Freyre

Comitè ètic de recerca:

Comitè Ètic d'Investigació en Persones, Societat i Medi Ambient (CEIPSA)

Entitat:

Universitat Rovira i Virgili

Sessió:

CEIPSA2/2025, de 28/02/2025

Número d'autorització:

CEIPSA-2024-PR-0029

Una vegada revisada i validada la informació aportada, l'expedient de referència CEIPSA-2022-TDO-0023 no ha de superar el procés d'avaluació addicional.

Annex L - Additional tables and figures

Table 1- Historical approaches to mental and emotional states, by culture and region

Period / Region	Approach to Mental States	Practices & Substances	Interpretive Setting
Ancient Greece	Dream incubation; melancholia as philosophical temperament	Olive oil, wine, mandrake, poppy; communal sleep spaces	Temples, oracles, symposiums
Classical China	Qi imbalance treated via herbs, acupuncture, moral cultivation	Ginseng, tea, fasting, ancestor veneration	Confucian and Taoist circles
Medieval Islamic World	Prophetic dreams; spiritual melancholy	Saffron, ambergris, music, Qur'anic recitations	Hospitals, mosques, theological academies
Andean Cultures	Ritual singing, coca leaves, trance for balance and vision	Maize rituals, tobacco, fasting, dance	Community elders, spiritual healers
Renaissance Italy	Humoral theory, artistic catharsis, pilgrimage	Opium, absinthe, wine, confession	Courts, monasteries, salons
19th-century Europe	Institutional care; medicalized moral treatment	Morphine, bleeding, electrotherapy	Asylums, elite clinics, literary circles

Treatments and interpretive settings for mental, emotional, and spiritual crises in various civilizations.

Table 2- Physiological control of cognition and emotion across eras, by culture and region

Era	Control Mechanism	Health Impact	Narrative Justification
Ancient Civilizations	Fasting rituals, wine caste-based food distribution	Feasts, Nutrient-based stratification, ritual intoxication	Divine hierarchy, ritual purification
Medieval Europe	Church feasts for control, alcohol as religious sacrament, bread as loyalty tool	Famine cycles, malnutrition, dietary restriction	Moralistic suffering, monastic divine punishment
Modern Capitalist States	Processed food addiction, subsidies for sugar/alcohol, pharmaceutical dependency	Obesity, inflammation, pathologization	Diabetes, psychiatric consumer choice, biological determinism
Russia, late USSR	Vodka rationing, institutionalized alcoholism, chemical sedation for dissent	Liver disease, mass suicides, apathy	Revolutionary sacrifice, national hardship
Contemporary Global South	Junk food proliferation, privatized water, mental illness framing of poverty	Stunting, gut-brain dysfunction, mass depression and suicide	Clinical diagnosis, self-blame

Historical uses of food, drink, and altered states as instruments of social control and their psychiatric consequences, across epochs and geographies.

Table 3, Ancient patterns of marginalization and control

Targeted Group	Mechanism of Harm	Structural Role	Exploitative Driver
Enslaved laborers	Overwork, beatings, no legal rights	Resource extraction, class enforcement	Profit from forced labor
Urban poor in temple economies	Food debt, labor conscription	Surplus dependency structure	Control and surplus extraction
War prisoners, enslaved	Forced public works, mutilation	Imperial consolidation	Domination via labor, fear
Household servants, slaves	Sexual/physical coercion	Lineage and domestic control	Power and normalized abuse

This table outlines the early institutional, economic, and ideological mechanisms used to regulate, exclude, or exploit marginalized populations in ancient societies, including Mesopotamian, Egyptian, Greco-Roman, and early imperial models. It highlights how sociopolitical systems organized labor, justified social hierarchies, and medicalized or spiritualized dissent, laying the groundwork for later biomedical and psychiatric rationales of exclusion and control.

Table 4, Medieval and early modern systems of targeted harm

Targeted Group	Mechanism of Harm	Structural Role	Exploitative Driver
Feudal serfs	Bonded to land, no mobility	Agrarian wealth, elite maintenance	Rent extraction, control
Women	Torture, execution	Moral/patriarchal purification	Sadistic spectacle, forced sexual pleasure, male power
Religious minorities	Ghettoization, massacres	Territorial consolidation	Confiscation, ethnic purge
Pauper orphans	Forced labor, abuse	Cost-saving institutions	Institutional labor, neglect

This table presents the structural targeting of vulnerable populations in feudal and premodern Europe, including women, serfs, orphans, and religious minorities. These mechanisms -ranging from torture and forced labor to public executions -served not only as instruments of order and moral enforcement but also as technologies of terror, pleasure, and accumulation. The continuity of these practices into medical-legal frameworks underscores how control and exploitation were historically normalized through theological, patriarchal, and juridical rationales.

Table 5- Historical Governance

Era / Region	Gender/Class Subjugation	Knowledge Preservation	& Skill Pleasure/Profit from Violence
Late Empire	Roman Women pushed to domesticity, elite concubinage	Classical knowledge preserved in minor schools	Public executions, military spectacles
Byzantine Empire	Elite women cloistered, women silenced	Preserved Hippocratic and Galenic medicine	Heresy purges and imperial torture rituals
Islamic Age	Golden Gender roles ambivalent; women could own property	Translation movement, Razi, Ibn Sina	Al- Judicial amputations, corporal punishments
Western Medieval Europe	Serfdom, female witch-hunts, orphans enslaved	Monasteries kept rudimentary archives	Witch-burnings, pillories, sacrificial wars
Early Europe	Modern Factory discipline, commodification	Renaissance clandestine printing	humanism, Colonization as health sacrifice zone

This table disaggregates the role of gender and class in systems of exploitation, emphasizing how social identity intersected with epistemic and somatic control. Women, the poor, and the colonized were subject to layered forms of violence, including the confiscation of reproductive autonomy, criminalization of alternative knowledge systems, and commodification of pain for profit or pleasure. These dynamics laid the groundwork for modern institutional cruelty, in which trauma is still misrecognized as disorder and agency as deviance.

Table 6, Historical Governance Table

Era / Region	Health & Public Systems	Governance & Control Strategies	Population Obedience & Training
Late Empire	Roman Urban health infrastructure failing; aqueducts collapsing	Tax pressure, military conscription, Christianity as unifying coercion	Discipline by legions, declining civilian readiness
Byzantine Empire	Hospital and orphanage system maintained in Constantinople	Bureaucratic complexity, theological policing	Monastic discipline, literacy enforced in clergy
Islamic Age	Golden Advancements in hospital, hygiene, pharmacology	Meritocratic science hubs under caliphates	Intellectual training for elites, physical jihad
Western Medieval Europe	Monastic medicine, leechcraft, rural famine	Feudal oppression, authoritarianism	Church Martial training for nobility, no peasant rights
Early Europe	Modern Poor laws, plague patchy	Absolutism, birth of central states	Standing armies, mass conscription

This table synthesizes key historical structures across antiquity and the medieval period, highlighting governance logics that linked obedience to biopolitical submission. Populations were managed through enforced ignorance, physical exhaustion, or ritualized subjugation, with the state or empire extracting productivity and loyalty by shaping bodily and cognitive norms. Medical traditions -when not entirely

displaced -were co-opted into controlling apparatuses that punished deviation or suffering as moral failure. Structural violence was normalized and encoded into law, pedagogy, and sacred practice.

Table 7- Modern governance and social control

Era / Region	Health & Public Systems	Governance & Control Strategies	Population Training	Obedience &
Early Century (Global)	20th State hospitals, eugenics programs	Nationalist social hygiene laws	science, Work-based military drafts	rehabilitation,
Mid Century	20th Mass institutionalization, psychiatric genocide	Ideological racial biology	purges, Compulsory secret policing	loyalty rituals,
Late Century	20th Deinstitutionalization, privatized healthcare	Market biopolitical management	logics, Self-optimization, culture	therapy
21st Century	Digital health surveillance regimes,	data Platform algorithmic control	capitalism, Censorship, profiling	predictive

This table contrasts the dominant political logics of population control across the 20th and 21st centuries, spanning totalitarianism, neoliberal governance, and algorithmic rationality. While modes differ -from centralized psychiatric repression to decentralized economic dispossession -all systems share a core commitment to suppressing dissent and reinforcing hierarchical order through coercive or pharmacological means. Rationality is often redefined to justify violence as necessity, psychiatry as discipline, and poverty as pathology.

Table 8- Modern governance and institutionalized violence

Era / Region	Gender/Class Subjugation	Knowledge & Skill Preservation	Pleasure/Profit from Violence
Early Century (Global)	20th Pro-natalist industrial patriarchy	propaganda, Medical colonial science	academies, Anatomical exploitation, forced labor profits
Mid 20th Century	Re-education camps, gender purging	Propaganda psychiatric policing	science, Spectacular trials, state terror aesthetics
Late 20th Century	Sexual commodification, gig precarity	Elite managerialism	universities, Prison-industrial complex, insurance markets
21st Century	Digital trafficking, biometric sorting	Platform monopolies	knowledge AI prediction economies, migrant exploitation

This table catalogs the institutional mechanisms -psychiatric, legal, technological, and bureaucratic -used to surveil, silence, or chemically subdue populations deemed unfit, inconvenient, or rebellious. While framed as therapeutic or security-enhancing, these systems function to obscure structural violence and redistribute blame from failing institutions to vulnerable individuals. The so-called care infrastructure reproduces inequality while denying the epistemic legitimacy of those most harmed.

Table 9- Institutional, psychiatric, and ideological control in the 20th–21st century

Category of Control	Mechanism Employed	Institutions Involved	Target Populations
Psychiatric Coercion	Involuntary hospitalization, forced medication, misdiagnosis of dissent as pathology	Asylums, psychiatric hospitals, forensic units	Political dissidents, abused women, neurodivergent individuals
Medical Pathologization Poverty	Reclassification of trauma or social deprivation as chronic mental illness	Social security disability assessments	Working-class populations, unemployed, single mothers
Carceral Expansion	Prison-like psychiatric wards, secure treatment centers, chemical restraints	Prisons, institutions, psychiatric units	juvenile closed Racialized youth, migrants, the homeless
Welfare Surveillance	Psychiatric labeling to restrict parental rights, enforce state guardianship, or justify state guardianship removals	Family courts, CPS, state guardianship bodies	Poor families, survivors of abuse, foster system entrants
Ideological education	Re- Therapeutic correction of gender identity, political beliefs, or trauma narratives	Conversion programs, military psychiatry, propaganda schools	LGBTQ+ individuals, political prisoners, rape victims
Digital & Algorithmic Control	Predictive policing, mental health flagging via social media, biometric sorting	Tech companies, predictive analytics firms, insurance brokers	Protesters, those with non-normative behaviors or expressions
Drug-Based Pacification	Long-term prescription of sedatives, antipsychotics, and mood stabilizers for non-severe distress	Primary care clinics, elderly care, schools	Children, elderly, women, those reporting abuse
Bureaucratic Silencing	Diagnosis used to dismiss testimony, deny legal claims, or erase credibility	Courts, police forces, hospitals	Victims of domestic and institutional violence

This table categorizes the dominant state and institutional strategies of psychological, ideological, and bodily control from the 20th century to the present. It includes coercive psychiatry, militarization, food monopolies, welfare surveillance, and technocratic governance across authoritarian, neoliberal, and hybrid regimes. Emphasis is placed on the operational role of psychiatry and health discourses in reframing dissent as disorder, and on the continuity of social control logics across political systems allegedly opposed in ideology but aligned in biopolitical function.

Table 10- Cultural Handling of Altered States and Mental Distress, by era and region

Period / Region	Induced or States	Treated	Substances / Foods Used	Rituals and Settings	Interpretive Agents
Ancient Greece	Melancholy, catharsis, mania	divine	Wine, hellebore, potions	opium, honeyed, Dionysian Asclepian incubation	rites, dream Temple philosophers, priests,
Vedic India	Mystical sorrow, mental	ecstasy, heat	Soma, butter, herbs	clarified ayurvedic, Fire meditative seasonal fasting	sacrifices, chanting, Brahmins, healers, gurus,
Indigenous Amazon	Vision ancestral	quests, possession	Ayahuasca, chicha	tobacco, Night singing, immersion	rituals, group jungle Shamans, women, elder
Classical China	Grief, spiritual	madness, imbalance	Ginseng, mushroom, rice	reishi wine, Ancestral seasonal diaries	rituals, dream Daoist Confucian scholars, sages,
Medieval Islamicate	Spiritual melancholia, obsession		Ambergris, rosewater, saffron	Music therapy, dream interpretation	Qur'anic Hakims, theologians, Sufis
Medieval Europe	Demonic possession, melancholia		Absinthe, belladonna, and bread	fasting Exorcisms, flagellation, confession	fasting, Monks, inquisitors, barbers
Edo Japan	Existential societal shame	grief,	Green tea, fermented rice, incense	Theater (Noh), communal poetry	writing, Zen monks, poets, physicians
Andean Highlands	Soul loss, ecstatic mourning	trance,	Coca leaves, beer, llama fat	maize Dance, mountain offerings	bloodletting, Curanderos, community elders
Renaissance Europe	Black melancholy, madness	bile divine	Laudanum, tonics, red wine	herbal Patronage of alchemy, mirror-gazing	art, Artists, physicians, mystics
Yoruba Africa	West Spirit ecstatic	possession, healing	Palm wine, kola nut, herbal smokes	Drumming, divination ceremonies	trance, Orisha healers, priests,
Early Modern Europe	Hysteria, melancholia, rapture		Purgatives, opiates, hot baths	mercury, Magnetism sessions, mesmerism, confession	Physicians, moral managers

Historical approaches to madness, melancholy, divine ecstasy, and psychological suffering across world traditions, focusing on ritual, substances, communal interpretation, and contextual care practices.

Table 11- Physiological and social harms of forced psychotropic drugging

Category	Description of Harm
Neurological impairment	Tardive dyskinesia, akathisia, extrapyramidal symptoms, cognitive dulling, and neuroleptic-induced deficit syndrome are frequent outcomes of long-term use of antipsychotics
Metabolic and endocrine harm	Weight gain, insulin resistance, hyperlipidemia, and elevated risk of diabetes and cardiovascular disease
Sedation dependency	and Many psychotropics, including benzodiazepines and antipsychotics, originate from or mimic substances used in veterinary anesthesia; their use leads to dependency and emotional blunting
Loss of autonomy	Individuals subjected to forced drugging report lack of control, hopelessness, and inability to exercise basic civil or bodily rights
Isolation	Coerced individuals are perceived as dangerous or incompetent, intensifying social exclusion and familial rupture
Institutional dependency	Psychiatric treatment becomes synonymous with medication compliance; relational or psychosocial interventions are sidelined or unavailable
Social death	The combined effect of stigma, surveillance, and disempowerment results in symbolic exclusion from community and public life
Increased mortality	Long-term use of psychotropics, especially antipsychotics, is associated with reduced life expectancy by 10–20 years compared to the non-drugged cohorts, suicide and disease exceedingly high due to compounding harm and forced nature of the regime

Multifaceted physiological and social harms associated with forced psychiatric drugging, as documented in global and Spanish research contexts. These harms challenge the legitimacy of treatment-as-usual models, especially in coercive settings, and demand systemic transformation in mental health care.

Table 12- Perceived benefits of pharmacotherapy and stakeholder gains

Actor / Stakeholder	Perceived Benefit from Pharmacotherapy	Limitations / Costs Not Internalized by Actor
Individual patient (selected cases)	Short-term relief of acute symptoms (e.g., anxiety, hallucinations)	Long-term metabolic, cognitive and social harm (De Hert et al., 2011; Vancampfort et al., 2015)
Family members (under duress or without support)	Perceived behavioral stabilization reducing household conflict	Loss of autonomy and relational strain; lack of alternatives or systemic support
Clinical staff (psychiatrists, nurses)	Simplified patient management, symptom control under time/resource constraints	Ethical conflicts, burnout, and professional dissatisfaction in coercive settings
Hospital administrations	Cost-effective containment strategy; lower staffing burdens	Poor long-term outcomes; dependency on institutional cycles
Pharmaceutical companies	Revenue from medication sales; expansion of clinical indications	No responsibility for adverse outcomes or social consequences
Government / public policy makers	Budget control, reduced political risk from visible unrest or psychiatric crises	Long-term social exclusion, disability rates, and human rights scrutiny
Insurance systems (public/private)	Predictable and measurable cost structure	Externalization of broader psychosocial recovery costs

Actors who benefit directly or indirectly from pharmacotherapeutic paradigms in mental health care, while highlighting how harms and systemic consequences are often borne by patients and society at large rather than those incentivized to uphold current models.

Table 19. Structural Dangers of Coercive Psychiatric Regimes

Mechanism	Description	Consequences
Diagnostic ambiguity	Psychiatric categories are broad and elastic, easily fitting divergent behaviors	Enables strategic misuse to delegitimize or silence individuals
Family-based false reporting	Relatives fabricate symptoms or narratives to institutionalize or disempower	Enables extrajudicial detention and forced drugging
Institutional obedience	Staff comply with hierarchical mandates despite ethical doubts	Reduces possibility of intervention or whistleblowing
Legal incapacitation	Diagnoses lead to diminished legal standing and presumption of untrustworthiness	Limits capacity to defend oneself or contest abuse
Forensic re-interpretation of protest	Acts of self-defense or dissent are redefined as symptoms of illness	Eliminates legitimacy of resistance, justifies further coercion
Physical health deterioration	Forced medication causes long-term damage without addressing underlying suffering	Increases dependency, vulnerability, and chronicity
Social death	Isolation, forced treatments, and stigma result in permanent loss of community ties and self-agency	Perpetuates exclusion, unemployment, and juridical disadvantage
Reputational erasure	Labeling as mentally ill undermines credibility across social and legal domains	Facilitates exploitation and sustained structural disadvantage

Mechanisms of structural abuse and life destruction under coercive psychiatric regimes.

Table 20. Normalized punitive practices in psychiatric settings

Actor	Tool of Punishment or Control	Justification Used	Abuse Mechanism	Normalization
Psychiatrist	Involuntary drugging, seclusion, diagnosis escalation	Therapeutic necessity, risk management	Clinical authority interpreted as infallible judgment	
Nurse	Physical restraints, isolation, verbal intimidation	Behavioral control, safety protocol	Culture of obedience, understaffing, and hierarchical impunity	
Psychologist	Misinterpretation of trauma, gaslighting, denial of therapeutic alliance	Lack of insight, secondary gains	Pathologization of complaint or critique	
Family member	False claims, reinforcement of diagnosis, denial of support	Duty of care, concern for safety	No external oversight; deference to family in institutional contexts	
Social worker	Blocking access to housing or autonomy-related services	Non-compliance, mental incapacity	Collaboration with medical files without independent evaluation	
Community institutions	Disregard for complaints, deferral to psychiatric authority	Professional consensus, risk avoidance	Psychiatric documents dominate administrative and judicial decisions	
Punitive practices and mechanisms enabling systemic abuse across psychiatric and family settings.				

Table 21- Rationalizations and incentives in psychiatric care nowadays

Actor / Group	Stated Justification	Dissonance with Reality	Empirical Underlying Incentives (Money, Power, Status)
Academic psychiatrists / professors	Evidence-based standards; safety; biological causality	Ongoing controversy over evidence quality and generalizability	Professional prestige; and industry ties; influence in policy and curricula
Politicians / public health officials	Public order, risk reduction, budgetary efficiency	Failure to address structural causes of distress; chronicity worsens under treatment-as-usual (Sisti et al., 2021)	Political capital; avoidance of structural reform; outsourcing responsibility
Practicing psychiatrists / clinicians	Clinical necessity; symptom management; legal safety	Time constraints, resource gaps, and lack of support for legal alternatives drive overreliance on medication	Avoidance of liability; institutional conformity; procedural simplicity
Pharmaceutical-aligned researchers	Scientific advancement; optimization of treatment	Selective publication, ghostwriting, and conflicts undermine neutrality	Research funding; financial career progression; corporate affiliations
Nurses / support staff	Patient and safety; manageability	Frequent distress caused by work forced measures and training in trauma-informed	Job security; lack of systemic alternatives; burnout deflection

Actor / Group	Stated Justification	Dissonance with Reality	Empirical	Underlying Incentives (Money, Power, Status)
Family members (ambivalent/abusive)	'Stabilization', obedience, relief from caregiving burden	Often participate in cycles of control, scapegoating, or silence about abuse		Restored order; avoidance of accountability; social legitimacy
Legal actors / judicial systems	Due process followed; therapeutic exception	Often rely on institutional claims, overlook human rights violations		Case resolution ease; institutional trust; avoidance of political conflict
Sociomedical educators	Enforcing allegedly neutral so-called science processes; appearance of technocratic rationality	Marginalize critical and user-led perspectives; reinforce top-down power		Intellectual gatekeeping; ideological alignment; systemic career incentives

Rationalizations used by institutional actors to justify coercive pharmacological interventions in mental health, alongside empirical dissonances and material or symbolic incentives maintaining the current system. Evidence suggests that these justifications often obscure deeper patterns of neglect, coercion, and power asymmetry.

Table 22. Historical Evolution of Psychiatric Interventions, 20th–21st Century

Period	Pharmacological Interventions	Physical/Institutional Approaches	Psychosocial/Community Approaches	Force Coercion	and Target Populations and Patterns
1900–1950	Barbiturates, early antipsychotics, insulin shock	Asylums, electroconvulsive therapy, lobotomies	Limited, confined to psychoanalysis (elitist)	Often to involuntary; massive confinement	Women, poor, disabled, colonized subjects framed as deviant
1950–1970	Chlorpromazine, lithium, MAOIs	Deinstitutionalization begins, ECT remains	Rise of social psychiatry, family therapy	Ambiguous: outpatient clinics expand, coercion persists	Allegedly therapeutic force; racial minorities disproportionately institutionalized
1970–1990	Benzodiazepines, SSRIs, atypical	Hospital rise of	Hospital downsizing, psychiatric mental health	Community health	Restraints used, Women medicalized for non-compliance

Period	Pharmacological Interventions	Physical/Institutional Approaches	Psychosocial/Community Approaches	Force Coercion	and Target Populations and Patterns
	antipsychotics	wards in general hospitals	centers promoted (esp. post-WHO 1979)	unregulated; lack of awareness	despair, anti-rights psychiatric critiques rise
1990–2010	Polypharmacy, overprescription, off-label uses, stimulant and other drugs use rise in children population	Forensic psychiatry and emergency interventions dominate	Global Mental Health movement emerges, posing both risks and opportunities	Legislation increases procedural safeguards, but implementation weak	Rise in psychotropics among elderly, youth, and racialized populations
2010–present	Long-acting injectables, digital therapeutics, overprescription trends worsen	Acute care, seclusion, and mechanical restraints still widespread	Trauma-informed care, recovery-oriented approaches barely adopted	UN/WHO condemn coercive practices common	Shared decision-making discussed rarely implemented; structural abuse persists

Main treatments, modalities, and political logics across global and European contexts. Historical overview of psychiatric practice by dominant treatment logics, coercion levels, and affected populations (1900–present). Based on scientific and policy literature.

Table 23. Timeline of global mental health advocacy and policy shifts

Period	Dominant Framing	Key Institutions	Goals Articulated	Political-Economic Context	Effectiveness
1970s–1980s	Public health integration	WHO, PAHO	Primary care inclusion of mental health (Alma-Ata, 1978)	Post-colonial restructuring, War	Limited implementation; high institutional inertia

Period	Dominant Framing	Key Institutions	Goals Articulated	Political-Economic Context	Effectiveness
1990s	Neurobiological focus rises	NIMH, WPA, pharma-aligned agencies	Emphasis on diagnostics (e.g. DSM-IV), pharmaceutical rollout	Rise of global pharma, neoliberalism	Community-based models undercut by privatization
2001	Rights-based global reform	WHO (World Health Report 2001)	Community-based, user-involved services	Globalization, post-Soviet health transition	Key declarations; partial reform in few countries
2007–2013	mhGAP program	WHO, UNHRC	Integration in non-specialist settings, rights emphasis	Global burden of disease framing	Some regional impact; insufficient structural funding
2018–present	Human rights, LGBT+, anti-racism, One Health	UN, WHO, CRPD	End coercion, promote autonomy and choice	UNCRPD enforcement, Sustainable Development Goals	Systemic coercion persists; calls for compliance unheeded in many contexts

International mental health advocacy phases, from primary care reform to human rights-based frameworks, with limited structural transformation.

Table 24- Sociocultural models of psychiatry and abuses of the discipline to punish, control

Psychiatric tradition	Violence Inflicted	Ideological Motifs	Biological framing
Buddhist-informed	Spiritual bypassing, behavioral conformity	Detachment from suffering, integration	Meditation as neurological regulation
Classical asylum	Confinement, dehumanization, discipline	Social order, moral hygiene	Degeneration theory, inherited inferiority
Freudian psychoanalysis	Verbal domination, pathologizing normativity	Libidinal economy, repression theory	Somatic roots of hysteria and libido
Lacanian psychoanalysis	Ambiguity, institutional cultism, symbolic violence	Subject split, language mastery	Linguistic inscription over neurology
Soviet psychiatry	Political imprisonment, psychiatric labeling	Ideological conformity, state security	Material brain-based deviance
Democratic psychiatry	Minimal; rights-based, disruption of coercion	Equality, emancipation, community care	Critique of reductionism, neuroplasticity support
Postcolonial ethnopsychiatry	Cultural assimilation, epistemic domination	Colonial control, identity erasure	Organicism denied or distorted via 'soul sickness'
Neocolonial psychiatry	Criminalization, silencing of resistance	Order maintenance, cultural export	Diagnostic mimicry of Western pathologies
Community-based and open dialogue models	Low; minimal or pharmacological physical coercion	Dialogue, subjectivity, social recovery	Complex adaptive neurobiology

Paradigms of psychiatry with their historical and contemporary misuses to exert punitive control, marginalize dissent, and enforce normative behavior under the guise of care.

Table 25- Biological and allegedly biological models of psychiatry

Psychiatric tradition	Violence Inflicted	Ideological Motifs	Social Framing
Francoist	Political repression through biological deviance	Biological inferiority justifying national moral order	Moral deviation encoded in bloodline and class
National Socialist	Sterilization, extermination by racial-biological doctrine	Racial hygiene, eugenic cleansing, societal purification	Biological race as societal value metric
Biologicist Psychiatry	Polypharmacy, chronicization, dismissal of cause	Neurochemical correction, diagnostic standardization	Functional adaptation to disorder; lifestyle blamed
Nutritional Psychiatry	Neglect of social context, over-focus on micronutrients	Gut-brain restoration, on micronutrient optimization	Diet-driven personality traits and cognition
Metabolic Psychiatry	Metabolic labeling, medicalization of stress	Systemic resilience, glucose-lipid-mental	Stress as pathology of social performance

Psychiatric tradition	Violence Inflicted	Ideological Motifs	Social Framing
		health link	
Psychoneuroimmunology-based Approaches	Reductive profiling, essentialism	immune Inflammation biomarker cytokine-mediated regulation	control, Social threat read as immune activation
Neuroendocrine-Informed Models	Hormonal manipulation, gendered bias	Hormonal balance, HPA axis recalibration	Stress exposure framed through gendered life roles
Microbiota-Gut-Brain Axis Psychiatry	Overinterpretation of correlations, overselling	Barrier protection, probiotic digestive-immune co-regulation	Western diet and urbanization as disease vectors
Systems Biology	Datafied abstraction, individual burden framing	Multi-scalar predictive frameworks	modeling, Individualized health responsibility for failure to self-regulate

Biologically framed psychiatric models, their scientific foundations and controversies, including critique of chemical imbalance theories and reductionist diagnostic frameworks.

Table 26- Coercive measures in psychiatric and general healthcare settings in Spain

Setting	Coercive Practices
Primary Care	Coercion is primarily symbolic. Patients pressured into pharmacological compliance. Referral used to discipline rather than support (Moncrieff, 2022).
Outpatient Health Units	Mental Legal coercion via guardianship and compulsory outpatient treatment. Emergency measures sometimes bypass procedural safeguards (Muñoz & Lobato, 2021).
Hospital Wards	Psychiatry Mechanical restraints and isolation used routinely under therapeutic pretext. Often applied punitively or to suppress distress (González Pinto et al., 2020; WHO, 2021).
Forensic Units	Psychiatry Prolonged seclusion and forced medication normalized. Coercion institutionalized and poorly monitored. Human rights safeguards minimal (Rodríguez-Pulido et al., 2021).

Common coercive practices in mental health settings in Spain, showing normalization of physical and legal control mechanisms.

Table 27- Patterns of psychotropic overprescription in Spain by clinical setting

Setting	Overprescription of Psychotropics
Primary Care	Benzodiazepines and antidepressants frequently prescribed as first-line treatment without comprehensive assessment. Most affected: elderly and women (Abas et al., 2018; WHO, 2021).
Outpatient Health Units	Mental Polypharmacy is common. Medication is maintained over time without regular review. Consent procedures often inadequate or absent (Rose et al., 2022).
Hospital Wards	Psychiatry Dosage increases and drug switching are frequent during crises. Informed consent not prioritized. Medication dominates therapeutic approach (Rodríguez-Pulido et al., 2021).
Forensic Units	Psychiatry Antipsychotics administered systematically for behavioral containment. Alternatives rarely considered. Consent typically circumvented (Otero & Pérez, 2019).

Summary of overprescription trends in different healthcare settings in Spain, highlighting systemic pharmacological excess and lack of dialogical care.

Thematic index and mapping

Below is a thematically organized mapping of the dissertation's major concepts, aligned with the chapters and annexes where each is most substantively developed. This table supports reader orientation and clarifies the conceptual architecture across the empirical, legal, and applied dimensions of the work. Please note that due to sustained institutional pressure, abusive constraints, and structurally hostile conditions endured during the final stages of dissertation preparation, coinciding with intense academic, legal, and coordination workloads, it was not feasible to include the full breadth of content, evidence, and analytical resources in this printed version. Severe formatting restrictions, together with time-sensitive deadlines and repeated episodes of obstruction and violence, further limited the capacity to render the document in its complete and intended form.

Coercion in psychiatry is a central theme appearing throughout the dissertation. It is addressed in section 1.1 in its historical form under institutional repression and carceral psychiatry, in section 1.2 as part of the current framework of involuntary treatment, and in sections 1.6 and 1.7 as systemic failure and power-related diagnostic exclusion. It also features prominently in sections 2.2, 2.4, and 2.7 in the analysis of coercion through mixed-methods research and reflexive methodologies. Sections 3.1 to 3.3 elaborate the lived experiences of coercion, especially in institutional settings, while sections 4.1 to 4.4 extend this analysis through ethnographic documentation of coercive practices. Section 5.1 connects psychiatric coercion with learned helplessness, while section 6.2 treats coercion as a violation of international human rights.

Structural violence is identified in sections 1.2, 1.3, and 1.6 as embedded in pharmacocentric psychiatric systems. It is analytically developed in sections 2.1, 2.2, and 2.7 as both an empirical finding and a methodological challenge, then further documented through participant testimony in

sections 3.3 and 4.3. Its long-term effects on health and neurodevelopment are discussed in sections 5.1 and 5.2, and its legal implications are examined in section 6.2.

Institutional betrayal is explored from section 1.5 onward, with special emphasis in sections 3.4 to 3.7 as a relational and organizational phenomenon that affects both users and professionals. In sections 4.1 to 4.4, it is analysed through narrative reconstruction and ethnographic evidence. The term reappears in sections 5.1 and 6.2 when addressing structural impunity, forensic accountability, and the failure of legal safeguards.

Epistemic injustice appears as a core concept in section 1.5 on legal and epistemic foundations, and is further developed in section 1.7 through the lens of diagnosis and exclusion. Methodologically, it frames sections 2.1, 2.2, 2.5, and 2.6. Empirical data reflecting epistemic injustice are presented in sections 3.2 to 3.6 and again in 4.5 and 4.6 through testimonial erasure and narrative foreclosure. Sections 5.2 and 5.4 connect it to reductionist diagnostics, and 7.1 and 7.3 propose educational responses.

Shared decision-making is treated as a countermodel to coercion in psychiatry, discussed in section 1.4 regarding deprescription and user autonomy. It is also part of the research instruments described in section 2.3 and analyzed in findings in sections 3.1 and 3.6. It appears again in section 5.5 as part of legal reform proposals, and in 7.2 within future-oriented frameworks for rights-based psychiatric care.

Pharmacocentrism and overmedication are analyzed in section 1.3 as systemic features of Spanish psychiatric care. Section 1.4 focuses on alternatives such as deprescription and long-term medication ethics. These themes are then referenced in empirical findings (sections 3.6 and 5.4) and addressed normatively in sections 6.1 and 6.3 through proposals for neurobiological literacy, somatic regulation, and open-source expert systems.

Transdisciplinary action research is outlined in sections 1.0, 1.8, and 2.1 as the overarching methodology. It also underpins the work in sections 2.4 and 2.9 through its application in mixed methods, reflexivity, and systemic transformation. The design is reaffirmed in sections 5.5 and 7.1 to 7.3 in reference to future implementation through One Health education and participatory governance.

Legal accountability is developed in sections 1.2, 1.5, and 1.6 with respect to coercive practices and rights violations. Sections 3.7 and 4.3 analyze legal ambiguity, institutional silencing, and accountability failures. Section 5.5 proposes new legal-pedagogical standards, while section 6.2 addresses the alignment of national practice with international human rights law and CRPD principles.

Biocultural psychiatry and **trauma-informed care** appear in section 1.4 and 1.6, and more explicitly in 2.1 and 2.5 as foundations for a new clinical paradigm. Section 5.2 links biocultural trauma with neurodevelopment, and 7.1 and 7.3 present it as part of a curricular transformation for mental health and social care professionals.

Narrative sovereignty and **testimonial justice** are articulated in sections 4.3, 4.5, and 4.6 as correctives to epistemic violence and reductionist diagnostics. These themes also frame

participatory methods (sections 2.3 and 2.8) and reappear in section 5.4 and 6.3 within structural and educational reform proposals.

One Health is introduced in section 1.8 and developed as a unifying concept in sections 2.8, 5.5, 6.1, and 7.3. It provides a framework for integrative ethics, interdisciplinary education, and resilient system design that addresses mental, physical, and ecological health together.

Ethical AI and expert systems in psychiatry emerge in sections 6.3 and 7.2, where they are proposed as tools for ethical governance and patient empowerment. They are linked to participatory design, precision mental health, and rights-based oversight, and are part of the structural response proposed in the EU BEACON framework.

Educational reform is addressed through sections 5.5, 6.1, 7.1, and 7.3 as a necessary step to prevent future epistemic violence and structural failure. It incorporates trauma-informed pedagogy, neurobiological literacy, relational ethics, and participatory learning, with emphasis on long-term system resilience and justice.

An expanded and interactive version of this dissertation is therefore being made available online as an open access ebook. This living edition incorporates all annexes, updated analyses, extended methodological notes, evidence tables, and thematic mappings, as well as the tools, instruments, and codes used in this research. It will continue to grow in accuracy, depth, and applicability in line with the principles of action research and scientific accountability. For full access to the updated version, including dynamic indexes and embedded documentation, please visit the dedicated repository and dissemination platform accompanying this work:

Thematic keywords	Chapters	Annexes
Structural violence	1, 4, 5, 6	D, G, K
Psychiatric coercion	1, 3, 5	C, F, G
Shared decision-making	2, 7	F, J, K
Epistemic injustice	1, 2, 4, 5	C, G
Action research	2, 3, 4	B, G
Human rights and legal frameworks	1, 6, 8	G, H, I, K
Biocultural methodology	2, 4, 5	D, F
Testimony and narrative evidence	4, 5	B, C
Dialogical and relational care	3, 7	A, F
Psychiatric diagnosis and medication	3, 5	D, F
Institutional betrayal and repression	4, 6	B, C
Alternatives to coercion	5, 7	A, F
Systems transformation and reform	7, 8	H, I, J, K
Open science and pedagogy	7	J, M
Survivor-researcher positionality	2	F

Thematic keywords	Chapters	Annexes
Ethics of qualitative research	2, 6	A, F
Policy translation and implementation	7, 8	H, I, K, L

The full mapping of keywords, themes, and actors relevant to this dissertation link will be shared on the open science laboratory and fieldwork notebook. The repository is conceived not as a static archive, but as a living, version-controlled environment subject to ongoing refinement, correction, and enrichment. Following the principles of action research, the structure and content of the repository will evolve in response to new evidence, user feedback, critical input, and implementation needs arising from fieldwork and policy engagement. The mapping exercise will progressively deepen and systematize the documentation of all major analytical categories, conceptual clusters, and empirical references appearing across the chapters and annexes. It will include cross-referenced indexes of themes, legal principles, methodological frameworks, discursive patterns, and institutional actors, providing an integrated navigational and interpretive guide for readers, reviewers, and allied professionals. This process will be grounded in the rigorous logic of transdisciplinary inquiry and the ethical imperative to make visible the underlying structures of violence, resistance, and repair documented throughout the work. In parallel, the repository includes all instruments and codes developed and employed in the course of the research. These encompass survey instruments, thematic coding schemas, case analysis matrices, legal mapping procedures, and computational scripts for organizing and analyzing the dataset. Each component is provided in fully accessible formats and accompanied by detailed documentation to support adaptation, reuse, and local implementation across diverse educational, clinical, legal, or policy contexts. The online version of this work will continue to be updated as part of the dissertation's ongoing contribution to the field, ensuring that its analytical tools, empirical insights, and proposed reforms remain usable, improvable, and contextually relevant. This reflects a core ethical and scientific commitment: that research of this nature ought to remain open, traceable, and accountable, not only in its results but also in its mechanisms, limitations, and possible futures.

